INSTRUÇÕES

Aqui temos o banco de questões do medgrupo. Cada pdf tem 500 questões, são 112 pdfs então 56.000 questões.

As questões são divididas da mesma forma que é no medgrupo, então, por exemplo, a pasta "CIR 1" irá conter as questões do modulo CIR 1 do medcurso. No pdf, primeiro há as questões e por final os comentários e gabaritos. Como é uma questão por pagina, sempre por volta da pagina 500 terá o começo do gabarito.

A numeração de cada questão é pelo seu ID, da mesma forma que é no app do medgrupo. Por exemplo, se no modulo CIR 1, uma questão ter o ID 33345 (o ID aparece em cima do enunciado em negrito), no gabarito irá aparecer o mesmo ID como a enumeração da questão.

Além disso, certas questões tem imagens e videos respostas. Dessa maneira se acaso a questão de ID 33345 ter uma imagem, ela estará na pasta Imagens (Cir 1/Imagens/33345.png) com o nome 33345.png e o vídeo estará em (Cir 1/videos/33345.mp4)

***Recomendo, para se localizar no gabarito, utilizar CTRL+F (pesquisar), procure o ID da questão que quer ver a resposta, como o ID 33345.**

***Se houver algum erro, envie mensagem no twitter @livremedicina**

-- Medicina livre, contra os preços abusivos na medicina.

-- Venda proibida

-- @Livremedicina - twitter

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

281102)

Enunciado: Homem, 46 anos, hipertenso e tabagista, refere dor na região anterior do tórax, que piora com decúbito, de início há 6 horas. Sinais vitais na admissão: PA 160/100mmHg, FV 100bpm, Temp.axilar 37,5ºC, FR 30mrpm. Com base nos dados clínicos e no ECG abaixo, qual seria a hipótese diagnóstica mais provável?

A) Pericardite aguda

B) Cardiomiopatia hipertrófica

C) Disseção aórtica

D) Taquiarritmia supraventricular por reentrada

E) Síndrome coronariana aguda

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

281103)

Enunciado: Homem de 55 anos de idade com história de infarto do miocárdio há 3 meses, com dieta de estágio II, exercitando-se regularmente em programa de reabilitação cardíaca. Não fuma e a pressão arterial é de 120/80 mmHg sob terapia com betabloqueador e AAS. Apresenta colesterol total = 240 mg/dl, HDL col. = 55 mg/dl, LDL col. = 165 mg/dl e triglicérides = 100 mg/dl. Sua conduta no tratamento desse paciente é:

A) Recomendar dieta de estágio III.

B) Iniciar sinvastatina, 20 mg/dia.

C) Avaliar membros da família para descartar hipercolesterolemia familiar.

D) Encaminhar a um especialista em lipídeos.

E) Iniciar niacina, 2.000 mg/dia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

251871)

Enunciado: Qual dessas condutas não fazem parte do tratamento no atendimento inicial do infarto agudo do miocárdio:

A) Aspirina.

B) Beta-bloqueador.

C) Morfina.

D) Digitálico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

251874)

Enunciado: Não é contraindicação absoluta para uso de betabloqueador:

A) Bloqueio atrioventricular de 3º grau.

B) Pressão arterial sistólica menor que 80 mmHg.

C) Frequência cardíaca de 49 batimentos por minuto.

D) Asma.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

247161)

Enunciado: Paciente do sexo masculino, 56 anos, com antecedentes de hipertensão e dislipidemia, procura o ambulatório com dor torácica retroesternal tipo aperto que iniciou há cerca de dois meses, de forma esporádica, durante suas caminhadas matinais, associada a períodos de aumento de intensidade do exercício. Os episódios de dor tinham duração de 5 minutos e melhoravam com repouso. Há duas semanas refere que toda vez que caminha apresenta episódio de dor desencadeada por esforço menor que o habitual. Assinale a alternativa CORRETA, que classifica a dor torácica apresentada pelo paciente.

A) Angina típica e estável.

B) Angina atípica e estável.

C) Angina atípica e instável.

D) Angina típica e instável.

E) Angina de Prinzmetal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182600)

Enunciado: Correlacione CORRETAMENTE as características da dor torácica descritas abaixo com as respectivas doenças cardiovasculares. I. Dor retroesternal que irradia para a região cervical, mandíbula, epigástrio, ombros ou braços (mais comum do lado esquerdo), em opressão, queimação, aperto ou peso, com duração menor do que 2-10 minutos, desencadeada pelo esforço, frio ou "stress" emocional, aliviada pelo repouso. II. Dor que geralmente inicia sobre o esterno, ou em direção ao ápice cardíaco e pode irradiar-se para o pescoço ou ombro esquerdo, muitas vezes, mais localizada que a dor do infarto do miocárdio, tipo aguda em "facada", que pode durar muitas horas até dias, pode alternar períodos de maior e menor intensidade, piora com a inspiração profunda, rotação do tórax, ou posição supina, aliviada na posição supina, sentada ou com a inclinação anterior do tórax. III. Dor no tórax anterior, que pode irradiar-se para o dorso, lancinante em "facada", de início súbito, que geralmente ocorre na vigência de hipertensão ou em pacientes com predisposição, como na síndrome de Marfan. IV. Dor subesternal ou localizada, pleurítica ou em opressão, de início súbito, com duração de minutos e menor do que 1 hora, que pode piorar com a respiração. A. Pericardite; B. Angina pectoris; C. Embolia pulmonar; D. Dissecção aórtica.

A) I-A, II-B, III-C e IV-D.

B) I-B, II-A, III-D e IV-C.

C) I-C, II-D, III-A e IV-B.

D) I-D, II-C, III-B e IV-A.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183132)

Enunciado: Homem hipertenso de 65 anos de idade chega a seu consultório devido a início recente de desconforto torácico, que você suspeita ser angina. A pressão arterial foi devidamente controlada com tiazídico e, agora, é de 150/96 mmHg. Qual das seguintes medicações é a menos apropriada?

A) Ácido acetilsalicilico.

B) Betabloqueador.

C) Nitrato sublingual.

D) Diidropiridina de ação curta.

E) Diltiazem.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

66983)

Enunciado: Qual a medicação indicada para prevenção primária de eventos cardiovasculares (doença coronariana)?

A) Ácido acetilsalicílico 100 mg/dia.

B) Sinvastatina 40 mg/dia.

C) Enalapril 10 kg/dia.

D) Não há medicações indicadas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

37070)

Enunciado: Assinale a alternativa que apresenta o (s) critério (s) eletrocardiográfico (s) para a utilização de trombolíticos no infarto agudo do miocárdio.

A) Bloqueio do ramo esquerdo do feixe de Hiss e Bloqueio A-V de 1º grau, que existiam previamente.

B) Infradesnível do segmento ST em duas derivações contíguas > 1 milímetro.

C) Bloqueio do ramo direito novo e supradesnível do segmento ST em duas derivações contíguas > 1 milímetro.

D) Supradesnível do segmento ST ou infradesnível do segmento ST > 1 milímetro.

E) Bloqueio do ramo esquerdo novo ou supradesnível do segmento ST, > 1 milímetro em duas derivações contíguas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

29399)

Enunciado: Todas as ações abaixo são medidas de prevenção bem definidas contra Doença Coronariana, EXCETO:

A) Tratamento da Hipercolesterolemia com Estatinas.

B) Tratamento de Diabetes com Metformina.

C) Interrupção do tabagismo.

D) Prática regular de Exercícios Físicos.

E) Tratamento da Hipertensão com Ácido Acetil Salicílico (Aspirina)

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

29387)

Enunciado: Quanto ao tratamento da angina instável e do infarto agudo do miocárdio sem supra desnivelamento do segmento ST, é correto afirmar;

A) A heparina convencional é semelhante a enoxaparina no desfecho combinado morte/infarto do miocárdio, independentemente do escore de risco de TIMI. A segunda droga, entretanto, apresenta maior facilidade na forma de administração.

B) A morfina não deve ser realizada como rotina, mas habitualmente deve ser empregada em pacientes com dor persistente apesar de nitratos e betabloqueadores.

C) Os nitratos endovenosos, mas não os sublinguais, são contra-indicados se o paciente tiver feito iso de sildenafil nas últimas 24 horas.

D) A combinação de clopidogrel e aspirina, aumenta o risco de sangramento e não reduz mortalidade. Não é, portanto, indicada.

E) O trombolítico deverá ser utilizado nos casos em que haja aumento sérico das enzimas cardíacas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343222)

Enunciado: O teste de caminhada de 6 minutos (TC6min):

A) Não é avaliação validada da reserva cardiorrespiratória em adultos de alto risco e não gestantes, tanto em patologias crônicas quanto na avaliação perioperatória.

B) É avaliação validada da reserva cardiorrespiratória em adultos de alto risco e não gestantes, em patologias crônicas, mas não na avaliação perioperatória.

C) É avaliação validada da reserva cardiorrespiratória em adultos de alto risco e não gestantes, tanto em patologias crônicas quanto na avaliação perioperatória.

D) É avaliação invalidada da reserva cardiorrespiratória em adultos de alto risco e não gestantes, tanto em patologias crônicas quanto na avaliação perioperatória.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343223)

Enunciado: O estabelecimento de intervalos de referência para o TC6min em mulheres grávidas saudáveis:

A) Não permite a avaliação individual da capacidade funcional e pode ajudar a personalizar os programas de exercícios.

B) Permite a avaliação individual da capacidade funcional e pode ajudar a personalizar os programas de exercícios.

C) Permite a avaliação individual da capacidade funcional, mas não pode ajudar a personalizar os programas de exercícios.

D) Permite a avaliação individual da capacidade não funcional e pode ajudar a personalizar os programas de exercícios.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

314191)

Enunciado: Podem acontecer resultados falso-positivos, em que a CK-MB é positiva e a troponina é negativa em cerca de 4% dos pacientes. Sendo correto que:

A) Nos casos em que a CK-MB está elevada e a troponina está normal, ambas dentro de sua janela cinética, deve-se basear a decisão clínica no resultado da CK-MB.

B) Nos casos em que a CK-MB está elevada e a troponina está normal, ambas dentro de sua janela cinética, deve-se basear a decisão clínica no resultado da troponina.

C) Nos casos em que a CK-MB está elevada e a troponina está anormal, ambas dentro de sua janela cinética, deve-se basear a decisão clínica nunca no resultado da troponina.

D) Nos casos em que a CK-MB está elevada e a troponina está normal, ambas dentro de sua janela cinética, nunca se deve basear a decisão clínica no resultado da troponina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

314195)

Enunciado: Pacientes com dor torácica no setor de emergência, identificados como de risco baixo ou intermediário, tem como adequado o item:

A) Nunca podem ser submetidos ao teste ergométrico (TE), apesar do resultado normal confere risco anual baixo de eventos cardiovasculares, permitindo a alta hospitalar mais precoce e segura.

B) Podem ser submetidos ao teste ergométrico (TE), cujo resultado anormal confere risco anual baixo de eventos cardiovasculares, permitindo a alta hospitalar mais precoce e segura.

C) Podem ser submetidos ao teste ergométrico (TE), cujo resultado normal confere risco anual baixo de eventos cardiovasculares, permitindo a alta hospitalar mais precoce e segura.

D) Podem ser submetidos ao teste ergométrico (TE), cujo resultado normal confere risco anual elevado de eventos cardiovasculares, permitindo a alta hospitalar mais precoce e segura.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

314198)

Enunciado: Comparada ao escore de cálcio, a angiotomografia de coronárias está de acordo com o item correto:

A) É um exame que apresenta como vantagens a visualização de placas não calcificadas e estimativas do grau de estenose luminal.

B) É um exame que apresenta como desvantagens a visualização de placas não calcificadas e estimativas do grau de estenose luminal.

C) É um exame que apresenta como vantagens a visualização de placas não calcificadas e não estimativas do grau de estenose luminal.

D) É um exame que apresenta como vantagens a visualização de placas não calcificadas e estimativas do grau de estenose extra-luminal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

314200)

Enunciado: O uso da angiotomografia de coronárias apresenta claros benefícios, no item correto:

A) Em pacientes assintomáticos de baixo risco para DAC, tanto na emergência como no âmbito ambulatorial. Isso porque afasta a doença como causadora dos sintomas.

B) Em pacientes sintomáticos de baixo risco para DAC, na emergência, mas não no âmbito ambulatorial. Isso porque afasta a doença como causadora dos sintomas.

C) Em pacientes sintomáticos de baixo risco para DAC, tanto na emergência como no âmbito ambulatorial. Isso porque não afasta a doença como causadora dos sintomas.

D) Em pacientes sintomáticos de baixo risco para DAC, tanto na emergência como no âmbito ambulatorial. Isso porque afasta a doença como causadora dos sintomas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

313474)

Enunciado: Em relação à Síndrome Metabólica, Diabetes Mellitus e o Corolário Contínuo da Doença Arterial Coronária, pode-se considerar adequado que:

A) A SM e o DM compõem um espectro de doenças multissistêmicas, em particular do endotélio vascular, e que não contribuem dramaticamente para a progressão dos substratos fisiopatológicos da DAC.

B) A SM e o DM compõem um espectro de doenças multissistêmicas, em particular do endotélio vascular, e que contribuem pouco para a progressão dos substratos fisiopatológicos da DAC.

C) A SM e o DM não compõem um espectro de doenças multissistêmicas, em particular do endotélio vascular, e que contribuem dramaticamente para a progressão dos substratos fisiopatológicos da DAC.

D) A SM e o DM compõem um espectro de doenças multissistêmicas, em particular do endotélio vascular, e que contribuem dramaticamente para a progressão dos substratos fisiopatológicos da DAC.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

278609)

Enunciado: O critério eletrocardiográfico para IAMCST inclui elevação do segmento ST em duas derivações contíguas, sendo CORRETO de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a alternativa:

A) Acima de 1,5 mm em mulheres, acima de 2 mm em homens ? 60 anos e acima de 2,5mm em homens < 40 anos nas derivações V2-V3 e/ou acima de 1 mm nas demais derivações.

B) Acima de 1,5 mm em mulheres, acima de 2 mm em homens ? 40 anos e acima de 2,5mm em homens < 40 anos nas derivações V2-V3 e/ou acima de 1 mm nas demais derivações.

C) Acima de 1,5 mm em mulheres, acima de 2 mm em homens ? 40 anos e acima de 2,5mm em homens < 40 anos nas derivações V2-V3 e/ou acima de 2 mm nas demais derivações.

D) Acima de 2,5 mm em mulheres, acima de 2 mm em homens ? 40 anos e acima de 2,5mm em homens < 40 anos nas derivações V2-V3 e/ou acima de 1 mm nas demais derivações.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

279030)

Enunciado: A dor torácica é o principal sintoma sugestivo de Síndrome Coronária Aguda (SCA) com características da dor torácica sugestivas de isquemia miocárdica. Sendo correto que:

A) Pacientes com dor anginosa em repouso com mais de 60 minutos de duração, angina limitante de início recente e angina em crescendo (maior frequência, maior intensidade e menor limiar para aparecimento dos sintomas que o habitual) devem ser encaminhados aos serviços de emergência, já que essas características da dor são sugestivas de SCA.

B) Pacientes com dor anginosa em repouso com mais de 20 minutos de duração, angina limitante de início recente e angina em crescendo (maior frequência, maior intensidade e menor limiar para aparecimento dos sintomas que o habitual) devem ser encaminhados aos serviços de emergência, já que essas características da dor não são sugestivas de SCA.

C) Pacientes com dor anginosa em repouso com mais de 20 minutos de duração, angina limitante de início recente e angina em crescendo (maior frequência, maior intensidade e menor limiar para aparecimento dos sintomas que o habitual) devem ser encaminhados aos serviços de ambulatório de cardiologia, já que essas características da dor são sugestivas de SCA.

D) Pacientes com dor anginosa em repouso com mais de 20 minutos de duração, angina limitante de início recente e angina em crescendo (maior frequência, maior intensidade e menor limiar para aparecimento dos sintomas que o habitual) devem ser encaminhados aos serviços de emergência, já que essas características da dor são sugestivas de SCA.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

278614)

Enunciado: Os critérios para diagnóstico de IAM são aumento e/ou queda de marcadores de necrose miocárdica, preferencialmente a troponina, com pelo menos um valor acima do percentil 99 do método, indique o item correto:

A) Associado a pelo menos duas das seguintes alterações: sintomas sugestivos de isquemia, novas alterações do segmento ST, onda T ou Bloqueio de Ramo Esquerdo (BRE) novo, aparecimento de ondas Q patológicas no ECG, exame de imagem com perda de miocárdio viável ou nova alteração na contratilidade segmentar e identificação de trombo intracoronário na angiografia ou em autópsia.

B) Associado a pelo menos uma das seguintes alterações: sintomas sugestivos de isquemia, novas alterações do segmento ST, onda T ou Bloqueio de Ramo Esquerdo (BRE) antigo, aparecimento de ondas Q patológicas no ECG, exame de imagem com perda de miocárdio viável ou nova alteração na contratilidade segmentar e identificação de trombo intracoronário na angiografia ou em autópsia.

C) Associado a pelo menos uma das seguintes alterações: sintomas sugestivos de isquemia, novas alterações do segmento ST, onda T ou Bloqueio de Ramo Esquerdo (BRE) novo, aparecimento de ondas Q patológicas no ECG, exame de imagem com perda de miocárdio viável ou nova alteração na contratilidade segmentar e identificação de trombo intracoronário na angiografia ou em autópsia.

D) Associado a pelo menos uma das seguintes alterações: sintomas sugestivos de isquemia, novas alterações do segmento ST, onda T ou Bloqueio de Ramo Esquerdo (BRE) novo, aparecimento de ondas Q patológicas no ECG, exame de imagem com perda de miocárdio viável ou nova alteração na contratilidade segmentar e identificação de trombo intracoronário na angiografia exceto em autópsia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

278616)

Enunciado: A dor torácica pode não estar presente durante um episódio de SCA em até cerca de um terço dos casos. Estes pacientes podem apresentar dispneia isoladamente, náuseas, vômitos, palpitações, síncope, ou mesmo parada cardíaca. Podemos indicar como correto que:

A) Sintomas denominados equivalentes não isquêmicos normalmente acometem idosos, mulheres e pacientes diabéticos.

B) Sintomas denominados equivalentes isquêmicos normalmente acometem idosos, mulheres e pacientes diabéticos.

C) Sintomas denominados equivalentes isquêmicos nunca acometem idosos, mulheres e pacientes diabéticos.

D) Sintomas denominados equivalentes isquêmicos normalmente acometem somente pacientes diabéticos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

278681)

Enunciado: No Brasil, país de dimensão continental e grande diversidade social e econômica, dentre as inúmeras barreiras ao acesso à Reabilitação Cardiovascular - RCV, podemos assim aceitar a alternativa abaixo como correta.

A) Programas de Reabilitação Cardiovascular Domiciliar (RCVD), em que a maioria das sessões ocorre no ambiente domiciliar sob supervisão indireta, não são alternativas aos programas tradicionais, nos quais as sessões são sempre realizadas sob supervisão direta ou presencial.

B) Programas de Reabilitação Cardiovascular Domiciliar (RCVD), em que a maioria das sessões ocorre no ambiente domiciliar sob supervisão indireta, surgem como complemento ou alternativa aos programas tradicionais, nos quais as sessões são sempre realizadas sob supervisão direta ou presencial.

C) Programas de Reabilitação Cardiovascular Domiciliar (RCVD), em que a maioria das sessões ocorre no ambiente domiciliar sob supervisão indireta, surgem como complemento ou alternativa aos programas tradicionais, nos quais as sessões são sempre realizadas sob supervisão indireta.

D) Programas de Reabilitação Cardiovascular Domiciliar (RCVD), em que a maioria das sessões ocorre no ambiente domiciliar sob supervisão indireta, surgem como complemento, mas nunca como uma alternativa aos programas tradicionais, nos quais as sessões são sempre realizadas sob supervisão direta ou presencial.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

252879)

Enunciado: Homem, 66 anos de idade, da entrada na UPA queixando-se de desconforto precordial em aperto, há cerca de três semanas, inicialmente aos grandes esforços e, nos últimos dias, mesmo aos pequenos esforços. No momento, queixa-se de dor grau 7/10 em repouso. É portador de Diabetes Mellitus tipo 2 e de hipertensão, em uso de metformina, losartana e ácido acetilsalicílico, além de tabagista de 20 anos/maço. Ao exame físico, encontra-se em regular estado geral, com fácies de dor. PA: 200x120mmHg, FC: 100bpm, SatO? 94%, IMC: 33Kg/m². Ausculta cardiorrespiratória e exame abdominal sem alterações. Extremidades bem perfundidas, sem edemas, com pulsos simétricos. Realizado eletrocardiograma com achado de alterações da repolarização ventricular em V1 a V3 e ondas T positivas e simétricas em V5 e V6. Marcadores de necrose miocárdica da entrada negativos. Diante do quadro, indique o diagnóstico mais adequado para este paciente nesse momento.

A) Emergência hipertensiva associada a síndrome coronariana aguda sem supra de ST.

B) Angina instável associada a pseudocrise hipertensiva, devido à dor.

C) Urgência hipertensiva associada a infarto agudo do miocárdio sem supra de ST.

D) Emergência hipertensiva associada a dissecção aguda de aorta.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

252880)

Enunciado: Homem, 66 anos de idade, dá entrada na UPA queixando-se de desconforto precordial em aperto, há cerca de três semanas, inicialmente aos grandes esforços e, nos últimos dias, mesmo aos pequenos esforços. No momento, queixa-se de dor grau 7/10 em repouso. É portador de diabetes mellitus tipo 2 e de hipertensão, em uso de metformina, losartana e ácido acetilsalicílico, além de tabagista de 20 anos/maço. Ao exame físico, encontra-se em regular estado geral, com fácies de dor. PA: 200 x 120 mmHg, FC: 100 bpm, SatO? 94%, IMC: 33 kg/m². Ausculta cardiorrespiratória e exame abdominal sem alterações. Extremidades bem perfundidas, sem edemas, com pulsos simétricos. Realizado eletrocardiograma com achado de alterações da repolarização ventricular em V1 a V3 e ondas T positivas e simétricas em V5 e V6. Marcadores de necrose miocárdica da entrada negativos. Indique a conduta diagnóstica mais adequada nesse caso.

A) Teste ergométrico, dentro das próximas 6 horas.

B) Cintilografia de perfusão miocárdica, dentro de 72 horas.

C) Cineangiocoronariografia, nas próximas 48 horas.

D) Cineangiocoronariografia, nos próximos 30 minutos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

252881)

Enunciado: Homem, 66 anos de idade, da entrada na UPA queixando-se de desconforto precordial em aperto, há cerca de três semanas, inicialmente aos grandes esforços e, nos últimos dias, mesmo aos pequenos esforços. No momento, queixa-se de dor grau 7/10 em repouso. É portador de Diabetes Mellitus tipo 2 e de hipertensão, em uso de metformina, losartana e ácido acetilsalicílico, além de tabagista de 20 anos/maço. Ao exame físico, encontra-se em regular estado geral, com fácies de dor. PA: 200x120mmHg, FC: 100bpm, SatO? 94%, IMC: 33Kg/m². Ausculta cardiorrespiratória e exame abdominal sem alterações. Extremidades bem perfundidas, sem edemas, com pulsos simétricos. Realizado eletrocardiograma com achado de alterações da repolarização ventricular em V1 a V3 e ondas T positivas e simétricas em V5 e V6. Marcadores de necrose miocárdica da entrada negativos. Indique o tratamento farmacológico mais adequado para esse paciente.

A) Ácido acetilsalicílico, clopidogrel, nitroglicerina, morfina, metoprolol, atorvastatina.

B) Ácido acetilsalicílico, clopidogrel, nitroglicerina, heparina não fracionada, alteplase, metoprolol.

C) Clopidogrel, nitroprussiato de sódio, heparina não fracionada, abciximab, metoprolol, atorvastatina.

D) Ácido acetilsalicílico, nitroprussiato de sódio, morfina, heparina não fracionada, metoprolol, enalapril.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

249193)

Enunciado: Nos pacientes com alto risco de sangramento e baixo risco isquêmico, deve-se introduzir diretamente dupla terapia com anticoagulante e clopidogrel desde o início. Nesse contexto, o item com erro é:

A) Quando houver alto risco isquêmico e também alto risco hemorrágico, recomenda-se que se use tripla terapia por, no máximo, um mês ou inicie-se diretamente dupla terapia com anticoagulante e clopidogrel.

B) O uso de inibidores de bombas de prótons como profilaxia de úlcera de estresse nesse grupo de pacientes nunca deve ser considerado como primeira escolha devido ao risco elevado de sangramento gastrintestinal.

C) A descontinuação do tratamento antiplaquetário deve ser considerada após 12 meses.

D) A avaliação da necessidade de manutenção da anticoagulação e o cálculo do risco de sangramento devem ser realizados em todos os pacientes através dos escores de CHA2DS2-VASc e HAS-BLED.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

249399)

Enunciado: Escolar, sexo masculino, 8 anos, está frequentando a escolinha de futebol de areia do Pelezão. A principal orientação durante a atividade física é hidratar com:

A) Energéticos a cada 30 minutos.

B) Isotônicos a cada 30 minutos.

C) Água normal a cada 20 minutos.

D) Guaraná com açaí a cada 30 minutos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215198)

Enunciado: O estudo que comparou clopidogrel versus AAS em pacientes com risco de isquemia, tendo demonstrado uma redução significativa do número total de readmissões para eventos isquêmicos. NÃO podemos, apenas, concordar que:

A) Naqueles pacientes que apresentam alergia ao AAS ou intolerância gástrica, o clopidogrel pode ser considerado uma alternativa.

B) Redução de novas hospitalizações foi consistente em todos os resultados individuais de angina, ataque isquêmico transitório, isquemia de membros e sangramento.

C) Clopidogrel não resultou em diminuição em desfecho combinado de morte vascular, AVC, infarto do miocárdio ou nova hospitalização para eventos isquêmicos ou sangramento em comparação com o AAS.

D) Dessa forma clopidogrel pode ser usado como alternativa ao AAS em intolerantes.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215272)

Enunciado: Quanto à indicação da terapia antiplaquetária nos pacientes de muito alto risco, incluindo aqueles com Doença Aterosclerótica Clínica (DACL) e eventos cardiovasculares prévios (prevenção secundária), o benefício é estabelecido em diversos estudos, o AAS (ou outro antiplaquetário):

A) Foi protetor na maioria dos pacientes com risco aumentado de eventos vasculares, incluindo aqueles com IAM ou AVC isquêmico, bem como outras doenças vasculares prévias.

B) Não foi protetor na maioria dos pacientes com risco aumentado de eventos vasculares, incluindo aqueles com IAM ou AVC isquêmico, bem como outras doenças vasculares prévias.

C) Foi protetor na maioria dos pacientes com risco aumentado de eventos não vasculares, incluindo aqueles com IAM ou AVC isquêmico, bem como outras doenças vasculares prévias.

D) Foi protetor na maioria dos pacientes com risco aumentado de eventos vasculares, excluindo aqueles com IAM ou AVC isquêmico, bem como outras doenças vasculares prévias.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

212227)

Enunciado: Paciente de 58 anos, sexo feminino, portadora de hipertensão, dislipidemia e obesidade, evoluiu de forma súbita com quadro de dor torácica, em aperto, de forte intensidade, náuseas e sudorese. Atendida imediatamente ao chegar ao hospital de emergência, realizou eletrocardiograma e foi colhido o sangue para avaliação dos marcadores de necrose miocárdica. Cardiologista avaliou o resultado do eletrocardiograma e a paciente foi diagnosticada com infarto agudo do miocárdio com supradesnível de ST (IAMST). As primeiras medidas terapêuticas foram iniciadas e a reperfusão coronariana indicada. Uma das medidas terapêuticas na fase aguda do IAMST consiste em iniciar o inibidor da enzima conversora de angiotensina (IECA). Assinale a alternativa que apresenta uma contraindicação ao uso dos IECAS.

A) Hemofilia.

B) DPOC grave.

C) Úlcera péptica em atividade.

D) Estenose bilateral da artéria renal.

E) Uso de inibidores da fosfodiesterase nas últimas 24 h.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183029)

Enunciado: Em discussão com amigos nesse final de semana, você foi questionado sobre treinamento de emergência para pessoal que não fosse da saúde. Assim, explicou que a importância da FV como mecanismo de óbito precoce e a habilidade na ressuscitação e na desfibrilação foram os fatores que propiciaram o desenvolvimento de programas de tratamento pré-hospitalar do IAM. Estando INCORRETO, apenas, que

A) se estima que a desfibrilação salve cerca de seis vezes mais vidas que o tratamento trombolítico, mas depende de sua rápida aplicação ao paciente.

B) o impacto potencial, em termos de benefício, ao se intervir na fase pré-hospitalar no IAM, reforça a necessidade de programas.

C) identificar o perfil dos casos de IAM que não chegam aos hospitais, qualificando o estado atual de atendimento e quantificando o impacto de uma nova estratégia de grande difusão na população.

D) fornecer maior informação à população quanto aos sintomas de IAM e a importância de uma busca rápida por auxílio médico. Realizar treinamento restrito, apenas à saúde, para atendimento de urgência nos moldes do BLS, a fim de evitar erros.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182733)

Enunciado: A fisiopatologia do IAM perioperatório difere um pouco da do IAM espontâneo. Considerando os Testes Não Invasivos para Detecção de Isquemia Miocárdica, o entendimento do Eletrocardiograma de Esforço apenas NÃO é compatível com a seguinte alternativa.

A) No IAM perioperatório, a ruptura de placa ocorre em aproximadamente 90% dos casos.

B) No IAM perioperatório se dá, também, por um desequilíbrio prolongado entre a redução da oferta de oxigênio para o miocárdio (anemia, baixo fluxo etc.) e o aumento da demanda arterial coronariana (taquicardia e hipertensão).

C) O TE é uma ferramenta segura, útil e eficaz para a detecção de isquemia miocárdica, tendo justamente como mecanismo produzir este desbalanço entre oferta e demanda.

D) A detecção de anormalidades durante sua execução dos testes de esforços possa ser reprodutível durante o perioperatório e seus variados níveis de estresse.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183053)

Enunciado: Órgãos governamentais de saúde e o sistema privado de saúde suplementar devem criar e manter um plano regional de atendimento emergencial integrado de pacientes com IAMCST, como o já existente em vários países. Podemos apenas concordar que, as terapias recomendadas na fase pré-hospitalar

A) são baseadas em estudos realizados em pacientes pré-hospitalares. Desse modo, deve ser feita por equipe capacitada e treinada.

B) são quase todas empíricas e baseadas em estudos realizados em pacientes hospitalizados. Embora o cenário seja diferente, a circunstância clínica é a mesma: IAM. Trata-se, desse modo, de uma extrapolação coerente, que, naturalmente, deve ser feita por equipe capacitada e treinada.

C) são quase todas empíricas e baseadas em estudos realizados em pacientes hospitalizados. Embora o cenário seja diferente, a circunstância clínica é a mesma: IAM. Trata-se, desse modo, de uma extrapolação incoerente, que, naturalmente, não deve ser feita por equipe capacitada e treinada.

D) são quase todas empíricas e baseadas em estudos realizados em pacientes hospitalizados. Embora o cenário seja igual, a circunstância clínica é diferente do IAM. Trata-se, desse modo, de uma extrapolação coerente, que, naturalmente, deve ser feita por equipe capacitada e treinada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182742)

Enunciado: O Teste de Esforço TE é uma ferramenta segura, útil e eficaz para a detecção de isquemia miocárdica, tendo justamente como mecanismo produzir este desbalanço entre oferta e demanda. Somente sendo INCORRETO que,

A) assim, é razoável pensar que a detecção de anormalidades durante sua execução possa ser reprodutível durante o perioperatório e seus variados níveis de estresse.

B) não há evidências de que usar esta estratégia para todos os pacientes resulte na redução de eventos cardiovasculares perioperatórios.

C) também deve se considerar que, quanto maior a prevalência da doença coronária em determinada população, menor será também o valor preditivo positivo do TE.

D) considerando que o objetivo da estratificação do risco é reduzir o risco perioperatório, não seria lógica a realização do teste em uma população já estratificada como de baixo risco pelos algoritmos recomendados.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183060)

Enunciado: A administração de oxigênio é rotineira no atendimento a um paciente com IAM, garantindo, assim, uma melhor chance de sobrevida aos pacientes. Somente podemos CONCORDAR que

A) administração de oxigênio é indicada somente em pacientes com saturação de oxigênio < 90%, congestão pulmonar ou na presença de desconforto respiratório.

B) quando utilizada de forma necessária, a administração de oxigênio por tempo prolongado pode causar vasoconstrição sistêmica, e aumento da resistência vascular sistêmica e da pressão arterial, reduzindo o débito cardíaco, sendo, portanto, prejudicial.

C) quando utilizada de forma desnecessária, a administração de oxigênio por tempo prolongado pode causar vasoconstrição sistêmica e aumento da resistência vascular sistêmica e da pressão arterial, reduzindo o débito cardíaco, sendo, portanto, prejudicial.

D) quando utilizada de forma desnecessária, a administração de oxigênio por tempo prolongado pode causar vasoconstrição sistêmica e redução da resistência vascular sistêmica e da pressão arterial, aumentando o débito cardíaco, sendo, portanto, prejudicial.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182749)

Enunciado: A ecocardiografia sob estresse é precisa e segura em identificar pacientes com doença arterial coronária, com importante papel como preditor de eventos cardíacos. Somente sendo INCORRETO que,

A) as ecocardiografias sob estresse pela dobutamina e pelo exercício apresentam acurácia diagnóstica semelhantes e superiores ao estresse com dipiridamol.

B) caso um ecocardiograma sob estresse pela dobutamina demonstre isquemia residual no paciente com infarto prévio, o prognóstico é bom, e a probabilidade de reinfarto, morte e edema agudo pulmonar é baixa no período transoperatório de uma cirurgia não cardíaca.

C) o uso da ecocardiografia sob estresse pela dobutamina na avaliação do risco perioperatório já está bem documentado na literatura.

D) comparando a cintilografia de perfusão miocárdica e a ecocardiografia sob estresse pela dobutamina na estratificação de risco vascular antes cirurgia, foi demonstrado que o valor prognóstico das anormalidades em ambas as modalidades de imagens para eventos isquêmicos perioperatórios é semelhante.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183067)

Enunciado: O diagnóstico e a caracterização das regiões de IAM pela Ressonância Magnética Cardiovascular RMC baseiam-se na técnica do

realce tardio. Podemos, apenas, concordar que

A) a capacidade de identificação da presença e da extensão das regiões de infarto, da presença ou não de obstrução microvascular, da área peri-nfarto e da contratilidade regional faz da RMC uma ferramenta cada vez mais importante, não apenas na avaliação diagnóstica, mas também na avaliação prognóstica dos pacientes.

B) a capacidade de identificação da presença e da extensão das regiões de infarto, da presença ou não de obstrução microvascular, da área peri-infarto e da contratilidade regional faz da RMC uma ferramenta cada vez mais importante, apenas na avaliação diagnóstica.

C) a capacidade de identificação da presença e da extensão das regiões de infarto, da presença ou não de obstrução microvascular, da área peri-infarto e da contratilidade regional faz da RMC uma ferramenta cada vez mais importante, apenas na avaliação prognóstica dos pacientes.

D) a incapacidade de identificação da extensão das regiões de infarto, mas sim da presença ou não de obstrução microvascular, da área peri-infarto e da contratilidade regional faz da RMC uma ferramenta cada vez mais importante, apenas na avaliação

diagnóstica, mas não na avaliação prognóstica dos pacientes.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182758)

Enunciado: Quando analisamos a Angiografia Coronária por Tomografia Computadorizada, podemos apenas CONCORDAR com o seguinte:

A) A angiotomografia (angio-TC) de coronárias tem sido utilizada de forma crescente na avaliação de pacientes sem suspeita de coronariopatias. Ela apresenta alta sensibilidade para a detecção de estenose coronariana, incluindo doença multiarterial e lesão em tronco de coronária esquerda.

B) A angiotomografia (angio-TC) de coronárias tem sido utilizada de forma crescente na avaliação de pacientes com suspeita de coronariopatias. Ela apresenta baixa sensibilidade para a detecção de estenose coronariana, incluindo doença multiarterial e lesão em tronco de coronária esquerda.

C) A angiotomografia (angio-TC) de coronárias tem sido utilizada de forma crescente na avaliação de pacientes com suspeita de coronariopatias. Ela apresenta alta sensibilidade para a detecção de estenose coronariana, excluindo doença multiarterial e lesão em tronco de coronária esquerda.

D) A angiotomografia (angio-TC) de coronárias tem sido utilizada de forma crescente na avaliação de pacientes com suspeita de coronariopatias. Ela apresenta alta sensibilidade para a detecção de estenose coronariana, incluindo doença multiarterial e lesão em tronco de coronária esquerda.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182769)

Enunciado: O aumento da sensibilidade dos kits disponíveis das troponinas propiciou uma maior acurácia e rapidez no diagnóstico ou não do IAM em pacientes com dor torácica na sala de emergência. Somente NÃO sendo correto que,

A) no perioperatório de operações não cardíacas, as evidências científicas disponíveis não incluem todas as troponinas (I e T) e nem todos os métodos utilizados para sua dosagem apresentam limites de detecção e valores de referência diferentes.

B) o limite de detecção significa o máximo valor que é detectado pelo método.

C) o valor de referência da normalidade é determinado utilizando o percentil 99, que é obtido realizando-se o exame em uma população normal e, significa que, 99% dos indivíduos normais apresentam valores abaixo deste cut-off.

D) os kits de troponina podem ser classificados em baixa (convencionais), média (contemporâneos ou sensíveis) ou alta sensibilidade. Esta classificação é baseada na porcentagem de indivíduos saudáveis em que a troponina pode ser detectada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182819)

Enunciado: Na Pericardite, o processo inflamatório decorrente da epicardite subjacente nos ventrículos é o responsável pelas seguintes alterações eletrocardiográficas, EXCETO

A) pela onda T: na fase inicial, apresenta-se pouco aumentada e assimétrica.

B) pela onda T: caracteristicamente não apresenta inversão enquanto ocorrem manifestações de elevação do ST.

C) que pode apresentar inversão de T na fase crônica da doença, após a normalização do ST.

D) quando esta ocorre inversão de T, raramente é profunda o suficiente para assemelhar-se ao padrão da onda T isquêmica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182738)

Enunciado: Amostra de sangue para avaliação do perfil lipídico deve ser obtida nas primeiras 24 horas da admissão de todos os pacientes com síndrome coronariana aguda (SCA). Sendo INADEQUADO, apenas, o seguinte:

A) após este período, comumente ocorre aumento de TG e diminuição do LDL-C e do HDL-C, modificações que podem permanecer por cerca de um a três meses.

B) recomenda-se a instituição precoce do tratamento com altas doses de estatina entre o primeiro e o quarto dia da SCA, preferencialmente atorvastatina na dose 80 mg.

C) pacientes indicados para intervenção percutânea e angioplastia podem experimentar benefício adicional quando a dose de estatina for administrada até 12 horas antes do procedimento.

D) a dose de estatina apropriada para manter o LDL-C na meta terapêutica (< 100 mg/dl) deverá ser mantida .

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183101)

Enunciado: As doenças e as respostas inflamatórias do pericárdio podem ocorrer de distúrbios comuns e incomuns. Das patologias citadas abaixo, qual não entra nas possíveis etiologias de pericardite e derrame pericárdico?

A) Artrite reumatóide.

B) Granulomatose de Wegener.

C) Diabetes insipidus.

D) Hipotireoidismo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

187849)

Enunciado: Considerando a terapia clinica do infarto agudo do miocárdio com supra-desnivelamento do segmento-ST, assinale a alternativa ERRADA:

A) O ácido acetilsalicílico deve ser utilizado com dose de ataque de 200mg a 300mg e o clopidogrel com dose de ataque de 300mg a 600mg, não sendo necessária a suspensão para execução da trombólise.

B) Os betabloqueadores reduzem o consumo miocárdico de oxigênio pela redução da frequência cardíaca, da pressão arterial e pela contratilidade. Podem ser utilizados por via oral ou venosa, devendo ser evitado na presença de sinais de choque.

C) Os bloqueadores dos canais de cálcio, verapamil e diltiazem, podem ser utilizados em associação aos betabloqueadores para melhor controlar a resposta ventricular de arritmias.

D) Os inibidores da enzima conversora de angiotensina não devem ser utilizados em pacientes com pressão sistólica menor que 100mmHg ou com redução de 30mmHg em relação ao valor basal

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161318)

Enunciado: Paciente masculino, 47 anos de idade, apresentou dor torácica em aperto acompanhado de mal-estar, diaforese e dispneia de início há duas horas, nessa manhã de segunda-feira. Podemos assim determinar que:

A) ácido acetilsalicílico é o único anti-inflamatório indicado rotineiramente para todos os pacientes com suspeita de IAM, eventualmente como automedicação.

B) pacientes com maior risco de doença coronária devem ser instruídos a tomar ácido acetilsalicílico (AAS) tamponado em
situações emergenciais.

C) é o antiplaquetário de eleição a ser utilizado no IAM, tendo sido demonstrado que sua redução na mortalidade é muito menor que o da trombólise química.

D) não tem ação sinérgica com o próprio fibrinolítico, levando à associação de ambos ao aumento da mortalidade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161275)

Enunciado: Paciente procurou Pronto-socorro com intensa dor torácica e dispneia de início nesta manhã. Refere ser hipertenso e tabagista. Seu ECG demonstra supra de segmento ST de 3 mm nas derivações D2 e D3. Marque a opção que NÃO influencia na mortalidade, nesse caso.

A) Ausculta cardíaca.

B) Ausculta pulmonar.

C) Alterações à direita.

D) Local da dor torácica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161325)

Enunciado: A abordagem de pacientes acometidos por Insuficiência Coronariana Aguda deve contemplar diversos tratamentos coadjuvantes a fim de melhorar o prognóstico da lesão em evolução. Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA.

A) A recomendação atual é de se utilizar o betabloqueador por via oral nas primeiras 24 horas.

B) Recomenda-se iniciar o betabloqueador e titular sua dose para um alvo de 50 batimentos por minutos.

C) Recomenda-se iniciar o betabloqueador e titular sua dose para um alvo de 70 batimentos por minutos.

D) A utilização de betabloqueador endovenoso deve ser feita sem maiores critérios ou cuidados, pois é pouco associada com

complicações.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

158813)

Enunciado: Paciente J.T.A., 25 anos, sexo masculino, deu entrada na emergência com quadro de dispneia aos pequenos esforços, ascite e edema de membros inferiores. Ao exame físico: ausculta pulmonar normal; avaliação cardiológica: ritmo cardíaco regular e um ruído diastólico mitral de +++/4+, definido como estalido protodiastólico (?Knock? pericárdico); Fc: 92bpm; PA: 110 x 60 mmHg. Presença de turgência de jugular. Abdome: globoso, flácido, doloroso à palpação de hipocôndrio direito, sem sinais de irritação peritoneal. Piparote positivo. Fígado palpável 5 cm do rebordo costal direito. Extremidades: presença de edema (+/4+) em membros inferiores. Realizou raio-X de tórax que evidenciou área cardíaca normal e calcificação por todo o pericárdio, que permitiu realizar o diagnóstico de pericardite constritiva. No nosso meio, qual a principal causa de pericardite constritiva?

A) Tuberculose.

B) Esclerodermia.

C) Artrite reumatoide.

D) Infarto agudo do miocárdio.

E) Lúpus eritematoso sistêmico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161208)

Enunciado: Paciente foi atendido, no setor de emergência nesta manhã, de acordo com a última atualização a respeito de IAM. Diante dessa situação, indique a opção CORRETA.

A) É indicada administração de oxigênio rotineira em pacientes com saturação de oxigênio < 90%, congestão pulmonar ou na presença de desconforto respiratório.

B) A analgesia deve ser feita de preferência com sulfato de morfina endovenosa, exceto para pacientes alérgicos a esse fármaco, na dose inicial de 2 a 8 mg (geralmente suficiente para aliviar a dor e a ansiedade). Com a monitorização da pressão arterial, essas doses podem ser repetidas em intervalos de 3 minutos.

C) Os Anti-inflamatórios Não Esteroides (AINES) não devem ser utilizados na vigência de IAM e, se o paciente que apresenta esse diagnóstico fizer uso crônico de AINES, este deve ser suspenso. O único anti-inflamatório indicado rotineiramente para todos os pacientes com suspeita de IAM é o Ácido Acetilsalicílico.

D) Nitratos podem ser utilizados somente na formulação sublingual (nitroglicerina, mononitrato de isossorbida ou dinitrato de isossorbida), para reversão de eventual espasmo e/ou para alívio da dor anginosa. Também estão recomendados para controle da hipertensão arterial ou alívio da congestão pulmonar, se presentes.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161126)

Enunciado: Paciente masculino, 59 anos de idade, internado, na sala de emergência do hospital onde você se encontra de plantão, com diagnóstico de Insuficiência Coronariana. Ele apresentou, novamente de madrugada, intensa dor torácica, sendo então solicitado que você o avaliasse novamente. Diante de tal quadro clínico, aponte a conduta CORRETA.

A) Tratamento da dor não diminui o consumo de oxigênio pelo miocárdio isquêmico, provocado pela ativação do sistema nervoso simpático.

B) A analgesia deve ser feita de preferência com sulfato de morfina oral, exceto para pacientes alérgicos a esse fármaco, na dose inicial de 2 a 8 mg (geralmente suficiente para aliviar a dor e a ansiedade). Com a monitorização da pressão arterial, essas doses podem ser repetidas em intervalos de 5 a 15 minutos.

C) Analgesia com morfina pode ser substituído pelo sulfato de Meperidina.

D) Alguns estudos iniciais sugerem que a atividade dos novos antiplaquetários, prasugrel e ticagrelor, tenham sua atividade aumentada em pacientes que receberam morfina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161136)

Enunciado: Logo ao chegar ao Hospital, você foi solicitado para avaliar um paciente que já estava internado há 5 dias com diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio; já havia sido liberado da Unidade Coronariana, mas como apresentava ainda dificuldade de controle da Pressão Arterial, necessitava de constante intervenção, mesmo estando na enfermaria. Relacionado a essa situação, aponte a alternativa contendo a conduta CORRETA.

A) Nitratos não podem ser utilizados na formulação sublingual (nitroglicerina, mononitrato de isossorbida ou dinitrato de isossorbida) para reversão de eventual espasmo e/ou para alívio da dor anginosa, nesse caso somente venosos.

B) Nitratos estão recomendados para controle da hipertensão arterial ou alívio da congestão pulmonar, se presentes.

C) Estão contraindicados (nitratos) na presença de hipotensão arterial (Pressão Arterial Sistólica ? PAS < 110 mmHg).

D) Estão contraindicados (nitratos) quando houver suspeita de comprometimento de Parede Inferior.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152657)

Enunciado: A angina pectoris instável é conhecida como angina de:

A) Korotkoff.

B) Prinzmetal.

C) Simmers.

D) Blomberg.

E) NDA.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161400)

Enunciado: Dentro da análise estatística e epidemiológica das relações da sobreposição de doenças como o Diabetes, a Hipertensão Arterial e a Arteriosclerose, aponte a alternativa INCORRETA.

A) A frequência de hipertensão mascarada pode ser maior no DM do que em indivíduos sem DM, e a incidência de desfechos cardiovasculares é maior nesses pacientes, quando não tratados.

B) A apresentação clínica da DAC pode ser de dor anginosa típica ou atípica, mas a ausência de sintomas é muito raro.

C) Além disso, a DAC nesses pacientes tem pior prognóstico, com menor sobrevida em curto prazo, maior risco de recorrência e pior resposta aos tratamentos propostos.

D) A letalidade do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) em pacientes com DM é duas vezes maior do que naqueles sem DM, em razão da maior frequência de complicações como IC, reinfarto e morte súbita.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161194)

Enunciado: O impacto estatístico de um Eletrocardiograma (ECG), executado no local de atendimento inicial do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e interpretado por um médico habilitado (no local ou em local remoto), mostrou ser um método que

A) reduz em 70% o tempo porta-agulha.

B) reduz em 50% o tempo porta-balão.

C) proporciona menores taxas de tempo porta-balão ideal.

D) leva a tendência à redução de mortalidade intra-hospitalar em pacientes com IAMCST.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161412)

Enunciado: Existem razões pelas quais se devem desenvolver uma estratégia preventiva para a prática clínica, promovendo a reabilitação cardiovascular. Aponte a alternativa INCORRETA referente a esse caso.

A) A aterosclerose se desenvolve de forma insidiosa durante décadas e suas manifestações clínicas só se fazem notar nos estágios avançados da doença.

B) Em sua maior parte, as DCVs possuem uma estreita relação com estilo de vida, assim como com fatores fisiológicos e bioquímicos não modificáveis.

C) As modificações dos fatores de risco, promovidas pela RCV, reduzem a morbimortalidade por DCV, sobretudo para os indivíduos classificados como de alto risco.

D) A carga das DCVs tem crescido nas últimas décadas, paralelamente ao incremento da prevalência de fatores de risco.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134813)

Enunciado: A necessidade de doses cada vez maiores e a perda de eficiência da medicação anti-hipertensiva e antianginosa das famílias dos ditos nitratos, está MELHOR explicada pela afirmativa:

A) Filtração renal.

B) Metabolismo hepático.

C) Metabolismo endotelial.

D) Resistência cárdica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134119)

Enunciado: Paciente masculino de 54 anos de idade deu entrada na sala de emergência com dor torácica intensa, sudorese e mal-estar. Seu exame físico apresenta ausculta pulmonar normal, ausculta cardíaca com B3. Sua PA 130 x 60 mm Hg, FC 89 bpm, Saturação de 95% ao ar ambiente. Ao solicitar ECG, demonstramos supra de ST em V1, V2, V3 com 3 mm. Dentro das várias condutas a serem tomadas nesse caso, podemos afirmar que o uso de Oxigênio:

A) Mostra-se indicado pela saturação abaixo de 99%.

B) Somente seria indicado caso a saturação fosse abaixo de 94%.

C) Pode ser administrado sem riscos.

D) Nunca deve ser utilizado no quadro de IAM.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134804)

Enunciado: Paciente durante consulta refere intensa dor precordial, logo após subir pequeno lance de escada para trabalhar. Em sua história refere ser fumante e hipertenso leve. Exame físico demonstra galope de B3 bem como fascie de dor além de sudorese fria e pegajosa. Então, é solicitado ECG. O ECG demonstra corrente de lesão com supra de 2 mm no segmento ST nas seguintes derivações DII, DIII e aVF. Podemos, assim, AFIRMAR que:

A) Trata-se de infarto agudo do miocárdico do ventrículo direito.

B) A coronariana envolvida provavelmente é a descente anterior.

C) Esse supra é imagem em espelho de parede posterior.

D) Nesse caso, podemos utilizar, a princípio, nitratos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134033)

Enunciado: Paciente com queixa de dor epigástrica, sudorese e mal-estar, de início há alguns minutos, procura o hospital e realiza ECG que demonstra supra do seguimento ST nas seguintes derivações: D2, D3 e aVF, tendo 3 mm. Ao realizar a prescrição na sala de emergência, você, como médico, lembra que nitratos são contraindicados quando ocorre uma das seguintes situações, EXCETO por uma das alternativas. Aponte-a.

A) Uso prévio de sildenafil ou similares, nas últimas 24 horas.

B) Quando houver suspeita de comprometimento do Ventrículo Direito.

C) Pressão Arterial Sistólica ? PAS < 90 mmHg.

D) Suspeita de IAM inferior.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

131404)

Enunciado: São fatores de risco para doença coronariana, EXCETO:

A) Fumo, sedentarismo e história familiar de IAM.

B) Fumo, diabetes e varizes de MMII.

C) Diabetes, hipertensão e sedentarismo.

D) Hipercolesterolemia e diabetes.

E) NDA.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

110052)

Enunciado: Paciente do sexo feminino, 65 anos, admitida com Infarto Agudo do Miocárdio, antecedente de Osteoartrite em uso crônico de anti-inflamatórios não esteroidais. Com relação ao uso desta classe de medicamentos no Infarto, é CORRETO afirmar que deve ser:

A) mantida, pois não aumenta os riscos cardiovasculares, porém há necessidade de associação do Ácido Acetilsalicílico para a prevenção de reinfarto.

B) mantida, pois não aumenta os riscos cardiovasculares e não há necessidade de associação do Ácido Acetilsalicílico para a prevenção de reinfarto, pois se trata da mesma classe farmacológica.

C) suspensa pelo risco aumentado de hipertensão, reinfarto e mortalidade, e introduzido o Ácido Acetilsalicílico.

D) suspensa pelo risco aumentado de Gastrite e Úlcera Gástrica se utilizado em conjunto com o Ácido Acetilsalicílico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

110598)

Enunciado: Paciente de 62 anos de idade, é atendido na Unidade de Emergência, com história de dor lancinante, extremamente súbita em região precordial, irradiada ao dorso. Ao chegar, estava pálido, taquicárdico, Pressão Arterial de 180 x 110 mmHg, com sopro de regurgitação no foco aórtico e estertores em bases pulmonares. Pulsos periféricos diminuídos em MMIIS. Em relação ao caso, NÃO devemos introduzir imediatamente:

A) Nitroprussiato de sódio.

B) Derivados da morfina.

C) Beta-bloqueadores.

D) Nitratos.

E) Bloqueadores da enzima conversora.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

110608)

Enunciado: A Síndrome metabólica é descrita como:

A) Obesidade abdominal (acima de 102 cm no homem e 88 cm na mulher), hipertrigliceridemia (acima de 150 mg/dl), baixos níveis de HDL-colesterol (menor que 40 mg/dl nos homens e 50 mg/dl nas mulheres) e hipertensão arterial (PA maior ou igual a 130 x 85 mmHg).

B) IMC acima de 35 nas mulheres e 38 nos homens. Associado a: hiperglicemia de jejum (acima de 126 mg/dl), hipertrigliceridemia (acima de 150 mg/dl) e hipertensão arterial (PA maior ou igual a 130 x 85 mmHg).

C) Obesidade abdominal (acima de 102 cm no homem e 88 cm na mulher), hipertrigliceridemia (acima de 180 mg/dl), baixos níveis de HDL-colesterol (menor que 40 mg/dl nos homens e 50 mg/dl nas mulheres), hiperglicemia de jejum (acima de 118 mg/dl) e hipertensão arterial (PA maior ou igual a 130 x 85 mmHg).

D) Hipertensão arterial (PA maior que 130 x 85 mmHg), hipertrigliceridemia (acima de 180 mg/dl), baixos níveis de HDL-colesterol (menor que 40 mg/dl nos homens e 50 mg/dl nas mulheres), hiperglicemia de jejum (acima de 118 mg/dl) e obesidade.

E) Hiperglicemia de jejum (acima de 126 mg/dl), hipertrigliceridemia (acima de 150 mg/dl), hipertensão arterial (PA maior ou igual a 130 x 85 mmHg) e obesidade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

86610)

Enunciado: As afirmativas abaixo incluem uma série de medidas sobre o manejo inicial de pacientes com síndromes coronarianas agudas. Assinale a alternativa correta: (compêndio de UTI).

I ? O uso da nitroglicerina está contraindicado em pacientes que fizeram uso de inibidor, da fosfodiesterase para disfunção erétil nas últimas 24 horas. II ? As tienopiridinas utilizadas como antiagregantes plaquetários, são drogas que bloqueiam de forma irreversível os receptores de superfície envolvidos na agregação plaquetária induzida pelo ADP. III ? os ?-bloqueadores não são recomendados para o infarto do miocárdio induzido pela cocaína em virtude do potencial do agravamento do vasoespasmo coronariano pela atividade sem oposição dos receptores ?.

A) Apenas afirmativa II está correta.

B) Apenas afirmativas I, II estão corretas.

C) Apenas afirmativas I, III estão corretas.

D) Apenas afirmativa I está correta.

E) Todas afirmativas estão corretas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

86869)

Enunciado: O Sr. João, de 72 anos, foi à consulta na Unidade Saúde da Família Terra Firme, tendo como motivo principal a necessidade de realizar exames de rotina. Após realizar o SOAP, seu Médico de Família e Comunidade detecta o antecedente de angina instável e fibrilação atrial crônica sem tratamento e a presença de ritmo cardíaco irregular no exame físico. Ao final da consulta, pergunta se tem algo mais que o Sr. João gostaria de relatar. A partir disto, ele diz ao médico que está ?impotente? (ficou ansioso e perdeu a ereção e a partir disto o quadro se repete. Ereção matinal presente). Marque a alternativa com a melhor conduta para o Sr. João.

A) A conduta seria a prescrição de dinitrato de

isossorbida e ácido acetilsalicílico contínuos, e sildenafila quando necessário;

B) A conduta seria a prescrição de ioimbina por 30 dias, associada ao ácido acetilsalicílico e ao propatilnitrato contínuos;

C) A onduta seria encaminhar o Sr. João ao urologista para avaliação;

D) A conduta seria investigar o quadro de angina instável e arritmia e fazer a abordagem comportamental da disfunção erétil;

E) A conduta seria a prescrição de amiodarona,

sinvastatina, ácido acetilsalicílico e propatilnitrato contínuos e tadalafila quando necessário.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

49614)

Enunciado: Assinale a droga de primeira indicação na arritmia secundária a infarto agudo do miocárdio:

A) Lidocaína.

B) Propranolol.

C) Verapamil.

D) Amiodarona.

E) Metoprolol.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

176046)

Enunciado: Paciente de 65 anos, tabagista, sedentário e obeso, chega no pronto-socorro em 28 de agosto com dor precordial típica. Seu ECG na admissão revelou supradesnivelamento do seg ST de 0,3 mV em V4R, V5R e V6R. Neste cenário, qual o diagnóstico e tratamento imediato? Escolha dentre as opções abaixo:

A) Infarto de ventrículo direito e o tratamento deve ser feito com expansão de volume.

B) Infarto de ventrículo direito e o tratamento deve ser feito com nitrato endovenoso.

C) Infarto de parede anterior localizada e tratamento com betabloqueadores endovenosos.

D) Infarto de parede anterosseptal e tratamento com betabloqueadores endovenosos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

129756)

Enunciado: A terapia trombolítica no infarto agudo do miocárdio com supra de ST tem como contraindicação absoluta:

A) Menstruação excessiva.

B) Diabetes mellitus descompensado.

C) Hipertrigliceridemia acentuada.

D) História de acidente vascular encefálico hemorrágico há 2 anos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

129770)

Enunciado: Paciente de 55 anos, sem comorbidades conhecidas, traz um eletrocardiograma de repouso sem alterações, apresenta dor torácica precordial que o obriga a reduzir o passo no meio de suas caminhadas diárias e que cede em repouso. A opção de exame complementar para diagnóstico de doença coronariana é:

A) Teste ergométrico.

B) Holter de 24 horas.

C) Cintilografia miocárdica com dobutamina.

D) Ecocardiograma transtorácico com estresse farmacológico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

107601)

Enunciado: Entre as situações descritas abaixo, aquela que contraindica formalmente a terapia trombolítica no infarto agudo do miocárdio com supra de ST é:

A) Sangramento menstrual.

B) Diabetes mellitus descontrolado.

C) Idade superior a 65 anos.

D) História de acidente vascular encefálico hemorrágico há 2 anos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

107951)

Enunciado: Paciente do sexo feminino, 55 anos, hipertensa e tabagista, admitida com dor torácica anginosa com duração de 15 minutos e melhora espôntanea. Durante o atendimento médico, teve nova dor precordial de curta duração associada à inversão dinâmica de onda T de V1 a V4, com normalização após nitrato sublingual. O melhor tratamento inicial para essa paciente seria:

A) Metoprolol + nitrato + AAS + dalteparina + clopidogrel.

B) Nitrato + propanolol + heparina não fracionada + tirofiban.

C) Clopidogrel + bloqueador de cálcio + nitrato + IECA + oxigênio + heparina não fracionada.

D) AAS + enoxaparina + nitrato + metoprolol + clopidogrel + oxigênio.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

103816)

Enunciado: Em relação a um paciente com diagnóstico de IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) é CORRETO afirmar:

A) FC >100 e FC< 50 não estão relacionadas com prognóstico no IAM.

B) Nitrato endovenoso deve ser usado em infarto de ventrículo direito, pois melhora o retorno venoso.

C) Troponina T e Troponina I são iguais em relação ao diagnóstico de IAM.

D) O bloqueio do ramo esquerdo está mais relacionado ao infarto sem supra de ST.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

87408)

Enunciado: Qual o objetivo primordial no tratamento do infarto agudo do miocárdio até 12 horas de evolução?

A) Melhorar a dor com analgésicos potentes.

B) Restaurar o fluxo na artéria responsável pelo infarto o mais precocemente possível.

C) Controlar as arritmias, que frequentemente são causas agravantes do infarto.

D) Iniciar o tratamento de insuficiência cardíaca decorrente de necrose.

E) Realizar o cateterismo para verificar o grau de disfunção ventricular esquerda.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

81993)

Enunciado: Um homem de 42 anos apresenta-se ao Pronto-Socorro com queixa de dor no peito. Além da isquemia miocárdica, cada uma das seguintes é uma causa potencial de desconforto no peito, EXCETO:

A) Espasmo esofágico.

B) Dissecção aórtica.

C) Herpes-zóster.

D) Bronquiectasia.

E) Costocondrite.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

60830)

Enunciado: Sobre o exame clínico de pacientes com suspeita diagnóstica de IAM de VD, assinale a alternativa INCORRETA:

A) Sinal de Kussmaul.

B) Hipofonese de bulhas.

C) Ausculta pulmonar sem estertores.

D) Presença de estase venosa jugular.

E) Hipotensão arterial acentuada após uso de nitrato.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

46723)

Enunciado: Paciente é atendido no PS e internado com diagnóstico de IAM (Infarto Agudo do Miocárdio). Após uma semana, paciente apresenta novo episódio de dor de forte intensidade com duração de mais de 20 minutos. Que marcador cardíaco seria fundamental para confirmar o diagnóstico de novo IAM?

A) CKMB

B) CPK

C) DHL

D) Troponina T

E) Troponina I

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

34131)

Enunciado: Ao avaliarmos uma curva enzimática que mostra elevação de troponina e CPK-MB com queda precoce pensamos tratar-se de:

A) Reperfusão coronariana.

B) Infarto Agudo do Miocárdio.

C) Angina instável.

D) Embolia pulmonar.

E) Edema agudo de pulmão.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

26440)

Enunciado: Selecione a alternativa em que a dosagem da troponina I seria conclusiva para a lesão miocárdica decorrente de isquemia miocárdica nas primeiras 12 horas após o início do quadro clínico. Assuma, em todas as situações, que a troponina não foi dosada previamente:

A) Sexo feminino, 56 anos, com dor precordial ventilatório dependente há 2 dias, portadora de insuficiência renal crônica em decorrência de nefropatia hipertensiva, com hipertrofia ventricular esquerda ao ECG.

B) Sexo masculino, 65 anos, com dor precordial típica há uma hora e supra segmento ST em derivações antero-septais (V1 e V3).

C) Sexo feminino, 60 anos, com dor precordial recorrente após infarto agudo do miocárdio ocorrido há 2 dias.

D) Sexo masculino, 48 anos, diabético, sem alterações eletrocardiográficas, com epigastralgia incaracterística.

E) Sexo feminino, 70 anos, submetida à cirurgia de revascularização miocárdica (2 pontes de safena) há 1 dia, com dor precordial de leve intensidade há cinco horas e sem alterações eletrocardiográficas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

26612)

Enunciado: Com a morte dos miócitos, macromoléculas intracelulares passam através da membrana da célula lesada, e o seu aparecimento na corrente sanguínea significa a ocorrência de infarto do miocárdio. O padrão de elevação é útil para fins diagnósticos sendo correto afirmar, exceto:

A) A troponina T e I cardioespecíficas não existem nos tecidos extracardíacos e sua presença no soro em qualquer concentração detectável é altamente específica de necrose miocárdica.

B) Embora a CK-MB tenha sido o marcador sérico mais amplamente utilizado para confirmar o diagnóstico de IAM, sua utilidade clínica é limitada pelo não aparecimento durante a primeira hora do infarto e pela sua falta de especificidade total.

C) A CK-MB começa a subir cerca de quatro a seis horas após o início dos sinais e sintomas, atingindo o máximo em aproximadamente 24 horas, e retornando aos níveis basais em três ou quatro dias.

D) A troponina semelhante à CK-MB começa a subir com quatro a seis horas e atinge seus níveis máximos em cerca de 24 horas, entretanto são liberadas continuamente por até 10 a 14.

E) A mioglobina é um marcador muito sensível de necrose muscular cardíaca sendo importante para as decisões diagnósticas e mensurar a extensão do infarto.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

26684)

Enunciado: O infarto agudo do miocárdio apresenta várias complicações sendo a complicação mecânica mais comum:

A) rotura do septo interventricular

B) rotura do músculo papilar

C) aneurisma ventricular

D) rotura da parede livre do Ventrículo esquerdo

E) insuficiência mitral

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

7447)

Enunciado: Para um homem idoso, com um infarto do miocárdio pregresso, foi indicado o uso de ácido acetilsalicílico para prevenção secundária de novas síndromes coronarianas. Dentre as seguintes, a dose diária que melhor une as características de prevenção e menor custo é:

A) 50 mg.

B) 100 mg.

C) 200 mg.

D) 300 mg.

E) 500 mg.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

10001)

Enunciado: Fazem parte da Classe I na classificação de Braunwald para angina instável:

A) Angina em repouso subaguda mas não nas 48 horas precedentes.

B) Angina em repouso aguda dentro das 48 horas.

C) Angina de início recente, intensa ou acelerada.

D) Angina precipitada por grandes esforços.

E) Angina vasoespástica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

10007)

Enunciado: Dos marcadores de lesão miocárdica abaixo, qual leva mais tempo para normalização dos seus níveis séricos?

A) CKMB massa.

B) Mioglobina.

C) CKMB atividade.

D) Troponina.

E) Isoforma MB2.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152293)

Enunciado: Homem, 45 anos de idade, procura atendimento ambulatorial com cardiologista queixando-se de dor torácica retroesternal mal caracterizada, associada aos grandes esforços, com duração de poucos minutos, há cerca de quatro meses. Relata que há uma semana esteve no PS com o mesmo quadro. Melhorou após o uso de aspirina e nitrato, tendo sido liberado. Traz eletrocardiograma e radiografia torácica sem alterações e marcadores de necrose miocárdica normais. De antecedentes, apresenta HAS, em uso de enalapril e anlodipino, e resistência a insulina, em uso de metformina. Ao exame, apresenta-se em bom estado geral, com sobrepeso. Ausculta e demais exames segmentares sem alterações. Considerando o caso descrito, indique a principal suspeita diagnóstica e o principal diagnóstico diferencial.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152181)

Enunciado: Homem, 45 anos de idade, procura atendimento ambulatorial com cardiologista queixando-se de dor torácica retroesternal mal caracterizada, associada aos grandes esforços, com duração de poucos minutos, há cerca de quatro meses. Relata que há uma semana esteve no PS com o mesmo quadro. Melhorou após o uso de aspirina e nitrato, tendo sido liberado. Traz eletrocardiograma e radiografia torácica sem alterações e marcadores de necrose miocárdica normais. De antecedentes, apresenta HAS, em uso de enalapril e anlodipino, e resistência à insulina, em uso de metformina. Ao exame, apresenta-se em bom estado geral, com sobrepeso. Ausculta e demais exames segmentares sem alterações. Considerando o caso descrito, cite dois exames não invasivos que podem ser solicitados para avaliação do prognóstico desse paciente.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152190)

Enunciado: Homem, 45 anos de idade, procura atendimento ambulatorial com cardiologista queixando-se de dor torácica retroesternal mal caracterizada, associada aos grandes esforços, com duração de poucos minutos, há cerca de quatro meses. Relata que há uma semana esteve no PS com o mesmo quadro, melhorou após o uso de aspirina e nitrato, tendo sido liberado. Traz eletrocardiograma e radiografia torácica sem alterações e marcadores de necrose miocárdica normais. De antecedentes, apresenta HAS, em uso de enalapril e anlodipino, e resistência a insulina, em uso de metformina. Ao exame, apresenta-se em bom estado geral, com sobrepeso. Ausculta e demais exames segmentar sem alterações. Considerando o caso descrito, indique a conduta mais importante, nesse momento, sabendo-se que, poucos meses após iniciado o tratamento, o paciente voltou a ter dor retroesternal, associada a dispneia e edema de membros inferiores.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

129999)

Enunciado: Homem, 58 anos de idade, dá entrada no pronto-socorro queixando-se de dor torácica retroesternal, iniciada há 30 minutos, sem irradiação, associada a náuseas. De antecedentes, tem HAS compensada, em uso de losartana. Nega tabagismo ou etilismo. Tem história familiar de AVC em pai e irmão. Ao exame físico, apresenta regular estado geral, lúcido, com fácies de dor. Exames laboratoriais apresentam: FC = 90 bpm; PA = 120 x 70 mmHg; FR = 20 irpm; SatO2 = 94%; IMC = 25 kg/m². Ausculta respiratória sem alterações. Ausculta cardíaca com ritmo cardíaco regular. Bulhas hipofonéticas, em 2 tempos, sem sopros. Abdome sem alterações. Logo na entrada, a enfermagem realiza eletrocardiograma apresentado a seguir: (VER IMAGEM) Considerando o relato do caso, indique o diagnóstico completo da situação aguda desse paciente.

A) Resposta.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

130003)

Enunciado: Homem, 58 anos de idade, dá entrada no pronto-socorro queixando-se de dor torácica retroesternal, iniciada há 30 minutos, sem irradiação, associada a náuseas. De antecedentes, tem HAS compensada, em uso de losartana. Nega tabagismo ou etilismo. Tem história familiar de AVC em pai e irmão. Ao exame físico, apresenta regular estado geral, lúcido, com fácies de dor. Exames laboratoriais apresentam: FC = 90 bpm; PA = 120 x 70 mmHg; FR = 20 irpm; SatO? = 94%; IMC = 25 kg/m². Ausculta respiratória sem alterações. Ausculta cardíaca com ritmo cardíaco regular. bulhas hipofonéticas, em 2 tempos, sem sopros. Abdome sem alterações. Logo na entrada, a enfermagem realiza eletrocardiograma apresentado a seguir: (VER IMAGEM) Considerando o relato do caso, após manejo inicial, o paciente foi internado na UTI e seguia estável, monitorizado, evoluindo 72 horas após com piora súbita do quadro, com PA = 60 x 40 mmHg; FC = 100 bpm; SatO? = 89%. No momento do exame físico, apresenta sopro pansistólico, alto, audível em borda esternal esquerda baixa, além de estertores crepitantes até ápice de pulmões. O paciente é intubado e são iniciadas medidas para estabilizar o quadro hemodinâmico. Nesse momento, indique o exame complementar mais importante à beira-leito para diagnóstico da complicação apresentada.

A) Resposta.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

130005)

Enunciado: Homem, 58 anos de idade, dá entrada no pronto-socorro queixando-se de dor torácica retroesternal, iniciada há 30 minutos, sem irradiação, associada a náuseas. De antecedentes, tem HAS compensada, em uso de losartana. Nega tabagismo ou etilismo. Tem história familiar de AVC em pai e irmão. Ao exame físico, apresenta regular estado geral, lúcido, com fácies de dor. Exames laboratoriais apresentam: FC = 90 bpm; PA = 120 x 70 mmHg; FR = 20 irpm; SatO? = 94%; IMC = 25 kg/m². Ausculta respiratória sem alterações. Ausculta cardíaca com ritmo cardíaco regular. Bulhas hipofonéticas, em 2 tempos, sem sopros. Abdome sem alterações. Logo na entrada, a enfermagem realiza eletrocardiograma apresentado a seguir: (VER IMAGEM) Após manejo inicial, o paciente foi internado na UTI e seguia estável, monitorizado, evoluindo 72 horas após com piora súbita do quadro, com PA = 60 x 40 mmHg; FC = 100 bpm; SatO2 = 89%. No momento do exame físico apresenta sopro pansistólico, alto, audível em borda esternal esquerda baixa, além de estertores crepitantes até ápice de pulmões. O paciente é intubado e são iniciadas medidas para estabilizar o quadro hemodinâmico. Considerando o relato do caso, indique a hipótese diagnóstica mais provável e a terapia específica mais adequada, tendo em vista a piora do paciente.

A) Resposta.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

106529)

Enunciado: Homem, 30 anos de idade, retorna à UBS de seu bairro preocupado com os resultados dos exames solicitados. Na consulta anterior foi constatado peso de 90Kg, altura de 1,70m, circunferência abdominal: 104cm. PA: 140/95mmHg. Os exames mostraram colesterol total: 240mg%, HDL: 35mg%, LDL:180mg%, triglicérides: 230mg%. Diante do quadro apresentado, indique as metas terapêuticas desejadas quanto aos exames realizados.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

49293)

Enunciado: Mulher, 67 anos de idade, hipertensa e obesa, internada por pé diabético, apresentou mal-estar súbito com sudorese e náuseas. Nega dor torácica ou tosse. PA: 105 x 70 mmHg deitada. Pulso radial: 118 bpm rítmico. Temp: 36,7°C. Mucosas coradas, sem estase de jugulares. Aparelho respiratório: MV preservados, sem crépitos, ACV: íctus no 5º EICE, ritmo regular, sem sopros, com B4. Abdome: fígado palpável a 3 cm do RCD, elástico, sem outras alterações. Pé esquerdo com úlcera seca profunda em região plantar e necrose isquêmica de 5 pododáctilo. No momento, lúcida, ansiosa, sem déficits motores. Exames imediatos: glicemia capilar: 144 mg/dl, saturação de O2 ao ar ambiente: 91%. O diagnóstico mais provável a ser confirmado é:

A) Infarto do miocárdio.

B) Tromboembolismo pulmonar.

C) Sepse em instalação.

D) Acidente vascular encefálico.

E) Síncope vasomotora.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

34966)

Enunciado: Na avaliação de risco cardíaco pré-operatório, para cirurgia intraperitoneal de um paciente cardiopata, representa o pior risco - ou risco mais elevado de morte cardiovascular relacionada à intervenção - paciente com IAM nos seis meses prévios

A) com estenose aórtica importante e idade > 70 anos.

B) DPOC e idade > 70 anos.

C) com fibrilação atrial e ritmo de galope à ausculta cardíaca.

D) DPOC e ECG com extrassístoles ventriculares frequentes .

E) com insuficiência renal crônica e cirurgia de emergência.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

34978)

Enunciado: De acordo com as alterações observadas nas derivações do eletrocardiograma, pode-se, topograficamente, classificar o infarto agudo do miocárdio. Sendo assim, é incorreto afirmar que, em relação à localização, a parede miocárdica envolvida é a:

A) Lateral: alterações de D1, aVR, V5 e V6.

B) Anterosseptal: alterações de V1 a V3.

C) Anterior extenso: alterações de V1 a V6, D1 e aVL.

D) Inferior: alterações de D2, D3 e aVF.

E) Posterior (dorsal): alterações de V7, V8, V9 e V10, com ondas R amplas em V1 e V2.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

35014)

Enunciado: Em relação à isquemia miocárdica, é correto afirmar:

A) A função miocárdica pode permanecer deprimida por até 6 horas, após resolução de isquemia que se segue à oclusão de uma artéria coronária, por um período de até 15 minutos, na ausência de necrose tecidual, fenômeno que é conhecido por miocárdio atordoado.

B) Miocárdio disfuncionalmente viável pode ser definido como qualquer região que não obteve melhora contrátil após revascularização coronária é chamado de miocárdio hibernado.

C) Miocárdio que não normaliza a sua função após rápidos períodos de isquemia com duração de até 2 minutos é chamado de miocárdio hibernante.

D) Infarto subendocárdico pode ocorrer quando se mantém moderada isquemia por um período de tempo > 24 horas, com o desenvolvimento de miocárdio hibernado.

E) Atordoamento miocárdico crônico é improvável, ainda que ocorra isquemia reversível de repetição, antes que a função miocárdica esteja normalizada. O mecanismo celular de atordoamento não deve envolver lesão miocárdica, mantendo sensibilidade ao cálcio miofilamentar.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

34917)

Enunciado: Em relação à abordagem do paciente com dor torácica, segundo as diretrizes da American College of Cardiology, e validados no Brasil pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, é falso afirmar:

A) Dor torácica atípica que reduz a probabilidade de representar isquemia miocárdica compreende sintomas com as seguintes características: dor pleurítica, localizada primariamente na região mediana ou inferior do abdome, dor que pode ser localizada com a ponta de um dedo, dor que pode ser reproduzida com movimentos ou palpação da parede torácica ou dos braços.

B) A superfície visceral do pericárdio é insensível à dor, bem como a maior parte da superfície parietal. Assim, causas não infecciosa de pericardite geralmente ocasionam pouca ou nenhuma dor.

C) Dissecções da aorta ascendente tendem a manifestar dor na linha média da parede anterior do tórax.

D) Embolia pulmonar maciça pode causar dor subesternal aguda e persistente, atribuída à distensão da artéria pulmonar. A hipertensão pulmonar, nesses casos, também pode levar à dor torácica, atribuída à isquemia do VD, porém com características diferentes da dor anginosa causada por obstrução coronária do VE.

E) Síndrome do pânico pode levar à dor torácica, geralmente associada à dispneia, com duração semelhante à angina pectoris.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

34997)

Enunciado: O eletrocardiograma (VER IMAGEM) é de um paciente, 70 anos de idade, sexo masculino, que apresenta dor torácica típica há cinco horas. O médico que o atendia obteve outras informações adicionais, como: paciente diabético há 10 anos, hipertenso há 5 anos, tabagista de 20 cigarros/dia, por 30 anos. Tem peso estimado em torno de 60 kg. Dados vitais na admissão mostravam PA: 90 x 50 mmHg, pulso: 110 bpm, FR: 24 inc/min; mucosas coradas. Cabeça e pescoço: percebe-se estas e jugular a 45°. Tórax: pulmões com MV rude bem distribuído, estertores crepitantes em terço inferior de ambos os hemitóraces. ACV: B1 e B2 normais. B3+ em FM, SS grau II/VI em FM, irradia para axila. Abdome: sem alterações. É habitual classificar o paciente em categorias de risco para desfechos negativos em 30 dias. As classificações/escores mais utilizados são Killip-Kimbal e TIMI RISK. Com base nessa informação, pode-se afirmar:

A) O paciente tem um infarto com supra de ST-T de parede anterior, Killip-Kimbal III, TIMI RISK 10, com mortalidade em 30 dias, que pode chegar a 35%, e a conduta inicial deve incluir AAS, diuréticos, betabloqueador, nitrato, morfina, oxigênio sob máscara de Venturi e trombólise com tenecteplase.

B) O paciente tem um infarto com supra de ST-T de parede anterosseptal, Killip-Kimbal II, TIMI RISK 8, com mortalidade em 30 dias de 35%, e a conduta inicial deve ser feita com AAS, metoprolol venoso 5 mg, nitroglicerina venosa, furosemida venosa (1 mg/kg), morfina venosa, oxigênio sob máscara de Venturi e angioplastia coronária, pois deve haver oclusão da artéria descendente anterior.

C) O paciente se encontra em Killip-Kimbal III, TIMI RISK 11, com mortalidade que pode chegar a 35% em 30 dias. Não há diferença estatística entre trombólise e angioplastia nessa situação, devendo-se optar pela estratégia disponível no centro de saúde. Além disso, o paciente deve receber diuréticos de alça, morfina, nitroglicerina e metoprolol venoso, medidas que comprovadamente reduzem a mortalidade inicial no paciente com infarto com supradesnível de ST-T.

D) O paciente se encontra em classe Killip-Kimbal II, TIMI RISK 13, com possibilidade de até 35%

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

de desfechos negativos em 30 dias, e a melhor conduta deve incluir AAS, diuréticos de alça, clopidogrel, oxigênio sob máscara de Venturi e angioplastia imediata.

E) O paciente se encontra em classe II de Killip-Kimbal, TIMI RISK 12, com alto risco de desfechos negativos em 30 dias, e a melhor

conduta deve ser feita com diuréticos de alça, oxigênio nasal, morfina venosa, nitroglicerina venosa, digital, tenecteplase venosa e, caso não haja sinais de reperfusão, transferência para angioplastia da artéria descendente anterior.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

13889)

Enunciado: Paciente, 40 anos de idade, sexo masculino, procura emergência com quadro de precordialgia, com irradiação para ombro esquerdo. Tabagista, sedentário, com histórico familiar de coronariopatia, dislipidêmico. O médico plantonista faz a suspeita de IAM. Os exames que devem ser solicitados para confirmar a suspeita são:

A) ECG e CPK.

B) CPK e LDH.

C) ECG e LDH.

D) ECG, CK-MB e troponina.

E) ECG, TGO e troponina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

13890)

Enunciado: Paciente, 40 anos de idade, sexo masculino, procura emergência com quadro de precordialgia, com irradiação para ombro esquerdo. Tabagista, sedentário, com histórico familiar de coronariopatia, dislipidêmico. O médico plantonista faz a suspeita de IAM.O ECG mostrou inversão da onda T e os marcadores estavam normais. A melhor conduta a ser adotada é:

A) Internamento, seriar marcadores e monitorização, apenas.

B) Uso de trombolíticos.

C) Uso de AAS e liberar para casa.

D) Uso de betabloqueador.

E) Internamento, monitorização, seriar marcadores e uso de AAS.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

281902)

Enunciado: Além de esfigmomanômetros e estetoscópios, há vários recursos disponíveis, como cardiofrequencímetros e aplicativos de celulares para monitoramento da frequência cardíaca (FC), glicosímetros e oxímetros digitais na Reabilitação Cardiovascular. Sendo correto que:

A) Dependendo da complexidade clínica e do risco de eventos cardiovasculares favoráveis, é desejável o monitoramento eletrocardiográfico no repouso e durante o exercício.

B) Dependendo da complexidade clínica e do risco de eventos cardiovasculares desfavoráveis, é desejável o monitoramento eletrocardiográfico no repouso e durante o exercício.

C) Dependendo da complexidade clínica e do risco de eventos cardiovasculares desfavoráveis, não é desejável o monitoramento eletrocardiográfico no repouso e durante o exercício.

D) Dependendo da complexidade clínica e do risco de eventos cardiovasculares desfavoráveis, é desejável o monitoramento eletrocardiográfico no repouso e nunca durante o exercício.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

249968)

Enunciado: Sobre o risco de trombose de stent em pacientes que foram submetidos à ICP com stents convencionais nos primeiros dias e semanas após o procedimento, podemos concordar que:

A) Uma dupla Antiagregação Plaquetária é recomendada por um semestre.

B) Os stents convencionais foram reservados, idealmente, para os pacientes com risco muito alto de sangramento e que necessitam de um período mais curto (ao menos um mês) de dupla Antiagregação.

C) No Brasil, o stent convencional metálico não é utilizado principalmente em serviços públicos.

D) Trombose de stent em pacientes com stents metálicos é muito mais raro nos primeiros dias e semanas após o procedimento.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

181159)

Enunciado: A observação, principalmente em mulheres que tem angina, mas que não apresentam obstruções à angiografia coronária, há anos chama a atenção é denominada de Síndrome X. Sobre isso, assinale a alternativa INCORRETA:

A) Ocorre que mesmo sem obstruções nas artérias, estas têm comportamento inadequado para o fluxo, tanto as epicárdicas quanto a microcirculação, o que é suficiente para provocar isquemia miocárdica.

B) Isso não consegue ser detectado por meio da eletrocardiografia de esforço ou pela Cintigrafia de Perfusão Miocárdica (CPM), infelizmente.

C) Essa síndrome é interpretada como uma doença da microcirculação coronária devido a uma disfunção endotelial ou a alterações do tônus vascular, resultando em uma redução da oferta de oxigênio no nível celular.

D) Muitas das pessoas com essa síndrome, em verdade, tem placas ateroscleróticas em vários segmentos sem obstrução coronária quando avaliadas por Ultrassom Intravascular (USIV) coronária.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

181165)

Enunciado: Dentro da abordagem do diagnóstico diferencial da dor torácica e das condições associadas, que podem ser provocadoras ou mesmo fatores de alívio da angina, podemos considerar que os pacientes, especialmente naqueles com angina típica, devem ser consideradas as doenças associadas (simultâneas) que possam precipitar angina ?funcional?, isto é, isquemia miocárdica na ausência de obstrução coronariana anatômica significante. Sendo INCORRETA apenas a seguinte situação:

A) Uma redução no consumo de oxigênio pode ser produzida por hipertermia, hipertireoidismo e uso de cocaína.

B) Geralmente, são doenças que causam isquemia miocárdica, por aumentarem o consumo ou por diminuírem a oferta de oxigênio para o miocárdio.

C) Hipertermia, particularmente se acompanhada de redução de volemia, devido à sudorese ou a outras perdas de fluidos, pode precipitar angina, mesmo na ausência de DAC significante.

D) Hipertireoidismo, com sua taquicardia associada e índice metabólico elevado, aumenta o consumo de oxigênio e pode também reduzir a sua oferta.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

181170)

Enunciado: É importante identificar a angina instável, pois está muito relacionada com o evento coronariano agudo. Dentre os achados clínicos, assinale a alternativa INCORRETA:

A) Um desconforto repentino, fugaz, ou então contínuo, com duração de várias horas, raramente se trata de angina.

B) A angina usualmente incide sobre a região retroesternal, tendo irradiação para o pescoço, mandíbula, epigástrio ou membros superiores.

C) Dor localizada nas regiões das articulações condroesternais quase sempre tem origem cardíaca.

D) Diversas classificações já foram propostas e a mais utilizada é a que divide a dor torácica em três grupos: típica, atípica e não cardíaca.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

181173)

Enunciado: Dentro da terapia antiagregante plaquetária podemos considerar diversas intervenções, sendo que somente uma das afirmativas abaixo listadas se mostra INCORRETA assinale-a:

A) O AAS e o Clopidogrel é a combinação de antiplaquetários orais mais utilizada na terapêutica antiplaquetária dupla em nosso meio, por ser eficaz na maioria dos pacientes, ter baixo custo e estar amplamente disponível.

B) O prasugrel tem demostrado menor grau de inibição plaquetária, início de ação mais rápido e redução de eventos isquêmicos comparados ao clopidogrel.

C) O ticagrelor tem demostrado maior grau de inibição plaquetária, início de ação mais rápido e redução de eventos isquêmicos comparados ao clopidogrel.

D) O prasugrel está associado à maior risco de sangramentos, tem maior custo e está aprovado para uso apenas em pacientes portadores de Síndrome Coronária Aguda.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

181184)

Enunciado: Quando realizamos o exame físico em um paciente com suspeita de angina, além dela, há várias situações de dor torácica, ou sintomas manifestados nas regiões habituais de sua manifestação, que possuem outros diagnósticos como relacionados a DAC (Doença Arteriosclerótica Coronariana). Sobre isso, assinale a alternativa INCORRETA:

A) O exame físico é usualmente normal nos pacientes com angina estável.

B) Entretanto, durante o episódio anginoso, pode fornecer indícios valiosos a respeito da existência ou não de DAC.

C) Quando é possível realizar o exame fisico do paciente na vigência de dor, Terceira Bulha (B3), Quarta Bulha (B4) ou galope, sopro de regurgitação mitral, desdobramento paradoxal de Segunda Bulha (B2) e estertoração pulmonar bibasal indicam achados sugestivos e preditores de DAC.

D) Achados de aterosclerose em outros territórios, como pulsos de membros inferiores diminuídos, endurecimento arterial e aneurisma abdominal, diminuem a probabilidade de DAC.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

181169)

Enunciado: A Aterosclerose é uma doença inflamatória crônica de origem multifatorial que ocorre em resposta à agressão endotelial, acometendo principalmente a camada íntima de artérias de médio e grande calibres. Sendo INCORRETO a seu respeito:

A) A formação da placa aterosclerótica inicia-se com a agressão ao endotélio vascular devida a diversos fatores de risco como dislipidemia, hipertensão arterial ou tabagismo.

B) A disfunção endotelial diminui a permeabilidade da íntima às lipoproteínas plasmáticas, favorecendo a retenção das mesmas no espaço subendotelial.

C) Ocorre que as partículas de LDL sofrem oxidação, causando a exposição de diversos neoepitopos e tornando-as imunogênicas.

D) O depósito de lipoproteínas na parede arterial, processo-chave no início da aterogênese, ocorre de maneira proporcional à concentração dessas lipoproteínas no plasma.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

181199)

Enunciado: Fatores como os listados abaixo aumentam também a chance de Doença Arterosclerotica Coronariana DAC, sendo que após a probabilidade ter sido estimada, ela é categorizada como baixa, intermediaria e alta, de acordo com valores estabelecidos na diretriz nacional, somente uma das alternativas não corresponde completamente como correta:

A) Tabagismo (mínimo de meio maço ao dia por 5 anos ou 25 maços ao ano).

B) Colesterol total (> 250 mg/dL).

C) Glicemia de jejum (> 140 mg/dL).

D) História familiar são fortemente preditivos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

181201)

Enunciado: A variedade e possível gravidade das condições clínicas que se manifestam com dor torácica faz com que seja primordial um diagnóstico rápido e preciso das suas causas. Esta diferenciação entre as doenças que oferecem risco de vida (dor torácica com potencial de fatalidade), ou não, é um ponto crítico na tomada de decisão do médico emergencial para definir sobre a liberação ou admissão do paciente ao hospital e de iniciar o tratamento imediatamente. Sendo que a epidemiologia apresenta importante papel nessa tomada de decisão, assinale a alternativa INCORRETA:

A) A Síndrome Coronariana Aguda (infarto agudo do miocárdico e angina instável) representa quase 1/5 das causas de dor torácica nas salas de emergência.

B) A Síndrome Coronariana Aguda por possuir uma significativa morbimortalidade, a abordagem inicial desses pacientes é sempre feita no sentido de confirmar ou afastar este diagnóstico.

C) A característica anginosa da dor torácica tem sido identificada como o dado com menor poder preditivo de doença coronariana aguda.

D) O exame físico no contexto da doença coronariana aguda não é expressivo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

181203)

Enunciado: O Eletrocardiograma (ECG) exerce papel fundamental na avaliação de pacientes com dor torácica, tanto pelo seu baixo custo e ampla disponibilidade como pela relativa simplicidade de interpretação. Sendo somente inadequado o seguinte dado epidemiológico de acordo com a diretriz atual:

A) A incidência de Síndrome Coronariana Aguda nesses pacientes é de cerca de 5%.

B) Um ECG absolutamente normal é encontrado na minoria dos pacientes que se apresenta com dor torácica na sala de emergência.

C) Diversos estudos têm demonstrado que a sensibilidade do ECG de admissão para Infarto Agudo do Miocárdio varia de 45% a 60% quando se utiliza o supradesnível do segmento ST como critério diagnóstico

D) Metade dos pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio não são diagnosticados com um único ECG realizado à admissão.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

181205)

Enunciado: A Cardiologia Nuclear avalia o coração enfocando os seguintes aspectos de perfusão miocárdica, tendo importante valor como índice prognóstico e epidemiológico, sendo INCORRETO apenas que avalia:

A) A integridade celular.

B) O metabolismo miocárdio.

C) A contratilidade miocárdica

D) A função ventricular global somente.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157628)

Enunciado: Dentro do diagnóstico de doença aterosclerótica coronariana subclínica, podemos considerar como VERDADEIRA a seguinte situação. Assinale-a.

A) A identificação apenas de indivíduos sintomáticos, portadores de aterosclerose e, dessa forma, sob risco de eventos cardiovasculares agudos, como o infarto e morte, é fundamental para se instituírem medidas de tratamento e prevenção secundária.

B) Diversos algoritmos têm sido criados com base em análises de regressão de estudos populacionais, por meio dos quais a identificação do risco global é substancialmente piorada pela criação de viés.

C) A estimativa do risco de doença aterosclerótica não apresenta necessidade de ser avaliada pelo somatório do risco causado individualmente ou pelo sinergismo dos reconhecidos fatores de risco para doença cardiovascular.

D) Diante da complexidade dessas interações cardiovasculares, a atribuição intuitiva do risco frequentemente resulta em subestimação ou superestimação dos casos de maior ou menor risco, respectivamente. Para contornar essa dificuldade, diversos algoritmos têm sido criados com base em análises de regressão de estudos populacionais, por meio dos quais a identificação do risco global é substancialmente aprimorada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157671)

Enunciado: Dentro da avaliação do risco de Doença Coronariana Silenciosa em pacientes diabéticos, podemos considerar INADEQUADA a seguinte alternativa a seguir. Assinale-a.

A) Em geral, o DM adianta em 15 anos a idade para a ocorrência de DCV.

B) Homens e mulheres diabéticos tipos 1 e 2, com idades respectivamente superiores a 40 e 50 anos,

geralmente apresentam risco de eventos coronarianos > 2% ao ano.

C) Sexo feminino: risco relativo aumenta 10 vezes.

D) Idade > 40 anos nos homens e > 50 anos nas mulheres.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157735)

Enunciado: Para o correto entendimento do uso da ecocardiográfica sob estresse, na doença aterosclerótica coronariana crônica, podemos apenas considerar VÁLIDO o contido em apenas uma das alternativas. Indique-a.

A) A ecocardiografia sob estresse é um método não invasivo, estabelecido para a avaliação de pacientes com DAC obstrutiva suspeita ou conhecida, para a determinação do diagnóstico e prognóstico, na avaliação do impacto de terapias de revascularização, na detecção de viabilidade miocárdica, mas não é capaz de auxiliar as decisões terapêuticas.

B) A ecocardiografia bidimensional permite a avaliação de todos os segmentos miocárdicos do ventrículo esquerdo com grande resolução espacial e temporal, tornando-se a ferramenta ideal para a avaliação não invasiva da isquemia miocárdica.

C) A ecocardiografia sob estresse apresenta acurácia ruim para detecção de isquemia miocárdica induzida em pacientes com probabilidade pré-teste intermediária ou alta.

D) Enquanto a ecocardiografia pela dobutamina e pelo exercício apresenta acurácia diagnóstica semelhante (83 e 85%,respectivamente), a ecocardiografia sob estresse pelo dipiridamol parece apresentar uma acurácia diagnóstica um pouco muito maior.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157742)

Enunciado: A cardiologia nuclear pode ser utilizada para avaliar o coração enfocando os aspectos de perfusão miocárdica, integridade celular, metabolismo miocárdico, contratilidade miocárdica e função ventricular global ou segmentar. Diante disso, marque a opção INCORRETA.

A) Estudos de perfusão miocárdica têm importante espaço no diagnóstico da doença isquêmica, apesar de utilizarem métodos muito invasivos, com muitas reações adversas ao radiotraçador.

B) A análise da especificidade do método ? usualmente relatada ? é afetada por subestimação decorrente de viés, pois a maioria dos pacientes com cintilografia de perfusão normal acaba não sendo referido para o exame padrão-ouro da coronariográfica.

C) Pode-se confirmar ou excluir doença arterial coronária com altos valores de sensibilidade e especificidade.

D) Técnicas atuais de sincronização eletrocardiográfica e de quantificação regional, associadas ao estudo tomográfico, permitem objetivar informações concomitantes da perfusão miocárdica e da motilidade parietal e função global do Ventrículo Esquerdo (VE), aumentando, de forma significativa, o poder diagnóstico do método.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157747)

Enunciado: Sobre a utilização do ecocardiograma para separação entre eventos agudos e crônicos de insuficiência coronariana, podemos considerar INCORRETA uma das opções. Aponte-a.

A) Ecocardiográfica transtorácica é um excelente método de triagem em pacientes com DAC durante eventos agudos.

B) Alterações da motilidade segmentar ocorrem segundos após a oclusão coronariana e são marcadores fidedignos de infarto antigo do miocárdio.

C) As alterações da motilidade segmentar podem significar isquemia ou infarto antigo somente.

D) A ecocardiográfica em repouso fornece uma série de informações sobre a função ventricular esquerda, como a viabilidade miocárdica, com importantes implicações terapêuticas e prognósticas após o IAM.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157751)

Enunciado: A Angiotomografia Computadorizada das Artérias Coronárias (angio-TC) permite a avaliação da luz das artérias coronárias de maneira não invasiva. Os equipamentos são capazes de adquirir tais imagens com alta qualidade, permitindo a visualização detalhada da luz das artérias coronárias com alta acurácia diagnóstica quando comparada ao cateterismo cardíaco (o padrão-ouro), porém de maneira não invasiva, rápida e segura. Indique a alternativa que NÃO corresponde a esse caso.

A) Uma melhora da qualidade de imagem associada à redução do volume do meio de contraste infundido e à queda drástica na dose de radiação utilizada, aumentando ainda mais a segurança do método.

B) O método não apresenta desempenho adequado na avaliação de indivíduos em diversas situações clínicas, com revascularização miocárdica cirúrgica e com stents > 3 mm.

C) Pacientes estáveis com suspeita de DAC demonstram que não apenas a presença e a extensão de estenoses coronárias significativas como também a presença e a extensão da aterosclerose não obstrutiva foram fatores preditores independentes de maior mortalidade.

D) As principais indicações clínicas do método na avaliação da doença coronária crônica são para pacientes sintomáticos de risco intermediário, podendo ser utilizado como exame inicial ou quando há testes de isquemia prévios conflitantes ou inconclusivos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157744)

Enunciado: Dentre o conceito de prevenção, agora não mais primária, o Teste Ergométrico (TE) é o método não invasivo utilizado com maior frequência na angina estável, visando à confirmação diagnóstica, entre outros. Para interpretação do TE, devem ser considerados diversos fatores, com EXCEÇÃO de um deles. Assinale-o.

A) Depressão do segmento ST.

B) Respostas hemodinâmicas, clínicas e a capacidade funcional.

C) Dispersão do QT, para diagnóstico de isquemia residual após revascularizações.

D) Em pacientes já revascularizados, as respostas clínicas relacionadas não se aplicam.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157740)

Enunciado: Paciente masculino, 48 anos de idade, deu entrada em Pronto Atendimento primário com dor torácica típica de início há 1 hora. Seu eletrocardiograma demonstra supra de ST nas seguintes derivações V1/V2/V3/V4 com 2 mm de altura. Seu diagnóstico inicial é o de Infarto Agudo do Miocárdio, sendo então realizado trombólise química, vez que não estava disponível Angioplastia Primária. Porém, o paciente evolui com: dor torácica persistente importante, especialmente associada à sudorese e dispneia, e instabilidade hemodinâmica com queda de sua pressão Arterial. Frente a esse caso clínico, assinale a alternativa que NÃO pode ser considerada como adequada.

A) A falha da terapia fibrinolítica pode ser avaliada por ECG com supradesnivelamento de ST persistente, ou que não reduziu mais que 50% do padrão inicial ou que aumenta.

B) Não existindo recanalização adequada, deve ser realizada a intervenção coronária percutânea de resgate em tempo < 180 minutos após o fibrinolítico.

C) É importante ressaltar que não é seguro a tentativa para transferência para um hospital terciário habilitado.

D) Angioplastia de resgate é definida como a estratégia de recanalização mecânica realizada precocemente quando a terapia fibrinolítica falha em atingir a reperfusão miocárdica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157668)

Enunciado: Idoso, 68 anos de idade, procura hospital com quadro de dor torácica, provavelmente cardiogênica, possuindo algumas características que não são compatíveis com insuficiência coronária. Ao ser realizado eletrocardiograma, foram encontradas alterações de repolarização ventricular causada por patologias não isquêmicas, que podem ser exemplificados pelas opções seguintes, com EXCEÇÃO de uma delas. Indique-a:

A) Supradesnivelamento do segmento ST em todas as derivações no caso da pericardite.

B) Inversão de ondas T no caso de embolia pulmonar.

C) Aumento de amplitude de ondas no caso de derrame pericárdico.

D) Ondas T gigantes causadas por hipercalemia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157670)

Enunciado: O Nitroprussiato de sódio é uma medicação de uso bastante comum em situações de lesão de órgão-alvo, durante as crises hipertensivas. Em qual das situações a seguir seu potencial tóxico se encontra exacerbado?

A) Insuficiência Cardíaca.

B) Edema Agudo de Pulmão.

C) Insuficiência Hepática.

D) AVC hemorrágico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157750)

Enunciado: Paciente masculino, 56 anos de idade, foi internado no hospital com quadro de dor torácica, sendo diagnosticado com IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) com supra do segmento ST na parede anterosseptal. O mesmo foi transferido alguns dias depois da Unidade Coronariana para a enfermaria de Clínica. Você então é convidado a dar seu parecer para realização da prescrição, que agora é uma prescrição de Enfermaria. Sendo assim, qual das alternativas abaixo NÃO é condizente com o caso apresentado.

A) Inibidores do sistema renina angiotensina orais reduzem mortalidade após o infarto agudo do miocárdio, com e sem terapias de reperfusão. Seus efeitos benéficos são mais pronunciados em pacientes acometidos de infarto anterior, congestão pulmonar e fração de ejeção < 40%.

B) Embora a administração precoce do betabloqueador possa ajudar a prevenir ocorrências de taquiarritmias e reduzir reinfarto, é observado aumento da incidência de choque cardiogênico.

C) Ticlopidina, antagonista seletivo e irreversível dos receptores de difosfato de adenosine de superfície de membrana, bloqueia a ligação induzida por difosfato de adenosina do fibrinogênio ao complexo IIb / IIIa.

D) Os nitratos são indicados para os pacientes com SCA em decorrência da capacidade de levar à vasodilatação coronariana com

consequente aumento do fluxo sanguíneo coronariano, além de diminuir a capacitância venosa, levando ao aumento da pré-carga ventricular.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134697)

Enunciado: Durante o tratamento de emergências cardiovasculares, frequentemente oferecemos oxigênio aos pacientes, notadamente quadros de Infarto Agudo do Miocárdio. Marque a alternativa que NÃO pode ser considerada como adequada sobre essa conduta.

A) Quando mal indicada a administração de oxigênio por tempo prolongado pode causar vasoconstrição sistêmica.

B) Caso inadequadamente indicado pode levar ao aumento da resistência vascular sistêmica.

C) É indicada sua administração rotineira em pacientes com saturação de oxigênio < 94%.

D) É indicada sua administração rotineira em pacientes com saturação de oxigênio < 90%.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134710)

Enunciado: Considere o caso a seguir. Paciente hipertenso, dislipidêmico e diabético mal controlado, deu entrada no hospital no dia anterior com intensa dor torácica e diaforese. Seu ECG demonstrava corrente de lesão em parede anterior, septal e inferior. Como angioplastia, estava indisponível e seu tempo de dor era de 10 horas, foi decidido por trombólise química. Evolui com melhora discreta da dor, e sua ausculta pulmonar demonstra estertores em ambas as bases pulmonares; sua pressão é de 110 x 60 mmHg. Qual das medicações abaixo listadas está contraindicada?

A) Atenolol.

B) Captopril.

C) Nitroglicerina.

D) Oxigênio.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

139775)

Enunciado: Mulher de 54 anos de idade, hipertensa, fumante e com histórico de uso de anticoncepcional oral, procura atendimento médico com dor no ombro esquerdo, dispneia e diaforese. Na avaliação física, encontra-se sudorese fria, dispneia, taquipneia e estertores crepitantes bi basais. ECG demonstra supra de ST em V1, V2 e V3. Para esse caso, assinale a alternativa que apresenta o tratamento ADEQUADO.

A) Atenolol oral.

B) Metoprolol venoso.

C) Aspirina

D) Trombolítico seguido de angioplastia (facilitada).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

139786)

Enunciado: Mulher, 40 anos de idade, hipertensa, fumante e com histórico de uso de anticoncepcional oral, procura atendimento médico com dor no ombro esquerdo, dispneia e diaforese. Na avaliação física, encontra-se sudorese fria e pegajosa, dispneia, taquipneia e estertores crepitantes bi basais. ECG demonstra supra de ST em V1, V2, V3 e V4. Para esse caso, assinale a alternativa CORRETA.

A) Indicar angioplastia facilitada.

B) Contraindicar beta bloqueador.

C) Contraindicar oxigênio suplementar.

D) Contraindicar analgésico com opioide.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

111854)

Enunciado: Paciente diabético com início de quadro de mal-estar e vômitos de 30 a 30 minutos. Ao procurar seu médico, é realizado Eletrocardiograma que demonstrou supra do segmento ST nas derivações D2, D3 e a VF. Podemos, assim, afirmar que:

A) está contraindicado nitratos.

B) ocorreu provavelmente obstrução da Coronariana Direita.

C) ocorreu provavelmente obstrução da Descendente Anterior.

D) ocorreu infarto de VD.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

111880)

Enunciado: O conceito de roubo coronariano pode ser explicado:

A) pelo aumento do fluxo para coronariana sadia.

B) pelo aumento do consumo de O2 pelo miocárdio.

C) pela taquicardia.

D) pela piora do tempo diastólico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

111914)

Enunciado: Quando avaliamos pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio, podemos utilizar diversos escores tanto para conduta quanto evolutivos. Um índice clínico interessante baseia-se nos achados de disfunção ventricular que são os seguintes:

A) ausculta cardíaca com B3, ausculta pulmonar e ECG.

B) ausculta cardíaca com B4, ausculta pulmonar e ECG.

C) ausculta cardíaca com B3 ou não, além de ausculta pulmonar.

D) ausculta pulmonar, apenas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

111918)

Enunciado: Quando iniciamos avaliação de paciente com quadro de dor torácica, além de uma anamnese e de um ECG, solicitamos os ditos Marcadores de Necrose Miocárdica. Esse, por sua vez:

A) a Troponina é bastante precoce.

B) o mais sensível é a mioglobina.

C) a fração M da Creatinina fosfo quinase relaciona-se mais com tecido cerebral.

D) a metodologia baseada da atividade da CPK MB mostra-se mais efetiva para diagnóstico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

111879)

Enunciado: Quando avaliamos paciente com quadro de dor torácica, usualmente realizamos Eletrocardiograma para verificar diversas patologias. Ao encontrarmos um supra desnivelamento do segmento ST nas derivações D2, D3 e aVF, podemos supor que:

A) ocorreu infarto de Ventrículo Direito.

B) contraindicamos Nitratos.

C) a coronariana afetada é a Direita.

D) todas são afirmativas adequadas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

111892)

Enunciado: A utilização de nitratos mostra-se bastante comum, tanto a nível ambulatorial quanto a nível de emergência hospitalar, sendo importante a compreensão de seu uso farmacológico. Dessa maneira, podemos afirmar que os mesmos possuem essas propriedades, EXCETO:

A) Exaurir o óxido nítrico endotelial.

B) Melhorar prognóstico do infarto miocárdico.

C) Venodilatador.

D) Apresentar absorção cutânea.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

350876)

Enunciado: Paciente de 67 anos, masculino, procurou atendimento na UPA devido quadro de dor torácica iniciado há 2 horas, descreve a dor como sensação de mal-estar, não conseguindo definir um local específico do peito, associado à sensação de queimação, com irradiação para membro superior esquerdo e sudorese. Refere que a dor se iniciou após retirar o lixo de seu domicílio, começando de maneira leve, porém, devido a piora da dor, procurou atendimento. Faz acompanhamento na UBS devido quadro de hipertensão arterial e Diabetes Mellitus, em uso irregular de insulina NPH, enalapril e alopurinol. Fuma 01 carteira de cigarros por dia, desde os 15 anos de idade. Ao exame físico, consciente, orientado, sudoreico, pálido, com fácies de dor, PA 120x80 mmHg em ambos os membros, FC 90 bpm, f 16 irpm, SpO? 94% em ar ambiente. Ausculta cardíaca e pulmonar normais. Abdome flácido. Pulsos periféricos simétricos e palpáveis. Devido quadro de dor, foi medicado com morfina venosa, com melhora dos sintomas, além de realizar o ECG a seguir. Dentro do contexto do caso, assinale o item que demonstra o melhor planejamento diagnóstico nesse momento.

A) Solicitar dosagem de CK-MB e mioglobina.

B) Realizar ECG e dosagem de troponinas de maneira seriada.

C) Realizar ECG apenas na chegada e solicitar dosagem de TGO, LDH e CK-MB.

D) Transferir paciente para tratamento invasivo percutâneo (cateterismo) de imediato.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

199702)

Enunciado: Paciente, 52 anos, piloto de aviação comercial, chega ao consultório para avaliar quadro de dor torácica. O quadro iniciou há 3 meses, se caracteriza por dor retroesternal, em aperto, que surge geralmente quando está caminhando em esteira, na academia. Necessita parar a atividade e a dor cede em cerca de 3 minutos. O quadro está estável desde o início. É portador de hipertensão arterial sistêmica e tabagista. Usa olmesartana. Tem irmão falecido por infarto aos 50 anos. Traz radiografia de tórax normal e tem eletrocardiograma com bloqueio de ramo esquerdo. No exame físico, a pressão arterial é 140 x 90 mmHg. Qual dos testes abaixo é o mais adequado para esse paciente?

A) Coronariografia.

B) Teste ergométrico.

C) Ecocardiograma de estresse com dipiridamol.

D) Escore de cálcio pela tomografia computadorizada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

172990)

Enunciado: Paciente feminina, 45 anos, portadora de hipertensão arterial, ex-tabagista, procura ambulatório com queixa de dor torácica precordial em queimação, que irradia para pescoço. Refere que a dor aparece ao esforço moderado nos últimos 3 meses, dura em torno de 5 minutos e melhora espontaneamente. Realizou o seguinte eletrocardiograma: Qual exame deve ser realizado como próximo passo na investigação?

A) Teste ergométrico.

B) Tomografia coronária com escore de cálcio.

C) Cateterismo com coronariografia diagnóstica.

D) Cintilografia miocárdica de estresse farmacológico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

150883)

Enunciado: Homem de 65 anos, com dor precordial que irradia para mandíbula, associada a náuseas e diaforese, de início há 30 minutos. Filho refere que o paciente já apresentara dor de caráter semelhante há 2 semanas. É portador de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e dislipidemia, tomando medicações prescritas de forma irregular. Realizou o seguinte eletrocardiograma na entrada: (VER IMAGEM) Evoluiu com sinais de hipotensão, congestão pulmonar e má perfusão periférica. Qual a conduta a ser realizada no momento, além do controle hemodinâmico, uso de dupla antiagregação plaquetária e anticoagulante parenteral?

A) Trombolítico.

B) Intervenção coronária percutânea.

C) Cirurgia de revascularização do miocárdio.

D) Tratamento clínico e teste provocativo de isquemia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

126996)

Enunciado: Dona Maria Helena tem 45 anos, é diabética, sedentária, fumante de meio maço de cigarros por dia. Apresenta-se assintomática do ponto de vista cardiovascular, exceto pelo baixo condicionamento para exercícios evidenciado em teste de esteira que foi negativo para doença isquêmica. O risco cardiovascular da paciente, pelo critério de Framingham, é de 13,1%. Que nível de prevenção estará sendo aplicado a esta paciente se for considerada terapia com aspirina em baixas doses (75-100 mg por dia)?

A) Primária.

B) Secundária.

C) Terciária.

D) Quartenária.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

102173)

Enunciado: Paciente, feminina, 58 anos, diabética, comparece em consulta de seguimento com seu médico de família e comunidade. Faz uso contínuo de hipoglicemiante oral de forma regular. Trouxe exames solicitados na última consulta: glicemia jejum 168 mg/dl, hemoglobina glicada 8,2%, triglicérides 400 mg/dl, Colesterol total 230 mg/dl, HDL 20 mg/dl. Que conduta deve ser tomada na situação acima?

A) Prescrever fibrato.

B) Prescrever estatina.

C) Prescrever fibrato e estatina.

D) Prescrever fibrato, estatina e ácido acetilsalicílico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

81249)

Enunciado: Paciente do sexo masculino, 65 anos, diabético e hipertenso, comparece ao pronto-socorro com uma hora de dor precordial constritiva com irradiação para o membro superior esquerdo. Encontra-se ansioso e sudoreico. Realizado ECG com imagem. (VER IMAGEM) Qual o melhor tipo de tratamento para esse paciente?

A) Cardioversão elétrica, sob sedação.

B) Intervenção percutânea coronariana imediata.

C) Administração de ativador de plasminogênio tecidual.

D) Amiodarona em bolus, seguida de administração intravenosa contínua.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

65777)

Enunciado: Paciente do sexo masculino, 65 anos, diabético e hipertenso, vem se queixando de dor precordial em aperto, com irradiação para o membro superior esquerdo, quando faz grandes esforços. Ao exame físico: PA de 150/100 mmHg, ausculta cardíaca com presença de quarta bulha. O ECG foi o primeiro exame complementar realizado e está exposto ao lado (VER IMAGEM). Qual o próximo exame a ser solicitado?

A) Teste ergométrico.

B) Cateterismo cardíaco.

C) Cintilografia do miocárdio.

D) Ecocardiograma sob estresse.

E) Ecocardiograma convencional.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

51199)

Enunciado: Um paciente de 50 anos, obeso, tabagista e sedentário, realizou teste ergométrico prévio interrompido no estágio II por fadiga e dor torácica. Que outro achado neste teste indicaria um sinal de prognóstico adverso importante?

A) Taquicardia sinusal após o esforço.

B) Redução da pressão arterial durante o esforço.

C) Aumento da pressão arterial durante o esforço.

D) Depressão de até 0,03 milivolt do segmento ST.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

51236)

Enunciado: Homem de 38 anos, motorista, negro, procura seu médico de família para avaliação de rotina. Relata etilismo, tabagismo, sedentarismo e alimentação rica em gordura animal. Ao exame: 98 Kg; 1,65 metros de altura; PA 165 x 95 mmHg (1° medida), PA: 160/95 mmHg (2° medida); cintura abdominal 98 cm. Ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações. Exames complementares: Colesterol total: 200 mg/dl; HDL: 50 mg/dl; triglicérides: 260 mg/dl; glicemia de jejum: 98 mg/dl; creatinina: 0,8 mg/dl; sumário de urina sem alterações; ácido úrico 8,2 mg/dl. Raio X de tórax e ECG de repouso sem alterações. Segundo a escala de Framingham, qual o risco cardiovascular estimado para esse paciente?

A) Risco médio, ou entre 15 e 20% em 10 anos.

B) Risco baixo, ou menos de 10% em 10 anos.

C) Risco médio, entre 10 e 15% em 10 anos.

D) Risco alto, ou mais de 20% em 10 anos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

141579)

Enunciado: Qual o principal elemento para o diagnóstico da síndrome coronariana aguda?

A) CK-MB.

B) Troponina.

C) História clínica.

D) Eletrocardiograma.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

45382)

Enunciado: Homem, de 57 anos, fumante, e portador de hipertensão arterial sistêmica chega ao pronto-socorro com forte dor torácica central opressiva e sudorese. Um eletrocardiograma mostra inversão de onda T das derivações V1 a V4 e avaliação laboratorial mostra troponina elevada. Qual das medicações abaixo deve ser evitada nesse paciente?

A) Aspirina.

B) Clopidogrel.

C) Metoprolol.

D) Alteplase (t-PA).

E) Morfina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

36982)

Enunciado: Homem de 54 anos comparece à emergência com dor retroesternal em aperto com irradiação para o pescoço, sudorese e náusea há oito horas. É hipertenso, tabagista, tem história de LDL elevado e índice de massa corporal de 35 kg/m². Seu ECG mostra inversão de onda T de V1 a V4. Seus exames mostram troponina elevada. Qual dos itens abaixo NÃO ESTÁ INCLUÍDO nas estratégias terapêuticas para este caso?

A) Enoxaparina.

B) Clopidogrel.

C) Estreptoquinase.

D) Angioplastia coronariana.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

37383)

Enunciado: Em relação à melhor conduta nas síndromes coronarianas agudas com supradesnivelamento do segmento ST, podemos afirmar que:

A) A estratégia de reperfusão imediata tem benefícios comprovados até as 12h iniciais do início do IAM na grande maioria dos casos.

B) Em relação à estratégia de reperfusão, o uso de fibrinolíticos é tão eficaz quanto a angioplastia com stents após as 3h iniciais do evento agudo.

C) A menstruação presente é contraindicação absoluta ao uso de fibrinolíticos e da heparina.

D) A heparinização plena é uma das estratégias responsáveis pela reperfusão da artéria ?culpada?.

E) O uso de aspirina na fase aguda tem pouco ou nenhum impacto sobre a mortalidade final.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

37393)

Enunciado: Considere o quadro clínico e escolha a alternativa correta: Francisco, 58 anos, chegou à emergência com história de dor precordial intensa com início há 2 horas, com irradiação para o braço esquerdo, acompanhada de sudorese e palidez. Relata antecedentes de hipertensão arterial sistêmica e tabagismo há 35 anos. Faz uso regular de captopril e sinvastatina. O exame físico mostra paciente ansioso, pálido, com sudorese fria e taquicárdico. O restante sem particularidade. PA = 140 x 90 mmHg, FC = 115 bpm, T = 37°C, FR = 24 irpm. Eletrocardiograma realizado na chegada à emergência:(VER IMAGEM)

A) O ECG mostra IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) anterior extenso, devendo ser prescritos AAS, nitrato sublingual, betabloqueador e oxigênio e solicitadas enzimas cardíacas, hemograma completo, bioquímica, perfil lipídico, TAP e TPTA. Está indicado realização de cateterismo cardíaco com angioplastia OU trombolítico, com posterior admissão do paciente em UTI.

B) O ECG mostra IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) inferior, devendo ser prescritos AAS, nitrato sublingual, betabloqueador e oxigênio e solicitadas enzimas cardíacas, hemograma completo, bioquímica, perfil lipídico, TAP e TPTA. Está indicado realização de cateterismo cardíaco com angioplastia OU trombolítico, com posterior admissão do paciente em UTI.

C) O ECG mostra IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) anterior, devendo ser prescritos AAS, nitrato sublingual, betabloqueador e oxigênio e solicitadas enzimas cardíacas, hemograma completo, bioquímica, perfil lipídico, TAP e TPTA. Está indicado realização de cateterismo cardíaco com angioplastia OU trombolítico, com posterior admissão do paciente em UTI.

D) O ECG mostra IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) lateral, devendo ser prescritos AAS, nitrato sublingual, betabloqueador e oxigênio e solicitadas enzimas cardíacas, hemograma completo, bioquímica, perfil lipídico, TAP e TPTA. Está indicado realização de cateterismo cardíaco com angioplastia OU trombolítico, com posterior admissão do paciente em UTI.

E) O ECG mostra IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) anterolateral, devendo ser prescritos AAS, nitrato sublingual, betabloqueador e oxigênio e solicitadas enzimas cardíacas, hemograma completo, bioquímica, perfil lipídico, TAP e TPTA. Está indicado realização de cateterismo cardíaco

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

com angioplastia OU trombolítico, com posterior admissão do paciente em UTI.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

9051)

Enunciado: Em relação ao infarto agudo do miocárdio (IAM), é CORRETO afirmar:

A) A taxa de mortalidade precoce do IAM é de 30%, e mais da metade dessas mortes ocorrem após a chegada do paciente ao hospital

B) Ao contrário da angina instável, a dor do IAM nunca começa com o paciente em repouso

C) Além do IAM, cirurgia cardíaca, miocardite e cardioversão elétrica podem elevar a CKMB

D) No IAM sem elevação de ST, o tratamento por fibrinólise é formalmente indicado, pois existem evidências claras na literatura do seu benefício.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

13441)

Enunciado: Paciente de 55 anos, masculino, hipertenso, diabético e tabagista. Procurou a emergência com dor precordial contínua por 60 minutos sem irradiação ou outros sintomas. Chegou ao pronto-socorro uma hora após o término da dor. A CKMB e troponina coletadas na chegada ao pronto-socorro encontravam-se normais. Eletrocardiograma com alterações da repolarização ventricular de V1 a V6. Marque a alternativa correta:

A) paciente necessita de trombolítico.

B) evitar heparina para não ter risco de sangramento.

C) retornar o paciente para sua residência e fazer nova avaliação no dia seguinte.

D) provável IAM sem supradesnivelamento do segmento ST.

E) não fazer antiagregantes plaquetários.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

349738)

Enunciado: Em relação ao uso de trombolíticos em paciente com infarto agudo do miocárdio com supra de ST no eletrocardiograma, é considerado(a) contraindicação absoluta

A) uso crônico de AAS 100 mg diário.

B) trauma cranioencefálico importante nos últimos 3 meses.

C) histórico de úlcera péptica mesmo sem evidência de sangramento ativo.

D) acidente vascular encefálico isquêmico há 1 ano.

E) gestação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

349712)

Enunciado: A boa prática médica está associada à promoção da saúde, além de práticas terapêuticas e diagnósticas. A atividade física vem se tornando o centro da promoção à saúde em decorrência de seus inúmeros benefícios de curto, médio e longo prazo. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade recomendada de atividade física para pessoas entre 6 e 17 anos.

A) Realização de atividade física variada, envolvendo atividades lúdicas e recreativas.

B) Realização de 60 minutos de atividades físicas moderadas a vigorosas por dia, sendo estas adequadas para cada idade.

C) Realização, no máximo, de 150 minutos por semana de atividades físicas vigorosas, devido ao risco de acidentes.

D) Realização de 40 minutos de atividades físicas de reforço muscular por dia, sendo estas adequadas para cada idade.

E) Realização de 60 minutos de atividades físicas moderadas a vigorosas, no máximo 3x por semana devido ao risco de lesões.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

337517)

Enunciado: Paciente de 80 anos foi encontrado em rua pública, e testemunhas disseram que ele estava caminhando quando subitamente caiu no chão, perdendo a consciência. No hospital, foi realizado eletrocardiograma mostrado a seguir. Ao exame físico, sua pressão arterial era de 80x40mmHg, havia estertores pulmonares em todos os segmentos pulmonares com turgência jugular; sua glicemia estava normal. Durante seu atendimento, o paciente demonstrou ritmo cardíaco no monitor. Com base nos conhecimentos clínicos e nos eletrocardiogramas apresentados, julgue o item a seguir: O eletrocardiograma número 1 denota um eletrocardiograma com supradesnivelamento do segmento ST, compatível com infarto agudo do miocárdio.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

337518)

Enunciado: Paciente de 80 anos foi encontrado em rua pública, e testemunhas disseram que ele estava caminhando quando subitamente caiu no chão, perdendo a consciência. No hospital, foi realizado eletrocardiograma mostrado a seguir. Ao exame físico, sua pressão arterial era de 80x40mmHg, havia estertores pulmonares em todos os segmentos pulmonares com turgência jugular; sua glicemia estava normal. Durante seu atendimento, o paciente demonstrou ritmo cardíaco no monitor. Com base nos conhecimentos clínicos e nos eletrocardiogramas apresentados, julgue o item a seguir: O paciente apresenta-se em Killip III.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

337521)

Enunciado: Paciente de 80 anos foi encontrado em rua pública, e testemunhas disseram que ele estava caminhando quando subitamente caiu no chão, perdendo a consciência. No hospital, foi realizado eletrocardiograma mostrado a seguir. Ao exame físico, sua pressão arterial era de 80x40mmHg, havia estertores pulmonares em todos os segmentos pulmonares com turgência jugular; sua glicemia estava normal. Durante seu atendimento, o paciente demonstrou ritmo cardíaco no monitor. Com base nos conhecimentos clínicos e nos eletrocardiogramas apresentados, julgue o item a seguir: No contexto clínico apresentado, o paciente não apresenta benefício na revascularização miocárdica imediata.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

322165)

Enunciado: Uma mulher de 78 anos procura atendimento médico de urgência com queixa de dor no estômago e náuseas há aproximadamente 2 horas, obtendo-se o seguinte ECG da paciente: Nesse caso, considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que

A) se trata de uma colecistite aguda, e a paciente deve ser internada aos cuidados da cirurgia geral.

B) uma opção de reperfusão coronariana deve ser indicada imediatamente.

C) o uso de morfina e nitrato está indicado.

D) uma endoscopia digestiva alta é prioritária.

E) a paciente deve ser encaminhada para avaliação ambulatorial com um cardiologista.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

284272)

Enunciado: Um paciente de 54 anos de idade, com história de hipertensão arterial e dislipidemia, deu entrada no pronto-socorro com queixa de dor torácica retroesternal irradiada para a mandíbula há uma hora. Sinais vitais na entrada: pressão arterial de 140 x 90 mmHg; frequência cardíaca de 92; saturação de O? de 94%; e frequência respiratória de 20. Exame cardiopulmonar: ritmo cardíaco regular, sem sopros; e presença de B3 e B4. Murmúrio vesicular audível bilateralmente, com estertores finos em ambas as bases. Eletrocardiograma revelou infradesnivelamento de ST. Com base nesse caso hipotético, julgue o item a seguir. Trata-se de um infarto agudo do miocárdio sem supra de ST.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

284273)

Enunciado: Um paciente de 54 anos de idade, com história de hipertensão arterial e dislipidemia, deu entrada no pronto-socorro com queixa de dor torácica retroesternal irradiada para a mandíbula há uma hora. Sinais vitais na entrada: pressão arterial de 140 x 90 mmHg; frequência cardíaca de 92; saturação de O? de 94%; e frequência respiratória de 20. Exame cardiopulmonar: ritmo cardíaco regular, sem sopros; e presença de B3 e B4. Murmúrio vesicular audível bilateralmente, com estertores finos em ambas as bases. Eletrocardiograma revelou infradesnivelamento de ST. Com base nesse caso hipotético, julgue o item a seguir. A classificação da apresentação clínica é Killip 2.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

284274)

Enunciado: Um paciente de 54 anos de idade, com história de hipertensão arterial e dislipidemia, deu entrada no pronto-socorro com queixa de dor torácica retroesternal irradiada para a mandíbula há uma hora. Sinais vitais na entrada: pressão arterial de 140 x 90 mmHg; frequência cardíaca de 92; saturação de O? de 94%; e frequência respiratória de 20. Exame cardiopulmonar: ritmo cardíaco regular, sem sopros; e presença de B3 e B4. Murmúrio vesicular audível bilateralmente, com estertores finos em ambas as bases. Eletrocardiograma revelou infradesnivelamento de ST. Com base nesse caso hipotético, julgue o item a seguir. A trombólise é contraindicada para o paciente.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

284275)

Enunciado: Um paciente de 54 anos de idade, com história de hipertensão arterial e dislipidemia, deu entrada no pronto-socorro com queixa de dor torácica retroesternal irradiada para a mandíbula há uma hora. Sinais vitais na entrada: pressão arterial de 140 x 90 mmHg; frequência cardíaca de 92; saturação de O? de 94%; e frequência respiratória de 20. Exame cardiopulmonar: ritmo cardíaco regular, sem sopros; e presença de B3 e B4. Murmúrio vesicular audível bilateralmente, com estertores finos em ambas as bases. Eletrocardiograma revelou infradesnivelamento de ST. Com base nesse caso hipotético, julgue o item a seguir. No momento, está recomendada a prescrição de atenolol 25 mg VO.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

284276)

Enunciado: Um paciente de 54 anos de idade, com história de hipertensão arterial e dislipidemia, deu entrada no pronto-socorro com queixa de dor torácica retroesternal irradiada para a mandíbula há uma hora. Sinais vitais na entrada: pressão arterial de 140 x 90 mmHg; frequência cardíaca de 92; saturação de O? de 94%; e frequência respiratória de 20. Exame cardiopulmonar: ritmo cardíaco regular, sem sopros; e presença de B3 e B4. Murmúrio vesicular audível bilateralmente, com estertores finos em ambas as bases. Eletrocardiograma revelou infradesnivelamento de ST. Com base nesse caso hipotético, julgue o item a seguir. Está indicada a suplementação de oxigênio por cateter nasal.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

261228)

Enunciado: Um paciente de 35 anos de idade iniciou com dor torácica de início súbito, febre (38,5ºC) e dor pleurítica dependente. Foi solicitado um eletrocardiograma que demonstrou infra do segmento PR e supra do segmento ST difuso. Laboratorialmente, o paciente apresentava troponina negativa e 10.000 leucócitos. Considerando esse caso clínico e com base na imagem apresentada e nos conhecimentos médicos correlatados, julgue o item a seguir. Trata-se provavelmente de pericardite aguda.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

261229)

Enunciado: Um paciente de 35 anos de idade iniciou com dor torácica de início súbito, febre (38,5 ºC) e dor pleurítica dependente. Foi solicitado um eletrocardiograma que demonstrou infra do segmento PR e supra do segmento ST difuso. Laboratorialmente o paciente apresentava troponina negativa e 10.000 leucócitos. Considerando esse caso clínico e com base na imagem apresentada e nos conhecimentos médicos correlatados, julgue o item a seguir. Em geral, início súbito dos sintomas é associado ao pior prognóstico em relação a início subagudo.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

261230)

Enunciado: Um paciente de 35 anos de idade iniciou com dor torácica de início súbito, febre (38,5 ºC) e dor pleurítica dependente. Foi solicitado um eletrocardiograma que demonstrou infra do segmento PR e supra do segmento ST difuso. Laboratorialmente o paciente apresentava troponina negativa e 10.000 leucócitos. Considerando esse caso clínico e com base na imagem apresentada e nos conhecimentos médicos correlatados, julgue o item a seguir. É comum associação dessa patologia com edema agudo de pulmão e, consequentemente, insuficiência ventricular esquerda.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

261231)

Enunciado: Um paciente de 35 anos de idade iniciou com dor torácica de início súbito, febre (38,5 ºC) e dor pleurítica dependente. Foi solicitado um eletrocardiograma que demonstrou infra do segmento PR e supra do segmento ST difuso. Laboratorialmente o paciente apresentava troponina negativa e 10.000 leucócitos. Considerando esse caso clínico e com base na imagem apresentada e nos conhecimentos médicos correlatados, julgue o item a seguir. É necessário internar o paciente.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

261232)

Enunciado: Um paciente com história de dor torácica aos esforços comparece à consulta por estar mais cansado do que o normal. Refere que vem apresentando ortopneia e dispneia paroxística noturna. Foram realizados investigação laboratorial, Holter, ecocardiograma e cateterismo cardíaco. O ecocardiograma e o cateterismo estão representados a seguir. Tendo em vista esse caso clínico, as imagens apresentadas e os conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Na imagem do cateterismo, observa-se lesão em artéria descendente anterior.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

261235)

Enunciado: Um paciente de 35 anos de idade, com miocardiopatia isquêmica dilatada com fração de ejeção prévia de 30%, encaminha-se à emergência com dor torácica em aperto há sete horas, dispneia importante e sudorese. Foram solicitados exames laboratoriais que demonstram hemograma normal, função renal e eletrólitos normais. Seu peptídeo natriurético cerebral (BNP) era de 300 pg/mL (valor de referência até 150 pg/dL). Solicitou-se, então o eletrocardiograma representado na figura a seguir. Considerando esse caso clínico, a figura apresentada e os conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. O paciente apresenta-se com infarto agudo do miocárdio anterior.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

261236)

Enunciado: Um paciente de 35 anos de idade, com miocardiopatia isquêmica dilatada com fração de ejeção prévia de 30%, encaminha-se à emergência com dor torácica em aperto há sete horas, dispneia importante e sudorese. Foram solicitados exames laboratoriais que demonstram hemograma normal, função renal e eletrólitos normais. Seu peptídeo natriurético cerebral (BNP) era de 300 pg/mL (valor de referência até 150 pg/dL). Solicitou-se, então o eletrocardiograma representado na figura a seguir. Considerando esse caso clínico, a figura apresentada e os conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Ao avaliar o valor de BNP para esse paciente, pode-se afirmar que ele está com insuficiência cardíaca descompensada.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

274378)

Enunciado: A pericardite é uma doença inflamatória de etiologia autoimune ou infecciosa que acomete o pericárdio e faz parte do diagnóstico diferencial de dor torácica. Atualmente, cerca de 1% dos casos de infarto agudo do miocárdio que têm elevação do segmento ST são, na verdade, pericardite. Sobre esse tema, é correto afirmar que

A) a pericardite bacteriana é a forma infecciosa mais comum.

B) o citomegalovírus é um agente comum em imunodeprimidos e soropositivos.

C) A síndrome de Marfan é uma causa autoimune comum.

D) a forma que ocorre pós-infarto do miocárdio deve ser aventada em sintomas que ocorrem após 3 semanas do evento.

E) a dosagem de BNP e NT-proBNP deve ser rotineira porque indica o prognóstico da doença.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

255667)

Enunciado: Um paciente com angina instável foi submetido a cateterismo cardíaco, que demonstrou lesões de 80% em artéria descendente anterior proximal, coronária direita de 70% em terço medial e lesão de 80% em circunflexa. Foi submetido à cirurgia de revascularização do miocárdio com circulação extracorpórea. O cirurgião utilizou duas pontes de safena e uma mamária, sendo esta por técnica pediculada. Considerando esse caso clínico e os conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Geralmente a técnica pediculada causa mais trauma pleural comparada à esqueletizada.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

255668)

Enunciado: Um paciente com angina instável foi submetido a cateterismo cardíaco, que demonstrou lesões de 80% em artéria descendente anterior proximal, coronária direita de 70% em terço medial e lesão de 80% em circunflexa. Foi submetido à cirurgia de revascularização do miocárdio com circulação extracorpórea. O cirurgião utilizou duas pontes de safena e uma mamária, sendo esta por técnica pediculada. Considerando esse caso clínico e os conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Em geral, nos pacientes com ponte de safena, no primeiro mês, o principal mecanismo de perda do enxerto é trombose.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

255669)

Enunciado: Um paciente com angina instável foi submetido a cateterismo cardíaco, que demonstrou lesões de 80% em artéria descendente anterior proximal, coronária direita de 70% em terço medial e lesão de 80% em circunflexa. Foi submetido à cirurgia de revascularização do miocárdio com circulação extracorpórea. O cirurgião utilizou duas pontes de safena e uma mamária, sendo esta por técnica pediculada. Considerando esse caso clínico e os conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Pacientes com drenagem pleural pós-cirúrgica imediata normalmente vão necessitar de talcagem.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

255691)

Enunciado: Paciente de 35 anos de idade chega ao pronto-socorro com dor torácica em aperto, irradiada para membro superior esquerdo há duas horas. Foi realizado um eletrocardiograma de repouso. Acerca desse caso clínico e tendo em vista os conhecimentos médicos correlatos, considerando o traçado eletrocardiográfico apresentado, julgue o item a seguir. Esse paciente é um candidato a terapia de reperfusão e, com base nas diretrizes da ESC, a trombólise é a opção de escolha.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

255693)

Enunciado: Paciente de 35 anos de idade chega ao pronto-socorro com dor torácica em aperto, irradiada para membro superior esquerdo há duas horas. Foi realizado um eletrocardiograma de repouso. Acerca desse caso clínico e tendo em vista os conhecimentos médicos correlatos, considerando o traçado eletrocardiográfico apresentado, julgue o item a seguir. Provavelmente a lesão culpada é a coronária direita.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

255694)

Enunciado: Paciente de 35 anos de idade chega ao pronto-socorro com dor torácica em aperto, irradiada para membro superior esquerdo há duas horas. Foi realizado um eletrocardiograma de repouso. Acerca desse caso clínico e tendo em vista os conhecimentos médicos correlatos, considerando o traçado eletrocardiográfico apresentado, julgue o item a seguir. Embora tromboaspiração de rotina seja classe III, pelas diretrizes da ESC, em alguns cenários, ela deve ser considerada.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

239284)

Enunciado: Considere uma paciente de 54 anos de idade, diabética (HbA1c = 8,2%), cardiopata isquêmica com infarto agudo do miocárdio prévio e insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Encontra-se em tratamento para diabetes com metformina 850 mg três vezes ao dia e glibenclamida 5 mg pela manhã. No exame físico, chama a atenção a presença de manchas hiperpigmentadas/escurecidas em áreas de dobras. A respeito desse caso clínico e com base nos conhecimentos médicos correlatados, bem como nas últimas diretrizes mundiais relacionadas ao tratamento da diabetes, publicadas em 2019, julgue o item a seguir. Por definição, a paciente tem alto risco cardiovascular.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

239365)

Enunciado: Uma paciente de 58 anos de idade, hipertensa, com história de mau controle, obesidade grau 1, dislipidêmica, tabagista 40 anos/maços, com histórico de participação sem sucesso em programa de abandono ao tabagismo, é atendida em consulta de acolhimento em Unidade de Saúde da Família, após dois anos da última consulta agendada. Alega que procura atendimento em razão da dor de intensidade grau quatro em hemitórax anterior esquerdo há dois dias, contínua, sem irradiações, realizando "sinal do apontamento" para demonstrar local exato da dor, sem fator gatilho ou fator de piora notados. Além disso, relata que vem apresentando tosse não produtiva frequente há um mês, sem febre, dispneia, emagrecimento ou demais comemorativos. Não vem fazendo uso das respectivas medicações, alegando que se esquece de administrá-las. Leva boletim de atendimento em consulta realizada há duas semanas em unidade de pronto atendimento em razão da dor lombar, mostrando receita de corticoide intramuscular fornecida na alta, medicação da qual admite fazer uso com certa frequência, afirmando que esta sempre lhe é prescrita quando consulta na UPA. Mostra também exames realizados, há dois meses, solicitados em consulta médica em clínica popular, com os seguintes resultados: Hb = 13,2 g/dl, Ht = 37,1%, leucócitos = 7,2 mil, plaquetas = 148 mil, Cr = 1,1 mg/dl, Ur = 42 mg/dl, colesterol total = 270 mg/dl, HDL = 38 mg/dl, LDL =192 mg/dl, triglicerídeos = 198 mg/dl e glicemia de jejum = 123 mg/dl. Com relação a esse caso clínico e tendo em vista os conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. As características da dor torácica apresentadas pela paciente resultam em baixo valor preditivo positivo para dor torácica por etiologia cardíaca.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

196641)

Enunciado: Um paciente de 65 anos de idade, diabético, vem apresentando dor torácica de forte intensidade há 30 dias. Foi então submetido a um cateterismo cardíaco, demonstrando lesão grave em artéria descendente anterior, lesão grave em artéria descendente posterior e lesão grave em primeiro ramo marginal. Em relação a esse caso clínico e aos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Obrigatoriamente se deve tratar esse paciente por via cirúrgica.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

196643)

Enunciado: Um paciente de 65 anos de idade, diabético, vem apresentando dor torácica de forte intensidade há 30 dias. Foi então submetido a um cateterismo cardíaco, demonstrando lesão grave em artéria descendente anterior, lesão grave em artéria descendente posterior e lesão grave em primeiro ramo marginal. Em relação a esse caso clínico e aos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Se o caso foi passível de cirurgia, pode-se utilizar a artéria radial como um dos enxertos.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

214514)

Enunciado: Certo paciente de 52 anos de idade compareceu ao pronto atendimento levado pela família, relatando apresentar, há cerca de 30 minutos, desconforto precordial em "aperto", sensação de ansiedade, taquicardia e sudorese. Refere que os sontomas se inciaram após uma discussão exacerbada com os familiares a respeito de "opiniões políticas". Relata quadro prévio de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e hipertensão arterial sistêmica (HAS), em uso de anti-hipertensivos e hipoglicemiantes orais. A esposa informa que o paciente faz uso de inibidores seletivos de recaptação de seratonina (ISRS) para controle de transtorno de ansiedade. Nega uso de outras medicações e alergias medicamentosas. Nega presença de outras comorbidades neuropsiquiátricas prévias ou atuais. Nega histórico prévio de traumas ou de hemorragias por quaisquer vias. Na avaliação inicial, o paciente mostra-se em estado geral regular, com fácies de dor, sem particularidades à ausculta pulmonar e cardíaca. PA=190 mmHg x 120 mmHg; FC=112 bpm; Sat=96%; e FR=28 irpm. A respeito desse caso clínico e considerando os conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. O paciente mencionado apresenta pelo menos três fatores de risco para a presença de aterosclerose (principal fator de risco para doenças isquêmicas do miocárdio) e deve ser avaliada a possibilidade de uma sindrome coronariana aguda.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

214516)

Enunciado: Certo paciente de 52 anos de idade compareceu ao pronto atendimento levado pela família, relatando apresentar, há cerca de 30 minutos, desconforto precordial em "aperto", sensação de ansiedade, taquicardia e sudorese. Refere que os sontomas se inciaram após uma discussão exacerbada com os familiares a respeito de "opiniões políticas". Relata quadro prévio de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e hipertensão arterial sistêmica (HAS), em uso de anti-hipertensivos e hipoglicemiantes orais. A esposa informa que o paciente faz uso de inibidores seletivos de recaptação de seratonina (ISRS) para controle de transtorno de ansiedade. Nega uso de outras medicações e alergias medicamentosas. Nega presença de outras comorbidades neuropsiquiátricas prévias ou atuais. Nega histórico prévio de traumas ou de hemorragias por quaisquer vias. Na avaliação inicial, o paciente mostra-se em estado geral regular, com fácies de dor, sem particularidades à ausculta pulmonar e cardíaca. PA=190 mmHg x 120 mmHg; FC=112 bpm; Sat=96%; e FR=28 irpm. A respeito desse caso clínico e considerando os conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. A presença de um ECG dentro dos padrões de normalidade à chegada e de troponinas sem elevação sugerem um diagnóstico de sintomas de origem psicogênica, provavelmente em razão de um transtorno somatoforme desencadeado por uma crise de ansiedade.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

214519)

Enunciado: Certo paciente de 52 anos de idade compareceu ao pronto atendimento levado pela família, relatando apresentar, há cerca de 30 minutos, desconforto precordial em "aperto", sensação de ansiedade, taquicardia e sudorese. Refere que os sontomas se inciaram após uma discussão exacerbada com os familiares a respeito de "opiniões políticas". Relata quadro prévio de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e hipertensão arterial sistêmica (HAS), em uso de anti-hipertensivos e hipoglicemiantes orais. A esposa informa que o paciente faz uso de inibidores seletivos de recaptação de seratonina (ISRS) para controle de transtorno de ansiedade. Nega uso de outras medicações e alergias medicamentosas. Nega presença de outras comorbidades neuropsiquiátricas prévias ou atuais. Nega histórico prévio de traumas ou de hemorragias por quaisquer vias. Na avaliação inicial, o paciente mostra-se em estado geral regular, com fácies de dor, sem particularidades à ausculta pulmonar e cardíaca. PA=190 mmHg x 120 mmHg; FC=112 bpm; Sat=96%; e FR=28 irpm. A respeito desse caso clínico e considerando os conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Em caso de confirmação diagnóstica de um infarto agudo do miocárdio (IAM) com supradesnivelamento de segmento ST, e havendo a impossibilidade de ancaminhar-se o paciente para realização de reperfusão por angioplastia, pode-se indicar a reperfusão por trombólise, pois ele não apresenta contraindicações absolutas ou fatores de risco para angramentos com o uso de trombolíticos.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

214521)

Enunciado: Certo paciente de 52 anos de idade compareceu ao pronto atendimento levado pela família, relatando apresentar, há cerca de 30 minutos, desconforto precordial em "aperto", sensação de ansiedade, taquicardia e sudorese. Refere que os sintomas se inciaram após uma discussão exacerbada com os familiares a respeito de "opiniões políticas". Relata quadro prévio de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e hipertensão arterial sistêmica (HAS), em uso de anti-hipertensivos e hipoglicemiantes orais. A esposa informa que o paciente faz uso de inibidores seletivos de recaptação de seratonina (ISRS) para controle de transtorno de ansiedade. Nega uso de outras medicações e alergias medicamentosas. Nega presença de outras comorbidades neuropsiquiátricas prévias ou atuais. Nega histórico prévio de traumas ou de hemorragias por quaisquer vias. Na avaliação inicial, o paciente mostra-se em estado geral regular, com fácies de dor, sem particularidades à ausculta pulmonar e cardíaca. PA = 190 mmHg x 120 mmHg; FC=112 bpm; Sat=96%; e FR = 28 irpm. A respeito desse caso clínico e considerando os conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Na confirmação de um IAM com supradesnivelamento de segmento ST, o procedimento de revascularização por angioplastia tem indicação preferencial em relação à revascularização por trombólise, desde que o "tempo porta-balão" não ultrapasse três horas.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

214522)

Enunciado: Certo paciente de 52 anos de idade compareceu ao pronto atendimento levado pela família, relatando apresentar, há cerca de 30 minutos, desconforto precordial em "aperto", sensação de ansiedade, taquicardia e sudorese. Refere que os sintomas se inciaram após uma discussão exacerbada com os familiares a respeito de "opiniões políticas". Relata quadro prévio de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e hipertensão arterial sistêmica (HAS), em uso de anti-hipertensivos e hipoglicemiantes orais. A esposa informa que o paciente faz uso de inibidores seletivos de recaptação de seratonina (ISRS) para controle de transtorno de ansiedade. Nega uso de outras medicações e alergias medicamentosas. Nega presença de outras comorbidades neuropsiquiátricas prévias ou atuais. Nega histórico prévio de traumas ou de hemorragias por quaisquer vias. Na avaliação inicial, o paciente mostra-se em estado geral regular, com fácies de dor, sem particularidades à ausculta pulmonar e cardíaca. PA=190 mmHg x 120 mmHg; FC=112 bpm; Sat=96%; e FR=28 irpm. A respeito desse caso clínico e considerando os conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Pacientes com quadro de DM2 apresentam maior incidência de infarto silencioso e IAM com sintomas atípicos do que pacientes não portadores de DM2.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152119)

Enunciado: Paciente do sexo masculino, 55 anos de idade, hipertenso e diabético, chega ao pronto-socorro com intensa dor torácica, em aperto, irradiada para membro superior direito. Relata dispneia concomitante. Ao exame físico, observava-se bulhas normofonéticas, ritmo regular. Na ausculta, havia estertores em bases pulmonares bilaterais Sat O2 = 90% com óculos nasal complementar. Foi realizado eletrocardiograma que demonstrou supra de ST em D2, D3 e AVF, sendo que o supra D3 é maior que o de D2, e D1 é isoelétrico. Com base neste caso clínico, e considerando os conhecimentos médicos a ele relacionados, julgue o item a seguir. A trombólise, nos primeiros 90 minutos, tem os mesmos resultados na redução de mortalidade que a angioplastia.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152122)

Enunciado: Paciente do sexo masculino, 55 anos de idade, hipertenso e diabético, chega ao pronto-socorro com intensa dor torácica, em aperto, irradiada para membro superior direito. Relata dispneia concomitante. Ao exame físico, observava-se bulhas normofonéticas, ritmo regular. Na ausculta, havia estertores em bases pulmonares bilaterais Sat O2 = 90% com óculos nasal complementar. Foi realizado eletrocardiograma que demonstrou supra de ST em D2, D3 e AVF, sendo que o supra D3 é maior que o de D2, e D1 é isoelétrico. Com base neste caso clínico, e considerando os conhecimentos médicos a ele relacionados, julgue o item a seguir. A artéria acometida provavelmente é a artéria coronária direita.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152129)

Enunciado: Paciente do sexo masculino, 55 anos de idade, hipertenso e diabético, chega ao pronto-socorro com intensa dor torácica, em aperto, irradiada para membro superior direito. Relata dispneia concomitante. Ao exame físico, observavam-se bulhas normofonéticas, ritmo regular. Na ausculta, havia estertores em bases pulmonares bilaterais SatO2 = 90% com óculos nasal complementar. Foi realizado eletrocardiograma que demonstrou supra de ST em D2, D3 e AVF, sendo que o supra D3 é maior que o de DII, e DI é isoelétrico. Com base neste caso clínico, e considerando os conhecimentos médicos a ele relacionados, julgue o item a seguir. A administração, com segurança, de nitroglicerina IV é CORRETA.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152133)

Enunciado: Paciente do sexo masculino, 55 anos de idade, hipertenso e diabético, chega ao pronto-socorro com intensa dor torácica, em aperto, irradiada para membro superior direito. Relata dispneia concomitante. Ao exame físico, observava-se bulhas normofonéticas, ritmo regular. Na ausculta, havia estertores em bases pulmonares bilaterais Sat O2 = 90% com óculos nasal complementar. Foi realizado eletrocardiograma que demonstrou supra de ST em D2, D3 e AVF, sendo que o supra D3 é maior que o de D2, e D1 é isoelétrico. Com base neste caso clínico, e considerando os conhecimentos médicos a ele relacionados, julgue o item a seguir. O diagnóstico é de um infarto agudo do miocárdio com classificação de Killip I.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

131848)

Enunciado: De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, no que se refere ao tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) com desvio de segmento ST, assinale a alternativa CORRETA:

A) A suplementação de oxigênio somente está recomendada aos pacientes que apresentarem saturação sanguínea de oxigênio inferior a 86%, medida por oximetria de pulso.

B) O analgésico de escolha no IAM é o sulfato de morfina, exceto em pacientes que apresentarem IAM complicado por edema agudo de pulmão.

C) O uso de nitratos está indicado especialmente aos pacientes que apresentam bradicardia, taquicardia, pressão arterial sistólica abaixo de 90 mmHg e àqueles que apresentaram queda de mais de 30 mmHg no respectivo nível pressórico basal.

D) Os betabloqueadores aumentam a perfusão miocárdica bem como a função cardíaca e estão indicados, sobretudo, aos pacientes com doença vascular periférica, com bloqueio atrioventricular de terceiro grau, com doença pulmonar obstrutiva crônica, e aos que apresentarem intervalo PR maior que 0,24 segundo no eletrocardiograma.

E) Os antiagregantes plaquetários apresentam benefícios no IAM, sendo que o AAS deve ser administrado aos pacientes o mais rápido possível após o diagnóstico provável, na dose de 160 mg a 325 mg, e a terapia deve ser mantida sem interrupção, na dose diária de 100 mg ao dia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134986)

Enunciado: Um paciente de vinte anos de idade foi internado no pronto-socorro de um hospital, onde recebeu o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Os familiares negaram ocorrência de doenças prévias no paciente. Durante o exame físico, o paciente apresentou quadro de ansiedade e agitação psicomotora, dilatação das pupilas com o emprego de reflexo fotomotor, taquicardia e taquipneia. Além de receber tratamento, o paciente foi submetido à investigação de abuso de drogas. Julgue o item subsequente, relativo a esse caso clínico. A dilatação das pupilas devido ao efeito fotomotor indica uso de opioides.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134995)

Enunciado: Um paciente de vinte anos de idade foi internado no pronto-socorro de um hospital, onde recebeu o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Os familiares negaram ocorrência de doenças prévias no paciente. Durante o exame físico, o paciente apresentou quadro de ansiedade e agitação psicomotora, dilatação das pupilas com o emprego de reflexo foto motor, taquicardia e taquipneia. Além de receber tratamento, o paciente foi submetido à investigação de abuso de drogas. Julgue o item subsequente, relativo a esse caso clínico. Nesse caso, a detecção de uso de drogas por meio do exame de urina pressupõe uso recente dessas drogas.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

140746)

Enunciado: Uma paciente de sessenta e três anos de idade foi atendida no setor de emergência de um hospital terciário apresentando dor retroesternal, em aperto, de forte intensidade, irradiada para a região epigástrica e para o ombro esquerdo, associada a náuseas e um episódio de vômito; sintomas que haviam iniciado, segundo a paciente, cerca de seis horas antes do atendimento no hospital, durante uma discussão com o seu cônjuge. Ela relatou, ainda, ter hipertensão arterial, em uso irregular de anti-hipertensivo, colesterol elevado, e que era tabagista crônico. No exame clínico, constatou-se que a paciente estava consciente, orientada, eupneica, ansiosa, e apresentou os seguintes dados clínicos: pressão arterial de 148 mmHg x 92 mmHg (em ambos os membros superiores, em posição de decúbio dorsal); frequência cardíaca de 98 bpm; frequência respiratória de 27 irpm, com saturação de oxigênio à oximetria de pulso a 94%; ritmo cardíaco regular em três tempos, à custa de quarta bulha, sem sopros; pulsos arteriais palpáveis e simétricos; pulmões limpos; abdome livre; e extremidades sem cianose ou edema. Os resultados do eletrocardiograma revelaram ritmo sinusal, com frequência ventricular média de 95 spm (sístoles/minuto); eixo elétrico do complexo QRS = +30°; presença de raras e isoladas extrassístoles ventriculares monomórficas; supradesnivelamento do segmento ST (de 5 mm), com convexidade para baixo, associado à onda T negativa nas derivações D2, D3 e aVF, onde também foi observada onda Q profunda e alargada. Os resultados da radiografia de tórax (projeções PA e perfil, com esôfago constrastado) mostraram área cardíaca normal, pulmões sem anormalidades e ectasia leve da aorta torácica. A dosagem de troponina T sanguínea foi de 1,8 ng/mL (valor de referência < 0,1 ng/mL). Com base nesse caso clínico, julgue o item a seguir. O principal diagnóstico para a paciente desse caso clínico é de angina instável.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

140748)

Enunciado: Uma paciente de sessenta e três anos de idade foi atendida no setor de emergência de um hospital terciário apresentando dor retroesternal, em aperto, de forte intensidade, irradiada para a região epigástrica e para o ombro esquerdo, associada a náuseas e um episódio de vômito; sintomas que haviam iniciado, segundo a paciente, cerca de seis horas antes do atendimento no hospital, durante uma discussão com o seu cônjuge. Ela relatou, ainda, ter hipertensão arterial, em uso irregular de anti-hipertensivo, colesterol elevado, e que era tabagista crônico. No exame clínico, constatou-se que a paciente estava consciente, orientada, eupneica, ansiosa, e apresentou os seguintes dados clínicos: pressão arterial de 148 mmHg x 92 mmHg (em ambos os membros superiores, em posição de decúbio dorsal); frequência cardíaca de 98 bpm; frequência respiratória de 27 irpm, com saturação de oxigênio à oximetria de pulso a 94%; ritmo cardíaco regular em três tempos, à custa de quarta bulha, sem sopros; pulsos arteriais palpáveis e simétricos; pulmões limpos; abdome livre; e extremidades sem cianose ou edema. Os resultados do eletrocardiograma revelaram ritmo sinusal, com frequência ventricular média de 95 spm (sístoles/minuto); eixo elétrico do complexo QRS = +30°; presença de raras e isoladas extrassístoles ventriculares monomórficas; supradesnivelamento do segmento ST (de 5 mm), com convexidade para baixo, associado à onda T negativa nas derivações D2, D3 e aVF, onde também foi observada onda Q profunda e alargada. Os resultados da radiografia de tórax (projeções PA e perfil, com esôfago constrastado) mostraram área cardíaca normal, pulmões sem anormalidades e ectasia leve da aorta torácica. A dosagem de troponina T sanguínea foi de 1,8 ng/mL (valor de referência < 0,1 ng/mL). Com base nesse caso clínico, julgue o item a seguir. Nesse caso clínico, como foi ultrapassada a "janela terapêutica" e não há evidências de necrose miocárdica, são contraindicados tanto o uso de medicamentos trombolíticos como a realização de angioplastia coronariana transluminal percutânea primária.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

135056)

Enunciado: Com relação aos tratamentos de doenças cardiovasculares, julgue o item seguinte. O tratamento de dislipidemias, realizado com estatinas, causa efeitos adversos como dor muscular e fraqueza. Para evitar toxicidade excessiva do medicamento, é necessário que se monitorem os níveis de CPK. As enzimas TGO e TGP devem ser analisadas no momento anterior ao início do tratamento, bem como três meses após. No caso de alterações nas dosagens das enzimas três vezes acima do considerado normal, deve-se suspender o tratamento medicamentoso.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

140723)

Enunciado: Durante consulta, um paciente de cinquenta e sete anos de idade, com histórico de hipertensão arterial sistêmica e tabagismo, reportou que, havia uma semana, vinha tendo episódios de dor retroesternal opressiva, de moderada intensidade, com irradiação para membro superior esquerdo. A dor geralmente surgia durante pequenos esforços habituais com o banho. Ele acrescentou que, no dia anterior à consulta, tivera, em momento de repouso, dois episódios de dor com as mesmas características, que cessaram em torno de vinte minutos. Na consulta, foi detectado que o paciente apresentava precordialgia que já persistia havia três horas com as mesmas características descritas anteriormente. No exame físico, constatou-se que o paciente estava com saturação de oxigênio de 93% (em ar ambiente), pressão arterial de 136 mmHg x 74 mmHg (aferida por três vezes), frequência cardíaca de 76 bpm e ritmo cardíaco regular em dois tempos sem sopros. O restante do exame físico foi normal. Os resultados da dosagem de CK-MB massa e da troponina, no momento de admissão no pronto-socorro, foram normais. O paciente foi submetido à realização de eletrocardiograma (com calibração padrão), cujo resultado está apresentado na figura precedente (VER IMAGEM). Com base nas informações presentes no texto e na figura referente a esse caso clínico, julgue o item a seguir. Os resultados dos exames indicam que esse é um caso de anginina instávelde início recente.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

105561)

Enunciado: Os principais fatores de risco do infarto do miocárdio e das doenças cerebrovasculares são a hipertensão, o tabagismo, o colesterol elevado e o diabetes. Em relação às características desses fatores de risco, assinale a alternativa CORRETA.

A) Hipertensão arterial: acarreta maior mortalidade por infarto do miocárdio que por doença cerebrovascular.

B) Tabagismo: a interrupção do fumo é a intervenção com maior impacto na redução do risco cardiovascular, mas esses benefícios são demorados.

C) Colesterol elevado: há uma relação direta entre dislipidemias e aterosclerose, especialmente com relação a níveis elevados de colesterol total, triglicérides, colesterol HDL (High Density Lipoprotein) ou valores reduzidos de colesterol LDL (Low Density Lipoprotein).

D) Diabetes: principalmente o tipo I, associado diretamente à obesidade e ao ganho de peso.

E) Uso de anticoncepcionais hormonais femininos: deve ser evitado, pois aumenta muito o risco de complicações circulatórias, incluindo tromboses venosas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

108184)

Enunciado: Um paciente de sessenta anos de idade compareceu à emergência de um hospital queixando-se de dor precordial em aperto de forte intensidade que tinha se iniciado, havia trinta minutos, imediatamente após acordar. O exame físico mostrou pressão arterial de 150 x 100 mmHg, frequência cardíaca de 100 bpm, frequência respiratória de 20 irpm, temperatura de 36°C e saturação de oxigênio de 97%. A ausculta cardíaca mostrou ritmo cardíaco em 3 tempos com presença da quarta bulha. Com referência ao caso clínico apresentado, julgue o item seguinte. A presença de quarta bulha aumenta a probabilidade de que a dor seja decorrente de síndrome coronariana.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

108189)

Enunciado: Um paciente de sessenta anos de idade compareceu à emergência de um hospital queixando-se de dor precordial em aperto de forte intensidade que tinha se iniciado, havia trinta minutos, imediatamente após acordar. O exame físico mostrou pressão arterial de 150 mmHg x 100 mmHg, frequência cardíaca 100 bpm, frequência respiratória de 20 irpm, temperatura de 36°C e saturação de oxigênio de 97%. A ausculta cardíaca mostrou ritmo cardíaco em 3 tempos com presença da quarta bulha. Com referência ao caso clínico apresentado, julgue o item seguinte. O paciente em questão deve ser submetido imediatamente a exame de eletrocardiograma.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

108151)

Enunciado: Um paciente de sessenta anos de idade compareceu à emergência de um hospital queixando-se de dor precordial em aperto de forte intensidade que tinha se iniciado, havia trinta minutos, imediatamente após acordar. O exame físico mostrou pressão arterial de 150 mmHg x 100 mmHg, frequência cardíaca 100 bpm, frequência respiratória de 20 irpm, temperatura de 36°C e saturação de oxigênio de 97%. A ausculta cardíaca mostrou ritmo cardíaco em 3 tempos com presença da quarta bulha. Com referência ao caso clínico apresentado, julgue o item seguinte. Se o paciente apresentasse, no momento da admissão, medida sérica da troponina em nível normal, a hipótese de infarto agudo do miocárdio estaria excluída.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

108234)

Enunciado: Uma paciente de sessenta e três anos de idade, com antecedente de doença aterosclerótica arterial coronária, dislipidemia, sedentarismo e hipertensão arterial sistêmica, compareceu ao ambulatório para um exame periódico. A paciente estava assintomática e relatou uso regular de atenolol e ácido acetilsalicílico nas doses diárias de 50 mg e 100 mg, respectivamente. Ao exame físico, a paciente apresentou peso de 93 kg, altura de 1,65 m, circunferência abdominal de 99 cm, pressão arterial de 152 x 94 mmHg (posição sentada, média de três aferições), frequência cardíaca de 62 bpm e o restante do exame físico não apresentou alterações. Os exames complementares revelaram creatinina de 0,9 mg/dl, albuminúria (em amostra isolada de urina) de 118 mg de albumina por grama de creatinina, colesterol total de 190 mg/dl, HDL-colesterol de 32 mg/dl, LDL-colesterol de 114 mg/dl, triglicérides de 220 mg/dl e glicemia, em jejum, igual a 101 mg/dl. O eletrocardiograma apresentou resultado dentro da normalidade. Com relação ao caso clínico acima apresentado julgue o item seguinte. No caso em apreço, a paciente deverá ser estratificada pelo escore de risco de Framingham quanto à probabilidade de ocorrer infarto do miocárdio ou morte, a fim de se estabelecer a necessidade de exames invasivos.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

108235)

Enunciado: Uma paciente de sessenta e três anos de idade, com antecedente de doença aterosclerótica arterial coronária, dislipidemia, sedentarismo e hipertensão arterial sistêmica, compareceu ao ambulatório para um exame periódico. A paciente estava assintomática e relatou uso regular de atenolol e ácido acetilsalicílico nas doses diárias de 50 mg e 100 mg, respectivamente. Ao exame físico, a paciente apresentou peso de 93 kg, altura de 1,65 m, circunferência abdominal de 99 cm, pressão arterial de 152 x 94 mmHg (posição sentada, média de três aferições), frequência cardíaca de 62 bpm e o restante do exame físico não apresentou alterações. Os exames complementares revelaram creatinina de 0,9 mg/dl, albuminúria (em amostra isolada de urina) de 118 mg de albumina por grama de creatinina, colesterol total de 190 mg/dl, HDL-colesterol de 32 mg/dl, LDL-colesterol de 114 mg/dl, triglicérides de 220 mg/dl e glicemia, em jejum, igual a 101 mg/dl. O eletrocardiograma apresentou resultado dentro da normalidade. Com relação ao caso clínico acima apresentado julgue o item seguinte. A paciente em questão deverá ser submetida a terapia nutricional e a mudanças no estilo de vida nos próximos seis meses. Se, após esse período, a paciente não apresentar melhora em sua condição clínica, deve-se prescrever estatina para a redução dos níveis lipídicos.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

85508)

Enunciado: Paciente de quarenta e oito anos de idade foi levado ao serviço de pronto-socorro com relato de que, havia três horas, começou a sentir forte dor retroesternal, em aperto e peso, irradiada para a face lateral esquerda do pescoço e para o braço esquerdo, além de sudorese profusa. O paciente, que negou ter diabetes melito, informou ter diagnóstico de hipertensão arterial, teor de colesterol aumentado e ser fumante. Ao exame físico, na sala de emergência, apresentou pressão arterial de 130 mmHg × 85 mmHg, frequência cardíaca de 98 bpm, ritmo cardíaco regular à custa de quarta bulha cardíaca, sem sopros, e pulsos arteriais palpáveis e simétricos. O paciente não apresentava alterações pulmonares e, durante o exame de oximetria de pulso, respirando ar ambiente, a saturação de oxigênio foi de 92%. Foi realizado o eletrocardiograma de 12 derivações ? calibração: 1 cm = 1 mV e velocidade do papel = 25 mm/s ?, apresentado na figura a seguir (VER IMAGEM). Com base no quadro clínico apresentado e nas principais alterações observadas no traçado eletrocardiográfico, faça o que se pede a seguir. Indique o ritmo cardíaco de base.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

85509)

Enunciado: Paciente de quarenta e oito anos de idade foi levado ao serviço de pronto-socorro com relato de que, havia três horas, começou a sentir forte dor retroesternal, em aperto e peso, irradiada para a face lateral esquerda do pescoço e para o braço esquerdo, além de sudorese profusa. O paciente, que negou ter diabetes melito, informou ter diagnóstico de hipertensão arterial, teor de colesterol aumentado e ser fumante. Ao exame físico, na sala de emergência, apresentou pressão arterial de 130 mmHg × 85 mmHg, frequência cardíaca de 98 bpm, ritmo cardíaco regular à custa de quarta bulha cardíaca, sem sopros, e pulsos arteriais palpáveis e simétricos. O paciente não apresentava alterações pulmonares e, durante o exame de oximetria de pulso, respirando ar ambiente, a saturação de oxigênio foi de 92%. Foi realizado o eletrocardiograma de 12 derivações ? calibração: 1 cm = 1 mV e velocidade do papel = 25 mm/s ?, apresentado na figura a seguir (VER IMAGEM). Com base no quadro clínico apresentado e nas principais alterações observadas no traçado eletrocardiográfico, faça o que se pede a seguir. Especifique as principais alterações morfológicas presentes.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

85510)

Enunciado: Paciente de quarenta e oito anos de idade foi levado ao serviço de pronto-socorro com relato de que, havia três horas, começou a sentir forte dor retroesternal, em aperto e peso, irradiada para a face lateral esquerda do pescoço e para o braço esquerdo, além de sudorese profusa. O paciente, que negou ter diabetes melito, informou ter diagnóstico de hipertensão arterial, teor de colesterol aumentado e ser fumante. Ao exame físico, na sala de emergência, apresentou pressão arterial de 130 mmHg × 85 mmHg, frequência cardíaca de 98 bpm, ritmo cardíaco regular à custa de quarta bulha cardíaca, sem sopros, e pulsos arteriais palpáveis e simétricos. O paciente não apresentava alterações pulmonares e, durante o exame de oximetria de pulso, respirando ar ambiente, a saturação de oxigênio foi de 92%. Foi realizado o eletrocardiograma de 12 derivações ? calibração: 1 cm = 1 mV e velocidade do papel = 25 mm/s ?, apresentado na figura a seguir (VER IMAGEM). Com base no quadro clínico apresentado e nas principais alterações observadas no traçado eletrocardiográfico, faça o que se pede a seguir. Apresente as conclusões do ECG ? principal diagnóstico clínico do paciente.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

88682)

Enunciado: Uma paciente de sessenta e oito anos de idade, com antecedentes de tabagismo e diabetes, refere que, há quatro horas, iniciou um quadro de dor retroesternal em peso de forte intensidade, com erradiação para o membro superior esquerdo e sem alívio com o uso de dipirona. No exame físico, a paciente apresentou-se eupneica e acianótica, com pressão arterial de 132 mmHg x 84 mmHg, frequência cardíaca de 78 bpm e ritmo cardíaco regular em dois tempos sem sopros. O eletrocardiograma revelou supradesnível do segmento ST na parede anterior do ventrículo esquerdo. A dosagem das enzimas cardíacas (CK-MB massa e troponina), o exame de raios X de tórax e os demais exames laboratoriais de rotina foram normais. Considerando esse caso clínico, julgue o próximo item. A realização da cintilografia de perfusão miocárdica, com aplicação do radiofármaco no estresse farmacológico, é indicada para detecção e localização da isquemia.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

88708)

Enunciado: Uma paciente de sessenta e oito anos de idade, com antecedentes de tabagismo e diabetes, refere que, há quatro horas, iniciou um quadro de dor retroesternal em peso de forte intensidade, com irradiação para o membro superior esquerdo e sem alívio com o uso de dipirona. No exame físico, a paciente apresentou-se eupneica e acianótica, com pressão arterial de 132 mmHg x 84 mmHg, frequência cardíaca de 78 bpm e ritmo cardíaco regular em dois tempos sem sopros. O eletrocardiograma revelou supradesnível do segmento ST na parede anterior do ventrículo esquerdo. A dosagem das enzimas cardíacas (CK-MB massa e troponina), o exame de raios X de tórax e os demais exames laboratoriais de rotina foram normais. Considerando esse caso clínico, julgue o próximo item. O quadro descrito é de angina instável de recente começo.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

88714)

Enunciado: Uma paciente de sessenta e oito anos de idade, com antecedentes de tabagismo e diabetes, refere que, há quatro horas, iniciou um quadro de dor retroesternal em peso de forte intensidade, com irradiação para o membro superior esquerdo e sem alívio com o uso de dipirona. No exame físico, a paciente apresentou-se eupneica e acianótica, com pressão arterial de 132 mm/Hg × 84 mm/Hg, frequência cardíaca de 78 bpm e ritmo cardíaco regular em dois tempos sem sopros. O eletrocardiograma revelou supradesnível do segmento ST na parede anterior do ventrículo esquerdo. A dosagem das enzimas cardíacas (CK-MB massa e troponina), o exame de raios X de tórax e os demais exames laboratoriais de rotina foram normais. Considerando esse caso clínico, julgue o próximo item. A paciente deve ser tratada com ácido acetilsalicílico, clopidogrel e betabloqueador.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

82068)

Enunciado: Um paciente de quarenta e oito anos de idade buscou atendimento no ambulatório com relato de dor retroesternal em aperto com irradiação para o membro superior esquerdo, desencadeada por atividades físicas e melhorada com repouso. A investigação mais aprofundada da condição mostrou que o paciente apresentava angina estável. Acerca dessa cardiopatia, julgue o item seguinte. A suficiência coronariana depende do equilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio para o miocárdio, que, por sua vez, é determinada por frequência cardíaca, pressão arterial sistólica, estresse da parede miocárdica e contratilidade miocárdica.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

88622)

Enunciado: Com relação aos pacientes com dislipidemias, julgue o item seguinte. Os estudos atuais comprovam a eficácia e a segurança do uso de estatinas durante a gestação e a lactação em mulheres com dislipidemia.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

88635)

Enunciado: Com relação aos pacientes com dislipidemias, julgue o item seguinte. A modificação dos hábitos de vida (alimentação saudável, prática regular de atividades físicas, manutenção do índice de massa corporal saudável) é parte essencial do acompanhamento desses pacientes e tem impacto significativo na redução do risco de doença aterosclerótica cardiovascular dos indivíduos.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

88634)

Enunciado: Acerca de doenças cardiovasculares e hipertensão, julgue o item a seguir. Pacientes adultos, tabagistas e portadores de hipertensão ou diabetes apresentam alto risco de desenvolver doenças cardiovasculares.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

49193)

Enunciado: Um paciente de sessenta anos de idade procurou atendimento no setor de emergência de um hospital secundário (sem laboratório de cardiologia intervencionista), queixando-se de dor retroesternal de forte intensidade, em aperto, com irradiação para o membro superior esquerdo, associada a vômitos e sudorese profusa. Relatou que a dor, de início súbito, o acordou havia quatro horas. Informou que sofria de hipercolesterolemia e que seus pais faleceram de ataque cardíaco. Negou diabetes melito ou hipertensão arterial pregressa. O resultado do exame físico indicou pressão arterial de 140 mmHg x 85 mmHg, frequência cardíaca de 90 bpm, ritmo cardíaco regular à custa de quarta bulha cardíaca, sem sopros, pulsos arteriais palpáveis e simétricos, pulmões sem alterações, saturação de oxigênio com 92% na oximetria de pulso (sem oxigênio complementar). Na sala de emergência, foi realizado eletrocardiograma cujo traçado é ilustrado abaixo (calibração: 1 cm = 1 mV; velocidade do papel: 25 mm/s) (VER IMAGEM). Considerando o caso clínico e o traçado eletrocardiográfico apresentados acima, indique as principais alterações eletrocardiográficas observadas, descrevendo, necessariamente, o ritmo cardíaco, a frequência ventricular média, o eixo elétrico médio do complexo QRS (SÂQRS), a(s) principal(ais) alteração(ões) morfológica(s) e funcional(is) presente(s) e, por fim, a conclusão.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

52638)

Enunciado: Julgue o item a seguir, relativo a emergências cardiovasculares. O uso de medicamentos betabloqueadores não é recomendado nas fases iniciais do tratamento de pacientes com síndromes coronarianas agudas relacionadas ao uso de cocaína; essas medicações podem acentuar a vasoconstrição coronariana e a hipertensão arterial sistêmica nessas situações.

A) Certo

B) Errado

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

37943)

Enunciado: Uma senhora de 67 anos de idade, que teve diagnóstico de infarto do miocárdio por doença coronariana aterosclerótica, há 6 meses, vem fazendo acompanhamento periódico e regular com cardiologista, sem sintomas. Em sua última consulta, ela relatou que, nos últimos 30 dias, passou a apresentar muita fadiga e cansaço aos pequenos esforços e voltou a apresentar episódios de dor precordial do tipo anginosa, que, inicialmente, ocorriam aos grandes esforços e, na última semana, passaram a ocorrer aos médios esforços, que melhoram com o repouso e, às vezes, com o uso de nitrato sublingual. Ela também informou que estava apresentando sudorese noturna excessiva (sem relação com esforços físicos ou com a dor anginosa). Em seu exame físico, apresentava: pressão arterial de 125 x 80 mmHg, frequência cardíaca de 60 bpm, ritmo cardíaco regular em 3 tempos (à custa de quarta bulha), pulmões limpos, presença de esplenomegalia (baço palpável a 14 cm abaixo da borda costal esquerda na posição intermediária de Schuster), fígado impalpável (hepatimetria de 8 cm), sem edemas ou lesões. O exame hematológico mostrou hemoglobina de 10,0 g/dl, leucócitos totais = 105.000 céls/mm³ (aumento de neutrófilos, bastonetes, metamielócitos e também de eosinófilos e basófilos); a contagem de plaquetas foi de 780.000/mm³. O ácido úrico sérico foi de 14 mg/dl. Diante do quadro, o cardiologista suspeitou de doença hematológica e encaminhou-a ao hematologista. Foi então realizado um exame de biópsia da medula óssea (mielograma), que evidenciou medula hipercelular com granulócitos em diferentes estágios de maturação (bastonetes, metamielócitos, mielócitos, promielócitos e mieloblastos), aumento de eosinófilos e basófilos. O exame citogenético detectou uma translocação recíproca entre os braços longos dos cromossomas 9 e 22, levando à formação de um novo gene específico, o BCR-ABL. O traçado do último Eletrocardiograma (ECG) convencional realizado é apresentado abaixo. Tendo por base as informações clínicas e laboratoriais apresentadas no texto acima, julgue o item. "A análise do ECG permite concluir que a paciente apresentou infarto do miocárdio localizado na parede inferior."

A) Certo.

B) Errado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

8603)

Enunciado: Homem de 53 anos de idade, com queixa de dor abdominal intensa, há 1 hora, em epigástrio e região retroesternal, com irradiação para todo o abdome. Tem como antecedentes pessoais o diagnóstico prévio de insuficiência coronariana, com revascularização do miocárido há 5 anos e hipertensão arterial sistêmica. Faz uso regular de ácido acetilsalicílico - 200 mg/dia, propranol 120 mg/dia e dinitrato de isosorbida 120 mg/dia. Ao exame clínico apresenta pressão arterial = 160 x 84 mmHg, pulso = 108 bpm, frequência respiratória = 30 incursões/minuto. Semiologia cardiopulmonar normal. Dor difusa à palpação do abdome, com resistência voluntária. Não há outras alterações ao exame clínico. Feito eletrocardiograma (infarto antigo apical) e a radiografia a seguir: (VER IMAGEM). O diagnóstico e a conduta para o caso são:

A) Pneumotórax, internação, drenagem em selo d´água, tomografia de tórax.

B) Angina instável, internação, cateterismo cardíaco, revascularização.

C) Retenção de gases, dimeticona (V.O.)+ omeprazole (E.V.), observação.

D) Dissecção de aorta, internação, angioressonância, cirurgia.

E) Abdome agudo, sonda nasogástrica aberta, soro de manutenção E.V., cirurgia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343391)

Enunciado: Acerca do manuseio de pacientes com dor torácica, é CORRETO afirmar:

A) A pericardite pode ser confundida com angina, pois costuma causar dor precordial em aperto, aliviada pelo repouso e pela nitroglicerina, mas que piora com a respiração profunda.

B) A dor torácica que acompanha a pneumonia é bastante variável, tanto em intensidade quanto em característica, refletindo geralmente acometimento pulmonar periférico, com estimulação das terminações nervosas da pleura.

C) Os transtornos psiquiátricos não podem e não devem ser diagnosticados como a causa de dor torácica em um paciente, pelo risco de uma desordem orgânica de base ser negligenciada.

D) A dor torácica causada por patologia esofágica é localizada na região central do tórax, dura de segundos a poucos minutos, sendo frequentemente descrita pelo paciente como pontada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

334883)

Enunciado: Um paciente de 61 anos de idade, sedentário, obeso e tabagista, há duas horas iniciou epigastralgia em queimação de forte intensidade após o almoço. O exame físico mostrou uma frequência cardíaca igual a 60 bpm, frequência respiratória = 25 irpm, SatO2 = 92% e PA = 100 mmHg x 60 mmHg, com ausculta cardíaca e pulmonar normais e sem edema de membros inferiores. Na admissão em uma unidade de pronto atendimento, ele realizou o eletrocardiograma (ECG) a seguir. Qual é a principal hipótese de diagnóstico?

A) Bloqueio de ramo direito.

B) Infarto agudo do miocárdio

C) Síndrome de Wolf Parkinson White

D) Hipertonia vagal

E) Fibrilação atrial

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

291558)

Enunciado: Uma mulher com 55 anos de idade procura a unidade de emergência referenciada com queixa de dor precordial em aperto há 12 horas. Antecedentes pessoais: diabética tipo 2, há 12 anos, em uso de metformina 1.500 mg ao dia e glicazida 30 mg ao dia, hipertensão arterial, há 8 anos, em uso de captopril 150 mg ao dia. Exame físico da admissão: PA = 100 x 60 mmHg, FC = 70 bpm, FR = 18 irpm, Sat = 92%. Ritmo cardíaco regular em 2 tempos sem sopros, murmúrio vesicular presente e simétrico com estertores crepitantes em base, abdome globoso, fígado a 4 cm do rebordo costal direito, baço não percutível. Extremidades: pulsos periféricos diminuído, edema 3+/4+. ECG a seguir: Diante do quadro apresentado, o diagnóstico e tratamento são:

A) Infarto agudo do miocárdio e trombólise com ateplase.

B) Infarto do miocárdio evoluído e cateterismo.

C) Síndrome coronariana aguda e balão intra-aórtico.

D) Pericardite aguda e colchicina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

230548)

Enunciado: Considerada recomendação para uso de antiagregantes plaquetários e anticoagulantes em pacientes oncológicos com trombocitopenia o item:

A) Uso do ácido acetilsalicílico em pacientes com doença coronária.

B) O ácido acetilsalicílico deve ser usado sempre em dose máxima, preferencialmente ? 500 mg ao dia.

C) Uso de terapia antiplaquetária e/ou anticoagulante em pacientes com síndrome coronária aguda, exceto caso com plaquetopenia.

D) Uso de dose reduzida de enoxaparina e heparina não fracionada em pacientes com contagem de plaquetas < 150.000.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

244470)

Enunciado: Um paciente de 55 anos de idade procurou atendimento médico de emergência em razão de dor precordial retroesternal de forte intensidade tipo queimação, iniciado em repouso com duração de 24 horas. O paciente tinha consciência de ser hipertenso, sedentário e fumante há 40 anos. Ao exame físico, verificaram-se FC = 115 bpm, pulsos simétricos, porém de baixa amplitude em MMSS e MMII, perfusão periférica lentificada, PA = 90 mmHg x 50 mmHg, SatO2 = 90% em ar ambiente e FR = 25 irpm. O exame pulmonar não mostrou alterações. A avaliação cardíaca mostrou bulhas hipofonéticas com sopro sistólico 4+/6+ na borda esternal esquerda inferior e na área mitral, e turgência de jugulares. O eletrocardiograma inicial mostrou FC de 115 bpm, ritmo sinusal, elevação do ST nas derivações de DII, III e a VF. Em relação a esse caso clínico e aos conhecimentos médicos referentes a infarto agudo do miocárdio (IAM), assinale a alternativa correta.

A) O derrame pericárdico é uma complicação mecânica do IAM comum em idosos, mulheres e diabéticos. Geralmente, ocorre 24 horas após o infarto ou entre o terceiro e o quinto dia; tem incidência de 18% a 36,2%.

B) A terapia fibrinolítica deverá ser instituída no paciente, pois estudos atuais indicam benefício em até 48 horas do início da dor.

C) Se houver evidência de eletrocardiograma de isquemia da parede inferior (alterações da onda ST ou T nas derivações II, III e a VF), as derivações do lado direito V4R, V5R e V6R também devem ser obtidas para avaliar a possibilidade de infarto do ventrículo direito.

D) O paciente apresenta escore prognóstico intra-hospitalar pelo TIMI risk de alto risco, com base nos seguintes parâmetros: sopro sistólico, hipoxemia, taquidispneia, hipotensão, idade e tempo de dor.

E) O paciente deve receber lidocaína intravenosa como prevenção para arritmias de reperfusão, caso ele mesmo seja submetido a terapia trombolítica ou a cateterismo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

230556)

Enunciado: A morfologia da Placa Aterosclerótica (PC) tem um papel importante na ocorrência de eventos cerebrovasculares e pode também ser um importante preditor de evento. Assim podemos APENAS aceitar que:

A) O reconhecimento das características ultrassonográficas da placa pode atrapalhar a identificação de uma placa instável.

B) O reconhecimento das características ultrassonográficas da placa não altera a identificação de uma placa instável.

C) O reconhecimento das características ultrassonográficas da placa não facilita a identificação de uma placa estável.

D) O reconhecimento das características ultrassonográficas da placa pode facilitar a identificação de uma placa instável.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

206086)

Enunciado: As categorias de risco baixo e intermediário cardiovascular são baseadas apenas na idade e nos Estratificadores de Risco (ER). Doença aterosclerótica subclínica não está presente nestes grupos de risco. Determine qual dos itens abaixo não se enquadra no seu quadro:

A) Escore de cálcio arterial coronário > 10 U Agatston.

B) Placa carotídea (espessura íntima média > 1,5 mm)14.

C) Angiotomografia coronária computadorizada com presença de placa 15?.

D) Índice tornozelo braquial < 0,7

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

206135)

Enunciado: A Calcificação Arterial Coronariana (CAC) está associada a eventos cardiovasculares e mortalidade em pacientes com diabetes. Podemos apenas ACEITAR que:

A) O rastreamento de aterosclerose clínica, não se utilizando o escore de cálcio coronário, pode ser considerado em indivíduos com fatores de risco no início da idade adulta, para melhor discriminar o risco cardiovascular em prevenção primária.

B) O rastreamento de aterosclerose subclínica, utilizando-se o escore de cálcio coronário, pode ser considerado em indivíduos com fatores de risco no início da terceira idade, para pior discriminar o risco cardiovascular em prevenção primária.

C) O rastreamento de aterosclerose subclínica, utilizando-se o escore de cálcio endotelial, pode ser desconsiderado em indivíduos com fatores de risco no início da idade adulta, para melhor discriminar o risco cardiovascular em prevenção primária.

D) O rastreamento de aterosclerose subclínica, utilizando-se o escore de cálcio coronário, pode ser considerado em indivíduos com fatores de risco no início da idade adulta, para melhor discriminar o risco cardiovascular em prevenção primária.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

206147)

Enunciado: Considere a investigação de isquemia miocárdica em pacientes com diabetes, assintomáticos e na presença dos achados abaixo descritos, indique o INCORRETO:

A) Alterações de ECG de repouso.

B) Pacientes que apresentam sintomas atípicos.

C) Pacientes que apresentam dispneia inexplicada, dor torácica atípica ou desconforto.

D) Calcificação arterial coronariana CAC muito alta (> 100).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

206151)

Enunciado: Em indivíduos com diabetes, o SPECT tem maior sensibilidade e especificidade do que o teste ergométrico. Estando de acordo com o seguinte item:

A) A cintilografia do miocárcio (SPECT) com tálio ou a cintilografia miocárdica de perfusão com Tc-99m sestamibi fornecem ampla

gama de informações, incluindo localização e extensão da isquemia e função ventricular esquerda.

B) A cintilografia do miocárcio (SPECT) com tálio ou a cintilografia miocárdica de perfusão com Tc-99m sestamibi fornecem informações restritas, excluindo localização e extensão da isquemia e função ventricular esquerda.

C) A cintilografia do miocárcio (SPECT) com tálio ou a cintilografia miocárdica de perfusão com Tc-99m sestamibi fornecem ampla gama de informações, incluindo localização e extensão da isquemia, mas não a função ventricular esquerda.

D) A cintilografia do miocárcio (SPECT) com tálio ou a cintilografia miocárdica de perfusão com Tc-99m sestamibi fornecem ampla gama de informações, excluindo localização e extensão da isquemia e função ventricular esquerda.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

203106)

Enunciado: Um paciente de 60 anos de idade é internado em razão de dor torácica típica de síndrome coronariana com duração de duas horas. Ele apresenta frequência cardíaca de 42 bpm, com bradicardia sinusal observada e confirmada no ECG, associada ao supradesnivelamento do segmento ST nas derivações DII, DIII e AVF. No que se refere a esse caso clínico, assinale a alternativa correta.

A) O paciente provavelmente tem um aneurisma de ventrículo esquerdo como complicação do infarto agudo do miocárdio.

B) O paciente apresenta quadro de infarto agudo do miocárdio de parede inferior, pois a artéria coronária direita irriga a parede inferior do ventrículo esquerda e o nó sinusal.

C) A bradicardia sinusal apresentada pelo paciente é fator protetor do aumento da área de isquemia. Assim, não deve ser considerada como fenômeno patológico.

D) O paciente apresenta infarto agudo do miocárdio de ventrículo direito, pois as derivações descritas são da artéria circunflexa e coronária direita.

E) O ECG com supradesnivelamento do segmento ST, bem como o tempo de dor torácica, indicam que esse paciente não é candidato a terapia trombolítica ou angioplastia primária no momento.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

212077)

Enunciado: Paciente do sexo feminino, de 37 anos de idade, faxineira, quatro filhos, foi atendida no pronto-socorro hospitalar com índice de massa corporal de 32 e histórico de crises dispépticas e cólicas abdominais, localizadas em epigástrico. O quadro clínico evoluiu nas últimas 8 horas com dor forte e contínua no epigástrico e hipocôndrio direito, houve remissão transitória, com o uso de analgésicos orais, e dois episódios de vômitos. No exame físico, apresentava-se ansiosa, hipocorada (+/4+), taquicárdica (90 bpm) e levemente ictérica. No que tange a esse caso clínico e aos múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue o item subsecutivo. As informações apresentadas nesse caso clínico podem sugerir o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio em parede anterior.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

175089)

Enunciado: Durante seu último plantão, foi solicitada sua avaliação para um paciente que deu entrada no hospital com queixa de dor torácica, e que referia ser diabético. Foi feito exame de ECG. Dentre os possíveis achados do exame e sobre os conceitos diagnósticos, qual das alternativas se mostra INCORRETA?

A) Sobrecarga ventricular esquerda miocárdica ao eletrocardiograma (ECG) indica baixa de eventos cardiovasculares no DM.

B) Ondas ?Q? ao eletrocardiograma (ECG) indicam risco elevado de eventos cardiovasculares no DM.

C) Isquemia miocárdica ao eletrocardiograma (ECG) indica risco elevado de eventos cardiovasculares no DM.

D) ECG, contudo é um exame pouco sensível.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

175090)

Enunciado: A Enoxaparina apresenta grande indicação de ser administrada quando do diagnóstico do IAMCST, não podemos, contudo, afirmar que:

A) Em pacientes com idade < 75 anos: 30 mg por via Intravenosa (IV) em bolus seguidas de 1 mg/kg de peso Subcutâneo (SC) a cada 12 horas até a alta hospitalar.

B) Em pacientes com idade = 75 anos: não administrar o bolus e iniciar com 0,75 mg/kg SC a cada 12 horas.

C) A Enoxaparina não tem demonstrado redução de mortalidade.

D) Uso de Enoxaparina demonstra que não houve redução do desfecho primário de morte ou infarto do miocárdio não fatal sem um aumento importante de sangramento.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

177262)

Enunciado: Um homem de 65 anos de idade, portador de diabetes e de hipertensão arterial apresenta quadro doloroso precordial iniciado há 2 dias , quando foi internado em unidade hospitalar em cidade remota , de modo a aguardar transferência para uma unidade de referência em cardiologia. O resultado do eletrocardiograma apresenta supra de ST e onda Q, embora o paciente se apresente hemodinamicamente estável. Ele chega a uma unidade terciária para vaga em UTI. Durante o transporte, houve piora súbita do estádo clínico do paciente , que apresentou dispneia, diaforese e edema agudo de pulmão. Na admissão na UTI, o paciente apresentava PA de 98 mmHg x 72 mmHg (PA média de 81 mmHg), sopro meso-sistólico leve, mas audível, em ápice, irradiando-se para axila. além de edema agudo de pulmão. Considerando-se o referido caso clínico e os conhecimentos médicos relacionados a ele, é correto afirmar que, ao admitir o paciente, a equipe deverá realizar

A) estabilização do quadro respiratório, com suporte ventilatório e ecocardiograma precoce, para planejamento de plastia ou troca mitral.

B) estudo hemodinârnico para reperfusão de resgate e iniciar imediatamente terapia com dupla antigregação plaquetária.

C) o procedimento do balão intra-aórtico, em razão de tratar-se de sopro secundário à degeneração ventricular esquerda, com reperfusão programada.

D) intubação orotraquel e investigação de evento tromboembólico pulmonar para início da administração trombolítico.

E) infusão de agentes inotrópicos e vasopressores por se tratar de insuficiência ventricular esquerda decorrente de infarto agudo do miocárdio.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183912)

Enunciado: Um paciente de quarenta e oito anos de idade, sem doenças prévias, procurou atendimento de emergência em um hospital de nível terciário, com quadro de dor retroesternal, de grande intensidade, em aperto, com irradiação para o membro superior esquerdo (tipo formigamento), iniciada havia quatro horas. Com exceção da presença de quarta bulha cardíaca, não apresentou outras alterações significativas no exame físico. O eletrocardiograma realizado na sala de emergência evidenciou ritmo sinusal, frequência ventricular média de 98 bpm, SÂQRS de + 60°, presença de supradesnivelo do segmento ST de 5 mm nas derivações precordiais de V1 a V6 e nas derivações do plano frontal D1 e aVL. Os níveis de troponina T e de CKBM estavam elevados e com valores acima do triplo do limite superior de referência. Com base nas informações clínicas e laboratoriais do caso clínico precedente, julgue o item subsequente. O paciente deve ser submetido a uma estratégia de recanalização coronariana com intervenção coronariana percutânea primária - via cateterismo cardíaco - ou por meio de fibrinólise intravenosa, devendo o médico optar pela que tiver possibilidade de início mais rápido.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183930)

Enunciado: Um paciente de quarenta e oito anos de idade, sem doenças prévias, procurou atendimento de emergência em um hospital de nível terciário, com quadro de dor retroesternal, de grande intensidade, em aperto, com irradiação para o membro superior esquerdo (tipo formigamento), iniciada havia quatro horas. Com exceção da presença de quarta bulha cardíaca, não apresentou outras alterações significativas no exame físico. O eletrocardiograma realizado na sala de emergência evidenciou ritmo sinusal, frequência ventricular média de 98 bpm, SÂQRS de + 60°, presença de supradesnível do segmento ST de 5 mm nas derivações precordiais de V1 a V6 e nas derivações do plano frontal D1 e aVL. Os níveis de troponina T e de CKBM estavam elevados e com valores acima do triplo do limite superior de referência. Com base nas informações clínicas e laboratoriais do caso clínico precedente, julgue o item subsequente. O provável diagnóstico para esse paciente é de infarto do miocárdio transmural ? com supra do segmento ST do eletrocardiograma ?, localizado na parede anterior extensa.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

175167)

Enunciado: A decisão sobre a liberação para a atividade desportiva após IAM é baseada nas avaliações clínicas e nos resultados dos exames complementares: teste ergométrico, ecocardiograma, ECG, Holter 24 horas, radiografia de tórax e exames laboratoriais. Sendo inadequado apenas que:

A) É importante a avaliação do anseio do paciente e qual atividade e, principalmente, qual desempenho ele espera atingir.

B) Os pacientes, após submetidos à estratificação, devem ser classificados entre baixo, moderado e alto risco.

C) Os pacientes de baixo risco são os que apresentaram alterações nos exames complementares e que permanecem assintomáticos, são orientados à realização de quaisquer tipos de atividade física.

D) Já os indivíduos de moderado e alto risco são contra indicados às atividades competitivas e devem ser encaminhados para atividades físicas supervisionadas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

175169)

Enunciado: Dentro da conduta médica frente à realização de exercícios físicos nos paciente Infartados em reabilitação, somente podemos considerar INCORRETO o seguinte item:

A) A prática de natação e hidroginástica merece alguns cuidados. Apesar de ideal para os obesos, pode gerar alguns problemas para o coronariano, como bradicardia reflexa vagal e arritmias complexas.

B) O choque térmico pode causar espasmos arteriais.

C) Indivíduos que já estejam praticando atividade física no após IAM devem ser orientados às mínimas modificações nos sintomas e sinais, ou à alterações nos exames de reavaliação indicativas da progressão da doença aterosclerótica coronárias.

D) Pacientes infartados que não possuam prévio domínio da técnica natatória devem ser desaconselhados à hidroginástica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

175172)

Enunciado: Dentro das indicações da Emergência de Insuficiência Coronariana, podemos considerar completamente adequado somente a seguinte alternativa:

A) Ácido acetilsalicílico é um dos muitos anti-inflamatórios indicados rotineiramente para todos os pacientes com suspeita de IAM.

B) Ácido acetilsalicílico é contraindicado na alergia ou intolerância ao medicamento, sangramento ativo, hemofilia e úlcera péptica ativa.

C) Pacientes com maior risco de doença coronária devem ser instruídos por seus médicos assistentes a tomar Ácido Acetilsalicílico (AAS) tamponado em situações emergenciais.

D) É o antiplaquetários de eleição a ser utilizado no IAM, tendo sido demonstrado que reduz a mortalidade em 90%, isoladamente, quase tanto quanto a Estreptoquinase (SK).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

175177)

Enunciado: Com o uso de ensaios cada vez mais sensíveis para dosagem de troponinas, as mudanças absolutas e relativas de seus valores na fase aguda têm sido muito valorizadas para o diagnóstico correto de IAM. Como a curva ou alteração da troponina (delta change), sendo inadequado que:

A) Alguns estudos demonstraram que incrementos relativos de 20 a 50% em relação aos Valores Basais são insuficientes para detectar uma curva.

B) Da mesma forma, incrementos absolutos (de uma vez o referencial de cada ensaio) também demonstraram uma acurácia melhor que a dosagem isolada das troponinas na admissão.

C) No entanto, não existe consenso de qual ponto de corte seja ideal.

D) Os incrementos nas troponinas ultrassensíveis são muito sensíveis para infarto em evolução, mas pouco específicos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

175176)

Enunciado: Para que ocorra melhora do prognóstico, a adesão aos programas de reabilitação cardiovascular é importante para o sucesso de qualquer intervenção de prevenção secundária, e está diretamente relacionada à aderência ao tratamento. Somente uma das alternativas listadas se mostra inadequada dentro da atual abordagem, assinale-a:

A) Os índices de aderência aos programas de reabilitação cardíaca após IAM excedem a 80% nos 3 primeiros meses, caindo para 60 a 71% no sexto mês, para 60% aos 12 meses e para 30 a 40% entre o segundo e o quarto ano

B) A insistência do Médico Assistente e a integração da equipe multidisciplinar ao atendimento aos pacientes, por meio de esclarecimento e controle dos fatores de risco, não tem demonstrado aumento na adesão ao tratamento.

C) Aumento da capacidade funcional, redução de sintomas, benefício psicológico, auxílio no controle de fatores de risco, retorno mais precoce ao trabalho e aumento da sobrevivência justificam o emprego sistemático da reabilitação no tratamento do IAM, em todas as fases, considerando sua excelente relação custo/efetividade.

D) A orientação fundamental a ser dada pelo cardiologista é a de que a reabilitação após o infarto não se limita a programas formais e sofisticados, mas à mudança do estilo de vida, abrangente em relação aos fatores de risco controláveis, e à marcada convivência com movimentos de qualquer espécie em relação às atividades cotidianas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

168434)

Enunciado: Um homem com 50 anos de idade, ao ser atendido em um Serviço de Emergência, refere desconforto torácico descrito como sensação de aperto, com início há cerca de 90 minutos, sem fatores de alívio. Questionado a respeito da localização da dor, o paciente coloca a mão fechada sobre o lado esquerdo do peito. Informa, ainda, que o desconforto teve início após ter subido escadas, tendo evoluído também com náuseas, palidez cutâneo-mucosa e sudorese fria. O paciente é portador de hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia, estando em uso regular de enalapril - 20 mg/dia, de sinvastatina - 20 mg/dia e de ácido acetilsalicílico - 100 mg/dia. Durante o atendimento, foi realizado eletrocardiograma, cujo resultado está reproduzido a seguir. (Conforme imagem no caderno de questões) Nessa situação, qual é o diagnóstico mais provável e o que se espera encontrar na curva enzimática do paciente no momento de sua chegada?

A) Angina variante de Prinzmetal; troponina e CPK-MB positivas.

B) Angina instável; marcadores de necrose miocárdica negativos.

C) Infarto agudo do miocárdio inferolateral dorsal; mioglobina positiva.

D) Infarto agudo do miocárdio de parede lateral alta; elevações séricas de mioglobina e CK-MB.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

104738)

Enunciado: O segmento ST no eletrocardiograma reflete:

A) repolarização atrial.

B) despolarização atrial.

C) despolarização ventricular.

D) o intervalo de despolarização entre átrios e ventrículos.

E) repolarização ventricular.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

104755)

Enunciado: Além dos benefícios de natureza mais ampla para a saúde e a melhoria da qualidade de vida, vários estudos têm demonstrado que a atividade física é um fator importante na prevenção e no controle de alguns problemas de saúde, quando analisada a partir da perspectiva populacional. A orientação para a prática de atividades físicas moderadas está relacionada ao controle da frequência cardíaca como parâmetro de segurança. Um indivíduo de sessenta anos de idade deve atingir frequência cardíaca (bat/min) máxima e ideal, respectivamente, de

A) 140 e entre 110 e 118.

B) 150 e entre 124 e 138.

C) 160 e entre 104 e 128.

D) 170 e entre 114 e 138.

E) 180 e entre 108 e 128.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

80711)

Enunciado: O diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) geralmente é feito pela tríade: dor precordial característica, anormalidades ao Eletrocardiograma (ECG) e marcadores cardíacos séricos elevados. A análise de segmento ST ao ECG tem implicações terapêuticas e prognósticas e deve sempre ser procedida com suspeita desse quadro, por que:

A) O supradesnivelamento do segmento ST é indicação de imediata revascularização.

B) O supradesnivelamento de ST é patagnomônico de angina instável.

C) O infradesnivelamento de ST sempre precede fibrilação ventricular.

D) O infradesnivelamento de ST só ocorre nos pacientes que já tiveram IAM prévio.

E) Fibrilação atrial sempre se associa a supradesnivelamento de ST e por isso entra no diagnóstico do diferencial do IAM.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

80704)

Enunciado: De acordo com a 1ª Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia - 2013, a Parada Cardiorrespiratória (PCR) permanece como um problema mundial de saúde pública. Apesar de avanços nos últimos anos relacionados à prevenção e ao tratamento, muitas são as vidas perdidas anualmente no Brasil relacionadas à PCR. Nesse sentido, assinale a alternativa correta em relação à epidemiologia.

A) A disponibilidade obrigatória dos Desfibriladores Automáticos não trouxe importante relevência, pois a maioria das PCR não é por fibrilação.

B) Em relação à educação, à implementação e ao retreinamento, as habilidades adquiridas após um treinamento em Ressuscitação Cardiorrespiratória (RCP) podem ser perdidas em tempo muito curto (três a seis meses), caso não utilizadas ou praticadas.

C) Informações sobre epidemiologia e desfechos da RCP não têm contribuído para um maior sucesso das tentativas de ressuscitação devido à baixa notificação.

D) Em relação à importância dos cuidados pós-ressuscitação, muitas vítimas de PCR ressuscitadas morrem nas primeiras 24 a 36 horas de disfunção miocárdica, mas as que sobrevivem raramente apresentam disfunção e sequelas cerebrais importantes.

E) Uma simplificação de procedimentos, principalmente voltada para o socorrista leigo, pode proporcionar uma maior aderência a possíveis tentativas de melhoria do sucesso das ressuscitações, entretanto a fase pré-hospitalar não apresenta muita relevência no prognóstico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

97752)

Enunciado: Uma mulher com 65 anos de idade apresenta o seguinte histórico: antecedentes de obesidade, hipertensão arterial e angioplastia coronariana prévia, em uso prévio de diltiazem - 90 mg/dia, propranolol - 40 mg duas vezes ao dia, AAS - 100 mg/dia, dinitrato de isossorbida e sinvastatina - 20 mg/dia. A paciente, residente em uma cidade do interior, apresentou, há cerca de 24 horas, quadro de infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento de ST de parede inferior associado a infarto do ventrículo direito. Como não havia equipe de hemodinâmica disponível, foi administrada estreptoquinase, com melhora apenas parcial da dor. Após estabilização clínica a paciente foi encaminhada para Serviço de Emergência de hospital terciário. Na admissão a paciente estava eupneica, orientada, ainda com queixas de dor precordial com as mesmas características, mas de menor intensidade e intermitente. A pressão arterial era de 100 x 60 mmHg, frequência cardíaca = 78 bpm, frequência respiratória = 16 irpm. As auscultas cardíaca e pulmonar estavam normais. Enquanto eram colhidos os exames complementares e repetido o ECG, a paciente subitamente apresentou quadro de choque (pressão arterial = 60 x 20 mmHg), com rebaixamento do nível de consciência, palidez cutâneo-mucosa e insuficiência respiratória. A saturação de 02 caiu para 75% em ar ambiente e a frequência cardíaca aumentou para 135 bpm. A perfusão periférica encontrava-se muito prejudicada e as extremidades frias e sudoreicas. O ictus cardíaco estava hiperdinâmico e a ausculta cardíaca revelava bulhas audíveis, com 3ª bulha e sopro holossistólico pancardíaco, mais audível em borda estrenal esquerda. Havia turgência jugular a 45°. A ausculta pulmonar revelava estertores bolhosos até os ápices. Alem da intubação orotraqueal, as medidas terapêuticas recomendadas são:

A) iniciar noradrenalina e dobutamina e encaminhar para angioplastia de emergência.

B) iniciar nitroprussiato de sódio e dopamina e realizar pericardiocentese de emergência.

C) iniciar nitroprussiato de sódio e dobutamina e encaminhar para cirurgia cardíaca de emergência.

D) iniciar noradrenalina e dopamina e encaminhar para instalação, de emergência, de balão intra-aórtico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

97805)

Enunciado: Um homem com 35 anos de idade, obeso, sedentário, foi admitido no Serviço de Emergência com quadro agudo de dor retroesternal e epigástrica, em queimação, que o acordou no meio da noite. Relata episódios pregressos semelhantes, porém de menor intensidade e geralmente após refeições copiosas. No momento da consulta, estava extremamente ansioso, frequência cardíaca = 104 bpm, pressão arterial = 150 x 110 mmHg e auscultas cardíaca e pulmonar sem anormalidades. O paciente foi incluído em protocolo de avaliação de dor torácica e foi indicada internação para observação e exames seriados por 12 horas. Qual dos seguintes achados de exames complementares afasta o diagnóstico de dor torácica não cardíaca?

A) ECG normal após 12 horas.

B) Ecocardiograma normal após 12 horas.

C) EDA - hérnia hiatal com esofagite de refluxo moderada.

D) Ausência de elevação de CK-MB e troponina em 12 horas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

64433)

Enunciado: O aumento da mortalidade do infarto agudo do miocárdio está relacionado ao uso de:

A) Diltiazem

B) Amlodipina

C) Nifedipina

D) Verapamil

E) Captopril

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

75539)

Enunciado: Homem com 54 anos de idade, com antecedentes de dislipidemia, hipertensão arterial e histórico de doença familiar cardiovascular precoce (pai teve infarto do miocárdio aos 50 anos), deu entrada na Emergência de um hospital com história de dor em região epigástrica há cerca de cinco horas, em aperto, de forte intensidade, sem relação com a alimentação e sem fatores de melhora, acompanhada de náuseas e vômitos. Havia recebido 200 mg de AAS no hospital de origem. Ao exame, encontrava-se pálido, sudoreico e sonolento. Temperatura axilar = 35,8ºC; pressão arterial = 80 x 50 mmHg; frequência cardíaca = 118 bpm; frequência respiratória = 16 irpm. Perfusão periférica diminuída. A ausculta cardíaca revelava bulhas normofonéticas, sem sopros. Havia turgência jugular a 45º. A ausculta pulmonar não revelava estertores. O eletrocardiograma da admissão é apresentado abaixo: (VER IMAGEM) Diante do quadro clínico do paciente, a hipótese diagnóstica, a provável causa do choque e o tratamento inicial recomendado são, respectivamente:

A) Infarto do miocárdio com supra de ST de parede inferior; tamponamento cardíaco; pericardiocentese.

B) Infarto do miocárdio com supra de ST de parede anterior; resposta inflamatória sistêmica; noradrenalina.

C) Infarto do miocárdio com supra de ST de parede inferior; infarto de ventrículo direito; hidratação com solução salina.

D) Infarto do miocárdio com supra de ST de parede anterior; ruptura de músculo papilar; colocação de balão intra-aórtico.

E) Infarto do miocárdio com supra de ST de parede anterosseptal; ruptura do septo interventricular; cirurgia cardíaca de emergência.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

137701)

Enunciado: Um homem de 48 anos, hipertenso, obeso, chega à Emergência com queixa de episódios de dor torácica precordial, sem irradiação, iniciada nos últimos dois dias, com piora há 24 horas. A dor dura de 5 a 15 minutos, sendo precipitada por esforços intensos, como subir escadas, e é aliviada pelo repouso. O paciente informa não sentir a dor no momento da anamnese. Usa captopril e hipoglicemiante oral de forma regular. Nega antecedentes de doença coronariana e um eletrocardiograma foi considerado normal pelo seu cardiologista na última consulta, há 6 meses. Ao exame, mostra-se ansioso, mas em bom estado geral, pulso = 85 bpm, regular, cheio, PA = 140 x 80 mmHg, pulsos periféricos palpáveis e simétricos, extremidades bem perfundidas. As auscultas pulmonar e cardíaca estão dentro da normalidade. O seu eletrocardiograma à admissão mostra os seguintes achados (VER IMAGEM). Qual a abordagem mais adequada ao paciente?

A) Realizar tratamentos anti-isquêmico e antitrombótico administrados de modo imediato e simultâneo.

B) Observar em Unidade Coronariana e administrar medicamentos sintomáticos até realização de cateterismo cardíaco.

C) Observar na Emergência por 12 horas e encaminhar ao cardiologista para teste ergométrico se persistir assintomático.

D) Realizar tratamento anti-isquêmico imediato, seguido de terapia antitrombótica em caso de alterações do segmento ST no ECG nas próximas 12 horas.

E) Realizar tratamento antitrombótico imediato, seguido de terapia anti-isquêmica em caso de elevação de troponina sérica e/ou CK-MB nas próximas 12 horas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

138599)

Enunciado: Mulher, com 58 anos de idade, diabética, é admitida no Pronto-Socorro com dor precordial opressiva, intensa, irradiada para membro superior esquerdo há 40 minutos, associada a sudorese fria e sensação de morte iminente. Durante o exame clínico, encontra-se em bom estado geral, eupneica, Pressão arterial = 100 x 70 mmHg, Frequência cardíaca = 92 bpm, Frequência respiratória = 20 ipm. Pulmões limpos. Ritmo cardíaco regular, dois tempos, sem sopros. Abdome flácido, sem visceromegalias, ruídos hidroaéreos presentes. Sem edemas de membros inferiores, panturrilhas livres. Fez uso de dinitrato de isossorbida 5 mg sublingual, tendo cessado a dor. Eletrocardiograma realizado na admissão está normal. Qual a recomendação para o acompanhamento desta paciente?

A) Acompanhamento ambulatorial, se Troponina e CKMB massa colhidas na admissão estiverem normais.

B) Internação hospitalar, monitorização cardíaca contínua, mesmo com troponina normal à admissão.

C) Acompanhamento ambulatorial especializado, com cardiologista, se Troponina colhida na admissão estiver normal.

D) Internação hospitalar, monitorização cardíaca contínua, se Troponina colhida na admissão estiver elevada.

E) Internação hospitalar, sem monitorização cardíaca contínua, se a Troponina e CKMB massa colhidas na admissão estiverem normais.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

351582)

Enunciado: Paciente do sexo masculino, 77 anos de idade, diabético tipo 2, coronariopata, com revascularização miocárdica há 8 anos, chegou ao pronto-socorro com quadro de dor precordial com as mesmas características do infarto agudo do miocárdio, ocorrido há 9 anos, acompanhado de palidez e sudorese. O exame físico revelou pressão arterial de 140 x 90mmHg em membros superiores, frequência cardíaca de 80bpm e peso de 80kg. O paciente apresentava-se com bom estado geral, ansioso, pálido, hidratado e afebril. Estava em uso de 100mg/dia de AAS, 850mg de metformina 3x/dia, 50mg de captopril 3x/dia, 25mg/dia de atenolol e 20mg/dia de sinvastatina. Realizou ECG que não evidenciou alterações no segmento ST. Foram realizadas três dosagens negativas de troponinas. Nesse caso, é CORRETO afirmar que a principal hipótese diagnóstica é:

A) Síndrome coronariana aguda com angina instável.

B) Infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST.

C) Infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST.

D) Angina estável.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

352187)

Enunciado: Quanto aos tipos de infarto agudo do miocárdio (IAM), assinale a alternativa incorreta.

A) Tipo 1: é o infarto decorrente de instabilização de uma placa aterosclerótica na coronária.

B) Tipo 2: é o infarto causado mais comumente por um desbalanço entre oferta e demanda de oxigênio para o músculo cardíaco.

C) Tipo 3: quadro sugestivo de IAM em acidente que evoluiu com morte súbita e no qual não houve tempo de colher marcadores de necrose miocárdica.

D) Tipo 4: infarto relacionado à cirurgia de revascularização miocárdica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

320451)

Enunciado: As síndromes coronarianas agudas são emergências clínicas de alta morbimortalidade.

Acerca do tratamento dessas condições, julgue as alternativas abaixo e marque a correta:

A) O uso de oxigenoterapia deve ser realizado de rotina na sala de emergência.

B) O uso de beta-bloqueadores (via oral) deve ser feito nos pacientes sem sinais de baixo débito.

C) A morfina deve ser evitada, pois aumenta o consumo miocárdico de oxigênio.

D) A dose de ataque de enoxaparina deve ser feita na dose de 1 mg/kg, via subcutânea.

E) A fibrinólise pode ser realizada para os pacientes com síndrome coronariana aguda sem supra de ST de alto risco.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

336312)

Enunciado: Mulher, 52 anos, tabagista, portadora de lúpus eritematoso sistêmico e hipertensão arterial sistêmica, chega no pronto socorro com precordialgia intensa iniciada há 5 horas, espontaneamente, em repouso, que piora durante a inspiração forçada, irradiada para ombros, sem melhora desde então. Ao exame: regular estado geral, corada, acianótica, anictérica, desidratada +/4+, Tax: 38,1°C. Lúcida, orientada em tempo e espaço, pupilas isocóricas e fotorreagentes, sem déficits focais. Ritmo cardíaco regular, 2 tempos, bulhas hipofonéticas, sem sopros, FC: 106 bpm, PA: 142/80 mmHg, jugulares túrgidas, TEC < 3 segundos. Murmúrio vesicular fisiológico, sem ruídos adventícios, eupneica em ar ambiente, SpO2: 97%. Realizado eletrocardiograma e ultrassonografia cardíaca point-of-care na admissão, cujas imagens estão abaixo. O diagnóstico e tratamento, deste paciente são, respectivamente:

A) Miocardite aguda / Prednisona + amoxicilina

B) Pericardite aguda / Ibuprofeno + colchicina

C) Infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento de ST / Alteplase

D) Tamponamento cardíaco / Pericardiocentese imediata

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

305021)

Enunciado: Considere dois pacientes que buscaram atendimento médico no ambulatório de um hospital com queixa de tonteira. O paciente A é um homem de 73 anos de idade, hipertenso, com relato de sensação de rotação do ambiente que acontece pela manhã, ao se levantar da cama, associada à náusea, que passa muito rapidamente, embora ele permaneça por alguns minutos sudorético, nauseado e com as mãos frias. A paciente B é uma mulher de 54 anos de idade, hipertensa e diabética, com relato de sensação de desmaio, sudorese, palpitações e escurecimento visual que podem acontecer em repouso ou esforço, e duram alguns minutos, com remissão espontânea. Considerando as prováveis origens das tonteiras desses pacientes, os exames inicialmente indicados para auxílio diagnóstico são, respectivamente,

A) manobra de Dix-Hallpike e eletrocardiograma (ECG).

B) eletronistagmografia e Holter de 24 horas.

C) Holter de 24 horas e manobra de Dix-Hallpike.

D) eletronistagmografia e ECG.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

304873)

Enunciado: Adolescente, sexo masculino, 12 anos, comparece a consulta solicitando atestado para prática de natação. Assintomático, sem história familiar de risco para doença cardiovascular. Exame físico: dados vitais e exame segmentar normais. Traz eletrocardiograma realizado há um ano para avaliação pré-operatória de cirurgia ortopédica com laudo de arritmia sinusal. A conduta indicada neste caso é:

A) Liberar para prática de natação.

B) Indicar Tilt teste.

C) Realizar ecocardiograma.

D) Solicitar novo eletrocardiograma.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

306731)

Enunciado: D.R.A, 58 anos, dá entrada no PS com queixa de dor torácica há 1 hora. Apresenta-se sudoreico e relata náuseas. Durante a avaliação inicial foi realizado eletrocardiograma, que está representado abaixo. PA = 80/50 mmHg, FC = 120 bpm, FR = 28 irpm, SpO2 = 92%. A troponina encontra-se 3 vezes acima do valor de referência superior. Qual das drogas abaixo está contraindicada neste caso?

A) Ácido acetilsalicílico

B) Clopidogrel

C) Dinitrato de isossorbida

D) Heparina

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

287337)

Enunciado: Paciente de 65 anos, diabético, hipertenso, dislipidêmico e tabagista. Relata dor/desconforto no hemitórax esquerdo há 02 semanas, durante uma atividade física moderada. Há 01 dia apresentou desconforto mais intenso (7+/10+), com cerca de 10 minutos de duração. Nessa madrugada, às 05h15, foi acordado com dor retroesternal (10+/10+), acompanhado de náuseas e mal-estar intenso. Às 08h30 é atendido com desconforto em hemitórax esquerdo (4+/10+). O eletrocardiograma está apresentado abaixo. Qual diagnóstico? (Obs. Cópia da Figura a seguir na página 13 ampliada para consulta).

A) Síndrome Coronariana Aguda.

B) Angina Estável.

C) Dissecção de aorta.

D) Tomboembolismo Pulmonar.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

246719)

Enunciado: A inflamação desempenha papel central na gênese da doença coronariana isquêmica. Nos últimos anos, vários medicamentos têm sido utilizados em pesquisas clínicas buscando reduzir novos eventos coronarianos adversos, a nível de prevenção secundária, agindo exclusivamente por vias inflamatórias. Dentre os medicamentos abaixo, qual possui evidência científica mais favorável neste contexto?

A) Corticoides

B) Anti-Inflamatórios não hormonais

C) Idarucizumab

D) Metotrexato

E) Colchicina

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

246355)

Enunciado: Paciente de 49 anos, apresentou quadro de dor torácica tipo aperto, irradiando para MSE, seguido de náuseas e dispneia, sem fatores de melhora. Procurou atendimento médico após 1 hora do início do quadro, realizado eletrocardiograma conforme a figura abaixo. Entre as medidas recomendadas na abordagem inicial de pacientes com suspeita de infarto, assinale a não recomendada.

A) Administração de fibrinolíticos na impossibilidade de intervenção coronária percutânea (ICP) ou expectativa de transporte/transferência (tempo ""primeiro contato médico-balão"") > 120 minutos para hospital com Angioplastia coronariana.

B) Utilização da Ckmb massa para tomada de decisão em locais onde dispõe de troponina ultrasensível.

C) Pacientes com IAM com Supra de ST com menos de 12 horas de evolução e que têm contraindicação ao uso de fbrinolíticos devem ser encaminhados à ICP primária, independentemente do tempo.

D) Encaminhar para cateterismo de urgência apenas com história clínica compatível de IAM e eletrocardiograma com supra de ST, mesmo sem resultado de marcadores de necrose miocárdica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

243062)

Enunciado: Paciente do sexo masculino, 55 anos, é admitido na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com forte dor precordial há 2 horas. Eletrocardiograma mostra supradesnível de segmento ST em parede anterior. É submetido à trombólise química com critérios de reperfusão. Segundo a estratégia farmacoinvasiva atualmente indicada, este paciente:

A) deve ser submetido a cateterismo com vistas à possível intervenção coronária percutânea dentro de 3 a 24 horas após a trombólise bem-sucedida.

B) deveria ter sido administrada metade da dose do trombolítico no atendimento pré-hospitalar e, em seguida, ter sido encaminhado para hospital de referência.

C) deve ser submetido a cateterismo o quanto antes após a administração de trombólise, mesmo que a reperfusão química seja bem-sucedida.

D) deve ser submetido a cateterismo com vistas à possível intervenção coronária percutânea após 48 horas da trombólise bem-sucedida.

E) caso seja optado por cateterismo cardíaco, a trombólise intra-arterial está indicada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

243067)

Enunciado: A ecocardiografia sob estresse é um método não invasivo, estabelecido para a avaliação de pacientes com doença arterial coronária. Qual, dentre as alternativas abaixo, NÃO constitui indicação para a realização do ecocardiograma sob estresse na doença arterial coronária crônica?

A) Estratificação de risco de pacientes com doença arterial coronária.

B) Avaliação de isquemia miocárdica em indivíduos assintomáticos com teste ergométrico positivo ou duvidoso.

C) Avaliação de rotina em pacientes após revascularização do miocárdio.

D) Avaliação de isquemia miocárdica na presença de bloqueio do ramo esquerdo ou alterações que impeçam adequada análise eletrocardiográfica de isquemia.

E) Estresse farmacológico na avaliação de viabilidade miocárdica (miocárdio hibernado) para planejamento de revascularização.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

243074)

Enunciado: Dentre os achados de exame físico, qual, entre os abaixo, NÃO é característico de um episódio anginoso provocado por isquemia miocárdica?

A) sopro diastólico aspirativo em foco aórtico acessório.

B) terceira bulha.

C) quarta bulha.

D) sopro de regurgitação mitral.

E) desdobramento paradoxal da segunda bulha.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215173)

Enunciado: Paciente de 50 anos, tabagista, refere que acordou às 6 horas da manhã com dor retroesternal em queimação, com irradiação para o pescoço, associado a sudorese, náuseas e vômitos. Chega ao pronto-socorro às 10 horas e é submetido a realização de eletrocardiograma que evidenciou supra do segmento ST em parede anterior. O paciente encontra-se a 30 minutos do centro de referência com hemodinâmica. Qual é o próximo passo?

A) Administrar AAS 200 mg, clopidogrel 300 mg, enoxaparina 30 mg IV e encaminhar ao serviço de hemodinâmica para angioplastia primária.

B) Administrar AAS 200 mg, clopidogrel 300 mg, enoxaparina 30 mg IV e aguardar a troponina antes de encaminhar para angioplastia primária.

C) Administrar AAS 100 mg, clopidogrel 75 mg, enoxaparina 80 mg SC e encaminhar ao serviço de hemodinâmica para angioplastia primária.

D) Administrar AAS 100 mg, clopidogrel 75 mg, enoxaparina 80 mg SC e aguardar a troponina antes de encaminhar para angioplastia primária.

E) Realizar trombólise com tenecteplase.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215179)

Enunciado: Paciente de 52 anos, do sexo masculino, chegou ao pronto-socorro com queixa de dor retroesternal em aperto, com duração de 20min, que se repetiu por 2 vezes nas últimas 24 horas. Estava assintomático havia 2 anos, em uso de ácido acetilsalicílico (AAS), sinvastatina e enalapril. Apresenta antecedentes de hipertensão, dislipidemia. Pai falecido de infarto do miocárdio aos 54 anos. Exame físico: ritmo cardíaco regular; Frequência Cardíaca (FC) = 88 bpm; Pressão Arterial (PA) = 140 x 90 mmHg; pulmões sem ruídos adventícios. Primeira medida de troponina positiva. O eletrocardiograma (ECG) está apresentado na figura que segue:

A) Paciente de alto risco (TIMI = 6); deve ser estratificado invasivamente nas próximas 24 horas.

B) Paciente de alto risco (TIMI = 5); deve ser estratificado invasivamente nas próximas 48 horas.

C) Paciente de alto risco (TIMI = 7); deve ser estratificado invasivamente nas próximas 24 horas.

D) Paciente de moderado risco (TIMI = 4); deve ser estratificado invasivamente nas próximas 72 horas.

E) Paciente de alto risco (TIMI = 6); deve ser estratificado invasivamente nas próximas 48 horas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215181)

Enunciado: Homem de 68 anos chegou à emergência do Hospital de Marechal Floriano com infarto agudo do miocárdio (IAM) com supradesnivelamento de do segmento ST na parede inferior. Clinicamente, apresentava-se estável hemodinamicamente em Killip I. Os sintomas haviam iniciado há 60 minutos, não possui contra-indicação ao uso de trombolítico. Qual a estratégia de tratamento mais adequada, considerando-se o tempo de transferência para o centro de referência para hemodinâmica estima-se ser de cerca de 150 minutos?

A) Encaminhar o paciente imediatamente ao centro capacitado para realização de angioplastia primária.

B) Administrar metade da dose do trombolítico preconizada para IAM com supra de ST e encaminhar o paciente para estratégia de angioplastia facilitada.

C) Utilizar inibidor de IIb/IIa e encaminhar o paciente para estratégia de angioplastia facilitada.

D) Por ser o IAM de baixo risco para complicações, tratar o paciente sem estratégia de reperfusão, evitando-se os riscos do uso de trombolítico em local com poucos recursos ou os riscos de transporte.

E) Administrar trombolítico imediatamente, com posterior estratificação coronariana invasiva.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215106)

Enunciado: O que apresenta um paciente com infarto agudo do miocárdio e insuficiência cardíaca Killip III:

A) Choque cardiogênico.

B) Edema agudo de pulmão cardiogênico.

C) Estertores crepitantes bibasais.

D) Perda de líquido para terceiro espaço.

E) Todas as alternativas anteriores.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

196813)

Enunciado: Homem de 59 anos com dor precordial em aperto iniciada há duas horas, irradiando para o andar superior do abdome, com vômitos. Ausculta pulmonar normal. PA = 115 x 70 mmHg. Amilase e lipase normais. Radiografias de tórax e abdome normais e o ECG abaixo. Dentre as drogas abaixo, qual deve ser evitada neste paciente?

A) Nitroglicerina.

B) AAS.

C) Sinvastatina.

D) Enoxaparina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

172803)

Enunciado: Homem de 78 anos admitido em pronto-socorro com dor precordial típica, há cerca de 1 hora, associada à dispneia. Histórico de uso de sildenafila há 3 horas. Ao exame físico, apresentava-se orientado, sudoreico, com frequência cardíaca de 110 bpm e pressão arterial de 85 x 50 mmHg. O eletrocardiograma evidencia infradesnivelamento de segmento ST de V1 a V3. Este paciente deve ser tratado com:

A) Heparina de baixo peso molecular associada a antiagregante plaquetário.

B) Nitroprussiato de sódio por via endovenosa.

C) Nitrato sublingual.

D) Trombolítico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

148540)

Enunciado: Paciente feminina, 60 anos, multípara, obesa, apresenta dor intensa epigástrica, acompanhada de sudorese profusa, dispneia e taquicardia, que durou cerca de 15 minutos. No dia seguinte procura assistência médica já assintomática. A pressão arterial foi aferida em 130 x 80 mmHg, frequência cardíaca de 80 batimentos por minuto, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, abdome indolor, sem massas palpáveis ou visceromegalias, com peristalse normal e exame do aparelho respiratório normal. Ao iniciar a investigação, qual a conduta mais adequada neste contexto clínico?

A) Solicitar endoscopia digestiva alta.

B) Solicitar eletrocardiograma de repouso e de teste ergométrico.

C) Solicitar ultrassonografia abdominal.

D) Solicitar exame de urina.

E) Solicitar tomografia computadorizada de tórax.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

155474)

Enunciado: Dentre os biomarcadores séricos abaixo, o mais específico para necrose miocardica é:

A) Mioglobina.

B) BNP.

C) CK-MB.

D) Troponina.

E) Interleucina 6.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

131638)

Enunciado: Em pacientes com infarto agudo do miocárdio, o maior benefício com o uso de fibrinolíticos é encontrado naqueles que apresentam:

A) Bloqueio A-V de 1º e 2º graus.

B) Elevação do segmento ST em parede anterior.

C) Eletrocardiograma normal.

D) Depressão do segmento ST, em qualquer área.

E) Elevação do segmento ST em parede inferior.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

106427)

Enunciado: Dentre as condições abaixo, qual delas contraindica formalmente o uso de trombolíticos no infarto com supra de ST?

A) Menstruação em atividade

B) Diabetes melito descompensada

C) Hipertrigliceridemia severa

D) Idade superior a 65 anos

E) AVC hemorrágico há 5 anos

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

101014)

Enunciado: Homem de 74 anos, diabético, hipertenso e dislipidêmico com dor precordial sem irradiação há 40 minutos, dispneia, crepitações em bases pulmonares bilateralmente, níveis pressóricos de 90x40 mmHg, frequência cardíaca de 105 bpm, bulhas hipofonéticas. Eletrocardiograma na sala de emergência revela infradesnivelamento do seguimento ST de 1 mm nas derivações precordiais V1 a V4. Nesta ocasião está contraindicado:

A) Oxigenioterapia nasal a 3 l/min.

B) Analgesia com sulfato de morfina.

C) Nitroglicerina endovenosa.

D) Administração de betabloqueador por via endovenosa e/ou oral.

E) Ácido acetilsalicílico por via oral.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

101028)

Enunciado: São fatores de risco para pior prognóstico dos pacientes com quadro de infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST pelo escore TIMI (Thrombolysis In Myocardial Infarction), EXCETO:

A) Uso de ácido acetilsalicílico nos últimos 7 dias.

B) Infradesnivelamento do segmento ST "maior ou igual a" 0,5 mm.

C) Angina grave de início nas últimas 24 horas.

D) Presença de pelo menos dois fatores de risco tradicionais para doença coronariana.

E) Idade acima de 65 anos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

100952)

Enunciado: Em relação ao tratamento das dislipidemias assinale a alternativa incorreta.

A) Rabdomiólise ocorre em cerca de 10% dos pacientes tratados com estatina.

B) A adição de ezetimiba é recomendada quando o paciente não atinge as metas de LDL colesterol com a maior dose tolerada de uma estatina.

C) A niacina atua na redução da trigliceridemia e aumento dos níveis de LDL colesterol, porém sua associação às estatinas não altera o desfecho cardiovascular.

D) A colestiramina reduz o LDL colesterol em até 30%, sendo este efeito dose dependente.

E) O risco de miopatia aumenta com a associação de fibrato e estatina, devendo-se evitar o uso de genfibrosila devido ao maior risco de rabdomiólise.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

100986)

Enunciado: T.V.Z., homem, 73 anos, necessita realizar tratamento cirúrgico de hérnia inguinal bilateral. Entretanto, devido sua idade, e ao fato de apresentar hipertensão arterial bem controlada com uso de anlodipina, ele e sua família estão preocupados com os riscos da operação. Passou em avaliação com o cardiologista que o classificou como classe I de Goldman. Na consulta com o anestesiologista, foi classificado como classe II de ASA (American Society of Anesthesiologists). Isso significa que:

A) O risco de morte de origem cardíaca para o doente em questão é aproximadamente 0,2%.

B) Com oito pontos atribuídos pela idade, utilizando-se a classificação de Goldman, o doente apresenta probabilidade de não complicação de 86%.

C) O doente não está apto a ser operado, tendo em vista que, com a classificação ASA II tem alta probabilidade de apresentar evento cardíaco no período intraoperatório.

D) O doente está apto a ser operado, mas deve passar o período pós-operatório imediato em Unidade de Tratamento Intensivo.

E) Os riscos potenciais à vida do doente em questão são de aproximadamente 11%.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

77502)

Enunciado: Homem de 56 anos procura o pronto-socorro por dor torácica. Refere pressão retroesternal irradiada para a mandíbula, desencadeada por esforço, e melhorando após 3 minutos em repouso. Não se altera com a posição ou ventilação. Atendido 1 hora após e no momento assintomático. O eletrocardiograma é normal. A alternativa que melhor relaciona a hipótese mais provável e a conduta, respectivamente, nesse momento, é:

A) Angina de peito - dosagem de troponina.

B) Infarto agudo do miocárdio - ecocardiograma.

C) Infarto agudo do miocárdio - coronariografia.

D) Dissecção de aorta - radiografia de tórax.

E) Angina de peito - teste de esforço.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

88889)

Enunciado: Paciente hipertenso, diabético, dislipidêmico, 57 anos, vem apresentando precordialgia associada aos esforços, típica de coronariopatia. Porém, teste ergométrico foi normal. Qual a melhor conduta?

A) Prosseguir com a investigação de coronariopatia, pois deve ser um falso-negativo do teste ergométrico.

B) Encerrar a investigação, pois não deve ser coronariopatia.

C) Medicar com AAS e acompanhar o paciente ambulatorialmente.

D) Solicitar CT de tórax, sem contraste, pois pode ser outra patologia torácica.

E) Investigar patologia osteomuscular.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

88847)

Enunciado: Qual o tempo porta-agulha ideal para trombólise, no IAM com supradesnivelamento do segmento ST, após admissão hospitalar?

A) até 30 minutos.

B) até 45 minutos.

C) até 10 minutos.

D) até 35 minutos.

E) até 90 minutos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

88844)

Enunciado: Qual o tempo porta-balão ideal em pacientes com IAM com supradesnivelamento do segmento ST?

A) até 30 minutos.

B) até 45 minutos.

C) até10 minutos.

D) até 35 minutos.

E) até 90 minutos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

43923)

Enunciado: Um paciente deu entrada no Pronto-Socorro com quadro de dor precordial intensa sendo diagnosticada síndrome coronariana aguda sem supradesnivelamento do segmento ST. Qual das medidas a seguir foi demonstrado, em ensaios clínicos, ser eficaz claramente para tratamento inicial em diminuir a gravidade em eventos cardiovasculares?

A) Uso intravenoso de nitrato nas primeiras horas do início da dor.

B) Associação de clopidogrel e ticlopidina.

C) Utilização de bloqueadores do cálcio (Verapamil ou Diltiazem).

D) Uso de heparina de baixo peso molecular.

E) Utilização de inibidores da enzima conversora da angiotensina 2.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

32460)

Enunciado: Paciente de 68 anos com relato de desconforto em hemitórax esquerdo há 01 semana, durante o estresse no trabalho. Há 24 horas, apresentou desconforto mais intenso (5+/10+), com cerca de 10 minutos de duração. Nessa madrugada, às 05:30h, foi acordado com intenso desconforto retroesternal (8+/10+) acompanhado de mal-estar e náuseas. Utilizou Atenolol 50 mg com melhora parcial dos sintomas. Fatores de risco: Hipertensão Arterial Sistêmica, dislipidemia, tabagista e com pai falecido por Acidente Vascular Cerebral aos 74 anos. Às 08:10h é atendido com desconforto em hemitórax esquerdo (2+/10+) e são realizados Eletrocardiograma de repouso apresentado abaixo e coleta de amostra de sangue. O exame físico revela 4ª bulha, ausência de sopros e pulmões limpos. Pressão Arterial = 165/88 mmHg, peso = 87 kg e altura = 1,73 m. Em relação ao quadro clínico descrito, pode-se afirmar que: (VER IMAGEM)

A) A história clínica e o Eletrocardiograma são suficientes para o diagnóstico e conduta terapêutica iniciais.

B) A descrição clínica é compatível com Angina Estável, com evolução para Síndrome Coronária Aguda.

C) A descrição clínica é compatível com Angina Instável e a estratificação no momento da admissão é compatível com grupo de alto risco para eventos adversos na fase intra-hospitalar.

D) A realização de ecocardiograma é necessária para diagnóstico diferencial entre as diversas apresentações das Síndromes Coronárias Agudas e orientará a terapêutica inicial.

E) A presença da 4ª bulha é útil na diferenciação entre angina instável e infarto.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

32497)

Enunciado: É expressivo o aumento da prevalência de obesidade na faixa etária pediátrica, concomitante ao incremento significativo de morbidades associadas à doença nesta idade, tais como:

A) Síndrome metabólica, Hipertensão arterial e Síndrome da apneia do sono.

B) Dislipidemia, Genu varum, Esteatose hepática.

C) Diabetes Mellitus tipo 1, Insuficiência venosa, Dislipidemia.

D) Acanthosis nigrians, Infarto agudo do miocárdio, Síndrome do ovário policístico.

E) Acidente Vascular Cerebral, Refluxo gastroesofágico, Estrias.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

27402)

Enunciado: Paciente sem fatores de risco para DAC, com dor precordial típica há 50 minutos chega ao PS com PA = 155 x 90 mmHg e FC = 78 bpm. Realizou ECG que é demonstrado abaixo. Após administração de dinitrato de isossorbida SL evolui com piora da dor precordial associada à dispneia e pré-síncope. PA = 60 x 40 mmHg e FC = 55 bpm. Qual o diagnóstico mais provável?

(VER IMAGEM)

A) IAM inferior complicando com edema agudo de pulmão

B) IAM lateral com provável rotura de músculo papilar

C) IAM anterior + CIV pós-infarto

D) IAM inferior com acometimento de ventrículo direito

E) Trata-se de pericardite aguda e hipotensão causada pela vasodilatação secundária ao uso de nitrato

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

9388)

Enunciado: Paciente de 67 anos, portador de hipertensão arterial, tem colesterol total de 280 mg/dL, HDL 32 mg/dL, triglicerídeos 190 mg/dL e cintura 104 cm. Fez uma CT Slice-64 para diagnóstico de doença coronariana. Que parecer clínico é dado ao paciente?

A) O teste negativo para estenose coronariana nos permite excluir a possibilidade de doença aterosclerótica coronariana.

B) A presença de estenose não necessita confirmação por cateterismo coronariano.

C) Trata-se de um exame com baixa especificidade e sensibilidade, sem aplicabilidade clínica.

D) O valor preditivo negativo para estenose dos segmentos iniciais, médio e distal das artérias coronárias é baixo, aproximadamente 20%.

E) Esse teste apresenta pequena exposição à radiação, sem risco para o paciente.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

355622)

Enunciado: Paciente masculino, 60 anos, é atendido com dor precordial constritiva iniciada em repouso desde duas horas antes. Encontra-se diaforético e pálido; PA = 110/75 mmHg; FC = 106 bpm; ausculta cardíaca com ritmo cardíaco regular, sem sopros. O nível sérico de troponina está elevado e o traçado do ECG é compatível com infarto agudo do miocárdio sem elevação do segmento ST. Assinale a alternativa que apresenta a melhor opção terapêutica para este paciente:

A) ácido acetilsalicílico

B) AAS, betabloqueador, clopidogrel e enoxiparina

C) betabloqueador, maleato de enalapril e enoxiparina

D) nitroglicerina, sulfato de morfina e betabloqueador

E) estreptoquinase, AAS, fondaparinux e clopidogrel

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

353832)

Enunciado: De acordo com a Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Angina Instável e Infarto Agudo do Miocárdio sem Supradesnível do Segmento ST (SCASSST), julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F). 1. O uso de AAS é recomendado na sala de emergência o mais precoce possível em todos os pacientes sem contraindicação, em dose inicial de 150 a 300 mg e dose de manutenção de 75 a 100 mg. 2. Os Anti-Inflamatórios Não Esteroides (AINE) são preconizados para controle da dor em pacientes com infarto agudo do miocárdio. 3. É indicado iniciar o tratamento com nitrato para alívio da angina na sala de emergência, sendo administrado inicialmente por via sublingual, e, caso não haja melhora rápida da dor, a administração intravenosa é recomendada. Sendo (V) para verdadeiro e (F) para falso, é CORRETO afirmar:

A) 1F ? 2V ? 3F.

B) 1V ? 2V ? 3F.

C) 1F ? 2F ? 3V.

D) 1V ? 2F ? 3V.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

334095)

Enunciado: O ecocardiograma sob estresse pode ser recomendado para estratificação de risco de pacientes em unidades de dor torácica:

A) Especialmente quando o ECG não define o diagnóstico e o teste ergométrico é submáximo, de realização não factível ou com resultado inconclusivo, uma vez aliviada a dor por pelo menos 24h em pacientes de baixo a moderado risco e sem alterações isquêmicas evidentes no ECG e marcadores de necrose.

B) Especialmente quando o ECG define o diagnóstico e o teste ergométrico é submáximo, de realização não factível ou com resultado inconclusivo, uma vez aliviada a dor por pelo menos 24h em pacientes de baixo a moderado risco e sem alterações isquêmicas evidentes no ECG e marcadores de necrose.

C) Especialmente quando o ECG não define o diagnóstico e o teste ergométrico não é submáximo, de realização factível ou com resultado inconclusivo, uma vez aliviada a dor por pelo menos 24h em pacientes de baixo a moderado risco e sem alterações isquêmicas evidentes no ECG e marcadores de necrose.

D) Especialmente quando o ECG não define o diagnóstico e o teste ergométrico é submáximo, de realização não factível ou com resultado conclusivo, uma vez aliviada a dor por pelo menos 4h em pacientes de baixo a moderado risco e sem alterações isquêmicas evidentes no ECG e marcadores de necrose.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

334097)

Enunciado: Em pacientes com dor torácica aguda e ECG não diagnóstico:

A) O uso da ecocardiografia com contraste reduz a sensibilidade para o diagnóstico da síndrome coronariana aguda - SCA.

B) O uso da ecocardiografia sem contraste não aumenta a sensibilidade para o diagnóstico da síndrome coronariana aguda - SCA.

C) O uso da ecocardiografia com contraste não aumenta a sensibilidade para o diagnóstico da síndrome coronariana aguda - SCA.

D) O uso da ecocardiografia com contraste aumenta a sensibilidade para o diagnóstico da síndrome coronariana aguda - SCA.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

334773)

Enunciado: Um paciente do sexo masculino, diabético, com 62 anos de idade, foi submetido à angioplastia coronariana com implante de stent há 7 dias, na vigência de quadro de infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST. No seguimento ambulatorial deste paciente é importante garantir que

A) a terapia de dupla antiagregação plaquetária seja mantida por no máximo seis meses após o infarto.

B) os fármacos análogos do GLP-1 não sejam associados ao esquema terapêutico antes de 30 dias do infarto.

C) o nível máximo de LDL-C em 50 mg/dL deve ser alcançado o mais brevemente possível.

D) o ácido acetilsalicílico seja suspenso, em pacientes com ritmo sinusal, após doze meses do infarto.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

339771)

Enunciado: Um jovem previamente hígido de 22 anos dá entrada na emergência com dor em pontada no hemitórax esquerdo e febre após 3 dias de um quadro de gastroenterocolite aguda. Ao exame físico, apresentava com FC = 70bpm, PA 100x60mmHg e Temp. 37,8º. A dosagem laboratorial de troponina foi de 2.000ng/ml (VR < 0,04ng/ml) e o eletrocardiograma foi o seguinte: O quadro clínico apresentado sugere como diagnóstico:

A) infarto agudo do miocárdio com supra desnivelamento do segmento ST.

B) dissecção de coronária.

C) miopericardite.

D) vasoespasmo coronariano.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

339772)

Enunciado: Um jovem previamente hígido de 22 anos dá entrada na emergência com dor em pontada no hemitórax esquerdo e febre após 3 dias de um quadro de gastroenterocolite aguda. Ao exame físico, apresentava com FC = 70bpm, PA 100x60mmHg e Temp. 37,8º. A dosagem laboratorial de troponina foi de 2.000ng/ml (VR < 0,04ng/ml) e o eletrocardiograma foi o seguinte: Qual dos exames a seguir deverá ser solicitado nesse caso?

A) Cateterismo cardíaco.

B) Angiotomografia de coronárias.

C) Cintilografia do miocárdio.

D) Ecocardiograma.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

339773)

Enunciado: Um jovem previamente hígido de 22 anos dá entrada na emergência com dor em pontada no hemitórax esquerdo e febre após 3 dias de um quadro de gastroenterocolite aguda. Ao exame físico, apresentava com FC = 70bpm, PA 100x60mmHg e Temp. 37,8º. A dosagem laboratorial de troponina foi de 2.000ng/ml (VR < 0,04ng/ml) e o eletrocardiograma foi o seguinte:

Nesse caso, o tratamento adequado é o da indicação de

A) aspirina e clopidogrel.

B) anti-inflamatório não hormonal e colchicina.

C) corticosteroides e nitrato.

D) heparina, aspirina e clopidogrel.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

339774)

Enunciado: Um paciente de 61 anos de idade, sedentário, obeso e tabagista, há duas horas iniciou epigastralgia em queimação de forte intensidade após o almoço. O exame físico mostrou uma frequência cardíaca igual a 60 bpm, frequência respiratória = 25 irpm, SatO2 = 92% e PA = 100 mmHg x 60 mmHg, com ausculta cardíaca e pulmonar normais e sem edema de membros inferiores. Na admissão em uma unidade de pronto atendimento, ele realizou o eletrocardiograma (ECG) a seguir. Qual é a principal hipótese de diagnóstico?

A) Bloqueio de ramo direito.

B) Infarto agudo do miocárdio

C) Síndrome de Wolf Parkinson White

D) Hipertonia vagal

E) Fibrilação atrial

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

346432)

Enunciado: Você está de plantão no pronto socorro do hospital e existem 04 pacientes na sala vermelha. Assinale qual dos pacientes possui indicação de trombólise endovenosa de urgência, considerando ausência de contra indicações?

A) Homem de 40 anos, diabético e hipertenso, apresentou episódio de perda de força à direita e dificuldade para falar há 05 horas. EF: Hemiplegia à direita e Afasia motora. Exames Complementares: TC Crânio Sem alterações;

B) Mulher de 55 anos, tabagista 40 anos/maço, apresentou episódio de dor torácica, em opressão, de forte intensidade, com irradiação para o membro superior esquerdo e mandíbula há 11 horas. Exames Complementares: ECG Supra de segmento ST em parede anterior;

C) Homem de 35 anos, submetido a cirurgia de joelho esquerdo há 01 semana, apresentou episódio de dor em membro inferior esquerdo há 06 horas. EF: Dor à palpação de panturrilha esquerda. Exames Complementares: USG Doppler Venoso de Membro Inferior Esquerdo: Trombose venosa profunda extensa;

D) Mulher de 35 anos, em uso de anticoncepcional oral, apresentou episódio de dor torácica ventilatória dependente à esquerda há 03 horas, sem instabilidade hemodinâmica. Exames Complementares: Angio TC Tórax, com presença de TEP Defeitos de enchimento completos dos ramos inferiores dos lobos médio e inferiores pulmonares.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

321608)

Enunciado: Um jovem previamente hígido de 22 anos dá entrada na emergência com dor em pontada no hemitórax esquerdo e febre após 3 dias de um quadro de gastroenterocolite aguda. Ao exame físico, apresentava com FC = 70bpm, PA 100x60mmHg e Temp. 37,8º. A dosagem laboratorial de troponina foi de 2.000ng/ml (VR < 0,04ng/ml) e o eletrocardiograma foi o seguinte: O quadro clínico apresentado sugere como diagnóstico:

A) infarto agudo do miocárdio com supra desnivelamento do segmento ST.

B) dissecção de coronária.

C) miopericardite.

D) vasoespasmo coronariano.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

337459)

Enunciado: A adição do escore de cálcio coronário aos de riscos clínicos:

A) Tem figurado como a alternativa mais eficiente e não custo-efetiva na atualidade para estimar o risco de doença arterial coronariana (DAC) em pacientes com risco intermediário.

B) Tem figurado como a alternativa mais eficiente e custo-efetiva na atualidade para estimar o risco de doença arterial coronariana (DAC) em pacientes com risco intermediário.

C) Não Tem figurado como a alternativa mais eficiente e custo-efetiva na atualidade para estimar o risco de doença arterial coronariana (DAC) em pacientes com risco intermediário.

D) Tem figurado como a alternativa menos eficiente e custo-efetiva na atualidade para estimar o risco de doença arterial coronariana (DAC) em pacientes com risco intermediário.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

321609)

Enunciado: Um jovem previamente hígido de 22 anos dá entrada na emergência com dor em pontada no hemitórax esquerdo e febre após 3 dias de um quadro de gastroenterocolite aguda. Ao exame físico, apresentava com FC = 70bpm, PA 100x60mmHg e Temp. 37,8º. A dosagem laboratorial de troponina foi de 2.000ng/ml (VR < 0,04ng/ml) e o eletrocardiograma foi o seguinte:

Qual dos exames a seguir deverá ser solicitado nesse caso?

A) Cateterismo cardíaco.

B) Angiotomografia de coronárias.

C) Cintilografia do miocárdio.

D) Ecocardiograma.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

321610)

Enunciado: Um jovem previamente hígido de 22 anos dá entrada na emergência com dor em pontada no hemitórax esquerdo e febre após 3 dias de um quadro de gastroenterocolite aguda. Ao exame físico, apresentava com FC = 70bpm, PA 100x60mmHg e Temp. 37,8º. A dosagem laboratorial de troponina foi de 2.000ng/ml (VR < 0,04ng/ml) e o eletrocardiograma foi o seguinte:

Nesse caso, o tratamento adequado é o da indicação de

A) aspirina e clopidogrel.

B) anti-inflamatório não hormonal e colchicina.

C) corticoesteroides e nitrato.

D) heparina, aspirina e clopidogrel.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

337466)

Enunciado: De forma concordante, o uso de estatinas em pacientes com doença arterial coronariana (DAC) parece estabilizar placas ateroscleróticas:

A) Não podendo até produzir sua regressão volumétrica, com uma relação aproximadamente linear não apenas entre a redução do LDL-c e a taxa de eventos doença cardiovascular CV, mas também entre o nível de LDL-c e a progressão do volume de ateroma em carótidas.

B) Podendo até produzir sua regressão volumétrica, com uma relação aproximadamente linear não apenas entre a redução do LDL-c e não para a taxa de eventos doença cardiovascular CV, mas também entre o nível de LDL-c e a progressão do volume de ateroma em carótidas.

C) Podendo até produzir sua regressão volumétrica, com uma relação aproximadamente linear não apenas entre a redução do LDL-c e a taxa de eventos doença cardiovascular CV, e não para o nível de LDL-c e a progressão do volume de ateroma em carótidas.

D) Podendo até produzir sua regressão volumétrica, com uma relação aproximadamente linear não apenas entre a redução do LDL-c e a taxa de eventos doença cardiovascular CV, mas também entre o nível de LDL-c e a progressão do volume de ateroma em carótidas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

315764)

Enunciado: Nos pacientes que chegam ao serviço de emergência com menos de 3h do início do quadro de dor:

A) As Trop-US são significativamente mais sensíveis que a troponina convencional para diagnóstico de SCA, melhorando em 61% o poder diagnóstico de IAM naquele momento e em 100% se a coleta for 6h após o início do quadro.

B) As Trop-US são significativamente menos sensíveis que a troponina convencional para diagnóstico de SCA, melhorando em 61% o poder diagnóstico de IAM naquele momento e em 100% se a coleta for 6h após o início do quadro.

C) As Trop-US são significativamente mais sensíveis que a troponina convencional para diagnóstico de SCA, piorando em 61% o poder diagnóstico de IAM naquele momento e em 100% se a coleta for 6h após o início do quadro.

D) As Trop-US são significativamente mais sensíveis que a troponina convencional para diagnóstico de SCA, melhorando em 61% o poder diagnóstico de IAM naquele momento e em 100% se a coleta for 1h após o início do quadro.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

315767)

Enunciado: A dose de enoxaparina é de 1mg/kg administrado por via subcutânea (SC) duas vezes ao dia. Na idade superior a 75 anos, a dose deve ser reduzida para 0,75mg/kg duas vezes ao dia. Sendo correto que:

A) Em pacientes com a taxa de filtração glomerular estimada (TFGe) igual ou inferior a 30mL/min/1,73m2, a dose deve ser reduzida por 10, sendo então administrado 0,1mg/ kg (SC) uma vez ao dia.

B) Em pacientes com a taxa de filtração glomerular estimada (TFGe) igual ou inferior a 30mL/min/1,73m2, a dose deve ser reduzida pela metade, sendo então administrado 1mg/ kg (SC) duas vezes ao dia.

C) Em pacientes com a taxa de filtração glomerular estimada (TFGe) igual ou inferior a 30mL/min/1,73m2, a dose não deve ser reduzida.

D) Em pacientes com a taxa de filtração glomerular estimada (TFGe) igual ou inferior a 30mL/min/1,73m2, a dose deve ser reduzida pela metade, sendo então administrado 1mg/ kg (SC) uma vez ao dia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

300807)

Enunciado: Considerando as partes que recorrentemente classificam a anamnese, quanto ao elemento ?antecedentes pessoais?, é CORRETO afirmar:

A) Pergunta-se sobre o início dos sintomas, como evoluíram e como estão no momento.

B) Pergunta-se sobre a sua atual profissão e se o paciente utiliza algum equipamento de proteção.

C) É de suma precisão para que se possa obter do paciente se ele possui algum tipo de alergia e intolerância a medicações e alimentos.

D) Pergunta-se se o paciente é fumante ativo ou passivo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

315777)

Enunciado: Com a introdução das troponinas de alta sensibilidade (Trop-US), está correto o item:

A) Passou a ser possível a detecção de níveis mais baixos de troponina, em menor tempo após início do quadro de lesão miocárdica de causa isquêmica.

B) Passou a ser impossível a detecção de níveis mais baixos de troponina, em menor tempo após início do quadro de lesão miocárdica de causa isquêmica.

C) Passou a ser possível a detecção de níveis mais elevados de troponina, em menor tempo após início do quadro de lesão miocárdica de causa isquêmica.

D) Passou a ser possível a detecção de níveis mais baixos de troponina, em maior tempo após início do quadro de lesão miocárdica de causa isquêmica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

316331)

Enunciado: Paciente de 24 anos, sem comorbidades, com histórico de internação recente por covid-19, procura novamente o PS devido ao quadro de dor torácica com início há 3 dias com piora gradativa. Relata que ao decúbito e também a inspiração profunda apresenta piora significativa. Realizado o ECG (mostrado a seguir) logo na admissão junto com 2 coletas de marcadores de necrose miocárdica - Troponina (VR <0,2) -> 1º: 0,45/ 2º:2,3. De acordo com o caso, qual o diagnóstico mais provável?

A) SCA com supradesnivelamento do segmento ST.

B) SCA sem supradesnivelamento do segmento ST.

C) Miopericardite.

D) Sd. de Takotsubo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

273123)

Enunciado: Homem, 46 anos, com dor em região torácica (precordial), aperto ou queimação que irradia para ambos os ombros, mandíbula e membro superior esquerdo. Nesse caso haverá indicação do exame complementar de cintilografia de perfusão miocárdica:

A) Para a avaliação das funções sistólica e diastólica, de alterações da motilidade ventricular, das valvas cardíacas e do pericárdio.

B) Por haver moderada probabilidade de DAC, no caso de cintilografia inconclusiva, e paciente sintomático, com exames normais.

C) Por haver relato de dor torácica ou suspeita de angina.

D) Caso tenha havido teste ergométrico inconclusivo por alterações eletrocardiográficas prévias ou incapacidade de realizar exercícios até uma faixa de frequência cardíaca adequada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

273207)

Enunciado: Considerando os evidentes benefícios da prática de atividade física para a saúde e seus possíveis riscos, uma exposição equilibrada de riscos e benefícios e uma avaliação das características e adaptações necessárias de determinados indivíduos e grupos são elementos essenciais de uma boa prática assistencial, a qual busca evitar o risco de agravos que derivam da prática de:

A) Atividades de maior intensidade e menor duração na presença de condições favorecedoras, como lesões preexistentes e obesidade.

B) Atividades de menor intensidade e maior duração na presença de condições desfavorecedoras, como lesões preexistentes e obesidade.

C) Atividades de maior intensidade e maior duração na presença de condições favorecedoras, como lesões preexistentes e obesidade.

D) Atividades de menor intensidade e menor duração na presença de condições desfavorecedoras, como lesões preexistentes e obesidade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

273209)

Enunciado: Considerando que a prática de atividade física tem contribuído para a redução no risco de desenvolvimento de alguns agravos à saúde, bem como para um melhor prognóstico na evolução de algumas doenças, quanto à recomendação de sua adoção, deve fazer parte do conjunto de orientações oferecidas pelos profissionais de saúde:

A) A duração recomendada é de pelo menos 30 minutos por dia, com uma frequência desejada de 2 a 4 dias por semana, sendo que os indivíduos inicialmente sedentários devem atingir o nível de atividade pretendido de forma súbita, a fim de se adaptar aos poucos, reduzindo o risco de lesões ou complicações.

B) A duração recomendada é de pelo menos 45 minutos por dia, com uma frequência desejada de 5 a 7 dias por semana, sendo que os indivíduos inicialmente sedentários devem atingir o nível de atividade pretendido de forma gradual, a fim de se adaptar aos poucos, reduzindo o risco de lesões ou complicações.

C) A duração recomendada é de pelo menos 30 minutos por dia, com uma frequência desejada de 5 a 7 dias por semana, sendo que os indivíduos inicialmente sedentários devem atingir o nível de atividade pretendido de forma gradual, a fim de se adaptar aos poucos, reduzindo o risco de lesões ou complicações.

D) A duração recomendada é de pelo menos 45 minutos por dia, com uma frequência desejada de 2 a 4 dias por semana, sendo que os indivíduos inicialmente sedentários devem atingir o nível de atividade pretendido de forma súbita, a fim de se adaptar aos poucos, reduzindo o risco de lesões ou complicações.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

254211)

Enunciado: Homem 54 anos, obeso, hipertenso e diabético, admitido no PA com quadro de dor torácica típica e eletrocardiograma evidenciando supradesnívelamento de segmento ST em D2, D3 e avF. Ao exame físico, apresentava-se acordado, consciente, orientado, com taquidispneia, estertor crepitante bibasal, turgência jugular, PA 140x90mmHg, tempo de enchimento capilar 2seg. Baseadonos dados apresentados, pode-se classificar o paciente em qual classe de Killip:

A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

229499)

Enunciado: Nas síndromes coronarianas agudas que podem estar acompanhadas de elevação da PA, devido a um reflexo do miocárdio isquêmico, somente podemos CONCORDAR que:

A) O aumento da RVP eleva a demanda de oxigênio miocárdico, pelo aumento da tensão parietal do ventrículo esquerdo.

B) Os nitratos IV reduzem a RVP, e pioram a perfusão coronariana.

C) Os nitratos IV não possuem importante efeito vasodilatador sistêmico.

D) Os nitratos IV reduzindo a pré-carga, mas não o consumo de oxigênio miocárdico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

249848)

Enunciado: Paciente S.G.A, do sexo masculino, de 66 anos, hipertenso, tabagista, diabético, em uso regular de losartana (50 mg/dia), metformina (850 mg/dia) e de ácido acetilsalicílico (100 mg/dia) há seis meses, deu entrada no pronto atendimento com dor precordial típica, de início há três horas e que melhorou com uso de nitrato. Após realizar os exames de emergência para síndrome coronariana aguda (troponina positiva, creatinina 0,8 mg/dl, ureia 32 mg/dl e eletrocardiograma). Nesse caso, o paciente

A) deve ser estratificado invasivamente (cateterismo cardíaco), com urgência, por se tratar de uma síndrome coronariana aguda com supra de ST.

B) deve ser estratificado invasivamente (cateterismo cardíaco), de maneira precoce, por se tratar de alto risco cardiológico (TIMI RISK alto), com uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST.

C) deve ser encaminhado para estratificação não invasiva, por se tratar de um paciente de baixo risco cardiológico (TIMI RISK baixo), com uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST.

D) deve ser trombolisado, por se tratar de síndrome coronariana aguda, na falta de estratificação invasiva (cateterismo cardíaco).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

232225)

Enunciado: Leia o caso clínico a seguir. Um paciente de 80 anos dá entrada no pronto-socorro com forte dor no peito, há 30 minutos, associada à sudorese. À admissão, observam-se um ritmo regular, FC = 80 bpm, PA = 80 x 55 mmHg e SatO? = 95%. O ECG mostrou supradesnivelamento do segmento ST de V1 a V4. Nesse caso, a conduta imediata é:

A) Dosar enzimas cardíacas.

B) Avaliar função renal.

C) Iniciar noradrenalina.

D) Realizar revascularização percutânea.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

229866)

Enunciado: Gilmar, 52 anos, gari, vem à consulta na Unidade Básica de Saúde com queixa de dor no peito há 2 meses. A dor aparece quando está trabalhando e precisa correr ou carregar muito peso. Sente como um peso atrás do peito, que dura um 1 minuto e melhora quando fica em repouso. Ele é tabagista, fuma 1 maço/dia há 20 anos, e hipertenso, faz uso de captopril quando a pressão sobe. O risco cardiovascular calculado na consulta é de 34% e a probabilidade pré-teste para doença coronariana é maior que 90%. A alternativa que não corresponde ao caso de Gilmar é

A) se o teste ergométrico não evidenciar sinais de isquemia miocárdica, é necessário iniciar investigação para outras etiologias de dor torácica como causas esofágicas e pulmonares;

B) caso a dor de Gilmar apresente piora progressiva, com episódios de dor com duração maior e com menor limiar de esforço, é necessário manejar como síndrome coronariana aguda;

C) em caso de um episódio de dor torácica maior do que 20 minutos, no momento do atendimento médico, é importante obter um eletrocardiograma e oferecer 300 mg de ácido acetilsalicílico (AAS);

D) no caso de Gilmar, é recomendado o início de beta-bloqueadores, que podem promover alívio sintomático da angina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

247467)

Enunciado: A Doença Cardiovascular (CV) aterosclerótica é, em termos proporcionais, a principal causa da mortalidade em países desenvolvidos e em muitos países em desenvolvimento como o Brasil. Nos últimos anos, ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas vêm apontando avanços no potencial de prevenção dessas doenças. Em relação a prevenção das doenças cardiovasculares tem-se o seguinte:

A) a alimentação saudável é um dos pilares da prevenção cardiovascular, porém nenhuma intervenção nutricional específica mostrou-se efetiva na redução de eventos CV.

B) evidências consistentes de estudos observacionais demonstram que a realização de atividade física está associada à redução do risco de eventos CV tanto em homens quanto em mulheres, independente da idade e intensidade desta atividade.

C) em prevenção secundária, o uso de alguns fármacos anti-hipertensivos está associado a uma redução de eventos CV mesmo em pacientes sem hipertensão.

D) ensaios clínicos randomizados recentes têm demonstrado que terapia de reposição hormonal diminuiram os eventos CV.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

254291)

Enunciado: Manoel é um homem de 55 anos, branco, sedentário, hipertenso, que chega até a unidade de saúde com a expectativa de fazer exames. Diz que utiliza losartana 50 mg de 12/12 horas há 10 anos e que acredita que a medicação esteja fraca, pois a pressão tem ficado descontrolada. Entendendo o contexto de Manoel, você solicita exames complementares, os quais mostram os resultados a seguir: Colesterol total = 195; HDL = 40; LDL = 120; Triglicérides = 230; Glicemia de jejum = 108; Hemoglobina glicada = 5,6%; Creatinina = 0,7; EAS = sem alterações; Eletrocardiograma = normal; Medida ambulatorial de pressão arterial (MAPA) = PA média de 145 x 78 mmHg; Após analisá-los, você decide calcular o risco cardiovascular de Manoel por meio da calculadora Framingham, cujo desfecho é de 21,40%. Diante do risco cardiovascular aferido, a melhor conduta é:

A) Prescrever AAS diário e estimular perda de peso.

B) Prescrever ciprofibrato e sinvastatina, para repetir lipidograma em 3 meses.

C) Prescrever sinvastatina e estimular exercícios físicos.

D) Prescrever metformina e aumentar a dose de losartana.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

254292)

Enunciado: Manoel é um homem de 55 anos, branco, sedentário, hipertenso, que chega até a unidade de saúde com a expectativa de fazer exames. Diz que utiliza losartana 50 mg de 12/12 horas há 10 anos e que acredita que a medicação esteja fraca, pois a pressão tem ficado descontrolada. Entendendo o contexto de Manoel, você solicita exames complementares, os quais mostram os resultados a seguir: Colesterol total = 195; HDL = 40; LDL = 120; Triglicérides = 230; Glicemia de jejum = 108; Hemoglobina glicada = 5,6%; Creatinina = 0,7; EAS = sem alterações; Eletrocardiograma = normal; Medida ambulatorial de pressão arterial (MAPA) = PA média de 145 x 78 mmHg; Após analisá-los, você decide calcular o risco cardiovascular de Manoel por meio da calculadora Framingham, cujo desfecho é de 21,40%. Imagine que Manoel retorne à UBS e relate o surgimento, há 4 meses, de dor retroesternal ao realizar esforços mais intensos, com melhora ao repouso, de caráter não progressivo. Para compreender melhor a probabilidade de se tratar de um quadro de doença arterial coronariana, você pesquisa pela tabela abaixo: Dentre as opções abaixo, aquela que representa a melhor conduta diante da suspeita de angina é:

A) Solicitar teste de esforço para estratificação de risco, devido à alta probabilidade pré-teste de angina estável.

B) Encaminhar para serviço de urgência devido ao risco de angina instável.

C) Solicitar cintilografia miocárdica para estabelecer diagnóstico definitivo.

D) Manter a losartana 100 mg/dia e acrescentar AAS e furosemida.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

201903)

Enunciado: Um homem de 56 anos procura o pronto-socorro por dor torácica, referindo pressão retroesternal, irradiada para a mandíbula, desencadeada por esforço, melhorando após 3 minutos em repouso, que não se altera com a posição ou com a ventilação. O paciente é atendido 1 hora após e no momento está assintomático. O eletrocardiograma é normal. A alternativa que melhor relaciona a hipótese mas provável e a conduta, respectivamente, nesse momento, é:

A) angina de peito ? dosagem de troponina

B) infarto agudo do miocárdio - ecocardiograma

C) infarto agudo do miocárdio - coronariografia

D) dissecção de aorta ? radiografia de tórax

E) angina de peito ? teste de esforço

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

218210)

Enunciado: Um paciente com suspeita de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) realiza no pronto atendimento um eletrocardiograma que revela a presença de Bloqueio do Ramo Esquerdo (BRE). Sobre o quadro acima exposto, assinale a alternativa CORRETA:

A) A presença do BRE torna menos provável um quadro de IAM.

B) Se o paciente apresentar no pronto atendimento um teste ergométrico realizado há 2 anos com BRE no traçado de repouso, fica menos provável um quadro de IAM.

C) Na vigência do BRE, a presença de uma elevação do segmento ST de 2 mm em V1 e V2 torna o traçado favorável a um quadro de IAM, com provável acometimento de artéria descendente anterior.

D) Na vigência do BRE, a presença de uma elevação do segmento ST de 1 mm em D1 e aVL com complexos QRS positivos torna o traçado favorável a um quadro de IAM.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

205559)

Enunciado: A Calcificação Arterial Coronariana (CAC) está associada à mortalidade em pacientes com diabetes, podendo ser considerada marcador de carga de placa aterosclerosclerótica, já demonstrado em análise anatômica. Podemos assim, aceitar que:

A) Em pacientes sem diabetes, CAC > 10 é preditor de mortalidade e eventos cardiovasculares futuros. Recomenda-se que pacientes com diabetes, com CAC > 10 sejam considerados de alto risco cardiovascular.

B) Em pacientes com diabetes, CAC > 10 é preditor de mortalidade e eventos cardiovasculares futuros. Recomenda-se que pacientes com diabetes, com CAC > 10 sejam considerados de alto risco cardiovascular.

C) Em pacientes com diabetes, CAC > 5 é preditor de mortalidade e eventos cardiovasculares futuros. Recomenda-se que pacientes com diabetes, com CAC > 10 sejam considerados de alto risco cardiovascular.

D) Em pacientes com diabetes, CAC > 10 é preditor de mortalidade e eventos cardiovasculares futuros. Recomenda-se que pacientes com diabetes, com CAC > 12 sejam considerados de alto risco cardiovascular.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

205573)

Enunciado: A alternativa para o rastreio de isquemia é a ecocardiografia de estresse, usando exercício ou estresse farmacológico com dobutamina. Sensibilidade e especificidade são 81 e 85%, respectivamente, em pacientes diabéticos assintomáticos. Sendo CORRETO que:

A) O ecocardiograma de estresse não detecta possíveis anormalidades no movimento segmentar da parede ventricular, fornecendo informações sobre a intensidade da isquemia e a função ventricular esquerda.

B) O ecocardiograma de estresse detecta possíveis anormalidades no movimento segmentar da parede ventricular, fornecendo informações sobre a intensidade da isquemia e a função ventricular esquerda.

C) O ecocardiograma de estresse detecta possíveis anormalidades no movimento global apenas da parede ventricular, fornecendo informações sobre a intensidade da isquemia e a função ventricular esquerda.

D) O ecocardiograma de estresse detecta possíveis anormalidades no movimento segmentar da parede ventricular, não fornecendo informações sobre a intensidade da isquemia e a função ventricular esquerda.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

217026)

Enunciado: A respeito do manejo clínico da Síndrome Coronariana Aguda, assinale a alternativa correta.

A) O uso de betabloqueador em pacientes com essa síndrome implica redução da mortalidade.

B) Hipoperfusão, broncoespasmo e tabagismo são contraindicações ao betabloqueador.

C) A enoxaparina apresenta maior incidência de plaquetopenia que a heparina não fracionada.

D) Deve-se evitar o uso de nitratos no caso de crepitações ou na presença de B3.

E) A prescrição de inibidor de ECA e do AAS deve ser precoce à admissão.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

216683)

Enunciado: Sabe-se que a troponina, CPK e a fração MB, possuem valores diagnósticos no infarto agudo do miocárdio. Temos ciência de que a troponina após o início da dor se eleva de 4-6 horas e apresenta seu pico de 12-48 horas. Considerando-se essas informações, em quanto tempo ela se normaliza?

A) De 7 a 14 dias.

B) De 1 a 3 dias.

C) De 3 a 5 dias.

D) Após 16 dias.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

174409)

Enunciado: Diversos estudos utilizaram fibrinolíticos fora do ambiente hospitalar com condições operacionais apropriadas para seu uso, e para a monitorização tanto clínicas como eletrocardiográfica pré-hospitalar dos pacientes e para o tratamento das taquiarritmias. Esses estudos consolidaram alguns conceitos, dos apresentados nas alternativas a seguir, assinale o INCORRETO.

A) A utilização da terapêutica fibrinolítica pré hospitalar baseia-se no conceito clássico experimental de que, ao se abreviar o tempo de isquemia miocárdica aguda, reduz-se o tamanho do infarto do miocárdio.

B) Quanto mais precoce é administrada a terapêutica fibrinolítica, menores a mortalidade e o grau de disfunção ventricular.

C) O retardo pré-hospitalar, intervalo entre o início dos sintomas isquêmicos e a chegada ao hospital, não é um dos determinantes do tamanho do infarto e da mortalidade pré e intra-hospitalar.

D) O retardo pré-hospitalar, esse tempo é de, em média, 3 a 4 horas. A utilização pré-hospitalar da terapêutica fibrinolítica visa reduzir esse retardo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

175391)

Enunciado: Um homem de 56 anos procura o pronto-socorro por dor torácica, referindo pressão retroesternal, irradiada para a mandíbula, desencadeada por esforço, melhorando após 3 minutos em repouso, que não se altera com a posição ou com a ventilação. O paciente é atendido 1 hora após e no momento está assintomático. O eletrocardiograma é normal. A alternativa que melhor relaciona a hipótese mais provável e a conduta, respectivamente, nesse momento, é:

A) angina de peito ? dosagem de troponina

B) infarto agudo do miocárdio ? ecocardiograma

C) infarto agudo do miocárdio ? coronariografia

D) dissecção de aorta ? radiografia de tórax

E) angina de peito ? teste de esforço

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

174422)

Enunciado: Dentro do uso de medicamentos para tratamento de Síndromes Coronarianas, podemos apenas afirmar como CORRETO o seguinte item a respeito do Ácido acetilsalicílico:

A) Um dos muitos antiinflamatórios indicados rotineiramente para todos os pacientes com suspeita de IAM.

B) Pacientes com maior risco de doença coronária devem ser instruídos por seus médicos assistentes a tomar Ácido Acetilsalicílico (AAS) tamponado em situações emergenciais.

C) É o antiplaquetário de eleição a ser utilizado no IAM, tendo sido demonstrado sua eficácia.

D) Tem ação antagônica com o próprio fibrinolítico, levando à associação de ambos os medicamentos a um acréscimo na mortalidade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

174451)

Enunciado: Quanto ao uso de nitratos nas Síndromes Coronarianas Agudas, podemos considerar como INCORRETA a alternativa:

A) Podem ser utilizados na formulação sublingual (nitroglicerina, mononitrato de isossorbida ou dinitrato de isossorbida), para reversão de eventual espasmo e/ou para alívio da dor anginosa.

B) Não estão recomendados para controle da hipertensão arterial ou alívio da congestão pulmonar, se presentes.

C) Estão contraindicados na presença de hipotensão arterial (Pressão Arterial Sistólica - PAS < 90mmHg).

D) Estão contraindicados com o uso prévio de sildenafil ou similares nas últimas 24 horas e quando houver suspeita de comprometimento do Ventrículo Direito (VD).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

173504)

Enunciado: As complicações relacionadas com a doença coronária e, especificamente, com o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) são diversas e frequentes. É uma complicação mecânica do IAM:

A) Trombose coronariana.

B) Dissecção coronariana.

C) Aneurisma de ventrículo esquerdo.

D) Bloqueio Atrioventricular Total (BAVT).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

174433)

Enunciado: Durante avaliação médica da sala de emergência coronariana, foi solicitado que você desse um parecer fundamentado a respeito da contraindicação de betabloqueadores. Dessa forma, em relação aos betabloqueadores, é CORRETO afirmar:

A) Na ausência de contraindicações, essa classe de medicamentos deve ser iniciada, de preferência, por via endovenosa, após a admissão do paciente.

B) A utilização de betabloqueador endovenoso deve ser feita com critério, sendo recomendado atualmente de se utilizar o betabloqueador por via endovenosa nas primeiras 48 horas, reservando-se a via endovenosa para casos selecionados, como em pacientes hipertensos e taquicardíacos.

C) Recomenda-se iniciar o betabloqueador e titular sua dose para um alvo de 60 batimentos por minutos.

D) Pacientes com contraindicação para o uso precoce dos betabloqueadores não devem ser reavaliados para candidatos a essa terapia na prevenção secundária.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

173520)

Enunciado: Um paciente dá entrada no pronto-socorro com síndrome coronariana aguda sem supradesnivelamento do segmento ST. A qual tipo de conduta médica esse paciente não poderá ser submetido?

A) Aspirina.

B) Heparina.

C) Trombolítico.

D) Betabloqueador.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

173531)

Enunciado: Mulher de 68 anos, hipertensa, fumante e diabética, dá entrada no pronto-socorro com forte dor no peito do tipo aperto e associada a sudorese, náusea e palidez, iniciados há 45 minutos. O exame físico, o eletrocardiograma e as enzimas cardíacas, realizados imediatamente, foram normais. Qual seria a conduta médica adequada?

A) Administrar aspirina e clopidogrel, internar e seriar enzimas e ECG.

B) Dar alta hospitalar e encaminhar para o ambulatório de cardiologia.

C) Solicitar cateterismo cardiaco.

D) Solicitar um teste isquêmico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182490)

Enunciado: Um homem de 54 anos chega ao pronto atendimento referindo desconforto torácico descrito como sensação de peso e a localiza colocando a mão no esterno, com irradiação para o ombro esquerdo. O desconforto foi desencadeado após esforço físico habitual. Nega sintomatologia semelhante. A dor aliviou 20 minutos após a chegada ao hospital. Tem diagnóstico, há 3 anos, de dislipidemia, e está em uso de sinvastatina 20mg/d. Nesse caso, qual é a hipótese diagnóstica?

A) embolia de pulmão

B) esofagite

C) síndrome coronariana aguda

D) pneumotórax

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

185144)

Enunciado: Na avaliação de um paciente com infarto agudo do miocárdio com supra de ST, cujos sintomas iniciaram há 18 horas, a coronariografia deve ser realizada

A) em caráter de urgência, para a realização de angioplastia primária.

B) na presença de isquemia refratária às medidas farmacológicas.

C) apenas quando houver falência da terapia com fibrinolíticos.

D) apenas nos pacientes de risco moderado a alto pelo escore TIMI.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

187602)

Enunciado: Paciente masculino realizou um eletrocardiograma que evidenciou a presença de depressão do segmento ST com inversão da onda T. O diagnóstico mais provável para o caso é:

A) cardiopatia chagástica.

B) hipertrofia de ventrículo direito.

C) infarto agudo do miocárdio.

D) bloqueio átrio ventricular;

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

178865)

Enunciado: Um adulto de 28 anos procura o serviço médico por causa de dores internas em região torácica. Relata tratar-se de uma dor contínua em todo o hemitórax direito, que começou há aproximadamente 2 dias, após um jogo de vôlei com os amigos. Em um Raio-X de tórax, observa-se a seguinte condição: Após a realização do exame, o adulto refere que a dor piorou e observa-se que ele está dispnéico, com FR = 28 irpm, e taquicárdico, com FC = 121 bpm. Pode-se concluir que o paciente:

A) está com um pneumotórax espontâneo que, devido aos sinais de instabilidade súbitos após a realização do exame, está progredindo para um pneumotórax hipertensivo. A conduta é de transferência para um serviço de saúde com maior capacidade; mas, caso o doente piore, é necessário realizar a descompressão torácica.

B) está com um provável tamponamento cardíaco que, em consequência dos sinais de instabilidade súbitos após a realização do exame, está aumentando rapidamente. A conduta é de tranferência para um serviço de saúde com maior capacidade; contudo, caso o doente piore, é necessário realizar a punção de Marfan.

C) está com uma pneumonia adquirida na comunidade que, pelos sinais de instabilidade súbitos após a realização do exame, está progredindo para um quadro séptico. A conduta é transferir para um serviço de saúde com maior capacidade e iniciar hidratação.

D) está com um tromboembolismo pulmonar que, pelos sinais de instabilidade súbitos após a realização do exame, está progredindo para uma insuficiência respiratória. A conduta é é transferir para um serviço de saúde com maior capacidade, iniciar hidratação controlada e instalar cateter de oxigênio a 2 L/min.

E) está com um provável tumor pulmonar que, por causa dos sinais de instabilidade súbitos após a realização do exame, está progredindo para uma insuficiência respiratória. A conduta é de transferência para um serviço de saúde com maior capacidade, com sugestão de encaminhamento para o oncologista.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

174465)

Enunciado: Em relação à necessidade do diagnóstico de Doença Aterosclerótica Coronariana Subclínica, marque a opção considerada INCORRETA:

A) A identificação de indivíduos assintomáticos portadores de aterosclerose e, dessa forma, sob risco de eventos cardiovasculares agudos, como o infarto e morte, é fundamental para se instituírem medidas de tratamento e prevenção secundária.

B) Diante da complexidade dessas interações, a atribuição intuitiva do risco frequentemente resulta em subestimação ou superestimação dos casos de maior ou menor risco, respectivamente.

C) Para contornar essa dificuldade, diversos algoritmos têm sido criados com base em análises de regressão de estudos populacionais, por meio dos quais a identificação do risco global é substancialmente aprimorada.

D) A não identificação de indivíduos assintomáticos portadores de aterosclerose e, dessa forma, sob risco de eventos cardiovasculares agudos, como o infarto e morte, é de pouca importância em termos de prevenção secundária.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

178766)

Enunciado: Paciente, 71 anos, chega à unidade de saúde, trazida por seu filho, referindo dor torácica em aperto há aproximadamente 30 minutos, além de sudorese intensa e mal-estar geral. Na avaliação da paciente, entende-se que os sintomas são sugestivos de isquemia ou infarto. Portanto, qual é a melhor conduta?

A) Realizar um eletrocardiograma (ECG); administrar aspirina na dose de 500 mg sublingual; considerar administrar oxigênio (se saturação de oxigênio "menor ou igual" 94%) e nitroglicerina sublingual. Em caso de não haver allteração no ECG, por medida preventiva, encaminhar para um serviço especializado.

B) Realizar um eletrocardiograma (ECG) devido à dor intensa; administrar morfina como primeira escolha (em solução decimal); considerar administrar oxigênio (se saturação de oxigênio "menor ou igual" 92%) e aspirina 500 mg, se a dor persistir após morfina. Em caso de alteração no ECG, transferir para uma unidade de saúde com maior capacidade de atendimento.

C) Realizar um eletrocardiograma (ECG), se possível, de 12 derivações; administrar nitroglicerina em spray ou sublingual, como primeira escolha, devido ao quadro álgico intenso; considerar administrar oxigênio (se saturação de oxigênio "menor ou igual" 85%) e morfina, se o desconforto torácico não for aliviado pela nitroglicerina. Em caso de não haver alteração no ECG, por medida preventiva, encaminhar para um serviço especializado.

D) Realizar um eletrocardiograma (ECG), se possível, de 6 derivações; administrar aspirina na dose de 160 a 325 mg mastigável; considerar administrar oxigênio (se saturação de oxigênio " menor ou igual" 85%) e morfina, se o desconforto torácico não for aliviado pela nitroglicerina. Em caso de não haver alteração no ECG, por medida preventiva, encaminhar para um serviço especializado.

E) Realizar um eletrocardiograma (ECG), se possível, de 12 derivações; administrar aspirina na dose de 160 a 325 mg mastigável; considerar administrar oxigênio (se saturação de oxigênio " menor ou igual" 90%), nitroglicerina sublingual ou spray e, se o desconforto torácico não for aliviado pela nitroglicerina, morfina. Em caso de alteração no ECG, transferir para uma unidade de saúde com maior capacidade de atendimento.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183345)

Enunciado: O núcleo da equipe é formado por Médicos, Enfermeiras e especialistas em exercícios, com a opção de agregar especialistas em outras disciplinas para fornecer ao paciente atendimento e educação completa (Nutricionista, Psicólogo, entre outros), dessa forma, podemos considerar como completamente adequado o item:

A) Um programa de reabilitação cardiovascular RCV não necessita de ser integrado por uma equipe multidisciplinar.

B) Um programa de reabilitação cardiovascular RCV é integrado por uma equipe multidisciplinar, que requer as seguintes competências: conhecimento básico na área cardiovascular apenas.

C) Um programa de reabilitação cardiovascular RCV é integrado por uma equipe multidisciplinar, que requer as seguintes competências: conhecimento básico nas áreas cardiovascular, pulmonar e musculoesquelética, interpretação do eletrocardiograma, manejo de emergências médicas e conhecimentos em teoria e prática do exercício físico.

D) Um programa de reabilitação cardiovascular RCV é integrado por uma equipe multidisciplinar, que requer as seguintes competências: conhecimento básico nas áreas cardiovascular, pulmonar e musculoesquelética, interpretação do eletrocardiograma é desnecessária, manejo de emergências médicas e conhecimentos em teoria e prática do exercício físico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183343)

Enunciado: O cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) tem sido proposto pelo Instituto Nacional da Saúde dos Estados Unidos (NHLBI) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como o método convencional para diagnosticar sobrepeso e obesidade. Sendo INCORRETO afirmar que:

A) Embora o IMC seja um método simples para detectar sujeitos com aumento considerável de gordura corporal, particularmente em âmbito populacional, estudos recentes têm confirmado totalmente a sua validade para diagnosticar obesidade individual.

B) O obeso tem maior frequência e incidência de outros fatores de risco.

C) O risco manifesta-se também de forma direta, uma vez que a gordura, particularmente a visceral intra-abdominal, é um órgão endócrino, metabolicamente ativo, que sintetiza e libera na circulação sanguínea diferentes peptídeos e outros compostos não peptídicos que participam da homeostase cardiovascular.

D) O obeso perde em maior ou menor grau esse equilíbrio e assim o risco também aumenta.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183337)

Enunciado: A presença de estenose significativa no Tronco de Coronária Esquerda - TCE tem grande importância prognóstica e impacto na tomada de decisão. Em relação a isso, somente NÃO podemos concordar com a alternativa:

A) Deve-se ter em mente ainda que doença no Tronco de Coronária Esquerda - TCE está raramente associada à doença em ramos subsequentes, e a presença de estenoses significativas na artéria descendente anterior e/ou na artéria circunflexa pode sub ou superestimar o valor da RFF medida na lesão no TCE.

B) Presença de estenose significativa no Tronco de Coronária Esquerda - TCE tem grande importância prognóstica, e a determinação do significado funcional de tais estenoses é fundamental para a decisão da estratégia terapêutica.

C) Revascularização de lesões no Tronco de Coronária Esquerda - TCE não significativas, do ponto de vista funcional, pode levar à oclusão precoce dos enxertos cirúrgicos, mesmo que condutos de artéria mamária interna esquerda sejam utilizados.

D) Ademais, deve-se ter em mente que o TCE representa o local da árvore coronária em que a avaliação angiográfica da gravidade da estenose é mais ambígua e variável.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157348)

Enunciado: Paciente homem, 65 anos, tabagista, hipertenso em tratamento adequeado, procura atendimento de urgência queixando-se de dor em região epigástrica iniciado há 30 minutos. Com base nessas informações e no eletrocardiograma a seguir, assinale a alternativa com o diagnóstico provável. (Conforme imagem do caderno de questões).

A) Infarto Agudo em Parede Inferior.

B) Infarto Agudo em Parede Lateral Alta.

C) Infarto Agudo em Parede Anterior.

D) Infarto Agudo Anterior Extenso.

E) Infarto Agudo em Parede Anterosseptal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

150226)

Enunciado: Homem de 65 anos dá entrada no pronto-socorro com forte dor no peito iniciada há uma hora, e associada a sudorese e náuseas. Ao exame físico, observam-se fácies de dor, ritmo cardíaco regular, PA = 140x90 mmHg, frequência cardíaca de 90 BPM e Sat. O? = 95%. O ECG exibe supradesnivelamento do segmento ST de V1 a V4. No caso desse paciente, considera-se inapropriada, na admissão, a seguinte conduta:

A) Administração de aspirina.

B) Administração de betabloqueador.

C) Solicitação de enzimas cardíacas.

D) Encaminhamento para o cateterismo cardíaco.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

150722)

Enunciado: Um paciente apresenta-se na emergência com diagnóstico de síndrome coronariana aguda, com ECG normal, porém com elevação de marcadores enzimáticos de necrose miocárdica. Nessas condições, a conduta inicial, além das medidas gerais, deve ser:

A) Terapia antiplaquetária dupla + terapia anticoagulante (enoxaparina).

B) Terapia fibrinolítica.

C) Angioplastia primária dentro das primeiras três horas do quadro.

D) Terapia anticoagulante (enoxaparina), sem terapia antiplaquetária.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157410)

Enunciado: Paciente masculino de 60 anos de idade foi internado no hospital com quadro de dor torácica, estável pela manhã, mas com progressiva piora da dor torácica, que apesar de não ocorrer positivação dos marcadores de lesão miocárdica, teve indicado cateterismo diagnóstico e possivelmente terapêutico por parte da cardiologia. Diversas condutas serão realizadas a fim de melhorar os desfechos desse paciente, dentre eles o uso de medicações que interagem com plaquetas. A respeito dessa intervenção, assinale a alternativa considerada INADEQUADA:

A) Na utilização de clopidogrel, é preciso ressaltar ainda que, dentre os pacientes submetidos à trombólise, a dose de ataque de 300 mg não deve ser administrada em pacientes acima de 75 anos.

B) A dose dobrada de 150 mg/dia de clopidogrel deve ser restrita aos pacientes com baixo risco de sangramento.

C) Em caso de intervenção cirúrgica, o clopidogrel deve ser suspenso 10 dias antes do procedimento.

D) Para uso de clopidogrel com dose de ataque de 600 mg em pacientes submetidos à ICPP, tem se baseado na inibição do receptor do ADP mais rápido que se obtém com essa dose.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157422)

Enunciado: Em recente discussão clínica a respeito de terapia antiplaquetária para tratamento de insuficiência coronariana que você participou, foi chamada a atenção para as diversas opções para a modulação de atividade plaquetária. Desse modo, marque a opção INADEQUADA:

A) O uso do ácido acetilsalicílico (AAS, aspirina) está embasado em evidências sólidas, sendo o seu uso considerado imprescindível. Meta-análises posteriores reforçaram o papel fundamental do AAS na redução de mortalidade e eventos cardiovasculares, tanto no uso precoce quanto em longo prazo.

B) O clopidogrel é um derivado tienopiridínico inibidor da adenosina difosfato (ADP).

C) O prasugrel, componente da classe dos inibidores da agregação plaquetária induzida por adenosina difosfato (ADP) por meio do bloqueio irreversível dos receptores P2Y12, surgiu com o intuito de promover uma antiagregação plaquetária mais efetiva que o clopidogrel, além de antiagregação mais rápida e consistente, evitando a conhecida resistência ao clopidogrel existente em uma parcela da população.

D) O ticagrelor, outro componente da classe dos antiagregantes plaquetários inibidores da ADP, tem como características importantes: ser um inibidor irreversível dos receptores P2Y12 da ADP, ser uma droga que depende de metabolização primária (logo, não se trata de uma pró-droga), além de obter efeito antiagregante mais intenso, rápido e consistente em relação ao clopidogrel.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

149245)

Enunciado: Paciente masculino de 64 anos de idade, com intensa dor torácica, deu entrada no hospital com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Dentre as condutas iniciais a serem tomadas para melhor prognóstico, podemos referenciar como ADEQUADO, quanto ao uso de oxigênio, o seguinte:

A) Indicado sempre que ocorrer desconforto respiratório, queda da saturação abaixo de 94% ou congestão pulmonar.

B) Seu uso, sem indicação precisa, sempre é considerado benéfico.

C) Seu uso, quando desnecessário, pode provocar vasodilatação sistêmica.

D) Seu uso, quando desnecessário, pode provocar queda do débito cardíaco.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

156520)

Enunciado: Marque a afirmativa correta:

A) Dentre os fatores de risco para doença cardiovascular podemos citar a deficiência de componentes do complemento.

B) Segundo a organização mundial de saúde (OMS) as doenças cardiovasculares são as principais causas de óbito no mundo. Somente no Brasil, mais de 300 mil pessoas morrem anualmente

C) Dentre os Fatores modificáveis para doenças cardiovasculares podemos citar a predisposição genética

D) Dentre os fatores não modificáveis, para doenças cardiovasculares podemos citar corrigir os maus hábitos de vida e alimentação

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157423)

Enunciado: Podemos considerar a aterosclerose como uma doença inflamatória crônica de origem multifatorial que ocorre em resposta à agressão endotelial, que acomete principalmente a camada íntima de artérias de médio e grande calibres. A formação da placa aterosclerótica se relaciona com o contido em uma das opções. Aponte-a.

A) Agressão ao endotélio vascular devido a diversos fatores de risco, como dislipidemia, hipertensão arterial ou tabagismo.

B) Pela disfunção endotelial diminui a permeabilidade da íntima às lipoproteínas plasmáticas, favorecendo a retenção das mesmas no espaço subendotelial.

C) As HDL sofrem oxidação, causando a exposição de diversos neo-epitopos e tornando-as imunogênicas.

D) O depósito de lipoproteínas na parede arterial, processo-chave na parada da aterogênese.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157428)

Enunciado: De acordo com a importância epidemiológica das placas de aterosclerose e suas relações com os eventos clínicos trombogênicos, assinale a alternativa CORRETA:

A) Placas estáveis caracterizam-se por predomínio de colágeno, desorganizado em capa fibrosa espessa, muitas células inflamatórias e núcleo lipídico e necrótico de proporções menores.

B) As placas instáveis apresentam atividade inflamatória reduzida, especialmente nas suas bordas laterais, com grande atividade proteolítica, núcleo lipídico e necrótico proeminente e capa fibrótica tênue.

C) A ruptura desta placa instável expõe material endotelial colágeno altamente trombogênico, levando à formação de um trombo sobrejacente.

D) O processo de aterotrombose é um dos principais determinantes das manifestações clínicas da aterosclerose.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157435)

Enunciado: Para se entender a epidemiologia da estratificação de risco cardiovascular para adequada prevenção de eventos relacionados com a arteriosclerose, aponte a alternativa INCORRETA:

A) Um evento coronário agudo é a primeira manifestação da doença aterosclerótica em menos de um décimo dos indivíduos que apresentam essa complicação.

B) Ocorre necessidade de identificação dos indivíduos assintomáticos que estão mais predispostos para a prevenção efetiva com a
correta definição das metas terapêuticas individuais.

C) Diversos algoritmos têm sido criados com base em análises de regressão de estudos populacionais, por meio dos quais a identificação do risco global é aprimorada substancialmente.

D) A estimativa do risco de doença aterosclerótica resulta da somatória do risco associado a cada um dos fatores de risco mais a potenciação causada por sinergismos entre alguns desses fatores. Diante da complexidade destas interações, a atribuição
intuitiva do risco frequentemente resulta em subestimação ou superestimação dos casos de maior ou menor risco.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

138261)

Enunciado: Homem de 62 anos é atendindo no pronto-socorro com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio com supradesnivel do segmento ST. Após realização de checklist, é submetido á fibrinólise com estreptoquinase. Após, a infusão da medicação, o paciente ainda refere dor e o ECG mantém o supradesnivel do seguimento ST. Nesse caso, o cateterismo cardiaco

A) deve ser realizado em caráter de urgência.

B) está indicado após controle dos sintomas.

C) deve ser realizado antes da alta hospitalar para estratificação.

D) está contraindicado após fibrinólise com estreptoquinase.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

127669)

Enunciado: Paciente de 75 anos, tabagista, hipertenso, diabético e dislipidêmico, relata início, há seis horas, de dor precordial tipo queimação, de forte intensidade, associada a náuseas e vômitos, piora com exercício leve, sem fatores de melhora e com irradiação para membro superior esquerdo. Ao exame, apresenta ritmo cardíaco regular, pressão arterial de 170 x 100 mmHg; SatO? de 92% em ar ambiente e com o seguinte ECG: (VER IMAGEM) Nesse caso, a primeira conduta terapêutica a ser feita é:

A) Encaminhar para cateterismo cardíaco (cineangiocoronariografia).

B) Prescrever estreptoquinase 1.500.000 UI EV em uma hora.

C) Prescrever morfina 2 mg EV.

D) Prescrever aspirina 300 mg VO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

129840)

Enunciado: Paciente de 55 anos, do sexo masculino, se apresenta na emergência com dor retroesternal em queimação de forte intensidade, de início súbito, que evoluiu posteriormente com tonteira, mal-estar importante e dispneia. ECG mostrou supradesnível do segmento ST em D2, D3 e aVF e BAVT. A artéria mais provavelmente acometida é:

A) Artéria coronária direita.

B) Tronco da coronária esquerda.

C) Artéria descendente anterior.

D) Artéria circunflexa.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

136892)

Enunciado: Homem de 58 anos, hipertenso e tabagista, é admitido no pronto-atendimento com queixa de dor torácica retroesternal de forte intensidade irradiando para as mandíbulas, que se iniciou há 2 horas. Nega episódios semelhantes de dor. O ECG realizado está apresentado a seguir. (VER IMAGEM) Nesse caso, além do ácido-acetilsalicílico, a melhor conduta é:

A) trombólise com tenecteplase, heparina não fracionada e ticagrelor.

B) trombólise com tenecteplase, enoxaparina e clopidogrel.

C) angioplastia primária, heparina não fracionada e clopidogrel.

D) angioplastia primária, enoxaparina e ticagrelor.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

136598)

Enunciado: Paciente deu entrada no hospital com intensa dor torácica, típica de insuficiência coronariana, seu ECG demonstrava alteração de regularização ventricular de V1 até V3. Como sua pressão arterial era de 190 x 120 mmHg, foi medicado com Nitroglicerina, Atenolol, Captopril, ASS, Clopidogrel além de Morfina. Qual das medicações listadas necessita de repouso endotelial a fim de manter o efeito da medicação?

A) AAS.

B) Nitroglicerina.

C) Atenolol.

D) Morfina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

127347)

Enunciado: Grande parte da mortalidade, decorrente dos Infartos Agudos do Miocárdio, refere a arritmias cardíacas ventriculares. Qual das condutas abaixo está INDICADA como profilaxia?

A) Desfibrilação com 360 J.

B) Cardioversão com 200 J.

C) Amiodarona.

D) Betabloqueador oral.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

136615)

Enunciado: Paciente, sabidamente usuário de substâncias ilícitas, dá entrada no hospital agitado, com dor torácica, dispneia e mal-estar geral. Seu monitor cardíaco demonstra alteração de repolarização de VE, além de uma taquicardia de 180 bpm. Sua pressão é de 195 x 120 mmHg. Acompanhante refere uso de cocaína. Qual das condutas abaixo PODE agravar o quadro de intoxicação?

A) Propranolol.

B) Diazepam.

C) Haloperidol.

D) Nitroprussiato de Sódio.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

136608)

Enunciado: Paciente deu entrada no hospital com queixa de dor torácica em aperto e mal-estar de início, aproximadamente, há 1 hora. Seu exame físico demonstra ausculta cardíaca normal e ausculta pulmonar com murmúrio vesicular normal e sem ruídos adventícios. Sua PA é de 130 x 90 mmHg, Saturação no oxímetro de pulso de 94%, ECG demonstra alteração de supra de ST em D2, D3 e aVF. Medicado com Morfina, Nitroglicerina, AAS, Clopidogrel e Oxigênio. Frente a esse caso, qual das condutas abaixo NÃO deve ser indicada?

A) Morfina.

B) Nitroglicerina.

C) Oxigênio.

D) Clopidogrel.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

136574)

Enunciado: Paciente deu entrada no hospital com quadro de dor torácica típica, de início há 6 horas, irradiando para pescoço. Seu ECG demonstra supra de ST nas derivações V1 até V5. Seu exame físico demonstra galope em B3 e discreta congestão pulmonar bibasal. Qual das medicações seguintes é contraindicação no momento?

A) Nitroglicerina.

B) Atenolol.

C) Captopril.

D) Clopidogrel.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

138643)

Enunciado: Homem de 74 anos, hipertenso e tabagista foi admitido por dor torácica retroesternal de forte intensidade, em pressão, há 1 hora. Ao exame clínico: pulso de 100 bpm, frequência respiratória 20 irpm, pressão arterial 180x100 mmHg em membro superior direito, pulsos assimétricos, bulhas cardíacas normofonéticas com sopro diastólico em foco aórtico 3+/6+. Eletrocardiograma mostrou infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST de parede inferior. Qual a conduta farmacológica necessária ao paciente neste momento na sala de emergência?

A) Betabloqueador endovenoso.

B) Trombólise.

C) Anticoagulação.

D) Antiagregação plaquetária.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

109337)

Enunciado: A aterosclerose é uma doença sistêmica, na qual ocorre acúmulo de lipídio e de material fibroso na camada

A) endotelial.

B) intimal.

C) média.

D) muscular.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

111423)

Enunciado: Os betabloqueadores são excelentes fármacos que reduzem as morbimortalidades das síndromes coronarianas agudas. Podem ser indicados em situações como:

A) Doença Arterial periférica grave.

B) Pacientes com disfunção grave de VE.

C) Infarto Agudo do Miocárdio submetido à trombólise farmacológica.

D) BAV de 2° e 3° graus.

E) Nenhuma das situações acima.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

112353)

Enunciado: A correta abordagem do infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST é fundamental para a redução da morbimortalidade do quadro. Em relação a esta abordagem:

A) O uso de aspirina é indicado após a terapia de reperfusão ter sido realizada com sucesso.

B) A monitorização cardíaca contínua pode ser dispensada enquanto se aguarda a terapia de reperfusão.

C) A angioplastia primária é a terapia de escolha com melhores resultados e menores riscos.

D) A terapia de reperfusão está indicada após a confirmação diagnóstica com os marcadores de lesão miocárdica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

101146)

Enunciado: A presença do supradesnivelamento do segmento ST (supra de ST) ao ECG pode ser indicativo de:

A) infarto agudo do miocárdio, angina de Prizmetal e endocardite.

B) aneurisma ventricular, quando está presente em uma fase tardia de um infarto do miocárdio com supra de ST.

C) reperfusão, quando sua diminuição é maior que 25% na derivação de maior amplitude.

D) infarto agudo do miocárdio, quando sua elevação é maior que 2 mm em mais de uma derivação frontal contígua.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

103742)

Enunciado: Paciente, durante consulta, refere intensa dor precordial logo após subir pequeno lance de escada para trabalhar. Em sua história refere ser fumante e hipertenso leve. Exame físico demonstra galope de B3 bem como fácies de dor, além de sudorese fria e pegajosa. Então é solicitado ECG. O ECG demonstra corrente de lesão com supra de 2 mm no segmento ST nas seguintes derivações DII, DIII e a VF. Podemos, assim, AFIRMAR que:

A) trata-se de infarto agudo do miocárdico do ventrículo direito.

B) a coronariana envolvida provavelmente é a descente anterior.

C) esse supra é imagem em espelho de parede posterior.

D) nesse caso, podemos utilizar, a princípio, nitratos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

110218)

Enunciado: Paciente de 67 anos foi admitido no pronto-socorro com quadro de dor torácica opressiva em repouso, com irradiação para a mandíbula, acompanhada de diaforese com duração de duas horas. Paciente é hipertenso, diabético, tabagista e dislipidêmico. O ECG apresenta infradesnivelamento de ST de 2 mm em parede lateral. Relata quadro semelhante há um ano, com melhora espontânea em casa. Diante do quadro clínico apresentado, quais medicações devem ser administradas no pronto-socorro que as publicações científicas demonstram gerar redução de mortalidade em pacientes com esse diagnóstico?

A) AAS; clopidogrel; heparinas.

B) Nitratos, beta-bloqueadores, inibidores glicoproteína IIBIIIA.

C) AAS; clopidogrel; morfina.

D) Estatinas; morfina; nitratos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

110222)

Enunciado: Paciente de 67 anos foi admitido no pronto-socorro com quadro de dor torácica opressiva em repouso, com irradiação para a mandíbula, acompanhada de diaforese com duração de duas horas. Paciente é hipertenso, diabético, tabagista e dislipidêmico. O ECG apresenta infradesnivelamento de ST de 2 mm em parede lateral. Relata quadro semelhante há um ano, com melhora espontânea em casa. O paciente foi submetido ao protocolo de dor torácica com ECGs seriados e dosagem seriada de marcadores de necrose. Ao final de 12 horas após início da dor precordial ele apresentava ECG sem sinais de isquemia, marcadores de necrose sem elevação em nenhuma das mensurações e clinicamente não apresentava mais a dor precordial. Nesse caso, qual a melhor estratégia de tratamento para o paciente?

A) Alta hospitalar, com teste ergométrico em 7 dias.

B) Internação hospitalar, com cateterismo cardíaco em 24 a 48 horas.

C) Alta hospitalar, com ecocardiograma de stress em 7 dias.

D) Alta hospitalar para seguimento ambulatorial precoce.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

83824)

Enunciado: São contraindicações absolutas ao Teste Ergométrico:

A) Angina instável.

B) BAV de 3°grau.

C) Dissecção aguda da aorta.

D) Embolia pulmonar aguda.

E) Estenose aórtica severa.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

89997)

Enunciado: Sobre Angina de peito, é INCORRETO afirmar que:

A) A dor geralmente é retroesternal.

B) Em 40% dos pacientes, a dor tem localização atípica.

C) Os equivalentes anginosos são mais comuns em hipertensos.

D) O ECG é normal em 50% dos pacientes.

E) O teste ergométrico tem boa sensibilidade e alta especificidade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

84686)

Enunciado: No Infarto Agudo do Miocárdio, as derivações eletrocardiográficas indicam a região coronária onde o trombo se instalou ou o espasmo se sucedeu. Sendo assim, pode-se afirmar que em um Infarto do Miocárdio de parede lateral, a presença de elevação de ST e ondas Q serão encontradas nas seguintes derivações:

A) DI, DII e DIII.

B) DI, AVL, V5 e V6

C) V1 e V2.

D) V1, V2, V3 e V4.

E) DII, DIII e AVF.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

78102)

Enunciado: No tratamento do infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST,

A) o ácido acetilsalicílico deve ser administrado a todos os pacientes com IAM, tão rápido quanto possível, após o diagnóstico ser considerado provável, na dose de 81-500 mg/dia (o AAS deve ser mastigado para facilitar sua absorção).

B) a recanalização precoce da artéria responsável pelo infarto limita a necrose miocárdica, sem reduzir a mortalidade dos pacientes, já que a oclusão coronária por um trombo é a principal causa desta dramática condição clínica.

C) o maior benefício do uso dos fibrinolíticos é visto nos pacientes tratados nas primeiras horas do evento, portanto, quanto mais precoce a infusão do fibrinolítico, maior o benefício em relação à preservação da função ventricular, porém sem redução da mortalidade.

D) a angioplastia primária com implante de stent constitui a melhor opção para a obtenção da reperfusão coronária, se iniciada até 90 minutos após o diagnóstico do IAM, e sua utilização reduziu significativamente as taxas tardias de nova revascularização do vaso alvo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

85411)

Enunciado: A pesquisa de dor torácica é um desafio para o médico, já que são inúmeras as causas etiológicas. Marque a alternativa em que os sintomas estão relacionados com o fator causal.

A) Na pericardite, a dor é de natureza pleurítica e piora quando o paciente deita, respira ou deglute, e melhora na posição sentada e inclinada para frente. O atrito pericárdico é um sinal patognomônico.

B) A embolia pulmonar apresenta, como sintoma mais comum, a dor torácica de início gradativo. Dispneia é sintoma raro.

C) O prolapso de válvula mitral se apresenta como dor bem localizada no ápice cardíaco e tem relação bem definida com atividades físicas e com irradiação para o epigástrio.

D) Doenças esofágicas causam dor com características bem distintas da dor coronariana. Não se apresentam com dor em aperto ou em queimação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

63218)

Enunciado: Se Paulo sofrer um infarto agudo do miocárdio, NÃO recomendaríamos anticoagulação plena, se:

A) Estiver programada angioplastia coronária transluminal percutânea.

B) Houver fibrilação atrial ou insuficiência cardíaca de qualquer grau.

C) Opção terapêutica inicial for de fibrinólise com estreptoquinase.

D) O infarto for de parede anterior ou de grande extensão.

E) O ECG não apresentar supradesnivelamento do segmento ST.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

62694)

Enunciado: Homem de 65 anos, diabético, hipertenso, dislipidêmico, é admitido no serviço de emergência com dor precordial de forte intensidade, iniciada há quatro horas com irradiação para o dorso, associada com sudorese fria, náuseas e vômitos. Nega tabagismo, etilismo, história familiar de doença arterial coronariana e refere que ficou internado há 60 dias devido a AVC, sem sequelas. Ao exame físico, encontrava-se orientado, com palidez cutâneo-mucosa, acianótico e com dispneia leve. PA = 90/60 mmHg e FC = 70 bpm, Sat 89%. A ausculta cardíaca apresentava RCR em 2T, sem sopros. Ausculta pulmonar normal. O ECG apresentava supradesnivelamento de segmento ST em D2, D3 e AVF de 3 mm. Qual das opções terapêuticas oferecidas na admissão, além do oxigênio, AAS e nitrato sublingual, é a mais apropriada?

A) Meperidina e trombolítico.

B) Betabloqueador e heparinização plena.

C) Clopidogrel e angioplastia coronariana percutânea primária.

D) Ticagrelor e trombolítico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

47300)

Enunciado: O aumento de mortalidade no infarto agudo do miocárdio está associado ao uso de:

A) diltiazem.

B) anlopidina.

C) nifedipina.

D) verapamil.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

51006)

Enunciado: O senhor Pedro, um executivo de 56 anos, é admitido ao hospital com dor no peito de 2 horas de duração. Sua frequência cardíaca é de 42 bpm, com bradicardia sinusal no ECG, o qual também revelou supradesnivelamento de ST nas derivações II, III e aVF. Qual o diagnóstico mais provável do senhor Pedro?

A) tônus vagal aumentado.

B) infarto do miocárdio de parede inferior.

C) aneurisma de aorta.

D) intoxicação por atropina.

E) infarto do miocárdio de parede posterior.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

48219)

Enunciado: Paciente de 50 anos apresenta dor tipo pleuropericárdica e febre, que iniciou cerca de 4 semanas após infarto agudo do miocárdio. A hipótese diagnóstica mais provável é:

A) Síndrome de Dressler.

B) Pericardite epistenocárdica.

C) Pericardite bacteriana.

D) Aneurisma de ventrículo esquerdo.

E) Reinfarto do miocárdio.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

48245)

Enunciado: Paciente de 60 anos, sem comorbidades conhecidas, refere dor precordial que o obriga a reduzir as passadas no meio de suas caminhadas diárias, mas que alivia ao repouso. Traz ECG normal. Qual exame para diagnóstico de doença coronariana você solicita:

A) Teste ergométrico

B) Holter cardíaco de 24 horas

C) Cintilografia miocárdica com dobutamina

D) Ecocardiograma transesofágico

E) Ecocardiograma transtorácico com estresse farmacológico

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

47702)

Enunciado: Um homem de 55 anos é admitido no pronto-socorro com dor retroesternal iniciada há 30 minutos, como irradiação para região cervical e dorso, de forte intensidade, sem fator de alívio, acompanhada de sudorese fria, náuseas e vômitos. Antecedentes: refere hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, tabagismo e dislipidemia. Eletrocardiograma: supradesnivelamento do segmento ST de 3 mm em DII, DIII e AVF. Nesse paciente, pode-se encontrar a seguinte alteração:

A) Bradicardia com hipotensão devido ao reflexo vagal de Bezold-Jarisch, comum no infarto agudo de parede anterior;

B) Supradesnivelamento do segmento ST em V1 , V3R e V4R, secundário ao infarto agudo do ventrículo direito;

C) Presença de pulsos assimétricos, o que exclui o diagnóstico de IAM concomitante à dissecção de aorta;

D) Cineangiocoronariografia demonstrando oclusão da coronária circunflexa.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

48504)

Enunciado: Paciente de 62 anos foi admitido na emergência com quadro de dor precordial de forte intensidade, de aproximadamente 50 minutos de duração, acompanhada de sudorese, náuseas e vômitos. Foi diagnosticado, através do ECG, infarto agudo do miocárdio inferoapical. As derivações que exploram essa lesão incluem D2, D3, AVF e:

A) V1 e V2

B) V3 e V4

C) V5 e V6

D) V7 e V8

E) V1 e V3

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

48160)

Enunciado: Em um paciente com síndrome coronariana aguda, porém com fatores de risco controlados, o colesterol LDL deve ser abaixo de:

A) 200 mg/dL

B) 160 mg/dL

C) 130 mg/dL

D) 100 mg/dL

E) 70 mg/dL

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

35616)

Enunciado: Uma mulher de 66 anos, tabagista há 28 anos, obesa, tossidora crônica, em uso de enalapril, amlodipina e glimepirida, procura o pronto-socorro com história de ter apresentado, nas últimas 4 horas, 2 episódios de dor retroesternal em aperto, com irradiação para as costas e duração de cerca de 30 minutos; o último foi há 1 hora. Nos últimos 6 meses procurou atendimento de urgência duas vezes por aumento da tosse e dispneia. Está eupneica, com pulso e pressão arterial normais. É colocada na sala de emergência, ligado o monitor cardíaco e obtido acesso venoso. Solicita-se e eletrocardiograma. É recomendável que receba de imediato:

A) Oxigênio, ácido acetilsalicílico e betabloqueador VO.

B) Morfina EV.

C) Betabloqueador EV em dose baixa.

D) Oxigênio em dose baixa e se aguarde o eletrocardiograma antes de qualquer medicação.

E) Oxigênio em dose baixa e ácido acetilsalicílico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

35628)

Enunciado: Homem de 56 anos hipertenso e diabético deu entrada no pronto-socorro com duas horas de dor precordial de forte intensidade, irradiada para membro superior esquerdo e acompanhada de sudorese. O eletrocardiograma apresentava 2 mm de supradesnivelamento do segmento ST em DII, DIII e aVF. Ao exame estava em bom estado geral com palidez cutânea +/++, PA = 100 x 70 mmHg, P = 60 (2 extrassístoles por minuto). Coração e pulmão sem alterações. Nega cirurgias ou traumas recentes. Teve infarto há cerca de 4 meses quando recebeu estreptoquinase. Qual alternativa contém diagnóstico e o grupo hemodinâmico correto pela classificação de Forrester?

A) Infarto inferior, grupo I.

B) Infarto anterior, grupo I.

C) Infarto inferior, grupo II.

D) Infarto anterior, grupo II.

E) Não se pode fazer o diagnóstico definitivo de IAM sem a dosagem das enzimas cardíacas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

35630)

Enunciado: Homem de 56 anos hipertenso e diabético deu entrada no pronto-socorro com duas horas de dor precordial de forte intensidade, irradiada para membro superior esquerdo e acompanhada de sudorese. O eletrocardiograma apresentava 2 mm de supradesnivelamento do segmento ST em DII, DIII e aVF. Ao exame estava em bom estado geral com palidez cutânea +/++, PA = 100 x 70 mmHg, P = 60 (2 extrassístoles por minuto). Coração e pulmão sem alterações. Nega cirurgias ou traumas recentes. Teve infarto há cerca de 4 meses quando recebeu estreptoquinase. Qual das medicações abaixo não deve ser administrada a este paciente?

A) Morfina.

B) Nitrato sublingual.

C) Estreptoquinase.

D) Ácido acetilsalicílico.

E) Meperidina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

35626)

Enunciado: Homem de 56 anos, hipertenso e diabético deu entrada no Pronto-Socorro com duas horas de dor precordial de forte intensidade, irradiada para membro superior esquerdo e acompanhada de sudorese. O eletrocardiograma apresentava 2 mm de supradesnivelamento do segmento ST em DII, DIII e AVF. Ao exame, estava em bom estado geral com palidez cutânea +/++, PA = 100 x 70 mmHg, P = 60 (2 extrassístoles por minuto). Coração e pulmão sem alterações. Nega cirurgias ou traumas recentes. Teve infarto há cerca de 4 meses quando recebeu estreptoquinase. Após ter recebido 5 mg de Isordil sublingual e 1 mg de morfina endovenosa, o paciente evoluiu com confusão mental, queda da pressão para 50 x 30 mmHg e no eletrocardiograma apresentou bloqueio A-V total. Qual conduta imediata mais adequada dentre as alternativas abaixo?

A) Cateterismo de emergência.

B) Marca-passo externo transcutâneo.

C) Atropina 0,25 mg intravenosa.

D) Dobutamina 2,5 mg/kg/min intravenosa.

E) Nitroglicerina intravenosa.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

35804)

Enunciado: Qual das opções abaixo é mais indicada para abordagem inicial na suspeita de infarto agudo do miocárdio?

A) Estreptoquinase, aas, heparina e nitrato.

B) Morfina, oxigênio, nitrato e aas.

C) Estreptoquinase, aas, heparina e betabloqueador.

D) Oxigênio, betabloqueador, nitrato e aas.

E) Estreptoquinase, aas, oxigênio e adalat.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

35810)

Enunciado: Paciente de 65 anos, masculino, tabagista, IMC de 31, procura o pronto-socorro de ortopedia por apresentar dor torácica, braquialgia esquerda, sudorese e mal-estar, surgidos após jogo de futebol onde teve "bola dividida" com outro jogador, tendo inclusive sido jogado ao chão. Sua primeira atenção propedêutica visaria a possibilidade de:

A) Luxação de ombro.

B) Trauma torácico na "bola dividida".

C) Dor anginosa.

D) Pneumonia.

E) RGE com esofagite.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

26941)

Enunciado: Raimundo, 48 anos, branco, tabagista inveterado, sedentário, foi atendido em posto de saúde com quadro de dor epigástrica de forte intensidade com duração de 2 horas. Ao exame físico, apresentava sudorese profusa e fria, palidez cutane omucosa, náuseas e vômitos, PA = 130/70 mmHg, FC = 58 bpm irregular. ECG demonstrou bloqueio AV intermitente e infarto de parede inferior. Rx de tórax demonstrou área cardíaca normal sem alargamento de mediastino. Transferido à UTI após 45 minutos, apresenta-se com PA = 70/40 mmHg, bulhas cardíacas abafadas e com turgência jugular. Rx de tórax sem alterações em relação ao anterior. ECG com QRS de baixa amplitude. O mais provável é:

A) Dissecção aórtica

B) Infarto de ventrículo direito

C) Infarto anterior

D) Disfunção de músculo papilar

E) Ruptura ventricular

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

27197)

Enunciado: Qual o diagnóstico provável em situação de: dor precordial intensa, palidez cutânea, sudorese profusa, náuseas, com elevação de ck mb e troponina?

A) Pericardite aguda.

B) Taquicardia ventricular.

C) Edema agudo de pulmão.

D) Infarto agudo miocárdio.

E) Dissecção de aorta.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

23009)

Enunciado: Nas cirurgias de revascularização do miocárdio,

A) os enxertos de veia safena estão sendo menos utilizados.

B) a artéria radial é o enxerto arterial mais utilizado.

C) os enxertos de veia safena ocluem cerca de 30% no primeiro ano após a cirurgia.

D) o uso de dupla mamária está contraindicado em pacientes diabéticos pelo maior risco de deiscência e infecção do esterno.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

22977)

Enunciado: Em implantes de stents coronarianos após angioplastia,

A) o período de maior ocorrência de reestenose é entre três e seis meses.

B) a trombose intra-stent é prevenida com uso de anticoagulante, mantendo-se o RNI entre 2,5 e 3.

C) o stent de metal é preferível ao stent farmacológico nas lesões em coronárias de menor diâmetro, segmentares longas e de tronco de coronária esquerda.

D) a utilização do clopidogrel por um ano previne a reestenose nos stents farmacológicos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

27026)

Enunciado: Ao interpretar o resultado do teste ergométrico de um aviador de 35 anos de idade, assintomático, o médico deverá considerar que:

A) o valor preditivo positivo será muito baixo

B) o valor preditivo negativo será muito baixo

C) o teste não tem indicação no caso

D) o teste tem baixa especificidade

E) o teste tem baixa sensibilidade

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

11100)

Enunciado: Na abordagem inicial do infarto agudo do miocárdio podemos afirmar que:

A) O uso de opiódes endovenoso é indicado para diminuir a dor e ansiedade.

B) A aspirina associada a heparina contraindica o uso de fibrinoliticos.

C) O uso de betabloqueadores associado a morfinomiméticos aumenta o risco de depressão respiratória.

D) Alterações do segmento ST, com supradesnível nas derivações D2, D3 e a VF reflete obstruções na parede antero-lateral do ventrículo esquerdo.

E) N.r.a.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

16059)

Enunciado: Dor ou desconforto torácico retroesternal, de curta duração, com irradiação para o dorso e que obtém alívio com o uso de nitrato, pode ser consequência de angina de peito, bem como de:

A) hipertensão pulmonar.

B) dissecção aórtica.

C) pericardite aguda.

D) espasmo esofágico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

216365)

Enunciado: Ao avaliar um paciente com dor torácica aguda, escores de risco como o TIMI ou o GRACE se prestam a definir:

A) Necessidade de realizar eletrocardiograma na sala de emergência.

B) Candidatos à estratificação invasiva precoce num contexto de provável síndrome coronariana sem supra ST.

C) Revascularização cirúrgica versus percutânea em pacientes com IAM com supra de ST.

D) O tipo de dor torácica em: definitivamente anginosa, definitivamente não-anginosa, provavelmente anginosa ou provavelmente não-anginosa.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

105710)

Enunciado: Paciente de 72 anos, masculino, dislipidêmico e diabético controlado, em uso de sinvastatina e metformina não é hipertenso. No momento, assintomático. Em avaliação cardiológica de rotina, fez ecocardiograma que mostrou: hipertrofia concêntrica de VE, fração de ejeção preservada e uma doença valvar pura, além de ausência de hipertensão pulmonar e de quaisquer outras alterações nas demais câmaras cardíacas e nas demais valvas. Considerando a valvopatia mais provável nesse contexto clínico-epidemiológico, não é correto afirmar sobre essa doença:

A) A etiologia mais provável é a degeneração fibrocalcificante. Além disso, sua patogênese parece ter em comum diversas características da aterosclerose vascular, incluindo disfunção endotelial.

B) Há relevante associação estatística de doença coronariana nesses pacientes. A angina de esforço é sintoma típico dessa valvopatia. Tal sintoma pode ser consequência da Doença Arterial Coronariana (DAC), da própria fisiopatologia da valvopatia ou mesmo de ambos os mecanismos.

C) Dispneia aos esforços, ortopneia e edema agudo de pulmão ocorrem precocemente na sua história natural.

D) A síncope geralmente ocorre durante esforço físico, devido à vasodilatação periférica causada pela atividade sem o aumento compensatório do débito cardíaco.

E) Nos pacientes sintomáticos, o tratamento é eminentemente cirúrgico. Diurético de alça pode ser utilizado em pacientes com risco cirúrgico proibitivo ou como ponte para a cirurgia. Além disso, o uso não cauteloso, nesses pacientes, de medicamentos, que reduzem a pré-carga, a pós-carga e/ou o inotropismo, podem causar hipotensão severa e síndrome de baixo débito.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

105682)

Enunciado: Após angioplastia coronariana com stent farmacológico, a prevenção da reestenose de enxerto é melhor realizada com:

A) Ácido acetilsalicílico + clopidogrel + varfarina ou outro anticoagulante por pelo menos 12 meses.

B) Ácido acetilsalicílico ou clopidogrel por toda a vida.

C) Ácido acetilsalicílico ou clopidogrel por pelo menos 12 meses.

D) Ácido acetilsalicílico por toda a vida + clopidogrel por pelo menos 15 dias.

E) Ácido acetilsalicílico por toda a vida + clopidogrel por pelo menos 12 meses.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

62659)

Enunciado: Paciente, 62 anos, recebido no serviço de Urgência/Emergência com queixa de dor precordial, em repouso com duração > 10 minutos. Relata dois episódios semelhantes há uma semana, porém de menor intensidade que o quadro atual. Apresenta história de tabagismo, dislipidemia e HAS. Realizou ECG que não mostrou alteração do segmento ST, coletado troponina sérica que foi normal na 1ª e 6ª hora. Em relação ao caso, é correto afirmar, EXCETO:

A) Caracteriza um quadro de angina instável.

B) Está indicado uso de inibidor IIb-IIIa plaquetário.

C) Está indicada realização de cineangiocoronariografia precoce (até 48h).

D) Não está indicado o CATE na vigência de dor recorrente com hipotensão, apesar da terapia anti-isquêmica.

E) Está indicado uso de heparina não fracionada, betabloqueador, AAS e clopidogrel.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

47478)

Enunciado: Dentre estes marcadores de lesão miocárdica, o que mais rapidamente retorna ao normal após um infarto do miocárdio é:

A) Troponina I cardíaca

B) Troponina T cardíaca

C) CKMB-massa

D) Mioglobina

E) Relação CPK/CKMB

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

35750)

Enunciado: Um homem de 60 anos de idade com um histórico de hipertensão e dislipidemia realiza uma avaliação devido angina. Ele afirma que, rotineiramente, sente dispneia, fadiga e dor torácica retroesternal na realização de atividades, como caminhadas ao redor do quarteirão ou subindo as escadas dentro de sua casa. Além de tomar medicamentos para a hipertensão e hipercolesterolemia, ele usa nitrato, que alivia com sucesso seus sintomas, porém lhe causa taquicardia. Ele não apresenta esta sensação em outro momento. Qual a conduta mais adequada para controlar este fenômeno?

A) Descontinuar o nitrato.

B) Aumentar a dose do nitrato.

C) Usar nifedipina ao invés de nitrato.

D) Continuar nitrato e iniciar isoproterenol.

E) Continuar nitrato e iniciar betabloqueador.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

35706)

Enunciado: São critérios para suspensão do tratamento com estatinas:

A) TGP > 3x limite superior da normalidade (LSN) e CPK > 5x LSN.

B) TGP > 10x LSN e CPK > 3x LSN.

C) Mialgia insuportável embora a CPK seja normal.

D) TGP > 3x LSN e CPK > 10x LSN.

E) C e D são corretas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

11471)

Enunciado: Marque a resposta correta:

A) A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica de origem multifatorial que ocorre em resposta a agressão endotelial, acometendo principalmente a camada média de artérias de médio e grande calibre.

B) O diagnóstico de síndrome metabólica requer a presença de obesidade abdominal como condição essencial. A pressão arterial sistólica > ou = 135 mmHg não é critério obrigatório.

C) Os fitosterois, que são encontrados apenas nos vegetais, reduzem a colesterolemia e a trigliceridemia por competirem com absorção destes na luz intestinal.

D) As estatinas reduzem a mortalidade cardiovascular e incidência de eventos isquêmicos coronários agudos e a necessidade de revascularização do miocárdio; entretanto, não apresentaram efeito benéfico na redução de incidência de acidente vascular cerebral (AVC).

E) O ácido nicotínico reduz a ação na lipase tecidual nos adipócitos; levando à redução do triglicerídio e do colesterol LDL e aumentando o colesterol HDL.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

311491)

Enunciado: Homem de 54 anos, diabético, admitido com dor retroesternal intensa irradiada para mandíbula e MSE há 50 minutos. ECG de entrada com ST supra de 5mm de V1 a V6, D1 e AVL. Qual diagnóstico provável e melhor conduta?

A) IAM de parede lateral. Administrar AAS 300mg, clopidogrel 300mg, heparinização plena e cateterismo cardíaco.

B) Espasmo coronário difuso grave. Iniciar nitroglicerina IV e seriar enzimas cardíacas.

C) IAM de parede anterior extenso. Administrar AAS 300mg, ticagrelor 180mg e encaminhar para angioplastia primária em caráter emergencial.

D) Dissecção aguda de aorta. Solicitar angiotomografia de aorta torácica de urgência.

E) TEP com repercussão eletrocardiográfica. Heparinização plena e providenciar angiotomografia de artérias pulmonares.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

302039)

Enunciado: Quando o profissional de saúde orienta mudanças no estilo de vida é fundamental identificar qual o estágio motivacional que o usuário se encontra para poder elaborar a melhor estratégia. Prochaska, DiClemente e Norcross (1992) desenvolveram um Modelo de Avaliação do Grau de Motivação para a Mudança, descrevendo etapas que podem ser identificadas no discurso da pessoa quando indagada acerca de sua vontade de mudança de hábito e de seus planos para mudança. Assinale a alternativa que relaciona a fala do paciente e o estágio motivacional quando se aborda a cessação do tabagismo.

A) Preparação: ""Eu tenho tentado parar de fumar de um tempo para cá""

B) Ação: ""Eu não quero parar de fumar"".

C) Pré-contemplação: ""Eu voltei a fumar regularmente"".

D) Contemplação: ""Eu parei de fumar"".

E) Recaída: ""Eu tenho feito uso descontínuo do cigarro de um mês para cá"".

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

250391)

Enunciado: Homem, 68 anos, internado com quadro de angina instável. Qual, dentre as alternativas abaixo, NÃO constitui estratificador de alto risco nesta condição clínica?

A) Angina noturna.

B) Dor em repouso prolongada (> 20 minutos) e contínua.

C) Angina com hipotensão.

D) Angina associada a sopro sistólico de regurgitação em foco mitral.

E) Angina em repouso com alterações dinâmicas de ST (igual ou maior do que 1mm).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

218043)

Enunciado: Paciente admitido na unidade coronariana com quadro compatível com IAM anterior com menos de 8 horas de duração. Como não existia hemodinâmica disponível, foi submetido a trombólise com estreptoquinase. Após 30 minutos da infusão inicia arritmia no monitor. Feito um ECG com o traçado mostrado abaixo. Pergunta-se sobre este paciente: Qual o ritmo registrado no ECG?

A) Fibrilação atrial.

B) Fibrilação ventricular.

C) Taquicardia supraventricular com aberrância.

D) Ritmo idioventricular acelerado.

E) Ritmo sinusal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

203195)

Enunciado: Mulher, 69 anos, é submetida a cateterismo cardíaco para avaliação de uma angina estável que não obteve resposta ao tratamento clínico. A complicação mais comum do cateterismo cardíaco e da angiografia coronariana é:

A) Insuficiência renal aguda.

B) Taquiarritmias.

C) Bradiarritmia.

D) Infarto do miocárdio.

E) Sangramento do local de acesso vascular.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

154409)

Enunciado: Homem, 35 anos, tabagista, hipertenso, refere dor na região anterior do tórax, que piora com decúbito, de início há 8 horas. À admissão, apresentava PA = 160 x 100 mmHg, FC = 120 bpm, FR = 32 mrpm, Temperatura = 38,0°C. Eletrocardiograma evidenciava elevação difusa de segmento ST com concavidade para cima. Qual das hipótese diagnóstica mais provável?

A) Cardiomiopatia hipertrófica.

B) Dissecção aórtica.

C) Síndrome coronariana aguda.

D) Taquiarritmia supraventricular por reentrada.

E) Pericardite aguda.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

103951)

Enunciado: Paciente do sexo masculino, com 65 anos, foi internado nesta unidade hospitalar com quadro de apendicite aguda e será submetido a procedimento cirúrgico laparoscópico, dentro das 6 horas após o diagnóstico clínico e de imagem do quadro. O paciente citado é usuário de AAS de longa data por doença coronária. Marque afirmativa correta:

A) Sangue e plaquetas vão dar segurança ao procedimento.

B) O procedimento deverá ser adiado.

C) Entrar com antibiótico para esfriar o processo e esperar.

D) Pós-operatório imediato na unidade de terapia intensiva não será necessário.

E) A raquianestesia e a cirurgia aberta deverão ser indicadas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

107941)

Enunciado: No contexto de SCA (Síndrome Coronariana Aguda), qual das assertivas a seguir está CORRETA?

A) O mecanismo fisiopatológico da SCA é aterotrombótico, justificando a importância do uso de antiagregantes e anticoagulantes de maneira imediata.

B) Em SCA no contexto de uso de cocaína, devemos priorizar o uso imediato de betabloqueador.

C) Paciente submetido à angioplastia com stent farmacológico deve usar AAS ou clopidogrel (ou seja, monoterapia antiagregante) por no mínimo 1 ano.

D) Menstruação ativa é contraindicação absoluta ao uso de trombolítico.

E) No infarto agudo sem supra de ST, a presença de infradesnivelamento de ST, idade e uso prévio de AAS não interferem na estratificação de risco destes pacientes.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

89551)

Enunciado: Na vigência de síndrome coronariana aguda, qual alternativa contempla apenas indicações de nitroglicerina endovenosa?

A) Dor refratária, congestão pulmonar e hipertensão de difícil controle.

B) Presença de terceira bulha, arritmia ventricular intermitente e supradesnivelamento do segmento ST.

C) Infarto com supra em DII, DIII, aVF, V3R e V4R, insuficiência cardíaca e contraindicação aos inibidores de ECA.

D) Instabilidade hemodinâmica, instabilidade elétrica e dor refratária.

E) Congestão pulmonar, presença de quarta bulha e insuficiência mitral grave.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

89268)

Enunciado: Com relação ao Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) com elevação do segmento ST podemos considerar, exceto:

A) Embora o ECG inicial não seja nem perfeitamente específico, nem perfeitamente sensível em todos os pacientes que desenvolvem IAM com elevação de ST, desempenha um papel fundamental na estratificação inicial, na triagem e no tratamento.

B) Nos últimos anos, as troponinas derivadas do coração (TnI e TnT) surgiram como os melhores marcadores de necrose miocárdica.

C) Um terço da metade dos pacientes idosos ou diabéticos são propensos ao IAM indolor ou atípico.

D) Mais da metade das mortes relacionadas ao IAM ocorre dentro de 1 hora do início dos sintomas, antes da chegada ao hospital, a maioria causada por Fibrilação Ventricular (FV).

E) O tratamento à base de fibrinólise produz melhores resultados do que a Intervenção Coronariana Percutânea (ICP).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

65600)

Enunciado: Paciente do sexo masculino, 54 anos, queixa-se de dor torácica de início súbito, de moderada a grande intensidade. Taquipneico, taquicárdico, com FC = 120 bpm, realizou ECG onde se evidencia bloqueio de ramo esquerdo novo ou supostamente novo, não se observa elevação de segmento ST. Devemos considerar como diagnóstico e conduta:

A) Angina instável sendo tratada como IAM sem elevação do segmento ST;

B) A dissecção aguda da aorta, devendo-se realizar anticoagulação plena;

C) IAM sem supra de segmento ST, devendo ser tratado como tal;

D) IAM sem supra de ST, porém deve ser considerado e tratado como se fosse IAM com supra de ST;

E) Não é uma síndrome coronariana aguda, devendo ser tratado com analgesia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

65613)

Enunciado: O dinitrato de isossorbida deve ser administrado precocemente em pacientes com suspeita de síndrome coronariana aguda, preferencialmente após realização do ECG, se este puder ser feito rapidamente. Dentre as afirmações abaixo, qual não corresponde à contraindicação ao seu uso?

A) Pressão arterial sistólica inferior a 100 mmHg.

B) IAM de ventrículo direito.

C) Uso prévio de Sildenafil nas últimas 24h.

D) Bradicardia abaixo de 60 bpm.

E) Bloqueio de ramo esquerdo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

327464)

Enunciado: Masculino, 78 anos, tabagista, diabético e hipertenso, deu entrada no pronto atendimento com queixa de dor epigástrica há 2 horas, de forte intensidade, em queimação, sem atenuação desde o início do quadro, associado à sudorese fria, escurecimento da vista e náuseas. Em uso de metformina 850g 2 vezes/dia, losartana 100 mg/dia e anlodipino 5 mg/dia. Foi aberto protocolo de dor torácica. Realizado exame físico: SatO2: 97%, FC= 108 bpm; FR= 16 irpm; PA = 84/52 mmHg, REG, ansioso, sudoreico, hipocorado ++/4+, acianótico, anictérico. ACV: bulhas normofonéticas, ritmo regular 2t, sem sopros. Pulsos amplos e simétricos, mantendo presença de turgência jugular a 45°. AR: Murmúrio vesicular audível, sem alterações. ECG: Em relação ao caso dado, responda aos itens. Qual o diagnóstico do paciente?

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

327465)

Enunciado: Masculino, 78 anos, tabagista, diabético e hipertenso, deu entrada no pronto atendimento com queixa de dor epigástrica há 2 horas, de forte intensidade, em queimação, sem atenuação desde o início do quadro, associado à sudorese fria, escurecimento da vista e náuseas. Em uso de metformina 850g 2 vezes/dia, losartana 100 mg/dia e anlodipino 5 mg/dia. Foi aberto protocolo de dor torácica. Realizado exame físico: SatO2: 97%, FC= 108 bpm; FR= 16 irpm; PA = 84/52 mmHg, REG, ansioso, sudoreico, hipocorado ++/4+, acianótico, anictérico. ACV: bulhas normofonéticas, ritmo regular 2t, sem sopros. Pulsos amplos e simétricos, mantendo presença de turgência jugular a 45°. AR: Murmúrio vesicular audível, sem alterações. ECG: Em relação ao caso dado, responda aos itens. Qual o tratamento frente ao diagnóstico?

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

308317)

Enunciado: Sobre a Pericardite Aguda, assinale a afirmativa correta.

A) A radiografia de tórax é geralmente alterada, pois pequenos volumes de líquido no pericárdio 30 a 50 mL alteram a silhueta cardíaca.

B) A grande maioria dos pacientes com pericardite aguda não apresenta dor torácica.

C) A pericardite aguda pode se manifestar com uma variedade de sinais e sintomas inespecíficos, dependendo da etiologia subjacente. No ECG, pode-se observar novo supradesnivelamento do segmento ST generalizado e depressão do PR.

D) O derrame pericárdico hemorrágico normalmente tem como causa a infecção viral.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

308319)

Enunciado: Paciente masculino, 52 anos, com história médica pregressa de hipertensão arterial sistêmica e síndrome de Marfan, chega à emergência com queixa de dor torácica retroesternal em aperto, com irradiação para o dorso. Nega tabagismo, dislipidemia ou diabetes. Ao exame, paciente se apresenta inquieto pela dor constante, sem alívio após uso de nitrato 5 mg sublingual. PA = 200 x 110 mmHg na chegada e 220 x 110 mmHg 3 minutos após uso de nitrato. Saturação de O? = 96 % em ar ambiente, ausculta cardíaca: ritmo regular, sopro sistólico +++/6 em foco mitral e sopro diastólico ++++/6 foco aórtico. Ausculta pulmonar sem alterações. Realizou ECG: ritmo sinusal, sinais de sobrecarga ventricular, associado a infradesnível do segmento ST em derivações V1 e V2 e supradesnível em derivações DII, DIII e avF. Após 20 minutos na emergência, paciente evolui com hipotensão e sinais clínicos de choque. A melhor explicação fisiopatológica para o caso é infarto agudo do miocárdio em parede.

A) Inferodorsal, causado por dissecção da aorta e insuficiência aórtica aguda e comprometimento do óstio do seio coronário direito, hipotensão e choque justificados por provável envolvimento do ventrículo direito.

B) Anterosseptal, causando ruptura de cordoalhas do folheto mitral, com consequente choque associado à piora com o uso de nitrato sublingual.

C) Inferior, causado pela crise hipertensiva e pela síndrome de Marfan. Posterior hipotensão, justificada pelo uso de nitrato sublingual.

D) Inferodorsal, causado por dissecção da aorta e insuficiência aórtica aguda e seu comprometimento da válvula mitral, causando insuficiência mitral aguda e posterior choque devido a edema agudo de pulmão cardiogênico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

316004)

Enunciado: Um homem de 54 anos chega ao pronto atendimento referindo desconforto torácico descrito como sensação de peso e a localiza colocando a mão no esterno, com irradiação para o ombro esquerdo. O desconforto foi desencadeado após esforço físico habitual. Nega sintomatologia semelhante. A dor aliviou 20 minutos após chegada ao hospital. Tem diagnóstico, há 3 anos, de dislipidemia, e está em uso de sinvastatina 20mg/d. Nesse caso, qual é hipótese diagnóstica?

A) Embolia de pulmão

B) Esofagite

C) Síndrome coronariana aguda

D) Pneumotórax

E) Dissecção de aorta

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

308386)

Enunciado: Paciente M. C. S. de 35 anos vem para consulta médica com queixa de ganho de 15 kg nos últimos 24 meses, após sua última gestação. Refere que tem preferência por doces, não faz lanches, passa o dia trabalhando e come mais à noite, quando chega em casa. É sedentária, nega tabagismo, nega diagnósticos prévios e não faz uso de qualquer medicação. Teve 3 gestações e 3 partos vaginais, sem intercorrências. Sua mãe é diabética e seu pai morreu aos 57 anos de infarto agudo do miocárdio. Ao exame: peso 89 kg, estatura 155 cm, PA 140 x 85 mmHg, cintura 97 cm. Traz os seguintes exames: glicemia 104 mg/dL; colesterol total 225 mg/dL; triglicerídeos 188 mg/dL; HDL 33mg/dL. Marque a afirmativa correta.

A) A paciente apresenta obesidade grau III, pois seu IMC é de 37.

B) A paciente apresenta diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2, por apresentar obesidade central associada a alterações na glicemia de jejum.

C) A paciente deve ser incentivada a iniciar programa de Modificação de Estilo de Vida imediatamente, instituindo atividade física regular, alimentação saudável e manutenção do peso ideal.

D) O diagnóstico de Síndrome Metabólica ainda não pode ser firmado devido à falta de alguns exames diagnósticos na história clínica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

313414)

Enunciado: Mulher, 67 anos, hipertensa e diabética de longa data, chega à unidade com quadro de dor torácica típica após realização de esforço físico. Realizado eletrocardiograma abaixo: Qual o diagnóstico mais provável?

A) Infarto agudo do miocárdio de parede lateral;

B) Infarto agudo do miocárdio de parede inferior;

C) Síndrome coronariana aguda sem supra de ST;

D) Infarto agudo do miocárdio com bloqueio de ramo esquerdo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

274111)

Enunciado: Mulher de 41 anos de idade internou no HUJM por dor precordial e dispneia aos moderados esforços. História prévia de hipertensão arterial, dislipidemia mista, tabagismo e lúpus eritematoso sistêmico, desde os 21 anos. Nos últimos meses, queixou-se de quadro de dor precordial do tipo pleurítica, que piorava no decúbito e melhorava com posição sentada. Antecedente de anemia e convulsões, atribuídas ao lúpus há 2 anos. Ao exame físico, paciente em razoável estado geral, hidratada, eupneica, FC 115 bpm, PA 110 x 70 mmHg. Ausculta pulmonar normal e ausculta cardíaca revelou bulhas rítmicas, hipofonese do componente aórtico da segunda bulha e sopro sistólico ++++/6+. O exame do abdome foi normal, não havendo edema e os pulsos, simétricos. O ECG revelou ritmo sinusal, frequência cardíaca de 109 bpm, com ondas T apiculadas e elevação do segmento ST. Assinale a alternativa que apresenta os dados semiológicos identificados compatíveis com a fisiopatologia/histologia.

A) Miocardite necrotizante eosinofílica ? alterações degenerativas da fibra com hipertrofia e fibrose instersticial; sopro sistólico grave ++++/6+.

B) Pericardite constritiva ? espessamento fibroso acentuado e aderências dos folhetos visceral e parietal e calcificação extensa ou em placas; ondas T apiculadas e elevação do segmento ST.

C) Doença arterial coronariana ? ? de IL-6 associado ao ? de cálcio coronário e TNF-? e IL-17 aumentam a resistência à insulina; PA normal associado à taquicardia com ritmo sinusal.

D) Insuficiência mitral ? espessamento dos folhetos valvares, áreas de calcificação, fusão comissural e encurtamento de cordoalhas; hipofonese do componente aórtico da segunda bulha.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

288136)

Enunciado: Todo paciente com dor torácica, atendido num pronto atendimento, deve ser investigado quanto à presença de doença isquêmica coronariana. No ECG, quando surge o supradesnivelamento do segmento ST de pelo menos 2 mm em duas derivações precordiais adjacentes, o paciente deve ser considerado candidato ao tratamento de reperfusão. Em relação ao infarto agudo do miocárdio (IAM), assinale a afirmativa CORRETA.

A) A creatinofosfoquinase (CK) eleva-se durante o período de 4 a 8 h e geralmente retorna ao normal em 48 a 72 horas.

B) A troponina T não é um bom biomarcador cardíaco num IAM.

C) A morfina não é um analgésico eficaz no tratamento da dor em um paciente com IAM e ainda pode aumentar a constrição arteriolar.

D) A fibrinólise deve ser iniciada mesmo se houver contraindicações, como sangramento ativo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

283991)

Enunciado: Mulher, 67 anos, hipertensa e diabética de longa data, chega à unidade com quadro de dor torácica típica após realização de esforço físico. Realizado eletrocardiograma abaixo: Qual o diagnóstico mais provável?

A) Infarto agudo do miocárdio de parede lateral.

B) Infarto agudo do miocárdio de parede inferior.

C) Síndrome coronariana aguda sem supra de ST.

D) Infarto agudo do miocárdio com bloqueio de ramo esquerdo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

244785)

Enunciado: Uma mulher jovem apresenta quadro de febre recorrente por acometimento das vias aéreas superiores, acompanhada de dor torácica, que varia com a respiração e a posição do tórax, variando, também, de intensidade e duração. Seu exame físico revela a presença de um atrito pericárdico. Das situações a seguir, qual não indica a necessidade de internação hospitalar?

A) Elevação de enzimas de necrose miocárdica

B) Febre acima de 38°C e leucocitose

C) Derrames pericárdicos volumosos, com ou sem tamponamento cardíaco

D) Acometimento em imunocomprometidos

E) Presença de bloqueio do ramo esquerdo no eletrocardiograma

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

221391)

Enunciado: A eficácia do AAS durante as primeiras 24 horas do IAMCSST foi demonstrada inicialmente. A dose apresenta a seguinte alternativa como CORRETA:

A) No entanto, a utilização de doses altas de AAS não associada a aumento significante das taxas de sangramento menor.

B) Quando comparadas doses altas de AAS (300-325 mg por dia) a doses menores (75-100 mg ao dia), foi evidenciada diferença significante entre os dois grupos no desfecho primário de morte cardiovascular, IAM ou AVC até 30 dias de acompanhamento.

C) No entanto, a utilização de doses altas de AAS esteve associada a aumento insignificante das taxas de sangramento menor.

D) Quando comparadas doses altas de AAS (300-325 mg por dia) a doses menores (75-100 mg ao dia), não foi evidenciada diferença significante entre os dois grupos no desfecho primário de morte cardiovascular, IAM ou AVC até 30 dias de acompanhamento.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

221398)

Enunciado: A eficácia e segurança da terapia antiplaquetária dupla TAD pós-intervenção coronária percutânea ICP em pacientes com alto risco de sangramento tem sido avaliada em estudos recentes. Podemos apenas concordar com o item:

A) O manejo da terapia antiplaquetária dupla TAD em pacientes submetidos a implante de Stent e em uso de anticoagulantes não representa um desafio na prática clínica devido ao elevado risco de complicações hemorrágicas associada à terapia tripla.

B) O manejo da terapia antiplaquetária dupla TAD em pacientes submetidos a implante de Stent e sem uso de anticoagulantes ainda representa um desafio na prática clínica devido ao elevado risco de complicações hemorrágicas associada à terapia tripla.

C) O manejo da terapia antiplaquetária dupla TAD em pacientes submetidos a implante de Stent e em uso de anticoagulantes ainda representa um desafio na prática clínica devido ao elevado risco de complicações hemorrágicas associada à terapia tripla.

D) O manejo da terapia antiplaquetária dupla TAD em pacientes submetidos a implante de Stent e em uso de anticoagulantes ainda representa um desafio na prática clínica devido ao elevado risco de complicações hemorrágicas não associadas à terapia tripla.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

221389)

Enunciado: Ticagrelor é um novo fármaco antagonista reversível do receptor não tienopiridínico P2Y12, sendo adequado o seguinte ao seu respeito:

A) Necessita de processo de conversão metabólica para um componente ativo.

B) Não necessita de processo de conversão metabólica para um componente inativo.

C) Não necessita de processo de conversão metabólica para um componente ativo.

D) Não necessita de processo de desconversão metabólica para um componente ativo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

221380)

Enunciado: A capacidade da reserva de fluxo fracionada - RFF em discriminar o significado funcional de estenoses coronárias epicárdicas foi extensamente validada em ampla gama de situações clínicas e anatômicas. Apenas podemos aceitar como CORRETO o item:

A) A avaliação de estenoses angiograficamente intermediárias (< 90%) representa um desafio do cotidiano do laboratório de cateterismo e é uma das indicações mais bem estabelecidas para uso clínico da reserva de fluxo fracionada RFF no auxílio da tomada de decisão.

B) A avaliação de estenoses angiograficamente intermediárias (> 60% e < 90%) representa um desafio do cotidiano do laboratório de cateterismo e é uma das indicações mais bem estabelecidas para uso clínico da reserva de fluxo fracionada RFF no auxílio da tomada de decisão.

C) A avaliação de estenoses angiograficamente intermediárias (> 40% e < 70%) representa um desafio do cotidiano do laboratório de cateterismo e é uma das indicações mais bem estabelecidas para uso clínico da reserva de fluxo fracionada RFF no auxílio da tomada de decisão.

D) A avaliação de estenoses angiograficamente intermediárias (> 50% e < 70%) representa um desafio do cotidiano do laboratório de cateterismo e é uma das indicações mais dificilmente estabelecidas para uso clínico da reserva de fluxo fracionada RFF no auxílio da tomada de decisão.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

221383)

Enunciado: O benefício da utilização da reserva de fluxo fracionada - RFF para guiar a propriedade da revascularização miocárdica em pacientes com doença arterial coronária - DAC multiarterial foi demonstrado em diversos estudos, não randomizados e randomizados. Podemos assim concordar que:

A) De forma geral, guiar o procedimento de revascularização, tratando apenas estenoses fisiologicamente insignificantes, ao invés de guiar a revascularização pela aparência angiográfica, foi seguro e reduziu o custo do procedimento e a ocorrência de eventos cardíacos adversos a longo prazo.

B) De forma geral, guiar o procedimento de revascularização, tratando apenas estenoses fisiologicamente significativas, ao invés de guiar a revascularização pela aparência angiográfica, foi inseguro, mas reduziu o custo do procedimento e a ocorrência de eventos cardíacos adversos a longo prazo.

C) De forma geral, guiar o procedimento de revascularização, tratando apenas estenoses fisiologicamente significativas, ao invés de guiar a revascularização pela aparência angiográfica, foi seguro e reduziu o custo do procedimento e a ocorrência de eventos cardíacos adversos a curto prazo.

D) De forma geral, guiar o procedimento de revascularização, tratando apenas estenoses fisiologicamente significativas, ao invés de guiar a revascularização pela aparência angiográfica, foi seguro e reduziu o custo do procedimento e a ocorrência de eventos cardíacos adversos a longo prazo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

214586)

Enunciado: Homem de 55 anos, hipertenso e tabagista, deu entrada no PA com queixa de desconforto epigástrico há uma hora. Ao exame físico, apresenta-se com PA = 80 x 50 mmHg; FC = 60 bpm; pálido e sudoreico, com pulsos filiformes, pulmões sem estertores, ausência de B3 ou sopros cardíacos. ECG mostra supradesnivelamento do segmento ST de 3 mm nas derivações D2, D3 e aVF. Qual é o diagnóstico e a conduta mais adequada?

A) Infarto inferior com repercussão hemodinâmica; iniciar infusão de dobutamina + noradrenalina e avaliar V3R e V4R.

B) Infarto de ventrículo direito; iniciar infusão de volume com cristaloide e dobutamina.

C) Infarto de ventrículo direito; iniciar infusão de volume com cristaloide e noradrenalina.

D) Infarto inferior com hipotensão arterial importante; iniciar infusão de volume com cristaloides e avaliar V3R e V4R.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

208559)

Enunciado: Um homem de 50 anos foi admitido em unidade de pronto atendimento com relato de dor torácica súbita, de leve intensidade, em aperto, iniciado a 15 minutos de sua admissão. Após rápida coleta de enzimas de injuria miocárdica, seu eletrocardiograma revelou corrente de lesão subepicárdica nas derivações D2, D3 e aVF. Ao exame físico, apresentava PA=160x80 mmHg e FC=100bpm. Em se tratando de infarto agudo do miocárdio, qual dos critérios a seguir determina a reperfusão coronariana imediata?

A) característica da dor torácica

B) achado eletrocardiográfico

C) nível de pressão arterial

D) frequência cardíaca

E) valores das enzimas cardíacas

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

177321)

Enunciado: Um homem de 69 anos apresenta quadro de angina instável e deve ser submetido a cateterismo cardíaco. Ele está internado em unidade coronariana, com pressão arterial controlada e FC = 66 bpm. A creatinina é de 1,2 mg%. A complicação mais esperada para essa angiografia é:

A) lesão renal aguda intrínseca

B) infarto agudo do miocárdio

C) taquiarritmia pós-procedimento

D) sangramento do local de punção

E) obstrução arterial aguda em femoral

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

158189)

Enunciado: Paciente diabético foi submetido à angioplastia primária e implante de stent na artéria descendente anterior por IAM. Apresentou evolução satisfatória e a coronariografia não mostrou lesões significativas nas demais coronárias. Após 5 dias, recebeu alta hospitalar. NÃO é droga utilizada na prevenção secundária desse paciente:

A) Nitrato.

B) Estatina.

C) Clopidogrel.

D) IECA.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

136992)

Enunciado: Em relação ao Infarto Agudo do Miocárdio, pode-se afirmar:

A) A administração de fibrinolítico pré-hospitalar pode ser realizada para reduzir a mortalidade e grau de disfunção ventricular, sendo estreptoquinase a melhor opção.

B) A presença de condução lenta e fragmentada favorece o surgimento de arritmias ventriculares por reentrada; o ECG de alta resolução pode ajudar na estratificação de risco.

C) As troponinas são proteínas do complexo de regulação miofibrilar cardíaco, por isso a Troponina C é um marcador específico cardíaco.

D) A realização do ECG no local do atendimento e sua interpretação por médico habilitado não resultam em impacto na redução do tempo porta-agulha ou porta-balão.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

137000)

Enunciado: Considerando a doença arterial coronária em diabéticos, assinale a afirmativa correta.

A) Devido ao alto risco de doença arterial coronária em diabéticos, pelo menos um exame de imagem para estratificação deve ser realizado após os 50 anos.

B) AAS 81 ? 100 mg/dia está indicado para prevenção de eventos cardiovasculares em todos os pacientes diabéticos, independente do sexo e idade.

C) As tiazolinedionas, agentes que melhoram a sensibilidade à insulina, são de escolha para o controle da glicemia após o IAM, devido à ausência de efeitos colaterais cardiovasculares.

D) Estatinas devem ser administradas a pacientes diabéticos com doença cerebrovascular conhecida ou com idade > 40 anos, independentemente do nível de colesterol.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

108109)

Enunciado: Correlacione a área acometida com a alteração na eletrocardiográfica no infarto agudo do miocárdio e marque a opção correta: 1) antero-septal; 2) anterior extenso; 3) inferior; 4) lateral alto; ( ) V1 a V4; ( ) V1 a V6, aVL, DI; ( ) DI, aVL; ( ) DII, DIII, aVF

A) 1, 2, 3, 4

B) 1, 2, 4, 3

C) 2, 1, 3, 4

D) 2, 1, 4, 3

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

85032)

Enunciado: Paciente sexo masculino, 77 anos, diabético tipo 2, coronariopata, com revascularização do miocárdio cirúrgica há 8 anos, chegou ao pronto-socorro com quadro de dor precordial com as mesmas características do infarto agudo do miocárdio ocorrido há 9 anos, acompanhado de palidez e sudorese. Exame físico: PA: 140 × 90 mmHg; FC: 80 bpm; peso: 80 kg. Bom estado geral, ansioso, pálido, hidratado, afebril. Em uso de ácido acetilsalicílico 100 mg/dia, metformina 850 mg 3×/dia, captopril 50 mg 3×/dia, atenolol 25 mg/dia, sinvastatina 20 mg/dia. Foram realizadas 3 troponinas negativas e CK-MB = 100 (normal até 25 mg/dl). Qual a hipótese diagnóstica e o destino desse paciente?

A) Angina Instável/Hemodinâmica.

B) Angina Instável/Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

C) Infarto Agudo do Miocárdio/Hemodinâmica.

D) Infarto Agudo do Miocárdio/Enfermaria de Cardiologia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

88433)

Enunciado: Paciente 45 anos, tabagista, obeso e hipertenso apresenta dor pré-cordial com irradiação para o membro superior esquerdo mesmo em repouso, ECG não apresenta supra de ST, laboratório sem elevações de marcadores, diagnóstico mais provável:

A) Infarto Agudo do Miocárdio.

B) Infarto Agudo do Miocárdio sem supra-ST.

C) Angina instável.

D) Angina estável.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

301651)

Enunciado: Com relação ao Brasil, não existem dados suficientes para análise detalhada quanto à evolução do consumo percentual de gorduras:

A) No entanto, resultados importantes da última POF/IBGE, 201922 que comparou o período de 2017-2018 a 2002-2003, não mostraram diminuição significativa nas despesas domiciliares com óleos e gorduras.

B) No entanto, resultados importantes da última POF/IBGE, 201922 que comparou o período de 2017-2018 a 2002-2003, mostraram diminuição significativa nas despesas domiciliares com óleos e gorduras.

C) No entanto, resultados importantes da última POF/IBGE, 201922 que comparou o período de 2017-2018 a 2002-2003, mostraram aumento significativo nas despesas domiciliares com óleos e gorduras.

D) No entanto, resultados importantes da última POF/IBGE, 201922 que comparou o período de 2017-2018 a 2002-2003, mostraram diminuição não significativa nas despesas domiciliares com óleos e gorduras.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

284213)

Enunciado: Em coronariopatas estáveis, a Reabilitação Cardiovascular (RCV) é uma estratégia que, em termos de custo-efetividade, está de acordo com o item:

A) Não é capaz de superar procedimentos amplamente utilizados no país, tais como a intervenção coronariana percutânea (ICP).

B) Supera, com larga margem, procedimentos amplamente utilizados no país, tais como a intervenção coronariana percutânea (ICP).

C) Supera, com larga margem, procedimentos amplamente utilizados no país, exceto a intervenção coronariana percutânea (ICP).

D) Nunca supera, somente a coronariana não percutânea.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

239610)

Enunciado: Nos últimos 30 anos, o tratamento dos fatores de risco cardiovascular resultou na redução de 50% das mortes por DAC, em grande parte devido ao advento das estatinas. Podemos aceitar que:

A) A doença arterial coronariana (DAC) não é a principal causa de mortalidade no mundo ocidental.

B) As estatinas são hoje a droga mais prescrita no mundo, atrás apenas dos anti-hipertensivos.

C) A eficácia comprovada e o bom perfil de segurança, aliados ao baixo custo, têm sido os principais determinantes do aumento do uso.

D) O grande debate atual sobre a prevenção de doenças cardiovasculares refere-se cada vez mais à questão de como e não quando usar estatinas no controle efetivo do risco cardiovascular mesmo com banalização e supertratamento com potencial aumento de efeitos adversos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

239611)

Enunciado: A fisiopatologia do IAM perioperatório difere um pouco da do IAM espontâneo. O item errado é:

A) No IAM perioperatório, a ruptura de placa ocorre em aproximadamente metade dos casos; o restante se dá por um desequilíbrio prolongado entre a redução da oferta de oxigênio para o miocárdio (anemia, baixo fluxo etc.) e o aumento da demanda arterial coronariana (taquicardia e hipertensão).

B) TE - teste de esforço é uma ferramenta segura, útil e eficaz para a detecção de isquemia miocárdica, tendo justamente como mecanismo produzir este desbalanço entre oferta e demanda.

C) Detecção de anormalidades durante execução TE - teste de esforço possa ser reprodutível durante o perioperatório e seus variados níveis de estresse.

D) Deve se considerar que, quanto menor a prevalência da doença coronária em determinada população, maior será também o valor preditivo positivo do TE.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

243736)

Enunciado: João, 49 anos, IMC de 39, tabagista, hipertenso e diabético em uso regular de hidroclorotiazida, anlodipina e metformina. Está com dor do tipo aperto em região torácica anterior esquerda iniciada há alguns minutos, após subir 3 lances de escada para chegar ao ambulatório. Durante a anamnese, conta sobre crises frequentes de "dor no coração" com piora ao estresse emocional e às atividades físicas. Exame físico normal, sem reprodução de dor à palpação de região torácica e ECG de repouso normal. Ao final do exame ele não sente mais dor. Sobre o caso, é possível afirmar que:

A) muitos pacientes com dor torácica referem que a dor pode ser de origem cardíaca, mas isso não tem nenhum valor semiológico

B) o eletrocardiograma de repouso sem alterações e a melhora espontânea da dor permitem afastar a possibilidade de cardiopatia isquêmica

C) apresentar dor torácica não reprodutível à palpação e com piora ao realizar atividade física torna muito provável que a causa seja doença arterial coronariana

D) em pacientes diabéticos, o padrão de apresentação de angina é diferente de pacientes não diabéticos, fazendo com que a queixa de dor torácica não seja tão importante

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

239620)

Enunciado: O aumento da sensibilidade dos kits disponíveis das troponinas propiciou uma maior acurácia e rapidez no diagnóstico ou não do IAM em pacientes com dor torácica na sala de emergência. Não podemos apenas concordar com o item:

A) No perioperatório de operações não cardíacas, as evidências científicas disponíveis incluem todas as troponinas (I e T) e todos métodos utilizados para sua dosagem, que apresentam limites de detecção e valores de referência diferentes.

B) O limite de detecção significa o mínimo valor que é detectado pelo método.

C) O valor de referência da normalidade é determinado utilizando o percentil 99, que é obtido realizando-se o exame em uma população normal e significa que 99% dos indivíduos normais apresentam valores abaixo deste cut-off.

D) Os kits de troponina podem ser classificados em baixa (convencionais), média (contemporâneos ou sensíveis) ou alta sensibilidade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

239621)

Enunciado: Definir a melhor maneira de tratar esses pacientes submetidos à ICP Intervenção Coronária Percutânea torna-se fundamental, principalmente quanto à associação de medicamentos antiplaquetários e anticoagulantes. Não podemos aceitar que:

A) Aproximadamente 6 a 8% dos pacientes submetidos à ICP têm indicação concomitante de utilização de anticoagulantes orais em longo prazo.

B) Indicação concomitante de utilização de anticoagulantes orais em longo prazo, devido a vários motivos como FA ou valvas biológicas.

C) Indicação concomitante de utilização de anticoagulantes orais em longo prazo, devido a vários motivos como valvas mecânicas.

D) Indicação concomitante de utilização de anticoagulantes orais em longo prazo, devido a vários motivos como o tromboembolismo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

221224)

Enunciado: A eficácia do AAS durante as primeiras 24 horas do IAMCSST foi demonstrada inicialmente. A dose apresenta a seguinte alternativa

como CORRETA:

A) No entanto, a utilização de doses altas de AAS não associada a aumento significante das taxas de sangramento menor

B) Quando comparadas doses altas de AAS (300-325 mg por dia) a doses menores (75-100 mg ao dia), foi evidenciada diferença

significante entre os dois grupos no desfecho primário de morte cardiovascular, IAM ou AVC até 30 dias de acompanhamento

C) No entanto, a utilização de doses altas de AAS esteve associada a aumento insignificante das taxas de sangramento menor.

D) Quando comparadas doses altas de AAS (300-325 mg por dia) a doses menores (75-100 mg ao dia), não foi evidenciada

diferença significante entre os dois grupos no desfecho primário de morte cardiovascular, IAM ou AVC até 30 dias de

acompanhamento.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

221253)

Enunciado: A eficácia e segurança da terapia antiplaquetária dupla TAD pós-intervenção coronária percutânea ICP em pacientes com alto risco de

sangramento tem sido avaliada em estudos recentes. Podemos apenas concordar com o item:

A) O manejo da terapia antiplaquetária dupla TAD em pacientes submetidos a implante de Stent e em uso de anticoagulantes não

representa um desafio na prática clínica devido ao elevado risco de complicações hemorrágicas associada à terapia tripla.

B) O manejo da terapia antiplaquetária dupla TAD em pacientes submetidos a implante de Stent e sem uso de anticoagulantes ainda

representa um desafio na prática clínica devido ao elevado risco de complicações hemorrágicas associada à terapia tripla.

C) O manejo da terapia antiplaquetária dupla TAD em pacientes submetidos a implante de Stent e em uso de anticoagulantes ainda

representa um desafio na prática clínica devido ao elevado risco de complicações hemorrágicas associada à terapia tripla.

D) O manejo da terapia antiplaquetária dupla TAD em pacientes submetidos a implante de Stent e em uso de anticoagulantes ainda

representa um desafio na prática clínica devido ao elevado risco de complicações hemorrágicas não associadas à terapia tripla.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

216819)

Enunciado: Paciente de 75 anos, tabagista, hipertenso, chega ao pronto-socorro com dor retroesternal em aperto, a dor é intensa, e persiste durante o deslocamento do paciente até o hospital mais próximo (45 minutos). Ao exame físico, paciente apresenta-se sudoreico, pálido, com B4 à ausculta cardíaca. O ECG feito na admissão revelou inversão de onda T e a troponina encontrava-se elevada. Qual é o seu provável diagnóstico?

A) Miocardite.

B) Infarto agudo do miocárdio com supra de segmento ST.

C) Infarto agudo do miocárdio sem supra de segmento ST.

D) Angina instável.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

221315)

Enunciado: A capacidade da reserva de fluxo fracionada - RFF em discriminar o significado funcional de estenoses coronárias epicárdicas foi
extensamente validada em ampla gama de situações clínicas e anatômicas. Apenas podemos aceitar como CORRETO o item:

A) A avaliação de estenoses angiograficamente intermediárias (< 90%) representa um desafio do cotidiano do laboratório de
cateterismo e é uma das indicações mais bem estabelecidas para uso clínico da reserva de fluxo fracionada RFF no auxílio da
tomada de decisão.

B) A avaliação de estenoses angiograficamente intermediárias (> 60% e < 90%) representa um desafio do cotidiano do laboratório
de cateterismo e é uma das indicações mais bem estabelecidas para uso clínico da reserva de fluxo fracionada RFF no auxílio da
tomada de decisão.

C) A avaliação de estenoses angiograficamente intermediárias (> 40% e < 70%) representa um desafio do cotidiano do laboratório
de cateterismo e é uma das indicações mais bem estabelecidas para uso clínico da reserva de fluxo fracionada RFF no auxílio da
tomada de decisão.

D) A avaliação de estenoses angiograficamente intermediárias (> 50% e < 70%) representa um desafio do cotidiano do laboratório
de cateterismo e é uma das indicações mais dificilmente estabelecidas para uso clínico da reserva de fluxo fracionada RFF no
auxílio da tomada de decisão.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

221316)

Enunciado: O benefício da utilização da reserva de fluxo fracionada - RFF para guiar a propriedade da revascularização miocárdica em pacientes
com doença arterial coronária - DAC multiarterial foi demonstrado em diversos estudos, não randomizados e randomizados. Podemos
assim concordar que:

A) De forma geral, guiar o procedimento de revascularização, tratando apenas estenoses fisiologicamente insignificantes, ao invés
de guiar a revascularização pela aparência angiográfica, foi seguro e reduziu o custo do procedimento e a ocorrência de eventos
cardíacos adversos a longo prazo.

B) De forma geral, guiar o procedimento de revascularização, tratando apenas estenoses fisiologicamente significativas, ao invés de
guiar a revascularização pela aparência angiográfica, foi inseguro, mas reduziu o custo do procedimento e a ocorrência de
eventos cardíacos adversos a longo prazo.

C) De forma geral, guiar o procedimento de revascularização, tratando apenas estenoses fisiologicamente significativas, ao invés de
guiar a revascularização pela aparência angiográfica, foi seguro e reduziu o custo do procedimento e a ocorrência de eventos
cardíacos adversos a curto prazo.

D) De forma geral, guiar o procedimento de revascularização, tratando apenas estenoses fisiologicamente significativas, ao invés de
guiar a revascularização pela aparência angiográfica, foi seguro e reduziu o custo do procedimento e a ocorrência de eventos
cardíacos adversos a longo prazo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

214099)

Enunciado: Mulher com 50 anos, obesa, hipertensa não controlada, recém-separada do marido, apresenta-se à consulta médica com dor torácica típica, teste ergométrico positivo e cineangiocoronariografia normal. No que diz respeito ao tema esquematizado nesse exemplo, assinale a alternativa correta.

A) Durante testes de estresse como Teste Ergométrico, muitos desses pacientes desenvolvem dor torácica e alterações eletrocardiográficas de isquemia, porém alterações cintilográficas de isquemia não são presentes.

B) Durante os perídos de maior demanda de oxigênio pelo miocárdio como exercícios físicos, esses pacientes não produziram evidência bioquímica consistente de isquemia como elevados níveis de lactato pelo miocárdio.

C) Não foram produzidas evidências de disfunção microvascular com reserva vasodilatadora inadequada nesses indivíduos.

D) Aumento da sensibilidade à dor e distúbios psiquiátricos não foram correlacionados a indivíduos com essa síndrome.

E) A incidência de calcificação coronária nas imagens de tomografia computodorizada com múltiplos cortes é igual a dos indivíduos-controle.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

214101)

Enunciado: Dá entrada na maternidade uma mulher de 40 anos, G3P2A0 com 36 semanas da gestação, precordialgia intensa típica iniciada há 60 minutos. O ECG demostra supradesnivelamento de 3 mm do segmento ST em parede anterior. Sobre isso, é correto afirma que

A) o infarto agudo do miocárdio é raro em mulheres em idade fértil, e a gestação não é fator de risco para IAM.

B) a dissecção da artéria coronária é a causa mais provável de IAM no período periparto.

C) o IAM pode ocorrer durante qualquer estágio da gestação e é mais freguente em primíparas, sendo que a maioria dos eventos ocorre em mulheres menor que 30 anos e na maior parte do tempo a localização é a parede inferior.

D) os fatores de risco tradicionais não estão presentes com frequência entre aquelas que experimentam IAM durante a gestação, incluindo tabagismo, hiperlipidemia, hipertensão e diabetes.

E) a angiocoronariografia de urgência deve ser evitada nessas situações.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

177891)

Enunciado: Um paciente de 70 anos procura o ambulatório de cardiologia com sintomas típicos de angina pectoris. Tem história prévia de IAM a cerca de 7 anos e há 4 meses iniciou dor retroesternal típica. Faz uso regular de antiadesivo plaquetário, além de isossorbida e betabloqueador em doses tradicionais. O exame físico encontra-se praticamente normal, apenas com bloqueio de ramo esquerdo no ECG de repouso. Em relação à propedêutica, qual seria o melhor exame para avaliar o quadro clínico desse paciente?

A) Ecocardiograma com stress farmacológico.

B) Cateterismo cardíaco.

C) Ressonância nuclear magnética do miocárdio.

D) Cintilografia perfusional miocárdica.

E) Teste ergométrico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

187414)

Enunciado: Paciente masculino, motorista de ônibus, 55 anos, tabagista, sedentário, que ingere em média duas cervejas por dia. Procurou serviço médico contando ser assintomático e ter sido detectada pressão arterial elevada em exame para renovação de carteira de motorista. Antecedentes familiares positivos: pai teve infarto agudo do miocárdio aos 50 anos. Exame físico: peso=85 Kg; altura=168 cm; circunferência de cintura= 104 cm; pressão arterial=160 X 96 mmHg (medida três vezes nas posições deitado e sentado); frequência cardíaca= 84 bpm. Restante do exame físico sem alterações. Avaliação laboratorial demonstrou: ECG normal; creatinina=0,8 mg/dL; glicemia=90 mg/dL; colesterol total= 260 mg/dL; HDL-C= 50 mg/dL; VLDL-C= 35 mg/dL; triglicerídeos= 175 mg/dL; K+ = 4,5 mEq/L; ácido úrico= 6,8 mg/dL; urina I normal. Trata-se de paciente com:

A) Risco cardiovascular alto

B) Risco cardiovascular baixo

C) Risco cardiovascular médio

D) Risco cardiovascular muito alto

E) Sem risco cardiovascular

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183517)

Enunciado: Paciente do sexo feminino, 62 anos, com antecedente de hipertensão arterial com tratamento irregular, dá entrada em sala de pronto atendimento com história de dor torácica há 2 horas. O ECG de entrada é: Assinale a alternativa que fornece CORRETAMENTE o diagnóstico e a conduta.

A) Síndrome coronariana aguda com supra do segmento ST inferolaterodorsal. Trombólise química ou angioplastia primária.

B) Síndrome coronariana aguda com supra do segmento ST inferolaterodorsal: solicitar enzimas cardíacas e CT de tórax para descartar dissecção de aorta.

C) Pericardite aguda. Supradifuso do segmento ST: solicitar ecocardiograma e introduzir ibuprofeno.

D) Tromboembolismo pulmonar. S1Q3T3: solicitar CT de tórax e ecocardiograma para avaliar função do VD. Trombólise caso VD com disfunção sistólica.

E) Dissecção de aorta: solicitar CT de tórax com urgência.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152285)

Enunciado: Mulher de 40 anos de idade, hipertensa, fumante e com histórico de uso de anticoncepcional oral, procura atendimento médico com dor no ombro esquerdo, dispneia e diaforese. Realizado avaliação física encontra sudorese fria e pegajosa, dispneia, taquipneia e estertores crepitantes bi basais. ECG demonstra supra de ST em V1, V2, V3 e V4. Dessa forma, assinale a alternativa CORRETA.

A) Indicar angioplastia facilitada.

B) Contraindicar beta bloqueador.

C) Contraindicar oxigênio suplementar.

D) Contraindicar analgésico com opioide.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152291)

Enunciado: Mulher de 54 anos de idade, hipertensa, fumante e com histórico de uso de anticoncepcional oral, procura atendimento médico com dor no ombro esquerdo, dispneia e diaforese. Realizado avaliação física encontra sudorese fria, dispneia, taquipneia e estertores crepitantes bi-basais. ECG demonstra supra de ST em V1, V2 e V3. Dessa forma, o tratamento ADEQUADO deve ser feito com:

A) Atenolol oral.

B) Metoprolol venoso.

C) Aspirina.

D) Trombolítico seguido de angioplastia (facilitada).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152264)

Enunciado: Paciente com cirurgia de revascularização do miocárdio prévia refere dor precordial, com 2 horas de evolução e apresenta supradesnivelamento de segmento S-T em parede diafragmática e marcadores cardíacos alterados. Nesse caso, qual é a conduta IMEDIATA?

A) Encaminhamento para estudo hemodinâmico.

B) Administração de fibrinolítico em Unidade Coronariana.

C) Avaliação de fatores de risco e acompanhamento com marcadores cardíacos.

D) Encaminhamento para cirurgia cardíaca.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

133834)

Enunciado: Paciente masculino de 48 anos de idade deu entrada no hospital com dor torácica típica de insuficiência coronariana. Seu eletrocardiograma demonstra supra de ST na parede anterosseptal. Seu exame físico apresenta ausculta cardíaca com B3 e sua ausculta pulmonar demonstra uma pequena faixa de estertoração bibasal. Dentro das possíveis condutas justificáveis, indique aquela que não se aplica a esse caso clínico:

A) Caso não esteja disponível angioplastia primária, está indicado trombólise química até 12 horas do início.

B) Ofertar oxigênio apenas caso ocorra evidência de hipóxia.

C) Betabloqueador para diminuir extensão da lesão.

D) Transferência para centro com hemodinâmica, caso disponível e viável.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

107003)

Enunciado: A necessidade de doses cada vez maiores e a perda de eficiência da medicação anti-hipertensiva e antianginosa das famílias dos ditos nitratos, está MELHOR explicada pela afirmativa:

A) filtração renal.

B) metabolismo hepático.

C) metabolismo endotelial.

D) resistência cárdica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

106937)

Enunciado: Quando classificamos a gravidade das doenças, interessa-nos a correlação com a mortalidade das mesmas. Nesse aspecto, a classificação de Infarto Agudo do Miocárdio de Killip mostra-se bastante interessante, utilizando como parâmetros básicos:

A) O eletrocardiograma.

B) O ecocardiograma.

C) A hemodinâmica.

D) O exame físico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

106944)

Enunciado: Quando avaliamos a gravidade de um Infarto Agudo do Miocárdio, utilizamos frequentemente o eletrocardiograma, este sendo capaz basicamente de:

A) Localizar a lesão.

B) Definir sua gravidade e mortalidade.

C) Excluir sua existência.

D) Indicar cateterismo cardíaco.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

106996)

Enunciado: Das alternativas abaixo, aponte a que pode ser considerada como diagnóstico alternativo de dor torácica cardíaca de origem não isquêmica.

A) Pericardite, Prolapso Mitral e Dissecção Aórtica.

B) Ponte Miocárdica e Síndrome Cardíaca X.

C) Angina de Prinzmetal.

D) Espasmo Esofágico e Refluxo Esofágico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

81211)

Enunciado: Assinale a alternativa que contenha, apenas, patologias que são diagnósticos diferenciais de infarto agudo do miocárdio:

A) Pericardite, derrame pericárdio, amigdalite, traqueobronquite.

B) Dissecção aguda de aorta, colecistopatia, pancreatite, infecção do trato urinário.

C) Dissecção aguda de aorta, colecistopatia, pancreatite, pneumotórax, pneumonia, traumatismo cranioencefálico.

D) Dissecção aguda de aorta, espasmo de esôfago, pneumotórax, pancreatite, patologias da coluna vertebral.

E) Cisto de ovário roto, litíase biliar e Aneurisma da veia da Galeno.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

81216)

Enunciado: Assinale a alternativa que contém, somente, contraindicações absolutas para o uso de trombolíticos:

A) Gravidez, arritmia cardíaca, pneumonia e tromboembolismo pulmonar.

B) Hemorragia digestiva alta, acidente vascular cerebral hemorrágico, massagem cardíaca externa traumática e menstruação.

C) Hemorragia digestiva alta ativa, acidente vascular cerebral hemorrágico, dor abdominal difusa e gravidez.

D) Hemorragia digestiva ativa, acidente vascular cerebral hemorrágico e dissecção aguda de aorta.

E) Hipertensão arterial sistêmica controlada, diabetes, insuficiência renal aguda e DPOC.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

83515)

Enunciado: Masculino, 67 anos, diabético e hipertenso. Admitido na sala de Emergência com quadro clínico sugestivo de síndrome coronariana aguda sem supra de segmento ST. Submetido à Cineangiocoronariografia que revelou acometimento multiarterial (lesões significativas) com bom leito distal. O ECO revelou disfunção sistólica deprimida em grau moderado. Assinale a estratégia terapêutica com nível de recomendação I.

A) Manter somente o tratamento clínico.

B) Tratamento clínico e angioplastia com stent farmacológico nas principais lesões.

C) Tratamento clínico e ressincronização cardíaca através de marcapasso.

D) Tratamento Clínico e Cirurgia de revascularização miocárdia.

E) O tratamento mais recomendado nesta situação específica é o transplante cardíaco devido à gravidade das lesões e acometimento multiarterial, dificultando extremamente a técnica do cirurgião cardíaco.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

83433)

Enunciado: Paciente de 60 anos, dá entrada no pronto-socorro com dor torácica sugestiva de isquemia miocárdica e dispneia. Em seu exame físico, a pressão arterial era de 80 x 40 mmHg e ausculta pulmonar normal, frequência respiratória de 32 irpm. A frequência cardíaca aproximadamente de 75 bpm. Eletrocardiograma abaixo: (VER IMAGEM) Assinale a assertiva CORRETA:

A) Trata-se de infarto do miocárdio extenso acometendo também o ventrículo direito, devendo medicamentos como nitratos e morfina ser evitados nesta fase do infarto.

B) Trata-se de infarto do miocárdio extenso acometendo também o ventrículo direito, devendo medicamentos essenciais como nitratos e analgesia rigorosa serem instituídos prontamente.

C) Trata-se de provável dissecção aórtica, devendo uma tomografia de tórax ser solicitada para avaliar aorta torácica.

D) Trata-se de caso raro de displasia arritmogênica do ventrículo direito, devendo o tratamento ser possível cardiodesfibrilador implantável.

E) Trata-se de pericardite aguda complicada com choque séptico, devendo ser instituído tratamento de suporte com hidratação vigorosa, antibioticoterapia empírica e drogas vasoativas. Atentar para a necessidade de ecocardiograma para descartar derrame pericárdico e tamponamento cardíaco.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

60288)

Enunciado: Quando empregamos fibrinolíticos, qual das contraindicações absolutas não está correta?

A) Sangramento intracraniano.

B) Período menstrual.

C) AVC isquêmico nos últimos 6 meses.

D) Neoplasia do sistema nervoso central.

E) Suspeita de dissecção de aorta.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

64952)

Enunciado: Homem de 60 anos de idade, hipertenso e diabético, procura o serviço de emergência por precordialgia em aperto iniciada há 3 horas, irradiada ao dorso, de forte intensidade, associada a náuseas, palidez e sudorese. Ao exame físico geral, encontra-se com fácies de dor, sudoreico e com tiragem de intercostal, com PA de 135 x 90 mmHg e pulso de 48 bpm (rítmico). Ao exame específico, verifica-se a presença de crepitações inspiratórias em bases pulmonares. Sem outras anormalidades nos demais aparelhos. Submetido ao seguinte ECG: (VER IMAGEM). Qual é a abordagem terapêutica inicial?

A) Monitorização cardíaca, oxigenioterapia, acesso venoso e administração de AAS.

B) Cineangiocoronariografia imediata para abertura da artéria relacionada ao infarto.

C) Fibrinólise imediata com rt-PA.

D) Monitorização cardíaca, expansão volêmica, nitrato sublingual e oxigenioterapia.

E) Monitorização cardíaca, oxigenioterapia, administração de AAS e dobutamina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

64956)

Enunciado: Homem de 60 anos de idade, hipertenso e diabético, procura o serviço de emergência por precordialgia em aperto iniciada há 3 horas, irradiada de dorso, de forte intensidade, associada a náuseas, palidez e sudorese. Ao exame físico geral, encontra-se com fácies de dor, sudoreico e com tiragem de intercostal, com PA de 135 x 90 mmHg e pulso de 48 bpm (rítmico). Ao exame específico, verifica-se a presença de crepitações inspiratórias em bases pulmonares. Sem outras anormalidades nos demais aparelhos. Submetido ao seguinte ECG: (VER IMAGEM). Qual é o diagnóstico e a classificação correta do evento?

A) IAM de parede anterior extenso Killip II.

B) IAM de parede inferior Killip I.

C) IAM de parede anterior Killip I.

D) IAM de parede septal Killip II.

E) IAM de parede inferior Killip II.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

34546)

Enunciado: Com relação ao Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnível ST, assinale a alternativa INCORRETA:

A) Para o diagnóstico de IAM tardio, o marcador de necrose mais útil é a troponina, que permanece elevada por até 2 semanas após o início do quadro.

B) Para o diagnóstico de reinfarto precoce, a CKMB deve ser escolhida, em virtude de sua rápida normalização em até 48 horas.

C) O uso de CPK e de mioglobina isoladamente como marcador de necrose miocárdica é fortemente desaconselhada.

D) O marcador de necrose miocárdica preferencial para diagnóstico de IAM é a troponina cardíaca, pela sua elevada sensibilidade e especificidade.

E) A CKMB massa é considerada a melhor opção, apresentando acurácia maior que a da troponina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

25774)

Enunciado: Em relação ao tratamento do infarto agudo do miocárdio (IAM) assinale a ALTERNATIVA INCORRETA:

A) Aspirina deve ser a primeira medicação administrada a todos os pacientes com dor torácica sugestiva de isquemia aguda;

B) O oxigêneo deve ser mantido em todos pacientes com IAM nas primeiras 24hs.

C) Os nitratos promovem vasodilatação venosa e arterial ocasionando redução da pré e pós-carga.

D) Os betabloqueadores são contra indicados em pacientes com DPOC e bloqueio atrioventricular de segundo e terceiro graus.

E) História de lesão expansiva cereblral conhecida é uma contra indicação absoluta para o uso de fibrinolíticos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

8749)

Enunciado: Em relação ao tratamento do infarto agudo do miocárdio (IAM), assinale a alternativa incorreta:

A) a Aspirina deve ser a primeira medicação administrada a todos os pacientes com dor torácica sugestiva de isquemia aguda.

B) o oxigênio deve ser mantido em todos os pacientes com IAM nas primeiras 24 horas.

C) os nitratos promovem vasodilatação venosa e arterial ocasionando redução da pré e pós-carga.

D) os betabloqueadores são contra-indicados em pacientes com DPOC e bloqueio atrioventricular de 2º e 3º graus.

E) história de lesão expansiva cerebral conhecida é uma contra-indicação absoluta para o uso de fibrinolíticos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

359377)

Enunciado: Homem de 64 anos foi atendido no pronto-socorro de um hospital que não possui serviço de hemodinâmica. Foi diagnosticado com infarto agudo do miocárdio (IAM) com supraelevação do segmento ST. Recebeu tratamento trombolítico com alteplase, apresentou resposta clínica e eletrocardiográfica (ECG pós-reperfusão sem anormalidades) e permaneceu sob monitorização. Encontrava-se assintomático e apresentava os seguintes dados vitais: FC 68bpm, FR 18ipm, SpO2 95% (ar ambiente), PA 136/84mmHg, quando foi observado o seguinte traçado eletrocardiográfico: Assinale a alternativa que apresenta a conduta MAIS ADEQUADA neste momento em relação à abordagem da alteração eletrocardiográfica observada:

A) Administração de amiodarona pela via IV.

B) Cardioversão elétrica sincronizada.

C) Conduta expectante e suporte clínico.

D) Transferência para cateterismo de urgência (em até 1 hora).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

149917)

Enunciado: Homem de 66 anos, admitido com infarto agudo do miocárdio acometendo parede inferior do ventrículo esquerdo com seis horas de evolução, apresenta-se com níveis pressóricos reduzidos, sinais de pressão venosa aumentada e pulmões limpos à ausculta. Qual afecção abaixo explica MELHOR este quadro clínico?

A) Edema agudo de pulmão.

B) Falência ventricular esquerda.

C) Infarto agudo do ventrículo direito.

D) Síndrome pós-infarto do miocárdio.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

127492)

Enunciado: Homem de 56 anos encontra-se no quinto dia após Infarto Agudo do Miocárdio, apresentando onda Q, evoluindo com estabilidade hemodinâmica e sem congestão pulmonar, mas passa a apresentar atrito pericárdico à ausculta e relato de dor torácica com irradiação para a topografia do músculo trapézio à esquerda. Diante deste contexto assinale a alternativa ERRADA:

A) Deve se tratar de dor torácica associada com a ventilação e que melhora após assumir a posição sentada.

B) Este quadro, geralmente, não necessita de tratamento específico, mas o uso de ácido acetilsalicílico auxilia no alívio da dor.

C) Uso de indometacina e corticoides podem alterar a cicatrização do infarto e predispor à ruptura do miocárdio.

D) Do ponto de vista fisiopatológico, trata-se de fenômeno autoimune e pode recorrer após semanas a meses.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

78425)

Enunciado: Homem de 76 anos, internado há oito horas com infarto agudo do miocárdio em parede anterior apresenta, repentinamente, perda da consciência acompanhada de ausência de pulso periférico e pressão arterial inaudível. Ao monitor cardíaco, observam-se ondas "P" precedendo complexos "QRS". Qual é o diagnóstico MAIS PROVÁVEL?

A) Infarto do ventrículo direito.

B) Regurgitação mitral aguda grave.

C) Ruptura de parede livre de ventrículo esquerdo.

D) Ruptura de septo ventricular.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

60337)

Enunciado: Em face do traçado eletrocardiográfico abaixo reproduzido, seria lícito esperar que o paciente referisse a seguinte queixa: (VER IMAGEM)

A) Dor precordial irradiada para a borda do músculo trapézio esquerdo, aliviada pela posição sentada, com o tórax inclinado para frente, e agravada pela inspiração profunda e pelo decúbito dorsal.

B) Dor precordial irradiada para a borda do músculo trapézio esquerdo, aliviada pela inspiração profunda e agravada pela posição sentada, com o tórax inclinado para frente.

C) Dor precordial irradiada para o braço esquerdo, aliviada pelo decúbito dorsal e agravada pela inspiração profunda e pela posição sentada, com o tórax inclinado para frente.

D) Dor precordial irradiada para o dorso, aliviada pelo decúbito dorsal e agravada pela posição sentada, com o tórax inclinado para frente.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

53362)

Enunciado: Homem de 62 anos, hipertenso e diabético, em uso de nifedipina e hidroclorotiazida, relata desconforto precordial em opressão, relacionado aos esforços maiores, aliviado com o repouso, de curta duração (cerca de 5 minutos), sem irradiação, iniciado há 6 meses. Ao exame físico: PA = 160/100 mmHg; FC = 84 bpm e presença de 4ª bulha. Exames complementares: glicemia de jejum: 150 mg%; LDL = 160 mg%; HDL = 42 mg%; triglicérides = 180 mg%; ureia = 40 mg%; creatinina = 1,1 mg%; ECG basal: ritmo sinusal, sobrecarga atrial esquerda e alterações inespecíficas da repolarização ventricular. Dentre as opções abaixo, além de solicitação da glicemia de jejum e da glico-hemoglobina, a melhor conduta médica, neste momento, seria:

A) Solicitar cintilografia miocárdica de repouso e após esforço prescrever uma estatina.

B) Solicitar radiografia do tórax, teste ergométrico em esteira e prescrever AAS, sinvastatina e captopril, este último em substituição à nifedipina.

C) Solicitar urinálise, microalbuminúria, fundoscopia, radiografia do tórax, ecocardiograma de estresse com dobutamina e prescrever AAS e uma estatina.

D) Solicitar urinálise, proteinúria de 24 horas, ecocardiograma e prescrever AAS e uma estatina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

52418)

Enunciado: Mulher de 74 anos, internada em unidade de terapia intensiva há 48 horas com o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) de parede inferior, desenvolve, subitamente, quadro de dispneia. O exame objetivo mostra PA = 140 x 80 mmHg, FP = FC = 100 bpm, FR = 36 ipm, palidez cutânea, vasoconstrição periférica, taquidispneia, crepitações pulmonares bilaterais na metade inferior do tórax, B3, B4, sopro sistólico grau III/VI, rude, na borda esternal esquerda média. Qual é o diagnóstico mais provável?

A) Falência de bomba pós-IAM

B) Infarto de ventrículo direito

C) Ruptura de septo interventricular

D) Tromboembolismo pulmonar

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

22880)

Enunciado: O diagnóstico da doença coronariana estável, pelas evidências atuais, se sustenta nos seguintes conceitos, EXCETO:

A) A história e o exame clínicos ainda permanecem como os principais elementos diagnósticos.

B) O eletrocardiograma de repouso realizado fora das crises é de baixo valor preditivo negativo.

C) O eletrocardiograma de esforço possui sensibilidade e especificidade aceitáveis, mas depende da probabilidade pré-teste para sua interpretação.

D) O cateterismo cardíaco é o exame padrão-ouro, porque revela não somente as placas estáveis como também as placas instáveis, com risco de infarto.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

359305)

Enunciado: É CORRETO afirmar que o uso de corticosteroides no tratamento da pericardite aguda está indicado para

A) pacientes que não responderam aos anti-inflamatórios não hormonais e à colchicina.

B) todos os pacientes, independente de comorbidades anteriores.

C) casos de etiologia viral.

D) pacientes com alergia ao ácido acetilsalicílico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

340700)

Enunciado: A recomendação da dupla antiagregação plaquetária DAPT, com associação de ácido acetilsalicílico e um inibidor de P2Y12 (clopidogrel, ticagrelor ou prasugrel) após intervenção coronária percutânea ICP, varia conforme o contexto clínico (doença arterial aguda ou crônica) e tipo de stent utilizado. Sobre isso, podemos afirmar que:

A) Em pacientes submetidos à ICP fora da vigência de síndrome coronariana aguda (SCA), recomenda-se a manutenção por 12 meses, podendo a terapia ser reduzida para 6 meses ou estendida, levando-se em consideração o risco individual de sangramento, bem como o risco isquêmico.

B) Em pacientes submetidos à ICP na vigência de síndrome coronariana aguda (SCA), recomenda-se a manutenção por 2 meses, podendo a terapia ser reduzida para 6 dias ou estendida, levando-se em consideração o risco individual de sangramento, bem como o risco isquêmico.

C) Em pacientes submetidos à ICP na vigência de síndrome coronariana aguda (SCA), recomenda-se a manutenção por 12 meses, podendo a terapia ser reduzida para 6 meses ou estendida, levando-se em consideração o risco individual de sangramento, bem como o risco isquêmico.

D) Em pacientes submetidos à ICP na vigência de síndrome coronariana aguda (SCA), recomenda-se a manutenção por 12 meses, podendo a terapia ser reduzida para 6 meses ou estendida, levando-se em consideração o risco individual de sangramento, mas não o risco isquêmico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

340706)

Enunciado: No contexto de Doença Arterial Coronariana (DAC) crônica, a recomendação atual é a realização de dupla antiagregação plaquetária (DAPT):

A) Durante tempo mínimo de 4 a 6 semanas para stents não farmacológicos, e geralmente de 3 a 12 meses para os stents farmacológicos, com abreviação excepcionalmente em 30 dias, a depender do risco de sangramento e geração do stent implantado.

B) Durante tempo mínimo de 4 a 6 semanas para stents não farmacológicos, e geralmente de 2 meses para os stents farmacológicos, com abreviação excepcionalmente em 3 dias, a depender do risco de sangramento e geração do stent implantado.

C) Durante tempo mínimo de 4 a 6 semanas para stents não farmacológicos, e geralmente de 3 a 12 meses para os stents farmacológicos, com abreviação excepcionalmente em 30 dias, independente do risco de sangramento e geração do stent implantado.

D) Durante tempo mínimo de 4 a 6 semanas para stents farmacológicos, e geralmente de 3 a 12 meses para os stents não farmacológicos, com abreviação excepcionalmente em 30 dias, a depender do risco de sangramento e geração do stent implantado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

346210)

Enunciado: A pericardite é caracterizada por inflamação do pericárdio, podendo levar a um importante derrame pericárdico e sintomas como dor torácica e dispneia. O exame físico pode ser caracterizado pela presença de atrito pericárdico à ausculta cardíaca e o seu prognóstico depende do acometimento e da causa. Sabendo disso, marque a alternativa que apresenta a causa mais comum de pericardite.

A) Doença bacteriana.

B) Doença fúngica.

C) Neoplasias.

D) Doença viral.

E) Lúpus eritematoso sistêmico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

340764)

Enunciado: O desempenho de exercícios resistidos em 2 a 3 dias por semana também pode ser recomendado.

A) Para benefício adicional em adultos saudáveis, recomenda-se um aumento gradual da atividade física aeróbica para 900 minutos por semana de intensidade moderada ou 150 minutos por semana de atividade física aeróbica de intensidade vigorosa, ou uma combinação equivalente dos mesmos, idealmente com exercício diário supervisionado.

B) Para benefício adicional em adultos saudáveis, recomenda-se um aumento gradual da atividade física aeróbica para 300 minutos por semana de intensidade moderada ou 50 minutos por semana de atividade física aeróbica de intensidade vigorosa, ou uma combinação equivalente dos mesmos, idealmente com exercício diário supervisionado.

C) Para benefício adicional em adultos saudáveis, recomenda-se um aumento gradual da atividade física aeróbica para 300 minutos por semana de intensidade moderada ou 150 minutos por semana de atividade física aeróbica de intensidade não vigorosa, ou uma combinação equivalente dos mesmos, idealmente com exercício diário supervisionado.

D) Para benefício adicional em adultos saudáveis, recomenda-se um aumento gradual da atividade física aeróbica para 300 minutos por semana de intensidade moderada ou 150 minutos por semana de atividade física aeróbica de intensidade vigorosa, ou uma combinação equivalente dos mesmos, idealmente com exercício diário supervisionado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

278836)

Enunciado: A dor torácica é o principal sintoma sugestivo de Síndrome Coronária Aguda (SCA) com características da dor torácica sugestivas de isquemia miocárdica. Sendo correto que:

A) Pacientes com dor anginosa em repouso com mais de 60 minutos de duração, angina limitante de início recente e angina em crescendo (maior frequência, maior intensidade e menor limiar para aparecimento dos sintomas que o habitual) devem ser encaminhados aos serviços de emergência, já que essas características da dor são sugestivas de SCA.

B) Pacientes com dor anginosa em repouso com mais de 20 minutos de duração, angina limitante de início recente e angina em crescendo (maior frequência, maior intensidade e menor limiar para aparecimento dos sintomas que o habitual) devem ser encaminhados aos serviços de emergência, já que essas características da dor não são sugestivas de SCA.

C) Pacientes com dor anginosa em repouso com mais de 20 minutos de duração, angina limitante de início recente e angina em crescendo (maior frequência, maior intensidade e menor limiar para aparecimento dos sintomas que o habitual) devem ser encaminhados aos serviços de ambulatório de cardiologia, já que essas características da dor são sugestivas de SCA.

D) Pacientes com dor anginosa em repouso com mais de 20 minutos de duração, angina limitante de início recente e angina em crescendo (maior frequência, maior intensidade e menor limiar para aparecimento dos sintomas que o habitual) devem ser encaminhados aos serviços de emergência, já que essas características da dor são sugestivas de SCA.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

260533)

Enunciado: A elevação do segmento ST, localizada em V1 e V2 não pode ser detectada no traçado eletrocardiogràfico de :

A) Padrão de Brugada.

B) Hipercalcemia.

C) Hipertrofia ventricular direita.

D) Hiperpotassemia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

260534)

Enunciado: Dentre as doenças a seguir a que cursa mais habitualmente com pulso paradoxal é:

A) Tamponamento Cardíaco.

B) Insuficiência cardíaca diastólica.

C) Insuficiência aórtica.

D) Dissecção aórtica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

260257)

Enunciado: Com relação às Síndromes Coronarianas Agudas Sem Supradesnivelamento do Segmento ST (SCASST), assinale a alternativa INCORRETA.

A) Os betabloqueadores devem ser iniciados precocemente, na ausência de contraindicações.

B) O emprego da nitroglicerina deve ser considerado quando houver precordialgia persistente, congestão pulmonar e/ou hipertensão arterial refratária.

C) A mortalidade dos pacientes com SCASST, em longo prazo, é inferior à dos pacientes com síndrome coronariana aguda com supradesnivelamento do segmento ST.

D) O escore GRACE (Global Registry of Acute Coronary Events) permite avaliar a gravidade dos pacientes, fornecendo uma estratificação de risco precisa tanto na admissão quanto na alta.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

266590)

Enunciado: Homem de 45 anos se queixa de dor retroesternal de forte intensidade, em aperto, mais intensa à inspiração, que piora em decúbito dorsal e alivia quando se assenta. Associa-se dispneia. Desconhece ser portador de doenças quaisquer. Ao exame físico, PA: 154 x 82 mmHg (membro superior direito) e 146 x 78 mmHg (membro superior esquerdo), FC: 123 bpm, FR: 21 irpm, SpO? 97% (em ar ambiente). Sem anormalidades no restante do exame físico. A radiografia do tórax não apresentou alterações. O eletrocardiograma encontra-se a seguir: Assinale a conduta MAIS ADEQUADA nesse momento para esse paciente.

A) Analgesia com anti-inflamatório não esteroidal e colchicina.

B) Prescrição de AAS, ticagrelor e enoxaparina e betabloqueador.

C) Realização de angiotomografia do tórax.

D) Realização de cateterismo cardíaco.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

253900)

Enunciado: Analise as alternativas abaixo e marque o betabloqueador que não está aprovado para tratamento clínico da cardiopatia isquêmica:

A) Propranolol

B) Metoprolol

C) Carvedilol

D) Bisoprolol

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

253902)

Enunciado: Uma opção terapêutica nos pacientes com doença coronariana crônica estável é a inibição do metabolismo de ácidos graxos pelos miócitos, que passam a utilizar vias metabólicas mais eficientes, diminuindo a isquemia. O medicamento que possui este mecanismo de ação é:

A) Neprisilina

B) Levosimendan

C) Ivabradina

D) Trimetazidina

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

244513)

Enunciado: Estudos sugerem que a terapia com AAS pode estar associada a uma diminuição do AVC entre mulheres diabéticas. Dos itens abaixo, qual apresenta erro?

A) Ocorre uma diminuição do infarto agudo do miocárdio (IAM) entre homens diabéticos.

B) Ocorrem que as reduções de risco obtidas com baixas doses (75 mg/dia) foram tão significativas quanto às obtidas com doses mais elevadas (650 mg/dia).

C) Baixa dose de AAS era benéfica para a prevenção primária de DCV nos pacientes de alto risco e que a decisão sobre o tratamento com AAS deveria ser feita coletivamente.

D) Indicação da terapia antiplaquetária nos pacientes de muito alto risco, incluindo aqueles com DACL e eventos cardiovasculares prévios (prevenção secundária), o benefício é estabelecido.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

238640)

Enunciado: Após a administração de fibrinolítico no infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, indica-se a intervenção coronariana percutânea de resgate na seguinte situação:

A) Quando há aumento de troponina após seis horas de administração do fibrinolítico.

B) Sempre e imediatamente após o término da fibrinólise.

C) Manutenção da dor torácica e/ou se não houver redução de pelo menos 50% do supradesnivelamento do ST no eletrocardiograma.

D) Se o paciente apresentar ritmo idioventricular acelerado ao eletrocardiograma.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

219404)

Enunciado: Paciente sexo feminino de 32 anos apresentando piora dor torácica retroesternal nos últimos 7 dias. Ela se queixa de dispneia e edema de membros inferiores. Faz uso de hidroxicloroquina para lesão facial fotossensível, rash e úlceras orais. Rx tórax com aumento da silhueta cardíaca. Qual a descrição mais característica do seu pulso?

A) Anacrótico

B) Bífido

C) Colapsante

D) Baixa amplitude

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

201647)

Enunciado: Um homem de 45 anos, portador de dislipidemia e diabetes, é admitido no Hospital da Polícia Militar queixando-se de dor torácica retroesternal, ventilatório-dependente, que melhora na posição sentada e inclinado para a frente, associada à dispneia leve, de início há 6 horas. Nega uso de entorpecentes. Realizado o ECG apresentado abaixo. Troponina = 0,2 ng/ml (VR = 0,01 ng/ml). Sobre esse caso, marque a alternativa CORRETA:

A) Trata-se de infarto agudo do miocárdio de parede anterior extenso, sendo indicado cateterismo de urgência ou trombólise.

B) Deve-se realizar angiotomografia de tórax ou cintilografia pulmonar de ventilação e perfusão na urgência e iniciar anticoagulação plena.

C) A realização de ecocardiograma não contribui para o diagnóstico e a avaliação da gravidade.

D) Anti-inflamatório, colchicina e repouso são medidas que devem ser prontamente instituídas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

203929)

Enunciado: Paciente de 52 anos com quadro de dor torácica de moderada intensidade, em aperto, com irradiação para MSE, duração de 8 minutos e associada a dispneia e sudorese. Paciente é hipertenso e diabético. Apresenta ECG a seguir: De acordo com a principal hipótese diagnóstica para o quadro descrito, são medicamentos que podem fazer parte do tratamento do paciente, EXCETO:

A) Alteplase.

B) Isordil.

C) Clopidogrel.

D) Ticagrelor.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

210452)

Enunciado: Analise o caso abaixo: um paciente de 52 anos foi admitido na UPA/Oeste com quadro de dor torácica típica para insuficiência coronariana aguda. O ECG mostrava supradesnivelamento de ST em DII, DIII e AVF, além de V3R e V4R (derivações feitas como imagem em espelho de V3 e V4 tradicionais, mais à direita). Não apresentava crepitações à ausculta pulmonar, mas exibia hipotensão e confusão mental. Ao exame, também apresentava elevação paradoxal da veia jugular externa durante a inspiração. Assinale a alternativa que representa as informações consideradas CORRETAS sobre o caso descrito:

A) O paciente apresenta um quadro de infarto agudo do miocárdio de parede inferior de VE com infarto de ventrículo direito e sinal de Kussmaul.

B) O edema agudo dos pulmões pode se apresentar com ausculta pulmonar normal se o paciente tiver infarto da artéria circunflexa.

C) O paciente apresenta-se também com sinais de tromboembolismo pulmonar maciço ou dissecção aguda da aorta, sendo necessário saber pelo menos as enzimas cardíacas para indicar a trombólise.

D) O quadro desse paciente se confunde com pericardite constritiva crônica com sinais de baixo débito cardíaco e, nesse caso, o ecocardiograma é necessário para o diagnóstico diferencial.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

181241)

Enunciado: O uso da Ecocardiografia sob estresse na doença aterosclerótica coronariana crônica, somente não apresenta a seguinte característica descrita a seguir:

A) O ecocardiografia sob estresse é um método não invasivo, estabelecido para a avaliação de pacientes com DAC obstrutiva suspeita ou conhecida, para a determinação do diagnóstico e prognóstico, na avaliação do impacto de terapias de revascularização, mas não na detecção de viabilidade miocárdica.

B) O estresse cardiovascular causa isquemia miocárdica em regiões supridas por uma artéria com grau significativo de estenose, e esse fenômeno é manifestado por alteração transitória da contração segmentar.

C) A ecocardiografia bidimensional permite a avaliação de todos os segmentos miocárdicos do ventrículo esquerdo com grande resolução espacial e temporal, tornando-se a ferramenta ideal para a avaliação não invasiva da isquemia miocárdica.

D) Os métodos disponíveis para a indução do estresse são o esforço físico (esteira ou bicicleta ergométrica), a estimulação atrial transesofágica, e o uso de drogas vasodilatadoras (dipiridamol e adenosina) ou de estimulantes adrenérgicos (dobutamina).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

181253)

Enunciado: Durante última visita em grupo da cardiologia, você foi indicado para explicar aos colegas sobre o uso de Marcadores de Lesão Miocárdica, sua apresentação foi bastante elogiada, mas o chefe do setor não concordou com uma de suas afirmações. De acordo com as últimas diretrizes aceitas, aponte essa possível afirmação:

A) Embora as troponinas sejam importantes fatores prognósticos de risco, elas não devem ser utilizadas isoladamente para definir o risco de pacientes com SCA.

B) A maior parte dos pacientes que desenvolvem complicações apresenta troponinas normais; nenhum marcador bioquímico é perfeitamente acurado para determinar dano miocárdio.

C) As Troponinas nos paciente que se apresentam em menos de 3 horas do início dos sintomas, estão dentro do valor de normalidade, não sendo sempre necessária a mensuração seriada do marcador.

D) As troponinas na admissão estão dentro do valor de normalidade em até um quinto dos pacientes que depois confirmam diagnóstico de IAM.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

181027)

Enunciado: Paciente de 64 anos com história prévia de radioterapia com irradiação do tórax apresenta-se com sintomas gradualmente progressivos de fadiga, ascite, edema de membros inferiores e elevação da pressão venosa jugular ao longo dos últimos 4 meses. A radiografia do paciente é mostrada abaixo. A respeito do provável diagnóstico é CORRETO afirmar:

A) O paciente irá apresentar a onda Y do pulso venoso jugular atenuada.

B) A tomografia de tórax é menos precisa que o ecocardiograma para demonstrar o diagnóstico.

C) A tuberculose não é causa importante do diagnóstico nos países em desenvolvimento.

D) Pode haver Knock pericárdico na diástole.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

181248)

Enunciado: Os Stents Farmacológicos (SF) desenvolvidos no final dos anos 1990 resultam da combinação de uma plataforma metálica com um fármaco antiproliferativo, em geral carreado ao sitio da lesão por meio de um polímero, que controla a cinética de liberação do agente antiproliferativo. Em relação a isso, assinale a alternativa INCORRETA:

A) O uso dos SFs de primeira geração não afetou a ocorrência de óbito e IAM, associando-se, porém ao aumento da ocorrência de trombose bastante tardia (após o primeiro ano do implante).

B) Atualmente, a primeia geração dos SFs não é mais utilizada na prática clínica, tendo sido amplamente substituida pelas novas gerações desses dispositivos, caracterizadas pela utilização de plataformas mais finas. Com respeito ao fármaco antiproliferativo, a quase totalidade desses novos dispositivos utiliza sirolimus ou seus nálogos/derivados.

C) SFs de nova geração, com polímeros duráveis e bioabsorvíveis, que têm seu uso aprovado no Brasil, com base nos resultados de ensaios randomizados com desfechos clinicos ou angiográficos. Cabe lembrar que esses quadros são dinâmicos, estando a aprovação de novos dispositivos sujeita à analise da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

D) O uso dos SFs de primeira geração afetou a ocorrência de óbito e IAM, associando-se, porém ao aumento da ocorrência de trombose bastante tardia (após o primeiro ano do implante).

Gabarito

281102.

Comentário: Tudo bem que estamos diante de um paciente de meia idade, com fatores de risco para doença coronariana, dor torácica e supradesnivelamento do segmento ST. Naturalmente, pensaremos em infarto agudo do miocárdio ou até mesmo em dissecção aórtica complicando com IAM (a hipótese de uma taquiarritmia fica mais distante, pois a FC é de 100 bpm e o ECG não mostra nenhuma arritmia além disso, não temos achados eletrocardiográficos sugestivos de sobrecarga ventricular esquerda, típico da cardiomiopatia hipertrófica). Agora, reparem que a dor piora com decúbito. Isso não caracteriza uma dor típica de síndrome coronariana Além disso, o supradesnivelamento de ST está espalhado pelo eletrocardiograma e o paciente tem febre Na

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

verdade, estamos diante de um quadro sugestivo de pericardite aguda Do ponto de vista clínico, a pericardite aguda é marcada por dor torácica de localização precordial ou retroesternal, contínua, do tipo pleurítica, que piora com decúbito dorsal e é aliviada na posição sentada com o tronco inclinado para frente (posição genupeitoral) ou abraçado ao travesseiro (posição de Blechman). A maioria dos casos é de etiologia viral, motivo pelo qual podemos observar um quadro viral inespecífico marcado por astenia, mialgia e febre. O eletrocardiograma está alterado em 90% dos casos e revela supra de ST com concavidade para cima e onda T positiva e apiculada em várias derivações (isso é, não respeita uma parede como no IAM). Pode haver infradesnivelamento do intervalo PR e elevação dos marcadores de lesão miocárdica, atribuída à lesão miocárdica por contiguidade. Resposta letra A (a banca não liberou gabarito oficial).

281103.

Comentário: A profilaxia secundária de eventos cardiovasculares é indicada para todos os pacientes vítimas de IAM, independentemente dos níveis de LDL. Esses pacientes são automaticamente considerados de alto risco cardiovascular, devendo utilizar estatinas de alta potência, como atorvastatina (40 a 80 mg dia) ou rosuvastatina (20 a 40 mg dia). Neste caso, a princípio não há indicação de especialista em lipídeos (nutrólogo) tampouco há razões para se considerar hipercolesterolemia familiar (não há níveis absurdamente altos de LDL e com manifestações cutâneas como xantomas, tampouco história familiar precoce de doença coronariana). A niacina pode ser empregada como adjuvante no tratamento da hipercolesterolemia refratária aos demais tratamentos. Agora, o termo dieta estágio III se refere à progressão de uma dieta líquida para uma dieta sólida branda. O paciente, após 3 meses do IAM, já deveria estar na dieta estágio IV (dieta plenamente sólida), e não mais na dieta estágio II (dieta líquida). Logo, por mais maluca que essa questão pareça, a melhor resposta é a letra A... A banca não liberou gabarito oficial.

251871.

Comentário: O atendimento inicial do infarto agudo envolve medicações sintomáticas e medicações que alteram o prognóstico da doença, com efeito na sobrevida. As medicações sintomáticas

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

incluem os nitratos e a morfina, que respectivamente aumentam a vasodilatação coronariana, favorecendo o suprimento sanguíneo local, e reduzem a demanda metabólica miocárdica, promovendo analgesia e redução do adrenergismo. Entre as medicações modificadoras da sobrevida, podemos listar os antiagregantes plaquetários, estatinas, e betabloqueadores, além da heparina, que atenuam a evolução e previnem complicações relacionadas ao infarto. Os digitálicos tem efeito intrópico positivo e cronotrópico negativo, e podem ser incluídos no tratamento da insuficiência cardíaca crônica e no controle da frequencia cardíaca em portadores de dibrilação atrial, porém não entram no tratamento da síndrome coronariana aguda, devendo ser evitados nesse contexto pelo possível aumento da demanda metabólica miocárdica. Resposta letra D

251874.

Comentário: Questão direta Pelo seu efeito inotrópico e cronotrópico negativo, os betabloqueadores são formalmente contraindicados em caso de bloqueio atrioventricular de segundo ou terceiro grau, bradicardia 50 bpm, e hipotensão arterial com pressão sistólica 80 mmHg ou choque hemodinâmico. Devido ao seu efeito bloqueador de receptores beta-2 pulmonares, a tendência a precipitar episódios de broncoespasmo torna a presença de asma e DPOC contraindicações RELATIVAS, devendo o risco benefício ser avaliado individualmente. Resposta letra D.

247161.

Comentário: São características da dor torácica anginosa dor precordial ou retroesternal em peso, aperto ou queimação, desencadeada por estresse físico ou emocional e aliviada com o repouso ou uso de nitrato. Para considerarmos a angina como TÍPICA, é necessário que as três características estejam presentes, como no caso apresentado. Por tratar-se de uma angina progressiva, desencadeada no momento por esforços menores que os habituais, considera-se a angina como INSTÁVEL. Gabarito alternativa D.

182600.

Comentário: A questão quer basicamente a semiologia da dor de cada doença. O item I descreve a dor da angina pectoris típica, que piora com esforço e estresse emocional, melhora com repouso, em opressão, podendo irradiar para mandíbula, membros superiores ou epigástrio. No item II temos

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

a descrição da dor da pericardite, que tipicamente tem um componente pleurítico, piora na posição supina e melhora quando o paciente fica sentado, com tronco inclinado para frente (posição genupeitoral) ou quando fica abraçado a um travesseiro (posição de Blechman). O item III fala da dor da dissecção aórtica, extremamente intensa, aguda e que vai irradiando, principalmente para o dorso, conforme vai progredindo, comum em pacientes com hipertensão mal controlada, aterosclerose e pacientes com doenças do tecido conjuntivo, como a síndrome de Marfan. E, finalmente, o item IV, fala da dor da embolia pulmonar, que caracteristicamente é localizada e tem componente pleurítico. Gabarito B.

183132.

Comentário: Paciente hipertenso com quadro anginoso, já em uso de um diurético tiazídico para controle pressórico. A aspirina pode ser utilizada como prevenção primária, já que trata-se de um homem 50 anos com um fator de risco (hipertensão) (A correta). Os betabloqueadores agem diminuindo o tônus adrenérgico, a demanda de oxigênio pelo miocárdio com consequente melhora dos sintomas anginosos (B correta). Os nitratos ao realizarem vasodilatação coronariana também diminuem a demanda de oxigênio pelo miocárdio, diminuindo a angina (C correta). As diidropiridinas de ação curta, como a nifedipina, possuem diversos efeitos colaterais (edema periférico, flushing, cefaleia) resultantes da vasodilatação periférica. Em um paciente já sintomático, não seria uma boa escolha (D incorreta). O diltiazem é um bloqueador de canal de cálcio não diidropiridínico, que é melhor tolerado que outros bloqueadores, pois não é um vasodilatador potente nem um depressor miocárdico (E correta). Resposta D

66983.

Comentário: A indicação de fármacos específicos para a prevenção PRIMÁRIA de eventos cardiovasculares (aquela instituída antes da ocorrência de um primeiro evento) depende do contexto clínico de cada paciente individual. No hipertenso , por exemplo, o uso regular de agentes anti-hipertensivos (ex. enalapril 10 mg dia) é comprovadamente eficaz em reduzir o risco cardiovascular global. No dislipidêmico de alto risco, as estatinas (como a sinvastatina 40 mg dia) também podem reduzir o risco. Nos pacientes masculinos, um risco pelo escore de Framingham

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

10% autoriza o emprego de AAS com vistas à prevenção primária, ao passo que na mulher é preciso um risco pelo Framingham 20%. Logo, no paciente que não se enquadra em nenhuma categoria de risco aumentado, não há indicação de medicações específicas para a prevenção primária de eventos cardiovasculares Como a questão se refere ao ser humano de uma forma genérica, sem especificar qualquer tipo de contexto clínico, resposta mais apropriada D.

37070.

Comentário: Os trombolíticos só devem ser empregados nas SCA com supradesnível do segmento ST ou BRE novo ou supostamente novo. Nas SCA sem supra de ST, paradoxalmente, eles aumentam a mortalidade O supra de ST de significância clínica obedece aos seguintes parâmetros (1) está presente em pelo menos duas derivações contíguas , isto é, que olham para a mesma parede miocárdica (2) possui tamanho 1 mm nas derivações periféricas (3) possui tamanho 2 mm nas derivações precordiais. Logo, resposta certa E.

29399.

Comentário: Questão simplória... O AAS (ácido acetilsalicílico) é um antiplaquetário e não um anti-hipertensivo. Logo, seu objetivo não é tratar a hipertensão arterial Resposta certa letra E.

29387.

Comentário: Vamos de baixo pra cima... A trombólise farmacológica está CONTRA-INDICADA nas SCA sem supra de ST Ao contrário do benefício observado no IAM com supra de ST (onde seu emprego reduz o tamanho do infarto e diminui a mortalidade), nas outras formas de SCA (angina instável e IAM sem supra de ST) os trombolíticos aumentam a mortalidade (E errada) É imprescindível administrar terapia antiplaquetária agressiva para pacientes com SCA sem supra de ST, e diversos estudos confirmam o grande benefício na mortalidade com a associação de AAS e clopidogrel, a despeito de um aumento no risco de hemorragia (este aumente é visto principalmente nos pacientes submetidos a uma cirurgia de revascularização miocárdica de urgência) letra D errada... Uso de sildenafil (Viagra) nas últimas 24 h contraindica o uso de qualquer forma de nitrato. Este inibidor da fosfodiesterase exacerba o efeito vasodilatador dos nitratos, levando a um quadro de choque circulatório refratário (C errada)... A enoxaparina vem se mostrando superior à

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

heparina não-fracionada convencional em portadores de SCA Além de maior benefício em termos de redução da mortalidade, sua administração é mais prática que a da HNF (pela boa biodisponibilidade, pode ser feita pela via subcutânea) letra A errada... Por fim, está correto afirmar que a morfina pode ser utilizada em pacientes que permanecem com dor a despeito da terapia antianginosa e anti-isquêmica inicial. Não é necessário fazer morfina de rotina, em todos os pacientes... Como deu pra perceber, a banca divulgou um gabarito errado para essa questão (letra A). GABARITO MEDGRUPO LETRA B.

343222.

Comentário: Questão extraída, integralmente, do Posicionamento sobre Exercícios Físicos na Gestação e no Pós-Parto 2021 documento oficial da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Segundo este documento, o teste de caminhada de 6 minutos (TC6min) é avaliação validada da reserva cardiorrespiratória em adultos de alto risco e não gestantes, tanto em patologias crônicas quanto na avaliação perioperatória. É prova submáxima, segura, viável e aplicável em mulheres grávidas a termo, mas seu uso não é difundido. O estabelecimento de intervalos de referência para o TC6min em mulheres grávidas saudáveis permite a avaliação individual da capacidade funcional e pode ajudar a personalizar os programas de exercícios. Recomenda-se o TC6min na avaliação cardiorrespiratória de gestantes. Resposta letra C.

343223.

Comentário: Essa questão foi baseada no documento Posicionamento sobre Exercícios Físicos na Gestação e no Pós-Parto 2021 . Veja o trecho que serviu como base para elaborar a questão A análise do condicionamento físico em grávidas pode ajudar a identificar as que desenvolveram ou estão em risco de desenvolver complicações cardiovasculares, como hipertensão arterial sistêmica (HAS) ou pré-eclâmpsia. O teste de caminhada de 6 minutos (TC6min) é avaliação validada da reserva cardiorrespiratória em adultos de alto risco e não gestantes, tanto em patologias crônicas quanto na avaliação perioperatória. É prova submáxima, segura, viável e aplicável em mulheres grávidas a termo, mas seu uso não é difundido. O estabelecimento de intervalos de referência para o TC6min em mulheres grávidas saudáveis permite a avaliação individual da capacidade funcional

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

e pode ajudar a personalizar os programas de exercícios. Recomenda-se o TC6min na avaliação cardiorrespiratória de gestantes . Com base no que vimos, percebemos que a alternativa B é a única opção de resposta possível. Chegamos a sugerir um recurso para quem se sentiu prejudicado pelo fato de o enunciado não explicar o significado da pouco conhecida sigla TC6min . Resposta letra B.

314191.

Comentário: Questão copiada, integralmente, das Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Angina Instável e Infarto Agudo do Miocárdio sem Supradesnível do Segmento ST. Vamos, então, revisar o trecho que respondia a questão Nos casos em que a CK-MB está elevada e a troponina está normal, ambas dentro de sua janela cinética, deve-se basear a decisão clínica no resultado da troponina . Resposta letra B.

314195.

Comentário: Na avaliação da dor torácica aguda no setor de emergência, temos que fazer a chamada estratificação do risco cardiovascular do paciente. Essa estratificação é o grande divisor de águas para guiar a conduta diagnóstico-terapêutica inicial, geralmente alocando o paciente em rotas (fluxogramas padronizados) de acompanhamento. Para tanto são analisados diversos parâmetros, como características semiológicas da dor (definindo se a mesma é anginosa ou não), padrão eletrocardiográfico (presença de supra de ST ou não), bem como fatores de risco cardiovascular existentes (idade, HAS, DM, dislipidemia, tabagismo, história de aterosclerose bem definida, entre outros). A conclusão da estratificação permite determinar se o paciente é de risco baixo, intermediário ou elevado... Quanto maior o risco, maior a probabilidade pré-teste de a dor ser ocasionada por uma isquemia miocárdica e, de maneira correspondente, maior a probabilidade de eventos cardiovasculares maiores (infarto miocárdico, arritmias, insuficiência cardíaca e morte). Em pacientes de alto risco não pode haver dúvida a conduta deve ser a mais agressiva e completa possível, visando orientar uma ação terapêutica rápida. Por outro lado, em pacientes de risco baixo ou intermediário, existe uma maior chance de a dor não ser de origem coronariana... Nestes casos, se houver melhora clínica no momento da avaliação (ausência de dor), com ECG e marcadores de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

necrose miocárdica dentro da normalidade, pode-se solicitar um teste provocativo de isquemia a fim de esclarecer se a dor é ou não isquêmica Esse teste pode ser o tradicional teste ergométrico, ou então algum teste que possua a mesma finalidade, como a cintilografia ou o eco-stress (o teste a ser escolhido dependerá da disponibilidade e expertise de cada serviço). O fato é se um paciente que preenche as condições para a realização de um teste provocativo tiver resultado NORMAL nesse teste, pode-se afastar com razoável certeza a hipótese de dor de origem isquêmica, viabilizando uma alta hospitalar precoce e segura, desde que, é claro, outras causas potencialmente graves para a dor também tenham sido descartadas (ex. dissecção aórtica, pericardite aguda, tromboembolismo pulmonar)... A literatura já demonstrou que, neste tipo de cenário (risco baixo a intermediário, estabilidade clínica-eletrocardiográfica-laboratorial, sem indícios de outras patologias graves), a probabilidade de um evento cardiovascular maior é extremamente baixa (D errada)... Assim, percebemos que a letra A está errada, pois o paciente PODE realizar um TE e a letra B está errada porque um resultado ANORMAL no TE indica origem isquêmica e reestratifica o paciente na categoria alto risco, demandando uma conduta agressiva. A letra C corresponde ao racional que apresentamos, logo, trata-se da resposta adequada para a questão.

314198.

Comentário: Segundo a Diretriz de Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia e do Colégio Brasileiro de Radiologia, temos que A pesquisa de aterosclerose subclínica utilizando a angioTC apresenta algumas vantagens em comparação ao escore de cálcio, como a visualização da placa não calcificada e a estimativa do grau de estenose luminal. As desvantagens residem na utilização do contraste endovenoso, custo mais elevado e maior exposição à radiação, apesar da crescente redução da dose de radiação com os tomógrafos mais modernos . Resposta letra A.

314200.

Comentário: Comparada ao escore de cálcio, a angiotomografia de coronárias é um exame que apresenta como vantagens a visualização de placas não calcificadas e estimativas do grau de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

estenose luminal. Contudo, as desvantagens seriam necessidade de infusão de contraste endovenoso, custo mais elevado e dose maior de radiação. Assim, segundo a Atualização da Diretriz Brasileira de Hipercolesterolemia Familiar 2021 O uso da angiotomografia de coronárias apresenta claros benefícios em pacientes sintomáticos de baixo risco para doença arterial coronariana (DAC), tanto na emergência como no âmbito ambulatorial. Isso porque afasta a doença como causadora dos sintomas. Resposta letra D.

313474.

Comentário: Três protagonistas da clínica médica são postos em evidência nessa questão a síndrome metabólica (SM), o diabetes mellitus (DM) e a doença arterial coronariana (DAC). Entenda que todas elas, por deflagrarem lesões ao endotélio dos vasos e, progressivamente, contribuírem com repercussões em quase todo o organismo, compõem um espectro multissistêmico de doenças (letra C incorreta). Além disso, as três estabelecem uma simbiose fisiopatológica entre si a SM e a DM, por serem capazes de alterar micro e macroscopicamente os tecidos com aumento de cascata inflamatória, necrose tecidual, aumento da aterosclerose e estresse metabólico contribuem sobremaneira para o desenvolvimento do continuum de lesões presente na DAC (letras A e B incorretas). Resposta letra D.

278609.

Comentário: Questão sem muita criatividade, integralmente, retirada da Atualização da Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia 2019. Vamos, então, revisar um trecho do documento que respondia a questão O critério eletrocardiográfico para IAMCST (infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST) inclui elevação do segmento ST em duas derivações contíguas acima de 1,5 mm em mulheres, acima de 2 mm em homens 40 anos e acima de 2,5mm em homens 40 anos nas derivações V2-V3 e ou acima de 1 mm nas demais derivações . Resposta letra B.

279030.

Comentário: De acordo com a Atualização da Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia 2019 A dor torácica é o principal sintoma sugestivo de SCA. (...) Pacientes com dor anginosa em repouso com mais de 20 minutos de duração, angina limitante de início recente e angina em crescendo (maior frequência, maior intensidade e menor limiar para aparecimento dos sintomas que o habitual) devem ser encaminhados aos serviços de emergência, já que essas características da dor são sugestivas de SCA. Resposta letra D.

278614.

Comentário: De acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Angina Instável e Infarto Agudo do Miocárdio sem Supradesnível do Segmento ST, o termo IAM deve ser utilizado quando há evidência de necrose miocárdica em um contexto clínico de isquemia com elevação de marcadores de necrose miocárdica (preferencialmente troponina) acima do percentil 99 do limite máximo de referência e, pelo menos, um dos seguintes parâmetros 1) sintomas sugestivos de isquemia miocárdica 2) desenvolvimento de novas ondas Q no ECG 3) novas ou presumivelmente novas alterações significativas no segmento ST, na onda T, ou BRE novo 4) evidência, em exame de imagem, de perda de miocárdio viável ou de nova alteração segmentar de contratilidade ventricular 5) identificação de trombo intracoronariano por angiografia ou necropsia. O diagnóstico diferencial entre IAM com ou sem supradesnível do segmento ST depende exclusivamente do aparecimento ou não deste tipo de alteração ao ECG o diagnóstico diferencial do IAM sem supradesnível de ST e angina instável depende da presença (IAM sem supra) ou não (angina instável) de marcadores de necrose miocárdica elevados. Resposta letra C.

278616.

Comentário: Questão sem muita criatividade, integralmente, retirada da Atualização da Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia 2019. Vamos, então, revisar um trecho do documento que respondia a questão A dor torácica é o principal sintoma sugestivo de SCA (síndrome coronariana aguda). Pacientes com dor anginosa em repouso com mais de 20 minutos de duração, angina limitante de início recente e angina em crescendo (maior frequência, maior intensidade e menor limiar para

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

aparecimento dos sintomas que o habitual) devem ser encaminhados aos serviços de emergência, já que essas características da dor são sugestivas de SCA. A dor torácica pode não estar presente durante um episódio de SCA em até cerca de um terço dos casos. Estes pacientes podem apresentar dispneia isoladamente, náuseas, vômitos, palpitações, síncope, ou mesmo parada cardíaca. Sintomas denominados equivalentes isquêmicos normalmente acometem idosos, mulheres e pacientes diabéticos . Resposta letra B.

278681.

Comentário: Questão sem muita criatividade, integralmente, retirada da Diretriz Brasileira de Reabilitação Cardiovascular 2020. Vamos, então, revisar um trecho do documento que respondia a questão Apesar dos benefícios documentados e do excelente significado em termos de custo-efetividade, a RCV é mundialmente subutilizada. No Brasil, país de dimensão continental e grande diversidade social e econômica, dentre as inúmeras barreiras ao acesso à RCV, vale destacar como algo presente em praticamente todas as regiões escassez de serviços estruturados, dificuldade de deslocamento (mobilidade urbana ruim) e níveis altos de violência nas cidades. Neste contexto, programas de reabilitação cardiovascular domiciliar (RCVD), em que a maioria das sessões ocorre no ambiente domiciliar sob supervisão indireta, surgem como complemento ou alternativa aos programas tradicionais, nos quais as sessões são sempre realizadas sob supervisão direta ou presencial . Resposta letra B.

252879.

Comentário: Diante de um paciente com alto risco cardiovascular, apresentando dor torácica, o principal diagnóstico a ser considerado é o infarto agudo do miocárdio. No entanto, percebemos que o paciente apresenta marcadores de necrose miocárdica negativos e alterações eletrocardiográficas que não sugerem fortemente o diagnóstico de infarto. Assim, os níveis pressóricos apresentados, uma vez que estão associados a dor torácica (lesão de órgão alvo por elevação importante da pós carga), configuram uma emergência hipertensiva com síndrome coronariana aguda sem supradesnivelamento do segmento ST (angina instável) associada. A conduta, portanto, visa a redução imediata e progressiva da pressão arterial com drogas venosas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Gabarito Alternativa A.

252880.

Comentário: Temos um paciente de alto risco cardiovascular, apresentando quadro típico de angina em crescendo , ou seja, houve início dos sintomas aos grandes esforços, mas progressão para os pequenos esforços. Nesse momento, no entanto, o paciente apresenta-se com dor em repouso e alteração eletrocardiográfica sugestiva de isquemia, associados a níveis pressóricos exacerbados, o que caracteriza um quadro de emergência hipertensiva, em que há lesão de órgão-alvo. Assim, após estabilização do paciente, recomenda-se a realização de cineangiocoronariografia para estratificação da gravidade da doença. Uma vez que estamos diante de uma síndrome coronariana aguda, a cintilografia e o teste ergométrico não estão recomendados. Sobre o tempo para a realização do exame em um paciente sem supradesnivelamento do segmento ST, as condições que indicam necessidade de intervenção precoce são choque cardiogênico instabilidade hemodinâmica, instabilidade elétrica (arritmias ventriculares) ou alterações isquêmicas dinâmicas recorrentes no eletrocardiograma, angina persistente ou complicações mecânicas. Caso contrário, objetiva-se a estabilização do paciente e realização do exame em até 48 horas. Resposta letra C.

252881.

Comentário: Diante de um paciente com alto risco cardiovascular, apresentando dor torácica, o principal diagnóstico a ser considerado é o infarto agudo do miocárdio. No entanto, percebemos que o paciente apresenta marcadores de necrose miocárdica negativos e alterações eletrocardiográficas que não sugerem fortemente o diagnóstico de infarto. No entanto, os níveis pressóricos apresentados, uma vez que estão associados a dor torácica (lesão de órgão alvo por elevação importante da pós carga), configuram uma emergência hipertensiva com síndrome coronariana aguda sem supradesnivelamento do segmento ST (angina instável) associada. A conduta, portanto, visa a redução imediata e progressiva da pressão arterial com drogas venosas e a terapia para SCASSST, sendo Dupla antiagregação plaquetária, vasodilatador venoso (preferencialmente a nitroglicerina por não promover roubo de fluxo coronariano), morfina, anticoagulação, betabloqueador, para controle da frequência cardíaca, e estatina. A alteplase

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

(alternativa B) está contraindicada na síndrome coronariana aguda sem supradesnivelamento do segmento ST. Gabarito Alternativa A.

249193.

Comentário: De acordo com o Posicionamento sobre Antiagregantes Plaquetários e Anticoagulantes em Cardiologia - 2019 , dentre as recomendações para o manejo de paciente com necessidade de anticoagulação oral submetidos à intervenção coronária percutânea estão (tabela completa em anexo) Letra A Quando houver alto risco isquêmico e também alto risco hemorrágico, recomenda-se que se use tripla terapia por, no máximo, um mês ou inicie-se diretamente dupla terapia com anticoagulante e clopidogrel. CORRETA Letra B O uso de inibidores de bombas de prótons como profilaxia de úlcera de estresse nesse grupo de pacientes deve ser considerado como primeira escolha devido ao risco elevado de sangramento gastrintestinal. INCORRETA Letra C A descontinuação do tratamento antiplaquetário deve ser considerada após 12 meses. CORRETA Letra D A avaliação da necessidade de manutenção da anticoagulação e o cálculo do risco de sangramento devem ser realizados em todos os pacientes através dos escores de CHA2DS2-VASc e HAS-BLED, respectivamente. CORRETA Resposta letra B.

249399.

Comentário: A Sociedade Brasileira de Pediatria, a alguns anos, lançou um documento intitulado como Promoção da Atividade Física na Infância e Adolescência, o qual apresenta uma série de orientações quanto ao tempo, o tipo de atividade e os cuidados que devem ser feitos relativos a atividade física. No que refere-se a hidratação, recomenda-se que a criança seja hidratada durante o exercício, com água livre a cada 20 minutos na primeira hora de atividade física e depois desse período, alternar água com repositores hidroeletrolíticos. Logo, a única alternativa correta é a letra C, pois ela especifica a necessidade de água a cada 20 minutos. Resposta letra C.

215198.

Comentário: Questão mal elaborada.Enunciado confuso e alternativas que foram claramente copiadas e coladas da conclusão de um estudo. A banca não menciona qual estudo em questão se trata, mas pede para o candidato marcar a alternativa correta (apesar de tentar confundir ao dizer

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Não podemos concordar...). Ela cita um estudo que comparou AAS vs Clopidogrel em pacientes com risco de isquêmia , e diz de um jeito não muito claro que o clopidogrel foi superior por apresentar redução significativa de internações. As alternativas que seguem só poderiam ser analisadas em posse do artigo, portanto essa questão deveria ser ANULADA. Alternativa liberada pela banca LETRA C.

215272.

Comentário: Como sabemos, na profilaxia secundária de eventos cardiovasculares, ou seja, após eventos como IAM e AVC, encontra-se recomendado o uso de antiagregantes plaquetários, visto que eles reduzem a recorrência de eventos. O antiplaquetário com melhores resultados e com menor taxa de eventos adversos é o AAS, que pode ser substituído pelo clopidogrel ou pelo ticagrelor em casos específicos de intolerância ao uso da primeira droga. Gabarito alternativa A.

212227.

Comentário: A maioria dos ensaios clínicos sugerem o uso de IECA ou de BRA no intervalo de 1 a 16 dias após o episódio de IAM por serem drogas capazes de melhorar a fração de ejeção ventricular até o primeiro ano de tratamento e de diminuir a toxicidade da angiotensina II nos cardiomiócitos. Acontece que existem certas contraindicações no contexto de um paciente que infartou que incluem história de alergia ou angioedema associado ao IECA, hipotensão (PA sistólica 90-100 mmHg ou queda da PA sistólica de base em valor maior ou igual a 30%), gravidez, hipercalemia 5,5 mEq l, choque, estenose de artéria renal bilateral ou histórico de piora da função renal após a introdução dessa droga. Úlcera péptica em atividade e hemofilia contraindicam o uso de AAS (LETRAS A e C INCORRETAS) enquanto o uso de inibidores da fosfodiesterase nas últimas 24h contraindica a prescrição de nitratos (LETRA E INCORRETA). Os betabloqueadores não devem ser utilizados em pacientes com asma ou DPOC grave (LETRA B INCORRETA). Gabarito letra D

183029.

Comentário: A educação da população é essencial para redução da mortalidade nos casos de morte súbita, especialmente relacionados a fibrilação ventricular. Nesse sentido, o treinamento

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

DIFUSO da população, e não restrito, torna-se essencial, podendo ser realizado através de programas que promovam a informação acerca do reconhecimento dos sinais e sintomas relacionados ao infarto (principal causa de morte súbita) e as medidas iniciais a serem tomadas, ainda que por um indivíduo que não seja da área da saúde, através do BLS (Basic Life Support). Alternativa D incorreta.

182733.

Comentário: O trauma cirúrgico-anestésico, tal como qualquer outra forma de trauma, desencadeia a famosa REMIT (resposta endócrino-metabólica-inflamatória ao trauma). Logo, no período pós-operatório inicial, observamos uma situação de estresse homeostático e, consequentemente, aumento do trabalho cardíaco e do consumo miocárdico de oxigênio Coronariopatas até então estáveis podem descompensar neste momento, justamente por ser serem confrontados com um súbito e significativo aumento na demanda metabólica Assim, em boa parte dos IAM que acontecem nesse contexto NÃO HÁ ruptura da placa de ateroma, havendo apenas um grave desequilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio pelo miocárdio... Resposta certa A.

183053.

Comentário: A abordagem inicial precoce em pacientes com infarto agudo do miocárdio é essencial para que esses pacientes tenham um desfecho favorável. Porém, não existem estudos específicos que estabeleçam medidas próprias a abordagem pré hospitalar, sendo as recomendações baseadas na abordagem intra-hospitalar, uma vez que a patologia de base é a mesma. Tais medidas devem ser realizadas por profissionais capacitados, com objetivo de reduzir a morbimortalidade dos pacientes, através da implementação de medidas apropriadas. Gabarito Alternativa B.

182742.

Comentário: Vamos avaliar cada alternativa separadamente (A) Correta. O coração deve estar apto a aguentar o estresse gerado por um procedimento cirúrgico. De certo modo, o teste ergométrico também aumenta o trabalho cardíaco, simulando o efeito causado por uma cirurgia. (B) Correta. De fato, não há evidências que a estratificação cardiovascular para TODOS os indivíduos resulte na

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

redução de eventos cardiovasculares perioperatórios. Essa estratégia costuma ser reservada para doentes de alto risco ou quando a capacidade funcional estimada não é adequada para o ato cirúrgico. (C) Incorreta. Afirmativa que traz um conceito de Preventiva. Se a prevalência de uma condição é elevada em uma determinada população, o valor preditivo positivo AUMENTA, e não diminui. (D) Correta. Realmente não faz sentido solicitarmos um teste ergométrico para uma população de baixo risco. Como já mencionado, a estratificação costuma ser reservada para pacientes de alto risco Não há estudos que comprovem seu uso para todos os indivíduos. Sendo assim, a única alternativa incorreta é a opção (C).

183060.

Comentário: A administração de oxigênio na condução de pacientes com infarto agudo do miocárdio, apesar de ser utilizada rotineiramente, tem indicações precisas, que devem ser respeitadas. Dentre elas estão a saturação de O2 95%, pacientes sintomáticos (dispneicos) ou em edema agudo de pulmão. O uso indiscriminado de oxigenoterapia de forma desnecessária pode ocasionar vasoconstrição sistêmica, com aumento da resistência vascular, o que leva a redução do débito cardíaco e da perfusão coronariana, agravando o quadro desses pacientes. Gabarito Alternativa C.

182749.

Comentário: Na avaliação da doença arterial coronariana, o ecocardiograma sob estresse é um exame importante para definir alteração segmentar no esforço (alternativa C correta), não havendo diferença significativa da acurácia do teste quando empregado o estresse físico ou farmacológico com dipiridamol ou dobutamina (alternativa A correta) ou ainda em comparação com a cintilografia miocárdica de estresse (alternativa D correta). A evidência de isquemia residual em paciente com infarto do miocárdio prévio é fator de mau prognóstico, com maior probabilidade de novo evento isquêmico, morte e edema agudo pulmonar em situações de estresse (alternativa B incorreta). Gabarito Alternativa B.

183067.

Comentário: A ressonância magnética de perfusão com dipiridamol tem papel importante para

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

estabelecer acometimento perfusional em pacientes com doença arterial coronariana. Através da técnica de realce tardio é possível avaliar a viabilidade miocárdica, identificando-se áreas de necrose fibrose, uma vez que há alteração na cinética de distribuição do gadolínio nas áreas com fibrose, com uma saída mais lenta do contraste desse tecido, conhecido como realce tardio. É possível ainda avaliar a contratilidade miocárdica e as áreas de alteração segmentar contrátil. Dessa forma, tais técnicas permitem estabelecer valor diagnóstico e prognóstico em pacientes com doença coronariana. Gabarito Alternativa A.

182758.

Comentário: A angiotomografia de coronárias vem sendo utilizada amplamente na prática clínica por ser um exame de rápida realização e pouco invasivo para estratificação de doença arterial coronariana. Ela apresenta alta sensibilidade para a detecção de estenose coronariana, incluindo doença multiarterial e lesão em tronco de coronária esquerda, porém, sofre influência de fatores como a quantidade de cálcio intracoronariano, podendo resultar em resultados falso-positivos, possuindo, portanto, baixa especificidade. Nesse contexto, é um exame com alto valor preditivo negativo, ideal para os pacientes com baixa a moderada suspeição clínica, para excluir a existência de lesão coronariana obstrutiva. Gabarito Alternativa D.

182769.

Comentário: Os kits de troponina podem ser classificados em baixa (convencionais), média (contemporâneos ou sensíveis) ou alta sensibilidade. Esta classificação é baseada na porcentagem de indivíduos saudáveis em que a troponina pode ser detectada (alternativa D correta). Os diversos marcadores de necrose miocárdica possuem limites para detecção (valor mínimo que o marcador é detectado pelo método - alternativa B incorreta) e valores de referência diferentes (alternativa A correta). O valor de referência da normalidade é determinado utilizando o percentil 99, que é obtido realizando-se o exame em uma população normal e, significa que, 99% dos indivíduos normais apresentam valores abaixo deste cut-off (alternativa C correta). Gabarito Alternativa B.

182819.

Comentário: O processo inflamatório decorrente da epicardite subjacente nos ventrículos é o

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

responsável pelas seguintes alterações identificadas ao eletrocardiograma - Onda T - Na fase inicial se apresenta pouco aumentada e SIMÉTRICA. Caracteristicamente não apresenta inversão enquanto ocorrem manifestações de elevação do ST. Pode apresentar inversão na fase crônica da doença, após a normalização do ST. Quando esta ocorre, raramente é profunda o suficiente para assemelhar-se ao padrão da onda T isquêmica - Segmento ST - Elevação difusa com concavidade superior. Não ocorrem ondas Q associadas - Depressão do segmento PR. Gabarito Alternativa A.

182738.

Comentário: Pacientes dislipidemicos com síndrome coronariana aguda comumente têm seus valores de LDL reduzidos após o evento inicial, alteração que pode permanecer por até três meses. O tratamento deve ser iniciado com estatina de alta potência (atorvastatina 80 mg 1x ao dia é a droga de escolha), com o objetivo de manter os níveis de LDL abaixo de 70 mg dL, por serem pacientes de alto risco, com possibilidade de novo evento vascular. A administração da droga até 12 horas antes da angioplastia oferece benefício adicional pelo efeito de estabilização das placas. Gabarito Alternativa D.

183101.

Comentário: A inflamação do pericárdio com formação de derrame pericárdico possui múltiplas etiologias, dentre às quais estão os processos infecciosos inflamatórios, como as pericardites virais, pós manipulação por procedimento invasivo, doenças reumatológicas, especialmente as doenças do colágeno e vasculites, além de distúrbios endócrino-metabólicos que resultem em retenção hídrica, como o hipotireoidismo. Dentre as causas de pericardite e derrame pericárdico não está o diabetes insípido (alternativa C incorreta). Gabarito Alternativa C.

187849.

Comentário: Questão polêmica Vamos analisar cada alternativa separadamente (A) Correta. A posologia da aspirina citada na alternativa (200-300 mg) costuma aparecer em referências bibliográficas brasileiras devido às especificidades das formulações encontradas no nosso país. A dose de 160-325 mg também costuma ser aceita. A dupla antiagregação deve ser prescrita para todos os pacientes, inclusive para aqueles que serão submetidos à trombólise química. Nesses

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

casos, a dose de ataque do clopidogrel deve ser de 300 mg, em menores de 75 anos. (B) Correta. De fato, os betabloquedores reduzem o tônus adrenérgico cardíaco, diminuindo o trabalho do coração através do bloqueio dos receptores beta. Por conta disso, devem ser evitados quando há suspeita de choque cardiogênico. (C) Correta. Verapamil e diltiazem são boas drogas cronotrópicas e inotrópicas negativas e podem reduzir o consumo miocárdico de O2. Dessa forma, ambas podem ser utilizadas para o tratamento de uma angina refratária (em associação aos betabloqueadores ou caso haja contraindicação ao seu uso) e ou para o controle da frequência cardíaca em arritmias. É importante ressaltar que esses fármacos não devem ser usadas de rotina, já que nunca demonstraram redução da mortalidade e nem da taxa de reinfarto. Só para você saber a nifedipina é sempre contraindicada. Esta medicação provoca uma taquicardia reflexa e hipotensão. (D) Correta. Os IECA devem ser utilizados apenas se a PA sistólica for superior a 100 mmHg. Caso haja hipotensão, esses fármacos são contraindicados. O gabarito oficial da Banca havia sido a alternativa (C). Contudo, um recurso foi formulado pela equipe do MEDGRUPO e a questão acabou sendo anulada, já que todas as afirmativas são corretas.

161318.

Comentário: Questão de livro sobre doença coronariana... O AAS é o único antinflamatório indicado rotineiramente para todos os pacientes com suspeita de IAM, eventualmente como automedicação, exceto nos casos de contraindicação (alergia ou intolerância ao medicamento, sangramento ativo, hemofilia e úlcera péptica ativa). Pacientes com maior risco de doença coronariana devem ser instruídos por seus médicos assistentes a tomar Ácido Acetilsalicílico (AAS) NÃO tamponado em situações emergenciais. É o antiplaquetário de eleição a ser utilizado no IAM, que reduz a mortalidade em 23%. A dose recomendada é de 160 mg ao dia a 325 mg a ser utilizada de forma mastigável quando do primeiro atendimento, ainda antes da realização do ECG. Resposta A.

161275.

Comentário: A presença de dor torácica com supradesnível do segmento ST em parede inferior sugere fortemente a hipótese de infarto agudo do miocárdio em parede inferior... Ausculta cardíaca e pulmonar fazem parte da classificação de Killip, que classifica este paciente quanto ao

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

prognóstico. O IAM de VD associado, não raro no IAM de parede inferior, também piora o prognóstico. Por fim nos resta o local da dor torácica, que em nada influencia na mortalidade. Resposta D.

161325.

Comentário: Em relação aos betabloqueadores, devemos marcar a correta. Na ausência de contraindicações, essa classe de medicamentos deve ser iniciada, de preferência por via oral, após a admissão do paciente. Todavia, a utilização de betabloqueador endovenoso deve ser feita com critério, tendo em vista o risco de choque cardiogênico após a administração de betabloqueador endovenoso. A recomendação atual é de se utilizar o betabloqueador por via oral nas primeiras 24 horas, reservando-se a via endovenosa para casos selecionados, como em pacientes hipertensos e taquicárdicos. Recomenda-se iniciar o betabloqueador e titular sua dose para um alvo de 60 batimentos por minutos. Pacientes com contraindicação para o uso precoce dos betabloqueadores devem ser reavaliados para candidatos a essa terapia na prevenção secundária. Resposta A.

158813.

Comentário: O autor floreia com um caso clínico completinho, mas no final faz uma pergunta bem direta Em nosso meio a tuberculose é a principal causa de pericardite constritiva. Infelizmente, o tratamento com RIPE não previne essa evolução. Todas as outras alternativas também podem determinar a ocorrência de pericardite constritiva, mas somente a letra A tem a principal.

161208.

Comentário: De acordo com as diretrizes brasileiras, o paciente com infarto agudo do miocárdio (IAM) deve receber suplementação de oxigênio quando a saturação de O2 for inferior a 94% e ou na presença de sinais clínicos de hipoxemia arterial - opção (A) incorreta. A dor decorrente dessa condição promove um aumento do tônus simpático, justificando a utilização de drogas analgésicas. O analgésico de escolha é o sulfato de morfina, que deve ser administrado pela via intravenosa na dose de 2-4 mg, diluída, podendo ser repetida em intervalos de 5-15 minutos - opção (B) incorreta. Os nitratos costumam ser indicados pela via intravenosa - opção (D) incorreta. De fato, os AINES não devem ser utilizados nesses indivíduos. Alguns estudos demonstraram aumento do risco de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

morte, reinfarto e outras complicações relacionados ao uso dessas drogas. Por outro lado, o AAS é indicado - opção (C) correta. Resposta (C).

161126.

Comentário: Como sabemos, a analgesia constitui importante pilar do tratamento das síndromes coronarianas agudas. O estímulo simpático provocado pela dor aumenta o consumo de oxigênio e o trabalho do coração, agravando a isquemia. Por isso, o controle álgico é tão importante. Segundo as diretrizes brasileiras de síndrome coronariana aguda, o sulfato de morfina é a droga de escolha e deve ser administrada pela via intravenosa. A dose inicial é de 2-8 mg, podendo ser repetida a cada 5-15 minutos. Um dado interessante que foi relatado recentemente é que a atividade do plasugrel e do ticagrelor pode estar diminuída em pacientes que receberam esse opioide. Caso a morfina não esteja disponível na unidade hospitalar, podemos prescrever o sulfato de meperidina, em doses fracionadas de 20-50 mg. Dessa forma, a única alternativa correta é a opção (C).

161136.

Comentário: Apesar da ausência de benefícios em termos de mortalidade, os nitratos são drogas amplamente utilizadas para o alívio da dor isquêmica. O tratamento inicial da angina pode ser feito com nitratos sublinguais na dose de 0.4mg, de 5 em 5 minutos, por um total de três doses. Caso o paciente apresente dor refratária ao uso de nitratos sublinguais, aí sim, utilizamos a nitroglicerina venosa (A incorreta). Através do seu efeito venodilatador, os nitratos diminuem a pré carga, reduzindo a pressão capilar pulmonar, efeito bastante útil nos casos de congestão pulmonar. Semelhantemente, a vasodilatação arterial resulta na queda da pressão arterial (B correta). E por falar em efeito hipotensor, os nitratos estão contraindicados em pacientes com pressão arterial sistólica menor que 90mmHg ou 30mmHg abaixo da linha de base (C incorreta). Apesar da estreita relação entre o infarto de parede inferior e o infarto de ventrículo direito (VD), os nitratos estão contraindicados apenas no infarto de VD (D incorreta). Resposta B

152657.

Comentário: O gabarito inicial da banca havia sido a letra B... Sabemos que a angina de Prinzmetal , também conhecida como angina vasoespástica , representa um tipo especial de angina em que

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

não necessariamente existe uma placa aterosclerotica severamente obstrutiva em uma coronária epicárdica - o que acontece nesses casos é que existe disfunção endotelial focal importante, gerando contração da musculatura lisa vascular e consequente estreitamento transitório da coronária, a ponto de causar isquemia sintomática ou até mesmo infarto, em alguns casos. No entanto, o conceito de angina instável é mais genérico, englobando a situação em que uma placa de ateroma se rompe e gera obstrução parcial e progressiva do lúmem coronariano, podendo evoluir com infarto sem supra ou com supra de ST, dependendo do grau dessa obstrução. Logo, não há uma resposta conceitualmente correta aqui, e essa questão - bastante sem sentido, diga-se de passagem - foi devidamente ANULADA pela banca após os pedidos de recurso.

161400.

Comentário: Vamos retirar um trecho da I Diretriz Sobre Aspectos Específicos de Diabetes (Tipo 2) Relacionados À Cardiologia A frequência de hipertensão mascarada pode ser maior no DM do que em indivíduos sem DM, e a incidência de desfechos cardiovasculares é maior nesses pacientes, quando não tratados (A CORRETA). A ausência de controle da HAS em pacientes com DM também está associada a uma significativa carga de doença nesses indivíduos, com uma fração de risco atribuível na população de cerca de 28%. A apresentação clínica da DAC pode ser dor anginosa típica ou atípica, mas a ausência de sintomas é frequente (55% dos pacientes com DM) - B INCORRETA . Além disso, a DAC nesses pacientes tem pior prognóstico, com menor sobrevida em curto prazo, maior risco de recorrência e pior resposta aos tratamentos propostos (C CORRETA). A letalidade do infarto agudo do miocárdio (IAM) em pacientes com DM é duas vezes maior do que naqueles sem DM, em razão da maior frequência de complicações como IC, reinfarto e morte súbita (D CORRETA). Como o enunciado deseja o gabarito INCORRETA, nossa resposta é a letra B.

161194.

Comentário: O impacto estatístico de um Eletrocardiograma (ECG) executado no local de atendimento inicial do IAM (ou seja no momento bem precoce do atendimento e que permite diferenciar entre as síndromes coronarianas com e sem SUPRA de ST) é a redução da mortalidade

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

intra-hospitalar em pacientes com IAMCST pois conseguimos realizar imediatamente a terapia de reperfusão primária com trombolíticos ou angioplastia. Portanto, o nosso gabarito é a letra D.

161412.

Comentário: Vamos lá De fato, a maioria das doenças cardiovasculares (DCV) possui relação com o estilo de vida. Contudo, os fatores fisiológicos e bioquímicos NÃO modificáveis (como os genéticos) não costumam apresentar uma relação tão estreita - opção (B) incorreta. Embora a conscientização da população sobre a prevenção das DCV tenha aumentado, a incidência dessas condições continua aumentando, assim como seus fatores de risco - opção (D) correta. A reabilitação cardiovascular reduz a morbidade desses pacientes, principalmente os de alto risco cardiovascular - opção (C) correta. De fato, a aterosclerose é um processo lento cujas manifestações clínicas podem só aparecer quando ocorre obstrução ao fluxo sanguíneo de um determinado vaso - opção (A) correta. Sendo assim, a única alternativa incorreta é a opção (B).

134813.

Comentário: O enunciado se refere ao fenômeno de taquifilaxia , comum com o uso prolongado de nitratos. A base biológica da taquifilaxia aos nitratos é a indução de enzimas endoteliais que metabolizam a droga. Resposta certa C.

134119.

Comentário: Esse valor pode variar em algumas publicações, mas a V Diretriz Brasileira da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnível de ST de 2015 (super atual) recomenda que pacientes com saturação de oxigênio 94% recebam oxigenioterapia suplementar. Vamos ler trecho desta É recomendável a monitorização da saturação sanguínea de oxigênio (pela oximetria de pulso), devendo os pacientes que apresentam hipoxemia arterial clinicamente evidente ou documentada (saturação de O2 94%) receber suplementação de oxigênio por máscara ou cateter nasal (2 a 4 L min). Em valores acima de 94% devemos evitar suplementação de O2 pelo risco de aumento da resistência vascular periférica com queda no débito cardíaco. Alternativa B está correta.

134804.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: DII, DIII e aVF são derivações que olham a PAREDE INFERIOR. O infarto de VD comumente se associa ao infarto inferior, pois ambos são irrigados pela mesma artéria a coronária direita Ora, mas para confirmar que existe IAM de VD concomitante, é preciso demonstrar o supra de ST em outras derivações V2R e V3R (que, vale lembrar, sempre devem ser realizadas em pacientes que apresentam IAM inferior) - A, B e C erradas. Os nitratos são drogas vasodilatadoras que exercem ação predominante em grandes vasos venosos de capacitância (basicamente, a veia cava inferior). Logo, são drogas que reduzem o retorno venoso e a pré-carga do ventrículo direito Na vigência de IAM de VD, o débito cardíaco passa a depender criticamente da pré-carga desta câmara... Por definição, todo IAM de VD compromete a função sistólica do VD Logo, na vigência de IAM de VD os nitratos são CONTRAINDICADOS, pelo risco de induzir choque cardiogênico. Ora, como já dissemos, nem todo IAM inferior se acompanha de IAM de VD. Assim, somente na coexistência desses dois tipos de infarto é que os nitratos serão contraindicados... IAM inferior isolado não contraindica nitrato, logo, a princípio não temos uma contraindicação formal aos nitratos neste paciente... Resposta certa D.

134033.

Comentário: Relembre, com auxílio da tabela a seguir, as CONTRAINDICAÇÕES aos nitratos nas síndromes coronarianas agudas. Perceba que, ainda que o infarto de VD comumente se associe ao infarto de parede inferior (D2, D3 e aVF), este último, por si só (isto é, sem infarto de VD associado) não contraindica o uso de nitratos... Resposta certa D.

131404.

Comentário: Os fatores de risco para doença coronariana são os fatores de risco para aterosclerose de um modo geral. Os CLÁSSICOS são (1) HAS (2) DM (3) tabagismo (4) obesidade (5) sedentarismo (6) história familiar positiva (7) hipercolesterolemia. Existem outros, é claro, mas o fato é que para acertar a questão bastava perceber que VARIZES DE MEMBROS INFERIORES são um sinal de insuficiência venosa crônica, o que, apesar de ser igualmente comum e com frequência coexistir no portador de doença coronariana, não tem nenhuma relação direta com aterosclerose. Resposta certa B.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

110052.

Comentário: Os anti-inflamatórios não esteroidais são medicações contraindicadas em pacientes que infartaram, principalmente os inibidores seletivos da COX-2, uma vez que aumentam o risco de infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca, insuficiência renal e hipertensão arterial. A terapia medicamentosa do IAM envolve drogas antiplaquetárias, como o AAS, e nos pacientes vítimas de IAM com supra de ST associaremos um inibidor do receptor P2Y12, como o Clopidogrel. Resposta, portanto, opção C.

110598.

Comentário: A pergunta não foi bem formulada e dá a entender que alguma das drogas listadas é contra-indicada na dissecção aórtica, no entanto, o que o autor quer saber é qual delas não traz benefício para o tratamento da dissecação aguda de aorta. Diante deste quadro, devemos controlar de forma emergencial, frequência cardíaca e pressão arterial para reduzir a propagação da dissecção. A pressão deve ser mantida em torno de 110 x 60 mmHg. Há preferência pela administração de medicamentos parenterais, como nitroprussiato do sódio, labetalol e esmolol, mas drogas orais podem ser utilizadas na indisponibilidade destas, como o captopril. O controle da dor é essencial, pois o estímulo adrenérgico pode perpetuar a hipertensão, devendo-se optar pelos opióides para adequada analgesia. Os nitratos possuem ação essencialmente venodilatadora e, por isso, possuem pouco espaço neste cenários. Letra D é o gabarito.

110608.

Comentário: O conceito mais aceito para a definição de Síndrome metabólica é proposto pelo National Cholesterol Education Program - ATP III. De acordo com este, na presença de três dos cinco critérios o paciente é classificado como portador de síndrome metabólica. S o eles Circunferência abdominal -Mulheres 88 cm -Homens 102 cm Pressão arterial sistólica 130 ou diastólica 85 mmHg Triglicerídeos 150 mg dl HDL-Colesterol -Mulheres 50 mg dl -Homens 40 mg dl Glicemia de jejum 100 mg dl Nenhuma resposta está perfeita. Mas a que melhor se encaixa no conceito é a letra A.

86610.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Vamos às assertivas I - Existem duas célebres contraindicações ao uso de nitratos em pacientes com infarto agudo do miocárdio uso de drogas para disfunção erétil, da clase dos inibidores da fosfodiesterase e infarto de ventrículo direito. Correta . II - As tienopiridinas, como é o caso do clopidogrel, inibem a agregação plaquetária de forma irreversível, diferentemente de drogas mais modernas, como o ticagrelor, cujo efeito inibidor do ADP é reversível. Correta. III - Quando temos um paciente intoxicado por cocaína, evoluindo gravemente com infarto agudo do miocárdio, temos que ter em mente que o uso dos betabloqueadores, num primeiro momento, é CONTRAINDICADO. Lembremos que os receptores beta na parede dos vasos, ao serem ativados, conferem estímulo vasodilatador e os receptores alfa, vasoconstrictor. Quando bloqueamos seletivamente os receptores beta, o doente fica com estímulos apenas vasoconstrictores, piorando a hipertensão. Correta. Resposta certa letra E.

86869.

Comentário: Se o paciente tem ereções matinais fisiológicas, isso significa que sua capacidade de produzir ereção peniana encontra-se preservada, ou seja, em face da história de disfunção erétil desencadeada por ansiedade, é muito provável que se trate de uma impotência psicogênica , sem substrato anatomopatológico e, portanto, sem necessidade de medicações específicas a princípio (melhor do que prescrever drogas que podem complicar o manejo da doença coronariana aguda, como é o caso dos inibidores da fosfodiesterase, idealmente devemos tentar uma abordagem psicoterapêutica ou comportamental da disfunção sexual). Evidentemente, se o paciente tem história de angina instável e FA crônica sem tratamento, estas serão as prioridades da abordagem clínica, pois são doenças graves potencialmente ameaçadoras à vida. Como a FA tem mais de 48h de duração antes de tentar a cardioversão é preciso anticoagular o doente, idealmente realizando exames como o ecocardiograma transtorácico para pesquisa de trombos intra-atriais. Sendo assim, resposta certa D.

49614.

Comentário: Questão controversa. Alguns distúrbios arrítmicos como extrassístole ventricular e TV monomórfica não sustentada não são nem tratadas. Casos de TV monomórfica sustentada e FV

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

devem ser tratadas preferencialmente com amiodarona. As novas recomendações de 2010 fornecem uma recomendação fraca para o uso da lidocaína nas arritmias ventriculares, devendo ser considerada apenas em situação onde a amiodarona não estiver disponível. Ou seja, a resposta mais adequada seria a letra D, embora o gabarito liberado tenha sido a alternativa A.

176046.

Comentário: Dor torácica aguda supra de ST 0.1 mV em duas ou mais derivações contíguas IAMST. As precordiais direitas (V3R, V4R, V5R etc.) topografam a lesão na parede do ventrículo DIREITO Se existe supra de ST, isso significa que a coronária está fechada, logo, é preciso abri-la o quanto antes. O método preferencial é a angioplastia primária, mas podemos utilizar trombolíticos em seu lugar, desde que não existam contraindicações. O fato é que no tratamento de suporte existem algumas limitações quando se trata de infarto de VD, por exemplo drogas que reduzem a PRÉ-CARGA ventricular são contraindicadas Isso porque no IAM de VD o débito cardíaco se torna criticamente dependente da pré-carga do ventrículo direito, a qual, por sua vez, depende diretamente do retorno venoso. Logo, otimizar o retorno venoso e a pré-carga de VD são medidas cruciais nestes casos, sendo mandatório expandir a volemia com infusão de salina intravenosa, ao mesmo tempo em que é proibido utilizar nitrato. Resposta certa A.

129756.

Comentário: A presença de acidente vascular hemorrágico em qualquer data prévia é uma contraindicação absoluta à terapia fibrinolítica. Outras contraindicações absolutas aos fibrinolíticos no infarto agudo do miocárdio são lesão vascular cerebral estrutural conhecida (ex. MAV) neoplasia intracraniana maligna conhecida (primária ou metastática) AVE isquêmico há menos de 3 meses suspeita de dissecção aórtica sangramento patológico ativo (menstruação não é patológico) ou diátese hemorrágica trauma facial ou TCE significativos há menos de 3 meses cirurgia intracraniana ou intraespinhal há menos de 2 meses hipertensão grave não controlada e não responsiva ao tratamento de emergência e para a estreptoquinase, tratamento prévio com a droga há menos de 6 meses. Resposta D.

129770.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Paciente de risco razoável (homem com mais de 50 anos) com queixa clínica altamente sugestiva de angina pectoris (DAC crônica estável). Este paciente, segundo a literatura, têm indicação de teste provocativo, e o teste de escolha para a maioria das situações (por ser barato, de fácil realização e amplamente disponível) é o teste ergométrico (teste da esteira). Sua sensibilidade diagnóstica gira em torno de 70%, isto é, ele confirma o diagnóstico na maioria das vezes, o que torna os demais testes provocativos (como eco-stress e cintilografia com estresse farmacológico mais caros e menos disponíveis) opções de segunda linha, ou reservadas para os casos em que o TE não pode ser feito ou tem resultados inconclusivos. Vale lembrar que além do diagnóstico os testes provocativos também são úteis na avaliação prognóstica da DAC crônica quanto maior a área isquêmica, maiores serão as repercussões detectadas e, por conseguinte, pior o prognóstico, já que na eventualidade de um infarto miocárdico a área infartada será muito grande, acarretando maior morbimortalidade (ex. maior chance de ICC, arritmias, choque cardiogênico, complicações mecânicas). Resposta certa A.

107601.

Comentário: Vamos recordar as contraindicações absolutas ao uso de trombolítico no IAM com supra de ST. Reveja a tabela a seguir (VER IMAGEM) Logo, resposta certa D.

107951.

Comentário: A resposta mais completa aqui é a letra D. Veja bem estamos diante de uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST (a princípio uma angina instável , já que ainda não temos a curva de marcadores de necrose miocárdica que pode estabelecer se houve ou não IAM nesses casos). A paciente apresenta dor torácica anginosa recorrente, acompanhada de alterações isquêmicas dinâmicas no eletro (isto é, alterações sugestivas de isquemia que aparecem somente na vigência de dor, desaparecendo junto com esta). Ora, a questão quer saber a melhor abordagem INICIAL (o que você deve fazer AGORA). Repare que, com os dados fornecidos, não temos como fazer uma estratificação precisa do risco. Dito de outro modo, no momento da avaliação que está sendo fotografado pela questão não temos como definir se a paciente deve ou não ir para o CATE nas próximas horas Logo, não se preocupe com isso, e sim, como já dissemos,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

apenas com a conduta inicial que deve ser tomada de forma genérica em todos as situações de SCA sem supra de ST (tanto os que vão para o CATE quanto os que não vão). Pois bem, sabemos que o primeiro passo após o diagnóstico de SCA consiste na pronta administração de terapia antiplaquetária, de preferência tratamento duplo (AAS clopidogrel). Existem fortes evidências de benefício com tal conduta na literatura. O paciente também deve ser anticoagulado, e a droga de escolha é a enoxaparina (uma heparina de baixo peso molecular feita na dose de 1 mg kg de 12 12h sem necessidade de monitoramento do PTTa). Faremos também nitrato , haja vista que a dor foi responsiva a este medicamento e faremos ainda um betabloqueador, de preferência uma droga seletiva para o bloqueio beta-1, como o metoprolol (objetivo controle de frequência cardíaca a fim de reduzir o consumo miocárdico de oxigênio). A suplementação de oxigênio é relativamente controversa sem dúvida ela está indicada se o paciente apresentar dessaturação arterial ou dispneia, no entanto, aceita-se que o O2 seja ministrado de forma genérica a todos os portadores de SCA durante as primeiras 6h de atendimento, podendo-se suspender o O2 após esse período caso não existe alguma indicação obrigatória para o seu uso. Na letra A ele fala em dalteparina, o que é inadequado. Na letra B ele fala em tirofiban, cuja indicação formal seria a presença de infarto confirmado. Na letra C ele fala em bloqueador do cálcio, o que só vai ser feito em casos de angina refratária aos nitratos e betabloqueadores, ou nos casos em que existe contraindicação aos betabloqueadores. Resposta certa D.

103816.

Comentário: Vamos analisar as assertivas dessa questão sobre o IAM Letra A incorreta Uma das drogas empregadas no arsenal terapêutico do IAM são os betabloqueadores, que atuam reduzindo a frequência cardíaca, a pressão arterial e a contratilidade miocárdica, diminuindo, assim, o consumo de oxigênio pelo miocárdio. O objetivo é manter a frequência cardíaca ao redor de 60 bpm. Letra B incorreta No IAM de VD é contraindicado o uso de nitratos, eles resuzem a pré-carga. Também não devem ser administrados em pacientes hipotensos (PAS 90 mmHg), com bradi ou taquicardia significativas ou que fizeram uso de inibidores da fosfodiesterase tipo 5 nas últimas 24-48h. Letra C correta Em relação à dosagem dos marcadores de necrose miocárdica para o

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

diagnóstico de IAM, os livros-texto e os principais consensos, apontam as Troponinas I e Troponina T como os marcadores mais específicos, não havendo preferência de uma em relação a outra, salvo em condições como Insuficiência Renal (quando prefere-se a troponina I). Letra D incorreta O BRE geralmente aparece em pacientes com infarto transmural, ou seja, IAM com supra de ST. Resposta, portanto, opção C.

87408.

Comentário: O infarto agudo do miocárdio decorre de uma redução crítica e aguda no fluxo de algum leito coronariano. Independente se a oclusão coronária é completa (o que corresponde ao supra de ST) ou incompleta (ausência de supra de ST), o objetivo primordial do tratamento deve ser a restauração de fluxo na artéria responsável pelo infarto, de preferência o mais precocemente possível (já que tempo é miocárdio). O benefício do tratamento é amplamente comprovado se o mesmo for iniciado nas primeiras 12h do evento. Logo, resposta certa B.

81993.

Comentário: O grande problema dessa questão é que ela se baseou numa queixa cujo diagnóstico diferencial é muito amplo - a dor torácica. Assim, há que se tomar bastante cuidado ao eleger um item que não seja capaz de se relacionar a ela. Isso porque a etiologia pode variar de condições musculoesqueléticos benignas até doenças cardíacas que ameacem a vida do paciente, como a dissecção da aorta, pneumotórax hipertensivo ou embolia pulmonar. Segundo o Harrison, dentre as causas orgânicas de dor torácica temos os distúrbios gastroesofágicos (refluxo, transtornos da motilidade esofágica, úlcera péptica e cálculos biliares) com 42% doença isquêmica do coração com 31% síndromes da parede torácica (costocondrite, dor muscular) com 28% pericardite com 4% pleurite pneumonia e embolia pulmonar com 2% ambas câncer de pulmão em 1.5% e aneurisma da aorta, estenose aórtica e herpes zoster com 1% cada. Observem que já citamos todas as opções, exceto pela letra D. Mas será que podemos exclui-lá mesmo Bom, as causas pulmonares de dor no peito têm geralmente característica pleurítica e podem estar relacionadas com os vasos pulmonares, parênquima, vias aéreas ou tecido pleural. Pacientes com BRONQUIECTASIA costumam ter como clínica principal a tosse produtiva e não são citados como grande diagnóstico

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

diferencial, mas eventualmente podem ter dor torácica como sintoma. Ou seja, certamente a melhor opção a ser marcada seria a letra D, mas não se pode dizer que a bronquiectasia também não possa levar à dor torácica.

60830.

Comentário: No IAM de VD pode ocorrer insuficiência sistólica do ventrículo direito, o que leva à dilatação desta câmara e aumento da pressão venosa central (presença de TJP a 45º, sinal de Kussmaul ou turgência jugular agravada pela inspiração profunda). Na insuficiência de VD, o débito desta câmara depende muito do retorno venoso. Após o uso de nitrato (vasodilatador que atua tanto sobre o sistema venoso quanto sobre o sistema arterial) pode ocorrer uma queda muito acentuada do retorno venoso ao coração direito, o que faz o débito do VD despencar e a pressão arterial cair, podendo levar ao choque circulatório. Como não há envolvimento direto do ventrículo esquerdo, não se espera o surgimento de congestão pulmonar (ausência de estertores na ausculta respiratória). Enfim, a hipofonese de bulhas é uma característica do tamponamento cardíaco e da DPOC, mas não do infarto de VD. Logo, resposta certa B.

46723.

Comentário: Os principais marcadores de necrose miocárdica são CK-MB e troponina, mas esta última só retorna ao seu nível de normalidade com 7-14 dias, não sendo um bom marcador para detecção de reinfarto. Para esta situação, a preferência recai sobre a CKMB, que retorna aos níveis normais em apenas 48-72h. Resposta certa letra A.

34131.

Comentário: Na vigência de necrose aguda dos cardiomiócitos (ex. IAM), certas macromoléculas intracelulares são liberadas para o interstício, os chamados marcadores de necrose miocárdica (ou enzimas cardíacas , como CK-MB e troponinas cardioespecíficas). Uma vez no interstício, tais moléculas são reabsorvidas pelo sistema linfático e aparecem na circulação sistêmica, obedecendo a uma cinética estereotipada (a chamada curva enzimática aumento e redução dos níveis séricos dentro de intervalos de tempo definidos). Se houver persistência da oclusão coronariana, o baixo (ou ausente) fluxo sanguíneo na região infartada faz com que a reabsorção linfática desses

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

marcadores seja lenta, porém, na ocorrência de reperfusão (espontânea ou induzida), o retorno precoce de circulação à área infartada faz com que a velocidade de reabsorção dos MNM seja mais rápida, gerando um pico precoce na curva enzimática Logo, a observação deste pico no monitoramento plasmático dos MNM indica reperfusão coronária. Resposta certa A.

26440.

Comentário: Questão bem mal-feita aqui... Da forma como o enunciado foi escrito, podemos deduzir que o paciente da letra B, após passadas 12 h do início do quadro clínico, também poderia ser diagnosticado com IAM diante do encontro de elevação da troponina I... Lembre-se que a troponina já pode se elevar após 3-6 h do início dos sintomas, mas após 12 h a maioria dos infartos já estará evidente Isso faz com que a questão tenha duas respostas possíveis, as letras B e D (esta última foi o gabarito oficial da banca, não modificado após os pedidos de recurso). Resposta letra D.

26612.

Comentário: A curva enzimática é um importante parâmetro diagnóstico para a injúria isquêmica das células miocárdicas. A CPK e a CPK-MB aumentam a partir de 4-6 horas do início do evento isquêmico, têm pico em torno de 24h e voltam ao normal após 36-48h. A CPK-MB não é especifica do músculo cardíaco, podendo ser encontrada em outros tecidos, tais como o músculo esquelético, intestino delgado, língua, diafragma, útero e próstata (alternativas B e C corretas). As troponinas I e T são especificas do tecido miocárdico, começam a se elevar 3-6 horas pós-isquemia, têm pico em 24h e permanecem elevadas por um longo período (até 10 dias para a troponina I, e até 14 dias para a troponina T). Alternativas A e D corretas Só nos restou a opção E... A mioglobina não é especifica para lesão do músculo cardíaco. Sua grande vantagem em relação à CPK-MB e às troponinas se deve a sua rápida cinética, podendo ser detectada apenas 1 hora após o início da isquemia, com pico em 2-4h. Esta rápida elevação pode ser utilizada na triagem do paciente com dor torácica a esclarecer. Assim, é um exame com ótima sensibilidade, porém, não consegue, de forma alguma, avaliar a extensão do infarto cardíaco. Resposta certa letra E.

26684.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: A complicação mecânica mais comum do IAM é a formação de aneurisma ventricular (10% dos casos), geralmente após infarto anterior . As principais consequências são a redução da fração de ejeção (a área aneurismática é discinética) e a propensão a arritmias. Resposta certa letra C.

7447.

Comentário: A dose crônica de AAS considerada antiplaquetária variou nos diversos estudos disponíveis na literatura entre 75 mg dia a 325 mg em dias alternados, todas mostrando excelentes resultados na prevenção secundária de eventos isquêmicos cardiovasculares Vários trabalhos mostraram redução no risco de angina instável, IAM, AVE e óbito A dose-padrão recomendada atualmente pela maioria das referência é de 100 mg dia, uso contínuo, pois apresenta a melhor relação custo-benefício. Sabemos que 300 mg de AAS são capazes de agir sobre todo o pool plaquetário circulante, enquanto a dose de 80-160 mg dia inibe os 10% de plaquetas que são produzidos diariamente. A dose de 100 mg, mantida a longo prazo, acaba resultando em proteção satisfatória por inibir gradualmente todo o pool plaquetário circulante Resposta certa letra B.

10001.

Comentário: Questão decoreba. Talvez você nunca tenha ouvido falar na classificação de Braunwald para dor anginosa. Então aproveite para conhecê-la abaixo Classe I - Angina de início recente (menos de 2 meses), freqüente ou de grande intensidade (3 ou mais vezes ao dia), acelerada (evolutivamente mais freqüente ou desencadeada por esforços progressivamente menores). Classe II - Angina de repouso subaguda (1 ou mais episódios em repouso nos últimos 30 dias, o último episódio ocorrido há mais de 48h). Classe III - Angina de repouso aguda (um ou mais episódios em repouso nas últimas 48h). Observando a classificação, vemos que a opção C é a que traz a definição de angina classe I de Braunwald

10007.

Comentário: Questão direta. A troponina I é o marcador mais específico de necrose miocárdica, o que mais demora a se elevar, e o que mais tempo leva para cair. Vamos aproveitar e rever a cinética dos diversos marcadores Mioglobina é a mais rápida de todas Aumenta em 1h após o início

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

da dor. Faz pico com 2-4h, e normaliza antes de 24h CK CK-MB aumentam após 4-6h do início dos sintomas, faz pico em 24h (pico mais precoce indica reperfusão) e normaliza após 36-48h Troponinas aumentam após 3-6h do início dos sintomas (praticamente junto com a CK), têm pico em 24h (igual à CK), mas só normaliza após 7-10 dias (troponina I) e 7-14 dias (troponina T). Logo, são os melhores marcadores para o diagnóstico retrospectivo do IAM Logo, resposta certa letra D

152293.

Comentário: Paciente com episódios dor retroesternal durando poucos minutos há cerca de 4 meses. Com ECG e marcadores de necrose miocárdica normais ainda, obviamente a principal suspeita diagnóstica não pode ser IAM, e sim angina estável. Este diagnóstico fica ainda mais provável quando observamos que há melhora da dor com nitrato. Entretanto, como diagnóstico diferencial de dor torácica mal caracterizada que melhora com nitrato, não podemos nos esquecer do espasmo esofagiano difuso, um distúrbio neurogênico generalizado da motilidade esofágica, no qual o peristaltismo normal é substituído de forma intermitente por intensas contrações não propulsivas Os nitratos relaxam a musculatura lisa, sendo drogas úteis no tratamento desses pacientes. A banca foi extremamente benevolente em considerar, entre os diferenciais, dor torácica não cardíaca . GABARITO OFICIAL angina estável E espasmo esofagiano difuso Respostas equivalentes angina estável OU Angina pectoris estável OU Angor pectoris estável Espasmo esofagiano difuso OU EED OU dor torácica de origem não cardíaca OU dor torácica não cardíaca GABARITO PÓS angina estável E espasmo esofagiano difuso Respostas Equivalentes angina estável OU Angina pectoris estável OU Angor pectoris estável Espasmo esofagiano difuso OU EED OU dor torácica de origem não cardíaca OU dor torácica não cardíaca.

152181.

Comentário: Nosso paciente apresenta um quadro de angina estável (DAC crônica), logo, sua estratificação deve ser feita, a princípio, com testes provocativos de isquemia NÃO INVASIVOS. As principais opções são (1) teste ergométrico (2) cintilografia de perfusão miocárdica sob estresse (3) eco- stress e (4) cardio-RM sob estresse. O estresse referido nos últimos três métodos pode ser o esforço físico (tal qual o teste ergométrico), ou então o estresse farmacológico (ex. dobutamina,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

dipiridamol). A banca considerou todas essas alternativas no gabarito.

152190.

Comentário: Questão anulada após a liberação da prova... Pelo que está sendo dito no enunciado, diríamos que a o objetivo da questão seria o de avaliar seus conhecimentos quanto à avaliação inicial de uma provável síndrome coronariana aguda (dor retroesternal aguda associada a dispneia e edema de membros inferiores)... Neste caso, o primeiro passo é obter um ECG de 12 derivações nos primeiros 10 min de atendimento, podendo repeti-lo a curtos períodos conforme a necessidade, aliado à solicitação da curva de marcadores de necrose miocárdica (ex. troponina no momento do exame e 6h após). Questão anulada pela banca sem uma justificativa clara. GABARITO OFICIAL ANULADA GABARITO PÓS Anulada no Gabarito Pré.

129999.

Comentário: O paciente em questão é admitido com dor torácica associada a náuseas e seu ECG nos mostra um supradesnivelamento do segmento ST em DII, DIII e aVF, o que é compatível com isquemia de parede inferior. A presença concomitante de infradesnivelamento do segmento ST em V1 e V2 fala a favor de comprometimento associado da parede posterior (o que poderia ser comprovado com a realização de um novo ECG com as derivações V7-V9). GABARITO OFICIAL infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST de parede inferior e posterior OU infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST de parede inferior e posterior OU IAMCSST de parede inferior e posterior OU SCACSST de parede inferior e posterior OU síndrome coronariana aguda com supra de ST de parede inferior e posterior OU síndrome coronariana aguda com supradesnivelamento de ST de parede inferior e posterior. Considerar, também, somente parede inferior nas possíveis respostas citadas.

130003.

Comentário: Temos um paciente com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) com supradesnivelamento do segmento ST, apresentando estabilidade hemodinâmica à admissão, vindo em boa evolução, até que após 72 horas apresentou-se SUBITAMENTE chocado e com edema agudo de pulmão (EAP estertores até ápices pulmonares e SatO2 89%). Devemos imediatamente pensar em uma

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

complicação mecânica pós IAM. Temos um sopro pansistólico alto, audível na borda esternal esquerda baixa. O mais provável é que estejamos diante de uma ruptura do septo interventricular, que manifesta-se exatamente desta forma. O sangue shuntado passa do ventrículo esquerdo para o direito, e daí aos pulmões, resultando em sobrecarga volêmica e falência biventricular. Obviamente, o exame complementar solicitado na questão é o ECOCARDIOGRAMA (ECO). O tratamento é SEMPRE cirúrgico. Na ruptura de músculo papilar o sopro também seria intenso, mas apenas sistólico, não englobando TODA a sístole, e também com EAP e choque cardiogênico. Por isso a distinção é feita apenas pelo ECO. GABARITO OFICIAL ecocardiograma transtorácico OU ECOTT OU ecocardiograma OU ECO.

130005.

Comentário: Temos um paciente pós Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) com supradesnivelamento do segmento ST, apresentando estabilidade hemodinâmica à admissão, vindo em boa evolução, até que após 72 horas apresentou-se SUBITAMENTE chocado e com Edema Agudo de Pulmão EAP (estertores até ápices pulmonares e SatO2 de 89%). Devemos imediatamente pensar numa complicação mecânica pós-IAM. Temos um sopro pansistólico alto, audível na borda esternal esquerda baixa. O mais provável é que estejamos diante de uma ruptura do septo interventricular , que se manifesta exatamente desta forma. O sangue shuntado passa do ventrículo esquerdo para o direito, e daí aos pulmões, resultando em sobrecarga volêmica e falência biventricular. O tratamento é SEMPRE cirúrgico , lembrando que medidas de suporte hemodinâmico invasivo, como o balão de contrapulsação aórtica, são extremamente úteis para tentar estabilizar o paciente até a realização da cirurgia. Na ruptura de músculo papilar o sopro também seria intenso, mas apenas sistólico, não englobando TODA a sístole, e também com EAP e choque cardiogênico. Por isso a distinção é feita apenas pelo ECOCARDIOGRAMA, já que a clínica pode ser idêntica. GABARITO OFICIAL hipótese CIV OU comunicação interventricular OU ruptura do septo interventricular. Terapia cirurgia de emergência OU cirurgia.

106529.

Comentário: Pelo escore de Framingham este paciente é considerado de baixo risco

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

cardiovascular, no entanto, percebe-se claramente que o mesmo é portador da síndrome metabólica (pelo menos 3 dos seguintes obesidade abdominal, triglicerídeo 150 mg dl, HDL 40 mg dl em homens, HAS, glicemia de jejum 100 mg dl). Ora, a síndrome metabólica pertence ao grupo dos fatores agravantes , isto é, fatores de risco cardiovascular atualmente bem estabelecidos, que não haviam sido descritos na época em que os escores validados para estimativa do risco cardiovascular foram desenvolvidos, e que portanto devem ser levados em conta na hora de estratificar o risco do paciente. Sendo o paciente de baixo risco pelo Framingham, mas possuindo pelo menos um fator agravante, o correto é reclassificá-lo na categoria de risco imediatamente acima, isto é, na realidade trata-se de um paciente de risco cardiovascular INTERMEDIÁRIO... Quais são as metas lipêmicas para esta situação Segundo os guidelines atuais, devemos buscar neste paciente (1) colesterol total 200 mg dl, (2) LDL 100 mg dl, (3) HDL 40 mg dl em homens, (4) TG 150 mg dl e (5) colesterol não-HDL 130 mg dl... Logo, o gabarito fornecido pela banca está parcialmente incorreto, já que nele consta um valor de LDL 130 e HDL 60...

49293.

Comentário: Nunca podemos nos esquecer das principais situações em que a síndrome coronariana aguda pode cursar SEM dor precordial (1) sexo feminino, (2) idade avançada, (3) diabetes mellitus , (4) insuficiência renal e (5) transplante cardíaco. Idade avançada, IRC e diabetes mellitus são fatores de risco para neuropatia sensitiva (somática e visceral) e, no transplante cardíaco, os nervos sensitivos do enxerto não são conectados ao sistema nervoso do receptor. A explicação para a menor frequência de dor em pacientes do sexo feminino com SCA não está muito clara. Logo, considerando que se trata de paciente de altíssimo risco cardiovascular, temos que pensar na possibilidade de EQUIVALENTE ANGINOSO para as queixas apresentadas. É mandatório, no mínimo, monitorar o ECG e realizar uma curva de marcadores de necrose miocárdica. Resposta A. Só uma observação não existe SÍNCOPE se o paciente não perder a consciência, portanto, a opção E estaria invalidada.

34966.

Comentário: Questão difícil e maldosa. Na avaliação pré-operatória de pacientes com elevado risco

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

cardiovascular (ex. IAM recente) que serão submetidos a uma cirurgia não cardíaca, podemos refinar a estratificação do risco de eventos adversos no período perioperatório através do cálculo do Índice de Risco Cardíaco de Goldman, veja a tabela a seguir (VER IMAGEM). Como você mesmo pode constatar somando os fatores apresentados em cada alternativa a combinação que apresenta maior pontuação no escore é aquela expressa pela letra C. Mas gostaríamos de chamar sua atenção para um importante ponto em relação a este assunto. Num coronariopata, a presença de sinais de disfunção ventricular esquerda (ex. B3 na ausculta cardíaca, que indica VE dilatado e insuficiente) representa o maior fator de risco de todos, se considerarmos cada fator isoladamente. Logo, mesmo sem ter decorado a tabela do índice de risco de Goldman, é possível perceber que a melhor resposta aqui deve ser mesmo a letra C.

34978.

Comentário: Fácil, dava pra acertar já na leitura da primeira alternativa. Sabemos que AVR é uma derivação que olha para o lado direito do coração, logo, ela não enxerga com nitidez os eventos que acontecem na parede lateral do VE (que está à esquerda). Resposta certa Letra A. (VER IMAGEM)

35014.

Comentário: Vamos aproveitar a questão para rever dois importantes conceitos sobre a fisiopatologia da isquemia miocárdica. Entre a situação normal e a evolução para infarto (irreversível) do músculo cardíaco, é possível a ocorrência de dois estados intermediários, na dependência da intensidade e duração do fenômeno isquêmico estamos falando do miocárdio atordoado e do miocárdio hibernante. Definimos isquemia como um desequilíbrio na relação oferta demanda de oxigênio de um tecido. No coração, a partir do momento em que se instala a isquemia, as funções de relaxamento contração muscular já começam a se alterar. Quando a isquemia tem duração inferior a 2min, a recuperação da função muscular é praticamente instantânea No entanto, com isquemias progressivamente mais duradouras, o tempo que leva para a recuperação da função muscular tende a ser exponencialmente mais longo, mesmo que a oferta de oxigênio tenha sido reestabelecida na íntegra. Evidentemente, se a isquemia for grave o bastante, a evolução será

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

para infarto tecidual, sendo a função da área infartada, por definição, irrecuperável. É fato bem documentado que, após isquemia de 15 minutos (desde que não tenha sido grave o bastante para gerar infarto), o miocárdio ventricular costuma levar até 6 horas para recuperar sua função contrátil de maneira completa A isso chamamos de miocárdio atordoado, ou seja, uma condição potencialmente reversível, consequente a uma isquemia não profunda e de curta duração. Quando existe isquemia leve moderada crônica, ou quando múltiplos episódios de atordoamento se sucedem, temos o que se convencionou chamar de miocárdio hibernante, uma condição em que a função contrátil do músculo cardíaco isquêmico está cronicamente abolida ou reduzida, porém, o tecido muscular permanece viável por longos períodos (ou seja, trata-se também de uma condição potencialmente reversível com a revascularização). Logo, a única alternativa que faz sentido aqui é a letra A.

34917.

Comentário: A descrição do que vem a ser uma dor torácica atípica para isquemia miocárdica, segundo o guideline AHA ACC, corresponde exatamente ao que foi escrito na letra A O fato citado pela letra B também é verdadeiro causas metabólicas de pericardite, como a uremia, por exemplo, em geral, cursam com pouca ou nenhuma dor precordial, pois a inflamação do pericárdio nesses casos se limita ao pericárdio visceral (insensível) e ao pericárdio parietal (relativamente insensível). Por outro lado, etiologias de pericardite aguda com maior potencial inflamatório local, como as pericardites infecciosas (viral, bacteriana), cursam com extensão do processo inflamatório para a superfície pleural adjacente ao pericárdio, o que justifica a maior frequência de dor torácica aguda, por vezes importante, e não raro com um caráter declaradamente pleurítico (isto é, pior à inspiração profunda). A dor torácica associada à dissecção aórtica costuma obedecer à localização da dissecção quando na aorta ascendente, predomina sobre a linha média do tórax anterior quando na aorta descendente, predomina sobre a linha média do tórax posterior (aorta torácica descendente) ou abdome (aorta abdominal). A síndrome do pânico causa ataques transitórios de pânico, de curta duração, os quais se acompanham de diversos sinais e sintomas que podem simular manifestações cardiovasculares agudas, como uma dor torácica sugestiva de isquemia miocárdica (angina). Por

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

fim, sabemos que o TEP é outra causa de dor torácica potencialmente confundível com isquemia miocárdica e, infelizmente, não raro é impossível distinguir entre essas etiologias somente pela análise das queixas do paciente (é preciso lançar mão de métodos propedêuticos complementares, como ECG e angiotomografia pulmonar). Resposta certa D.

34997.

Comentário: Estamos diante de um paciente com IAMST anterior extenso (supra de ST em DI e aVL, e V1-V6) que apresenta sinais indubitáveis de insuficiência ventricular esquerda aguda (congestão pulmonar e hipotensão arterial). Assim, logo de cara já podemos descartar as opções A, B e E, pois tanto os betabloqueadores quanto os nitratos estão contraindicados no contexto de IAM IVE grave. A letra C está errada porque a angioplastia é comprovadamente superior ao trombolítico, superioridade esta que tende a ser mais significativa quanto mais grave for o quadro clínico apresentado Num paciente com perda de grande porção de miocárdio ventricular (como no caso em questão) a maior eficácia da angioplastia em salvar o miocárdio isquêmico, em comparação aos trombolíticos, promove resultados relativamente melhores em termos de redução da morbimortalidade em curto e longo prazo. Assim, mesmo sem recordar o sistema de pontuação do TIMI-risk para IAMST, você poderia acertar essa questão ao reconhecer alternativas claramente erradas Repare que consideramos que você até poderia não saber o TIMI-risk para IAMST, mas nem passou pela nossa cabeça a possibilidade de você não saber classificar este paciente segundo Killip-Kimbal (o TIMI-risk realmente é mais complexo e não é obrigatório decorá-lo, mas a classificação de Killip-Kimbal é simples e extremamente prática, e você nunca mais deve esquecê-la). Veja as tabelas a seguir. Resposta certa Letra D.

13889.

Comentário: Questão simples...paciente que chega na sala de emergência com suspeita de IAM, além de receber tratamento imediato com AAS Nitrato SL Oxigênio Analgesia (Preferencialmente com morfina ou derivados, caso a dor não melhore com o uso do nitrato), deve-se solicitar ECG, obtido simultaneamente à coleta da HDA e à administração dos medicamentos. O tempo ideal para a realização do eletrocardiograma é de no máximo 10 minutos desde a chegada do paciente ao

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

serviço de emergência. Apesar de fundamental para o exame cardiológico e para a decisão terapêutica inicial, devemos lembrar que a sensibilidade do 1º ECG para o diagnóstico de IAM AI é inferior a 50%. Devemos ainda ter um acesso venoso e coletar sangue para a avaliação laboratorial, solicitando os marcadores de necrose miocárdica CK-MB e troponina, cuja elevação faz parte dos critérios para diagnóstico de IAM. Além disso, vale lembrar que Raio X de tórax também deve ser obtido sem prejudicar o andamento do tratamento, em tempo inferior a 30 minutos da chegada.

13890.

Comentário: Na presença de inversão de onda T ao ECG, ou o diagnóstico é angina instável ou IAM sem supra ST, estando descartada a hipótese de hipótese de IAM com supra ST. Portanto, mesmo sem elevação inicial dos marcadores de necrose miocárdica, a presença de alteração isquêmica no ECG já é indicação de internação do paciente em unidade coronariana, devendo ser iniciada toda a medicação para síndrome isquêmica aguda, com terapia anti-isquêmica agressiva. A terapia antitrombótica deve ser feita com AAS heparina ou enoxiparina clopidogrel, e a terapia antianginosa com nitroglicerina venosa betabloqueador venoso. Para definirmos o diagnóstico correto, devemos ter o resultado dos marcadores de necrose miocárdica, que devem ser colhidos de maneira seriada, nos tempos O e 8h. A elevação dos marcadores leva ao diagnóstico de IAM sem supra, e, caso permaneçam normais, o diagnóstico é angina instável. Como observamos, não há resposta correta, porém a que está menos errada e foi resposta oficial do concurso é a opção E.

281902.

Comentário: De acordo com a Diretriz Brasileira de Reabilitação Cardiovascular de 2020, na parte onde disserta sobre monitoramento Além de esfigmomanômetros e estetoscópios, há vários recursos disponíveis, como cardiofrequencímetros e aplicativos de celulares para monitoramento da frequência cardíaca (FC), glicosímetros e oxímetros digitais. Dependendo da complexidade clínica e do risco de eventos cardiovasculares desfavoráveis, é desejável o monitoramento eletrocardiográfico no repouso e durante o exercício, que pode ser obtido por equipamentos de conexão direta ao paciente ou por sistemas de telemetria, sendo de fundamental importância em

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

caso de eventos cardiovasculares a possibilidade do rápido acesso aos equipamentos, para identificação do quadro clínico e a subsequente conduta médica . Resposta letra B.

249968.

Comentário: Questão retirada, na íntegra, do Posicionamento sobre Antiagregantes Plaquetários e Anticoagulantes em Cardiologia do ano de 2019. Vamos, então, relembrar o trecho do documento que matava a questão O risco de trombose de stent em pacientes que foram submetidos à ICP (Intervenção Coronária Percutânea) com stents convencionais (metálicos) é muito mais frequente nos primeiros dias e semanas após o procedimento. (letra D - INCORRETA) Dessa forma, a dupla antiagregação plaquetária é recomendada por um mês. (letra A - INCORRETA) Com o advento dos stents farmacológicos, os stents convencionais foram reservados, idealmente, para os pacientes com risco muito alto de sangramento e que necessitam de um período mais curto (ao menos um mês) de dupla antiagregação. (letra B - CORRETA) Entretanto, no Brasil, o stent convencional metálico ainda é utilizado principalmente em serviços públicos . (letra C - INCORRETA) Resposta letra B.

181159.

Comentário: A síndrome X é uma entidade definida pela presença de angina e isquemia nos testes provocativos associados a uma coronariografia normal . É mais comum em mulheres relativamente jovens (45-55 anos), sendo considerada uma doença de bom prognóstico, apesar de seus sintomas poderem ser bastante limitantes e de difícil tratamento. Mesmo sem obstruções nas artérias, estas têm comportamento inadequado para o fluxo, tanto as epicárdicas quanto a microcirculação, o que é suficiente para provocar isquemia miocárdica (A correta). Isso pode ser verificado por meio da eletrocardiografia de esforço ou pela cintilografia de perfusão miocárdica (B incorreta). Essa síndrome é interpretada como uma doença da microcirculação coronária, devido a uma disfunção endotelial ou a alterações do tônus vascular, resultando em uma redução da oferta de oxigênio no nível celular. A explicação atual para a síndrome X é a baixa reserva coronariana secundária a uma patologia microvascular (disfunção endotelial que dificulta a vasodilatação da microcirculação letra C correta). Tais pacientes, com frequência, apresentam placas de ateroma não obstrutivas (com

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

crescimento extrínseco na parede do vaso), o que é chamado de remodelamento coronariano. Essas placas podem ser observadas, em até 60% dos pacientes acometidos, através do ultrassom intravascular coronário (D correta). O controle terapêutico da síndrome X deve ser feito preferencialmente com antagonistas do cálcio, havendo, na maioria das vezes, apenas resposta parcial. A resposta aos nitratos e betabloqueadores costuma ser insatisfatória. Os sintomas evoluem com um padrão de remissões e recidivas. Portanto, assertiva incorreta e resposta da questão letra B.

181165.

Comentário: Sabemos que a taxa de extração de O2 nas coronárias é fixa, girando em torno de 75%. Isso faz com que um aumento da demanda miocárdica, seja por aumento da frequência cardíaca ou da contratilidade, tenha que ser acompanhado por uma elevação no fluxo coronariano, que ocorre por vasodilatação. Os determinantes da oferta de O2 ao coração são exatamente o fluxo coronariano e o conteúdo arterial de O2. A Letra A está completamente errada, uma vez que traz situações que apenas elevam, e muito, a demanda miocárdica por O2, e podem precipitar insquemia e angina, mesmo sem oclusão aterosclerótica significativa. O uso de cocaina pode precipitar espasmo coronariano, inclusive com infarto agudo do miocárdio. Na hipertermia o consumo de O2 pode elevar em até 600%. Como a questão pede a incorreta, gabarito A.

181170.

Comentário: Questão sobre angina instável solicitando a alternativa errada... Vamos analisar cada uma delas A) A dor anginosa não é caracterizada por surgimento repentino. Ela ocorre de forma insidiosa, crescente, de acordo com o grau de evolução da isquemia. Por isso, desconforto repentino raramente é associado a angina - deve-se pensar em outras condições vasculares, como embolia pulmonar, ou pneumotórax. Certa. B) Uma das características da dor anginosa é sua irradiação, que pode ocorrer em direção a epigástrio, mandíbula, membros superiores ou pescoço. Certa. C) Dores localizadas em regiões de articulações condroesternais não tem origem cardíaca. Exemplo clássico é a dor da síndrome de Tietze. Errada. D) A dor torácica pode ser classificada em 3 grupos típica (ou definitivamente anginosa), atípica e dor torácica não-cardíaca (definitivamente

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

não anginosa, com características muscoloesqueléticas, por exemplo). Certa. Resposta C.

181173.

Comentário: Acerca do uso de antiagregantes plaquetários, especialmente no contexto de síndromes coronarianas, sabemos que a associação de AAS e clopidogrel possui alta eficácia na síndrome coronariana aguda, com extensa evidência na literatura (alternativa A correta). Na síndrome coronariana aguda sem supradesnivelamento do segmento ST admite-se o uso do ticagrelor em substituição ao clopidogrel devido ao seu início de ação mais rápido e maior atividade de inibição plaquetária, sem aumento significativo do sangramento (alternativa C correta). O prasugrel também possui maior taxa de inibição plaquetária e redução dos eventos isquêmicos (alternativa B incorreta), porém, de forma adversa, acaba por ocasionar maiores taxas de sangramento, o que causa restrição a sua ampla utilização na prática clínica (alternativa D correta). Gabarito Alternativa B.

181184.

Comentário: Sobre doença arterial coronariana (DAC), vejamos as alternativas A) A anamnese direcionada com características de angina estável é essencial para se diagnosticar DAC, já que esses pacientes usualmente não apresentam alterações durante o exame físico. Certa. B e D) O exame físico realizado durante episódio anginoso pode demonstrar outros sinais de doença aterosclerótica. É o caso, por exemplo, da redução de pulsos distais, o que poderia estar associado a doença aterosclerótica periférica. A existência de aterosclerose em determinado sítio aumenta a probabilidade de haver placas de ateroma em outros locais. B certa e D errada. C) O surgimento de B3 e B4 pode ocorrer por disfunção contrátil secundária à isquemia. O mesmo vale para congestão pulmonar, por exemplo. Certa. Resposta D.

181169.

Comentário: Diversos são os fatores que contribuem na gênese do processo ateroesclerótico tais como disfunção endotelial, dislipidemia, hipertensão arterial, ruptura de placas, tabagismo e eventos imunoinflamatórios (A correta) O endotélio funciona como uma barreira biológica ativa entre o sangue e os tecidos. A disfunção endotelial é um dos primeiros processos que ocorre no

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

processo de ateroesclerose e um destes eventos é o aumento da permeabilidade capilar a lipoproteínas oxidadas e mediadores inflamatórios, resultando em dano da musculatura lisa e formação de placas ateroescleróticas (B incorreta). A lesão endotelial está diretamente relacionada ao decaimento dos níveis de óxido nítrico, importante vasodilatador. As moléculas de LDL acumuladas na íntima, sofrem oxidação e expressam epítopos em sua superfície que são reconhecidos por macrófagos, resultando na fagocitose destas. Macrófagos que fagocitaram estas moléculas, dão origem as células espumosas e liberam uma série de citocinas e fatores pró inflamatórios que contribuem ainda mais para o dano endotelial (C correta). Níveis elevados de lipoproteínas resultam em maior deposição destas na parede do vaso e, consequentemente, maior formação de placas (D correta). Resposta D

181199.

Comentário: A avaliação dos pacientes com dor torácica inclui história clínica detalhada, exame físico para descartar causas não cardíacas para a dor torácica, realização de testes e procedimentos úteis para o diagnóstico e avaliação da gravidade da doença arterial coronariana (DAC). Os testes adicionais na angina estável são baseados na probabilidade de DAC significativa, sendo esta probabilidade decorrente do tipo de dor, do sexo, da comorbidade e da idade do paciente. Fatores como tabagismo (mínimo de meio maço ao dia por 5 anos ou 25 maços ao ano), colesterol total (250 mg dL) e glicemia de jejum (140 mg dL) aumentam também a chance de DAC. Outros fatores, como história familiar e hipertensão, não são fortemente preditivos. Após a probabilidade ter sido estimada, ela é categorizada como baixa, intermediária e alta, de acordo com valores estabelecidos 10 a 90% nos casos intermediários, 10% nos casos de baixa probabilidade e 90% nos casos de alta probabilidade. Gabarito Alternativa D.

181201.

Comentário: A síndrome coronariana aguda representa cerca de 20% dos atendimentos por dor torácica nas salas de emergência (alternativa A correta). Devido ao seu alto potencial de morbi-mortalidade, a investigação deve ser realizada na tentativa de confirmar ou descartar este diagnóstico para que a terapia adequada seja instituída precocemente (alternativa B correta).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Dentre os dados da história que corroboram para a confirmação diagnóstica, a característica anginosa da dor é o dado com maior valor preditivo de doença arterial coronariana (alternativa C incorreta). O exame físico não apresenta grandes alterações. Entretanto, alguns achados podem aumentar a sua probabilidade, como a presença de 4ª bulha, sopro de artérias carótidas, diminuição de pulsos em membros inferiores, aneurisma abdominal e os achados de sequela de acidente vascular encefálico. Da mesma forma, doenças não-coronarianas causadoras de dor torácica podem ter o seu diagnóstico suspeitado pelo exame físico, como é o caso do prolapso da válvula mitral, da pericardite, da embolia pulmonar, etc (alternativa D correta). Gabarito Alternativa C.

181203.

Comentário: Questão retirada, na íntegra, da I Diretriz de Dor Torácica na Sala de Emergência. Vamos, então, analisar letra por letra, aprendendo com a questão Letras A e B O eletrocardiograma (ECG) exerce papel fundamental na avaliação de pacientes com dor torácica, tanto pelo seu baixo custo e ampla disponibilidade como pela relativa simplicidade de interpretação. Um ECG absolutamente normal é encontrado na maioria dos pacientes que se apresenta com dor torácica na sala de emergência. A incidência de síndrome coronariana aguda nesses pacientes é de cerca de 5%. (letra A - CORRETA letra B - INCORRETA). Letra C e D Diversos estudos têm demonstrado que a sensibilidade do ECG de admissão para infarto agudo do miocárdio varia de 45% a 60% quando se utiliza o supradesnível do segmento ST como critério diagnóstico, indicando que perto da metade dos pacientes com infarto agudo do miocárdio não são diagnosticados com um único ECG realizado à admissão. Esta sensibilidade poderá ser aumentada para 70%-90% se utilizarmos as alterações de infradesnível de ST e ou alterações isquêmicas de onda T, e para até 95% quando se realizam ECGs seriados com intervalos de 3-4h nas primeiras 12h pós-chegada ao hospital. CORRETAS Resposta letra B.

181205.

Comentário: Questão retirada, na íntegra, da I Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia - Sobre Cardiologia Nuclear. Vamos, então, analisar um trecho da Diretriz para pontuarmos o nosso

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

conhecimento A cardiologia nuclear pode avaliar o coração enfocando os aspectos de perfusão miocárdica, integridade celular, metabolismo miocárdico, contratilidade miocárdica e função ventricular global ou segmentar . Resposta letra D.

157628.

Comentário: A questão nos traz conceitos a respeito da estratificação cardiovascular de pacientes com fatores de risco para doença arterial coronariana, algo importante para diagnosticar a doença em um estágio precoce, em que ainda não ocorreram sintomas relacionados à insuficiência coronariana (estágio subclínico). A. A síndrome coronariana aguda é a primeira manifestação da doença aterosclerótica em pelo menos metade dos indivíduos que apresentam essa complicação. Desta forma, a identificação dos indivíduos assintomáticos que estão mais predispostos é crucial para a prevenção efetiva com a correta definição das metas terapêuticas individuais. Incorreta. B. Os algoritmos citados vêm aumentando substancialmente a capacidade de identificar o risco global cardiovascular dos pacientes (ex. escore de risco de Framingham). Incorreta. C. Naturalmente, o risco global do paciente deve ser estimado pelo somatório e sinergismo dos diversos fatores individuais por ele apresentado. Incorreta. D. O escores de risco cardiovasculares têm o propósito de aumentar a acurácia na estimativa do risco, o qual pode ser subestimado ou superestimado se for calculado de modo intuitivo. Os escores de risco são geralmente construídos a partir de grandes estudos populacionais em que se tenta reduzir o número de vieses e aprimorar as ferramentas de análise, permitindo melhora de sua qualidade ao longo do tempo. Correta. Portanto, resposta certa letra D.

157671.

Comentário: O diabetes mellitus (DM), seja do tipo 1 ou 2, aumenta o risco cardiovascular tanto em homens quanto em mulheres, não só elevando a frequência de eventos, como também antecipando a ocorrência dos mesmos (A e B corretas)... A idade é fator de risco cardiovascular, sendo que nos homens considera-se aumento de risco a partir de 40 anos, e na mulher 50 anos (D correta)... O sexo, isoladamente, não é fator de risco importante, pois depende da idade do paciente. Por exemplo em homens o risco cardiovascular aumenta a partir da idade de 40 anos,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

mas em mulheres o risco só começa a aumentar após a menopausa. Na faixa etária idosa, o risco do sexo feminino se iguala ou até ultrapassa o masculino. A magnitude desse aumento, porém, não é tão significativa quanto 10x mais alto... Logo, resposta certa C.

157735.

Comentário: A letra A não faz o menor sentido, concorda Tudo o que ela fala está correto, até chegar na última frase, que se contrapõe à toda lógica anteriormente exposta... Se o eco-stress dá tanta informação diagnóstica e prognóstica, como ele não poderia ser importante para a tomada de decisões terapêuticas Ele é MUITO importante... A letra C está errada porque a acurácia do eco-stress é justamente máxima nos pacientes de média ou alta probabilidade pré-teste... A letra D está errada, pois a acurácia do eco-stress com exercício ou dobuta é muito maior que a da provocação com dipiridamol... Enfim, o correto é a letra B o eco bidimensional avalia todos os segmentos miocárdicos em tempo real, sendo importante para determinação da função contrátil global e segmentar, sendo esta última o principal parâmetro a ser avaliado na doença isquêmica do miocárdio. Resposta certa B.

157742.

Comentário: Logo de cara encontramos a resposta certa da questão, a letra A A medicina nuclear é um método NÃO INVASIVO de avaliação... As demais estão corretas (B) conceitual e correta (C) a cintilografia miocárdica possui alta sensibilidade e especificidade para doença isquêmica do miocárdio (D) o refinamento técnico da cintilografia miocárdica permite mensurar com precisão a perfusão regional e a contratilidade global e segmentar do VE, revelando o exato impacto da doença coronariana sobre a função cardíaca. Resposta certa A.

157747.

Comentário: Existem duas alternativas erradas aqui... As letras A e B estão corretas o ecocardiograma é um excelente método de avaliação da isquemia miocárdica aguda, pois as alterações da motilidade segmentar são precoces (antecendendo até mesmo as alterações eletrocardiográficas), sendo facilmente identificadas por este exame. O problema são as letras C e D alterações de motilidade segmentar podem significar isquemia aguda, quando dinâmicas (isto é,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

quando elas aparecem desaparecem em curto espaço de tempo, correlacionando-se com as queixas do paciente), mas TAMBÉM podem significar IAM prévio e fibrose, particularmente quando fixas (sem alterações evolutivas) numa área de miocárdio com aspecto atrofiado e hiperecogênico (letra C errada)... Por outro lado, a letra D comete um erro ao afirmar que o ecocardiograma em repouso é capaz de avaliar a viabilidade miocárdica... Sabemos que a avaliação de viabilidade só pode ser feita através do eco- stress , sendo a viabilidade de uma área aparentemente necrosada definida pela retomada transitória da contratilidade segmentar na medida em que doses crescentes de dobutamina são ministradas (o que mostra a existência de miocárdio hibernante naquela região). Logo, a letra D também está errada, e a questão é passível de anulação. O gabarito da banca foi a letra C.

157751.

Comentário: A angio-TC de coronárias é um exame que tem como objetivo delinear a anatomia das coronárias epicárdicas de forma não invasiva, evidenciado a presença de lesões obstrutivas e não obstrutivas, bem como anomalias anatômicas, fatores que comprovadamente se relacionam com a expectativa de morbimortalidade (C correta). Para a sua realização é necessário utilizar um tomógrafo com múltiplos canais, além de contraste iodado intravenoso. Os avanços tecnológicos têm permitido que o exame seja feito com doses progressivamente menores de radiação e contraste (A correta). Por ser não invasivo, trata-se de método que pode ser escolhido para dirimir dúvidas diagnósticas em pacientes não considerados de alto risco, servindo, nestes casos, como alternativa intermediária antes de partir para exames mais invasivos como a coronariografia tradicional (D correta). Além de seu papel no diagnóstico da doença coronariana, tal método também pode ser usado para reavaliar pacientes já submetidos à revascularização (cirúrgica ou percutânea), com o intuito de verificar a patência de enxertos ou stents (B errada)... Logo, resposta certa B.

157744.

Comentário: No teste ergométrico, o principal critério para a presença de isquemia esforço-induzida é o surgimento de infradesnivelamento do segmento ST (A correta). Quanto maior a área

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

isquêmica, maiores serão as repercussões funcionais sobre o miocárdio. A resposta hemodinâmica (ex. déficit inotrópico cronotrópico, isto é, ausência de aumento do débito cardíaco e da frequência cardíaca ao esforço, respectivamente) são parâmetros bastante significativos neste sentido, pois indicam isquemia mais extensa e, consequentemente, mais grave. As queixas clínicas (ex. dor anginosa) e a capacidade funcional (grau de esforço físico atingido) também são parâmetros importantes que refletem a adequação (ou não) do funcionamento cardíaco, estando prejudicados na vigência das isquemias mais extensas (B correta). Dispersão do QT é a diferença entre a duração do intervalo QT em diferentes derivações do ECG. Se esta dispersão for significativa (ex. 100 ms) isso é entendido com um distúrbio generalizado da repolarização ventricular, o que pode ser um sinal indireto de isquemia miocárdica (apesar de exisitirem outras etiologias possíveis, ou seja, não é uma manifestação específica de isquemia) - C correta. Enfim, todos os parâmetros que citamos se aplicam tanto ao paciente que nunca foi revascularizado quanto ao paciente que foi revascularizado... O importante é se existe ou não isquemia Resposta certa D.

157740.

Comentário: Paciente com IAMST de parede anterior sem resposta ao trombolítico, evoluindo - muito pelo contrário - com piora hemodinâmica progressiva (choque cardiogênico). Qual é a melhor conduta frente a esta gravíssima situação, segundo a literatura Ora, está mais do que estabelecido que a única chance de sobrevida desse paciente é a revascularização mecânica de resgate , lançando mão da angioplastia de resgate ou mesmo da cirurgia de revascularização miocárdica. A revascularização, evidentemente, deve ser feita o quanto antes, de preferência em tempo inferior a 180 minutos (quanto mais precoce melhor o resultado)... Se o paciente se encontra num centro médico que não dispõe desses tratamentos, a melhor conduta é tentar transferí-lo o quanto antes para um lugar onde tais tratamentos possam ser rapidamente realizados... Vale dizer que o risco da transferência de um doente como esse é sem dúvida muito grande, porém, como enfatizamos esta provavelmente será sua única chance de sobreviência, logo, qualquer esforço compensa esse risco Logo, resposta certa C.

157668.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: O supra de ST pode ser observado nas pericardites agudas. A diferença em relação à insuficiência coronariana é que no caso de pericardite aguda o supra de ST aparece em todas as derivações do ECG, sem respeitar territórios vasculares específicos (A correta). Na embolia pulmonar, a principal alteração eletrocardiográfica é a taquicardia sinusal, porém classicamente espera-se o encontro de sinais de sobrecarga do coração direito, como a famosa síndrome S1Q3T3 , que consiste no seguinte onda S em DI, onda Q e inversão de T em DIII (B correta). Nos distúrbios da calemia, a onda T acompanha o K , ou seja, na HIPERcalemia a onda T fica alta e apiculada (D correta). Nos derrames pericárdicos, o acúmulo de líquido entre o miocárdio e o saco pericárdico funciona como isolante elétrico , de modo que a amplitude dos complexos QRS DIMINUI no ECG. Logo, resposta certa C.

157670.

Comentário: O nitroprussiato de sódio é inicialmente metabolizado a CIANETO pelas hemácias. O cianeto é uma substância extremamente tóxica... Felizmente, tão logo é formado, o cianeto é convertido a tiocianato pelo fígado. Logo, é grande o risco de morte por intoxicação pelo cianeto quando o paciente que recebe nitroprussiato é portador de insuficiência hepática, sendo esta, aliás, uma importante contraindicação. Resposta certa C.

157750.

Comentário: Vamos comentar as assertivas dispostas na questão acerca do tratamento das síndromes coronarianas agudas (SCA) a)Correta Idealmente, os IECA devem ser prescritos em todas as vítimas de infarto agudo do miocárdio, visto que esta classe de drogas reduz morbimortalidade neste grupo. Se possível, a introdução deve ser realizada nas primeiras 24h, tendo maior benefícios os pacientes com fração de ejeção 40% ou sinais clínicos de ICC. b)Correta Os betabloqueadores podem ser aplicados nas SCA de forma imediato ou tardia (24h). Em virtude dos benefícios associados sempre deve ser avaliada a possibilidade do uso imediato, porém há potencial de choque cardiogênico, especialmente naqueles com FC 110 bpm, idade 70 anos e PAS ou 120 mmHG. c)Correta A ticlopidina é um antiagregante plaquetário seletivo e irreversível que atua por bloqueio a ligação induzida por difosfato de adenosina do fibrinogênio ao complexo IIb IIIa.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Possui mecanismo de ação semelhante ao clopidogrel, tendo caído em desuso em função de sua menor potência e possibilidade de causar neutropenia. d)Incorreta Nas SCA os nitratos tem capacidade de levar à vasodilatação coronariana com consequente aumento do fluxo sanguíneo coronariano, além de AUMENTAR a capacitância venosa, levando ao REDUÇÃO da pré-carga ventricular. Como consequência seus principais efeitos são como antianginoso e adjuvante na melhora da congestão pulmonar. Gabarito Letra D.

134697.

Comentário: A administração de oxigênio faz parte do protocolo inicial do tratamento das principais emergências cardiovasculares, incluindo o infarto agudo do miocárdio. O oxigênio deve ser ofertado a cerca de 4l min se o paciente estiver dispneico, hipoxêmico, tiver sinais óbvios de insuficiência cardíaca ou saturação de oxigênio 94% ou desconhecida (C correta, D incorreta). A terapia com oxigênio, quando mal indicada, pode levar a toxicidade por hiperóxia, o que inclui lesão ao parênquima pulmonar, atelectasias, hipercapnia e aumento da resistência vascular sistêmica e vasoconstricção coronariana, o que pode prejudicar o coração e favorecer a necrose miocárdica (A e B corretas). Alternativa incorreta D.

134710.

Comentário: Betabloqueadores são contraindicados no tratamento do IAMST nas seguintes situações (tabela). No caso da congestão pulmonar significativa (disfunção grave de VE), o motivo é que o efeito inotrópico negativo vai agravar o edema pulmonar. As demais drogas podem (e devem) ser usadas no tratamento do EAP cardiogênico. Resposta certa A.

139775.

Comentário: Nesse caso observamos uma paciente com fatores de risco cardiovascular que apresenta precordialgia atípica, mas que evoluiu com supra de ST em mais de 2 derivações contiguas, logo, trata-se de uma síndrome coronariana aguda com supra de ST. Portanto, devemos estabelecer o tratamento específico o quanto antes. O tratamento inclui dupla antiagregação (aspirina e clopidogrel ou aspirina e ticagrelor), terapia de reperfusão o mais rápido possível através de trombolítico ou angioplastia (dependendo do tempo porta-balão 90 min ou não), suporte de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

oxigênio se Sat 94%, controle de frequência com beta-bloqueador, controle pressórico e álgico com nitratos e anticoagulação com heparina. A prática de trombolítico seguido de angioplastia, conhecida como angioplastia facilitada não é a técnica padrão ou de escolha. Dessa forma, entre as opções da questão, a opção que inquestionavelmente terá que ser aplicada, independente da evolução do quadro clínico e da ciência dos sinais vitais da paciente no momento, é a aspirina, que está na letra C.

139786.

Comentário: Na presença de sinais de má-perfusão e congestão pulmonar, o uso de betabloqueadores está associado a um aumento de mortalidade, estando contraindicados no manejo agudo desses pacientes. Em contrapartida, uma vez o paciente adequadamente estabilizado, após intervenção coronariana percutânea, encontrando-se estável hemodinamicamente, os betabloqueadores devem ser iniciados o quanto antes. Alternativa B.

111854.

Comentário: Pacientes diabéticos podem ter apresentações atípicas de síndromes coronarianas agudas. Vejamos o nosso caso mal-estar e vômitos. O médico que atendeu o paciente da questão foi sagaz e pediu um ECG, onde confirmamos o diagnóstico de IAM com supra de ST de parede inferior (D2, D3 e aVF). Diante de um IAM de parede inferior devemos sempre solicitar as derivações adicionais V3R e V4R. Isto porque o infarto de parede inferior ocorre predominantemente por doença na artéria coronária direta. Esta artéria irriga o ventrículo direito e, nos casos de dominância direita (70% das pessoas), a porção basal do septo interventricular e as paredes posterior e inferior do ventrículo esquerdo. Em 30% das pessoas a dominância é esquerda e a irrigação de porção basal do septo interventricular e as paredes posterior e inferior do ventrículo esquerdo origina-se da artéria circunflexa (e n o da descendente anterior como sugere a letra C). Se as derivações adicionais mostrarem que também ocorreu infarto de ventrículo direito, está contraindicado o uso de nitratos, pois o VD utiliza a pré-carga para seu adequado funcionamento. Se o ECG mostrar que o IAM é exclusivamente inferior, está autorizado o uso de nitratos. Resumindo O IAM do paciente ocorreu, provavelmente, por lesão da artéria coronária direita (70%

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

de probabilidade). N o há dados para concluirmos que houve IAM de VD e, consequentemente, contra-indicarmos o uso de nitrato. Letra B é o gabarito.

111880.

Comentário: Você já deve ter ouvido falar em roubo coronariano quando estudou exames realizados com dipiridamol, pois esta droga é o melhor exemplo deste efeito. O dipiridamol bloqueia a captação celular de adenosina, aumentando seus níveis e, consequentemente, promovendo vasodilatação arteriolar coronariana. As arteríolas provenientes de coronárias epicárdicas estenosadas já se encontram dilatadas ao máximo. Desta forma, a adenosina promove vasodilataç o apenas nos vasos não isquêmicos, promovendo redistribuição de sangue de áreas isquêmicas para áreas sãs, desencadeando ou piorando isquemia miocárdica. Este é o efeito do roubo coronariano ou do Robin Hood reverso . Letra A correta.

111914.

Comentário: A questão está se referindo ao escore clínico de Killip e Kimbal, que avalia o prejuízo à função ventricular esquerda (e, consequentemente, à hemodinâmica) de pacientes que apresentam IAM com supra de ST. As letras A e B falam em ECG, o que vai contra o que está sendo perguntado (índice CLÍNICO). Observe a tabela. Resposta certa C.

111918.

Comentário: A mioglobina é uma hemoproteína encontrada no citoplasma de todas as células musculares e possui uma ascensão precoce no contexto do infarto agudo do miocárdio. Em 1-2 horas após o evento já é possível detectar seus níveis no sangue. Apesar de altamente sensível, este marcador é muito pouco específico para diagnosticar IAM, motivo pelo qual deixou de ser solicitado de rotina. A CK-MB é útil para o diagnóstico de IAM, com maior efetividade da metodologia baseada na massa do que em sua atividade. A fração B da creatinofosfoquinase associa-se mais ao tecido cerebral. A troponina é o marcador mais fidedigno para a isquemia miocárdica e sua elevação ocorre em cerca de 4-8 horas após o início dos sintomas, sendo muitas vezes o marcador mais tardio a se elevar. Gabarito letra B.

111879.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: O supradesnível de ST nas derivações D2, D3 e aVF correspondem a infarto de parede inferior. Para termos condições de respondermos adequadamente esta questão precisamos conhecer a irrigação cardíaca -Artéria descendente anterior Parede anterior e região apical do ventrículo esquerdo Septo interventricular (exceto porção basal) -Artéria circunflexa Parede lateral do ventrículo esquerdo. Em 30% das pessoas (dominância esquerda) também a porção basal do septo interventricular e as paredes posterior e inferior do ventrículo esquerdo -Artéria coronária direita Ventrículo direito. Em 70% das pessoas (dominância direita) a porção basal do septo interventricular e as paredes posterior e inferior do ventrículo esquerdo. A dominância coronariana é definida pela origem das artérias do nódulo AV e descendente posterior, que irrigam a porção basal do septo interventricular e as paredes posterior e inferior do ventrículo esquerdo. A dominância é direita em 70% dos indivíduos. Concluímos que, no infarto de parede inferior, a maior probabilidade é que a coronária direita seja a culpada. Diante de um infarto de parede inferior devemos sempre rodar as derivações adicionais V3R e V4R para avaliarmos a possibilidade de acometimento de VD, devido a irrigação do VD ter a mesma origem da parede inferior na maior parte dos casos. Quando há infarto de VD, os nitratos são contra-indicados, devido a necessidade de pré-carga para o adequado funcionamento desta câmara. O infarto de parede inferior por si não contra-indica a administração de nitratos, exceto quando há coexistência de IAM de VD. Desta forma, o gabarito é a letra C.

111892.

Comentário: Os nitratos são agentes antianginosos que podem ser usados na doença coronariana, tanto em sua forma crônica (angina estável) quanto aguda (angina instável, IAM sem supra e IAM com supra de ST). Sabemos que eles melhoram os sintomas, sem contudo, melhorar a mortalidade (B errada). Se utilizados de forma constante e prolongada, previsivelmente resultam em taquifilaxia, ou resistência ao efeito terapêutico, principalmente pelo fato de promoverem um esgotamento do óxido nítrico endotelial, cujo estoque necessita de um certo intervalo de tempo para ser regenerado (é por isso que, idealmente, a prescrição de 24h de nitrato de longa ação deve ter um intervalo de no mínimo 8-10h, sem ação da medicação). O efeito hipotensor advém essencialmente de suas

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

propriedades venodilatadoras, que reduzem a pré-carga cardíaca. Os nitratos possuem algum grau de absorção cutânea, tanto que, no passado, chegaram a ser feitos através de patches transdérmicos. Resposta certa B.

350876.

Comentário: Temos aqui paciente de 67 anos com quadro bem sugestivo de síndrome coronariana aguda, não é mesmo Além disso, o histórico de hipertensão, diabetes e tabagismo crônico só aumenta o risco de doença arterial coronariana. O eletrocardiograma realizado à chegada não mostra supradesnível do segmento ST, o que nos permite traçar o diagnóstico de síndrome coronariana aguda sem supra. Vejamos, então, as opções de manejo diagnóstico. Letra A incorreta. A dosagem de CK-MB e mioglobina até pode ter sido muito útil no passado, mas hoje em dia, a troponina é o marcador de escolha para necrose miocárdica, devido à sua maior especificidade e sensibilidade. Letra B correta. Essa é a abordagem padrão para avaliação de pacientes com síndrome coronariana aguda. O ECG é essencial para o diagnóstico inicial e deve ser repetido para acompanhar mudanças, enquanto a dosagem seriada de troponinas permite identificar a evolução do quadro, confirmando ou descartando o infarto. Letra C incorreta. O ECG de entrada pode não ser suficiente para capturar as alterações dinâmicas de evento coronariano agudo, e os outros biomarcadores mencionados não são os mais sensíveis ou específicos para o diagnóstico de infarto do miocárdio atualmente. Letra D incorreta. O tratamento invasivo percutâneo imediato nomeadamente a angioplastia primária é indicada no manejo do infarto com supradesnivelamento do segmento ST. Resposta letra B. Não cabe recurso.

199702.

Comentário: Rodapé de livro... Em certas profissões onde o trabalho do indivíduo implica potencial risco para a vida de terceiros, como é o caso dos pilotos de avião, recomenda-se utilizar no diagnóstico de doença coronariana frente a um quadro de elevada probabilidade pré-teste, como o caso em tela, partir direto para a coronariografia Afinal de contas, a coronariografia é o exame padrão-ouro para confirmar DAC, além de poder ser terapêutico, permitindo a realização imediata de angioplastia, se indicado. Nos dias de hoje este exame é feito com baixíssima

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

morbimortalidade... Muita gente pode ter ficado em dúvida com a letra C (com a letra B não dava para ficar em dúvida, pois a presença de bloqueio de ramo esquerdo inviabiliza a realização do teste ergométrico). Contudo, perceba duas coisas (1) se o eco- stress for positivo, a conduta será fazer um CATE (2) se o eco- stress for negativo, a conduta também será fazer um CATE, pois no contexto do caso, um eco- stress negativo mais provavelmente representa um falso-negativo . A profissão aqui pesa , frente ao fato de o paciente ter sintomas típicos de doença coronariana e outros critérios de alto risco (ex. morte cardíaca em familiar relativamente jovem). Neste tipo de paciente recomenda-se esclarecer logo a extensão da doença, e não perder tempo caso esteja indicado revascularizar. Resposta certa A.

172990.

Comentário: Numa paciente com fatores de risco cardiovascular (HAS e passado de tabagismo), a história de desconforto precordial e esforço induzido que melhora com repouso permite um diagnóstico clínico de angina estável até prova em contrário. Um teste provocativo encontra-se então indicado, tendo como objetivo não apenas CONFIRMAR o diagnóstico clínico, mas também e principalmente ESTRATIFICAR o risco da paciente, com base na demonstração da extensão e gravidade do processo isquêmico... O teste de escolha com este intuito é o teste ergométrico, porém, neste caso específico, há um impedimento ao uso de tal exame o ECG de base está alterado, o que dificulta a interpretação do teste ergométrico. Que tipo de alteração estamos vendo Ora, o QRS está alargado (duração 120ms, ou 3 quadradinhos), sugerindo a existência de bloqueio do sistema His-Purkinje na condução do estímulo ventricular. O padrão morfológico observado é condizente com bloqueio completo do ramo esquerdo, quer dizer, BRE de 3º grau , pois em D1 aVL e V5 V6 se observam ondas R largas, na ausência de onda q. Em correspondência a isso, existe onda S profunda de V1 a V4 (complexos rS). Neste contexto, o desnível de ST no sentido oposto ao da principal deflexão do QRS e onda T também oposta ao QRS indicam apenas o distúrbio da condução intraventricular, e não um processo de isquemia subendocárdica Diante da impossibilidade de realizar um TE confiável, a conduta é partir direto para um teste provocativo de imagem, como o eco -stress ou a cintilografia miocárdica . Neste tipo de exame as alterações

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

eletrocardiográficas de base não produzem qualquer interferência em relação à detecção de isquemia. A TC de coronárias para cálculo do escore de cálcio (que fornece um sinal indireto da existência de doença coronariana) só seria indicada se houvesse alguma dúvida quanto à possibilidade de a paciente ter ou não doença coronariana... Não há dúvida nesse sentido, pois se trata de paciente com alta probabilidade pré-teste de DAC, logo, a TC de coronárias não está indicada neste caso (se este exame vier positivo faremos um teste provocativo, e se vier negativo duvidaremos deste resultado e faremos um teste provocativo do mesmo jeito). Alguns podem ter ficado em dúvida quanto à opção de partir direto para o cateterismo cardíaco, porém, não há indicação de CAT aqui, pelo menos por enquanto O CAT estaria indicado se o quadro fosse de síndrome coronariana aguda, por exemplo (1) angina em crescendo, definida como a angina estável prévia que vem diminuindo de limiar de forma rápida (2) angina de início recente, definida como aquela de início há menos de dois meses que rapidamente atinge a classe III da CCS ou (3) angina de repouso, definida como aquela que dura 20min no repouso, de início na última semana. A princípio, esta paciente tem indicação de realizar teste provocativo para confirmação diagnóstica e estratificação do risco. Se o risco for alto (ex. área isquêmica extensa, com repercussões funcionais importantes), aí sim haverá indicação de CAT, pois o tratamento deverá incluir revascularização miocárdica. Outra situação em que o CAT poderá ser indicado é a refratariedade dos sintomas ao tratamento clínico otimizado, pois neste contexto também se indica a revascularização... Enfim, a melhor resposta aqui, sem dúvida, é a letra D

150883.

Comentário: Paciente do sexo masculino, 65 anos, com fatores de risco para doença aterosclerótica (diabetes, hipertensão, dislipidemia), com quadro de Síndrome Coronariana Aguda (SCA) clássica dor torácica precordial com irradiação para mandíbula, náuseas e diaforese (sudorese espontânea profusa). O eletrocardiograma é o grande divisor de águas nesta situação, devendo ser obtido e interpretado nos primeiros 10min do atendimento. Na questão, podemos observar elevação do segmento ST mais claramente nas derivações correspondentes à parede anterior (V1-V4), portanto, trata-se de uma SCA com supra de ST, em que ocorre oclusão total da

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

coronária acometida (no caso, descendente anterior), levando ao infarto das células miocárdicas. A conduta mais importante neste momento é a terapia de reperfusão miocárdica, sendo a intervenção coronária percutânea através da angioplastia primária (com stent) a estratégia preferencial, desde que o procedimento possa ser realizado em até 90min (ou 120min se o atendimento inicial foi em unidade sem angioplastia). A angioplastia primária melhora os desfechos, sendo também a primeira escolha de tratamento em pacientes com choque cardiogênico, IC grave e edema agudo de pulmão, como o paciente da questão . O trombolítico é tratamento de segunda escolha nesse caso (A incorreta). A cirurgia de revascularização não é habitualmente realizada no contexto agudo (C incorreta). A letra D também está incorreta, pois, como vimos, o paciente tem indicação de tratamento intervencionista Portanto, resposta correta letra B.

126996.

Comentário: Questão mal feita, mas que não podemos errar na hora da prova. Vamos entender o motivo após rever os principais níveis de prevenção de doenças A prevenção primária é o conjunto de ações que visam evitar a doença na população, através da remoção dos seus fatores causais. Ex medidas de promoção de saúde (lazer, saneamento básico, educação, etc) e proteção específica (imunização, controle vetorial, uso de equipamentos de proteção individual, etc). A prevenção secundária é o conjunto de ações que visam identificar e corrigir o mais precocemente possível qualquer desvio da normalidade, de forma a colocar o indivíduo de imediato na situação saudável. Ex testes de rastreamento de doenças. A prevenção terciária é o conjunto de ações que visa reduzir a incapacidade, para permitir uma rápida e melhor reintegração do indivíduo na sociedade, aproveitando as capacidades remanescentes. Ex terapia ocupacional, fisioterapia, etc. A prevenção quaternária é conceito de prevenção, que tem como objetivo a prevenção da iatrogenia e a prevenção da prevenção inapropriada. A questão deseja saber qual tipo de prevenção seria iniciar com a aspirina no intuito de prevenção de doença cardiovascular trata-se de uma prevenção primária pois o AAS atua antes da doença cardiovascular do paciente. Contudo, é importante o aluno entender que o paciente acima não tem indicação de iniciar AAS já que não temos dados informativos para afirmar que o paciente tem síndrome metabólica, que seria o critério

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

para iniciar o AAS. Portanto, mesmo mal feita, nosso gabarito é a letra A.

102173.

Comentário: Pelo teor das opções de resposta, fica claro que o autor está se referindo a um único aspecto da conduta que deverá ser tomada para essa doente toda mal controlada falaremos aqui somente sobre seu controle lipêmico. Pois bem, o que deve ser feito Não há indicação de fibrato, pois os triglicerídeos estão abaixo de 500 mg dl (acima de 500 mg dl e principalmente acima de 1.000 mg dl existe risco iminente de pancreatite aguda, logo, nestas situações é indicado iniciar fibrato imediatamente). Lembre-se de que não devemos combinar fibrato com estatina, devido ao elevado risco de miotoxicidade (incluindo um risco apreciável de rabdomiólise). Nossa paciente está metabolicamente fora do alvo , pois sua glicada está acima de 7%, seu colesterol total acima de 200 mg dl e seu HDL abaixo de 40 mg dl (e claro, seu triglicerídeo está acima de 150 mg dl, mas, como vimos, não há urgência em focar no controle farmacológico deste parâmetro - melhorando o resto e melhorando a DIETA, provavelmente os triglicerídeos ficarão dentro da faixa recomendada). Outro parâmetro que não foi citado, mas podemos inferi-lo é o COLESTEROL LDL (colesterol ruim). Sabemos que, em diabéticos, o LDL deve ser menor que 100 mg dl, idealmente menor que 70 mg dl, se possível (isto é, se o tratamento não for muito custoso e não trouxer importantes efeitos colaterais). Aí é que entra uma pegadinha da questão. Sabemos que existe uma fórmula para calcular o LDL a partir do colesterol total, do HDL e dos triglicerídeos trata-se da fórmula de Friedewald (LDL col total - (TG 5) - HDL). No entanto, quando o nível de TG é maior ou igual a 400 mg dl, esta fórmula não deve ser usada, pois perde sua precisão. Ora, quer dizer então que não temos como saber aqui (com os dados disponíveis) qual é o verdadeiro valor LDL da paciente A resposta é SIM, não teremos como saber. Então por que prescrever estatina Bem, em primeiro lugar, a tendência atual é que todo paciente de alto risco cardiovascular (como os diabéticos tipo 2), recebam estatina de forma rotineira. As estatinas não exercem apenas efeito hipolipemiante suas ações são pleiotrópicas , o que signfica que elas também são anti-inflamatórias e antioxidantes, trazendo um benefício genérico para a saúde do endotélio. E mais, mesmo que a questão não tenha fornecido a medida precisa do LDL (e mesmo que a fórmula de Friedewald não seja acurada

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

neste caso) é ÓBVIO que esta paciente tem o LDL aumentado (seguramente acima de 100 mg dl, haja vista que o HDL está muito baixo, as demais frações lipídicas muito altas e o contexto metabólico como um todo está desregulado). Logo, não resta dúvida além de otimizar o controle glicêmico (associando novos hipoglicemiantes orais ou introduzindo insulina) teremos que prescrever estatina para essa doente Melhor resposta B.

81249.

Comentário: Estamos diante de um paciente, com fatores de risco para doença arterial coronariana, que se apresenta agudamente com dor torácica tipicamente anginosa e sudorese, cujo traçado eletrocardiográfico evidencia um supradesnivelamento do segmento ST nas derivações DI e aVL, e também de V1-V6. Logo, estamos diante de um infarto agudo do miocárdio com supra de ST de parede anterior extensa. Sabemos que neste contexto, tanto a intervenção coronariana percutânea primária (PTCA) quanto à trombólise estão associadas a melhores desfechos clínicos, quando comparados com nenhuma terapia de reperfusão. Contudo, a PTCA quando comparada com a trombólise, promove menor taxas de óbito e de reinfarto. Assim, caso o paciente seja admitido em um centro em que a PTCA encontra-se prontamente disponível, esta deve ser a conduta de escolha. Alternativa B correta.

65777.

Comentário: Temos aqui um paciente idoso, hipertenso e diabético que apresenta uma história absolutamente compatível com a hipótese de angina estável (precordialgia em aperto aos esforços que irradia para o MSE). Seu exame físico revela a presença de hipertensão arterial sistêmica e um indício de provável lesão estrutural cardíaca podemos supor que ele é portador de cardiomiopatia hipertensiva, uma condição que cursa com hipertrofia do ventrículo esquerdo e endurecimento do miocárdio, decorrentes da HAS crônica e sustentada, alterações sugeridas pela presença de uma B4 de VE. Em suma, um paciente de alto risco cardiovascular que apresenta quadro clínico bastante característico de doença isquêmica e que, por conseguinte, possui uma elevadíssima probabilidade pré-teste de realmente ser portador de coronariopatia. O ECG em repouso mostra uma alteração inespecífica da repolarização (inversão assimétrica da onda T na parede

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

anterolateral) que apenas corrobora a impressão clínica inicial de hipertrofia do ventrículo esquerdo. Não há sinais francamente isquêmicos no ECG em repouso, o que, diga-se de passagem, está de acordo com a hipótese de angina ESTÁVEL Logo, a fim de confirmarmos este último diagnóstico, será preciso lançar mão de um teste provocativo, e o teste de escolha na prática, principalmente em pacientes com alta probabilidade pré-teste - que são aqueles com maior chance de positividade e maior valor preditivo positivo diante deste resultado - é o TESTE ERGOMÉTRICO. O teste ergométrico é razoavelmente sensível e específico, além de ser amplamente disponível e representar o método mais barato. Por tais motivos, outros tipos de teste provocativo só devem ser prioritariamente indicados na vigência de contraindicações ao teste ergométrico (ex. limitações neurolocomotoras alterações no ECG de base que prejudiquem sua interpretação, como o BRE completo), ou quando o teste apresenta um resultado suspeito de ser falso-negativo. Os testes provocativos não só CONFIRMAM o diagnóstico da doença isquêmica estável como também ESTRATIFICAM SEU PROGNÓSTICO, avaliando (direta ou indiretamente) a extensão da área isquêmica e, em alguns casos, o grau de comprometimento sobre a função cardíaca propriamente dita. Na doença coronariana ESTÁVEL, somente os indivíduos estratificados como de alto risco nos testes provocativos são referenciados para a cineangiocoronariografia, uma vez que o tratamento intervencionista (angioplastia ou cirurgia) só está indicado nos casos com maior chance de morbimortalidade cardiovascular pela doença de base Logo, melhor resposta para a questão, sem dúvida, letra A.

51199.

Comentário: Reveja na tabela em anexo os sinais de mau prognóstico passíveis de serem obtidos pelo teste ergométrico. Entenda que tais sinais refletem a existência de extensas e importantes áreas de miocárdio sob risco (isto é, na eventualidade de um infarto, as consequências serão desastrosas). Resposta certa B.

51236.

Comentário: Para uma adequada estratificação cardiovascular, inicialmente devemos avaliar quantos fatores de risco o paciente da questão apresentou. De acordo com a NCEP ATP III,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

incluem-se entre estes fatores Tabagismo HAS HDL 40 mg dl História de doença cardiovascular precoce (homem parente de 1º grau 55 anos mulher parente de 1º grau 65 anos) Idade (homem 45 anos mulher 55 anos). O paciente citado apresenta, numa primeira impressão, tabagismo e hipertensão 2 fatores. Assim, também numa primeira impressão, ele não poderia ser de RISCO BAIXO, que inclui 0-1 fator. Como tem 2 fatores, o risco é variável e a proposta é que o paciente seja pontuado de acordo com a escala de Framingham. Assim, os critérios seriam Idade 35-39 (-4 pts) Colesterol (7 pts) Tabagismo (8 pts) HDL (0 pt) PA sistólica (2 pts). Total 13 pts Risco Absoluto em 10 anos de 12%. Caso a probabilidade fosse acima de 20%, seria classificado como RISCO ALTO. Teremos então de classificá-lo como RISCO MODERADO, entre 10-15%. Mais especificamente MODERADAMENTE ALTO, de acordo com as recomendações atuais, por estar entre 10-20%. A resposta seria então a letra C. Este raciocínio, no entanto, tem um erro por uma armadilha da questão. Não se pode ainda classificá-lo como hipertenso por ter a medida apenas de uma consulta. Assim, com apenas 1 fator de risco no momento, ele seria de RISCO BAIXO. Daí a resposta oficial ser a letra B, sem que encontremos margens para elaborar um recurso. A crítica é se não posso dizer que é hipertenso, que espere até definir antes de avaliar o risco cardiovascular.

141579.

Comentário: O grande (e antigo) estudo CASS há muito já deixou claro que o sexo, a idade e a história clínica são parâmetros extremamente confiáveis para o diagnóstico de insuficiência coronariana quando a probabilidade pré-teste desta doença é não baixa existe boa correlação entre as queixas típicas, no paciente típico, e a presença de alterações na coronariografia Atualmente, o seguinte sistema é adotado devemos procurar por 3 queixas 1) Desconforto ou dor retroesternal 2) Desencadeado por esforço físico ou estresse emocional 3) Aliviado por repouso ou nitrato. A presença dos três elementos define a queixa como definitivamente anginosa . Apenas dois elementos caracterizam a queixa como provavelmente anginosa . Um ou nenhum elemento e temos uma queixa não cardíaca . Resposta certa C.

45382.

Comentário: A questão mostra uma síndrome coronariana aguda SEM supra de ST, logo podemos

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

prescrever as drogas do esquema MONAB morfina, oxigênio, nitrato, antiagregante plaquetários (AAS e clopidogrel) e betabloqueador, mas não podemos utilizar trombolítico (como alteplase, estreptoquinase), que é uma estratégia restrita às síndromes coronarianas agudas COM supra de ST. Resposta certa letra D

36982.

Comentário: Paciente com fatores de risco para coronariopatia (sexo masculino 45 anos, HAS, tabagismo, dislipidemia e obesidade) apresenta precordialgia aguda típica (em aperto, irradiada para o pescoço e acompanhada de diaforese) com alterações isquêmicas no ECG (inversão de T na parede anterior) e elevação de marcadores de necrose miocárdica (troponinas), isto é, um quadro de infarto agudo do miocárdio sem supra de ST (IAMSST). Ora, se não há supra de ST , não há indicação de trombolítico, pelo contrário os trombolíticos AUMENTAM a mortalidade de portadores de SCA sem supra de ST As demais medidas anti-isquêmicas e antitrombóticas são cabíveis. A angioplastia está indicada nos pacientes com critérios de alto risco que tenham anatomia favorável. Resposta certa C.

37383.

Comentário: Vamos de baixo para cima. O uso imediato de aspirina (2 comprimidos de AAS infantil de 100 mg mastigados e engolidos) é comprovadamente benéfico em todas as formas de SCA Sabemos que essa conduta reduz tanto a taxa de mortalidade quanto a taxa de reinfarto A heparinização, conquanto impeça a extensão e propagação dos trombos, não dissolve por si só o trombo já formado e, portanto, não constitui uma estratégia de reperfusão coronariana propriamente dita. A menstruação não contraindica trombolíticos ou heparina. Quanto mais precoce o emprego dos trombolíticos, melhor. Sabemos que passadas as primeiras 3h, o trombo coronariano fica progressivamente mais maduro , isto é, cada vez mais resistente aos efeitos da fibrinólise farmacológica (que, todavia, mantém-se comprovadamente eficaz nas primeiras 12h) Conquanto os trombolíticos possam ser usados nas primeiras 12h (ou entre 12-24h, se houver sintomas persistência de alterações dinâmicas no ECG), o maior benefício de seu uso é demonstrado nas primeiras 3h do delta T . A angioplastia é superior aos trombolíticos em todos os

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

momentos, mas sua superioridade tende a ser ainda mais expressiva quanto maior for o delta T além das 3h iniciais. Assim, resposta certa A.

37393.

Comentário: Paciente com fatores de risco para coronariopatia se apresenta à emergência com precordialgia aguda típica e ECG mostrando supra de ST na parede inferior (DII, DIII e aVF). Logo, estamos diante de um IAMST inferior, e existe indicação de terapia de reperfusão imediata, com angioplastia (de preferência) ou trombolítico Lembre-se supra de ST coronária fechada reperfusão. Desnecessário dizer que exames específicos (troponina) e inespecíficos devem ser coletados (incluindo lipidograma completo), e que os demais componentes da conduta anti-isquêmica e antitrombótica também estão indicados, mas só uma observação apesar de o enunciado citar uma FC de 115 bpm (o que contraindicaria o uso precoce de betabloqueadores, por ser um fator de risco para choque cardiogênico nas primeiras 24h), o ECG mostra uma FC diferente, com mais de 3 quadrados de distância no intervalo RR (isto é, FC 100 bpm). Logo, na realidade este paciente pode fazer uso precoce de BB Resposta certa B.

9051.

Comentário: Eis uma questão básica sobre as síndromes coronarianas agudas (SCA)... Vamos aproveitar pra rever IAM com supra e sem supra de ST são basicamente a mesma doença, porém com aspectos fisiopatológicos e terapêuticos um pouco diferentes A forma mais grave é o IAM com supra de ST (IAMST coronária epicárdica fechada e isquemia transmural), que cursa com mortalidade precoce (primeiros 30 dias) em torno de 30%. Desse total de óbitos, mais de 50% ocorrem ANTES da chegada do paciente ao hospital, geralmente por morte súbita arrítmica secundária à fibrilação ventricular (Letra A errada)... Tanto o IAMST, a angina instável (AI) e o infarto sem supra (IAMSSST) podem se manifestar com dor precordial típica em repouso, e ao contrário da angina estável, sua dor é duradoura (15 min) e tipicamente pouco responsiva ou mesmo irresponsiva aos nitratos (Letra B errada)... Quanto ao tratamento, podemos dividí-lo em 2 grandes grupos (1) angina instável IAM sem supra e (2) IAM com supra de ST. No primeiro, a idéia central consiste em evitar o fehchamento do vaso com uma terapia antitrombótica AGRESSIVA

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

(lembre-se o vaso está quase fechado nestas condições) Assim, devem-se administrar agentes antiplaquetários (AAS, clopidogrel e inibidores da GP IIB IIIA) e anticoagulantes (heparina). Além disso, de acordo com a estratégia de tratamento adotada em função do risco de eventos cardiovasculares adversos (estratégia agressiva precoce ou conservadora), podemos realizar uma cineangiocoronariografia para estudo e abordagem imediata da lesão É importante ressaltar que aqui NÃO está indicada a terapia fibrinolítica (pois ela comprovadamente aumenta a mortalidade) Já nos casos de IAM com supra de ST a conduta é, quando possível, realização de angioplastia primária ou, caso isso não seja possível nas primeiras 6 horas do evento, realização de trombólise com estreptoquinase ou rtPA. Por fim, para responder a questão você precisa lembrar que como infarto significa MORTE celular (subendocárdica no IAMSSST e transmural no IAMST) essas condições podem gerar aumento das enzimas cardíacas no sangue No entanto, tal elevação não é 100% específica... Outras condições podem aumentar os marcadores de necrose miocárdica como reanimação cardio-pulmonar, miocardite, contusão torácica, arritmias, cirurgia cardíaca, insuficiência renal crônica, embolia pulmonar... Resposta certa letra C

13441.

Comentário: Temos um paciente com importantes fatores de risco para doença coronariana chegando ao hospital 2 horas após início de precordialgia sugestiva de isquemia miocárdica Devido a certas características semiológicas da dor relatada (dor em repouso e duração 20 min), não temos como não pensar em IAM... O ECG apresenta somente alterações na repolarização ventricular de V1 a V6 (parede anterior)... Seria uma inversão de onda T A consideração mais prudente que devemos fazer, neste momento, é que o paciente apresenta uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST Mas não existe essa opção... Todavia, como ainda não houve tempo para que os marcadores de necrose miocárdica se elevem, a opção D, de fato, é a melhor a ser marcada... Este paciente deve ser internado, permanecendo monitorizado (procurar alterações dinâmicas do segmento ST-T), com coleta de curva enzimática e tratamento clínico anti-isquêmico e antitrombótico de acordo com a estratificação de risco da SCA

349738.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Questão direta que aborda as contraindicações à terapia fibrinolítica no contexto da síndrome coronariana aguda com supra de ST. Observe, no próximo quadro, as principais. Letra A incorreta. Uso crônico de AAS não é uma contraindicação. Letra B correta. Essa é uma contraindicação absoluta, pelo risco de hemorragia intracraniana. Letra C incorreta. A úlcera péptica é uma contraindicação relativa se estiver ativa seria contraindicação absoluta se estivesse sangrando. Letra D incorreta. O AVE isquêmico há mais de 3 meses é uma contraindicação relativa. Letra E incorreta. Gestação também é uma contraindicação relativa. Resposta letra B.

349712.

Comentário: De acordo o Ministério da Saúde (MS) em seu Guia de Atividade Física para a População, a intensidade do do esforço físico pode ser classificado em três tipos - Leve exige mínimo esforço físico e causa pequeno aumento da respiração e dos batimentos do seu coração. Numa escala de 0 a 10, a percepção de esforço é de 1 a 4. O paciente vai conseguir respirar tranquilamente e conversar normalmente enquanto se movimenta ou até mesmo cantar uma música. - Moderada exige mais esforço físico, faz o paciente respirar mais rápido que o normal e aumenta moderadamente os batimentos do seu coração. Numa escala de 0 a 10, a percepção de esforço é 5 e 6. O paciente vai conseguir conversar com dificuldade enquanto se movimenta e não vai conseguir cantar. - Vigorosa exige um grande esforço físico, faz o paciente respirar muito mais rápido que o normal e aumenta muito os batimentos do seu coração. Numa escala de 0 a 10, a percepção de esforço é 7 e 8. O paciente não vai conseguir nem conversar enquanto se movimenta. Para pessoas de 6 a 17 anos, as orientações do MS são praticar 60 minutos ou mais de atividade física por dia. Deve-se dar preferência para aquelas atividades que façam a respiração e os batimentos do coração aumentarem. Nessas atividades, o paciente vai conseguir conversar com certa dificuldade enquanto se movimenta e não vai conseguir cantar. Como parte desses 60 minutos ou mais por dia, o paciente deve incluir, em pelo menos 3 dias na semana, atividades de fortalecimento dos músculos e ossos, que envolvam movimentos como saltar (como pular corda), puxar ou empurrar (como cabo de guerra). Só por curiosidade, em adultos , o tempo mínimo para as atividades físicas moderadas, é de, pelo menos, 150 minutos de atividade física por semana. Já

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

para as atividades físicas vigorosas, o tempo é de, pelo menos, 75 minutos de atividade física por semana. Sendo assim, vamos analisar as assertivas. Letra A incorreta. Não são essas as recomendações descritas pelo MS. As atividades lúdicas e recreativas podem estar incluídas, porém é importante acrescentar atividades de fortalecimento dos músculos e ossos, como descrito acima. Letra B correta. Como vimos, o tempo diário indicado é de 60 minutos ou mais, de atividades que correspondem a um esforço físico, pelo menos, moderado (o paciente vai conseguir conversar com certa dificuldade enquanto se movimenta e não vai conseguir cantar). Letras C, D e E incorretas. O tempo mínimo é de 60 minutos dia. Resposta letra B.

337517.

Comentário: Paciente idoso que perdeu a consciência certamente o eletrocardiograma será de grande ajuda para elucidação diagnóstica Repare como temos supradesnivelamento do segmento ST em V1, V2, V3, V6, D1 e aVL, o que denota um infarto que pegou parede lateral e parede anterior. Note ainda o infra de ST em DII, DIII e aVF trata-se de uma imagem em espelho do supra de parede lateral. De fato, o ECG é compatível com infarto agudo do miocárdio com supra de ST. Agora, não é um infarto qualquer nosso paciente apresenta critérios de instabilidade hemodinâmica e evolução para uma arritmia potencialmente maligna e fatal mas essa discussão ficará para os próximos itens desse mesmo caso clínico. Afirmativa CERTA.

337518.

Comentário: Paciente idoso que perdeu a consciência certamente o eletrocardiograma será de grande ajuda para elucidação diagnóstica Repare como temos supradesnivelamento do segmento ST em V1, V2, V3, V6, D1 e aVL, o que denota um infarto que pegou parede lateral e parede anterior. Note ainda o infra de ST em DII, DIII e aVF trata-se de uma imagem em espelho do supra de parede lateral. De fato, o ECG é compatível com infarto agudo do miocárdio com supra de ST. Agora, não é um infarto qualquer nosso paciente apresenta critérios de instabilidade hemodinâmica e evolução para uma arritmia potencialmente maligna e fatal. Pois bem... qual seria a classificação de Killip desse paciente Trata-se de uma classificação prognóstica com base em sinais e sintomas clínicos de insuficiência ventricular esquerda. Este esquema é bastante útil ainda hoje, sendo o

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

prognóstico pior quanto mais alta for a classe do paciente Killip I - Sem dispneia, estertoração pulmonar ou B3 (sem evidências de IVE) Killip II - Dispneia e estertoração pulmonar discreta, B3 ou TJP Killip III - Franco edema agudo de pulmão Killip IV - Choque cardiogênico. Nosso paciente tem uma PA de 80 x 40, o que sugere choque cardiogênico. Por isso, devemos classificá-lo como Killip IV. Afirmativa ERRADA.

337521.

Comentário: Paciente idoso que perdeu a consciência certamente o eletrocardiograma será de grande ajuda para elucidação diagnóstica Repare como temos supradesnivelamento do segmento ST em V1, V2, V3, V6, D1 e aVL, o que denota um infarto que pegou parede lateral e parede anterior. Note ainda o infra de ST em DII, DIII e aVF trata-se de uma imagem em espelho do supra de parede lateral. De fato, o ECG é compatível com infarto agudo do miocárdio com supra de ST. Agora, não é um infarto qualquer nosso paciente apresenta critérios de instabilidade hemodinâmica e evolução para uma arritmia potencialmente maligna e fatal. Ora, diante de um infarto com supra , devemos proceder com a terapia de reperfusão miocárdica. E quanto à decisão de como reperfundir, não há dúvidas hoje de que a melhor terapia de reperfusão miocárdica é a angioplastia. Comparada com os fibrinolíticos, ela leva a taxas mais altas de patência e menor recorrência de isquemia, reinfarto, novos procedimentos de revascularização, hemorragia intracraniana e morte. E este benefício é ainda mais válido para pacientes mais graves. Afirmativa ERRADA.

322165.

Comentário: Cuidado com a queixa da sua paciente Geralmente, esses pacientes são encaminhados para a sala de medicação, recebendo um sorinho , omeprazol e algum antiemético. Alguns poderiam pensar em colecistite, solicitando uma USG abdominal, ou mesmo em doença ulcerosa péptica, situação na qual a endoscopia poderia ajudar. Entretanto, sabemos que alguns pacientes podem cursar com síndrome coronariana na ausência de dor torácica e com equivalentes anginosos... é por isso que não podemos esquecer de solicitar um eletrocardiograma (isso é particularmente verdadeiro em idosos, mulheres e diabéticos). E aqui, há uma clara alteração supra-ST em derivações de parede inferior (DII, DIII e aVF), nos indicando um infarto desta parede.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Além disso, também é possível observar um infra-ST nas derivações septais (V1 e V2), o qual poderia sugerir uma imagem em espelho da parede posterior. Estariamos diante, então, de um infarto inferodorsal. Lembre-se que o IAMST inferior se relaciona tradicionalmente à oclusão da coronária direita, o que também pode causar infarto na região dorsal do VE e no ventrículo direito (idealmente, devemos complementar esse eletro com as derivações direitas - V3R-V4R - e posteriores - V7 e V8). Ora, diante de um IAM com supra e com delta-T 12h, alguma terapia de reperfusão (ex angioplastia primária fibrinólise) deve ser indicada imediatamente. Lembre-se que não devemos aguardar o resultado da curva de marcadores de necrose miocárdica para iniciar a reperfusão, pois isso atrasa o início do tratamento e resulta em piores desfechos clínicos. Agora, cuidado com a letra C morfina e nitrato são contraindicados em pacientes com potencial infarto de VD É que o débito do VD é diretamente dependente da pré-carga, impactado negativamente com o uso desses medicamentos. Além disso, a morfina é usada somente em pacientes com dor refratária aos nitratos, não de rotina no caso dos nitratos, eles entram para pacientes não bradicárdicos (FC 50 bpm) e sem hipotensão (PAs 90 mmHg) - reparem que o enunciado não nos forneceu os sinais vitais da paciente. Resposta letra B.

284272.

Comentário: História mais clássica, impossível Paciente cheio de fatores de risco para doença coronariana com quadro de dor torácica típica. Todos, desde o médico responsável pelo atendimento até o próprio paciente, estão pensando em infarto agudo do miocárdio No entanto, é preciso tomar cuidado com alguns conceitos. A síndrome coronariana aguda com supra de ST é definida por necrose miocárdica transmural do tipo coagulativa por oclusão aguda de uma coronária por um trombo rico em fibrina e hemácias, que normalmente fica aderido a uma placa de ateroma que acabou de sofrer rotura. O diagnóstico dessa condução é dado frente a um quadro clínico compatível e eletrocardiograma com supradesnivelamento de segmento ST, sendo que os marcadores de necrose miocárdica estratificam e confirmam os casos duvidosos. Ora, não temos supradesnivelamento, então não é infarto com supra de ST. Por outro lado, quando falamos de síndrome coronariana aguda SEM supra de ST, estamos falando do infarto agudo do miocárdio

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

sem supra de ST, uma síndrome isquêmica aguda associada à necrose miocárdica não transmural, mas também da angina instável, que representa um surto agudo ou subagudo de isquemia miocárdica, sem provocar necrose dos miócitos. O eletrocardiograma ajuda a diferenciar ambas Não O eletrocardiograma pode ser normal ou apenas apresentar alterações prévias, ou então revelar anormalidades de isquemia aguda espontânea, eventualmente de caráter flutuante, como onda T simétrica e apiculada com segmento ST retificado, inversão de onda T, pseudonormalização da onda T e infradesnivelamento de ST. O que vai ajudar a diferenciar mesmo são os marcadores de necrose miocárdica a elevação dos marcadores caracteriza o diagnóstico de IAM sem supra de ST, enquanto a negatividade de dosagens seriadas marca o diagnóstico de angina instável. Sem os marcadores de necrose, não é possível falar que estamos diante de um infarto sem supra de ST neste momento. Resposta letra B.

284273.

Comentário: Em 1967, Killip e Kimball idealizaram uma classificação prognóstica do IAM com base em sinais e sintomas clínicos de insuficiência ventricular esquerda. Este esquema é bastante útil ainda hoje, sendo o prognóstico pior quanto mais alta for a classe do paciente. Killip I - Sem dispneia, estertoração pulmonar ou B3 (sem evidências de IVE) Killip II - Dispneia e estertoração pulmonar discreta, B3 ou turgência jugular patológica (nosso paciente seria mais bem classificado nesta classe) Killip III - Franco edema agudo de pulmão Killip IV - Choque cardiogênico. Resposta letra A.

284274.

Comentário: Definimos nos itens anteriores dessa mesma questão que estávamos diante de uma síndrome coronariana aguda sem supradesnivel de ST. O grande diferencial na abordagem da síndrome coronariana com supradesnivelamento de ST e sem supradesnivelamento de ST é justamente a terapia de reperfusão miocárdica, que fica indicada para pacientes com todos os três critérios preenchidos sintomas compatíveis com IAM (de preferência dor torácica aguda) delta-T de até 12h (tempo decorrido desde o início dos sintomas) supra de ST em duas ou mais derivações consecutivas ou bloqueio de ramo novo ou presumivelmente novo. Esta, por sua vez, pode ser feita

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

com fibrinólise ou com angioplastia percutânea, sendo o último o método de preferência. Por outro lado, não se deve administrar trombolíticos aos pacientes com síndrome coronariana aguda sem supra de ST, como é o caso em questão Diversos estudos comprovaram que tal conduta, paradoxalmente, aumenta a mortalidade Assim, o emprego de trombolíticos é possibilidade apenas para os casos com supra de ST. Resposta letra A.

284275.

Comentário: Paciente hipertensa e dislipidêmica com quadro de dor torácica típica cujo eletrocardiograma evidenciou infradesnivelamento do segmento ST. Pergunta-se sobre a indicação do uso atenolol no momento. Pacientes com angina instável ou IAM sem supra de ST devem receber terapia farmacológica precoce, semelhante aos pacientes com IAM com supra de ST, preferencialmente, dentro dos 20 minutos iniciais. Os betabloqueadores devem ser iniciados em baixa doses nos casos em que não houver contra-indicações, objetivando uma FC em torno de 60bpm. O início da droga deve ser nas primeiras 24 horas. Caso o paciente evolua com taquicardia não compensatória (causada pela insuficiência cardíaca) ou dor isquêmica persistente, opta-se pela formulação venosa em caráter mais urgente. Nas primeiras 24h, devemos iniciar um agente cardiosseletivo como o atenolol ou metoprolol. O atenolol pode ser administrado na dose de 25 a 50mg, 2x por dia ou numa dose de 12,5mg dia, quando existe preocupação quanto ao risco de efeitos colaterais. Diferente dos anti-agregantes que devem ser feito no momento inicial, não há urgência em iniciarmos o beta bloqueador. Como a paciente não preenche nenhuma indicação de uso de beta bloqueador venoso, a afirmativa está incorreta. Afirmativa ERRADA.

284276.

Comentário: Temos um paciente com quadro compatível com síndrome coronariana aguda sem supradesnível de segmento ST. Muita atenção, pois alguns ainda fornecem oxigênio para todo e qualquer paciente com diagnóstico de síndrome coronariana aguda, o que está EQUIVOCADO O suporte com O fica reservado para pacientes com infarto do miocárdio com saturação 90%, nos casos de desconforto respiratório ou na presença de fatores de risco para hipoxemia. A suplementação em pacientes sem hipoxemia não mostrou nenhum benefício, sendo que alguns

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ainda sugerem algum grau teórico de malefício com a hiperóxia, que pode ter efeito vasoconstrictor nas artérias coronárias (embora trabalhos não tenham mostrado aumento de mortalidade ou de complicações cardíacas). Assim, a maioria dos pacientes com saturação 90% não precisa de aporte de O . Uma exceção, no entanto, seria o paciente com insuficiência cardíaca, que podem receber oxigênio de forma selecionada mesmo na ausência de hipoxemia. Resposta letra B.

261228.

Comentário: O supradesnivelamento do segmento ST nos chama logo a atenção para a possibilidade de infarto agudo do miocárdio. Mas que paciente jovem para pensarmos em síndrome coronariana, não é mesmo Não só isso, ele também tem febre e dor do tipo pleurítica, não é uma dor muito típica... Inclusive, os marcadores de necrose miocárdica são negativos. Para completar, o supra de ST não parece respeitar parede, pegou todas as derivações Sim, estamos diante de um quadro compatível com pericardite aguda. Do ponto de vista clínico, temos dor torácica de localização precordial ou retroesternal, contínua, tipo pleurítica (piora com a inspiração profunda e tosse), com piora também com decúbito dorsal, mas sendo aliviada na posição sentada com o tronco inclinado para frente ou abraçado ao travesseiro. A dispneia também é uma queixa comum a maioria dos casos é de etiologia viral, então não é raro observamos sintomas virais inespecíficos como astenia, mal-estar e febre. Em relação aos exames complementares, temos extensão do processo para o epicárdio em 90% dos casos, causando alteração eletrocardiográfica. Na fase inicial, a alteração mais encontrada é o supradesnível de ST, com o ST de aspecto côncavo visto em várias derivações (embora poupe V1 e aVR). Pode haver infradesnível do PR (alteração mais específica, porém menos observada), que representa a corrente de lesão atrial e está presente, sobretudo, em derivações periféricas e precordiais esquerdas. Resposta letra A.

261229.

Comentário: Assertiva errada. Vamos partir do diagnóstico... Esse paciente tem dor torácica de início súbito, o que já nos lembraria a possibilidade de uma síndrome coronariana aguda (SCA) o supradesnível do ST só corrobora essa impressão... Porém, note a dor é de característica pleurítica, que fala contra SCA o paciente está febril, sugerindo condição eminentemente

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

inflamatória, que não é o caso da SCA o supradesnível do segmento ST é difuso, incompatível com doença coronariana e, por fim, há infradesnível do segmento PR. Tais achados sugerem pericardite aguda. O que a questionou é se o início súbito dos sintomas confere mau prognóstico. Ao contrário do que poderia sugerir o senso comum, é o início mais arrastado subagudo dos sintomas que sugere pior prognóstico. Resposta letra B.

261230.

Comentário: Assertiva errada. O paciente descrito tem provável pericardite aguda dor pleurítica, febre, supradesnível difuso do segmento ST e infradesnível do segmento PR. Tais achados sugerem pericardite aguda. Nessa condição, não se espera edema agudo de pulmão. O edema agudo poderia aparecer na disfunção ventricular esquerda por infarto agudo do miocárdio, diagnóstico diferencial importante da pericardite aguda. No infarto, não esperaríamos dor pleurítica, febre, supra difuso e infra de PR. Resposta letra B.

261231.

Comentário: Paciente jovem com quadro clínico e eletrocardiográfico sugestivo de pericardite aguda (febre, dor pleurítica, supra de ST difuso, infra de PR), sobre o qual pergunta-se qual deverá ser a conduta subsequente. Aqueles que apresentam alto risco para complicações devem ser internados e, geralmente, são aqueles cuja pericardite tem uma etiologia específica (ou seja, não viral). Entretanto, algumas características que sugerem alto risco ou mau prognóstico, quando presentes, motivam a internação. São elas - Febre 38oC - Curso de doença ao longo de dias ou semanas (sem aparecimento súbito de dor torácica) - Achados sugestivos de tamponamento - Derrame pericárdico moderado e grave - Pacientes imunossuprimidos - Uso de anticoagulantes orais não varfarinicos ou varfarina - Trauma agudo - Ausência de melhora após sete dias de uso de AINES e colchicina - Elevação da troponina sugerindo miocardite pericardite. Como o paciente apresenta febre com temperatura 38oC, ele deverá ser internado. A banca liberou como gabarito que o paciente não deverá ser internado, mas considerando o que vimos acima, a questão deveria ter sido anulada ou o gabarito alterado. Gabarito da banca Letra B Gabarito MEDGRUPO Letra A.

261232.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Este paciente com história de dor torácica aos esforços, que nos sugere dor de origem cardíaca, está apresentando agora sinais clínicos específicos de insuficiência cardíaca (principalmente a dispneia paroxística noturna é um sinal pouco sensível, mas bastante específico para IC). O ecocardiograma fornecido nos demonstra aumento importante do diâmetro das cavidades esquerdas (AE 40 mm, VE sistólico 35 mm, VE diastólico 55 mm) e do VD (30 mm), além de fração de ejeção do VE de 24% (muito reduzida), indicando que este paciente é portador de cardiomiopatia em fase dilatada com disfunção grave do ventrículo esquerdo. Pela história clínica de dor aos esforços, e pelo nosso conhecimento de epidemiologia, a primeira hipótese diagnóstica deve ser doença isquêmica coronariana em fase bastante avançada. A coronariografia não deixa dúvidas, confirma a hipótese diagnóstica, demonstrando que existe lesão coronariana grave, e ela se localiza no terço médio da artéria descendente anterior. Mas não se culpe se a imagem gerou dúvidas De fato, esta não é uma incidência habitual na coronariografia para a artéria descendente anterior, que na visão mais tradicional do exame progride da esquerda para a direita. Pegadinha desleal da prova, que exigiu um conhecimento profundo da anatomia coronariana para responder Como então podemos identificar corretamente as coronárias Perceba que, na extremidade direita da imagem, a artéria lesionada se origina de um ramo mais calibroso, que se bifurca em dois grandes ramos. Esta porção inicial mais calibrosa é o tronco da coronária esquerda, que dá origem às artérias circunflexa e descendente anterior. Nesse caso, a artéria circunflexa se direciona para a parte superior da imagem, e a descendente anterior segue na direção da esquerda da imagem. Mas a principal dica para identificar a descendente anterior é observar os seus ramos. Esta artéria se localiza no sulco interventricular anterior, e em sua porção proximal emite os ramos septais (que perfundem o septo interventricular). Estes ramos saem da artéria principal em ângulos próximos a 90 graus. Em suas porções média e distal, os ramos saem em ângulos mais oblíquos, em direção à parede lateral do ventrículo esquerdo, e são chamados ramos diagonais. Tanto os ramos septais quanto diagonais estão bem visíveis na imagem, o que nos confirma que esta é de fato a artéria descendente anterior. Resposta CERTA.

261235.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Repare que há supradesnivelamento do segmento ST evidente em V1-V4 (talvez, em V5 também), ou seja, existe acometimento de parede anterior, exatamente como o enunciado afirma. Analisando as outras paredes, percebemos que há supra também em parede lateral alta (DI e aVL). Perceba então que, embora a assertiva ao final do enunciado se refira apenas ao IAM anterior, ela não é errada, concorda Afinal, HÁ acometimento desta parede Ela poderia ter sido melhor formulada, é verdade, mas não está errada Para completar a análise do ECG em parede inferior, o que vemos é um INFRA de ST (imagem em espelho da parede lateral alta) e, como não há ondas P (o que vemos antes dos complexos QRS são, na verdade, ondas T) e o ritmo é irregular, estamos diante de uma fibrilação atrial. Resposta (A).

261236.

Comentário: A questão traz paciente jovem com quadro de miocardiopatia dilatada apresentando-se com síndrome coronariana aguda com supra de ST. É possível que a dispneia do paciente esteja associada à descompensação da insuficiência cardíaca de base pela isquemia coronariana. Uma das formas práticas de avaliar isso é por meio da dosagem laboratorial de marcadores como o peptídeo natriurético cerebral (BNP), mas um detalhe pacientes com IC prévia podem possuir valores desta substância naturalmente maiores. Então, o ponto de corte aqui irá subir para 500 pg mL. Abaixo de 150, é possível descartar a insuficiência cardíaca como causa de dispneia entre 150-500, este exame não possuirá boa sensibilidade ou especificidade. Portanto, um valor de 300 pg mL isolado não é possível estabelecer o diagnóstico de IC descompensada neste paciente, sendo necessário complementar a investigação com outros exames, como ecocardiograma. Resposta letra B.

274378.

Comentário: Vamos analisar as opções A pericardite corresponde à inflamação dos folhetos pericárdicos, que pode ter evolução aguda ou subaguda crônica. Principalmente na forma aguda, o que melhor caracteriza a pericardite é a dor torácica, de localização precordial ou retroesternal, contínua, tipo pleurítica (piora com a inspiração profunda e tosse), que piora com o decúbito dorsal e é aliviada na posição sentada com o tronco inclinado para frente (posição genupeitoral) ou

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

abraçado ao travesseiro (posição de Blechmann). A maioria dos casos de pericardite aguda é de etiologia viral (opção A está incorreta). Nessa situação, não é raro observarmos um quadro viral inespecífico com astenia, dor no corpo e febre. A infecção pelo citomegalovírus é uma causa comum de pericardite em pacientes imunocomprometidos, principalmente com contagem de CD4 muito baixa. Alternativa B, portanto, está correta. A síndrome de Marfan não é uma doença auto-imune e sim uma doença do tecido conjuntivo, genética, autossômica dominante, sem predileção por raça ou sexo, com uma prevalência de 1 10.000 indivíduos. Possui como característica principal o envolvimento multissistêmico, afetando principalmente o aparelho cardiovascular, musculoesquelético e ocular. A dilatação da aorta, disseção e rotura são as principais causas de morbimortalidade. Opção C, portanto, incorreta. Existem duas razões para o paciente evoluir com pericardite pós infarto agudo do miocárdio (IAM). Na primeira delas temos um paciente com um quadro de IAM transmural onde ocorre morte celular e reação inflamatória local que, por contiguidade, pode chegar até o pericárdio causando pericardite. O outro cenário possível consiste na morte dos miócitos liberando antígenos que são capazes de gerar uma reação imunológica e pericardite auto-imune. Essa pericardite auto-imune (chamada de síndrome de Dressler) geralmente é um evento mais tardio, podendo ocorrer até semanas pós IAM. Logo, a opção D também está correta. A dosagem de BNP e NT-proBNP deve ser realizada, quando necessária, em casos de insuficiência cardíaca e não de pericardite. Opção E, portanto, incorreta. Questão anulada pois existem dois gabaritos para a questão letra B e letra D.

255667.

Comentário: O enxerto mamário (artéria torácica interna) é o principal utilizado para revascularização miocárdica, uma vez que é o se maior patência e não depende de grandes alterações anatômicas. Uma das razões para se escolher a dissecção esqueletizada da artéria torácica interna é o fato de proporcionar um maior comprimento e calibre em comparação com a técnica convencional (pediculada), reduzindo a incidência de trauma pleural e tornando possível a revascularização de coronárias com lesões distais e mantendo a artéria torácica interna na forma in situ, pois é conhecida a perda de 10 a 15% de sua patência quando esta artéria permanece como

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

enxerto livre e é anastomosada na aorta ascendente. Afirmativa CERTA.

255668.

Comentário: O enxerto mamário (artéria torácica interna) é o principal utilizado para revascularização miocárdica, uma vez que é o se maior patência e não depende de grandes alterações anatômicas. Quando necessários mais enxertos, a safena é frequentemente utilizada, possuindo menor patência. Após 10 anos, cerca de 50% dos enxertos de safena magna encontram-se ocluídos, sendo a trombose o principal mecanismo, principalmente quando há competição de fluxo entre o leito nativo e o enxerto. Afirmativa CERTA.

255669.

Comentário: Acerca da revascularização cirúrgica do miocárdio, nos casos complicados com hemotórax, pode ser necessária drenagem e revisão da hemostasia. No entanto, por tratar-se de complicação pós operatória, sem fator de perpetuação recidiva do derrame, não é comum a necessidade de pleurodese (talcagem). Afirmativa ERRADA.

255691.

Comentário: Afirmativa INCORRETA. O quadro clínico de nosso paciente - apesar de ser relativamente jovem - é bastante sugestivo de síndrome coronariana aguda, o que é confirmado pelo eletrocardiograma. Perceba como há supradesnivelamento do segmento ST em DII, DII e aVF, além de infradesnivelamento em DI e aVL, o que sugere acometimento de parede inferior. Como o início dos sintomas se deu em menos de 12 horas, consideraremos oo paciente como candidato a terapia de reperfusão. Acontece que o método de preferência é a angioplastia primária, desde que ela possa ser feita em até 90 minutos ou 120 min se houver necessidade de transferênicia caso o atendimento inicial tenha sido em uma unidade sem angioplastia. A trombólise é feita quando a angioplastia não pode ser realizada a tempo, sendo assim a nossa segunda opção Resposta B.

255693.

Comentário: Você já identificou nesse eletrocardiograma o supradesnivelamento do segmento ST em DII, DIII e aVF com infradesnivelamento do ST em DI e aVL (ou seja, infarto de parede inferior), além de perceber o bloqueio atrioventricular total, uma complicação que ocorre em 10% dos casos

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

de infarto de parede inferior. Agora, o autor ainda quer saber qual é a artéria culpada E dá para saber só olhando o eletrocardiograma Dá Sabemos que o infarto de parede inferior é resultado de obstrução de coronária direita em 70% dos casos e da circunflexa em 30% dos pacientes. Quando há oclusão da coronária direita, a lesão naturalmente será mais proeminente no lado direto, de modo que o vetor de lesão aponta para este lado, tendendo a ser melhor visualiazado pela derivação DIII do que em DII, além de fugir das derivações esquerdas. Isso resultará em um supradesnivelamento em DIII DII e infra de ST em DI e aVL. Não é justamente esse o caso no eletrocardiograma do enunciado Sim E se a lesão fosse de circunflexa Aí a lesão seria mais intensa à esquerda e seria melhor visualizada em DII, indo em direção às derivações da esquerda. O resultado seria um supra de ST em DII DIII e supra de ST também em DI, aVL, V5 e V6. Resposta A.

255694.

Comentário: Temos um quadro clássico de síndrome coronariana aguda com supradesnivelamento do segmento ST. Assim, encontra-se recomendada a angioplastia primária para abordagem da lesão culpada. Havendo trombos visualizados na coronariografia, a aspiração de rotina não está recomendada, uma vez que associa-se a maior risco de AVC AIT. No entanto, nos casos de alta carga trombótica após a abertura do vaso, a aspiração dos trombos está associada a redução da morte por causas cardíacas, podendo ser considerada. Afirmativa CERTA.

239284.

Comentário: Questão polêmica, pois, como sabemos, a presença de doença arterial coronariana estabelecida, como no caso apresentado em que a paciente já teve infarto previamente, classicamente a caracteriza como uma paciente de MUITO ALTO risco cardiovascular, conforme as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia. No entanto, as referências utilizadas pelo concurso se limitam a caracterização desse perfil de paciente como de alto risco cardiovascular, uma vez que não utilizam o muito alto risco em seu sistema de classificação. Assim, apesar de entendermos que a questão está errada, já que o paciente é de muito alto risco, devemos considerar a referência bibliográfica utilizada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

239365.

Comentário: Questão que quer saber se a característica da dor torácica da paciente é indicativa de dor anginosa. Ora sabemos que a classificação utilizada pela maioria das diretrizes para avaliação da probabilidade pré-teste da dor torácica se resume às 3 principais características da dor anginosa típica -Localização retroesternal -Característica em aperto peso opressão -Piora com esforço e melhora com repouso ou uso de nitratos Nenhum desses fatores está presente no caso acima, sendo a dor caracterizada como provavelmente não cardíaca e traduzindo baixo valor preditivo positivo para doença cardiovascular. Afirmativa correta.

196641.

Comentário: Veja bem paciente diabético, com doença coronária trivascular sintomática, tem indicação de revascularização cirúrgica. Contudo, dizer que ele deve ser obrigatoriamente tratado com cirurgia está errado... O paciente sempre tem autonomia para decidir sobre a realização de procedimentos eletivos A proposta terapêutica deve ser aceita pelo paciente, estando de acordo com suas preferências e valores pessoais... O quadro em tela a princípio PODE ser tratado pela via percutânea, ainda que, tecnicamente falando, esta não seja a melhor escolha... Logo, assertiva ERRADA.

196643.

Comentário: Se houver indicação cirúrgica neste paciente (ex. refratariedade ao tratamento clínico, ou surgimento de disfunção sistólica de VE), a melhor opção para revascularizar cirurgicamente a descendente anterior é utilizando enxerto de artéria mamária interna, podendo-se utilizar também a radial. Assertiva CORRETA.

214514.

Comentário: Uma questão cansativa com enunciado enorme, mas relativamente fácil. Resumo Um homem de meia-idade, com dor torácica típica, HAS DM2 ANSIEDADE . Qual a primeira, a segunda e a terceira hipótese -Síndromes Isquêmicas Miocárdicas Instáveis (IAMST, SCASSST,Angina Instável) -O paciente tem 3 fatores de risco (idade,HAS,DM2). Por isso a afirmativa está CORRETA.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

214516.

Comentário: Uma questão cansativa com enunciado enorme, mas relativamente fácil. Resumo do quadro Homem de meia-idade, com dor torácica típica desencadeada por episódio de estresse, estável hemodinamicamente apesar de leve hipertensão. Antecedente HAS DM2 ANSIEDADE . Qual a primeira, a segunda e a terceira hipótese Síndromes Isquêmicas Miocárdicas Instáveis (IAMST, SCASSST,Angina Instável) O paciente tem 3 fatores de risco (idade,HAS,DM2). Lembre-se que o paciente já tem o diagnóstico de SIMI. Só nos resta saber qual das tres é baseado no ECG e nos marcadores de necrose. O paciente apresenta ECG normal e marcadores de necrose normais. Portanto, qual diagnóstico ANGINA INSTÁVEL Por isso a afirmativa está ERRADA.

214519.

Comentário: Uma questão cansativa com enunciado enorme, mas relativamente fácil. Resumo do quadro Homem de meia-idade, com dor torácica típica desencadeada por episódio de estresse, estável hemodinamicamente apesar de leve hipertensão. Antecedente HAS DM2 ANSIEDADE . Qual a primeira, a segunda e a terceira hipótese Síndromes Isquêmicas Miocárdicas Instáveis (IAMST, SCASSST,Angina Instável) A Banca afirmou que o ECG tem supradesnivelamento.Agora o diagnóstico de certeza é IAMST. Qual melhor conduta Angioplastia primária mas a banca já adiantou não será possível. Segunda opção Reperfusão química com trombolítico. O paciente tem contra-indicação SIM Uma PA 180x110 mmHg contra-indica o uso de trombolítico por alto risco de sangramento. Por isso a afirmativa está ERRADA.

214521.

Comentário: Uma questão cansativa com enunciado enorme, mas relativamente fácil. Resumo do quadro Homem de meia-idade, com dor torácica típica desencadeada por episódio de estresse, estável hemodinamicamente apesar de leve hipertensão. Antecedente HAS DM2 ANSIEDADE . Qual a primeira, a segunda e a terceira hipótese Síndromes Isquêmicas Miocárdicas Instáveis (IAMST, SCASSST,Angina Instável) A Banca afirmou que o ECG tem supradesnivelamento.Agora o diagnóstico de certeza é IAMST. Qual melhor conduta Angioplastia primária. Qual o tempo

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

porta-balão preconizado 90 minutos ou 120 minutos se paciente estiver sendo transportado. Por isso a afirmativa está ERRADA.

214522.

Comentário: Em certos pacientes, como idosos, mulheres, diabéticos ou transplantados cardíacos, o IAM pode se manifestar de forma atípica (não anginosa) ou mesmo sem qualquer queixa álgica. São exemplos clássicos de manifestações clínicas atípicas dor torácica em queimação, dispepsia (epigastralgia, náusea, vômitos), exaustão, lipotímia, síncope, deficit neurológico focal, choque cardiogênico indolor, edema agudo de pulmão e morte súbita. O paciente do enunciado até apresentou desconforto torácico em aperto, mas imagine que a queixa dele fosse de epigastralgia. Talvez, esse paciente chegasse à emergência e ganhasse um omeprazol para tratar uma provável dispepsia, nem mesmo um eletrocardiograma ganharia Naturalmente, esse paciente diria que seus sintomas não estão melhorando, sendo nessa hora que a familiar te diz que o paciente usa antidepresssivos para controle de transtorno de ansiedade. Pronto, você caiu na armadilha e agora acredita que o paciente não melhorou porque está ansioso. Aliás, deve ter brigado com a família justamente por causa da ansiedade Muito cuidado, é preciso ter alto grau de suspeição para síndrome coronariana aguda em pacientes com sintomas atípicos, em particular diabéticos. Inclusive, até 60% dos pacientes dirão que houve um fator desencadeante para o infarto, como estresse físico ou emocional. Resposta A.

152119.

Comentário: Essa questão é muito polêmica, pois alguns estudos mostraram que em alguns grupos de pacientes não havia diferença de mortalidade entre o uso de trombolítico ou angioplastia em até 90 min. Mas as metanálises mostram que não há dúvidas que a angioplastia é superior aos trombolíticos. Ambos os tratamentos devem ser realizados o mais rápido possível, pois tempo é miocárdio. Dessa forma, seria mais adequado dizer que essa afirmativa está errada do que certa, mas a banca considerou como correta.

152122.

Comentário: A artéria associada ao IAM (supra de ST em II, III, aVF) de parede inferior, na maioria

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

dos casos, é a coronária direita. Só em alguns casos a artéria culpada é a circunflexa (pacientes com dominância esquerda). Assertiva correta.

152129.

Comentário: O IAM de parede inferior frequentemente se associa ao infarto de VD (ambos supridos pela coronária direita). Logo, até que um IAM de VD seja excluído, estamos proibidos de administrar medicações que diminuam o retorno venoso, como nitratos. Morfina e diuréticos são outras drogas que devem ser evitadas até a exclusão deste diagnóstico. Logo, assertiva ERRADA.

152133.

Comentário: O infarto Killip I cursa sem estertores ou B3. Se há estertores bibasais, devemos classificar como Killip II (ou seja, existe insuficiência leve a moderada de VE). Lembremos a classificação Killip I - Sem B3 ausculta pulmonar limpa. Killip II - B3 crepitações bibasais. Killip III - B3 e edema agudo de pulmão. Killip IV - Choque cardiogênico. Assertiva errada.

131848.

Comentário: A opção A está incorreta, pois é indicada a suplementação com oxigênio quando a oximetria de pulso indica saturação menor que 90% e não 86%. A opção B está incorreta, pois a morfina é especialmente útil nos pacientes que apresentam edema agudo de pulmão, devido a seu efeito de redução da pré-carga por venodilatação associada à redução da sensação desagradável da dispneia. A opção C está incorreta, pois os nitratos são justamente contraindicados nos pacientes que se apresentam com hipotensão. A opção D está incorreta, pois ela está citando justamente as situações em que os betabloqueadores são contraindicados, doença vascular periférica, doença pulmonar obstrutiva crônica, bloqueio atrioventricular de terceiro grau (BAVT) e alargamento do intervalo PR. Já a opção E está completamente correta, pois a aspirina deve ser utilizada na fase aguda com dose aumentada, podendo chegar até 325 mg, mas sua manutenção é com a dose diária de 100 mg.

134986.

Comentário: Um jovem de 20 anos com infarto agudo do miocárdio (IAM) secundário ao uso de drogas simpaticomiméticas, que causam hiperestimulação adrenérgica (ansiedade, agitação,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

midríase, taquicardia e taquipneia), como a cocaína, por exemplo O mecanismo do IAM certamente é o VASOESPASMO coronariano. A afirmativa da questão está incorreta, uma vez que a alteração pupilar causada pelos opioides é a miose (pupilas pequenas), com pupilas puntiformes, além destas drogas causarem sedação e depressão respiratória, manifestações contrárias às apresentadas Gabarito B.

134995.

Comentário: Paciente jovem infartando sem história familiar de doença coronariana precoce ou comorbidades que podem cursar com esse tipo de complicação, como anemia falciforme, SAAF, Kawasaki, outras coagulopatias, sempre deve nos fazer pensar em uso de cocaína. O paciente da questão ainda apresenta sintomas como agitação psicomotora, taquicardia e ansiedade que são característicos do uso da droga. A cocaína é uma causa frequente de infarto em jovens e seu metabólito benzoilecgonina pode ser identificado na urina até 3 dias depois do uso. O mesmo metabólito é identificado no caso do uso de cocaína, crack ou oxi, não sendo possível a diferenciação. Afirmativa correta. Resposta LETRA A.

140746.

Comentário: Um enunciado gigantesco que pode ser resumido em poucas palavras idosa cheia de fatores de risco para doença coronariana que se apresenta com dor torácica típica após estresse emocional. Possui eletrocardiograma com supradesnivelamento do segmento ST e inversão de onda T nas paredes inferiores, além de troponina sanguínea elevada. Isso é um caso clássico de infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, não de angina instável. Até porque, na angina instável não esperamos nem supra de ST, nem troponina positiva. Resposta B.

140748.

Comentário: Resumindo o extenso enunciado estamos diante de uma paciente que se apresenta com quadro clássico de dor torácica anginosa há 6 horas associada a supradesnivelamento do segmento ST (além de algum grau de necrose já estabelecido, confirmado através das ondas Q profundas). Bom, o delta-T para a trombólise e para o cateterismo na síndrome coronariana aguda com supra é de 12 horas. Apesar de não haver contraindicações ao uso de trombolíticos, a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

coronariografia seria o método de escolha, já que se passaram 2-3 horas do início dos sintomas. De qualquer forma, a assertiva é incorreta. Resposta (B).

135056.

Comentário: O enunciado está completamente correto, as estatinas usadas para tratamento de dislipidemia causam hepatotoxicidade e miotoxicidade, dessa forma, deve-se acompanhar laboratorialmente com marcadores de lesões musculares (aldolase e creatinofosfoquinase (CPK)) e marcadores de lesões hepáticas (TGO (AST) e TGP (ALT)), idealmente antes do início do tratamento e após 3 meses. Se as dosagens forem 3 vezes acima do normal deve-se suspender o tratamento. A pravastatina é a estatina menos hepatotóxica. Geralmente os pacientes que evoluem com elevação das enzimas hepáticas, normalizam seus exames com a suspensão, ou mesmo com a redução da dose utilizada, provavelmente por um mecanismo de adaptação, que faz com que as aminotransferases geralmente se estabilizem mesmo com a manutenção da medicação.

140723.

Comentário: Bom, após ler o enunciado, é evidente que nossa grande preocupação é que o paciente esteja infartando, não é mesmo A análise eletrocardiográfica não deixa dúvida há supradesnivelamento do segmento ST nas derivações que correspondem à parede inferior (DII, DIII e aVF). O fato de os marcadores de necrose estarem negativos não exclui o diagnóstico lembre-se que a CK-MB e a troponina se elevam a partir de 4-6 horas do infarto (a troponina ultrassensível positiva de forma mais precoce). Para finalizar, não podemos esquecer que a angina instável, citada na assertiva final, não cursa com essa manifestação eletrocardiográfica. Afinal, trata-se de uma síndrome coronariana sem supra de ST. Resposta (B).

105561.

Comentário: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é fator de risco mais importante para a doença cerebrovascular do que para a coronariana (A errada - HAS é o PRINCIPAL fator de risco para acidente vascular cerebral isquêmico). A interrupção do tabagismo realmente reduz o risco cardiovascular (em um paciente infartado e tabagista, após 15 anos de abandono ao tabagismo, o risco de reinfarto se iguala ao de uma pessoa não fumante). O que não está certo é dizer que a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

interrupção do fumo é a intervenção com maior impacto na redução desse risco (B errada). Os níveis elevados de HDL são PROTETORES aos vasos, reduzindo o risco de aterosclerose (C errada). O diabetes tipo I não está associado ao ganho de peso. O ganho ponderal é o cerne do diabetes tipo II indivíduo ganha gordura abdominal, a qual aumenta a resistência periférica à insulina e pressiona um pâncreas geneticamente predisposto às alterações que culminam com o surgimento da doença (D errada). Apesar de, em conjunção com outros fatores de risco, os anticoncepcionais orais aumentarem a probabilidade de eventos trombóticos, seu uso ISOLADO está associado apenas RARAMENTE a fenômenos trombóticos (E errada). Como a questão não tem resposta, produzimos recurso, mas a banca não quis alterar o gabarito, mantendo-o como a letra E.

108184.

Comentário: A quarta bulha cardíaca indica que o ventrículo está menos complacente, isto é, há um déficit de relaxamento no miocárdio ventricular que torna as suas paredes mais duras . Sabemos que a disfunção diastólica segmentar é um dos primeiros eventos fisiopatológicos no curso natural da isquemia miocárdica aguda. Logo, no contexto apropriado (como o caso em questão, em que o paciente apresenta dor torácica anginosa), a presença de quarta bulha se reveste de um importante significado, pois corrobora a impressão de que se trata de uma síndrome coronariana aguda. Afirmativa CORRETA.

108189.

Comentário: Na dor precordial sempre devemos excluir as condições mais graves, entre elas a síndrome coronariana aguda. O eletrocardiograma é exame obrigatório em todos os pacientes suspeitos. Além de diagnóstico, este exame orienta a terapia. Deve ser realizado e interpretado em menos de 10 minutos da admissão ao hospital (tempo porta-ECG de até dez minutos). Correto

108151.

Comentário: Quando ocorre lesão miocárdica por isquemia s o liberados no interstício algumas moléculas que s o absorvidas pelos linfáticos e apresentam pico e decréscimo estereotipados no sangue. Essas moléculas s o conhecidas como marcadores de necrose miocárdica ou enzimas

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

cardíacas. Por conta desde comportamento não se recomenda dosagem isolada dos marcadores, mas realização de dosagens seriadas, ou seja, a curva enzimática. A sociedade brasileira recomenda a dosagem de CK-MB massa e troponina em todos os pacientes com suspeita de síndrome coronariana aguda. A CK-MB massa se eleva em 3-6 horas após o início do evento, com pico em 16-24 horas e normalização em 48-72 horas. Os níveis de troponina se elevam em 4-8 horas após o início dos sintomas, com pico em 36-72 horas e normalizaç o em 5-14 dias. Desta forma, uma dosagem de troponina após 30 minutos do início dos sintomas não é capaz de excluir a hipótese de infarto agudo do miocárdio.

108234.

Comentário: O cálculo do escore de Framingham (ou qualquer outro escore validado para estimativa do risco cardiovascular) é completamente DESNECESSÁRIO nesta paciente. O motivo é óbvio em vista de seus dados clínicos, podemos afirmar que ela automaticamente já é de alto risco cardiovascular Estamos falando aqui de uma paciente com doença coronariana já estabelecida Além do mais, o escore de Framingham não serve exatamente para nos orientar quanto à necessidade ou não de exames invasivos (o que ele faz é estimar a probabilidade de eventos cardiovasculares adversos nos próximos anos). Quem indica se a paciente precisa ou não de exames invasivos (como um cateterismo cardíaco, por exemplo) é a presença de sintomas e sua gravidade (isto é, se os sintomas são refratários ou não, incapacitantes ou não). O sentido de realizar uma angiografia coronariana só existe se houver sentido em submeter o paciente a um procedimento de revascularização invasiva (angioplastia ou cirurgia). Caso contrário, não vale a pena correr os riscos do exame. Afirmativa INCORRETA.

108235.

Comentário: Como a paciente é inquestionavelmente de alto risco cardiovascular, uma estatina deve ser usada independentemente de qualquer outro fator Já foi demonstrado que as estatinas melhoram a saúde endotelial desses doentes, o que se traduz num benefício clínico de diminuição dos eventos cardiovasculares adversos. Logo, temos que começar estatina agora. Afirmativa INCORRETA.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

85508.

Comentário: Ao enxergarmos ondas P positivas precedendo cada complexo QRS, temos a certeza que os átrios são ativados antes dos ventrículos - como deve ser. E ao olharmos para a derivação DII, enxergamos ondas P sempre positivas - o que também é normal. Ou seja, o coração está sendo comandado de forma normal pelo nó sinusal. GABARITO MEDGRUPO Ritmo Sinusal.

85509.

Comentário: O traçado mostra um supradesnivelamento do segmento ST nas derivações V1 a V6, DI e aVL, além de um infradesnivelamento do segmento ST em DII, DIII e AVF - compatível com uma imagem em espelho. GABARITO MEDGRUPO Supra de ST em V1 a V6, DI e aVL com imagem em espelho (infra de ST) em DII, DIII e aVF.

85510.

Comentário: Um paciente com precordialgia típica é portador de uma Síndrome Coronariana Aguda que pode ser dividida em com e sem supra de ST. No caso, houve supradesnivelamento deste segmento na parede anterior (V1 a V4) e lateral (V5, V6, DI e aVL), com imagem em espelho na parede inferior (DII, DIII e aVF). Quando o acometimento é simultâneo de parede anterior e lateral, dizemos que ele foi anterior extenso . GABARITO MEDGRUPO Síndrome Coronariana Aguda com Supra de ST ou IAM com supra de ST anterior extenso.

88682.

Comentário: Temos uma paciente com fatores de risco clássicos para aterosclerose que se apresente com precordialgia típica e, portanto, estamos diante de um caso atualmente sugestivo de síndrome coronariana aguda E o pior é um IAM com supra de ST Esta paciente deve ser imediatamente internada e submetida a terapia de reperfusão (com delta T de 4 horas, a angioplastia primária é claramente superior ao trombolítico). Veja que, neste momento, não há NENHUMA indicação de cintilografia de perfusão miocárdica. Este exame é usado em pacientes com angina estável para definição da área de isquemia.

88708.

Comentário: Q uando um doente entrar na sua sala de emergência com dor torácica, você tem

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

NADA MAIS, NADA MENOS que 10 minutos para realizar um Eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações em repouso, assim como foi feito para essa paciente. Observamos, então, ao eletrocardiograma, a presença de supradesnível do segmento ST em parede anterior somando-se a uma dor tipicamente anginosa Qual é o seu diagnóstico Síndrome Coronariana Aguda com supradesnível do segmento ST (SCACSST) Sabemos que, em constraste a esta paciente com SCACSST, temos a SCA sem supra de ST (SCASSST). Dentro da SCACSST, temos apenas o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) com supra de ST e na SCASSST, temos a angina instável e o IAM sem supra. Portanto, numa paciente com supra de ST, não cabe classificá-la como portadora de angina instável. Sabemos, ainda, que a confirmação laboratorial da necrose miocárdica, com alteração da troponina sérica, é necessária para fechar o diagnóstico de IAM, mas isto não atrasará nossa conduta Paciente com SCACSST há menos de 12 horas deverá ser encaminhada à trombólise ou angioplastia primária. Assertiva errada.

88714.

Comentário: Q uando um doente entrar na sua sala de emergência com dor torácica, você tem NADA MAIS, NADA MENOS que 10 minutos para realizar um Eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações em repouso, assim como foi feito para essa paciente. Observamos, então, ao eletrocardiograma, a presença de supradesnível do segmento ST em parede anterior somando-se a uma dor tipicamente anginosa Qual é o seu diagnóstico Síndrome Coronariana Aguda com supradesnível do segmento ST (SCACSST) Sabemos que, em contraste a esta paciente com SCACSST, temos a SCA sem supra de ST (SCASSST). Dentro da SCACSST, temos apenas o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) com supra de ST e na SCASSST, temos a angina instável e o IAM sem supra. Portanto, numa paciente com supra de ST, não cabe classificá-la como portadora de angina instável. Sabemos, ainda, que a confirmação laboratorial da necrose miocárdica, com alteração da troponina sérica, é necessária para fechar o diagnóstico de IAM, mas isto não atrasará nossa conduta Paciente com SCACSST há menos de 12 horas deverá ser encaminhada à trombólise ou angioplastia primária. Além dessas medidas já citadas, temos que lembrar que o tratamento do paciente com SCACSST demanda uso de drogas antiplaquetárias, como o AAS e o

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

clopidogrel, drogas antianginosas como o betabloqueador e os nitratos, além da morfina e da enoxaparina. Oxigênio suplementar só deverá ser fornecido em caso de necessidade. Assertiva correta.

82068.

Comentário: Correta. A suficiência depende do equilíbrio direto entre a oferta e a demanda de oxigênio para o miocárdio. A DEMANDA de oxigênio, por sua vez, é determinada pela frequência cardíaca, pressão arterial sistólica, estresse da parede miocárdica e contratilidade miocárdica. Alguns alunos na época erraram a questão por não observarem que os 4 fatores listados faziam referência à demanda, e não à oferta de O2 ao miocárdio. Vejam depende do equilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio para o miocárdio, que, por sua vez (ou seja, a demanda), é (no singular, ou seja referindo-se à demanda) determinada por...

88622.

Comentário: Nos Estados Unidos, estatinas são consideradas drogas de classe X para o uso em gestantes - isto é - são contraindicadas na gravidez. Estudos em animais sugerem que as estatinas causariam desfechos adversos da gravidez, enquanto que estudos em humanos indicam que essas drogas não sejam teratógenos importantes. Além disso, o FDA indica que pode haver alterações em membros e aumento de malformações congênitas no sistema nervoso central. Na lactação, como há poucos dados disponíveis, recomenda-se que não sejam usadas estatinas durante esse período da vida da mulher. Assertiva errada.

88635.

Comentário: O tratamento dos pacientes dislipidêmicos, quando indicado, não é só baseado em terapia farmacológica. Devemos nos lembrar que há outro importante componente da conduta terapêutica para esses pacientes as mudanças de hábitos de vida cessar tabagismo, controlar consumo de álcool, perda ponderal, exercício físico, alterações na dieta como a redução na ingestão de colesterol e gordura saturada e aumentar a ingestão de fibras solúveis. Lembremos ainda de uma atitude que está na moda o consumo moderado de vinho Isto se justifica pela presença, no vinho, dos flavanoides que parecem ser úteis ao inibirem a oxidação do LDL,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

reduzindo sua aterogenicidade. Assertiva correta.

88634.

Comentário: A presença de diabetes mellitus , por si só, já é suficiente para colocar o paciente na categoria alto risco cardiovascular , pois o risco de eventos cardiovasculares atribuído ao diabetes mellitus é equiparável ao risco atribuído à existência prévia de doença coronariana conhecida. Do modo como o enunciado está escrito estamos falando de um paciente que tem pelo menos 3 fatores de risco (idade, tabagismo e HAS ou DM), o que também implica alto risco cardiovascular. Assertiva, portanto, correta.

49193.

Comentário: Estamos diante de um paciente idoso do sexo masculino com quadro de dor torácica aguda típica, muito sugestivo de um infarto agudo do miocárdio (dor precordial em aperto, com irradiação para o MSE, duração 30 min em repouso, associada a sudorese e vômitos) Diante deste cenário é mandatório obter um ECG de 12 derivações em menos de 10 min. E o que estamos vendo neste ECG Ora, há um nítido supradesnivelamento do segmento ST em toda a parede anterior (de V1 a V6) e também na parede lateral (V5, V6, DI e aVL). Trata-se, portanto, de um IAMST extenso, provavelmente relacionado a uma oclusão proximal da DA ou mesmo do tronco da coronária esquerda, com indicação emergencial de alguma terapia de reperfusão (de preferência a angioplastia primária, se possível). O ritmo cardíaco é sinusal, pois observamos ondas p precedendo os complexos QRS (melhor derivação para análise D2 longo , inscrita na parte inferior do papel). A distância entre as ondas R (intervalo RR) é de aproximadamente 3 quadradões , o que dá uma resposta ventricular (frequência cardíaca) em torno de 100 bpm. O eixo elétrico médio da ativação ventricular (eixo médio do QRS) está em torno de -30º... Vamos relembrar Como está o complexo QRS em D1 Positivo, logo, o eixo médio está entre -90º e 90º. Como está o complexo QRS em aVF Negativo, logo, o eixo médio está entre zero e -90º. E como está em D2 Está isodifásico (fase positiva fase negativa), logo, o eixo médio coincide com uma linha perpendicular à derivação D2, ou seja, possui angulação de -30º. Podemos dizer, por conseguinte, que existe um hemibloqueio anterior esquerdo Só pra finalizar, pois o enunciado questiona qual seria a principal

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

alteração funcional presente... Bem, se existe supra de ST agudo (no contexto apropriado de um quadro clínico de IAM), a conclusão funcional óbvia é que existe oclusão completa de uma artéria coronária epicárdica, levando a um quadro de isquemia transmural. A conclusão final do caso, na realidade, já demos no início do comentário, até porque em casos como esse, na vida real, o diagnóstico tem que ser dado de imediato

52638.

Comentário: A cocaína é uma droga com propriedades simpatomiméticas, em particular, estimulando receptores alfa-adrenérgicos (vasoconstricção). O uso de betabloqueadores no contexto de uma síndrome coronariana aguda desencadeada pela intoxicação por cocaína pode resultar na exacerbação da isquemia miocárdica pelo fato de os betabloqueadores (cujo efeito é relativamente seletivo para os receptores beta-adrenérgicos nas paredes dos vasos, isto é, receptores com ação miorrelaxante) fazerem a balança pender para o lado da vasoconstricção nesta situação peculiar ... Ora, os betabloqs, no paciente intoxicado pela cocaína, promovem vasoespasmo coronariano e periférico, levando a um aumento da isquemia miocárdica e também da pressão arterial sistêmica, respectivamente, devendo ser evitados neste contexto. Afirmativa correta.

37943.

Comentário: Caso clínico interessante, porém, a pergunta neste momento é bem simples e direta. O que estamos vendo neste ECG Há uma onda Q patológica (larga e profunda, isto é, com 1 quadradinho de tamanho) em toda a parede inferior do coração (DII, DIII e aVF). A onda Q, quando com características patológicas , indica inatividade elétrica do miocárdio, que na grande maioria das vezes, na prática, é secundária a um infarto miocárdico prévio, seguido da formação de fibrose (cicatriz). Logo, considerando o contexto clínico (paciente sabidamente coronariopata e sintomática), podemos afirmar que o ECG de repouso está mostrando, muito provavelmente, o IAM prévio de 6 meses atrás. Afirmativa correta.

8603.

Comentário: Questão fácil onde a rotina de abdome agudo foi decisiva para o diagnóstico e conduta

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Observe que existe ar logo abaixo da hemicúpula diafragmática direita (pneumoperitônio), gerando um espaço entre esse músculo e o lobo hepático direito... No lado esquerdo podemos observar a bolha gástrica fisiológica, pois o paciente estava de pé na hora do exame Muita gente pode ter pensado em dissecção de aorta, pois lá em cima no campo pulmonar esquerdo se observa uma discreta hipotransparência paramediastinal... Felizmente, essa hipotransparência nada mais é que o HILO PULMONAR ESQUERDO (talvez o direito não esteja aparecendo tão nitidamente porque a radiografia deve estar rodada)... Se existe pneumoperitônio, não temos dúvida que existe perfuração no trato gastrointestinal, o que inclusive é perfeitamente compatível com a clínica de abdome agudo apresentada pelo doente... O mesmo é usuário de AAS, e talvez este fato justifique a existência de uma úlcera gástrica perfurada Seja como for estamos diante de um paciente de alto risco que necessita de cirurgia de emergência, e a conduta mais adequada é realizar uma laparotomia exploradora, encaminhando o paciente para pós-operatório em unidade fechada (CTI)...

343391.

Comentário: Vamos analisar as alternativas Letra A incorreta. Principalmente na forma aguda, o que melhor caracteriza a pericardite é a dor torácica, de localização precordial ou retroesternal, contínua, tipo pleurítica (piora com a inspiração profunda e tosse), que piora com o decúbito dorsal e é aliviada na posição sentada com o tronco inclinado para frente (posição genupeitoral) ou abraçado ao travesseiro (posição de Blechman). Em alguns casos a dor pode simular a angina pectoris, tendo caráter constritivo e irradiando para o braço esquerdo. Mas não há alívio com nitroglicerina. Letra B correta A pleura visceral (mais interna) é inervada pelo plexo autonômico simpático e não possui receptores de sensação dolorosa. A pleura parietal (mais externa), por sua vez, é rica em terminações nervosas sensitivas, sendo a estrutura responsável pela dor na maioria das afecções pulmonares. Apesar do padrão variável, é comum a presença de aspecto pleurítico. Letra C incorreta. Dor torácica é uma queixa comum entre pacientes com transtornos psiquiátricos, representando até 10% dos atendimentos relativos à dor torácica no setor de emergência. Os distúrbios que mais se apresentam dessa forma são o transtorno do pânico e a depressão. Em

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

alguns casos, o diagnóstico diferencial com síndrome coronariana aguda é desafiador. Letra D incorreta. As doenças do esôfago, em especial o Espasmo Esofagiano Difuso (EED), são condições que não raramente cursam com cólica esofagiana . No EED, essa dor torácica possui localização retroesternal típica, é intensa, compressiva, e pode irradiar para o restante do tórax, dorso, braços e mandíbula, durando de alguns segundos a vários minutos. Em geral ocorre no repouso, mas pode se associar à deglutição, à tensão emocional e aos exercícios E ainda é aliviada com uso de nitrato Como você pode concluir, às vezes o paciente com EED chega à emergência como se estivesse sofrendo um IAM O que nos permite diferenciar clinicamente o EED da dor de origem cardíaca muitas vezes é a disfagia, comumente (mas nem sempre) observada no primeiro. Resposta letra B.

334883.

Comentário: Questão sem maiores dificuldades Temos um paciente obeso, tabagista e sedentário com quadro de dor epigástrica em queimação de forte intensidade. A dor epigástrica, principalmente em um paciente com risco cardiovascular considerável, deve nos atentar para um possível quadro de equivalente anginoso e uma cuidadosa avaliação no sentido de diagnosticar um evento isquêmico coronariano deve ser realizado. Ao analisarmos o ECG podemos observar a presença de supradesnível do segmento ST na parede anterior (V1 a V4). A dor epigástrica (equivalente anginoso) associada ao supradesnível do segmento ST corrobora com o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Vamos avaliar as alternativas Letra A incorreta. O bloqueio de ramo direito apresenta como característica fundamental um complexo QRS alargado (120 ms). Podemos observar ainda onda R secundária (R) larga (padrão pode ser rsr , rsR ou rSR , em derivações V1 e V2 - orelhas de coelho) onda S profunda, ampla e empastada nas derivações precordiais esquerdas V5 e V6 deflexão intrinsecóide retardada (o início do complexo QRS até o pico da onda R tem duração 50 ms nas derivações precordiais direitas V1 e V2). Não há alteração segmento ST. Letra B correta. Conforme vimos acima, o infarto agudo do miocárdio é a hipótese diagnóstica mais acertada para essa questão. Letra C incorreta. A Síndrome de Wolff Parkinson White (WPW) é originada de uma via acessória congênita que permite a condução do átrio para o ventrículo (anterógrada), ou seja, o estímulo elétrico atinge o ventrículo pela via acessória antes do nódulo

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

AV, gerando uma pré-excitação ventricular (Onda Delta) e encurtando o intervalo PR. Os pacientes com padrão eletrocardiográfico de WPW possuem vias acessórias A-V que têm capacidade de condução anterógrada, resultando em alterações típicas no eletrocardiograma (intervalo PR curto ou ausente e presença de onda delta no início do complexo QRS). Letra D incorreta. Na hipertonia vagal esperamos exacerbação do parassimpático e achados eletrocardiográficos de bradicardia. Não são esperadas alterações no padrão ST. Letra E incorreta. A fibrilação atrial é definida no eletrocardiograma pela ausência de onda P e intervalo RR irregular. Resposta letra B.

291558.

Comentário: Paciente de 55 anos, com fatores de risco para doença arterial coronariana (diabetes e hipertensão), apresenta dor torácica opressiva há 12h, além de manifestações clínicas sugestivas de Insuficiência Cardíaca (IC) aguda com perfil frio e úmido pulsos periféricos diminuídos, edema, hepatomegalia, ascite (abdome globoso) e congestão pulmonar. Dor torácica em paciente de risco, até que se prove o contrário, é igual à síndrome coronária aguda O ECG corrobora esse diagnóstico, evidenciando sinais de isquemia, ou seja, supradesnivelamento do segmento ST na parede anterior e lateral (V2 a V6 DI e aVL), equivalente a infarto anterior extenso letra D incorreta. O melhor tratamento para a síndrome coronariana aguda com supra de ST é a terapia perfusional com angioplastia primária, realizada pelo cateterismo (letra B correta letra A incorreta). Ainda que o paciente apresente um delta T de início de sintoma prolongado (12h), o benefício nesse caso é indiscutível, já que há sinais de IC descompensada. O balão intra-aórtico é uma terapia específica de suporte hemodinâmico para a IC aguda, em caso de não resposta à terapia farmacológica do choque e à terapia reperfusional (letra C incorreta). Resposta letra B.

230548.

Comentário: Questão extraída do Posicionamento sobre Antiagregantes Plaquetários e Anticoagulantes em Cardiologia - 2019. Vamos, então, revisar um trecho que respondia a questão Recomendações para uso de antiagregantes plaquetários e anticoagulantes em pacientes oncológicos com trombocitopenia Uso do ácido acetilsalicílico em pacientes com doença coronária classe de recomendação I. (letra A - CORRETA) O ácido acetilsalicílico deve ser usado sempre em

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

dose mínima, preferencialmente 100 mg ao dia classe de recomendação IIa. (letra B - INCORRETA) Uso de terapia antiplaquetária e ou anticoagulante em pacientes com síndrome coronária aguda, mesmo com plaquetopenia classe de recomendação IIa. (letra C - INCORRETA) Uso de dose reduzida de enoxaparina e heparina não fracionada em pacientes com contagem de plaquetas 50.000. Monitorização de alvo terapêutico classe de recomendação IIa . (letra D - INCORRETA) Resposta letra A.

244470.

Comentário: Pessoal, a assertiva C é conceitual e corretíssima, trazendo um conceito básico sobre vascularização do VD e parede inferior, que geralmente apresentam a mesma origem. Por essa razão, em todo paciente diagnosticado com IAM inferior, devemos rodar as precordiais direitas para avaliar se há infarto de VD concomitante. Quanto às demais assertivas - A está incorreta, pois o derrame se manifesta de forma aguda (primeiras 24h) ou subaguda (2-12 semanas). A incidência, também, é bem menor que a relatada. - B está incorreta, pois o delta T para trombólise é de 12 horas. - Dentre os parâmetros listados na opção D, apenas hipotensão e idade entram no TIMI risk. D incorreta. - Por fim, não há indicação de lidocaína profilática. E errada.

230556.

Comentário: Diversos métodos foram desenvolvidos para auxiliar na avaliação de placas intermediárias visualizadas na coronariografia. Tal avaliação é importante uma vez que sabe-se que placas discretas não devem ser alvo de revascularização e placas importantes devem ser abordadas, principalmente após síndrome coronariana aguda. No entanto, os métodos desenvolvidos ajudam a entender as características, o risco associado e o impacto das placas ateroscleróticas intermediárias na circulação cardíaca. Entre estes métodos estão o FFR, que avalia a variação de fluxo pré e pós placa, o OCT, tomografia intra coronária, e a ultrassonografia. Este último auxilia no entendimento da constituição da placa, uma vez que sabemos que placas calcificadas estão relacionadas a um menor risco de rompimento, enquanto placas moles , ricas em conteúdo lipídico, estão mais associadas a síndromes coronarianas agudas. Gabarito Alternativa D.

206086.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Questão confusa e mal elaborada,mas que cobra o conceito de Doença Aterosclerótica Subclínica. Aparentemente, a banca pede para marcar qual dos itens não é um método possível para avaliar aterosclerose subclínica. Vamos lembrar quais são Escore de cálcio arterial coronário (escore de Agatston) por AngioTC com contraste Placa carotídea (espessura íntima média 1,5 mm) por por ultrassonografia bidimensional Angiotomografia coronária computadorizada com presença de placa 50% obstrução O índice tornozelo-braquial é usado para risco cardiovascular. Resposta LETRA D.

206135.

Comentário: Uma questão sobre ESCORE DE CÁLCIO ARTERIAL CORONÁRIO. Devemos lembrar que esse escore tem validade principalmente na detecção de Doença Aterosclerótica Subclínica, ou seja, nos pacientes que foram classificados pelos escores tradicionais como framingham em baixo risco ou risco intermediário, mas que se olharmos com mais cuidado, mais detalhe, perceberemos que na verdade eles são alto risco cardiovascular. Esse olhar com detalhe seria fazer uma angioTC, avaliar as calcificações e definir o escore de cálcio(escore de Agatston) do paciente. A pergunta é, fazemos para todos Não O racional é fazer na população que terá benefício de intervenção ADULTOS COM RISCO CARDIOVASCULAR(baixo ou intermediário) Por isso que a resposta certa é LETRA D.

206147.

Comentário: Enunciado confuso, mas a banca quer saber em qual cenário está INCORRETO iniciar investigação de DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA.O paciente já é DIABÉTICO, ou seja, quer nos direcionar para um paciente de, no mínimo,intermediário a alto risco cardiovascular, dependendo da idade. Agora ficou fácil, você investigaria com toda certeza esse paciente se ele apresentasse qualquer um dos cenários descritos nas letras A,B e C. Mas a LETRA D fala do escore de cálcio, que tem seu valor maior na Doença Aterosclerótica Subclínica, por isso essa alternativa está incorreta. GABARITO LETRA D.

206151.

Comentário: De preferência, a investigação de doença coronariana deve ser iniciada com um ECG

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

de repouso e ou um teste ergométrico. Contudo, a análise deste fica prejudicada quando algumas alterações eletrocardiográficas (um BRE, por exemplo) são encontradas. Nesses casos, podemos indicar a realização de um ecocardiograma com estresse farmacológico, uma cintilografia de perfusão miocárdica, uma ressonância magnética cardíaca com perfusão miocárdica, entre outros. A cintilografia do miocárdio (SPECT) com tálio ou a cintilografia com sestamibi, de fato, fornecem informações bastante úteis, como a localização e a extensão da isquemia, além da função ventricular. Resposta letra A.

203106.

Comentário: O ECG com supra em DII, DIII e aVF demonstra um infarto de parede inferior, que, em 70% das pessoas é irrigada pela coronária direita e nos outros 30% pela artéria circunflexa. A bradicardia sinusal encontrada pode ser justificada pela perfusão do nodo sinusal a partir da mesma coronária direita. Resposta certa LETRA B.

212077.

Comentário: A pergunta dessa questão é se o quadro seria compatível com um infarto agudo de miocárdio, o que gerou confusão. Na verdade, o afirmativa não diz que a principal hipótese diagnóstica é de infarto, mas o que se afirma é que esse é um dos diagnósticos diferenciais de dor epigástrica atípica. De fato, a principal hipótese nesse caso, uma paciente com dor epigástrica e em hipocôndrio direito prolongada, associada a vômitos, taquicardia discreta e icterícia leve, é de doença aguda da via biliar, mas é importante na avaliação clínica ter em mente também os principais diagnósticos diferenciais hepatite aguda, doença ulcerosa péptica e, sim, síndrome coronariana aguda. A afirmativa, assim, está correta. Resposta alternativa A.

175089.

Comentário: Questão conceitual sobre eletrocardiograma. Alterações eletrocardiográficas como bloqueio de ramo, onda Q (indicativo de zona de inatividade elétrica) e evidência de isquemia indicam risco elevado de eventos cardiovasculares (alternativa A incorreta e alternativas B e C corretas). A análise de supra ou infradesnível do segmento ST e inversão de onda T simétrica ao ECG são achados com alta especificidade, mas pouco sensíveis, pois ainda que não haja alteração

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

eletrocardiográfica, os pacientes podem apresentar doença coronariana e infarto (alternativa D correta). Gabarito Alternativa A.

175090.

Comentário: A enoxaparina é uma droga importante no tratamento do infarto agudo do miocárdio, devendo ser administrada nas seguintes doses em pacientes com idade 75 anos 30 mg IV em bolo e após 1,0 mg kg de peso subcutâneo de 12 12 horas até a alta hospitalar em pacientes com idade maior ou igual a 75 anos não administrar o bolus e iniciar com 0,75 mg kg subcutâneo de 12 12 horas. Vale lembrar que, embora a enoxaparina não tenha demonstrado redução de mortalidade, há redução na ocorrência de infarto do miocárdio não fatal, sem um aumento importante de sangramento. Gabarito Alternativa D.

177262.

Comentário: A questão apresenta um paciente com infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, sem realização de terapia adequada (angioplastia ou trombólise) e que evolui, portanto, com uma complicação grave e pouco frequente nos dias atuais, a ruptura de músculo papilar. Por tratar-se de necrose transmural, há risco aumentado de ruptura do músculo papilar, o que resulta no quadro clínico apresentado de insuficiência mitral aguda, instabilidade hemodinâmica e edema agudo de pulmão. Para esses casos, torna-se essencial estabilizar o paciente, realizar ecodopplercardiograma para definição do diagnóstico e programação cirúrgica, uma vez que há alta mortalidade caso o paciente não realize troca ou plastia mitral precocemente. Gabarito Alternativa A.

183912.

Comentário: Estamos diante de um paciente com uma síndrome coronariana aguda. No ECG, há supradesnivelamento do segmento ST de V1 a V6 e em D1 e aVL um infarto agudo do miocárdico anterior extenso, provavelmente com acometimento de tronco de coronária esquerda. Ainda por cima há relato de aumento de marcadores de necrose miocárdica para não deixar nenhuma dúvida de que é um infarto mesmo Pacientes com supradesnivelamento de ST e início dos sintomas em menos de 12 horas tem indicação de terapia de reperfusão. Entre angioplastia percutânea e

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

trombólise, damos sempre preferência à angioplastia se conseguirmos realizá-la em 90 minutos ou em 120 minutos caso seja necessário transferir o paciente para um hospital em que haja serviço de hemodinâmica. O médico não opta pela que tiver possibilidade de início mais rápido. Não é porque você está com o trombolítico na mão que você vai utilizá-lo Se houver disponível um serviço de hemodinâmica em tempo hábil, devemos esperar, pois o desfecho nesse caso é melhor do que com uso de trombólise Assim, a afirmativa está ERRADA, solicitamos anulação, mas a banca não cedeu, mantendo o gabarito como CERTO... Paciência.

183930.

Comentário: Paciente se apresenta com dor retroesternal em aperto, há 4h, bastante intensa e irradiação para membro superior esquerdo, configurando quadro clássico de síndrome coronariana aguda. O eletrocardiograma mostra supradesnível do segmento ST nas precordiais pegando, portanto, toda a parede anterior além de em DI aVL, ou seja, acometendo também a parede lateral alta. A combinação de supra da parede anterior com a lateral alta configura corrente de lesão na parede anterior extensa. A elevação das troponinas corrobora o diagnóstico de infarto anterior extenso com supradesnível do segmento ST. Assertiva correta. Resposta A.

175167.

Comentário: Questão retirada na íntegra do documento intitulado V Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST , mais precisamente em sua página 80. Vamos retirar o trecho ao qual as assertivas se referem e aprender com a questão É importante a avaliação do anseio do paciente e qual atividade e, principalmente, qual desempenho ele espera atingir (A correta). Assim, podemos realizar uma estratificação de risco de acordo com a atividade física que o paciente deseja realizar. Os pacientes, após submetidos à estratificação, devem ser classificados entre baixo, moderado e alto risco (B correta). Os pacientes de baixo risco são os que não apresentaram alterações nos exames complementares e que permanecem assintomáticos são orientados a realização de quaisquer tipos de atividade física (C INCORRETA). Já os indivíduos de moderado e alto risco são contraindicados às atividades competitivas e devem ser encaminhados para atividades físicas supervisionadas e,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

posteriormente, após tratamento e acompanhamento profissional, devem ser gradativamente encorajados às atividades físicas não supervisionadas (D correta). Perceba que somente a letra C encontra-se errada e portanto é o nosso gabarito.

175169.

Comentário: Questão retirada na íntegra do documento intitulado V Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST , mais precisamente em sua página 80. Vamos retirar o trecho ao qual as assertivas se referem e aprender com a questão A prática de natação e hidroginástica merece alguns cuidados. Apesar de ideal para os obesos, pode gerar alguns problemas para o coronariano, como bradicardia reflexa vagal e arritmias complexas (A correta). O choque térmico pode causar espasmos arteriais (B correta). A zona-alvo da frequência cardíaca de treinamento deve ser reduzida em dez batimentos, em decorrência de reflexo vagal de imersão da face. Pacientes infartados que não possuam prévio domínio da técnica natatória devem ser desaconselhados à prática da natação, sendo-lhes permitida hidroginástica (D INCORRETA). Indivíduos que já estejam praticando atividade física no pósIAM devem ser orientados às mínimas modificações nos sintomas e sinais, ou a alterações nos exames de reavaliação indicativas da progressão da doença aterosclerótica coronária (C correta). Como o enunciado deseja a única INCORRETA, o nosso gabarito é a letra D.

175172.

Comentário: O uso do ácido acetil salicílico (AAS) é imprescindível na abordagem de pacientes com doença arterial coronariana aguda (alternativa A incorreta), salvo contra indicação, como alergia, sangramento ativo, hemofilia ou úlcera péptica ativa (alternativa B correta), uma vez que o seu uso reduz a mortalidade desses pacientes em cerca de 23% (alternativa D incorreta). Pacientes de alto risco devem ser instruídos a utilizarem AAS NÃO tamponado em situações de emergência (alternativa C incorreta). Gabarito Alternativa B.

175177.

Comentário: Questão retirada, na íntegra, da V Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST. Vamos,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

então, rever o trecho que respondia a questão e aproveitar para revisar o tema Curva ou alteração da troponina Com o uso de ensaios cada vez mais sensíveis para dosagem de troponinas, as mudanças absolutas e relativas de seus valores na fase aguda têm sido muito valorizadas para o diagnóstico correto de IAM. Alguns estudos demonstraram que incrementos relativos de 20 a 50% em relação aos valores basais são suficientes para detectar uma curva. (letra A - INCORRETA) Da mesma forma, incrementos absolutos (de uma vez o referencial de cada ensaio) também demonstraram uma acurácia melhor que a dosagem isolada das troponinas na admissão. (letra B - CORRETA) Os estudos sugerem que mudanças absolutas sejam superiores a incrementos relativos. No entanto, não existe consenso de qual ponto de corte seja ideal (letra C - CORRETA) incrementos nas troponinas ultrassensíveis são muito sensíveis para infarto em evolução, mas pouco específicos. (letra D - CORRETA) Resposta letra A.

175176.

Comentário: A reabilitação cardíaca pós-IAM é comprovadamente benéfica e custo-efetiva (C correta). Seu programa deve ser abrangente, consistindo não apenas de rotinas de exercícios físicos, mas também em adesão a mudanças no estilo de vida, adotando-se uma rotina mais saudável capaz de modificar fatores de risco controláveis (D correta). Infelizmente, a taxa de adesão aos programas de reabilitação declina com o passar do tempo, como acontece com toda forma de tratamento conservador fundamentado em mudanças de hábito por longo prazo (A correta). No entanto, a insistência do médico e a integração da equipe multidisciplinar comprovadamente são capazes de ajudar a manter maiores taxas de adesão (B errada)... Resposta certa B.

168434.

Comentário: Existem sinais e sintomas de síndrome coronariana aguda neste paciente de alto risco cardiovascular, e existe supra de ST na parede inferior (D2, D3 e aVF) acompanhado de provável imagem em espelho de um supra de ST na parede dorsal (infra de ST em V1-V2), além de supra de ST em V5 e V6 (parede lateral). Logo, o diagnóstico é de IAMST inferolateral-dorsal Como o delta-T é de 90 min, o marcador de necrose miocárdica que estará positivo neste momento é a mioglobina

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

(positivo nas primeiras 2h). A partir de 3-4h podemos esperar aumento das troponinas cardioespecíficas e, posteriormente (4-6h), da CK-MB. Resposta C.

104738.

Comentário: Questão tranquila. O eletrocardiograma corresponde ao registro gráfico dos potenciais elétricos gerados pelo coração. Suas ondas s o denominadas em ordem alfabética. A onda P representa a despolarizaç o atrial. O complexo QRS representa a despolarizaç o ventricular. O complexo ST-T-U (segmento ST, ondas T e U) correspondem a repolarizaç o ventricular. Em geral, a repolarizaç o atrial tem amplitude muito baixa para ser detectada pelo ECG. Letra E correta.

104755.

Comentário: A frequência cardíaca máxima estimada durante o exercício físico é, geralmente, calculada subtraindo-se a idade de 220 (ou seja, 220 menos idade). A atividade física deveria, então, manter a freqüência cardíaca entre 65% e 80% da freqüência cardíaca máxima calculada. Exemplificando para um indivíduo de 60 anos, a freqüência cardíaca máxima 220 - idade é 160 e a atividade física deveria manter entre 104 e 128 batimentos cardíacos por minuto. Dessa forma, alternativa C correta.

80711.

Comentário: Uma das PRIMEIRAS atitudes a se tomar quando um doente com dor torácica dá entrada no seu pronto-socorro é realizar um eletrocardiograma em repouso de 12 derivações NOS PRIMEIROS DEZ MINUTOS. Lembre-se sempre, caro amigo TEMPO É MÚSCULO Devemos analisar, neste eletro, a presença de alterações do segmento ST. Para fecharmos esse conceito, vamos dar uma olhadinha nas alternativas Letra E Não, a Fibrilação Atrial (FA) nem sempre está associada a alterações do segmento ST. Simplesmente não há relação direta entre as duas coisas. Lembrando que a FA é uma arritmia caracterizada pela ausência de atividade atrial organizada, com frequência entre 90-170 bpm, ritmo irregular e QRS estreito. Alternativa incorreta. Letra D O infradesnivelamento do segmento ST - infra de ST, para os mais íntimos - ocorre agudamente em pacientes com corrente de lesão aguda no miocárdio. Em nada interfere a presença de coronariopatia prévia. Letra C O infra de ST não precisa estar presente num eletrocardiograma de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

um doente que evoluirá para fibrilação ventricular. Letra B O supradesnível do segmento ST INDICA oclusão das coronárias (infarto agudo do miocárdio), apesar de não ser patognomônico. Letra A Caso você faça um eletrocardiograma em um doente com dor torácica há menos de 12 horas e neste eletro apareça supradesnível do segmento ST em DUAS DERIVAÇÕES CONTÍGUAS, está indicada revascularização de urgência, que pode ser obtida tanto com a angioplastia primária quanto com a trombólise. Resposta certa Letra A.

80704.

Comentário: Vamos analisar as opções A) Incorreta. Tanto houve benefício, que passou a ser obrigatório em alguns centros. A fibrilação ventricular é um ritmo muito importante de parada e a chance de tratá-lo de forma adequada aumenta muito com o uso do desfibrilador. B) Correta. C) Incorreta. Ainda que ocorre uma subnotificação, esssas informações são fundamentais para melhorar as práticas de tratamento da PCR. Um exemplo foi a retirada da atropina no algoritmo do tratamento da assistolia. D) Incorreta. Infelizmente não é verdade. A PCR prolongada pode levar a sequelas neurológicas gravíssimas, relacionadas a hipóxia mantida. E) Incorreta. Claro que representa. A fase pré-hospitalar é importantíssima e deve ser alvo de muita atenção. A hipóxia pode começar ainda nessa fase e tem muita repercussão posterior. Um BLS bem feito é fundamental para um ACLS de sucesso. Resposta, item B.

97752.

Comentário: O quadro descrito é compatível com o diagnóstico de rotura de septo interventricular , uma das mais graves complicações mecânicas do IAM (quando ocorre no contexto do IAM inferior, a porção inferior do SIV é rompida)... Na rotura de septo, o débito sistólico do ventrículo esquerdo e, consequentemente, o próprio débito cardíaco, diminuem subitamente, pois parte desse débito passa a ser jogada para dentro do ventrículo direito. Desse modo, além de choque circulatório (baixa perfusão tecidual generalizada), nota-se um quadro de sobrecarga do VD e falência aguda desta câmara (ex. TJP). Há também falência do VE (com edema agudo de pulmão), configurando um quadro de insuficiência cardíaca biventricular aguda que clinicamente pode ser difícil de distinguir da rotura de músculo papilar com insuficiência mitral grave (quem definirá essa

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

diferenciação nos casos duvidosos é o ecocardiograma à beira do leito), ainda que a presença de sopro frêmito holossistólicos mais intensos na BEE baixa, irradiando da esquerda para a direita, seja sugestiva de ruptura de septo... Pois bem, o que fazer com estes pacientes Por ser uma complicação mecânica grave, a única chance de sobrevida é a cirurgia cardíaca imediata (para fechamento do comunicação interventricular). A fim de estabilizar o paciente até a chegada ao centro cirúrgico, devemos lançar mão do mais potente vasodilatador arterial conhecido o nitroprussiato, que reduz a resistência vascular periférica aumentando a ejeção ventricular esquerda e, desse modo, reduzindo o fluxo esquerda-direita que tanto prejudica o paciente neste momento... Também devemos ministrar um cardiotônico como a dobutamina, cujo intuito é melhorar ainda mais o débito cardíaco... Resposta certa C.

97805.

Comentário: Olha o que o enunciado está dizendo afasta o diagnóstico de dor torácica NÃO CARDÍACA ... Ou seja aponta para um diagnóstico de dor torácica CARDÍACA É, parece que o autor da questão se enrolou aqui. O gabarito oficial da banca foi a letra D diante da ausência de elevação dos marcadores de necrose miocárdica (CK-MB e troponina), um diagnóstico de IAM não pode ser confirmado. Ora, tal achado é compatível, por conseguinte, com uma dor torácica não cardíaca, mas a questão está perguntando o que AFASTARIA esta possibilidade. Sendo assim, não dá pra marcar a letra D com o que o enunciado está pedindo. A esofagite de refluxo pode muito bem coexistir com a doença coronariana, logo, ela não afasta dor cardíaca, apesar de revelar a existência de um componente de dor não cardíaca (logo, ela também não afasta dor não cardíaca). ECG e ECO normais não afastam dor cardíaca (é possível ter isquemia miocárdica com ECG e ECO normais, apesar de um ECO bem feito dificilmente ser normal na vigência de isquemia em atividade), assim como também não afastam dor torácica não cardíaca. Logo, questão sem resposta certa, que merecia ter sido anulada O gabarito oficial foi a letra D.

64433.

Comentário: Já foi amplamente demonstrado na literatura médica que o uso de bloqueadores de canais de cálcio di-hidropiridínicos de ação rápida - como a nifedipina - aumentam a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

morbimortalidade no contexto do infarto agudo do miocárdio, e por isso tais drogas estão absolutamente CONTRAINDICADAS nesses pacientes O motivo é o que os di-hidropiridínicos de ação rápida promovem uma súbita e poderosa vasodilatação periférica, o que gera taquicardia reflexa e aumento exagerado do consumo miocárdico de oxigênio (ampliando a área de infarto). Resposta certa letra C.

75539.

Comentário: O ECG deste paciente de 54 anos de idade e múltiplos fatores de risco para DAC é compatível com IAM com supra de ST em parede inferior (D2, D3 e aVF), que comumente se associa ao infarto de VD (até 50% dos casos). Os portadores de infarto de VD (que só seria diagnosticado caso rodássemos o ECG com as derivações V3R e V4R) se apresentam hipotensos e com insuficiência ventricular direita (caracterizada pela TJP). Quando o IAM inferior se associa ao infarto de VD, são contraindicados diuréticos, morfina e nitratos, devendo o paciente receber hidratação venosa visando ao restabelecimento da pressão arterial. Resposta, portanto, letra C.

137701.

Comentário: Temos uma síndrome coronariana aguda. O que fazer Vamos analisar o ECG para separar em com ou sem supra de ST. Nessa situação é uma síndrome sem supra de ST, mas com o ECG alterado porque mostra uma inversão importante de onda T nas derivações precordiais. Portanto, temos uma síndrome sem supra e grave (ECG alterado em relação ao basal e dor nas últimas 48horas). Nesse caso devemos fazer tudo que lembrarmos de tratamento anti-isquêmico (nitroglicerina betabloqueador) e antitrombótico (AAS, CLOPIDOGREL, ENOXIPARINA COM OU SEM INIBIDOR DA GPIIb IIIa , SEM o uso de trombolítico Portanto, resposta letra A.

138599.

Comentário: Sigam a linha de raciocínio 1º passo - Fatores de Risco Mulher, com 58 anos de idade, diabética, Paciente com risco de doença arterial coronariana e aterosclerose 2º passo - Anamnese Dor torácica opressiva, com dor precordial opressiva, intensa, irradiada para membro superior esquerdo e sensação de morte iminente, duração de 40 minutos Dor com características TÍPICAS DE ANGINA Como constatamos marcadores de necrose miocárdica NORMAIS, definimos Angina

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Instável 3º passo - Conduta Internar o paciente em uma unidade coronariana, iniciar terapia anti-isquêmica e antitrombótica, estimando o risco da atual síndrome coronariana aguda (isto é, risco de morbimortalidade cardiovascular).

351582.

Comentário: A questão traz paciente com quadro de dor precordial com as mesmas características do infarto agudo miocárdio prévio do paciente, acompanhado de palidez e sudorese. É provável que ele tenha tido uma angina de peito aguda e intensa, de caráter constritivo ou em queimação , de localização subesternal ou precordial. Portanto, nossa hipótese inicial será de uma SÍNDROME CORONARIANA AGUDA (SCA). O grande divisor de águas na definição da hipótese diagnóstica será o eletrocardiograma . Observe que esse exame não teve qualquer alteração no segmento ST, portanto, por definição, trata-se de uma SCA sem supra desnivelamento do segmento ST. Vamos analisar as assertivas e destrinchar um pouco mais Letra A correta. Existem dois tipos de SCA sem supra do segmento ST. A angina instável e o infarto agudo do miocárdio sem supra do segmento ST (IAMSST) Por definição, na angina instável, não ocorre injúria isquêmica suficiente para levar à necrose miocárdica, portanto, não há elevação das troponinas. É justamente o caso do nosso paciente Observe que as troponinas vieram consecutivamente negativas em três dosagens. Se houvesse elevação, o diagnóstico seria de IAMSST. Letra B incorreta. Esse seria o diagnóstico caso houvesse elevação das troponinas. Letra C incorreta. Não pode ser esse o diagnóstico, pois o eletrocardiograma não tem supra. Letra D incorreta. A angina estável é a manifestação clínica da crônica de doença coronariana, portanto, não compatível com o quadro descrito. Resposta letra A.

352187.

Comentário: Questão bem direta que nos perguntou sobre os tipos de infarto agudo do miocárdio, vejamos cada um deles, buscando a incorreta Letra A correta. O tipo 1, e mais clássico de todos, é o decorrente da instabilização de placa aterosclerótica. Letra B correta. O tipo 2 é relacionado ao desbalanço entre oferta e demanda de oxigênio, como em situações de alta demanda metabólica, como anemia ou sepse. Letra C correta. O tipo 3 é relacionado à morte súbita e que não houve tempo de coletar exames de necrose miocárdica. Letra D incorreta. O tipo 4 é o infarto relacionado

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

à angioplastia. Tanto pode ocorrer como consequência imediata do procedimento (IAM tipo 4a) como após o procedimento devido à trombose do stent (tipo 4b). Ainda há, também, o tipo 4c que é o ligado à reestenose intrastent. A banca não cobrou, mas vale a pena citar um quinto tipo tipo 5 relacionado à cirurgia de revascularização miocárdica. Resposta letra D.

320451.

Comentário: Em relação às síndromes coronarianas agudas, vamos analisar cada uma das alternativas Letra A incorreta. Na verdade, a oxigenoterapia (2-4 L min, por cateter nasal ou máscara) está formalmente indicada em pacientes com risco intermediário e alto na presença de SpO2 90% (algumas referências citam 94%) e ou sinais clínicos de desconforto respiratório. Ou seja, não deve ser feita de rotina. Oxigenoterapia desnecessária, por tempo prolongado, pode ser prejudicial, por causar vasoconstrição sistêmica. Naqueles com hipoxemia persistente, a oxigenoterapia deverá ser mantida enquanto for necessário, com ajuste pela oximetria de pulso e gasometrias arteriais seriadas. Naqueles com hipoxemia refratária ou grave, indica-se Ventilação Não Invasiva (VNI) ou mesmo intubação Orotraqueal (IOT). Letra B correta. De fato, o uso de betabloqueadores (via oral) deve ser feito nos pacientes sem sinais de baixo débito. Lembre-se que os BB são drogas que reduzem a FC, o inotropismo e a PA (isto é, reduzem o MVO2) ao mesmo tempo em que aumentam o fluxo sanguíneo na rede de colaterais e no subendocárdico (isto é, aumentam o MDO2). Logo, exercem efeitos sinérgicos no combate à isquemia Devem ser dados o quanto antes (dentro das primeiras 24h), preferencialmente pela via oral, em pacientes sem contraindicações (ex sinais de insuficiência cardíaca ou evidência de baixo débito cardíaco, BAV de 2º ou 3º graus, DPOC grave..) e sem fatores de risco para choque cardiogênico nas primeiras 24h (ex PAs 120 mmHg, FC 110 bpm..). Ou seja, a presença de sinais de baixo débito contraindica o uso dos BB. Visa-se manter a FC em torno de 50-60 bpm. A via IV é reservada aos casos refratários, bem como aqueles com crise hipertensiva ou taquiarritmias. A escolha do BB específico depende da disponibilidade e preferência experiência do médico, lembrando que devemos evitar o pindolol, pois ele possui efeito simpatomimético intrínseco. Letra C incorreta. Na verdade, a morfina também pode ser utilizada quando há persistência da dor, apesar do uso de nitrato e

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

betabloqueadores, embora o seu papel na síndrome coronariana aguda venha sendo rediscutido e o nível de recomendação reduzido nas diretrizes mais recentes. Letra D incorreta. De um modo geral, não se realiza dose de ataque de enoxaparina na SCA sem supra de ST, sendo que a dose de manutenção deve ser de 1 mg kg SC de 12 12h (0,75 mg kg, de 12 12h, se idade 75 anos 1 mg kg, de 24 24h, se clearance de creatinina 30 ml min). Por outro lado, quando utilizada na SCA com supra-ST, deve-se realizar um bolus IV de 30 mg, 15 minutos antes da primeira dose de 1 mg kg SC (tal bolus somente é realizado se idade 75 anos e ClCr 30 ml min). Letra E incorreta. A terapia fibrinolítica somente deve ser realizada nos pacientes com síndrome coronariana aguda COM supra-ST, pois pode paradoxalmente aumentar a mortalidade se realizada nos pacientes com síndrome coronariana aguda SEM supra-ST. Resposta letra B.

336312.

Comentário: Dor precordial contínua, que piora com inspiração profunda e irradia para os ombros (base do pescoço)... Esta é a queixa clássica da dor da pericardite aguda As jugulares estão túrgidas, o que sugere que existe um derrame pericárdico importante, mas não há sinais de tamponamento cardíaco, como abafamento de bulhas, hipotensão arterial e pulso paradoxal... A paciente é portadora de lúpus eritematoso sistêmico e está com febre, ou seja, existem uma causa importante (LES) e outras manifestações (febre) que corroboram a hipótese de pericardite aguda Foi feito um ECG que mostra alterações típicas de pericardite aguda (ver imagem anexa) infradesnível do segmento PR em várias derivações (círculo vermelho) (2) supradesnível do segmento ST também difuso (círculo verde) (3) supra de PR (seta preta virada para baixo) e infra de ST (seta preta virada para cima) na derivação aVR... O ecocardiograma confirma a existência de derrame pericárdico (ver imagem anexa a lâmina de derrame está marcada em vermelho, formando um C invertido que envolve todo o coração). Assim, está dado o diagnóstico pericardite aguda O tratamento de primeira linha é feito com AINE (como ibuprofeno) associado à colchicina. Resposta letra B.

305021.

Comentário: O primeiro paciente apresenta queixas típica de vertigem postural paroxística benigna

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

(VPPB) vertigem verdadeira (sensação de que o paciente ou o ambiente estão girando), desencadeada por mudança postural, acompanhada ou não de manifestações disautonômicas reflexas (sudorese, náuseas e mãos frias) de curta duração. O segundo paciente apresenta queixas típicas de pré-síncope ou lipotimia, uma manifestação de baixo débito cardíaco, no caso de provável etiologia cardiogênica sensação de escurecimento visual e desmaio associada a palpitações, com ou sem manifestações disautonômicas, de início e término súbitos e espontâneos. O diagnóstico de VPPB é firmado pelo exame clínico através da reprodução dos sintomas com a manobra de Dix-Hallpike a confirmação de arritmia cardíaca é obtida através de um eletrocardiograma. Inicialmente devemos solicitar um ECG de repouso, a fim de verificar se existe arritmia naquele momento ou, pelo menos, algum fator predisponente (ex. onda Q patológica, indicativa de IAM prévio, que serve como foco para reentrada e geração de taquiarritmias). Caso o ECG de repouso seja normal, pode-se solicitar um Holter (monitorização eletrocardiográfica por 24h ou mais) ou mesmo partir direto para um estudo eletrofisiológico, dependendo dos fatores de risco presentes (ex. ICFER grave). Resposta A.

304873.

Comentário: Todos provavelmente já ouviram esse pedido Doutor, me arranja um atestado para prática de atividade física . Às vezes é pior pedem para o filho que não está nem presente na consulta. Enfim, temos um paciente jovem com exame físico absolutamente normal, sem sintomas, mas com um eletrocardiograma esquisito . Será que precisamos dar prosseguimento na investigação e buscar algum tipo de cardiopatia capaz de contraindicar a realização de atividade física Nada disso A arritmia apresentada é completamente benigna e comum em crianças, sendo caracterizada pela presença de onda P positiva em D2 e D1 precedendo cada QRS, mas com variabilidade perceptível entre os intervalos P-P (uma diferença 160ms entre o maior intervalo P-P e o menor intervalo P-P). Provavelmente estamos diante do tipo respiratório, quando os intervalos P-P reduzem na inspiração (taquicardiza) e aumentam na expiração (bradicardiza). O que explicaria isso A mera alternância no tônus autonômico por mudanças no enchimento das câmaras cardíacas durante um ciclo respiratório. Entenda a inspiração inibe o tonus vagal, aumentando a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

frequência sinusal. A expiração faz exatamente o contrário. Inclusive, se o paciente prender a respiração, a arritmia desaparece O cenário seria diferente diante de um paciente com alterações eletrocardiográficas sugestivas de síndrome do QT longo, pré-excitação ventricular ou cardiomiopatia hipertrófica. Resposta letra A.

306731.

Comentário: O enunciado descreve um paciente com dor torácica e elevação de troponina, sugerindo diagnóstico de infarto agudo do miocárdio (IAM). Porém, o ponto central dessa questão é a análise do ECG temos um infradesnivelamento de V1-V3 associado à presença de um pequeno supra em DIII e aVF - o que sugere a presença de um supra de ST em parede inferodorsal Entenda o supra de ST e a onda Q patológica do IAM de parede dorsal não aparecem no ECG convencional de 12 derivações Para isso, teríamos que verificar três derivações extras V7, V8 e V9, localizadas na topografia da escápula esquerda. Porém, isso não seria necessário de rotina, já que o IAM dorsal poderia ser identificado pela sua imagem em espelho na parede septal, isto é, infra de ST e onda R proeminente em V1 (podendo chegar até V4). Outra pista seria o fato de dificilmente o IAM dorsal vir isolado normalmente estaria associado ao IAM de parede inferior (IAM inferodorsal) e, mais raramente, ao IAM de parede lateral (IAM laterodorsal). Por isso, na prática médica, é bom seguir a seguinte regra todo paciente com IAM de parede inferior deve ser avaliado para presença do infarto de VD (V3R e V4R), mesmo na ausência de sintomas sugestivos. Isso é importante porque o infarto de VD contraindica os nitratos, a morfina e os diuréticos Por outro lado, os antiagregantes plaquetários e a anticoagulação com enoxaparina devem ser feitos de rotina nestes casos. Resposta letra C.

287337.

Comentário: O paciente acima apresenta diversos fatores de rico cardiovascular, e um quadro de dor torácica aos esforços sugestivo de angina típica por doença coronariana. O quadro evolui, até que eventualment a apresentação se torna diferente. Desta vez, a dor é mais intensa e ocorre em repouso. A primeira hipótese nesse caso deve ser sem dúvidas uma síndrome coronariana aguda, que engloba a angina instável e o infarto agudo do mioceárdio com e sem supradesnivelamento do

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

segmento ST. Como diagnóstico diferencial, porém com menor probabilidade clínica, estão o TEP e a dissecção aórtica aguda. Por isso, tentaremos confirmar a primeira hipótese, para então descartar as alternativas. Apenas a angina estável não deve ser considerada no momento, pois claramente o quadro não é mais estável (existe angina em repouso). Após considerado o caso clínico, agora sim devemos analisar o eletrocardiograma. O exame não deixa dúvidas existe um grande supradesnivelamento do segmento ST em parede inferior (D2, D3 e aVF), sugerindo infarto agudo dessa região. Embora a dissecção aórtica por vezes seja acompanhada de dissecção da coronária direita, podendo mimetizar o exame acima, o quadro clínico é muito mais sugestivo de SCA pura, e esta deve continuar sendo nossa principal hipótese. Resposta letra A

246719.

Comentário: A colchicina é o agente anti-inflamatório já estudado e com resultados relativamente positivos na doença arterial coronariana. No estudo COLCOT, pacientes foram randomizados após um infarto do miocárdio entre o uso de colchicina 0,5 mg dia ou placebo. Após acompanhamento por 2 anos, aqueles que usaram colchicina tiveram benefícios como menor risco de angina e AVE. No entanto, o uso de colchicina ainda não é recomendando rotineiramente e essa é droga é pouco tolerada pelos pacientes, sobretudo pelos efeitos adversos gastrointestinais. Resposta E.

246355.

Comentário: Temos o caso de um paciente que apresentou dor torácica anginosa típica, sugerindo fortemente o quadro de síndrome coronariana aguda. Em seu eletrocardiograma, observamos supradesnivelamento do segmento ST em parede inferior (DII, DIII, aVF), lateral (V5 e V6), além de infradesnivelamento em parede anterior sugerindo existência de acometimento de parede dorsal. Vamos avaliar cada alternativa quanto à sua abordagem A) O tempo recomendado para intervenção percutânea, ou porta-balão é de até 90 minutos. Contudo, no caso de possibilidade de transporte até um centro que disponha desse serviço, esse tempo pode ser postergado até 120 minutos. Caso isso não seja possível, é recomendada terapia fibrinolitica o mais precocemente possível. CORRETA) B) Em locais com dosagem de troponina disponível, este deve ser considerado o padrão ouro, e o valor de sua especificidade é tanto maior, que não é recomendada

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

a dosagem de outros marcadores menos específicos para lesão miocárdica (INCORRETA) C) A ICP primária apresenta benefício menos sensível à passagem do tempo do que a terapia fibrinolítica. Dentro do período de 12h, ainda pode ser indicada na contraindicação ao primeiro método. Contudo, após 12 horas, estudos falharam em mostrar benefício com estratégia invasiva, a não ser que o paciente apresente sinais de insuficiência cardíaca grave, instabilidade hemodinâmica ou elétrica, ou sintomas isquêmicos persistentes. (CORRETA) D) O resultado da dosagem de marcadores de necrose NÃO deve atrasar a terapia de reperfusão, sendo suficiente a história clínica e alteração eletrocardiográfica compatível. (CORRETA) Única resposta incompatível com o caso clínico é a letra B

243062.

Comentário: Questão interessante a respeito da estratégia fármaco invasiva. Vamos responder cada alternativa A) Caso um infarto com supradesnivelamento do segmento ST seja tratado com estratégia fibrinolítica, é preferencial que este paciente seja submetido posteriormente a coronariografia e caso indicada, abordagem percutânea, dentro do período de 3 a 24h após a trombólise. Isso ocorre pois apenas em cerca de 50-60% dos casos a normalização completa do fluxo arterial é obtida com a fibrinólise. Em pacientes de menor risco (infarto menos extenso, de localização inferior, ausência de sinais de IC ou arritmias) o período maior do que 24h até 48h é aceitável. (CORRETA) B) Não há indicação de terapia pela metade da dose no infarto do miocárdio, devendo ser optado por uma estratégia completa ou outra, a depender da disponibilidade. Estudos com essa abordagem não evidenciaram benefício clínico (INCORRETA) C) A fibrinólise imediatamente antes da abordagem percutânea não é recomendada, pois estudos evidenciaram maiores complicações dessa estratégia sem benefício clínico adicional. O período de ao menos 3 horas após a fibrinólise demonstrou melhores resultados. (INCORRETA) D) Períodos superiores a 48h permitem maior risco de complicações e reinfartos nos pacientes que não reestabeleceram completamente o fluxo arterial após a terapia trombolítica, como visto acima (INCORRETA) E) O grande retardo em relação à técnica de administração em veia periférica faz com que o uso intracoronário do agente trombolítico só seja realizado naqueles raros casos em que um paciente

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

desenvolve trombose coronária durante a realização de uma coronariografia. Como estratégia inicial, a perda de tempo hábil se torna uma contraindicação a este método. (INCORRETA)

Resposta correta letra A

243067.

Comentário: Durante a abordagem de pacientes Doença Arterial Coronariana (DAC), um dos exames utilizados é o ecocardiograma sob estresse , que pode ser feito após esforço ergométrico (ex. esteira ou bicicleta) ou farmacológico (dobutamina). Avaliam-se alterações novas ou pioras na motilidade da parede ventricular, bem como alterações na função global do ventrículo esquerdo. Aliada a esses dados, temos a possibilidade de checar a função também em repouso e anormalidades valvares, o que pode contribuir para definição etiológica em casos duvidosos. Uma limitação do método é a redução na qualidade da imagem por características físicas do paciente, como a obesidade e a presença de DPOC. Sendo assim, vamos analisar as assertivas. A) Correta. Esse exame é utilizado exatamente para avaliar o risco cardiovascular de pacientes com DAC. Alguns achados durante o exame, como a presença de disfunção segmentar grave de uma determinada parede cardíaca, estão correlacionados à isquemia também grave, e podem levar à necessidade de indicação de exames invasivos, como o CAT. B) Correta. O teste ergométrico simples costuma ser o exame inicial na investigação de pacientes em que se quer excluir a presença de isquemia miocárdica, ainda que assintomáticos (exemplo portadores de valvopatias). Nesse caso, pode-se utilizar o ecocardiograma sob estresse para tirar a dúvida em relação à presença de DAC. C) Incorreta. Após revascularização do miocárdio, não é indicado rotineiramente a avaliação com testes provocativos apenas se o paciente apresentar algum novo sintoma ou piora clínica, sugerindo uma re-estenose recidiva da doença. D) Correta. Pacientes com alterações basais importantes no ECG não são bons candidatos ao teste ergométrico convencional, por dificuldades na interpretação dos achados isquêmicos. Nesses casos, pode-se indicar o eco sob estresse. E) Correta. Em pacientes que serão submetidos à revascularização, especialmente naqueles com disfunção ventricular importante, a viabilidade miocárdica é um parâmetro a ser avaliado. Isso porque, se a coronária estenosada supre uma área de VE já infartada, a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

revascularização dessa área pode não ser útil. Assim, quando o ecocardiograma do paciente apresenta área de hipocinesia ou acinesia, devemos saber se essa área corresponde à fibrose (já infartada, ou seja, inviável) ou ao miocárdio hibernant e (miocárdio pouco contrátil devido à isquemia, ou seja, viável). E como saber se o miocárdio é viável Uma das formas é checar se o paciente tem sintoma isquêmico (angina), quando assumiremos que o miocárdio é viável. Outra possibilidade, na ausência de sintoma isquêmico, é justamente utilizar testes funcionais como nos exames de perfusão miocárdica com SPECT PET ou ECO RM com dobutamina. Portanto, a única alternativa incorreta e nosso gabarito é a letra C.

243074.

Comentário: Vamos analisar as assertivas entre os achados de exame físico e um episódio anginoso provocado por isquemia miocárdica E) Correta. O desdobramento paradoxal B2 acontece quando o fechamento da valva aórtica é tão retardado a ponto do componente pulmonar ocorrer antes do primeiro. Assim, durante a expiração, o desdobramento é detectado, desaparecendo na inspiração, quando ocorre o retardo fisiológico do componente pulmonar. A situação clínica mais comumente associada ao desdobramento paradoxal é o bloqueio completo do ramo esquerdo, que pode ser resultado de isquemia miocárdica. D) Correta. No paciente com angina em síndrome coronariana aguda, pode surgir insuficiência mitral, que leva a sopro de regurgitação. C) Correta. A quarta bulha também pode surgir em síndromes isquêmicas, por deficit de relaxamento do ventrículo esquerdo B) Correta. A falência ventricular esquerda culmina, muitas vezes, com congestão pulmonar, que origina B3 (bulha de sobrecarga). A) INCORRETA. O sopro diastólico aspirativo em foco aórtico é sugestivo de insuficiência aórtica e não costuma ocorrer por mecanismo isquêmico. Portanto, a única INCORRETA é a letra A, nosso gabarito.

215173.

Comentário: Temos um homem, de meia-idade, com dor torácica do tipo isquêmica típica há 4 horas, com ECG apresentando SUPRAdesnivelamento. Qual diagnóstico IAMST Conduta Reperfusão. Primeira escolha com cineangiocoronariografia , segunda escolha reperfusão com trombolítico. Qual o tempo porta-balão recomendado 90 minutos ou 120 minutos considerando o

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

transporte (ou seja, transporte de 30 minutos). Conduta imediata AAS 100 200 ou 300 mg Clopidogrel 300 mg enoxaparina 30 mg EV (pois paciente 75 anos). Resposta certa LETRA A.

215179.

Comentário: Questão clássica sobre SÍNDROME CORONARIANA AGUDA. Temos um homem de meia-idade, dor torácica do tipo isquêmica, antecedente de angina estável,HAS,DLP e história familiar para IAM, já usava AAS, se apresentando com ECG sem supra mas com INFRA de ST e marcadores de necrose positivos. Estável hemodinamicamente. ECG sem supradesnivelamento. Marcador de necrose miocárdico positivo. Qual o diagnóstico Síndrome Coronariana Aguda Sem Supra de ST (SCASSST) Conduta Estratégia Invasiva Precoce em 48h a 120h(alguns autores), com cineangiocoronariografia. Quais os fatores do TIMI RISK Paciente acima só não pontua para idade 65 e estenose 50% conhecida, o restante pontua 1, somando 5. Resposta LETRA B.

215181.

Comentário: Questão objetiva sobre IAMST. Paciente tem supra de ST, Killip-Kimball I, estável, sem contra-indicação trombólise. O tempo para transporte para angioplastia primária é 30min, conforme o preconizado. Qual conduta imediata então TROMBÓLISE CATE na próximas 24h, estratégia conhecida como Estratégia Fármaco-invasiva . Resposta LETRA E.

215106.

Comentário: A classificação Killip III é prognóstica e utilizada para definir conduta em portadores de infarto agudo do miocárdio com supradesnível do segmento ST. Killip I indica ausência de insuficiência ventricular esquerda clinicamente identificável o II representa estertoração pulmonar nos terços inferiores do tórax Killip III corresponde à presença de edema agudo de pulmão cardiogênico e o IV, choque cardiogênico. Nos pacientes classificados como III ou IV, a terapia de reperfusão indicada é sempre endovascular (em detrimento do trombolítico). Resposta B.

196813.

Comentário: Paciente com IAMST inferior (supra de ST em D2, D3 e aVF) em 50% das vezes tem também IAM de VD, sendo contraindicação absoluta o uso de drogas venodilatadoras como os nitratos. O motivo é simples no IAM de VD o débito cardíaco se torna criticamente dependente do

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

retorno venoso e da pré-carga (volume diastólico final) do VD. Um VD infartado precisa AUMENTAR sua pré-carga a fim de manter a ejeção de sangue para a artéria pulmonar em níveis constantes. Logo, drogas que venodilatam a cava inferior, como os nitratos, reduzem o retorno venoso, a pré-carga de VD e, consequentemente, o próprio débito cardíaco neste contexto. Resposta certa A.

172803.

Comentário: Estamos diante de uma síndrome coronariana aguda típica, em que o ECG evidencia infradesnivelamento do segmento ST de V1 a V3, o que representa acometimento da parede anterior por lesão da artéria Descendente Anterior (DA). Alguns alunos podem ter se confundido com a lembrança de que o infarto da parede posterior pode manifestar-se como uma imagem em espelho nas derivações anteriores. Porém, dificilmente o IAM dorsal vem isolado, estando normalmente associado ao IAM de parede inferior e, mais raramente, ao IAM de parede lateral. Dessa forma, o manejo desse paciente deve ser para o tratamento de uma síndrome coronariana sem supra de ST , em que não está indicado o uso de trombolíticos (letra D incorreta). O tratamento do paciente envolve (1) a estratégia invasiva de revascularização e (2) a terapia medicamentosa que nesse caso, inclui drogas antiplaquetárias (AAS clopidogrel) drogas antitrombóticas (ex. heparina de baixo peso molecular) e drogas anti-isquêmicas, como estatinas e IECA. A prescrição de nitrato está contraindicada pelo uso recente de sildenafila, bem como não há indicação do nitroprussiato de sódio, um agente anti-hipertensivo parenteral, uma vez que o paciente está hipotenso (letras B e C incorretas) Resposta A.

148540.

Comentário: Temos uma paciente de 60 anos que apresentou no dia anterior um quadro de dor torácica atípica, mas que no momento encontra-se assintomática. Devemos excluir uma patologia cardiovascular, pois embora a dor não seja retroesternal ou precordial, ela foi acompanhada de sudorese, dispneia e taquicardia. A paciente não procurou atendimento durante os sintomas e não são informados os seus fatores de risco cardiovascular. Como a paciente não está em vigência de dor, podemos submetê-la a um exame provocativo de isquemia para poder realizar sua

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

estratificação funcional e, dependendo do resultado, avaliar se há ou não indicação de estratificação anatômica (coronariografia). Os exames para estratificação funcional podem ser teste ergométrico, ecocardiograma de estresse e cintilografia de estresse. O estresse pode ser proporcionado por exercício físico ou estímulo farmacológico, mas sempre devemos dar preferência ao esforço físico se houver essa possibilidade. Os pacientes mais sujeitos a apresentarem dor coronariana com sintomas atípicos são mulheres, idosos e diabéticos. Dessa forma, a resposta correta é a letra B.

155474.

Comentário: Atualmente a American Hearth Association - AHA recomenda apenas a utilização da troponina cardioespecífica (Troponina I ou Troponina T) no momento da admissão e 3-6 horas depois do início dos sintomas, podendo ser feitas mais medidas para o acompanhamento (Curva enzimática). A troponina é o marcador de escolha por ser mais sensível e específica, tendo como uma alternativa é a CK-MB de massa (CPK ou CK creatinofosfoquinase). A mioglobina NÃO é específica para lesão do músculo cardíaco, e sua grande vantagem em relação a troponina e a CK-MB é o fato de se elevar mais rápido do que as outras, podendo ser identificada em apenas uma hora após o início da isquemia, com pico 2-4 horas depois, sendo útil para a triagem do paciente com dor torácica a esclarecer. Outros marcadores laboratoriais mais modernos também poderiam ser utilizados, apesar de não haver uma recomendação formal pelas diretrizes. São eles proteína C Reativa (marcador inflamatório) ligante CD40 (marcador de atividade plaquetária) BNP (marcador de dinsfunção ventricular e NT- pró-BNP. Lembrando que o marcador de escolha é, sem dúvida a troponina cardioespecífica, por apresentar maior especificidade e sensibilidade. Resposta certa D

131638.

Comentário: Os fibrinolíticos constituem uma das alternativas de terapia de reperfusão miocárdica nas síndromes coronarianas com supradesnível de segmento ST . Possuem indicações semelhantes às da angioplastia primária, sendo esta última, sempre que possível, preferível. As terapias de reperfusão miocárdica exigem a associação de Presença de sintomas compatíveis com

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

infarto agudo do miocárdio (preferencialmente a dor torácica aguda) com delta T de sintomas de até 12 horas Supradesnível de segmento ST em duas ou mais derivações de uma mesma parede OU bloqueio de ramos esquerdo novo ou presumivelmente novo. OK, mas aí temos as alternativas B e E apresentando supra E aí, cuidado, pois dentro da pergunta, o supra que mais se beneficia é aquele que traduz maior lesão e potencial de desfechos ruins a longo prazo, por isso, o supra na parede anterior seja pior que o de parede inferior. Os fibrinolíticos não devem ser utilizados nas síndromes coronarianas sem supradesnível de segmento ST, sob risco de piora dos desfechos (já foi demonstrado que eles promovem um aumento paradoxal da mortalidade neste contexto). A letra B é a única correta.

106427.

Comentário: Vale a pena reler as contraindicações absolutas ao uso dos trombolíticos na síndrome coronariana aguda com supradesnível de ST -História de qualquer hemorragia intracraniana. -Les o vascular cerebral estrutural conhecida. -Neoplasia intracraniana maligna conhecida. -AVE isquêmico há menos de três meses. -Suspeita de dissecç o aórtica. -Sangramento patológico ativo ou diátese hemorrágica. -Trauma facial ou TCE significativos há três meses. Cabem algumas observações quanto a situações que geram confusão na prática Menstruaç o n o configura sangramento patológico e costuma ser pegadinha nas questões de prova. Idade acima de 65 anos n o é considerada contraindicação a trombólise. Algumas referências discutem a idade acima de 75 anos como contraindicação mas, de modo geral, a idade isolada n o contraindica a realização de trombólise. Desta forma, tirando nosso gabarito (letra E), as outras assertivas não configuram nem mesmo contraindicações relativas ao uso de trombolíticos.

101014.

Comentário: Estamos diante de um paciente de 74 anos, com diversos fatores de risco (HAS, DM, dislipidemia), se apresentando com síndrome coronariana aguda sem supra de ST, que pode tratar-se de um IAM sem supra ou de uma angina instável (só teremos tal diferenciação com o resultado dos marcadores de necrose miocárdica - as populares enzimas cardíacas). De qualquer forma, já podemos adiantar o tratamento enquanto esperamos o resultado das enzimas . Todas as

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

opções trazem condutas que seriam indicadas num caso de SCA SSST, exceto a letra C o nitrato deve ser administrado via sublingual (o nosso dinitrato de isossorbida, ou a nitroglicerina SL disponível nos EUA), sendo o nitrato venoso reservado aos casos de dor refratária Contudo, também existe uma contra-indicação ao uso de beta-bloqueador no caso em tela, que é a hipotensão arterial. Dessa forma, a questão apresenta três respostas possíveis (opções B, C e D) e foi anulada após pedidos de recurso dos candidatos.

101028.

Comentário: O TIMI risk estima o risco de eventos cardiovasculares maiores (ex. arritmia, ICC, morte súbita) em portadores de síndrome coronariana aguda no momento da primeira avaliação. Existem duas versões do TIMI risk uma para angina instável IAM sem supra, e outra para IAM com supra de ST. O TIMI para AI IAMSSST pontua os seguintes fatores - Idade 65 anos - Presença de 3 ou mais fatores de risco coronariano - Coronariopatia conhecida, com estenose 50% em pelo menos 1 vaso - Uso de AAS nos últimos 7 dias - Angina severa (2 ou mais episódios nas últimas 24h) - Infradesnivelamento do segmento ST 0,5 mm - MNM positivo. Logo, como podemos perceber, a resposta certa aqui é a letra D.

100952.

Comentário: O músculo esquelético é um alvo frequente dos efeitos colaterais das estatinas. Até 10% dos usuários dessa classe de medicamentos desenvolve dor muscular (mialgia), sendo que apenas uma minoria (1%) evolui com franca rabdomiólise (dor e fraqueza muscular acompanhada de aumento da creatinofosfoquinase sérica). O risco de rabdomiólise aumenta consideravelmente com a associação de estatina fibrato. A colestiramina (quelante intestinal de sais biliares) reduz os níveis de LDL colesterol no plasma, sendo o efeito dose-dependente (quanto maior a dose de colestiramina ingerida, maior a redução do LDL). A ezetimiba realmente potencializa o efeito das estatinas, reduzindo a absorção intestinal de colesterol. Agora, a niacina diminui a trigliceridemia, e aumenta os níveis de HDL colesterol, e não LDL. Questão com duas alternativas erradas (A e C), por esse motivo foi corretamente anulada.

100986.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Existem diferentes formas de estratificação formal do risco cardiovascular, como o escore cardiológico de Goldman (que avalia risco de eventos cardiovasculares no pós-operatório) e a classificação pré-anestésica da ASA (Sociedade Americana de Anestesiologia). O paciente ASA I é um indivíduo plenamente saudável o ASA II é aquele que tem doença sistêmica leve a moderada, sem limitação funcional ASA III é a doença sistêmica grave com limitação funcional ASA IV é doença sistêmica grave com risco de vida constante e, por fim, ASA V é o paciente moribundo (risco de vida iminente, com expectativa de óbito independentemente da cirurgia nas próximas 24h). Existe também o ASA VI, que é o paciente em morte cerebral que doará seus órgãos. vale lembrar, ainda, que situações de emergência agregam a letra E ao escore (ex. ASA IIIE). Pois bem, o paciente ASA II é um paciente de relativo baixo risco, com expectativa de mortalidade GERAL em torno de 0,74 por 10.000 cirurgias (E e C erradas). Como a herniorrafia inguinal é procedimento eletivo de baixo risco e o paciente encontra-se estável, não há indicação de observação pós-operatória na UTI (D errada). A idade 70 anos soma 5 pontos no escore de Goldman (meu Deus do céu, olha a filigrana que estão perguntando nessa questão) - B errada. Pacientes Goldman I têm chance de eventos cardiovasculares no pós-operatório 1%. No Goldman II essa chance sobe para 7%, e no Goldman III 14%. Pacientes Goldman IV (altíssimo risco) têm 78% de probabilidade de evoluir com eventos cardiovasculares no pós-operatório. Questão bizarramente difícil, de pura decoreba, sem sentido Resposta certa A.

77502.

Comentário: A dor torácica desse paciente deve ser classificada como dor anginosa (tipo A). Perceba que ela é desencadeada por esforço, melhora com o repouso, e possui localização e irradiação típicas num paciente com probabilidade pré-teste não baixa de doença coronariana (homem 50 anos de idade). A dor da dissecção aórtica é contínua e excruciante, sem melhora espontânea (D errada). Dentro do espectro de manifestações clínicas da doença coronariana, como descrever o padrão de dor do infarto agudo do miocárdio No IAM, a dor anginosa surge em repouso, tem forte intensidade, e se acompanha de sinais disautonômicos (ex. sudorese, náuseas e vômitos), persistindo por mais de 20 minutos (B e C erradas). Vale lembrar que um ECG normal,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

por si só, NÃO DESCARTA a possibilidade de infarto. Enfim, o padrão de dor apresentado é mais condizente com a síndrome de angina de peito ou angina estável . Nesta situação, a placa de ateroma encontra-se íntegra, sem trombos oclusivos ou semioclusivos aderidos à sua superfície (este evento define as síndromes coronarianas agudas ou instáveis angina instável, IAM sem supra e IAM com supra). O teste que, além de confirmar o diagnóstico de doença coronariana estável, ainda representa o primeiro passo na estratificação prognóstica, considerando que o paciente deambula e está assintomático, é geralmente o teste ergométrico , também chamado de teste da esteira ou teste de esforço . Resposta certa E.

88889.

Comentário: O paciente descrito pelo enunciado seguramente possui altíssima probabilidade pré-teste de coronariopatia. Esta probabilidade clínica é tão grande que um resultado negativo num teste provocativo de isquemia (como é o caso do teste ergométrico) mais provavelmente reflete um falso-negativo do que um verdadeiro-negativo (lembre-se a clínica é soberana). Ora, sabemos que, de todos os testes provocativos disponíveis, o teste ergométrico é justamente o menos sensível (sensibilidade em torno de 75%). Logo, não resta dúvida que devemos continuar perseguindo a confirmação diagnóstica neste caso, lançando mão de outras modalidades de teste provocativo (ex. cintilografia miocárdica, eco-stress e cardiorressonância). Vale dizer que, mais do que para confirmar o diagnóstico num caso óbvio como este, tais exames são importantes para estratificar a gravidade da coronariopatia (ex. quanto maior a área isquêmica, maior o risco de óbito e outros eventos adversos, devendo, por conseguinte, ser mais agressiva a terapia). Resposta certa A.

88847.

Comentário: Em pacientes com síndrome coronariana aguda com supradesnivelamento do segmento ST em pelo menos duas derivações contíguas, há indicação de reperfusão imediata do miocárdio em sofrimento em até 12h, ou após este período, caso haja critérios de isquemia persistente ou em curso. Existem duas opções para se chegar a este objetivo (1) trombólise (2) angioplastia primária. Os dois procedimentos, em termos de desfecho, são basicamente equivalentes entre o início da dor até 3 horas após. Depois disso, a angioplastia tem mostrado

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

melhores desfechos. O tempo máximo que devemos aguardar desde a chegada do paciente até o momento em que se inicia a infusão do trombolítico é de 30 minutos, o chamado tempo porta-agulha. Resposta Letra A.

88844.

Comentário: Em pacientes com síndrome coronariana aguda com supradesnivelamento do segmento ST em pelo menos duas derivações contíguas, há indicação de reperfusão imediata do miocárdio em sofrimento em até 12h, ou após este período, caso haja critérios de isquemia persistente ou em curso. Existem duas opções para se chegar a este objetivo (1) trombólise (2) angioplastia primária. Os dois procedimentos, em termos de desfecho, são basicamente equivalentes entre o início da dor até 3 horas após. Depois disso, a angioplastia tem mostrado melhores desfechos. O tempo que devemos aguardar desde a chegada do paciente até o momento em que existe balão insuflado no interior de uma coronária epicárdica, ou TEMPO PORTA-BALÃO, é de 1h30min ou 90 minutos. Resposta Letra E.

43923.

Comentário: Os nitratos são excelentes antianginosos, e também podem ser usados como anti-hipertensivos, em pacientes com Síndrome Coronariana Aguda (SCA). Todavia, seu impacto sobre a morbimortalidade não chega a ser expressivo, figurando apenas como medicação adjuvante (A errada). Drogas antiplaquetárias são consideradas essenciais no tratamento das SCA Recomenda-se, inclusive, que na abordagem inicial sejam associados dois antiplaquetários diferentes. Acontece que esta associação consiste em AAS clopidogrel (o que comprovadamente reduz a morbimortalidade em cerca de 20%, segundo o estudo CURE) e não em clopidogrel ticlopidina (B errada) Na prática médica atual a ticlopidina foi basicamente jogada para escanteio , sendo utilizada somente em última instância, dado o seu perfil de efeitos colaterais potencialmente graves (mais clássico neutropenia). Os bloqueadores de canais de cálcio não diidropiridínicos (verapamil e diltiazem) também podem ser usados como antianginosos (principalmente na angina variante de Prinzmetal) e como anti-hipertensivos, mas também não reduzem a morbimortalidade associada à SCA (C errada). Já os inibidores da ECA (ex. captopril) comprovadamente reduzem a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

morbimortalidade, porém, apenas num tipo específico de SCA a SCA com supra de ST, principalmente em pacientes de maior risco, como aqueles com IAM de parede anterior e ou disfunção sistólica de VE (E errada, pois a questão está falando especificamente de SCA sem supra de ST e, neste caso, as evidências de redução de morbimortalidade dos IECA são inconsistentes). Enfim, a anticoagulação plena com heparina é outro passo importante no tratamento de todas as formas de SCA. As heparinas de baixo peso (ex. enoxiparina) se mostraram superiores à tradicional heparina não fracionada no quesito redução de mortalidade da SCA. Logo, resposta certa D.

32460.

Comentário: Questão direta Temos um paciente masculino portador de múltiplos fatores de risco para aterosclerose (idade 45 anos, HAS, dislipidemia, tabagista, história familiar), que se apresenta com dor torácica aguda e ECG mostrando supradesnível de ST na parede inferior (DII, DIII e aVF). Do que mais você precisa para definir a presença de um infarto agudo do miocárdio com supra de ST (no caso, oclusão da coronária direita) e indicar o tratamento específico revascularização, com angioplastia primária (de preferência) ou trombolítico (se não houver contraindicações e não for possível realização de angioplastia primária) A descrição clínica atual é compatível com IAM, pois a dor tem duração 20min e está presente no atendimento. Nos dias antecedentes a dor era sugestiva de angina instável (neste caso, verdadeiramente uma angina pré-infarto), pois a dor surgiu apenas na última semana. Em nenhum momento na história clínica há referência a um quadro prévio de angina estável (dor esforço-induzida de curta duração e recorrente). O ecocardiograma, conquanto bem-vindo na avaliação imediata do portador de IAM, não é imprescindível neste momento, uma vez que não é útil para diferenciar entre as diferentes formas de SCA (ex. na fase aguda um déficit contrátil pode representar IAM, quando no futuro se mostrar irreversível, ou angina, quando no futuro mostrar recuperação). A quarta bulha é comum nas SCA, e indica apenas que o miocárdio do ventrículo esquerdo ficou duro , isto é, menos complacente, devido ao déficit diastólico secundário à isquemia aguda. Resposta certa A.

32497.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Uma série de complicações pode advir do quadro de obesidade na infância, tornando a intervenção sobre este quadro uma necessidade imperativa. Essas complicações podem ser divididas pelos sistemas que são acometidos. Assim, temos as seguintes associações 1) quadros dermatológicos acanthosis nigricans , infecção fúngica, estrias, celulite, acne, hirsutismo e furunculose 2) quadros ortopédicos joelho valgo (genu valgum), epifisiólise de cabeça do fêmur, osteocondrites, artrites degenerativas e pé plano 3) quadros cardiovasculares hipertensão arterial sistêmica 4) quadros respiratórios síndrome da apneia obstrutiva do sono e asma 5) quadros hepáticos e gastrointestinais colelitíase, doença gordurosa não alcoólica, refluxo gastroesofágico e constipação intestinal 6) quadros genitourinários síndrome dos ovários policísticos, pubarca precoce e incontinência urinária e 7) quadros neurológicos e psicológicos pseudotumor cerebral e problemas psicossociais. Assim, a única opção que traz sinais de doenças associados à obesidade é a opção A. Os erros identificados nas outras opções são geno varo, diabetes mellitus tipo 1, insuficiência venosa, infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral.

27402.

Comentário: Estamos diante de um IAM inferior supra de ST nas derivações que olham o coração de baixo pra cima , isto é, para a parede inferior (DII, DIII e AVF). Sabemos que 1 3 dos casos se associa ao infarto de ventrículo direito Por este motivo, sempre que o ECG demonstrar comprometimento isquêmico da parede inferior devemos rodar um novo eletro, dessa vez acrescentando derivações precordiais direitas (V3R e V4R), que podem revelar supra de ST, confirmando o IAM do VD. Ora, no infarto de VD a contratilidade desta câmara passa a depender enormemente da pré-carga, no caso, do retorno venoso. Assim, drogas que reduzem agudamente o retorno venoso por exemplo, causando venodilatação da cava inferior, como os nitratos têm o potencial de desencadear um quadro de falência aguda do ventrículo direito, o que se expressa clinicamente através de hipotensão e choque circulatório. Foi o que aconteceu no paciente da questão... A conduta será a suspensão do nitrato, a elevação dos membros inferiores, com o paciente em decúbito dorsal e a reposição volêmica com salina isotônica, na tentativa de aumentar a pré-carga e melhorar a contratilidade do VD. Resposta certa letra D.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

9388.

Comentário: Perceba como estamos falando de um paciente de risco para doença coronariana... Homem, idoso, hipertenso, dislipidêmico, obeso... A probabilidade de uma plaquinha nas coronárias é muito grande Seria uma surpresa estarrecedora descobrir que esse paciente não tem aterosclerose nas coronárias... Mas existe algum exame complementar não invasivo capaz de nos dizer isso Existe... Cada vez mais a angiotomografia coronariana tem sido incorporada à prática médica Ainda existem controvérsias na literatura a respeito de suas aplicações, mas o fato é que se trata de um exame com grande capacidade para medir a quantidade de cálcio na parede arterial (quantificando-a através de escores radiológicos). Sabemos que os escores de cálcio têm correlação direta e fidedigna com a carga de aterosclerose numa coronária, com grande sensibilidade e especificidade (C errada)... Assim, se o escore de cálcio for baixo ou nulo, podemos afirmar com MUITA SEGURANÇA que o paciente não é portador de aterosclerose na artéria examinada Em outras palavras estamos dizendo o seguinte O VALOR PREDITIVO NEGATIVO DA ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA É ELEVADÍSSIMO (D errada) Mesmo num paciente como este, com alta probabilidade pré-teste, seríamos forçados a acreditar que ele não tem aterosclerose importante, caso a angio-TC coronária nos mostrasse um escore de cálcio baixo ou nulo... Entretanto, temos que ressaltar o outro lado da moeda... Se o escore de cálcio for alto, esta informação não é de grande valia... Neste doente, por exemplo, não seria nenhuma surpresa a probabilidade pré-teste já era elevada, e um resultado positivo não nos surpreende O fato é que um escore de cálcio elevado NÃO CONSEGUE PREDIZER COM SEGURANÇA O RISCO FUTURO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES A simples presença de uma placa de ateroma não quer dizer que uma pessoa vai desenvolver síndrome coronariana... Logo, a angiotomografia coronariana não deve ser usada em pacientes assintomáticos Sua grande utilidade parece ser nos pacientes de médio risco (aqueles que nos deixam em dúvida) que se apresentam ao serviço de emergência com um quadro sugestivo de SCA... Uma angiotomografia normal nestes casos AFASTARIA a hipótese de SCA... Para quantificar o grau de obstrução de uma placa de ateroma só mesmo fazendo a coronariografia (B errada)... A técnica radiológica de escolha para a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

TC-coronariana é a multi-slice de 64 canais (várias fatias (64) cortadas ao mesmo tempo). Este aparelho permite obtenção das imagens num tempo curtíssimo, reduzindo a interferência dos próprios batimentos cardíacos Entretanto, essa vantagem é conseguida à custa de uma maior exposição à radiação ionizante (E errada)... Resposta certa letra A

355622.

Comentário: A banca constrói quadro de infarto agudo do miocárdio sem elevação do segmento ST (IAMSSST) e questiona a respeito do manejo terapêutico. Para começo de conversa, o ideal seria avaliarmos o risco desse paciente por escores como TIMI ou HEART para definir se o paciente é candidato à abordagem invasiva ou não. Porém, vamos omitir esta etapa, tendo em vista que nenhuma das alternativas citou tal estratégia assim, focaremos no tratamento medicamentoso do IAMSSST, que inclui antiagregantes, antianginosos e anticoagulantes. Letra A incorreta. O ácido acetilsalicílico é componente essencial inegociável na abordagem terapêutica de qualquer forma de SCA. Comprovadamente reduz a taxa de mortalidade e infarto reinfarto. Mas será que há opção mais completa Letra B correta. Aqui, já temos o citado AAS. Agora, pergunta importante está indicada dupla antiagregação plaquetária (DAPT) neste caso Sim, em toda SCASST Embora atualmente se prefira o prasugrel ou o ticagrelor ao clopidogrel, as alternativas não citam os dois primeiros. Complementando o tratamento, fica indicado o betabloqueador, como antianginoso, já que reduz o consumo miocárdico de oxigênio. Por fim, a antitrombótica pode ser feita com enoxaparina (cuidado que não é enoxiparina , tá) . A enoxaparina heparina de baixo peso molecular (HBPM) atualmente é o anticoagulante de escolha no tratamento da SCASSST. Letra C incorreta. Esta opção peca por não citar o pilar terapêutico inegociável o AAS. Em relação ao enalapril, a diretriz brasileira endossa a recomendação de iniciar inibidor da IECA em todos os casos de SCASSST de médio alto risco. Neste caso, como vimos, faltam informações para definir o risco do doente de todo modo, se começássemos IECA aqui, teríamos que redobrar a atenção para a possibilidade de queda drástica da pressão arterial, tendo em vista que nosso paciente não está hipertenso agora. Letra D incorreta. A nitroglicerina e a morfina são úteis para alívio da dor e redução da pré e pós-carga, mas faltam, nesta opção, outros pilares terapêuticos inquestionável e

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

obrigatórios já citados Letra E incorreta. A estreptoquinase é exemplo de trombolítico em pacientes com IAMSSST, não está indicada trombólise. Diversos estudos comprovaram que tal conduta, paradoxalmente, eleva a mortalidade Resposta letra B.

353832.

Comentário: Temos três afirmativas sobre síndromes coronarianas agudas sem supradesnível do segmento ST, vejamos cada uma delas. Afirmativa I Verdadeiro (V). O uso de AAS é recomendado para todos os pacientes com suspeita de SCASSST sem contraindicação, devido ao seu efeito antiplaquetário. A dose inicial recomendada é de 150 a 300 mg para obter um efeito antiplaquetário rápido. A dose de manutenção é geralmente de 75 a 100 mg por dia. Afirmativa II Falso (F). Os AINEs não são preconizados para o controle da dor em pacientes com infarto agudo do miocárdio. Na verdade, seu uso pode aumentar o risco de eventos cardiovasculares adversos, como infarto do miocárdio e insuficiência cardíaca. Outras opções de analgesia devem ser consideradas para o controle da dor nesses pacientes. Afirmativa III Verdadeiro (V). O tratamento com nitrato é indicado para o alívio da angina em pacientes com SCASSST. O nitrato deve ser administrado inicialmente por via sublingual e, se não houver melhora rápida da dor, a administração intravenosa é recomendada. Os nitratos ajudam a aliviar a angina ao dilatar as artérias coronárias e reduzir a carga de trabalho do coração. Resposta letra D.

334095.

Comentário: Questão baseada em um documento da Sociedade Brasileira de Cardiologia que diz o seguinte A evidência de nova alteração da contratilidade segmentar ao exame de repouso ou sua aparição ante a indução do estresse (exercício ou farmacológico) sugerem etiologia isquêmica. O ecocardiograma sob estresse é um preditor independente de morte cardiovascular, de valor adicional aos demais métodos e pode evitar a cinecoronariografia. Seu uso pode ser recomendado para estratificação de risco de pacientes em unidades de dor torácica, especialmente quando o eletrocardiograma não define o diagnóstico e o teste ergométrico é submáximo, de realização não factível ou com resultado inconclusivo. Tradicionalmente, a ecocardiografia sob estresse é realizada após 24 horas do alívio da dor torácica, em pacientes de baixo a moderado risco, sem alterações

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

isquêmicas evidentes no eletrocardiograma e enzimas cardíacas normais Resposta letra A.

334097.

Comentário: Já ouviu falar do ecocardiograma com contraste Veja só que interessante trata-se do contraste de microbolhas, que consiste em minúsculas bolhas compostas por um gás biológico, envolvido usualmente por uma fina cápsula proteica ou lipídica. Poucos minutos após sua administração, o gás é exalado e os compostos da cápsula são metabolizados. Esses agentes apresentam um comportamento semelhante ao das hemácias na corrente sanguí nea, realçando o sinal do sangue, sem causar dano a qualquer órgão, além de não envolver radiação nem possuir propriedades tóxicas ou alergênicas. O método é empregado para definição de borda endocárdica em pacientes que não apresentam boa resolução da imagem, na melhora do sinal Doppler e também para o estudo da perfusão miocárdica É um método capaz de AUMENTAR a sensibilidade para o diagnóstico da síndrome coronariana, sobretudo em pacientes com ECG duvidoso. Resposta letra D.

334773.

Comentário: A questão quer que saibamos sobre o acompanhamento ambulatorial de um paciente que sofreu um infarto agudo do miocárdio sem supra de ST e foi submetido a uma angioplastia. Vamos avaliar as alternativas Letra A incorreta. Os estudos que avaliaram o uso de clopidogrel, prasugrel e ticagrelor em pacientes com síndrome coronariana aguda (SCA) mantiveram a dupla terapêutica antiplaquetária (DAP) por um tempo médio de 12 meses. Assim, este é o tempo padrão recomendado, independentemente da estratégia terapêutica adotada (tratamento clínico, angioplastia ou cirurgia de revascularização miocárdica). Letra B incorreta. os fármacos análogos do GLP-1 podem ser associados ao esquema terapêutico antes de 30 dias do infarto. Letra C correta. Vários estudos comprovam os benefícios das terapias para a redução do colesterol em pacientes em prevenção secundária de doença cardiovascular. Nos pacientes de alto risco, o benefício é independente dos níveis basais do LDL-C. As metas lipídicas variam conforme as diretrizes, porém, nos últimos anos, foi incorporada uma estratégia de redução mais rigorosa dos níveis de LDL, sendo preconizados, níveis de LDL menores que 50mg dL e não HDL 80mg dL nos

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

pacientes classificados de muito alto risco. Quando as estatinas não são toleradas em doses maiores, uma opção é a associação da ezetimiba. Caberia recurso para essa questão pois a Diretriz especifica que níveis de LDL menores que 50mg dL são recomendados e não nível máximo de 50mg dL . No entanto, a banca manteve essa alternativa como a resposta correta após recurso. Letra D incorreta. O AAS é utilizado em todos os pacientes nessa situação, salvo contraindicações, independentemente da estratégia de tratamento, continuando por tempo indeterminado. Resposta letra C.

339771.

Comentário: Miocardites e pericardites são doenças que, com frequência, se apresentam associadas na prática clínica e representam diferentes espectros dentro do grupo das síndromes inflamatórias miopericárdicas. Isso se deve ao fato de ambas as doenças apresentarem agentes etiológicos comuns (especialmente virais). No entanto, raramente o acometimento miocárdico e pericárdico ocorre na mesma intensidade. O mais comum é haver predomínio da miocardite (perimiocardite) ou da pericardite (miopericardite). A distinção entre as diferentes formas de apresentação é relevante por ter impacto no prognóstico e tratamento. A miopericardite usualmente tem boa evolução, sem IC ou pericardite constritiva. O diagnóstico de miocardite associada à pericardite aguda deve ser suspeitado nos pacientes que apresentam diagnóstico de miocardite e pelo menos dois dos seguintes critérios dor torácica de caráter pleurítico, que pode ser difícil de identificar pela presença de dor pelo acometimento miocárdico atrito pericárdico alterações eletrocardiográficas sugestivas de pericardite com infra do segmento PR e supra de ST difuso com a concavidade para cima derrame pericárdico novo ou piora do preexistente. O laboratório geralmente revela leucocitose com predomínio de linfócitos (nos quadros virais) e elevação da PCR e velocidade de hemossedimentação (VHS). A extensão da inflamação pericárdica ao miocárdio é manifestada com elevação de troponina. As troponinas são mais específicas que CPK e CKMB para lesões miocárdicas e estão frequentemente elevadas em pacientes com miocardite. Vamos às alternativas Letra A incorreta. Claro que o IAM é um diagnóstico diferencial nesse contexto. Porém temos alguns dados que não corroboram com essa entidade clínica a idade ausência de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

comorbidades a estabilidade clínica diante de um supra ST tão extenso presença de febre e história prévia de gastroentrite e dor torácica não típica. Letra B incorreta. A dissecção espontânea da artéria coronária (DEAC) é considerada uma síndrome coronariana aguda frequentemente subdiagnosticada e com poucos casos descritos na literatura. A DEAC deve ser considerada em qualquer paciente jovem, especialmente do sexo feminino, sem história de doença coronariana ou fatores de risco, que apresente infarto agudo do miocárdio ou parada cardíaca. O contexto de febre, infecção prévia e supra difuso do ST enfraquece esta possibilidade. Letra C correta. Conforme vimos acima, é o diagnóstico mais provável do paciente. Letra D incorreta. O vasoespasmo coronariano (angina variante ou de Prinzmetal) geralmente acomete pacientes jovens, sexo feminino, sem fatores de risco cardiovasculares (exceto tabagismo) e tem um bom prognóstico. Os eventos dor precordial geralmente ocorrem na madrugada e duram de 5 a 15 minutos e podemos encontrar alterações isquêmicas transitórias no ECG. Os fatores de risco usualmente associados são uso de cocaína, maconha, anfetamina, álcool. Resposta letra C.

339772.

Comentário: Miocardites e pericardites são doenças que, com frequência, se apresentam associadas na prática clínica e representam diferentes espectros dentro do grupo das síndromes inflamatórias miopericárdicas. Isso se deve ao fato de ambas as doenças apresentarem agentes etiológicos comuns (especialmente virais). No entanto, raramente o acometimento miocárdico e pericárdico ocorre na mesma intensidade. O mais comum é haver predomínio da miocardite (perimiocardite) ou da pericardite (miopericardite). A distinção entre as diferentes formas de apresentação é relevante por ter impacto no prognóstico e tratamento. A miopericardite usualmente tem boa evolução, sem IC ou pericardite constritiva. O diagnóstico de miocardite associada à pericardite aguda deve ser suspeitado nos pacientes que apresentam diagnóstico de miocardite e pelo menos dois dos seguintes critérios dor torácica de caráter pleurítico, que pode ser difícil de identificar pela presença de dor pelo acometimento miocárdico atrito pericárdico alterações eletrocardiográficas sugestivas de pericardite com infra do segmento PR e supra de ST difuso com a concavidade para cima derrame pericárdico novo ou piora do preexistente. O laboratório

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

geralmente revela leucocitose com predomínio de linfócitos (nos quadros virais) e elevação da PCR e velocidade de hemossedimentação (VHS). A extensão da inflamação pericárdica ao miocárdio é manifestada com elevação de troponina. As troponinas são mais específicas que CPK e CKMB para lesões miocárdicas e estão frequentemente elevadas em pacientes com miocardite. Vamos às alternativas Letras A e B incorretas. A miocardite aguda e a miopericardite pode mimetizar IAM com dor torácica típica, anormalidades no ECG similares ao IAM com ou sem supradesnivelamento do segmento ST, elevação das enzimas cardíacas e instabilidade hemodinâmica. Na suspeita de miocardite com apresentação parecida com um infarto, é necessário excluir doença arterial coronariana (DAC) por coronariografia percutânea ou angiotomografia de coronárias. No entanto, nosso caso clínico está muito mais evidente o diagnóstico de miopericardite do que uma suspeita de DAC. Letra C incorreta. A cintilografia miocárdica pode ser usada no diagnóstico da miocardite por sarcoidose e também na estratificação de risco de doença coronariana em pacientes com angina estável. Letra D correta. De acordo com as diretrizes, devemos colher uma história médica detalhada, exame físico com ênfase na ausculta cardíaca, radiografia de tórax, eletrocardiograma, ecocardiografia e exames de sangue de rotina que devem incluir marcadores de inflamação (principalmente PCR) e troponina. A ressonância magnética cardíaca (RMC) tem um papel importante em um segundo momento. Na avaliação dos pacientes com miocardite, assim como na avaliação de outras cardiomiopatias não isquêmicas, a RMC apresenta grande utilidade na determinação dos parâmetros morfológicos e funcionais ventriculares. De fato, já foi amplamente validada para quantificar os volumes, a massa e a função tanto do VE quanto do VD, e é considerada, atualmente, a modalidade diagnóstica padrão-ouro para essa avaliação. Resposta letra D.

339773.

Comentário: Miocardites e pericardites são doenças que, com frequência, se apresentam associadas na prática clínica e representam diferentes espectros dentro do grupo das síndromes inflamatórias miopericárdicas. Isso se deve ao fato de ambas as doenças apresentarem agentes etiológicos comuns (especialmente virais). No entanto, raramente o acometimento miocárdico e

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

pericárdico ocorre na mesma intensidade. O mais comum é haver predomínio da miocardite (perimiocardite) ou da pericardite (miopericardite). A distinção entre as diferentes formas de apresentação é relevante por ter impacto no prognóstico e tratamento. A miopericardite usualmente tem boa evolução, sem IC ou pericardite constritiva. O diagnóstico de miocardite associada à pericardite aguda deve ser suspeitado nos pacientes que apresentam diagnóstico de miocardite e pelo menos dois dos seguintes critérios dor torácica de caráter pleurítico, que pode ser difícil de identificar pela presença de dor pelo acometimento miocárdico atrito pericárdico alterações eletrocardiográficas sugestivas de pericardite com infra do segmento PR e supra de ST difuso com a concavidade para cima derrame pericárdico novo ou piora do preexistente. O laboratório geralmente revela leucocitose com predomínio de linfócitos (nos quadros virais) e elevação da PCR e velocidade de hemossedimentação (VHS). A extensão da inflamação pericárdica ao miocárdio é manifestada com elevação de troponina. As troponinas são mais específicas que CPK e CKMB para lesões miocárdicas e estão frequentemente elevadas em pacientes com miocardite. Em relação ao tratamento, dispomos da dipirona para auxílio no manejo da dor. Ela deve ser associada ainda a um anti-inflamatório não esteroidal (AINE), o mais usado e estudado fora do Brasil é o ibuprofeno. O AINE deve ser usado com cautela. Além disso, existe discussão acerca do papel da colchicina, mas alguns trabalhos mostram que ela reduz o tempo de doença e a sua recorrência. Não há indicação de aspirina, heparina, clopidogrel e ou nitrato. Corticoesteróides e imunossupressores podem ter um papel em esquemas terapêuticos secundários. Resposta letra B.

339774.

Comentário: Questão sem maiores dificuldades Temos um paciente obeso, tabagista e sedentário com quadro de dor epigástrica em queimação de forte intensidade. A dor epigástrica, principalmente em um paciente com risco cardiovascular considerável, deve nos atentar para um possível quadro de equivalente anginoso e uma cuidadosa avaliação no sentido de diagnosticar um evento isquêmico coronariano deve ser realizada. Ao analisarmos o ECG podemos observar a presença de supradesnível do segmento ST na parede anterior (V1 a V4). A dor epigástrica (equivalente anginoso) associada ao supradesnível do segmento ST corrobora com o diagnóstico

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

de infarto agudo do miocárdio. Vamos avaliar as alternativas Letra A incorreta. O bloqueio de ramo direito apresenta como característica fundamental um complexo QRS alargado (120 ms). Podemos observar ainda onda R secundária (R) larga (padrão pode ser rsr , rsR ou rSR , em derivações V1 e V2 - orelhas de coelho) onda S profunda, ampla e empastada nas derivações precordiais esquerdas V5 e V6 deflexão intrinsecóide retardada (o início do complexo QRS até o pico da onda R tem duração 50 ms nas derivações precordiais direitas V1 e V2). Não há alteração segmento ST. Letra B correta. Conforme vimos acima, o infarto agudo do miocárdio é a hipótese diagnóstica mais acertada para essa questão. Letra C incorreta. A Síndrome de Wolff Parkinson White (WPW) é originada de uma via acessória congênita que permite a condução do átrio para o ventrículo (anterógrada), ou seja, o estímulo elétrico atinge o ventrículo pela via acessória antes do nódulo AV, gerando uma pré-excitação ventricular (Onda Delta) e encurtando o intervalo PR. Os pacientes com padrão eletrocardiográfico de WPW possuem vias acessórias A-V que têm capacidade de condução anterógrada, resultando em alterações típicas no eletrocardiograma (intervalo PR curto ou ausente e presença de onda delta no início do complexo QRS). Letra D incorreta. Na hipertonia vagal esperamos exacerbação do parassimpático e achados eletrocardiográficos de bradicardia. Não são esperadas alterações no padrão ST. Letra E incorreta. A fibrilação atrial é definida no eletrocardiograma pela ausência de onda P e intervalo RR irregular. Resposta letra B.

346432.

Comentário: A bola da vez é quando iremos trombolisar alguém Vejamos o porquê de optarmos ou não por esta conduta em cada paciente descrito. Letra A incorreta. O quadro leva a crer que seja um acidente vascular encefálico. Até trombolisaríamos frente a uma tomografia normal, porém, veja que o espaço de tempo (delta-T) é acima de quatro horas e meia, tempo padrão para trombólise. Letra B correta. Nos pacientes onde haja algum dos critérios abaixo, associado à impossibilidade de intervenção coronária percutânea, podemos prosseguir com trombólise, sendo eles (1) dor com duração 20 minutos e 12 horas não responsiva a nitrato sublingual (2) supradesnivelamento do ST 1 mm em pelo menos duas derivações precordiais contíguas ou duas periféricas adjacentes (3) bloqueio de ramo (novo ou presumivelmente novo). Letra C incorreta. Pensando no contexto de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

trombose venosa profunda, o correto é indicar a anticoagulação. Trombolisaríamos se, em vez disto, se tratasse de um caso de tromboembolismo pulmonar (TEP) com repercussão hemodinâmica. Letra D incorreta. Semelhante ao que acabamos de citar na letra C, aqui não temos um quadro de TEP com instabilidade hemodinâmica para pensarmos em trombólise. Resposta letra B.

321608.

Comentário: Miocardites e pericardites são doenças que, com frequência, se apresentam associadas na prática clínica e representam diferentes espectros dentro do grupo das síndromes inflamatórias miopericárdicas. Isso se deve ao fato de ambas as doenças apresentarem agentes etiológicos comuns (especialmente virais). No entanto, raramente o acometimento miocárdico e pericárdico ocorre na mesma intensidade. O mais comum é haver predomínio da miocardite (perimiocardite) ou da pericardite (miopericardite). A distinção entre as diferentes formas de apresentação é relevante por ter impacto no prognóstico e tratamento. A miopericardite usualmente tem boa evolução, sem IC ou pericardite constritiva. O diagnóstico de miocardite associada à pericardite aguda deve ser suspeitado nos pacientes que apresentam diagnóstico de miocardite e pelo menos dois dos seguintes critérios dor torácica de caráter pleurítico, que pode ser difícil de identificar pela presença de dor pelo acometimento miocárdico atrito pericárdico alterações eletrocardiográficas sugestivas de pericardite com infra do segmento PR e supra de ST difuso com a concavidade para cima derrame pericárdico novo ou piora do preexistente. O laboratório geralmente revela leucocitose com predomínio de linfócitos (nos quadros virais) e elevação da PCR e velocidade de hemossedimentação (VHS). A extensão da inflamação pericárdica ao miocárdio é manifestada com elevação de troponina. As troponinas são mais específicas que CPK e CKMB para lesões miocárdicas e estão frequentemente elevadas em pacientes com miocardite. Vamos às alternativas Letra A incorreta. Claro que o IAM é um diagnóstico diferencial nesse contexto. Porém temos alguns dados que não corroboram com essa entidade clínica a idade ausência de comorbidades a estabilidade clínica diante de um supra ST tão extenso presença de febre e história prévia de gastroentrite e dor torácica não típica. Letra B incorreta. A dissecção espontânea da

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

artéria coronária (DEAC) é considerada uma síndrome coronariana aguda frequentemente subdiagnosticada e com poucos casos descritos na literatura. A DEAC deve ser considerada em qualquer paciente jovem, especialmente do sexo feminino, sem história de doença coronariana ou fatores de risco, que apresente infarto agudo do miocárdio ou parada cardíaca. O contexto de febre, infecção prévia e supra difuso do ST enfraquece esta possibilidade. Letra C correta. Conforme vimos acima, é o diagnóstico mais provável do paciente. Letra D incorreta. O vasoespasmo coronariano (angina variante ou de Prinzmetal) geralmente acomete pacientes jovens, sexo feminino, sem fatores de risco cardiovasculares (exceto tabagismo) e tem um bom prognóstico. Os eventos dor precordial geralmente ocorrem na madrugada e duram de 5 a 15 minutos e podemos encontrar alterações isquêmicas transitórias no ECG. Os fatores de risco usualmente associados são uso de cocaína, maconha, anfetamina, álcool. Resposta letra C.

337459.

Comentário: Questão baseada na Atualização da Diretriz da Prevenção Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia - 2019. Esse documento fala sobre os escores de risco, que estão entre as estratégias mais utilizadas e consistem na estimativa do risco com base em dados prospectivos coletados em coorte de pacientes diabéticos. Explica, no entanto, que a maioria dos escores ainda são limitados subestimando o risco em pacientes jovens com DM ou pacientes de diagnóstico recente, mas também superestimando o risco em indivíduos com diagnóstico há 10 anos ou HbA1c 9.0%. Além disso, os escores não consideraram os avanços dos últimos 5 a 10 anos, como novas drogas e novos métodos diagnósticos e apresentam performance preditiva relativamente baixa (estatística C entre 0.54-0.70), considerando que o risco intermediário é identificado em 30 a 60% dos indivíduos. Dessa forma, a adição do escore de cálcio coronário aos de riscos clínicos tem figurado como a alternativa mais eficiente e custo-efetiva na atualidade para estimar o risco de DAC em pacientes com risco intermediário . Resposta letra B.

321609.

Comentário: Miocardites e pericardites são doenças que, com frequência, se apresentam associadas na prática clínica e representam diferentes espectros dentro do grupo das síndromes

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

inflamatórias miopericárdicas. Isso se deve ao fato de ambas as doenças apresentarem agentes etiológicos comuns (especialmente virais). No entanto, raramente o acometimento miocárdico e pericárdico ocorre na mesma intensidade. O mais comum é haver predomínio da miocardite (perimiocardite) ou da pericardite (miopericardite). A distinção entre as diferentes formas de apresentação é relevante por ter impacto no prognóstico e tratamento. A miopericardite usualmente tem boa evolução, sem IC ou pericardite constritiva. O diagnóstico de miocardite associada à pericardite aguda deve ser suspeitado nos pacientes que apresentam diagnóstico de miocardite e pelo menos dois dos seguintes critérios dor torácica de caráter pleurítico, que pode ser difícil de identificar pela presença de dor pelo acometimento miocárdico atrito pericárdico alterações eletrocardiográficas sugestivas de pericardite com infra do segmento PR e supra de ST difuso com a concavidade para cima derrame pericárdico novo ou piora do preexistente. O laboratório geralmente revela leucocitose com predomínio de linfócitos (nos quadros virais) e elevação da PCR e velocidade de hemossedimentação (VHS). A extensão da inflamação pericárdica ao miocárdio é manifestada com elevação de troponina. As troponinas são mais específicas que CPK e CKMB para lesões miocárdicas e estão frequentemente elevadas em pacientes com miocardite. Vamos às alternativas Letras A e B incorretas. A miocardite aguda e a miopericardite pode mimetizar IAM com dor torácica típica, anormalidades no ECG similares ao IAM com ou sem supradesnivelamento do segmento ST, elevação das enzimas cardíacas e instabilidade hemodinâmica. Na suspeita de miocardite com apresentação parecida com um infarto, é necessário excluir doença arterial coronariana (DAC) por coronariografia percutânea ou angiotomografia de coronárias. No entanto, nosso caso clínico está muito mais evidente o diagnóstico de miopericardite do que uma suspeita de DAC. Letra C incorreta. A cintilografia miocárdica pode ser usada no diagnóstico da miocardite por sarcoidose e também na estratificação de risco de doença coronariana em pacientes com angina estável. Letra D correta. De acordo com as diretrizes, devemos colher uma história médica detalhada, exame físico com ênfase na ausculta cardíaca, radiografia de tórax, eletrocardiograma, ecocardiografia e exames de sangue de rotina que devem incluir marcadores de inflamação (principalmente PCR) e troponina. A ressonância magnética cardíaca (RMC) tem um papel

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

importante em um segundo momento. Na avaliação dos pacientes com miocardite, assim como na avaliação de outras cardiomiopatias não isquêmicas, a RMC apresenta grande utilidade na determinação dos parâmetros morfológicos e funcionais ventriculares. De fato, já foi amplamente validada para quantificar os volumes, a massa e a função tanto do VE quanto do VD, e é considerada, atualmente, a modalidade diagnóstica padrão-ouro para essa avaliação. Resposta letra D.

321610.

Comentário: Miocardites e pericardites são doenças que, com frequência, se apresentam associadas na prática clínica e representam diferentes espectros dentro do grupo das síndromes inflamatórias miopericárdicas. Isso se deve ao fato de ambas as doenças apresentarem agentes etiológicos comuns (especialmente virais). No entanto, raramente o acometimento miocárdico e pericárdico ocorre na mesma intensidade. O mais comum é haver predomínio da miocardite (perimiocardite) ou da pericardite (miopericardite). A distinção entre as diferentes formas de apresentação é relevante por ter impacto no prognóstico e tratamento. A miopericardite usualmente tem boa evolução, sem IC ou pericardite constritiva. O diagnóstico de miocardite associada à pericardite aguda deve ser suspeitado nos pacientes que apresentam diagnóstico de miocardite e pelo menos dois dos seguintes critérios dor torácica de caráter pleurítico, que pode ser difícil de identificar pela presença de dor pelo acometimento miocárdico atrito pericárdico alterações eletrocardiográficas sugestivas de pericardite com infra do segmento PR e supra de ST difuso com a concavidade para cima derrame pericárdico novo ou piora do preexistente. O laboratório geralmente revela leucocitose com predomínio de linfócitos (nos quadros virais) e elevação da PCR e velocidade de hemossedimentação (VHS). A extensão da inflamação pericárdica ao miocárdio é manifestada com elevação de troponina. As troponinas são mais específicas que CPK e CKMB para lesões miocárdicas e estão frequentemente elevadas em pacientes com miocardite. Em relação ao tratamento, dispomos da dipirona para auxílio no manejo da dor. Ela deve ser associada ainda a um anti-inflamatório não esteroidal (AINE), o mais usado e estudado fora do Brasil é o ibuprofeno. Uma de suas vantagens é a possibilidade de titularmos sua dose, mas, geralmente sua

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

dose inicial é de 600-800mg a cada 6-8 horas. O AINE deve ser usado com cautela. Além disso, existe discussão acerca do papel da colchicina, mas alguns trabalhos mostram que ela reduz o tempo de doença e a sua recorrência. Não há indicação de aspirina, clopidogrel, nitrato e ou corticoide nesse caso. Resposta letra B.

337466.

Comentário: Esse trecho da questão foi retirado na íntegra da Atualização da Diretriz de Prevenção Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia 2019 . As estatinas estão entre as drogas mais prescritas em todo o mundo, refletindo seu papel fundamental na prevenção primária e secundária da doença aterosclerótica e a elevada prevalência das dislipidemias. A indicação das estatinas encontra-se solidificada com base em diversos ensaios clínicos randomizados e metanálises. De forma concordante, o uso de estatinas em pacientes com DAC parece estabilizar placas ateroscleróticas, podendo até produzir sua regressão volumétrica,95 com uma relação aproximadamente linear não apenas entre a redução do LDL-c e a taxa de eventos CV, mas também entre o nível de LDL-c e a progressão do volume de ateroma em carótidas. Em paralelo, não somente a dose de estatina e a redução do LDL-c reduzem o risco CV, mas o tempo de uso das estatinas parece também ter papel central na redução do risco de morte por causas CV e infarto do miocárdio não-fatal. Resposta letra D.

315764.

Comentário: Questão retirada, integralmente, das Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Angina Instável e Infarto Agudo do Miocárdio sem Supradesnível do Segmento ST 2021. Vamos, então, revisar o trecho que respondia a questão Nos pacientes que chegam ao serviço de emergência com menos de 3h do início do quadro, as Trop-US (troponinas de alta sensibilidade) são significativamente mais sensíveis que a troponina convencional para diagnóstico de SCA, melhorando em 61% o poder diagnóstico de IAM naquele momento e em 100% se a coleta for 6h após o início do quadro . Com o aumento da sensibilidade e da acurácia diagnóstica para detecção do IAM utilizando a troponina ultrassensível, foram propostos algoritmos de diagnóstico acelerado. Assim, podemos reduzir o tempo até o diagnóstico, traduzindo menor tempo de permanência na

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

emergência e menor custo. Resposta letra A.

315767.

Comentário: Essa questão foi baseada na mais nova diretriz de síndrome coronariana aguda sem supra de ST. Como sabemos, a anticoagulação é medida importante na abordagem desses pacientes. Assim como a heparina não fracionada (HNF), a heparina de baixo peso molecular (HBPM) também pode ser prescrita. A dose preconizada é de 1 mg kg, via subcutânea (SC), de 12 12h (é a famosa dose anticoagulante). Indivíduos com ClCr 30 ml min devem receber metade da dose preconiza-se 1 mg kg, SC, uma vez ao dia se ClCr 15 ml min, devemos evitar a HBPM, mas podemos utilizar a HNF, já que esta possui metabolismo exclusivamente hepático. Já em idosos (sem disfunção renal) com mais de 75 anos, é indicada dose reduzida 0.75 mg kg, SC, 12 12h. Resposta letra D.

300807.

Comentário: A parte da anamnese conhecida como antecedentes pessoais é a parte da história clínica em que se pergunta sobre a história fisiológica (nascimento, gestação e desenvolvimento sexual) e história patológica pregressa. Neste último caso, não podemos deixar de indagar quanto a doenças prévias, alergias, cirurgias, transfusões, história obstétrica, vacinas e uso de medicamentos (LETRA C CORRETA). O trabalho tem relação com as chamadas doenças ocupacionais e, por este motivo, é importante conhecer a profissão atual do paciente desde a identificação do paciente. Dados mais específicos a história profissional passada (como ocupações anteriores e uso de equipamento de proteção individual) podem ser obtidos na parte dos hábitos de vida (LETRA B INCORRETA). É nesse momento que também se pergunta sobre hábitos alimentares, ocupação atual e anteriores, atividades físicas e vícios como consumo de álcool ou tabaco, seja ativo ou passivo (LETRA D INCORRETA). O interrogatório sobre o início dos sintomas e sua evolução deve ser feita na história da doença atual (LETRA A INCORRETA). Resposta letra C.

315777.

Comentário: Segundo as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Angina Instável e

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Infarto Agudo do Miocárdio sem Supradesnível do Segmento ST 2021 As troponinas têm reconhecido valor na avaliação de pacientes com alterações isquêmicas no ECG ou com clínica sugestiva de dor anginosa. A maior limitação das troponinas convencionais é sua baixa sensibilidade quando o paciente tem um tempo de início do quadro inferior a 6h. Com a introdução das troponinas de alta sensibilidade (Trop-US), passou a ser possível a detecção de níveis mais baixos de troponina, em menor tempo após início do quadro de lesão miocárdica de causa isquêmica. A unidade usada para expressar os valores da troponina convencional é ng mL, e nas Trop-US, os valores podem ser expressos em ng L, com poder de detecção 10 a 100 vezes maior que o das troponinas convencionais. Nos pacientes que chegam ao serviço de emergência com menos de 3h do início do quadro, as Trop-US são significativamente mais sensíveis que a troponina convencional para diagnóstico de SCA, melhorando em 61% o poder diagnóstico de IAM naquele momento e em 100% se a coleta for 6h após o início do quadro.43 Com o aumento da sensibilidade e da acurácia diagnóstica para detecção do IAM utilizando a troponina ultrassensível, foram propostos algoritmos de diagnóstico acelerado. Assim, podemos reduzir o tempo até o diagnóstico, traduzindo menor tempo de permanência na emergência e menor custo. Resposta letra A.

316331.

Comentário: Questão direta. Temos uma paciente de 24 anos, sem fatores de risco para doença coronariana, que se apresenta na emergência com um relato de dor torácica de característica pleurítica há 3 dias e supradesnivelamento de ST em diversas derivações. A troponina é positiva. A opção B está excluída justamente pela presença do supra de ST. A opção A é improvável por alguns motivos Paciente jovem, sem comorbidades Dor de evolução há 3 dias, ventilatório-dependente, o que sem dúvida não é o padrão do IAM Supra de ST em múltiplas derivações, que não correspondem a uma parede específica. A cardiomiopatia de estresse ou síndrome de Takotsubo corresponde a uma disfunção sistólica de VE (podendo também se estender para VD) sem obstrução coronariana que a justifique, podendo ser precipitada por estresse - postula-se que sua patogênese envolva liberação de catecolaminas e vasoespasmo coronariano. É mais comum em mulheres 50 anos, de início súbito, após estresse emocional ou

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

físico, com desconforto precordial e supra de ST inversão de T nas precordiais. Troponina pode estar discretamente elevada. Até seria uma possibilidade, mas sem dúvida a nossa principal hipótese diagnóstica neste caso é miopericardite, pois A paciente apresentou quadro recente de COVID (fator de risco) A dor é ventilatório-dependente O supra de ST em múltiplas derivações poupando V1 e acompanhado pelo infra de PR é típico da pericardite A troponina positiva indica acometimento miocárdico (tratando-se, no caso em tela, de miopericardite). A melhor resposta é a opção C.

273123.

Comentário: Temos um paciente com sintomas de isquemia miocárdica e a questão quer que saibamos quando devemos pular para o exame de cintilografia de perfusão miocárdica para diagnóstico de doença. O teste ergométrico (TE) é o teste provocativo mais utilizado, por ser o mais barato, de mais fácil execução e mais amplamente disponível. Na ausência de contraindicações, costuma ser o método confirmatório de primeira escolha. É importante salientar que, além de poder confirmar o diagnóstico, o TE também permite estratificar o prognóstico. O exame consiste no registro contínuo do ECG antes, durante e após um protocolo específico de esforço físico (realizado na esteira ou bicicleta ergométrica). A PA, a FC e os sintomas também devem ser monitorados. A sensibilidade do TE gira em torno de 75%, e sua especificidade é de cerca de 85%. O TE não deve ser solicitado diante de certas limitações (1) quando o ECG basal possuir alterações que impeçam a detecção do critério de isquemia (ex. síndrome de Wolff-Parkinson-White, BRE de 3 grau, marca-passo, infra de ST prévio) (2) quando o paciente for incapaz de se exercitar (ex. sequelas ortopédicas ou neurológicas, doença arterial periférica grave) (3) quando houver alguma contraindicação específica. As principais CONTRAINDICAÇÕES para o TE são angina em repouso nas últimas 48h, ritmo cardíaco instável , estenose aórtica grave, miocardite aguda, insuficiência cardíaca não controlada, hipertensão pulmonar grave, endocardite infecciosa ativa, fase aguda de um IAM (primeiros cinco dias pelo risco de ruptura da região infartada). A cintilografia é um excelente método não invasivo para detecção de isquemia miocárdica, sendo capaz não apenas de confirmar o diagnóstico, mas também de fornecer parâmetros prognósticos, uma vez que visualiza

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

diretamente a extensão da área isquêmica. Ela permite ainda uma verificação direta das consequências da isquemia (através da mensuração da fração de ejeção do ventrículo esquerdo). O TE é geralmente o método de escolha por ser mais barato, fácil de fazer, amplamente disponível e satisfatório na maioria dos casos, ao passo que a cintilografia é cara, trabalhosa e bem menos disponível. Daremos preferência à cintilo ou outro teste provocativo de imagem quando o paciente apresentar alguma limitação para a realização do TE , ou quando o TE for inconclusivo. Logo, ficaremos com a opção D como resposta mais apropriada.

273207.

Comentário: Questão retirada, integralmente, de documento do Ministério da Saúde sobre a prática de atividades físicas Vamos, então, revisar o trecho que respondia a questão Considerando os evidentes benefícios da prática de atividade física para a saúde e seus possíveis riscos, uma exposição equilibrada de riscos e benefícios e uma avaliação das características e adaptações necessárias de determinados indivíduos e grupos são elementos essenciais de uma boa prática assistencial, a qual busca evitar o risco de agravos que derivam da prática de atividades de maior intensidade e maior duração na presença de condições favorecedoras, como lesões preexistentes e obesidade. Resposta letra C.

273209.

Comentário: Questão retirada, integralmente, de documento do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre a pratica de atividade física. Vamos, então, revisar o trecho que respondia a questão A duração recomendada é de pelo menos 30 minutos por dia, com uma frequência desejada de 5 a 7 dias por semana, sendo que os indivíduos inicialmente sedentários devem atingir o nível de atividade pretendido de forma gradual, a fim de se adaptar aos poucos, reduzindo o risco de lesões ou complicações. Resposta letras C.

254211.

Comentário: Temos um paciente com fatores de risco para doença coronariana, dor torácica típica e um eletrocadiograma que mostra supradesnível em DII, DIII e aVF, ou seja, é um infarto agudo do miocárdio (IAM) com acometimento de parede inferior. Ao exame físico, encontramos estertores

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

bibasais e turgência jugular, o que denota a presença de congestão sistêmica, mas não necessariamente edema agudo de pulmão. Lembre que podemos classificar os pacientes com IAM em quatro grupos distintos de acordo com os seu achados clínicos, o que traduz o respectivo prognóstico Killip I - Sem dispneia, estertoração pulmonar ou B3 (sem evidência de insuficiência ventricular esquerda Killiip II - Dispneia e estertoração pulmonar discreta, B3 ou turgência jugular patológica Killip III - Franco edema agudo de pulmão Killip IV - Choque cardiogênico Infarto turgência jugular e estertoração pulmonar discreta Killip II. Gabarito, B.

229499.

Comentário: De acordo com a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2016), As síndromes coronarianas podem estar acompanhadas de elevação da PA, devido a um reflexo do miocárdio isquêmico. O aumento da resistência vascular periférica (RVP) eleva a demanda de oxigênio miocárdico, pelo aumento da tensão parietal do ventrículo esquerdo (A correta). Os nitratos IV reduzem a RVP, melhoram a perfusão coronariana e possuem importante efeito venodilatador sistêmico, reduzindo a pré-carga e o consumo de oxigênio miocárdico (B, C e D incorretas). Sendo assim, a única alternativa correta é a letra A.

249848.

Comentário: Questão que nos fornece o diagnóstico já fechado de síndrome coronariana aguda com troponina positiva, caracterizando infarto do miocárdio. Pelo eletrocardiograma, podemos observar padrão de BRD, com alterações secundárias da repolarização ventricular, porém não há indício de supradesnivelamento do segmento ST, não havendo indicação de trombólise ou abordagem percutânea primária de emergência (A e D INCORRETAS). Resta definir se o paciente é de alto ou baixo risco, e para isso vamos avaliar seu escore TIMI RISK, como sugerido pelo enunciado. Este escore é composto de um somatório de pontos, sendo que cada elemento vale 1 ponto. Os fatores que compõem o escore para síndrome sem supra de ST são Idade 65 anos, presença de fatores de risco cardiovascular, doença arterial coronariana conhecida, uso de aspirina nos últimos 7 dias, 2 apisódios de dor em 24h, alterações do ST 0,5mm, e marcadores de necrose positivos. Para nosso paciente, podemos marcar sem nenhuma dúvida o primeiro, segundo, quarto

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

e último itens, totalizando ao menos 4 pontos no score. Esta pontuação representa alto risco de morte, devendo o paciente receber estratificação invasiva precoce. (C INCORRETA) Resposta correta letra B

232225.

Comentário: Observando as informações fornecidas pelo autor, percebemos que se trata de um eletrocardiograma evidenciando supradesnivelamento do segmento ST em parede anterior (V1 a V4), caracterizando uma síndrome coronariana aguda (infarto agudo do miocárdio) com supra de ST, por provável oclusão da artéria descendente anterior, estando prontamente recomendada a revascularização por trombólise ou angioplastia primária uma vez que esta é a principal medida capaz de promover a estabilidade hemodinâmica neste paciente. Gabarito alternativa D.

229866.

Comentário: O enunciado nos apresenta um caso de dor anginosa estável típica, em um indivíduo com fatores de risco cardiovascular (tabagismo e hipertensão) sem controle adequado. Nem é preciso olhar as tabelas ou calculadoras de referência, o enunciado ja nos fornece as medidas relevantes. Gilmar apresenta muito alto risco cardiovascular (20% em 10 anos) e altíssima probabilidade pré-teste para doença arterial coronariana (DAC). De posse destas informações, o diagnóstico de DAC ja pode ser firmado clinicamente, sem o auxílio de exames complementares. Caso um exame como o teste ergométrico não demonstre sinais de isquemia, existe uma elevada probabilidade de tratar-se de um resultado falso negativo (A INCORRETA). Sendo assim, o seguimento da investigação deve ser realizado nesse caso apenas para avaliação prognóstica. Caso a angina de Gilmar apresente piora progressiva, com maior tempo de duração, principalmente se iniciada no repouso, é necessário modificar a abordagem e iniciar o tratamento para síndrome coronariana aguda, guiado por eletrocardiograma e dosagem de marcadores de necrose miocárdica. Nesse contexto, a dose de ataque de 300mg de AAS está bem indicada como modificador da mortalidade. (B e C CORRETAS) Para tratamento crônico da angina estável, a medicação de primeira linha é de fato o betabloqueador, pelo efeito inotrópico e cronotrópico negativo, reduzindo assim a demanda miocárdica e produzindo melhora dos sintomas. (D

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

CORRETA). A única alternativa incorreta e resposta da questão é a letra A

247467.

Comentário: Sobre a doença cardiovascular e sua prevenção, vamos avaliar cada alternativa A) Algumas intervenções nutricionais mostraram-se efetivas na redução de eventos cardiovasculares. A tradicional dieta mediterrânea é comprovadamente efetiva e caracterizada por uma alta ingestão de gordura monoinsaturada, proteínas, vegetais, grãos e peixe consumo moderado de álcool baixo consumo de carne vermelha, cereais refinados e doces e consumo de óleo de oliva e canola como a principal fonte de gordura. (INCORRETA) B) Muito embora a realização de atividade física esteja relacionada à proteção contra eventos cardiovasculares em homens ou mulheres de qualquer idade, para este efeito deve consistir em atividade moderada a intensa (INCORRETA). C) De fato, na prevenção secundária de eventos cardiovasculares, existem evidências consistentes para recomendação do uso de betabloqueadores pós-infarto do miocárdio, inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA) e bloqueadores de receptores da angiotensina (BRA) em pacientes com diabetes, insuficiência cardíaca e cardiopatia isquêmica, por exemplo. (CORRETA) D) Ensaios clínicos randomizados demonstraram, ao contrário, um aumento na incidência de eventos isquêmicos cardiovasculares, bem como de tromboembolismo venoso e de neoplasia ginecológica em usuárias de TRH. Por isso, não há recomendação atual de qualquer forma ou dosagem de terapia de reposição hormonal como medida de prevenção cardiovascular. (INCORRETA) Gabarito letra C

254291.

Comentário: Vamos avaliar o caso com calma. Trata-se de um paciente com fatores de risco cardiovasculares, assintomático, e exames laboratoriais que demonstram dislipidemia mista leve (LDL 100 TG 150), glicemia na faixa de resistência insulínica porém hemoglobina glicada normal (permitindo excluir diabetes melitus por ora). Seu MAPA evidencia hipertensão sistólica isolada, significando tratamento inadequado da hipertensão arterial. Dois objetivos devem ser estabelecidos no tratamento do paciente acima. O primeiro é o adequado controle da pressão arterial, que pode ser obtido pela adição de outra droga anti-hipertensiva (visto que a primeira ja se encontra em dose

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

máxima), ou pela alteração do estilo de vida do paciente. O segundo objetivo é avaliar a necessidade de introdução de outras terapias para redução do risco cardiovascular. Certamente a perda de peso e a prática de exercícios serão benéficas nesse sentido, porém existe ainda uma intervenção medicamentosa que se faz necessáris em pacientes de alto risco cardiovascular (como é o caso de Manoel), que é o início da terapia com estatinas na prevenção primária de eventos cardiovasculares (independente da existência de dislipidemia). Não há indicação nesse caso de início de ciprofibrato, visto que os níveis de triglicerídeos não ultrapassam 500mg dL (B INCORRETA). Sem diagnóstico firmado de diabetes mellitus, não há motivo para início de metformina nesse momento (D INCORRETA). Por fim, a maioria das diretrizes não indica início de AAS na prevenção primária, sendo os resultados de estudos conflitantes quanto ao risco benefício da terapia. (A INCORRETA). A única alternativa que une as duas intervenções necessárias é a letra C

254292.

Comentário: Estamos diante de um paciente de 55 anos, hipertenso, dislipidêmico e com resistência insulínica que vem apresentando quadro de dor torácica desencadeada por esforços e que melhora com o repouso. Ora, nem precisávamos da tabela apresentada para concluir que a probabilidade de se tratar de uma doença coronariana é elevada, não é verdade Nesses casos, é preciso realizar algum teste de esforço (dependendo do resultado do ECG de base e da capacidade de praticar atividade física, optamos pelo teste ergométrico, pela cintilografia ou pelo ecocardiograma) para melhor investigação do quadro. Lembre-se que quanto maior a probabilidade pré-teste, mais confiável é o exame. As alternativas (B) e (D) são absurdas o diagnóstico mais provável é de angina Estável e não há necessidade alguma de prescrever furosemida. A dúvida maior fica entre as opções (A) e (C). Vamos relembrar como é feita a investigação... Se o paciente consegue fazer exercícios físicos, optamos pelo teste ergométrico (se ECG de base normal) ou pela cintilo ou ecocardiograma de esforço (se ECG de base apresenta alterações que prejudiquem a análise do traçado). Se não consegue realizar exercício, optamos pela cintilo ou ecocardiograma com estresse farmacológico. Apesar do enunciado não ser tão claro em relação a essas variáveis,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

não há nenhuma informação que sugira incapacidade de realizar atividades físicas. Também não existe um ECG de base para avaliarmos... Enfim, considerando (1) que o paciente não parece apresentar limitação às atividades físicas e (2) que não há informação sobre o ECG de base, a melhor opção é solicitar um teste ergométrico pelo seu custo reduzido. Dessa forma, a melhor resposta é a opção (A), embora a (C) também não esteja errada. Questão polêmica

201903.

Comentário: Esse paciente apresenta uma dor anginosa típica, não concorda Ela é caracterizada pela presença de dor (ou desconforto) retroesternal desencadeada por atividades físicas e que melhora com o repouso ou com o uso de nitratos. Tipicamente, o sintoma dura menos de 5 minutos e pode haver irradiação para os membros superiores e para a mandíbula (embora também possa irradiar para o dorso, esse padrão deve nos fazer considerar uma dissecção aórtica, especialmente nas provas). Como a isquemia só se desenvolve durante o esforço físico, é preciso realizar algum teste provocativo para que seja possível flagra-la. Em pacientes que conseguem caminhar correr, podemos optar pelo teste ergométrico (se o ECG de base for normal) ou pela cintilografia ECO de esforço (se o ECG de base apresenta alguma anormalidade que possa prejudicar a sua interpretação durante o esforço). Caso o indivíduo seja fisicamente inapto , devemos solicitar a cintilografia com dipiridamol ou adenosina ou um ECO com dobutamina. Mas será que o paciente da questão não está infartando Certamente, não... Repare que, ao ser atendido, a dor já não se faz mais presente o seu ECG é normal. Lembre-se que o diagnóstico de uma síndrome coronariana aguda é confirmada pela presença de dois dos três seguintes critérios (1) sintomas típicos (2) alterações eletrocardiográficas compatíveis (3) elevação dos marcadores de necrose miocárdica. Resposta (E).

218210.

Comentário: Ao contrário do BRD (que pode ser apenas uma variação da normalidade em pouco mais de 10% das pessoas), o BRE é sempre um importante indicativo de cardiopatia, na maioria das vezes, na prática, de etiologia isquêmica. Por essa razão, pode aparecer agudamente num paciente com IAM (A incorreta). Como sabemos dor torácica aguda BRE sabidamente novo tratar

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

paciente como infarto com supra de ST. Se o paciente apresentou BRE há dois anos, é mais provável que ele seja portador de cardiopatia isquêmica, ou seja, é mais provável que o mesmo apresente um IAM agora que é um paciente sem BRE (B incorreta). Na vigência de BRE antigo, a interpretação do ECG é prejudicada, de modo que recorremos a outros critérios, como os de Sgarbossa, para fazer o diagnóstico de IAM. Em 1996, Sgarbossa et al. identificaram três critérios que poderiam melhorar o diagnóstico de IAMST nos pacientes com bloqueio do ramo esquerdo 1. Elevação do ST 1 mm e concordância com o complexo QRS (5 pontos) 2. Depressão do ST 1 mm nas derivações V1, V2 ou V3 (3 pontos) 3. Elevação do ST 5 mm e discordância com o complexo QRS (2 pontos). Neste caso, o ponto de corte são 3 pontos, e apenas o paciente da opção D, e não da C (pois não cita concordância com o QRS), apresenta IAM provável. Questão difícil, gabarito letra D.

205559.

Comentário: Segundo a Diretriz brasileira baseada em evidências sobre prevenção de doenças cardiovasculares em pacientes com diabetes, em pacientes com diabetes, CAC 10 é preditor de mortalidade e eventos cardiovasculares futuros. Recomenda-se que pacientes com diabetes, com CAC 10 sejam considerados de alto risco cardiovascular. Gabarito B.

205573.

Comentário: O ecocardiograma por si só consegue fornecer boas informações sobre a função ventricular esquerda. A realização do ecocardiograma sob estresse fundamenta-se no fato de que o estresse cardiovascular causa isquemia miocárdica em regiões supridas por uma artéria com grau significativo de estenose e esse fenômeno é manifestado por alteração transitória da contração segmentar (e não global), ou seja, é capaz de fornecer informações sobre a intensidade da isquemia (suficiente para produzir alteração de contratilidade). Enquanto a ecocardiografia pela dobutamina e pelo exercício apresentam acurácia diagnóstica semelhantes (83 e 85%, respectivamente), a ecocardiografia sob estresse pelo dipiridamol parece apresentar uma acurácia diagnóstica um pouco menor, e essa diferença pode ser atribuída a uma menor sensibilidade do dipiridamol na identificação de pacientes com doença uniarterial (38% para dipiridamol, 70% para

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

exercício e 61% para dobutamina). Resposta certa LETRA B.

217026.

Comentário: Sobre síndrome coronariana, vamos analisar as alternativas A-CORRETO.Estudos clínicos como o COMMIT e o CRUSADE mostraram benefício nos pacientes com síndrome coronariana. B-ERRADO. Nem tabagismo nem hipoperfusão é contra-indicação ao betabloqueador. C-ERRADO. É justamente o contrário que ocorre, a enoxaparina tem menor incidência de plaquetopenia induzida por heparina. D-ERRADO. Deve-se usar nitratos nesses casos pelo benefício da vasodilatação venosa e alívio dos sintomas. E-ERRADO. Prescrição do AAS deve ser imediata, mas a do IECA deve-se ser nas primeiras 24h. Resposta certa LETRA A.

216683.

Comentário: Questão conceitual Os níveis das troponinas cardioespecíficas se elevam em 4 a 8 horas após o início dos sintomas de infarto agudo e atingem o pico entre 36 a 72 horas. A normalização é esperada, de forma aproximada, entre 5 a 14 dias, variando de acordo com a referência bibliográfica utilizada. Logo, a alternativa A é a que mais se aproxima do esperado. Vale lembrar que por este motivo, estes marcadores são preferíveis para o diagnóstico tardio do infarto, já que neste momento os demais marcadores encontram-se dentro da faixa da normalidade (a fração MB normaliza-se após 48 a 72 horas do evento, enquanto a mioglobina em 12 a 24 horas). Resposta letra A.

174409.

Comentário: Quanto maior for a demora em recanalizar uma coronária epicárdica fechada (SCA com supra de ST), maior o tamanho da área infartada e maior a morbimortalidade A literatura é farta em evidências inquestionáveis nesse sentido... A estratégia de reperfusão pré-hospitalar pode ser usada em cenários e pacientes bem selecionados, e visa reduzir o intervalo de tempo de isquemia miocárdica, comprovadamente REDUZINDO o tamanho da área infartada e a morbimortalidade. Resposta certa C.

175391.

Comentário: Paciente chega ao pronto-socorro com quadro típico de angina - pressão retroesternal,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

com irradiação para mandíbula, desencadeada por esforço. Uma hora após sua chegada ao serviço de emergência, está assintomático e com eletrocardiograma normal... O diagnóstico é, claramente, angina estável - por este motivo, não solicitaremos marcadores de necrose miocárdica nem radiografia de tórax. Qual a conduta adequada Deve-se realizar teste de esforço para reproduzir sintomas anginosos, buscando-se confirmar o diagnóstico e partir para avaliação mais invasiva, caso necessária. Resposta E.

174422.

Comentário: Com exceção do AAS em baixas doses (doses antiplaquetárias), que é droga de ESCOLHA em todas as formas de SCA (na ausência de contraindicações), nenhum outro AINE deve ser usado agudamente nesses doentes... Os AINEs aumentam a área de infarto através do remodelamento cardíaco (ao prejudicarem a cicatrização do miocárdio infartado), o que eleva o risco de complicações mecânicas como a ruptura miocárdica e também o risco de ICFER no futuro... O AAS deve ser usado cronicamente por todo paciente de alto risco coronariano, e não somente em situações emergenciais Sua ação é SINÉRGICA com a do trombolítico nas SCA com supra de ST, potencializando o efeito antitrombótico e, consequentemente, melhorando a morbimortalidade quando ministrado junto ao trombolítico. Resposta certa C.

174451.

Comentário: Os nitratos não são capazes de reduzir o dano isquêmico (a menos que haja vasoespasmo associado) e são indicados nos quadros de dor persistente ou na presença de hipertensão insuficiência cardíaca (LETRA B INCORRETA). Não devem ser administrados em pacientes hipotensos (PAs 90 mmHg), bradicárdicos ou taquicardicos, na presença de infarto de VD ou se houver uso de inibidores da fosfodiesterase tipo 5 nas últimas 24-48h (LETRA C e D CORRETAS). Podemos utilizar inicialmente a formulação sublingual para alívio de dor ou de eventuais espamos, reservando a via endovenosa para pacientes que não responderam ao nitrato sublingual e para os que encontram-se gravemente hipertensos ou com congestão pulmonar (LETRA A CORRETA). Como o autor quer a incorreta, o gabarito é a letra B.

173504.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: As complicações do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) podem ser a rrítmicas 1) arritmias ventriculares a isquemia transmural de instalação súbita altera as propriedades eletrofisiológicas do miocárdio ventricular, tornando-o instável do ponto de vista elétrico. Pode ocorrer fibrilação ventricular primária, secundária, tardia taquicardia ventricular... 2) arritmias supraventriculares fibrilação atrial e 3) bradiarritmias Bloqueio Atrioventricular (BAV) de 1º e 2º graus BAV Total (BAVT) bloqueio de ramo e hemibloqueio insuficiência cardíaca e choque cardiogênico insuficiência ventricular direita i squêmicas angina instável pós-IAM dor anginosa em repouso ou aos mínimos esforços que recorre entre 48h e duas semanas pós-IAM, causada por área isquêmica residual do miocárdio que pode evoluir para um novo infarto m ecânica aneurisma ventricular complicação mecânica mais comum do IAM (10% de incidência) . Ocorre quando o abaulamento discinético de um segmento do miocárdio permanece o mesmo após a cicatrização do infarto. Outras complicações mecânicas são ruptura do músculo papilar (insuficiência mitral aguda) ruptura do septo interventricular (CIV) e ruptura de parede livre do ventrículo esquerdo e o pseudoaneurisma (ruptura ventricular contida por trombo e hematoma) p ericárdica pericardite fibrinosa aguda (20% dos IAM transmurais) síndrome de Dressler (pleuropericardite autoimune). Resposta certa C

174433.

Comentário: Numa SCA os betabloqueadores (BB) podem ser usados tanto por via IV quanto por via VO, com preferência, sempre que possível, por esta última, que é mais segura (A errada). A contraindicação ao uso precoce de BB (presença de fatores de risco para choque cardiogênico nas primeiras 24h) não implica contraindicação absoluta para seu uso posterior (D errada). Os critérios para preferir a via IV são (1) crise hipertensiva, (2) taquiarritmia. Mesmo nestes casos preconiza-se manter o uso IV pelo menor tempo possível (24h), devendo-se passar para a via oral já no dia seguinte (B errada). Enfim, o grande objetivo dos BB no tratamento da SCA é o controle do duplo-produto cardíaco . Sua função neste controle é principalmente a redução da frequência cardíaca para uma meta em torno de 60 bpm... Resposta certa C.

173520.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Questão simples... A terapia de reperfusão com angioplastia primária ou trombólise é empregada em pacientes com síndrome coronariana aguda (SCA) com supradesnível do segmento ST. Em qualquer SCA, porém, deve-se realizar antiagregação plaquetária, anticoagulação e redução do consumo miocárdico de oxigênio com betabloqueadores (salvo em paciente com contraindicação). Resposta C.

173531.

Comentário: Estamos vendo paciente com múltiplos fatores de risco para doença coronariana que abre quadro de dor torácica típica, ou seja, ela tem síndrome coronariana aguda (SCA). Os exames iniciais, eletro e marcadores de necrose do miocárdio, foram normais, isto é, trata-se de SCA sem supradesnível do segmento ST. Todos os pacientes que assim se apresentam devem ser reavaliados por eletro e MNM seriados. Enquanto aguarda tais exames, ela deve receber dupla antiagregação plaquetária com ácido acetilsalicílico e clopidogrel. Resposta A.

182490.

Comentário: Bom, temos um adulto dislipidêmico com um quadro de dor torácica em peso, com sinal de Levine positivo, que irradia para o ombro esquerdo, que foi desencadeada por uma atividade física e que melhorou 20 minutos após a admissão hospitalar (acreditamos que tenha ficado em repouso quando chegou ao hospital, certo). Essas características são muito sugestivas de um quadro de síndrome coronariana aguda (SCA) Um eletrocardiograma e um exame laboratorial com marcadores de necrose miocárdica devem ser realizados o mais rápido possível Embora possa cursar com dor torácica, esperaríamos um quadro respiratório mais evidente caso se tratasse de uma embolia pulmonar. Podemos dizer o mesmo sobre o pneumotórax. Além disso, a dor costuma ter componente pleurítico nessas condições A esofagite cursa com um quadro mais arrastado de dor torácica devido ao quadro inflamatório que se estabelece no esôfago. O espasmo esofagiano difuso é a patologia esofágica que pode causar sintomatologia mais aguda, sendo um importante diagnóstico diferencial da SCA. Resposta (C).

185144.

Comentário: A terapia de reperfusão miocárdica é indicada no IAM com supra de ST em pacientes

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

com sintomas compatíveis com infarto, delta T de até 12h do início dos sintomas e supra de ST em duas ou mais derivações ou bloqueio de ramo esquerdo novo ou presumivelmente novo. No entanto, segundo a Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Tratamento do IAM com Supradesnivel do Segmento ST, Pacientes cujo primeiro contato médico e suspeição diagnóstica de IAM com supradesnivelamento do miocárdio sejam efetivadas com retardo superior a 12 horas até 24 horas podem ser submetidos à intervenção coronária percutânea primária mediante a evidência de isquemia miocárdica persistente, assim como de suas eventuais consequências (instabilidade hemodinâmica e ou arritmias ventriculares graves) . Por isso nossa resposta é a letra B.

187602.

Comentário: Questão mal escrita... Classicamente, a cardiopatia chagásica se apresenta com uma associação entre bloqueio de ramo direito e hemibloqueio anterior esquerdo. Não costumam surgir alterações no segmento ST (A errada). Nos bloqueios atrioventriculares, o segmento ST também não apresenta desnivelamentos (D errada). Lembre que nem todo infarto agudo do miocárdio cursa com supradesnivelamento do segmento ST. Em alguns casos, pode haver infra... Além disso, a onda T invertida também está presente - C certa. O problema é o seguinte nas sobrecargas ventriculares direitas, podemos observar o chamado padrão strain - uma espécie de infra de ST descendente com inversão de onda T. Nestes casos, costuma ser visualizado em V1 e V2 - B certa. Assim, como havia duas respostas, a questão deveria ter sido anulada. A banca deu como gabarito a alternativa C.

178865.

Comentário: Vamos juntar as peças desse quebra-cabeça Jovem Dor torácica Taquidispneia Taquicardia Ausência de trauma torácico. Certamente a primeira hipótese diagnóstica recai sobre o diagnóstico de pneumotórax espontâneo Lembre-se também do perfil do paciente com este quadro. São dois típicos jovem longilíneo e idoso adulto com história de tabagismo. Ok. Já temos um diagnóstico Mas o que parece que está acontecendo Bem, há um quadro de piora recente, sugerindo que o quadro possa evoluir para pneumotórax hipertensivo. O que fazer Se houver, de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

fato, a evolução para um quadro hipertensivo, a toracocentese de alívio deverá ser indicada. No entanto, se o quadro se mantiver estável, há necessidade de descompressão torácica com uma drenagem torácica em selo d água. Sendo assim, melhor resposta letra A.

174465.

Comentário: As letras B e C estão corretas, e o conceito expressão pela segunda é justificado pelo conceito expresso na primeira. A letra A está correta, e é antagônica ao que está sendo dito pela letra D, que obviamente está errada é claro que o grande objetivo de se identificar os portadores de coronariopatia assintomática é a possibilidade de instituir medidas terapêuticas e preventivas que evitem eficazmente a ocorrência de um primeiro evento cardiovascular potencialmente devastador, resultando assim numa diminuição de morbimortalidade associada à doença Resposta certa D.

178766.

Comentário: Diante da suspeita de Infarto Agudo do Miocárdio, a realização de um eletrocardiograma- ECG com o máximo de derivações possíveis, de preferência as 12 (tempo porta-ECG é de 10 minutos) e a administração de Aspirina (dose de 160-325mg mastigável) são medidas imediatas e que independem do resultado de quaisquer outros exames. A oxigenioterapia ainda precisa de comprovação, podendo inclusive aumentar a resistência coronariana, portanto, está indicada apenas para hipoxêmicos (Sat O2 90%). Os nitratos (vasodiloatadores) não são capazes de reduzir o dano isquêmico, estando indicados para os quadros de dor persistente ou na presença de hipertensão ou insuficiência cardíaca. A morfina também é usada, para fins de analgesia, reduzindo o trabalho respiratório, a ansiedade e congestão pulmonar, devendo ser evitada no infarto de ventrículo direito, por ter efeito venodilatador. Sabemos que serão necessárias outras medidas, como a solicitação da curva de enzimas cardíacas (troponina e a CK-MB massa), a associação de outro antiplaquetário (inibidor do receptor P2Y12 -ex clopidogrel), dentre outras medidas medicamentosas, respeitando as contraindicações e as situações de indicação (anticoagulantes, betabloqueadores e inibidor da ECA ou Antagonista da Angiotensina II, dentro das primeiras 24 horas, estatinas e etc...) Resposta certa E

183345.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: As bancas de residência médica estão cada vez mais sem criatividade. A nova moda é retirar trechos na íntegra de artigos, jornais, protocolos, diretrizes ou consensos de sociedades específicas e substituir uma palavra ou outra e pedir que o aluno encontre qual assertiva está correta ou incorreta. Nesse caso, vamos retirar um trecho do documento DIRETRIZ SUL-AMERICANA DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR Um programa de RCV é integrado por uma equipe multidisciplinar (Tabela 6), que requer as seguintes competências conhecimento básico nas áreas cardiovascular, pulmonar e musculoesquelética, interpretação do eletrocardiograma, manejo de emergências médicas e conhecimentos em teoria e prática do exercício físico . O núcleo da equipe é formado por médicos, enfermeiras e especialistas em exercícios, com a opção de agregar especialistas em outras disciplinas para fornecer ao paciente atendimento e educação completa (Nutricionista, Psicólogo entre outros). Nos resta apenas aprender com a questão. Portanto, o nosso gabarito é a letra C.

183343.

Comentário: Questão que se baseou na DIRETRIZ SUL-AMERICANA DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR. Vamos, então, analisar cada letra. Letra A Embora o IMC seja um método simples para detectar sujeitos com aumento considerável de gordura corporal, particularmente em âmbito populacional, estudos recentes têm questionado a sua validade para diagnosticar obesidade individual . INCORRETA Letras B, C e D O aumento da gordura se associa ao aumento dos ácidos graxos livres, hiperinsulinemia, resistência à insulina, DM, hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia. Os efeitos da obesidade sobre o risco cardiovascular global impacta de forma muito marcada. O obeso tem maior frequência e incidência de outros fatores de risco. (letra B - CORRETA) No entanto, o risco manifesta-se também de forma direta, uma vez que a gordura, particularmente a visceral intra-abdominal, é um órgão endócrino, metabolicamente ativo, que sintetiza e libera na circulação sanguínea diferentes peptídeos e outros compostos não peptídicos que participam da homeostase cardiovascular. (letra C - CORRETA) O obeso perde em maior ou menor grau esse equilíbrio e assim o risco também aumenta. (letra D - CORRETA) Resposta letra A.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183337.

Comentário: Questão retirada, na íntegra, da DIRETRIZ DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA E DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA SOBRE INTERVENÇÃO CORONÁRIA PERCUTÂNEA. Vamos, então, analisar cada letra. Letra A Deve-se ter em mente ainda que doença no Tronco de Coronária Esquerda está frequentemente associada a doença em ramos subsequentes, e a presença de estenoses significativas na artéria descendente anterior e ou na artéria circunflexa pode sub- ou superestimar o valor da RFF (reserva de fluxo fracionada) medida na lesão no TCE. INCORRETA Letras B, C e D Presença de estenose significativa no TCE tem grande importância prognóstica, e a determinação do significado funcional de tais estenoses é fundamental para a decisão da estratégia terapêutica. Revascularização de lesões no TCE não significativas, do ponto de vista funcional, pode levar à oclusão precoce dos enxertos cirúrgicos, mesmo que condutos de artéria mamária interna esquerda sejam utilizados. Ademais, deve-se ter em mente que o TCE representa o local da árvore coronária em que a avaliação angiográfica da gravidade da estenose é mais ambígua e variável. CORRETAS Resposta letra A.

157348.

Comentário: Em um idoso, com fatores de risco para doenças cardiovasculares e dor epigástrica de início agudo a realização de um eletrocardiograma em até dez minutos do início do atendimento é fundamental. E não deu outra o ECG mostra supradesnível de segmento ST de V1 a V6 e em D1 e aVL. Esses achados são compatíveis com infarto agudo do miocárdio com supradesnível de ST anterior extenso. Vamos rever as principais paredes do eletrocardiograma utilizadas para o diagnóstico das síndromes coronarianas agudas -IAM Anterosseptal V1-V2 V1-V3 V1-V4 -IAM Anterolateral V5, V6, D1 e aVL -IAM Anterior extenso V1-V6 D1 e aVL -IAM Lateral alto D1 e aVL -IAM Inferior D2, D3 e aVF -IAM Dorsal Imagem em espelho em V1-V2 ou V1-V5 ou supra ST em V7 e V8 -IAM Inferodorsal Parede inferior dorsal -IAM Laterodorsal Parede lateral alta dorsal -IAM Ínferolateral D2, D3 e aVF, V5 e V6 -IAM de VD V3R e V4R - V1 Gabarito letra D.

150226.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Questão bastante polêmica. Embora a medida menos necessária dentre as citadas seja realmente a solicitação de enzimas (visto que apenas o supra de ST já é suficiente para o diagnóstico de IAM com supra no caso em tela), é errado dizer que sua solicitação é inapropriada. Marcadores bioquímicos são fundamentais para auxiliar tanto no diagnóstico quanto no prognóstico de pacientes com Síndrome Coronária Aguda (SCA). Além disso, os mesmos fornecem importantes informações prognósticas, na medida em que existe uma direta associação entre a elevação dos marcadores séricos e o risco de eventos cardíacos em curto e médio prazos. A solicitação seria inapropriada apenas caso atrasássemos o cateterismo aguardando os resultados das enzimas, o que não foi citado. Porém, contudo, infelizmente a questão não foi anulada e o gabarito foi mantido na opção C.

150722.

Comentário: Diante de um infarto agudo do miocárdio sem supra de ST (IAMSST), a terapia antiplaquetária dupla está indicada. Uma dose de ataque de AAS deve ser administrada (200-300 mg, geralmente), seguida da terapia de manutenção nos dias subsequentes. Clopidogrel, ticagrelor e plasugrel podem ser utilizados como segundo agente antiplaquetário. Além da terapia antiplaquetária, está indicado o uso de drogas anticoagulantes. A enoxaparina costuma ser a droga mais utilizada. A heparina não fracionada é usada quando há previsão de cirurgia de revascularização miocárdica nas próximas 24 horas. A bivalirudina pode ser a substituta das heparinas nos casos de trombocitopenia induzida por heparina. O fondaparinux pode ser prescrito para aqueles indivíduos com alto risco de sangramento, mas não deve ser usado nos casassem que uma estratégia terapêutica invasiva seja necessária. Oxigenioterapia (caso necessário), analgesia, estatinas e betabloqueadores também estão indicados. Agora, diferente do que estudamos no IAM com supra de ST, não há indicação de terapia fibrinolítica no IAMSST A estratégia invasiva precoce costuma ser indicada para indivíduos de médio alto risco. Nenhum dado foi descrito no enunciado para que pudéssemos classificar o paciente em relação ao seu risco Dessa forma, a melhor alternativa é a opção (A).

157410.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Todas as assertivas sobre o clopidogrel são corretas, menos a letra C a droga é do grupo dos bloqueadores irreversíveis do receptor de ADP e portanto pode ser suspensa 7 dias antes de cirurgias eletivas (tempo aproximado de meia vida plaquetária). Resposta C.

157422.

Comentário: Questão retirada das Diretrizes brasileiras de antiagregantes plaquetários e anticoagulantes em cardiologia na íntegra. Foram copiados vários parágrafos da diretriz e apenas no parágrafo referente ao Ticagrelor foi feita alteração, de modo que o conteúdo do mesmo ficasse incorreto. Gabarito correto (opção D). Vejamos o conceito correto O ticagrelor, outro componente da classe dos antiagregantes plaquetários inibidores da ADP, tem como características importantes ser um inibidor reversível dos receptores P2Y12 da ADP, ser uma droga que não depende de metabolização primária (logo, não se trata de uma pró-droga), além de obter efeito antiagregante mais intenso, rápido e consistente em relação ao clopidogrel.

149245.

Comentário: Durante muito tempo, a oxigenoterapia foi considerada a terapêutica universal para todos os casos de síndrome coronariana aguda nas primeiras 6 horas, mas atualmente considera-se que ela é realmente indicada para os pacientes com redução da saturação de oxigênio (94% pela diretriz brasileira e 90% pela diretriz norte-americana) ou com desconforto respiratório. Isso porque há uma possibilidade de uma eventual hiperóxia provocar um efeito vasoconstritor coronariano. Por esse motivo, o gabarito liberado foi a letra A. Entretanto, a questão deveria ter sido anulada pela justificativa apresentada na letra D que também está correta, uma vez que a diretriz brasileira afirma que a administração de oxigênio poderia provocar vasoconstrição sistêmica, com aumento da resistência vascular sistêmica e pressão arterial, ocasionando redução do débito cardíaco. Desta forma, a questão, na realidade, apresenta 2 respostas certas. A banca manteve como gabarito a letra A.

156520.

Comentário: Questão tranquila Vamos analisar as assertivas a)Incorreta A hipocomplementenemia não é um dos fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Dentre os fatores laboratoriais

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

podemos citar Colesterol LDL alto Colesterol HDL baixo Aumento de fatores protrombóticos Aumento de fatores pró-inflamatórios. b)Correta Similarmente aos dados mundiais, no Brasil as doenças cardiovasculares constituem a principal causa de óbito. Mais de 300.000 mortes ocorrem anualmente por DCV, chegando a quase 30% das causas de óbitos no país. c)Incorreta A predisposição genética corresponde a um fator de risco não modificável para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. A genética é implacável d)Incorreta A modificação de hábitos de vida, entre os quais se inclui a melhora de padrões dietéticos, corresponde a um fator e risco modificável para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Gabarito letra B.

157423.

Comentário: Somente a letra A está correta. A formação da placa aterosclerótica relaciona-se a agressão ao endotélio vascular devido a diversos fatores de risco, como dislipidemia, hipertensão arterial ou tabagismo. A disfunção endotelial conseqüente AUMENTA a permeabilidade da íntima às lipoproteínas plasmáticas, favorecendo a retenção das mesmas no espaço subendotelial. Assim, o depósito de lipoproteínas na parede arterial é processo-chave na EVOLUÇÃO da aterogênese. O LDL sofre oxidação, causando a exposição de diversos neo-epitopos e tornando-se imunogênico. Resposta A.

157428.

Comentário: Vamos rever as assertivas INCORRETAS Placas estáveis caracterizam-se por predomínio de colágeno, desorganizado em capa fibrosa espessa, POUCAS células inflamatórias e núcleo lipídico e necrótico de proporções menores. As placas instáveis apresentam atividade inflamatória AUMENTADA, especialmente nas suas bordas laterais, com grande atividade proteolítica, núcleo lipídico e necrótico proeminente e capa fibrótica tênue. A ruptura desta placa instável expõe material LIPÍDICO altamente trombogênico, levando à formação de um trombo sobrejacente. Resposta D.

157435.

Comentário: A formação de um trombo sobre uma placa aterosclerótica é a manifestação mais temida da aterosclerose. Suas principais e MAIS COMUNS repercussões clínicas são as síndromes

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

coronariana aguda e cerebrovascular aguda. Estas complicações são frequentemente a primeira manifestação da doença. Resposta A.

138261.

Comentário: O enunciado trouxe um caso específico de um paciente que apresentou um IAM com supradesnivelamento do ST, que foi submetido a trombólise em tempo hábil porém não apresentou critérios de reperfusão, mantendo o quadro clínico e as alterações eletrocardiográficas. Nesse caso, podemos optar pela realização de angioplastia de RESGATE, na tentativa de promover a abertura do vaso ocluído, ainda no contexto do evento agudo. A realização de fibrinolítico não é impeditiva para o cateterismo (D INCORRETA) e o exame deve ser realizado tão logo esteja disponível (B e C INCORRETAS) Resposta letra A

127669.

Comentário: Temos um paciente com múltiplos fatores de risco para Doença Arterial Coronariana (DAC) e que nas últimas seis horas desenvolveu um quadro clínico extremamente típico de uma Síndrome Coronariana Aguda (SCA). E o que o traçado eletrocardiográfico nos mostra Um infradesnivelamento do segmento ST de parede anterior, o que nos permite fechar o diagnóstico de Síndrome Coronariana Aguda Sem Supra de ST (SCASSST). Como não estamos nem diante de uma SCA COM supra de ST e nem frente a um paciente instável (hipotenso, com congestão pulmonar), não está indicado nenhum tipo de terapia reperfusional de emergência (angioplastia primária, nem muito menos a trombólise, que paradoxalmente aumenta a mortalidade nesses doentes). Em tal contexto, nossa primeira intervenção deve ser administrar AAS em dose antiagregante plaquetária (300 mg VO), seguido do nitrato para controle da dor e dos níveis tensionais. Alternativa D correta.

129840.

Comentário: Temos um paciente com uma síndrome coronariana aguda, caracterizada pela presença de dor torácica de instalação rápida e de forte intensidade, associada a um ECG com supra de ST em derivações de parede inferior (DII, DIII e aVF). O IAM de parede inferior é na maioria das vezes resultado de uma obstrução da artéria coronária direita (70% dos casos) e da

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

circunflexa nos restantes (30%). Nos casos de infarto inferior como esse, é importante pesquisar a associação de infarto de ventrículo direito (com avaliação específica das derivações V3R e V4R) e de parede posterior (com avaliação das imagens em espelho presentes nas derivações anteriores, especialmente V1 a V3). Os sintomas de baixo débito cardíaco apresentados pelo paciente (tonteira e dispneia) poderiam ser explicados tanto por um infarto de grande extensão do VD quanto pela presença associada do BAVT, esse último sendo uma indicação de marca-passo temporário até estabilização dos sintomas. Como a questão quer saber qual artéria mais provavelmente acometida, a resposta correta é artéria coronária direita LETRA A.

136892.

Comentário: Paciente de 58 anos com fatores de risco para doença coronariana chega à emergência com dor anginosa há duas horas acompanhada de supra de ST em parede anterosseptal. Ou seja cabe abrir a artéria urgentemente, com trombólise ou angioplastia. Qual escolher Dentre elas, caso a angioplastia esteja prontamente disponível, ela será a escolha porque permite, além de desobstruir o vaso culpado, estudar a circulação coronariana como um todo (A e B erradas). Se o paciente fará angioplastia, devemos empregar heparina não fracionada e não enoxa (D incorreta, apesar de ter sido o gabarito inicial do concurso). Como percebemos que a alternativa C seria a melhor resposta, fizemos recurso e a banca resolveu anular a questão. Gabarito MEDGRUPO D.

136598.

Comentário: O conceito de repouso endotelial aplica-se classicamente ao uso dos nitratos, sejam por via oral (dinitrato de isossorbida ou mononitrato de isossorbida) ou via venosa (nitroglicerina Tridil). Essas drogas são muito utilizadas no tratamento da síndrome coronariana aguda por seu efeito vasodilatador sistêmico e coronariano, com redução do estresse miocárdico e do vasoespasmo. Seu mecanismo de ação é aumento da produção radicas livres de óxido nítrico, capazes de promover relaxamento das células musculares lisas do endotélio, principalmente venoso, mas também arterial. No entanto, uma limitação importante ao seu uso é a tolerância que se desenvolve a doses constantes. É aconselhável que os pacientes permaneçam 12 horas diárias

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

sem tomar a droga, para que sejam restauradas as reservas de glutation celular, principal fonte de sulfidrilas radicais usados pelos nitratos para sua ação. Assim, a posologia dos nitratos orais deve ser feita de 6 6 horas, omitindo uma dose noturna, num total de três doses (por exemplo, às 8h, 14h e 20h) e, no caso da nitroglicerina, sua infusão deve ser interrompida diariamente por períodos de cerca de 12 horas. Resposta A.

127347.

Comentário: Sabemos que a isquemia miocárdica é capaz de alterar as propriedades eletrofisiológicas do miocárdio ventricular, tornando-o susceptível à ocorrência de arritmias ventriculares. No entanto, sabemos também que uma classe de drogas utilizada de rotina no contexto das síndromes coronarianas agudas pode atuar de forma preventiva às arritmias ventriculares os betabloqueadores. Considerados antiarrítmicos do grupo II, este grupo medicamentoso bloqueia os beta-receptores adrenérgicos, os quais possuem atividade arritmogênica, visto que exacerbam a corrente de cálcio para o citoplasma, aumentando o automatismo miocárdico. Seu efeito fundamental no tratamento das síndromes isquêmicas agudas baseia-se no fato de que os betabloqueadores controlam a frequência cardíaca, a pressão arterial e o inotropismo, reduzindo o consumo miocárdico. A letra D tem a melhor resposta.

136615.

Comentário: Até 40% dos usuários de cocaína que chegam a um serviço de emergência apresentam precordialgia, possuindo um risco aumentado de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) devido à propriedade vasoconstrictora e trombogênica da droga, que também promove taquicardia, hipertensão arterial e maior consumo de 0 2 . O diagnóstico e tratamento do IAM são os mesmos, com uma observação importante os betabloqueadores devem ser evitados até 24h após o uso da droga (por exemplo, propranolol). Com o bloqueio beta, as catecolaminas, que têm seu efeito exacerbado pela cocaína, ficam livres para agir sobre os receptores alfa, podendo piorar a vasoconstricção generalizada já estabelecida. Nos casos de extrema necessidade (pro exemplo, em pacientes com dissecção aórtica que precisam de redução imediata da frequência cardíaca), devem ser utilizados apenas após a fentolamina. Nesse caso, o bloqueio alfa pela fentolamina

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

impede o efeito desastroso dos betabloqueadores. Mesmo drogas como o labetalol, com propriedades alfa e betabloqueadoras, não devem ser utilizadas isoladamente, pois geralmente seu bloqueio beta é mais intenso que o alfa. O uso de benzodiazepínicos (ex. diazepam) é indicado como droga de primeira linha, pois há melhora dos sintomas psicomotores e da reatividade simpática. O haloperidol e o nitroprussiato de sódio também pode ser considerados no tratamento da agitação psicomotora e da hipertensão arterial, respectivamente. Portanto, a única droga contraindica é o propranolol. Gabarito A.

136608.

Comentário: Estamos diante de um paciente com infarto agudo do miocárdio em parede inferior (supra de ST em derivações DII, DIII e aVF). Nesses casos, é importante excluir a concomitância de infarto do VD pela presença de supra de ST nas precordiais direitas (V3R e V4R), pois há maior risco de hipotensão e choque cardiogênico. Nesse caso, devemos evitar o uso de morfina, nitratos (como a nitroglicerina) e diuréticos. Porém, como a questão não cita comprometimento do VD, a princípio não há contraindicação a essas medicações (A e B incorretas). O clopidogrel é um agente antiplaquetário inibidor do receptor P2Y 12 , que está indicado em todos os pacientes no contexto da síndrome coronariana aguda, juntamente ao AAS (C incorreta). Já a administração de oxigênio suplementar no contexto do infarto agudo do miocárdio é indicada apenas para pacientes com saturação de oxigênio 90%. Não há comprovação de benefícios naqueles sem hipoxemia, podendo inclusive aumentar a resistência coronariana. Portanto, resposta C.

136574.

Comentário: Estamos diante de um paciente com Síndrome Coronariana Aguda (SCA) com supra do segmento ST e infarto agudo do miocárdio em parede anterior do coração (derivações V1 a V5). Ao exame físico, ele apresenta sinais de insuficiência cardíaca aguda, identificada pela presença de estertores finos pulmonares bibasais e terceira bulha (classificação KILLIP II). Nesse caso, a droga contraindicada é o betabloqueador (ex. atenolol), por piorar a contratilidade miocárdica e ser capaz de precipitar um choque cardiogênico. A nitroglicerina é um nitrato, vasodilatador que pode estar indicado no contexto da insuficiência cardíaca e edema pulmonar congestivo, especialmente

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

na presença de hipertensão. O captopril é um inibidor da ECA, que costuma ser administrado de rotina nas primeiras 24 horas do infarto para todos os pacientes, especialmente naqueles com localização anterior e insuficiência cardíaca. O clopidogrel é um agente antiplaquetário inibidor do receptor P2Y 12 , que está indicado em todos os pacientes no contexto da síndrome coronariana aguda, juntamente ao AAS. Portanto, a única droga contraindicada é o atenolol. Gabarito B.

138643.

Comentário: Questão interessante. O que esse paciente tem Será apenas um infarto de parede inferior Veja você que não Além da dor torácica e do supra de ST, ele tem pulsos assimétricos, sinal altamente sugestivo, quando em vigência de dor torácica, de dissecção aguda de aorta. Podemos antiagregar ou anticoagular um paciente que talvez tenha indicação cirúrgica de emergência Não (B, C e D erradas). Agora, com o objetivo de tentar reduzir a dissecção, precisamos reduzir o duplo-produto do paciente, empregando, para isso, o labetalol, um beta-bloqueador venoso, que, como tal, reduz a frequência cardíaca e a pressão arterial de forma rápida e facilmente titulável. Resposta A. Em tempo, lembre que no brasil não dispomos de labetalol, então, em geral, reduzimos a pressão com nitroprussiato de sódio e a frequência cardíaca com metoprolol venoso.

109337.

Comentário: A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica que acomete a camada íntima das artérias de grande e médio calibre. Ocorre a formação de placas de ateroma composta de um cerne lipídico, além de células inflamatórias mononucleares e células musculares lisas produtoras de colágeno. O processo de início por lesão do endotelio, que gera disfunção endotelial e aumento de permeabilidade da camada íntima as lipoproteínas plasmáticas. Esse conhecimento é a base de muitas doenças que conhecemos, como as síndromes isquêmicas do miocárdico. Letra B é o gabarito.

111423.

Comentário: As opções A, B e D, na realidade, constituem CONTRAINDICAÇÕES ao uso de betabloqueadores A letra C traz uma síndrome coronariana aguda grave (IAM com supra de ST),

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

condição de elevado risco de morbimortalidade que, por conseguinte, aufere o máximo de benefícios com o uso de betabloqueadores - desde que não haja contraindicação específica, é claro. Resposta certa C.

112353.

Comentário: No contexto clínico apropriado (sinais e sintomas de síndrome coronariana aguda), o encontro de supra de ST ou BRE novo presumivelmente novo indica, para todos os fins práticos, que EXISTE UMA CORONÁRIA QUE FOI AGUDAMENTE OCLUÍDA. Ora, se o lúmen de uma coronária fechou (provocando isquemia transmural do miocárdio irrigado por aquele vaso), o que temos que fazer é ABRIR ESSA CORONÁRIA O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL (terapia de reperfusão ou revascularização). A literatura demonstrou que, sempre que possível, o método de escolha para tratar um IAM com supra de ST é a angioplastia primária (aquela realizada emergencialmente no contexto de uma síndrome coronariana aguda). A angioplastia primária é superior ao trombolítico em termos de obtenção de patência do vaso, limitação da extensão da área infartada e melhora na morbimortalidade. Em relação à cirurgia de revascularização miocárdica, obviamente, a angioplastia primária é mais prática, mais rápida e mais disponível. O paciente deve entrar na sala de hemodinâmica já devidamente medicado com antiagregantes plaquetários orais (AAS clopidogrel), que devem ser ministrados imediatamente após o diagnóstico (A errada). Todo portador de SCA deve permanecer acamado e com monitorização cardíaca contínua, pois existe risco de arritmia maligna e morte súbita, bem como existe a possibilidade de detectarmos alterações dinâmicas do segmento ST (ex. aumento ou diminuição de infra ou supra de ST) B ERRADA. Um conceito muito importante é o de que a presença de supra de ST no contexto apropriado, como já dissemos, permite confirmar um diagnóstico clínico-operacional de IAMST, ou seja, não devemos esperar o resultado da dosagem de marcadores de necrose miocárdica (como as troponinas) para dar início à conduta terapêutica definitiva, que é a revascularização. Teoricamente, inclusive, o ideal seria revascularizar o paciente o mais rápido possível, antes mesmo que houvesse aumento expressivo desses marcadores (o que refletiria uma significativa limitação da área infartada). Às vezes isso é possível, por exemplo, quando o paciente chega a um

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

serviço de emergência com setor hemodinâmico disponível poucos minutos após o início do quadro de SCA (claro, num hospital de excelência e com uma equipe bem coordenada e experiente). Resposta certa C.

101146.

Comentário: A principal etiologia para o achado de supradesnivelamento do segmento ST no eletrocardiograma é o infarto miocárdico agudo TRANSMURAL (oclusão completa de uma coronária epicárdica). Nesta situação, o supra de ST deve ser maior que 1 mm e deve estar presente em, pelo menos, duas derivações contíguas (D correta). Outra etiologia menos comum para o supra de ST é o aneurisma ventricular, uma lesão que geralmente representa sequela de um infarto transmural prévio. Logo, a letra B também serviria como resposta Questão mal feita, que foi anulada após interposição de recurso.

103742.

Comentário: Muitas questões de SCA cobram este conhecimento. Sabemos que a irrigação arterial do miocárdio se dá por meio de três principais coronárias e seus ramos descendente anterior, circunflexa e coronária direita. A coronária direita é responsável pela irrigação do ventrículo direito e, em 70% das pessoas (dominância direita), pela porção basal do septo interventricular e as paredes posterior e inferior do ventrículo esquerdo. Desta forma, diante de um IAM de parede inferior, presumimos que na maioria dos casos a CD é o vaso culpado. Assim, sempre que diagnosticamos um IAM de parede inferior devemos, obrigatoriamente, solicitar as derivações adicionais para avaliação do restante do território irrigado pela CD, ou seja, V3R e V4R para avaliarmos o ventrículo direito e V7 e V8 para avaliarmos a parede posterior do VE. Mesmo sem as derivações adicionais para a parede posterior, na presença de supradesnível de ST na parede inferior, com frequência podemos diagnosticar o infarto de parede posterior pelo ECG através de imagem em espelho na parede anterior (infradesnível de ST). N o vamos esquecer que o supradesnível de ST sempre predomina sobre o infradesnível, ent o o primeiro nunca corresponde a imagem em espelho. Quando concluímos que houve IAM de VD n o devemos tratar o paciente com nitratos, pois o VD necessita de pré-carga para seu adequado funcionamento. O infarto isolado

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

de parede inferior não contra-indica o uso de nitratos. Desta forma, a letra D é a melhor resposta.

110218.

Comentário: Boa questão O quadro apresentado é de síndrome coronariana aguda sem supra de ST em paciente com múltiplos fatores de risco. O tratamento desta condição requer o uso das seguintes drogas, que podem ser subdivididas em grupos Drogas anti-isquêmicas estabilizadoras da placa (1) nitrato (2) beta-BQ (3) estatina. Drogas antiplaquetárias (4) AAS (5) clopidogrel prasugrel (este apenas após CAT) ou inibidor da GpIIbIIIa. Droga antitrombótica (6) Heparina não fracionada, enoxaparina, fondaparinux ou bivalirudina (este apenas na estratégia agressiva). Das 6 drogas indicadas no tratamento da SCA sem supra de ST, todas, menos o nitrato, aumentam a sobrevida e reduzem o risco de novo evento coronariano nas semanas seguintes (período crítico). Dessa forma, a única combinação correta é a opção A, já que B e D contêm o nitrato (ótima droga antianginosa, porém não leva a aumento de sobrevida) e as opções C e D contêm a morfina (que é utilizada no IAM com supra, fazendo parte do MONAB). Resposta certa A.

110222.

Comentário: Temos um paciente de 67 anos com três fatores de riscos cardiovasculares e quadro clínico composto por dor torácica anginosa típica e alteração eletrocardiográfica, porém, com marcadores de necrose negativo. Este cenário configura o diagnóstico de angina instável. Diante de uma Síndrome Coronariana Aguda (SCA) sem supra de ST, devemos definir o tipo de estratificação a qual o paciente deverá ser submetido. Em geral, pacientes de médio e alto risco se beneficiam de estratificação invasiva precoce, enquanto os de baixo risco podem ser manejados de maneira conservadora ou invasiva. Uma das formas mais conhecidas e de fácil memorização para definição do risco na SCA sem supra de ST é a aplicação do escore TIMI risk . Este considera sete fatores de risco independentes e atribui 1 ponto à presença de cada um deles Fatores de risco Idade 65 anos Presença de pelo menos três fatores de risco para coronariopatia Estenose coronária 50% previamente documentada Infradesnível de ST 0,5 mm no eletrocardiograma admissional Pelo menos dois episódios anginosos nas últimas 24 h Uso de AAS nos últimos 7 dias Elevação dos marcadores de necrose miocárdica. Baixo risco 0-2 Médio risco 3-4 Alto risco 5-7

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Nosso paciente apresenta três fatores de risco do Timi risk , sendo definido como de médio risco. Deve, portanto, permanecer internado e ser submetido à estratégia invasiva de estratificação. A alternativa B é a única que contempla esta opção.

83824.

Comentário: De acordo com as recomendações da maior diretriz acerca do tema (ACC AHA 2002 Guideline Update for Exercise Testing), são contraindicações absolutas ao teste ergométrico, principalmente embolia pulmonar aguda, angina instável sem estabilização com medicação, dissecção aórtica, estenose aórtica severa e arritmias cardíacas com sintomas ou alterações hemodinâmicas. As mesmas contraindicações são corroboradas pelas III Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia Sobre Teste Ergométrico. Ou seja, é bem provável que o autor da questão tenha se esquecido de colocar a palavra exceto e, por isso mesmo, a questão acabou sendo anulada.

89997.

Comentário: A angina pectoris ou angina de peito é a mais típica manifestação da isquemia miocárdica. Embora normalmente se manifeste como dor ou desconforto retroesternal, pode apresentar-se com localização atípica, desde a região mentoniana até a região epigástrica, com diferentes padrões de irradiação (ex. membro superior esquerdo, mandíbula etc). Em cerca de 50% dos pacientes, o ECG é normal e, exatamente por isso, é considerado quase uma extensão do exame físico, sendo o primeiro exame verdadeiramente complementar ao teste ergométrico. Este, dependendo da população estudada (quanto maior a incidência de doença coronariana na população, melhor é o teste), chega a apresentar sensibilidade de 65% e especificidade de 90%. Com isso, todas as alternativas estão corretas, EXCETO a opção C. Vamos recordar que equivalentes anginosos, ou seja, sintomas não habituais secundários à isquemia coronariana, são comuns em mulheres, idosos e diabéticos. Hipertensos não tendem a apresentá-los em maior número.

84686.

Comentário: Vamos lembrar as principais localizações do IAM ao ECG - IAM de parede anterior ou

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

anterosseptal (DA) V1 e V2 (septo), V3 e V4 (parede anterior livre). - IAM de parede lateral (Cx) DI e aVL (lateral alta), V5 e V6 (lateral baixa, apical). - IAM de parede inferior (CD, raramente Cx) DII, DIII e aVF. - IAM dorsal (inferodorsal ou laterodorsal) (CD ou Cx) imagem em espelho em V1 até V4 (ver texto). - Infarto de VD (CD) V1, V3R e V4R (acompanha o IAM inferior I 10%). Resposta, portanto, opção B.

78102.

Comentário: Analisando cada assertiva sobre o tratamento do infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST Assertiva A- INCORRETA A dose de AAS é de 162 a 325 mg no episódio agudo, lembrando que o paciente deve mastigar e engolir para facilitar a absorção. No Brasil, geralmente utilizamos 200 mg. Após essa dose de ataque, o paciente deve ser mantido com AAS 75-162 mg dia (geralmente utilizamos 100 mg dia, no almoço). Assertiva B- INCORRETA Quanto mais precoce for a recanalização, melhor será o prognóstico do paciente e menor será a mortalidade e a morbidade do IAM. Lembre-se da frase Tempo é miocárdio Assertiva C- INCORRETA O trombolítico é benéfico até o delta t de 12 horas, porém sabemos que, quanto mais precoce sua infusão, maior o benefício em relação à preservação da função ventricular e redução da mortalidade. Mais uma vez Tempo é miocárdio . Assertiva D, CORRETA e AUTOEXPLICATIVA. Sempre que houver disponibilidade, a angioplastia primária é preferível em relação ao trombolítico no tratamento do IAM com supra. O tempo porta-agulha ideal para angioplasia primária é de 90 minutos, ou seja, o procedimento deve ser realizado em no máximo 90 minutos após a chegada do paciente.

85411.

Comentário: A dor esofágica costuma ser indistinguível da dor coronariana... Desconforto precordial em aperto, angustiante, que pode ter forte intensidade e ser desencadeado por estresse, esforço físico ou mesmo lautas refeições... Um dado que ajuda bastante na diferenciação clínica é o relato do paciente de ter também DISFAGIA durante a dor, algo não esperado na dor coronariana (D errada)... O prolapso de valva mitral é uma alteração geralmente assintomática, raramente causando dor torácica atípica e sem relação com esforço físico (C errada)... A principal

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

manifestação clínica do TEP é a dispneia, tipicamente SÚBITA e importante, que pode se associar a um quadro de dor torácica de início igualmente súbito (B errada)... Enfim, a dor da pericardite aguda classicamente piora com o decúbito dorsal e melhor com a posição de prece maometana (genupeitoral). Essa dor também tem caráter pleurítico, isto é, piora quando o paciente inspira fundo. No contexto apropriado, o encontro de atrito pericárdico é suficiente para selar o diagnóstico de pericardite aguda... Resposta certa A.

63218.

Comentário: Qual dentre as alternativas seria uma contraindicação à anticoagulação plena Sabemos que não se deve instituir anticoagulação plena com heparina DURANTE a infusão de um trombolítico não fibrino-específico (como a estreptoquinase). A anticoagulação pode ser iniciada posteriormente à infusão do trombolítico, a fim de não aumentar a taxa de sangramento. Resposta certa C.

62694.

Comentário: Este paciente, de alto risco cardiovascular (idoso, hipertenso, diabético e dislipidêmico, vitimado por AVC recentemente e com história familiar positiva para DAC), apresenta um quadro de uma síndrome coronariana aguda confirmado pelo ECG de admissão, que revelou tratar-se de SCA com supra de ST . Em que parede miocárdica observam-se duas ou mais derivações consecutivas com supradesnivelamento do segmento ST É na parede inferior (D2, D3 e aVF), um segmento irrigado pela coronária direita. O que significa, em termos bem simples, um supra de ST num contexto da síndrome coronariana aguda Significa, para todos os fins práticos, que aquela coronária está completamente fechada , e necessita ser aberta (revascularizada) o quanto antes. Ora, existem três estratégias principais capazes de revascularizar uma coronária (1) trombolítico, (2) angioplastia, (3) cirurgia. Qual é considerada a primeira escolha , se prontamente disponível, num serviço de emergência Para a maioria dos casos é a ANGIOPLASTIA (neste caso, chamada de primária , isto é, aquela realizada na chegada do paciente à emergência), que se mostrou superior aos trombolíticos tanto em termos da obtenção de uma patência vascular mais adequada, quanto em termos de uma maior diminuição da morbimortalidade. Pacientes que serão submetidos

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

à angioplastia primária (assim como todas as formas de SCA de alto risco) idealmente devem receber, no mínimo, dupla antiagregação plaquetária (AAS Clopidogrel), pois tal conduta melhora os resultados. Resposta certa C.

47300.

Comentário: Questão clássica que volta e meia cai em alguma prova. A nifedipina é um antagonista do cálcio da classe dos diidropiridínicos. Por ser extremamente potente como vasodilatador periférico e possuir início de ação rápido e meia-vida muito curta, tem como principal efeito colateral a ocorrência de TAQUICARDIA REFLEXA Ora, no paciente coronariopata, tudo o que não queremos é que ele faça taquicardia, pelo contrário. O súbito aumento da frequência cardíaca nestes indivíduos pode desencadear isquemia, o que justifica o aumento da mortalidade em pacientes com SCA que se utilizam da nifedipina de liberação rápida. Resposta certa C.

51006.

Comentário: O comportamento eletrocardiográfico consegue mostrar muitas vezes a parede miocárdica em sofrimento isquêmico. Lembre-se de que DII, DIII e aVF são derivações capazes de explorar bem a parede inferior do coração. Mas qual seria a razão para essa bradicardia É interessante notar que a bradicardia sinusal é a principal arritmia associada ao infarto inferior, estando presente em até 40% dos casos nas primeiras 2 horas do evento isquêmico. Existem 2 mecanismos possíveis para justificar esse comportamento bradiarrítmico (1) maior atividade parassimpática (o chamado Reflexo de Bezold-Jarisch) (2) Isquemia do nodo sinusal. Resposta certa letra B.

48219.

Comentário: A clássica síndrome de Dressler atualmente é descrita dentro do conceito de síndrome pós-injúria cardíaca . A síndrome pós-injúria cardíaca é uma forma de reação autoimune tardia , desencadeada por lesões agudas ao tecido miopericárdico. Na verdade, diversas condições além do infarto agudo do miocárdio são capazes de desencadeá-la (ex. trauma cardíaco). Acredita-se que a síndrome pós-injúria cardíaca seja iniciada por uma combinação de dano ao mesotélio e presença de sangue no espaço pericárdico. Isso promoveria a exposição de antígenos locais que

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

passariam a ser reconhecidos pelo sistema imune, o qual, por sua vez, se encarregaria de montar uma resposta autoinflamatória contra tais antígenos. O quadro clínico é marcado fundamentalmente por pleuropericardite aguda, mas também é possível o surgimento de dano agudo ao parênquima pulmonar (pneumonite infiltrados pulmonares). A síndrome de Dressler, como dissemos, nada mais é que a forma clássica de síndrome pós-injúria cardíaca que acontece no contexto específico do IAM, surgindo, em média, cerca de 4 semanas após o evento. A pericardite epistenocárdica não é tardia, e representa a inflamação pericárdica por contiguidade que pode acompanhar a fase aguda dos infartos transmurais. Resposta certa A.

48245.

Comentário: Em um paciente com angina estável, 2 exames são fundamentais teste ergométrico para avaliação de critérios de isquemia e ecocardiograma para avaliação da função de VE. Como a questão pedia um exame diagnóstico de doença coronariana, as opções de resposta seriam letra A, letra C e letra E. Dentre todos, o teste provocativo de isquemia de escolha é o teste ergométrico que só não será feito se o ECG basal impedir a interpretação (como no BRE, HVE, Wolff-Parkinson-White) ou se o paciente tiver limitações ao exame (doença arterial periférica, problemas ortopédicos etc.). Resposta certa letra A.

47702.

Comentário: O paciente em tela apresenta IAMST da parede inferior (DII, DIII e aVF). Sabemos que todo IAMST de parede inferior deve ter o ECG de 12 derivações complementado com precordiais direitas (V3R, V4R) O motivo é que o IAM de parede inferior comumente se associa ao IAM de ventrículo direito, pois ambas as estruturas cardíacas são irrigadas pela mesma artéria coronária (a CD coronária direita) Além da possibilidade de IAM de VD, devemos estar atentos - diante de um paciente com IAM inferior - com a possibilidade de bradicardia sinusal instabilidade hemodinâmica reversível, secundária ao chamado reflexo de Bezold-Jarisch (hiperativação vagal reflexa, nas primeiras 6h do início do IAMST inferior). Outra preocupação que não deve ser olvidada é a possibilidade de que a oclusão de CD (com seu consequente IAMST de parede inferior VD) esteja sendo causada por uma dissecção da coronária direita decorrente de dissecção aórtica retrógrada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Neste caso, é importante avaliar a simetria dos pulsos periféricos do paciente, que quando assimétricos sugerem este diagnóstico, no contexto clínico apropriado... Assim, resposta certa aqui B. Não entendemos muito bem o motivo, mas a banca ANULOU essa questão.

48504.

Comentário: A parede inferior é explorada pelas derivações DII, DIII e AVF, enquanto a parede apical é melhor visualizada por V5 e V6. Resposta certa letra C

48160.

Comentário: Questão fácil e direta. Portadores de doença coronariana estabelecida, bem como pacientes considerados de alto ou altíssimo risco cardiovascular, devem ter o LDL-colesterol idealmente na faixa abaixo de 70 mg dl. Diversas evidências recentes comprovam que valores bem mais baixos do que se pensava antigamente são ainda mais benéficos nesse contexto. Resposta certa E.

35616.

Comentário: Paciente com importantes fatores de risco para doença coronariana se apresenta com quadro agudo sugestivo de SCA. Dentre as condutas terapêuticas iniciais a serem adotadas na abordagem da síndrome coronariana aguda, podemos citar a administração de oxigênio, nitrato, betabloqueadores e drogas antiplaquetárias, independente do tipo de SCA (IAMST IAMSST AI) Em pacientes sem dor no momento, e sem hipertensão, não há necessidade de nitrato também não há necessidade de morfina, pois não há dor refratária ao nitrato betabloqueadores devem ser evitados em pacientes com DPOC (grande tabagista, tosse crônica, descompensações recentes) Assim, a opção mais razoável aqui seria a letra E. No entanto, discordamos dela pelo seguinte motivo atualmente se recomenda ministrar dupla antiagregação plaquetária nas SCA, com AAS clopidogrel, ou seja, ficou faltando o clopidogrel Questão passível de recurso, que teve como gabarito oficial a letra E

35628.

Comentário: As derivações DII, DIII e aVF estão olhando para a parede inferior do coração, logo, um supradesnível de ST 1 mm em todas essas derivações confirma a existência de IAMST inferior

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Chegamos então à pegadinha da questão. A classificação hemodinâmica de Forrester necessita da avaliação de uma série de parâmetros através de medidas feitas com um cateter de artéria pulmonar (Swan-Ganz). Simplesmente não temos essas informações no caso. Porém, perceba que o paciente está estável, sem evidências de descompensação hemodinâmica (estado geral OK, PA e FC normais, ausência de alterações respiratórias). Logo, se tivéssemos os dados hemodinâmicos requisitados pela classificação de Forrester (VER IMAGEM), provavelmente constataríamos que se trata de paciente F-1 (grupo I). Resposta certa A.

35630.

Comentário: Após 5 dias do uso de estreptoquinase, grande parte dos pacientes desenvolve anticorpos antiestreptoquinase, os quais podem persistir no soro por até 10 anos, aumentando o risco de reação anafilática numa segunda exposição ao fármaco durante este período. Ora, mas isso não quer dizer que exista contraindicação ABSOLUTA para a readministração de SK no paciente quando de um novo infarto Na verdade, considera-se que isso seja uma contraindicação relativa, mais bem entendida como uma precaução . De qualquer forma, é prudente não administrar SK novamente, dando-se preferência aos outros trombolíticos não indutores da formação de anticorpos (ex. rtPA, TNK). Resposta certa C. Algumas pessoas podem ter ficado em dúvida com as opções A e B. O IAM de parede inferior pode se associar ao IAM de VD, situação em que os nitratos e a morfina devem ser evitados. Todavia, não há indícios de IAM de VD no caso em questão (as derivações precordiais direitas V3R e V4R devem ter sido obtidas nesse doente). Assim, a letra C permanece como melhor resposta.

35626.

Comentário: Em resumo, temos um IAM que evoluiu com BAVT (Bloqueio Atrioventricular de 3º grau). O BAVT ocorre em 5-15% dos IAM, geralmente no contexto de um IAM inferior (DII, DIII e AVF parede irrigada pela coronária direita, a mesma que irriga a porção alta do nódulo AV). Na maioria das vezes o BAVT é transitório no IAM relacionado à coronária direita, durando entre 5-7 dias, e cursando com QRS estreito (lesão supra-hissiana), FC 40 bpm e ritmo de escape juncional. Como o paciente está hemodinamicamente instável (hipotenso e com sintomas de má perfusão

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

cerebral), é preciso agir com rapidez, sendo a maneira mais célere de aumentar a FC, nesta situação, a instalação de um marca-passo transcutâneo . Obviamente, será preciso passar um marca-passo transvenoso, pois devido à impedância progressiva da pele do tórax (além, é claro, do desconforto imposto pelo aparelho, que fica dando choques no peito do paciente) não se consegue manter o transcutâneo por muito tempo. De toda forma, resposta certa B.

35804.

Comentário: Lembre-se trombolíticos são contraindicados nas SCA sem supra de ST, como o IAMSST. Logo, não poderíamos marcar as opções A, C e E, pois o tipo de infarto não foi especificado pelo enunciado... Mas, por que marcar a letra B (gabarito oficial da banca) e não a letra D Excelente pergunta Nós também não sabemos... Não adianta dizer que é porque alguns pacientes apresentam contraindicação ao uso precoce de betabloqueadores (maior risco de choque cardiogênico nas primeiras 24h) este argumento simplesmente não vai colar existem pacientes que têm contraindicação à morfina (ex IAM de VD) e inclusive ao AAS (ex alergia) Além do mais, cadê o clopidogrel, atualmente considerado tão importante quanto o AAS na abordagem antitrombótica inicial do IAM A nosso ver, questão sem resposta...

35810.

Comentário: Num paciente com fatores de risco para coronariopatia (sexo masculino 45 anos, tabagismo e obesidade), a dor torácica aguda acompanhada de irradiação para o membro superior esquerdo (braquialgia) e diaforese (sudorese mal-estar), principalmente após estresse (ex. esforço físico, emoções), deve nos fazer pensar em síndrome coronariana aguda como principal hipótese diagnóstica (pois se trata de dor anginosa típica) Assim, é mandatório avaliar esta possibilidade sem demora e, uma vez confirmada, dar pronto início ao seu tratamento. Resposta certa C.

26941.

Comentário: Paciente masculino, com mais de 45 anos de idade, tabagista e sedentário, veio ao hospital com quadro de IAM e supra de ST em parede inferior, apresentando também os sinais e sintomas do reflexo de Bezold-Jarisch (hiperativação vagal levando à bradicardia sinusal e alterações na condução AV nas primeiras 6h do IAM). Entretanto, após 45 minutos desde sua

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

chegada, evoluiu subitamente com hipotensão arterial, turgência jugular e abafamento de bulhas (tríade de Beck), além do clássico achado de QRS com baixa amplitude no eletro... Ora, o paciente desenvolveu uma síndrome de tamponamento cardíaco agudo No contexto de um IAM com supra de ST (infarto transmural), a súbita instalação de um quadro de tamponamento cardíaco aponta para o diagnóstico de ruptura de parede livre ventricular, gerando hemopericárdio agudo (neste caso, como se trata de IAM inferior relacionado à obstrução da coronária direita, temos uma ruptura da parede livre do VD). Um raio x de tórax sem aumento da área cardíaca não descarta esta possibilidade, uma vez que para causar tamponamento o derrame pericárdio AGUDO não precisa ser de grande monta Resposta certa letra E.

27197.

Comentário: Questão da prova de vestibular... Precordialgia intensa, sinais de hiperativação adrenérgica (palidez cutânea vasoconstrição periférica sudorese fria aumento do tônus sudomotor vasoconstrição periférica), náuseas e elevação de marcadores de necrose miocárdica representam alterações que, em conjunto, preenchem critérios para o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Resposta certa letra D.

23009.

Comentário: O enxerto de veia safena magna ainda é o mais utilizado em cirurgias de revascularização do miocárdio opção (A) errada... E embora o número de procedimentos empregando a artéria radial esteja progressivamente aumentando, a artéria torácica interna (mamária interna) ainda é o enxerto arterial mais utilizado opção (B) errada... A banca deu como resposta a letra C... Mas o Sabiston , principal referência em cirurgia (esta questão era da parte cirúrgica da prova), afirma que a patência do enxerto de safena após o 1º ano da cirurgia gira em torno de 81%, ou seja, somente cerca de 19% dos enxertos estarão ocluídos ao final deste período, e não 30%, como diz a letra C... E para complicar ainda mais a situação, a letra D, na verdade, está correta pacientes diabéticos possuem risco aumentado de complicações não-fatais da cirurgia de revascularização miocárdica, particularmente infecção e deiscência da esternotomia quando uma artéria mamária é dissecada. Quando as duas mamárias são empregadas, o risco aumenta

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

exageradamente (cerca de 14 vezes o normal), o que faz muitos autores contra-indicarem a mobilização de ambas as mamárias em pacientes diabéticos... Fizemos recurso contra essa questão, pedindo a troca do gabarito para a letra D (poderia ter sido um erro de digitação do gabarito), mas a banca manteve a letra C como resposta...

22977.

Comentário: Vamos de baixo pra cima... O clopidogrel reduz a reestenose dos stents , sejam eles farmacológicos ou não, mas o fato é que esta droga não é capaz de PREVENIR a lesão (nenhuma droga consegue impedir completamente a reestenose)... Lesões de tronco de coronária esquerda indicam a necessidade de revascularização CIRÚRGICA do miocárdio, e contraindicam a angioplastia com stent ... Não há necessidade de anticoagular ad eternum os pacientes que implantaram um stent coronariano tal medida simplesmente não é eficaz, haja vista que as tromboses do stent são causadas por trombos brancos , ricos em plaquetas (e não em rede de fibrina). Há indicação somente de uso de antiplaquetários indefinidamente... A reestenose dos stents , de fato, tem seu pico de maior incidência nos primeiros 6 meses após a implantação Resposta certa letra A.

27026.

Comentário: A interpretação dos testes provocativos de isquemia miocárdica deve sempre levar em conta a probabilidade pré-teste de doença coronariana, que nada mais é que a prevalência da doença numa população de indivíduos com as mesmas características do paciente estudado... Num homem com menos de 45 anos de idade, assintomático, a probabilidade de doença coronariana é extremamente baixa Assim, diante de alterações sugestivas de isquemia esforço-induzida, podemos dizer que provavelmente se trata de um resultado falso-positivo (baixo valor preditivo positivo) Por outro lado, se estivéssemos falando de um paciente idoso, hipertenso, diabético, sedentário e tabagista, um resultado positivo muito provavelmente representaria um verdadeiro positivo, e se este último paciente possuísse sintomas de isquemia miocárdica (ex angina pectoris), a chance de um resultado negativo representar um falso-negativo também seria muito elevada... Apesar da baixa probabilidade de DAC, o paciente em questão tem indicação de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ser avaliado quanto para esta doença, uma vez que exerce profissão onde a existência de coronariopatia coloca em risco a vida de muitas pessoas (piloto de aviação). Resposta certa letra A.

11100.

Comentário: Vamos de baixo pra cima Letra D errada as derivações D2, D3 e aVF detectam os eventos na parede INFERIOR. A parede anterior é vista nas precordiais (principalmente V1-4) e a parede lateral é vista em D1 e aVL (por vezes também em V5 e V6) Letra C errada os betabloqueadores podem causar broncoespasmo em pacientes suscetíveis (ex asmáticos). Esta é a toxicidade pulmonar dos beta, e não o fenômeno de depressão respiratória Letra B errada não há contra-indicação ao uso de fibrinolíticos no paciente que recebeu AAS heparina O que precisamos saber é o seguinte se o trombolítico empregado for a ESTREPTOQUINASE, não será necessário utilizar heparina pelas próximas 48h (a contar a partir do início da infusão de trombolítico). Por outro lado, se lançarmos mão dos ativadores recombinantes do plasminogênio, só não vamos infundir heparina durante a infusão do trombolítico, estando seu uso recomendado logo após o término desta última infusão Por fim, letra A ERRADA a dor é um grande fator estimulante da atividade adrenérgica (aumenta FC e PA), intensificando a demanda miocárdica de oxigênio Geralmente é uma dor MUITO intensa Assim, é mandatório utilizar desde o início um analgésico narcótico, de preferência os opióides (como a morfina). Além de analgesia ainda existe o benefício da diminuição do retorno venoso, reduzindo a sobrecarga de volume cardíaco nos pacientes com IVE Resposta certa letra A

16059.

Comentário: Questão clássica Doenças gastrointestinais, principalmente aquelas que acometem o esôfago como o refluxo gastroesofágico e o espasmo esofágico, podem simular clinicamente a dor cardíaca de origem isquêmica... Ambas as condições podem apresentar semelhanças clínicas como (1) constrição ou opressão retroesternal, (2) irradiação para região cervical ou mandíbula, (3) ocorrência pós-prandial, (4) desencadeamento com esforço físico, (5) sudorese e (6) melhora com nitratos ou bloqueadores de canais de cálcio A inervação autonômica do esôfago e do coração tem a mesma origem (nervo e vago e seis nervos torácicos superiores), o que poderia justificar tais

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

semelhanças... A dor da dismotilidade esofagiana é talvez a que apresente maior dificuldade diagnóstica com a de origem anginosa, pois caracteristicamente é retroesternal, dura segundos ou horas, é moderada ou muito forte, pode ser desencadeada por esforço físico e muito importante geralmente melhora com nitratos e bloqueadores de canais de cálcio A dor da hipertensão arterial pulmonar aguda (TEP) também pode ser retroesternal e desencadeada por esforço físico, mas não costuma irradiar para o dorso ou ser aliviada por nitratos, apesar de outras medicações que também elevam os níveis de óxido nítrico como o sildenafil (Viagra) terem mostrado benefício no manejo dessa condição (por diminuírem a resistência vascular pulmonar)... Além disso, a dor descrita na questão poderia ser exatamente a de uma dissecção aórtica aguda (retroesternal com irradiação para o dorso), não fosse sua curta duração e pronta melhora com nitratos... A dor da pericardite tende a ser retroesternal, pleurítica (isto é, piora com a inspiração profunda) e melhora com a inclinação anterior do tronco, bem como piora com o decúbito dorsal (sinal da prece maometana), além de não responder aos nitratos...

216365.

Comentário: Ótima questão sobre escores na cardiologia, especificamente, na síndrome coronariana aguda. Os dois escores de estratificação mais usados são o escore GRACE e Timi Risk. Qual objetivo de avaliar isso no paciente Avaliar se o paciente deve ser estratificado de forma INVASIVA ou NÃO-INVASIVA. Em quais pacientes isso tem maior valor Nos pacientes que existe a possibilidade de abordagem NÃO-INVASIVA, os pacientes com SÍNDROME CORONARIANA SEM SUPRA DE ST. Por isso a resposta certa é a LETRA B.

105710.

Comentário: Os dados fornecidos apontam para o diagnóstico de estenose aórtica . Que outra valvopatia compromete primariamente as paredes do ventrículo esquerdo tornando-as hipertrofiadas Sabemos que, em idosos, a principal etiologia de estenose aórtica é a degeneração fibrocalcificante, um fenômeno relacionado à disfunção endotelial (A correta). Estatisticamente, é muito comum que esses indivíduos apresentem também doença coronariana Afinal de contas, tratam-se de pacientes idosos que muitas vezes são portadores de fatores de risco compartilhados

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

(como diabetes e dislipidemia, tal qual este paciente). Inclusive, é praxe indicar uma cineangiocoronariografia no pré-operatório da cirurgia de troca valvar. Caso exista obstrução coronariana, a mesma pode ser corrigida no mesmo procedimento (B correta). A síncope é explicada na estenose aórtica pelo fato desses pacientes possuírem o que se chama de débito cardíaco fixo . Devido à grave limitação do orifício aórtico em portadores de estenose grave (que é quando costumam surgir os sintomas), por mais que a demanda metabólica dos tecidos periféricos aumente, o volume de sangue que consegue ser ejetado do VE acaba se mantendo o mesmo. O problema é que, numa situação de aumento da demanda, os leitos vasculares periféricos se dilatam, o que gera um estado de hipovolemia relativa (há pouco conteúdo arterial para muito continente). O resultado é uma súbita diminuição da perfusão cerebral, o que se manifesta clinicamente como síncope (D correta). O mesmo tipo de problema que acabamos de descrever pode ocorrer quando esses pacientes fazem uso de medicamentos que modificam a pré ou a pós-carga, ou mesmo o inotropismo cardíaco. Por este motivo, a estenose aórtica em fase sintomática deve sempre ser tratada pela via cirúrgica, aliviando a obstrução mecânica ao trato de saída do VE (E correta). Enfim, sabemos que, felizmente, a sintomatologia associada à estenose aórtica tende a surgir numa fase TARDIA de sua história natural. Contudo, após o surgimento de sintomas (angina, síncope e dispneia), o tempo de sobrevida é previsivelmente curto, na ausência de intervenção cirúrgica. Resposta certa C.

105682.

Comentário: Entre as complicações da angioplastia coronariana figura, de modo importante a estenose do stent que pode se dar de forma aguda ou progressiva. Os stents farmacológicos liberam substâncias que reduzem a frequência de ambas as formas de reestenose, sendo mais indicados nos pacientes diabéticos e multivasculares. Os pacientes submetidos à revascularização percutânea com stents convencionais devem receber dupla antiagregação plaquetária pelo período mínimo de um mês. Aqueles submetidos à revascularização percutânea com stent farmacológico devem ser duplamente antiagregados por, pelo menos, um ano. Nos dois casos, passado o período mais crítico para reestenose, está indicada a manutenção ad aeternum do AAS, droga que, em

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

longo prazo, acarreta importantes benefícios sobre a morbimortalidade cardiovascular. Resposta certa E.

62659.

Comentário: Dor torácica típica , aguda e persistente, isto é, um quadro compatível com SCA, em um paciente com múltiplos fatores de risco cardiovascular, porém sem alteração eletrocardiográfica e sem aumento nos marcadores de necrose miocárdica coletados de forma seriada (ausência de IAM), permite o diagnóstico de ANGINA INSTÁVEL. A abordagem terapêutica da angina instável depende de sua estratificação de risco (risco de morte, angina recorrente, IAM ou necessidade de intervenção cirúrgica de emergência, que pode ser BAIXO, MÉDIO ou ALTO). Como estratificar o risco do paciente durante o atendimento primário Hoje em dia, está claro que uma estratégia multimodal para estratificação de risco na AI é provavelmente superior ao emprego de qualquer escore de risco de forma isolada. O TIMI risk , por exemplo, nos daria a falsa impressão de que este paciente é de baixo risco (apenas 1 ponto, isto é, presença de 3 fatores de risco para DAC). O que define que este paciente na realidade deve ser considerado como de ALTO RISCO é o relato de angina recorrente em repouso na última semana, um fator que - por si só - é suficiente para indicar alto risco. E qual é a conduta preconizada para toda AI de médio ou alto risco É a chamada estratégia invasiva precoce realização de cineangiocoronariografia nas primeiras 48h da internação O paciente também deve ser medicado com o pacote completo destinado a manter a patência da coronária (AAS, clopidogrel e heparina, que pode ser de baixo peso ou não fracionada), além de inibidor de GP IIb IIIa durante a angioplastia (se for implantado um stent). Drogas para reduzir o consumo miocárdico de O2 também estão indicadas, como betabloqueadores, nitratos e quiçá analgésicos como os opioides (se a dor for persistente). Dor recorrente a despeito de terapia antianginosa otimizada e ou hipotensão arterial (sinal de isquemia extensa levando à falência do VE) sem dúvida nenhuma também representam fatores de alto risco no contexto da angina instável, indicando - de forma independente - a realização da estratégia invasiva precoce. Resposta certa Letra D.

47478.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: A mioglobina é o marcador de necrose miocárdica que apresenta a cinética mais rápida. O início de sua elevação se dá por volta de 1-2h após início do infarto, atingindo um pico entre 6-9h e normalização em 12-24h. Resposta certa D.

35750.

Comentário: Pacientes coronariopatas (como o da questão, que apresenta quadro clássico de angina estável) devem ser continuamente betabloqueados (FC de repouso entre 50-60 bpm). O uso de betabloqueadores diminui tanto a morbidade (sintomatologia) quanto a mortalidade (risco de IAM, arritmias e óbito) em portadores de doença coronariana. É fácil perceber o benefício dessa conduta através do exemplo fornecido no caso na vida cotidiana, todos nós passamos por situações que induzem taquicardia. Usuários de nitrato, por exemplo, possuem risco aumentado de taquicardia reflexa , em resposta à vasodilatação sistêmica estimulada pelo nitrato (que reduz a pré e a pós-carga) Se o paciente estiver adequadamente betabloqueado, essa resposta taquicárdica simplesmente não acontece. Logo, o acréscimo de betabloqueador protegerá o paciente em questão dos surtos de taquicardia do dia a dia (na verdade, ele já deveria estar betabloqueado por ser portador de angina estável), inclusive durante o uso de nitrato, que é uma medicação imprescindível no seu caso, haja vista ser capaz de aliviar os sintomas isquêmicos (os quais também podem diminuir com o acréscimo do betabloqueador). Resposta certa E.

35706.

Comentário: As estatinas geralmente são drogas seguras, sendo os dois principais efeitos adversos a miotoxicidade e a hepatotoxicidade. Embora não seja um consenso, uma abordagem aceita é suspender a droga apenas em pacientes com aumento de CK maior que 10 vezes o limite superior da normalidade (LSN). Segundo o guideline nacional de dislipidemia, as estatinas devem ser suspensas em caso de mialgia, aumento crescente da CK ou aumento da CK 10 vezes o LSN. O aumento da TGP 3x acima do LSN também demanda interrupção da droga. Como você pode ver, C e D estão corretas. Resposta letra E.

11471.

Comentário: Questão densa. Vamos de cima pra baixo. (A) O processo patológico da aterosclerose

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

se desenvolve na camada ÍNTIMA, e não na média... (B) Tanto a obesidade central quanto a hipertensão arterial fazem parte dos critérios diagnósticos da Síndrome Metabólica, mas a obesidade não é obrigatória segundo as definições do NCEP-ATP III... (C) Os fitoesteróis, como o estanol, alteram sim a absorção intestinal de colesterol, porém seu principal efeito é a redução do LDL (e não dos triglicerídeos, os quais estão relacionados à ingestão total de carboidratos). Tal redução atinge até 10% quando os fitoesteroides são ingeridos três vezes ao dia... (D) Diversos estudos comprovaram a redução de mortalidade com o uso de estatinas. Tal benefício consiste não apenas em redução de eventos coronarianos, mas também numa queda do número de eventos cerebrovasculares A diminuição do risco relativo de AVC com as estatinas pode chegar até 30%... (E) O ácido nicotínico, ou niacina, é um componente do complexo das vitaminas B (trata-se da vitamina B3) que já era utilizado no tratamento da dislipidemia desde o início do século passado. Inicialmente se demonstrou que a niacina reduzia o fluxo de ácidos graxos não esterificados (livres) para o fígado, o que explicaria a redução na síntese de triglicerídeos. Entretanto, mais recentemente se descobriu que a niacina possui um receptor específico dentro dos adipócitos, o qual inibe a lipase citoplasmática dessas células. Isso corrobora o mecanismo elucidado há muitas décadas Seu efeito, portanto, é reduzir a secreção hepática de triglicerídeos e LDL, além de promover aumento dos níveis de HDL Lembre-se que o ácido nicotínico é a única medicação hipolipemiante disponível até o momento capaz de reduzir os níveis de lipoproteína A... ALTERNATIVA CORRETA.

311491.

Comentário: Supradesnivelamento de ST em paciente com dor torácica típica e fatores de risco para doença coronariana deve ser encarado como infarto agudo do miocárdio. Qual é a parede acometida Vamos relembrar (1) IAM de parede anterior (artéria desendente anterior ou DA) V1 a V4 (parede anterosseptal e anterolateral) (2) IAM de parede lateral (artéria circunflexa ou CX) DI e aVL (lateral alta), V5 e V6 (lateral baixa, apical) (3) IAM de parede inferior (artéria coronária direita ou CD, raramente Cx) DII, DIII e aVF (4) Infarto de VD (CD) V1, V3R e V4R (acompanha o IAM inferior I 10%). Dizemos que há infarto anterior extenso quando há acometimento de V1 a V6, bem como

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

de D1 e aVL, exatamente como apresentado no enunciado. Resposta letra C.

302039.

Comentário: Questão clássica sobre os estágios de Prochaska, DiClemente e Norcross. Vamos revisar cada estágio 1. Pré-contemplação A pessoa ainda não vê necessidade de mudar seu comportamento. Há muita resistência, pois ela acredita que não existe uma motivação real para a mudança. 2. Contemplação O indivíduo começa a perceber seu problema, mas ainda não se mobiliza para tomar uma atitude de mudança. 3. Planejamento ou preparação O indivíduo já tem uma visão mais clara e precisa sobre seu problema e começa a pensar em possíveis ações que podem ajudá-lo a se recuperar e superar suas limitações. 4. Ação A pessoa começa a colocar em prática seus esforços de mudança. 5. Manutenção Esse estágio permite verificar se as atitudes tomadas no estágio anterior realmente levaram à mudança. Exige o máximo esforço do indivíduo para que não ocorra nenhum tipo de recaída. 6. Recaída ou conclusão Após o estágio da manutenção, a pessoa pode cometer um deslize ou retornar ao comportamento considerado inadequado ou prejudicial. Caso a recaída não aconteça, o indivíduo entra no estágio da conclusão, que é o objetivo do processo de mudança. Podemos ver que a opção que melhor se aproxima da lista é a letra A, em que o processo de mudança já começou. A letra E contém uma frase mais típica de quem está tentando parar (fase de ação), e não de quem parou e acabou recidivando. Resposta letra A

250391.

Comentário: Pessoal, questão que pode ser respondida usando o bom senso. A angina que representa maior risco é aquela mais prolongada ou de maior intensidade (letra B CORRETA), relacionada a indicadores eletrocardiográficos de corrente de lesão isquêmica (letra E CORRETA), ou que vem acompanhada de sinais e sintomas de possíveis complicações do infarto, como ruptura de músculo papilar ou da parede ventricular, insuficiência cardíaca aguda ou choque cardiogênico e insuficiência mitral aguda (letras C e D CORRETAS). O horário de acometimento da angina não está relacionado diretamente com o risco do sintoma em si, embora em muitos locais esteja relacionado à maior dificuldade de acesso ao sistema de atendimento de emergência. A única

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

resposta incorreta e gabarito da questão é a letra A.

218043.

Comentário: No traçado, a frequência cardíaca está próxima de 100 bpm, mas chega a passar desse valor, de modo que não há conceitualmente uma taquicardia. O ritmo não é sinusal (não há onda P visível), embora seja regular, o eixo encontra-se desviado para a esquerda e o complexo QRS está alargado (nas derivações precordiais fica mais fácil visualizar esta alteração). O fato de os intervalos R-R serem regulares exclui a hipótese de fibrilação atrial ou ventricular. Ao aplicarmos os critérios de Brugada, não parece que estamos diante de uma taquicardia supraventricular com condução aberrante também. De fato, o ritmo apresentado parece corresponder ao idioventricular acelerado (RIVA) Trata-se de uma arritmia esperada no contexto pós-trombólise, que indica a reperfusão da artéria acometida. A frequência cardíaca costuma variar de 40-100 bpm e ela geralmente é assintomática. Resposta certa LETRA D.

203195.

Comentário: Em relação às complicações associadas à coronariografia, as complicações no sítio de acesso vascular são as mais comuns, podendo incluir sangramento local, hematoma, trombose, embolização distal, dissecção vascular, fístulas arteriovenosas e pseudoaneurisma. As outras complicações citadas na questão podem ocorrer, porém em um percentual menor de casos. Resposta certa letra E.

154409.

Comentário: Questão bem marcada O achado de dor ventilatório-dependente (ou dor tipo pleurítica) que piora com o decúbito dorsal associada à supradesnivelamento do segmento ST com concavidade para cima DIFUSO no eletrocardiograma , grita uma condição bem alto pra gente PERICARDITE AGUDA Ao ECG também pode haver infradesnivelamento do intervalo PR, que é mais específica de pericardite, porém menos encontrada. As alterações no ECG se devem a extensão da inflamação para o epicárdio, uma vez que o pericárdio parietal não possui atividade elétrica (na pericardite urêmica, por exemplo, teremos um ECG normal, pois há importante processo fibrótico mas pouca inflamação epicárdica. Vale ressaltar a importância da realização do

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

diagnóstico diferencial com outras condições, porém a questão pede a hipótese diagnóstica mais provável para o caso descrito que, sem dúvida, é PERICARDITE AGUDA Resposta certa E

103951.

Comentário: Já está muito bem definido o benefício de manter o AAS em cirurgias não cardíacas de pacientes coronariopatas, o que evita complicações cardiovasculares, sem aumentar significativamente o sangramento intra operatório. Além do mais, no caso apresentado, temos uma urgência, cujo tratamento cirúrgico precoce é a melhor alternativa. Se a apendicite aguda tem 48hs e ausência de complicações (p.ex. abscesso) optamos pelo tratamento cirúrgico imediato. Pacientes com 48hs de evolução devem, necessariamente, passar por um exame de imagem, se não houverem complicações, trataremos como apendicite simples (cirurgia imediata). Mas se nos depararmos com um abscesso 4-6cm, devemos iniciar ATB (p.ex cefoxitina), realizar a drenagem percutânea do abscesso, indicar à colonoscopia em 2-4 semanas (risco de neoplasia ou colite associadas) e indicar a cirurgia em apenas 6-8semanas. Como o AAS inibe a COX-2 e a síntese de tromboxano, causando disfunção plaquetária, sem dúvidas teremos mais segurança ao transfundir plaquetas, sobretudo por se tratar de um procedimento laparoscópico (Letra A correta). Mas a alternativa A pode deixar subentendido ainda que ter estes hemocomponentes à disposição em sala dará segurança ao procediemento, caso haja necessidade. Letra B nem procedimentos eletivos deverão ser suspensos em coronariopatas usando AAS, muito menos os de urgência. Letra C Como exposto acima, só faríamos isso se fosse complicada ou com 48hs de evolução. Letra D a indicação de CTI até pode ser discutível nesse caso, mas não vamos brigar com a questão. Letra E nunca poderemos realizar bloqueios de neuroeixo com qualquer alteração na coagulação, obviamente pelo risco de hematoma e compressão medular E para terminar, a cirurgia laparoscópica tem ótimos resultados na apendicite aguda Gabarito Letra A

107941.

Comentário: Letra A está perfeita A principal etiologia da SCA é a aterotrombose. Ocorre aterosclerose coronariana, seguida de lesões nas placas de ateroma, com formação de trombos que podem levar a suboclus o ou oclus o do vaso. A partir deste conhecimento instituiu-se alguns

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

dos pilares da terapia da SCA o uso de antigregantes plaquetários e anticoagulantes. Vamos rever as seguintes B - No contexto do IAM associado ao uso de cocaína os betabloqueadores s o contraindicados. Isto porque a cocaína atua por mecanismo adrenérgico, e o betabloqueio pode liberar o alfabloqueio induzido pela cocaína, com grave crise hipertensiva e piora da isquemia miocárdica. C - Os pacientes submetidos á angioplastia com stent farmacológico devem permanecer em uso de dois antiagregantes plaquetários por no mínimo um ano. Aqueles submetidos á angioplastia com stent convencional devem receber dupla antiagregaç o por pelo menos um mês. D - Um clássico Hemorragia ativa ou diáteses hemorrágicas são contraindicações formais ao uso de trombolíticos, no entanto, a menstruação não é considerado um sangramento importante e não contraindica esta terapia. E - Lembrou de alguma coisa lendo esta assertiva Os três são critérios do TIMI Risk para estratificação de risco na síndrome coronariana sem supra de ST.

89551.

Comentário: A presença de quarta bulha, por si só, não indica o uso de nitrato intravenoso a quarta bulha reflete a disfunção diastólica do ventrículo isquêmico, e o nitrato não exerce qualquer efeito benéfico sobre este processo. Por serem drogas vasodilatadoras e, portanto, hipotensoras, os nitratos estão absolutamente CONTRAINDICADOS se o paciente apresentar instabilidade hemodinâmica. Na vigência de choque circulatório, o melhor a fazer é instituir suporte hemodinâmico invasivo, com um balão de contrapulsação aórtica (facilita a ejeção ventricular, diminuindo o consumo de O2, aumenta a pressão de perfusão coronariana, aumentando o aporte de O2). No IAM de parede inferior (D2, D3 e aVF), de um modo geral, os nitratos devem ser evitados, pois nestes pacientes é comum a coexistência de IAM de VD, uma vez que a coronária direita é o vaso envolvido em ambos os tipos de infarto. O grande problema do infarto de VD é que o débito sistólico desta câmara é altamente dependente do retorno venoso pelas veias cavas, e o nitrato dilata a veia cava inferior, reduzindo o retorno venoso. Assim, em portadores de IAM de parede inferior IAM de VD, o uso de nitratos pode desencadear um quadro de choque cardiogênico. As arritmias ventriculares também não indicam, por si mesmas, o uso de nitrato. Não há evidências

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

de que essas drogas, diretamente, suprimam ou evitem eventos elétricos malignos. Enfim, as principais indicações para o emprego de nitrato IV, no contexto da síndrome coronariana aguda, foram citadas na alternativa A, desde que, é claro, não existam francas contraindicações. Resposta certa A.

89268.

Comentário: Todas as assertivas apresentadas são corretas e consensuais sobre o IAM com supra de ST, exceto a letra E diante de um paciente com IAM e supra de ST, a conduta emergencial é a terapia de reperfusão miocárdica através de angioplastia primária ou fibrinólise, sendo a angioplastia o método de escolha, principalmente considerando o tempo de evolução (embora a fibrinólise seja aceita até o delta t de 12 horas, sabemos que ela vai perdendo sua eficácia a partir de 3-6 horas após instalado o IAM). Ou seja, se tivermos que escolher um método que produza melhores resultados certamente este será a angioplastia (intervenção percutânea).

65600.

Comentário: Diante de todo e qualquer paciente que apresenta dor torácica compatível com síndrome coronariana aguda, o encontro de supradesnivelamento de ST 1 mm em derivações precordiais ou 2 mm em derivações periféricas, em duas ou mais derivações contíguas, ou bloqueio completo de ramo esquerdo (BRE de 3º grau), novo ou supostamente novo, o diagnóstico operacional deve ser de coronária fechada . Dito de outro modo, ambas as situações são equivalentes e devem ser tratadas com o mesmo tipo de conduta reperfusão coronariana imediata. Resposta certa D.

65613.

Comentário: Nitratos são vasodilatadores venosos e arteriais, logo, não devem ser usados no paciente hipotenso e ou bradicárdico (risco de agravamento ou instalação de instabilidade hemodinâmica, respectivamente). No IAM de VD, o débito cardíaco passa a depender de forma crítica da pré-carga de VD, ou seja, do retorno venoso e enchimento diastólico dessa câmara. Logo, os nitratos também devem ser evitados em tal contexto, uma vez que a dilatação da veia cava inferior promovida por essas drogas vai reduzir o retorno venoso e, consequentemente, o

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

débito cardíaco, gerando instabilidade hemodinâmica. O sildenafil (Viagra) é um inibidor da fosfodiesterase, enzima que degrada o óxido nítrico endotelial. O efeito vasodilatador dos nitratos provém de um estímulo à produção de óxido nítrico no endotélio vascular. Ora, se o paciente combinar as duas drogas (nitrato sildenafil), a produção de óxido nítrico será exagerada, o que sabidamente se associa à hipotensão arterial grave e refratária, choque circulatório e alta probabilidade de óbito. Assim, antes de ministrar nitrato a um paciente, não se esqueça de perguntar se ele utilizou medicamentos para disfunção erétil nas últimas 24h (contraindicação ABSOLUTA). Um BRE completo (3º grau), novo ou supostamente novo, no paciente com dor torácica anginosa, a princípio, deve ser interpretado como um indício de coronária fechada (equivalente ao supradesnível de ST). Por si só, tal situação não contraindica o emprego de nitratos, pelo contrário na ausência de contraindicações específicas, os nitratos são os antianginosos de escolha para esses pacientes. Resposta certa Letra E.

327464.

Comentário: Paciente idoso, com alto risco cardiovascular, apresentando quadro de equivalente anginoso (dor epigástrico em queimação associada à sudorese fria, escurecimento da visão e náuseas). No seu exame físico, chama atenção a presença de hipotensão, taquicardia e turgência jugular. Diante de um quadro como esse, até prova em contrário, estamos diante de uma síndrome coronariana aguda Neste cenário, o ECG é fundamental E veja só o que ele nos mostra um supradesnivelamento do segmento ST em topografia de parede inferior (DII, DIII e aVF), além de infradesnível de V1-V4 (possível imagem em espelho de um supra localizado na parede posterior). Portanto, estamos diante de um infarto agudo do miocárdio com supra de ST. Resposta infarto agudo do miocárdio com supra de ST .

327465.

Comentário: Quadro compatível com infarto agudo do miocárdio com supra de ST E nesse sentido, a terapia de reperfusão miocárdica é a grande medida terapêutica, particularmente a angioplastia. Comparada com os fibrinolíticos, ela leva a taxas mais altas de patência e menor recorrência de isquemia, reinfarto, novos procedimentos de revascularização, hemorragia intracraniana e morte. E

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

este benefício é ainda mais válido para pacientes mais graves. Assim, a angioplastia será sempre o método de escolha, a menos que haja demora na sua realização. Além disso, prescreveremos AAS, algum inibidor da P2Y12 (tradicionalmente o clopidogrel), bem como heparina, IECA, estatina e betabloqueador (na ausência de contraindicações). A banca não liberou o gabarito oficial.

308317.

Comentário: Vamos analisar as alternativas Letra A incorreta. A radiografia é normal na maioria dos pacientes com pericardite aguda, já que é necessário o acúmulo de grande quantidade de líquido (200 ml) para que a silhueta cardíaca aumente. Letra B incorreta. Cerca de 95% dos indivíduos têm dor torácica. Duas de suas características nos ajudam a afastar outras hipóteses, como o infarto agudo do miocárdio há melhora quando o paciente se senta e inclina o tórax para frente (essa posição reduz a pressão no interior do pericárdio) e há irradiação para o trapézio. Cabe ressaltar que ela costuma ser mínima ou ausente quando a etiologia é urêmica ou reumatológica. Letra C correta. De fato, o supra de ST difuso e o infra de PR são achados característicos. Só para ganharmos bagagem, vamos discutir um pouco mais O eletrocardiograma apresenta evolução em estágios estágio I (horas-dias) supra de ST difuso com infra de PR estágio II (primeira semana) normalização dos segmentos ST e PR estágio III (achado subagudo , sem prazo exato determinado) inversão de onda T difusa estágio IV (pode surgir após o III ou após o início do tratamento em qualquer estágio) normalização do eletro. Letra D incorreta. O derrame pericárdico hemorrágico deve nos fazer considerar duas hipóteses principais neoplasia e tuberculose. Nas infecções virais, o líquido, quando presente, costuma ser seroso. Resposta letra C.

308319.

Comentário: Reparem nas dicas fornecidas no enunciado para pensarmos em dissecção aórtica Em primeiro lugar, temos fatores de risco enquanto 70% dos pacientes com dissecção aórtica são hipertensos, a dissecção aórtica pode ser considerada como principal causa de morbimortalidade em indivíduos com síndrome de Marfan A dor torácica também é característica, sendo intensa, com irradiação para dorso e refratária ao uso de nitrato. Além disso, temos um baita de um sopro diastólico em foco aórtico, sugerindo insuficiência aórtica. Isso é explicado pelo envolvimento da

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

valva aórtica, ocorrendo em mais da metade das dissecções ascendentes. Um parêntese aqui nosso paciente apresenta um sopro sistólico em foco mitral sugestivo de insuficiência desta valva. Sabemos que o prolapso da valva mitral é a anormalidade mais comum na síndrome de Marfan. O ECG, por sua vez, mostra supradesnivelamento de ST em DII, DIII e aVF parede inferior com infra em V1 e V2 trata-se de uma imagem em espelho da parede dorsal. Ou seja, tais achados sugerem acometimento inferodorsal. Cabe mais um pequeno parêntese aqui o termo infarto dorsal vem caindo em desuso, pois estudos mais recentes com RM cardíaca mostraram que esse espelho não é tão confiável assim, só que ele ainda aparece em prova Enfim, vamos seguir... Por que esse paciente apresenta alterações eletrocardiográficas isquêmicas Pelo envolvimento do óstio coronariano, sendo o infarto em território da coronária direita, que irriga a parede inferior na maioria dos pacientes, o mais comum. É frequente que os pacientes se apresentem hipertensos, mas, naturalmente, pode haver evolução com envolvimento importante do ventrículo direito, o que resultará em choque circulatório e hipotensão. Resposta letra A.

316004.

Comentário: Estamos diante de um homem dislipidêmico que se apresenta na Emergência com dor retroesternal em peso, que se resolveu espontaneamente 20 minutos após chegar ao hospital. Embora a irradiação para o ombro esquerdo não seja clássica , é mais provável que estejamos frente a um quadro de síndrome coronariana aguda (SCA). Pode não ser SCA Sim, mas é a hipótese principal e precisa ser descartada. Na embolia e no pneumotórax, não esperamos que a dor se resolva de forma espontânea na dissecção aórtica, a descrição típica da dor é de padrão lancinante e irradiação para o dorso já na esofagite, o sintoma costuma ser contínuo e, dificilmente, se apresenta de forma aguda, de uma hora para outra . Resposta letra C.

308386.

Comentário: Estamos diante de uma mulher com síndrome metabólica estabelecida. Lembra dos critérios (são necessários pelo menos três dos seguintes) - Circunferência abdominal 88 cm (mulheres) ou 102 cm (homens) - PA sistólica maior ou igual a 130 mmHg ou diastólica maior ou igual a 85 mmHg - Triglicerídeos maior ou igual a 150 mg dL - HDL 50 mg dL (mulheres) ou 40 mg

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

dL (homens) - Glicemia de jejum maior ou igual a 100 mg dL. Agora, vamos analisar às opções Letra A incorreta. De fato, o IMC é de 37,04. Porém esse valor corresponde à obesidade grau II (35-39,99). Para ser classificada como obesa grau III, o valor deveria ser maior ou igual a 40. Letra B incorreta. Níveis de glicemia de jejum entre 100-126 mg dL são compatíveis com pré-diabetes, e não diabetes. Mesmo que o resultado fosse superior a esse, seria necessário outro exame para confirmação. Letra C correta. Mesmo não apresentando diabetes, é fundamental que essa paciente mude seu estilo de vida. Afinal, ela tem síndrome metabólica Essas medidas são importantes para evitar que ela desenvolva doenças, como a própria diabetes. Letra D incorreta. Ela tem síndrome metabólica, como vimos. Resposta letra C.

313414.

Comentário: Temos uma paciente com vários fatores de risco para doença coronariana (idade, hipertensão e diabetes) que se apresenta com dor torácica típica. O diagnóstico que se impõe é o de síndrome coronariana aguda. O eletrocardiograma, por sua vez, mostra supradesnivelamento do segmento ST em DII, DIII e aVF, compatível com infarto de parede inferior Vamos aproveitar a questão para revisar rapidamente a correspondência entre parede acometida e derivações alteradas (1) IAM de parede anterior (artéria desendente anterior ou DA) V1 a V4 (parede anterosseptal e anterolateral) (2) IAM de parede lateral (artéria circunflexa ou CX) DI e aVL (lateral alta), V5 e V6 (lateral baixa, apical) (3) IAM de parede inferior (artéria coronária direita ou CD, raramente Cx) DII, DIII e aVF (4) Infarto de VD (CD) V1, V3R e V4R (acompanha o IAM inferior I 10%). O bloqueio de ramo esquerdo é defiindo pela presença de onda S alargada em V1 e onda R alargada ausência de onda Q em D1 e V6 - não é o que temos aqui, então não podemos marcar a letra D. Resposta letra B.

274111.

Comentário: A pericardite constrictiva é um tipo de pericardiopatia na qual o pericárdio está endurecido e exerce um efeito limitante ao enchimento ventricular diastólico, desencadeando uma síndrome congestiva. O pericárdio vai ficando progressivamente mais rígido e espesso, formando uma verdadeira carapaça em volta do coração. Os dois pericárdios (parietal e visceral) se fundem,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

obliterando o espaço pericárdico. O quadro clínico costuma manifestar-se com uma síndrome congestiva sistêmica, predominando a turgência jugular patológica, a hepato megalia congestiva, a ascite e o edema de membros inferiores e da genitália. A ascite geralmente é de grande monta, chamando atenção no quadro, frequentemente confundido com uma hepatopatia crônica primária. O médico perspicaz, ao examinar um paciente com ascite e hepato megalia, fará um cuidadoso exame das veias jugulares, pois a presença ou não de turgência patológica é o divisor de águas para a investigação diagnóstica. Alguns pacientes podem não ter edema de membros inferiores, porém apresentam uma ascite importante. Os sintomas de congestão pulmonar, como a dispneia aos esforços, ortopneia e dispneia paroxística noturna, e ou de baixo débito cardíaco, como a fadiga, tonteira, indisposição física, podem aparecer nas fases mais avançadas. O exame físico revela um aumento da pressão jugular, turgência patológica e um pulso venoso com dois descensos proeminentes (aspecto em W ou M). A hepato megalia está associada à detecção de um pulso hepático venoso visível e palpável à presença do refluxo hepatojugular. A ascite frequentemente é tensa, com o teste de piparote positivo. O exame do precórdio pode mostrar uma retração sistólica da ponta, uma discreta hipofonese de bulhas e o achado mais característico o knock pericárdico. Este som protodiastólico, de tom agudo e timbre áspero, corresponde ao breque no enchimento diastólico ventricular dado pela limitação pericárdica. Pode ser confundido com o estalido de abertura mitral, da estenose mitral, e com a B3 (esta, porém, é mais afastada da B2 e tem um tom grave). O sinal de Kussmaul é um dos marcos da pericardite constritiva. Os achados mais comuns no ECG são a baixa voltagem do QRS e as alterações na repolarização, geralmente achatamento ou inversão da onda T. A onda P pode apresentar sinais de aumento atrial esquerdo, comum na pericardite constritiva. A presença de doença do sistema de condução e a presença de ondas Q de fibrose sugerem o diagnóstico de cardiomiopatia, porém a extensão do processo fibroso pericárdico para o epicárdio pode levar a essas alterações. No nosso meio, a principal causa de pericardite constritiva é a tuberculose (2 3 complicam com pericardite constritiva o tratamento com RIPE não previne essa evolução). Outras causas são artrite reumatoide, lúpus, esclerodermia, IAM e uremia. Após rever alguns conceitos sobre pericardite constrictiva

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

observamos que o caso clínico não é compatível com o quadro de pericardite constrictiva, conforme o gabarito oficial da banca sugere (opção B). Questão anulada. O caso clínico fala mais a favor de um quadro de pericardite subaguda. O que melhor caracteriza a pericardite é a dor torácica, de localização precordial ou retroesternal, contínua, tipo pleurítica (piora com a inspiração profunda e tosse), que piora com o decúbito dorsal e é aliviada na posição sentada com o tronco inclinado para frente (posição genupeitoral) ou abraçado ao travesseiro (posição de Blechmann). Em alguns casos, a dor pode simular a angina pectoris , tendo caráter constritivo e irradiando para o braço esquerdo. A dispneia também é uma queixa comum, pois geralmente há irritação da pleura parietal adjacente ao pericárdio e o indivíduo respira superficialmente para evitar a dor. A maioria dos casos de pericardite aguda é de etiologia viral. Nessa situação, não é raro observarmos um quadro viral inespecífico (astenia, dor no corpo, febre). Ao exame físico, o paciente geralmente está taquicárdico e, algumas vezes, também taquipneico. O achado patognomônico de pericardite aguda é o atrito pericárdico, presente em 85% dos casos. No ECG a alteração mais encontrada é o supradesnível de ST, com o ST de aspecto côncavo. Este aspecto normalmente é visto em várias derivações, mas geralmente poupa V1 e aVR. A etiologia normalmente é viral ou idiopática. Os vírus mais implicados são o coxsackie B (principal) e o echovirus tipo 8, que comumente causam gripe e resfriado comum daí ser frequente o pródromo com quadro gripal na pericardite.

288136.

Comentário: A fibrinólise está proibida na presença de contraindicações absolutas como sangramento ativo (D- INCORRETA). A morfina é o analgésico de escolha para tratar a dor do IAM. Seus benefícios superam eventuais riscos, pois o alívio da dor diminui a resposta adrenérgica que contribui para o maior consumo miocárdico de O2 (C- INCORRETA). As troponinas são os marcadores de escolha para confirmar IAM (B- INCORRETA). Na ausência de troponina, pode-se utilizar a CK (especialmente a fração MB), cujos níveis aumentam em 4-8h após início do quadro, persistindo elevados no sangue por até 72h. Resposta A.

283991.

Comentário: O enunciado e as alternativas não deixam dúvidas esta paciente com fatores de risco

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

cardiovascular e dor torácica está apresentando uma síndrome coronariana aguda. Mas como caracterizar essa síndrome pelo eletrocardiograma Vamos avaliar o traçado. O ritmo é regular, sinusal e de QRS estreito, sem bloqueios de ramo (D INCORRETA). Chama atenção um supradesnivelamento do segmento ST em parede inferior (DII, DIII e aVF) e parede lateral (V5 e V6), além de infradesnivelamento nas precordiais direitas (V1V3), o que sugere imagem em espelho de um supradesnivelamento da parede posterior dorsal. O diagnóstico correto é uma síndrome coronariana aguda com supra de ST infero-latero-dorsal, que pode ter origem tanto na coronária direita quanto em um grande ramo marginal esquerdo. Não está incorreto, contudo, resumir o achado como IAM de parede inferior , que de fato existe. As outras alternativas simplesmente não se aplicam neste caso. Resposta letra B.

244785.

Comentário: Paciente com quadro sugestivo de pericardite aguda (infecção viral prévia, melhora da dor torácica ao fletir o tronco, atrito pericárdico) sobre a qual pergunta-se a indicação de internação hospitalar. São fatores de risco associados a pericardite de alto risco que motivam internação - Febre 38oC (B correta) - Curso de doença subagudo (sem dor torácica de início abrupto) - Sinais de tamponamento cardíaco (C correta) - Derrame pericárdico de grande monta (C correta) - Pacientes imunodeprimidos (D correta) - Uso de anticoagulantes - Trauma agudo - Ausência de resposta ao uso de AINES e colchicina - Aumento de troponina, sugerindo miocardite perimiocardite. (A correta) Resposta E.

221391.

Comentário: Segundo a Diretriz Brasileira, a dose de ataque recomendada para todos os pacientes com IAM é de 160 a 325 mg (o comprimido deve ser mastigado para facilitar a sua absorção). Na prática, costumamos prescrever 200 mg pela facilidade posológica, já que os comprimidos de AAS mais disponíveis são de 100 mg. Para profilaxia secundária, a dose preconizada é de 75-162 mg. Alguns estudos, como o CURRENT-OASIS 7, avaliaram o impacto de diferentes doses de AAS em pacientes com síndrome coronariana aguda. Quando comparadas doses elevadas (300-325 mg dia) a doses menores (75-100 mg dia), não foi evidenciada diferença estatística significante entre

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

os grupos no desfecho primário de morte cardiovascular, IAM ou AVE nos primeiros 30 dias. Além disso, o grupo que usou doses altas apresentou um aumento importante das taxas de sangramento. Por isso, a preferência é dada para as doses menores Resposta (D).

221398.

Comentário: Questão copiada, integralmente, da DIRETRIZ DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA E DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA SOBRE INTERVENÇÃO CORONÁRIA PERCUTÂNEA. Vamos, então, ao trecho retirado do tópico 20.4 (TAD Pós ICP em Pacientes com Alto Risco de Sangramento) que respondia a questão Já o manejo da TAD em pacientes submetidos a implante de stent e em uso de anticoagulantes ainda representa um desafio na prática clínica devido ao elevado risco de complicações hemorrágicas associada a terapia tripla. Soma-se a isso os diferentes agentes antiplaquetários e anticoagulantes disponíveis comercialmente com as evidências científicas sendo escassas em relação a essa questão. Logo, busca-se a individualizaçação do tratamento, pesando os riscos e benefícios em termos de sangramento e isquemia . Resposta letra C.

221389.

Comentário: O ticagrelor é um antiplaquetário inibidor reversível do receptor P2Y12. Essa droga é mais distante quimicamente do clopidogrel e prasugrel, não sendo classificada como uma ticlopidina. Não requer ativação metabólica para inibição plaquetária, possuindo início de ação mais rápido e eficácia superior ao clopidogrel em termos de supressão da agregação plaquetária induzida pelo ADP. Resposta letra C.

221380.

Comentário: Questão retirada, na íntegra, da Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Internvencionista sobre intervenção coronária percutânea. Observe o trecho que matava a questão A avaliação de estenoses angiograficamente intermediárias (40% e 70%) representa um desafio do cotidiano do laboratório de cateterismo e é uma das indicações mais bem estabelecidas para uso clínico da RFF (reserva de fluxo fracionada) no auxílio da tomada de decisão. A capacidade da RFF em discriminar o significado funcional de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

estenoses coronárias epicárdicas foi extensamente validada em ampla gama de situações clínicas e anatômicas . Resposta dessa absurda questão letra C.

221383.

Comentário: Questão retirada, na íntegra, da Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Internvencionista sobre intervenção coronária percutânea. Observe o trecho que matava a questão O benefício da utilização da RFF (reserva de fluxo fracionada) para guiar a propriedade da revascularização miocárdica em pacientes com DAC (doença arterial coronária) multiarterial foi demonstrado em diversos estudos, não randomizados e randomizados. De forma geral, guiar o procedimento de revascularização, tratando apenas estenoses fisiologicamente significativas, ao invés de guiar a revascularização pela aparência angiográfica, foi seguro e reduziu o custo do procedimento e a ocorrência de eventos cardíacos adversos a longo prazo. Resposta dessa absurda questão letra D.

214586.

Comentário: O caso é de IAM inferior com paciente apresentando hipotensão arterial associada, indicando provável IAM de VD (que deve ser avaliada através de V3R e V4R). Frente a essa suspeita, devemos administrar volume e não prescrever nitratos ou morfina, drogas que reduzem o retorno venoso. Gabarito D.

208559.

Comentário: Paciente com quadro clássico de síndrome coronariana aguda - dor torácica em aperto há 15 minutos... A grande dificuldade da questão era entender que o pedido era justamente indicar, dentre as opções, qual indica que o paciente deve receber terapia de reperfusão imediatamente Lembre que, em síndromes coronarianas com supradesnível do segmento ST nas primeras 12 horas de sintomas, está indicada abertura imediata da artéria, seja através de angioplastia primária, seja através de trombólise. Resposta B.

177321.

Comentário: A cineangiocoronariografia é um procedimento realizado frequentemente em pacientes com síndrome coronariana aguda ou na estratificação de pacientes de alto risco com dor torácica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

As complicações ocorrem em cerca de 10% dos procedimentos, sendo 6,5% leves (intercorrências), 2,5% moderadas (resolvidas em até 24 horas) e 1,4% graves (que necessitam de nova intervenção ou internação). A complicação mais frequentemente encontrada é o sangramento local, com presença de hematoma, correspondendo a cerca de 3% das complicações em todos os procedimentos. Gabarito Alternativa D.

158189.

Comentário: O tratamento de um infarto agudo do miocárdio com angioplastia primária exige um cuidado muito especial dupla antiagregação plaquetária. Apesar de garantir a reperfusão do vaso, o stent pode ser considerado um material trombogênico. Assim, até que a reepitelização de seu lúmen ocorra, indica-se o uso de aspirina, associada a outro antiagregante plaquetário (usualmente o clopidogrel) para a prevenção do reinfarto. Independente da realização ou não da terapia de reperfusão, todos os pacientes com história de IAM devem utilizar betabloqueadores e IECA, drogas que impactam em morbimortalidade cardiovascular. Da mesma forma, as estatinas também reduzem morbimortalidade pós-IAM, independente dos níveis de colesterol, visto que possuem atividades antiinflamatórias, reduzindo a aterogênese. E quanto aos nitratos Estas drogas não impactam em sobrevida no curso de um IAM, além de não promoverem prevenção secundária em longo prazo. Trata-se de uma classe de drogas com efeitos limitados a controle de sintomas. Gabarito letra A

136992.

Comentário: No Infarto agudo do miocárdio (IAM) com supra de ST podemos oferecer 2 tipos de terapia de reperfusão com trombolítico ou angioplastia primária. O que vai indicar a melhor terapia é o tempo porta-balão, se maior ou menor que 90 min. A utilização de fibrinolítico pré-hospitalar é indicada e reduz a mortalidade e o grau de disfunção ventricular, mas a estreptoquinase não é o melhor trombolítico para IAM. A troponina utilizada para o diagnóstico de infarto é a Troponina I e a Troponina T, não a troponina C. A realização e interpretação do ECG de forma rápida é fundamental para o estabelecimento precoce da terapia adequada para o caso, otimizando o tempo decorrido entre os sintomas e a terapia específica. O ECG de alta resolução permite a identificação

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

de áreas de condução lenta e fragmentada, que são áreas mais suscetíveis a arritmias por reentrada. Dessa forma, a resposta da questão é letra B.

137000.

Comentário: A opção A está incorreta, pois a realização de exames de imagem para estratificação funcional está indicada para pacientes diabéticos a partir dos 40 anos de idade. A Aspirina está indicada nos pacientes diabéticos com pelo menos um fator de risco, como hipertensão ou dislipidemia, além de idade maior que 50 anos em homens e 60 anos em mulheres. As tiazolinedionas são agentes hipoglicemiantes com importante efeito colateral cardiovascular, podendo inclusive, precipitar uma descompensação da insuficiência cardíaca. Pacientes diabéticos com doença vascular estabelecida ou com mais de 40 anos devem utilizar estatina independente dos níveis de colesterol, devido ao alto risco cardiovascular. Dessa forma, a afirmativa correta é a letra D.

108109.

Comentário: Vamos relembrar as localizações das paredes no eletrocardiograma -IAM Anterosseptal V1-V2 V1-V3 V1-V4 -IAM Anterolateral V5, V6, D1 e aVL -IAM Anterior extenso V1-V6 D1 e aVL -IAM Lateral alto D1 e aVL -IAM Inferior D2, D3 e aVF -IAM Dorsal Imagem em espelho em V1-V2 ou V1-V5 ou supra ST em V7 e V8 -IAM Inferodorsal Parede inferior dorsal -IAM Laterodorsal Parede lateral alta dorsal -IAM Ínferolateral D2, D3 e aVF, V5 e V6 -IAM de VD V3R e V4R - V1 Leta B tem a associação correta.

85032.

Comentário: Estamos diante de um paciente com diversos fatores de risco e que apresenta clínica compatível com síndrome coronariana aguda, a princípio sem supra de ST. A elevação da CK-MB 4x acima dos valores de referência favorece o diagnóstico de IAM, embora este seja um marcador com menor acurácia que a troponina para o diagnóstico de necrose miocárdica. Segundo as últimas Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Angina Instável e Infarto Agudo do Miocárdio sem Supradesnível do Segmento ST , do ponto de vista de marcadores bioquímicos de necrose miocárdica, o diagnóstico de IAM deve ser feito de acordo com os seguintes critérios -

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Troponina T ou I aumento acima do percentil 99 em pelo menos uma ocasião nas primeiras 24 horas de evolução. - Valor máximo de CK-MB, preferencialmente massa, maior do que o limite superior da normalidade em 2 amostras sucessivas valor máximo de CK-MB acima de 2 vezes o limite máximo da normalidade em 1 ocasião, durante as primeiras horas após o evento. Na ausência de CK-MB ou troponina, CK total acima de 2 vezes o limite superior pode ser utilizado, mas este biomarcador é consideravelmente menos satisfatório do que a CK-MB. Dessa forma, uma vez que o paciente apresenta CK-MB igual a 4 vezes o valor limite superior de normalidade, podemos inferir o diagnóstico de IAM ao caso em tela. Infelizmente, a banca não aceitou os pedidos de recurso e manteve como gabarito a opção B.

88433.

Comentário: A angina típica que surge mesmo ao repouso configura uma Síndrome Coronariana Aguda (SCA), que através do eletrocardiograma é dividida em 2 grupos - SCA com supra de ST Infarto Agudo do Miocárdio com supra de ST. - SCA sem supra de ST Angina Instável e Infarto Agudo do Miocárdio sem supra de ST. Estas 2 últimas são diferenciadas pelos marcadores de injúria miocárdica negativos na Angina Instável e positivos no infarto. Resposta certa letra C

301651.

Comentário: Mais uma péssima questão que nada tem de médica, apenas semântica. De fato, a tendência brasileira tem sido de diminuição do gasto familiar com óleos e gorduras, indicando uma redução no consumo. Resposta letra B.

284213.

Comentário: Questão baseada, integralmente, na Diretriz Brasileira de Reabilitação Cardiovascular 2020. Vamos, então, revisar um trecho do documento que respondia a questão Portanto, o impacto econômico provocado pelas DCV, aliado à obrigatoriedade do uso consequente e racional de recursos financeiros, exige a implementação em larga escala de modelos de baixo custo, viabilizando o atendimento de maior número de pacientes. Em coronariopatas estáveis, a RCV é uma estratégia que, em termos de custo-efetividade, supera, com larga margem, procedimentos amplamente utilizados no país, tais como a intervenção coronariana percutânea (ICP) . Além disso,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

sua utilização em maior escala proporcionaria redução nos gastos com saúde, em decorrência da diminuição de novos eventos cardiovasculares, reinternações hospitalares e tratamentos intervencionistas . Resposta letra B.

239610.

Comentário: São feitas quatro afirmativas a respeito da doença arterial coronariana (DAC) e do uso de estatina. Vamos avalia-las A) Incorreta, pois é a principal causa de mortalidade. B) Incorreta, pois as estatinas são a segunda classe farmacológica mais prescrita, atrás dos anti-hipertensivos. C) Correta e conceitual. D) Incorreta, pois o debate atual envolve a questão de como e quando usar estatinas no controle efetivo do risco cardiovascular, sem tornar o seu uso banal. Resposta C.

239611.

Comentário: Questão extraída da 3ª Diretriz de Avaliação Cardiovascular Perioperatória da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Vamos, então, relembrar o trecho que respondia a questão A fisiopatologia do IAM perioperatório difere um pouco da do IAM espontâneo. No IAM perioperatório, a ruptura de placa ocorre em aproximadamente metade dos casos o restante se dá por um desequilíbrio prolongado entre a redução da oferta de oxigênio para o miocárdio (anemia, baixo fluxo etc.) e o aumento da demanda arterial coronariana (taquicardia e hipertensão).(letra A - CORRETA) O TE é uma ferramenta segura, útil e eficaz para a detecção de isquemia miocárdica, tendo justamente como mecanismo produzir este desbalanço entre oferta e demanda. (letra B - CORRETA) Assim, é razoável pensar que a detecção de anormalidades durante sua execução possa ser reprodutível durante o perioperatório e seus variados níveis de estresse. (letra C - CORRETA) Porém, não há evidências de que usar esta estratégia para todos os pacientes resulte na redução de eventos cardiovasculares perioperatórios. Também deve se considerar que, quanto menor a prevalência da doença coronária em determinada população, menor será também o valor preditivo positivo do TE. (letra D - INCORRETA) Resposta letra D.

243736.

Comentário: O enunciado descreve o caso de um paciente com diversos fatores de risco cardiovascular, descrevendo dor anginosa típica estável (dor precordial em aperto, que piora com

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

repouso e melhora em repouso). Vamos responder cada alternativa A) A autoavaliação do paciente não pode ser ignorada ao coletar a história clínica. Muitas vezes a descrição do sintoma não é compatível com a descrição clássica dos livros, porém a importância dada a um sintoma pode sugerir quadros mais importantes, mesmo que frequentemente sea infundada (INCORRETA) B) O ECG de repouso normal NÃO pode descartar a presença de doença coronariana, sendo frequentemente necessários exames funcionais para demonstrar a presença de isquemia, já que o sintoma é esforço-dependente. A melhora em repouso é compatível com a natureza da doença, que se manifesta ao exercício. (INCORRETA) C) As características da dor, a idade e o sexo do paciente são os principais fatores que influenciam na probabilidade pré-teste para doença arterial coronariana. A ausência de características de dor torácica não-cardíaca reforça a suspeita clínica (CORRETA) D) Muito embora em alguns pacientes diabéticos, o padrão de apresentação da dor é mais frequentemente atípico, a presença de dor não pode ser ignorada nem perde importância (INCORRETA) Resposta correta letra C

239620.

Comentário: Questão extraída, na íntegra, da 3ª Diretriz de Avaliação Cardiovascular Perioperatória da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Vamos, então, relembrar um trecho do documento que respondia a questão O aumento da sensibilidade dos kits disponíveis das troponinas propiciou uma maior acurácia e rapidez no diagnóstico ou não do IAM em pacientes com dor torácica na sala de emergência. Por outro lado, no perioperatório de operações não cardíacas, as evidências científicas disponíveis não incluem todas as troponinas (I e T) e nem todos métodos utilizados para sua dosagem , que apresentam limites de detecção e valores de referência diferentes. (letra A - INCORRETA) Por esta razão, e pela importância desta ferramenta diagnóstica, esta diretriz optou por incluir uma explicação detalhada sobre os métodos disponíveis antes das recomendações. O limite de detecção significa o mínimo valor que é detectado pelo método. Já o valor de referência da normalidade é determinado utilizando o percentil 99, que é obtido realizando-se o exame em uma população normal e significa que 99% dos indivíduos normais apresentam valores abaixo deste cut-off. Os kits de troponina podem ser classificados em baixa (convencionais), média

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

(contemporâneos ou sensíveis) ou alta sensibilidade. (letras B, C e D - CORRETAS) Resposta letra A.

239621.

Comentário: Questão extraída, na íntegra, do Posicionamento sobre Antiagregantes Plaquetários e Anticoagulantes em Cardiologia - 2019. Vamos, então, relembrar um trecho do documento que respondia a questão Aproximadamente 6 a 8% dos pacientes submetidos à ICP têm indicação concomitante de utilização de anticoagulantes orais em longo prazo, (letra A - CORRETA) devido a vários motivos como FA, valvas mecânicas ou tromboembolismo. (letras C e D - CORRETAS e letra B - INCORRETA) Dessa forma, definir a melhor maneira de tratar esses pacientes torna-se fundamental, principalmente quanto à associação de medicamentos antiplaquetários e anticoagulantes. Resposta letra B.

221224.

Comentário: Segundo a Diretriz Brasileira, a dose de ataque recomendada para todos os pacientes com IAM é de 160 a 325 mg (o comprimido deve ser mastigado para facilitar a sua absorção). Na prática, costumamos prescrever 200 mg pela facilidade posológica, já que os comprimidos de AAS mais disponíveis são de 100 mg. Para profilaxia secundária, a dose preconizada é de 75-162 mg. Alguns estudos, como o CURRENT-OASIS 7, avaliaram o impacto de diferentes doses de AAS em pacientes com síndrome coronariana aguda. Quando comparadas doses elevadas (300-325 mg dia) a doses menores (75-100 mg dia), não foi evidenciada diferença estatística significante entre os grupos no desfecho primário de morte cardiovascular, IAM ou AVE nos primeiros 30 dias. Além disso, o grupo que usou doses altas apresentou um aumento importante das taxas de sangramento. Por isso, a preferência é dada para as doses menores Resposta (D).

221253.

Comentário: Questão retirada da DIRETRIZ DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA E DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA SOBRE INTERVENÇÃO CORONÁRIA PERCUTÂNEA. Vamos, então, ao trecho retirado do tópico 20.4 (TAD Pós ICP em Pacientes com Alto Risco de Sangramento) que respondia a questão Já o

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

manejo da TAD em pacientes submetidos a implante de stent e em uso de anticoagulantes ainda representa um desafio na prática clínica devido ao elevado risco de complicações hemorrágicas associada a terapia tripla. Soma-se a isso os diferentes agentes antiplaquetários e anticoagulantes disponíveis comercialmente com as evidências científicas sendo escassas em relação a essa questão. Logo, busca-se a individualizaçação do tratamento, pesando os riscos e benefícios em termos de sangramento e isquemia . Resposta letra C.

216819.

Comentário: Bom, temos um paciente idoso, tabagista e hipertenso, que se apresenta com dor torácica retroesternal em aperto há 45 minutos. Tudo leva a crer que esse paciente esteja infartando, não é mesmo De fato, isso é corroborado pela positividade da troponina, indicando que há lesão necrose miocárdica. Como o enunciado não menciona a presença de supradesnivelamento do segmento ST, o diagnóstico de IAM sem supra de ST está confirmado. Resposta C.

221315.

Comentário: Questão retirada da Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Internvencionista sobre intervenção coronária percutânea. Observe o trecho que matava a questão A avaliação de estenoses angiograficamente intermediárias (40% e 70%) representa um desafio do cotidiano do laboratório de cateterismo e é uma das indicações mais bem estabelecidas para uso clínico da RFF (reserva de fluxo fracionada) no auxílio da tomada de decisão. A capacidade da RFF em discriminar o significado funcional de estenoses coronárias epicárdicas foi extensamente validada em ampla gama de situações clínicas e anatômicas . Resposta dessa absurda questão letra C.

221316.

Comentário: Questão retirada da Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Internvencionista sobre intervenção coronária percutânea. Observe o trecho que matava a questão O benefício da utilização da RFF (reserva de fluxo fracionada) para guiar a propriedade da revascularização miocárdica em pacientes com DAC

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

(doença arterial coronária) multiarterial foi demonstrado em diversos estudos, não randomizados e randomizados. De forma geral, guiar o procedimento de revascularização, tratando apenas estenoses fisiologicamente significativas, ao invés de guiar a revascularização pela aparência angiográfica, foi seguro e reduziu o custo do procedimento e a ocorrência de eventos cardíacos adversos a longo prazo. Resposta dessa absurda questão letra D.

214099.

Comentário: Outra questão bastante específica... Trata-se de uma paciente com sintomas de angina típicos, teste não-invasivo (ergométrico) positivo, mas sem obstrução de coronárias epicárdicas à cineangiocoronariografia. À essa condição, damos o nome de síndrome X, ou angina microvascular. Vamos analisar as assertivas A) Incorreta, pois a cintilografia de perfusão miocárdica por estresse pode demonstrar defeitos de perfusão. B) Correta. A maioria dos estudos falhou em evidenciar evidências bioquímicas de isquemia, com elevação do lactato. C) Incorreta. A doença é caracterizada pela disfunção microvascular, por definição. D) Incorreta. Esses pacientes possuem aumento da sensibilidade à dor e maior incidência de distúrbios psiquiátricos. E) Incorreta. O escore de cálcio dos pacientes com síndrome X é maior que o dos pacientes controle. Resposta letra B.

214101.

Comentário: A dissecção coronariana espontânea (DCE) é uma causa rara de infarto agudo do miocárdio, correspondendo a menos de 1% dos casos, sendo mais frequente na coronária descendente anterior. No entanto, no contexto gestacional, a incidência de DCE como etiologia do infarto é de cerca de 40%. A principal causa de DCE (90%) é a displasia fibromuscular, que acomete principalmente mulheres jovens e sem outras comorbidades. No entanto, uma causa menos frequente é a dissecção associada a alterações hormonais, que podem ocorrer no contexto gestacional ou em mulheres pós menopausa em uso de terapia de reposição hormonal. Gabarito Alternativa B.

177891.

Comentário: Se existem alterações no ECG de base capazes de impedir a identificação de sinais

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

de isquemia aguda, como é o caso do bloqueio de ramo esquerdo, nenhum teste provocativo baseado em ECG poderá ser utilizado (E errada). Assim, poderíamos recorrer a qualquer um dos testes provocativos de imagem , como aqueles citados nas letras A, C ou D. Por que o gabarito da banca foi a letra B, um teste invasivo Ora, porque a questão está perguntando qual é o MELHOR exame para avaliar obstrução coronariana num paciente sabidamente coronariopata que vinha estável e voltou a ter sintomas. Em termos de acurácia, o melhor exame é o cateterismo cardíaco, que mostrará a presença de uma nova estenose coronária, fornecendo também sua localização e extensão. Além do mais, existe outra justificativa para partir direto ao CAT neste caso trata-se, na realidade, de paciente coronariopata sintomático a despeito do tratamento clínico (podendo ser enquadrado no conceito de angina refratária). O melhor tratamento para esta condição é a revascularização, e a estratégia de revascularização (cirúrgica ou percutânea) só pode ser definida a partir do conhecimento da anatomia coronariana, exigindo, portanto, a realização de CAT. Resposta certa B.

187414.

Comentário: Fatores como tabagismo (mínimo de meio maço ao dia por 5 anos ou 25 maços ao ano), colesterol total (250 mg dL) e glicemia de jejum (140 mg dL) aumentam a chance de DAC. Outros fatores, como história familiar e hipertensão, não são fortemente preditivos. Dessa forma, por apresentar pelo menos dois fatores de gravidade, com mau controle da hipertensão arterial, trata-se de paciente de alto risco cardiovascular. Gabarito Alternativa A.

183517.

Comentário: Temos uma paciente com supradesnivelamento de ST nas derivações D2, D3 e AVF, que correspondem à parede inferior e dorsal (em 70% dos casos irrigada pela artéria coronária direita, enquanto os outros 30% são irrigados pela artéria circunflexa, ramo da coronária esquerda). A paciente chegou rapidamente ao posto de saúde, dentro da janela permitida para as medidas intervencionistas, portanto não podemos perder tempo aguardando exames Há uma preferência à angioplastia que deve ser realizada em até 90 minutos da chegada de pacientes com delta T de até 12 horas ou em até 120 minutos para pacientes que tenham a possibilidade de ser transferido para

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

uma unidade de referência. Caso não seja possível cumprir o tempo porta-balão, opta-se pela trombólise. Gabarito A.

152285.

Comentário: Mulher hipertensa e tabagista, procura atendimento médico com quadro de dor torácica atípica (referida no ombro) associada a sudorese fria e congestão pulmonar. O ECG obtido de imediato demonstra a presença de supra de ST na parede anterior (V1-V4). Qual é o diagnóstico operacional É claro que isso é um infarto agudo do miocárdio IAM com supra significa coronária fechada , e a conduta prioritária é abrir a coronária. A melhor estratégia é a angioplastia primária (angioplastia logo após a chegada, não precedida pela administração de trombolítico). O termo angioplastia facilitada refere-se à antiga estratégia de submeter o paciente a uma angioplastia após a administração inicial de trombolítico ou inibidores da GPIIb-IIIa... Ressalte-se que a angioplastia facilitada caiu em desuso, pois não demonstrou melhorar a morbimortalidade, pelo contrário aumenta a chance de sangramentos (A errada) Feito o diagnóstico de IAM, não vamos deixar o paciente com dor fazemos medicamentos antiangionosos e, na ineficácia ou contraindicação a estes, estamos autorizados a utilizar analgésicos narcóticos, como os opioides (D errada). Oxigênio suplementar deve obrigatoriamente ser feito em pacientes que apresentam hipoxemia. Não obstante, a literatura aceita a administração genérica de O2 a todos os pacientes com IAM nas primeiras 6h da abordagem (C errada). Enfim, uma das formas de estratificar gravidade num IAMST é através da classificação clínica de Killip e Kimbal, que avalia o grau de comprometimento hemodinâmico do infarto. A presença de dispneia crepitações pulmonares coloca o paciente na categoria KILLIP II, o que contraindica o uso de betabloqueadores na fase aguda Logo, resposta certa B.

152291.

Comentário: Veja bem... É claro que diversas medidas fazem parte do pacote de tratamento adequado ideal para um caso de IAMST, e é claro que algumas dessas medidas encontram-se contraindicadas para determinados pacientes... O que temos de fazer nessa questão é avaliar qual das opções citadas PODE fazer parte do pacote que será oferecido ao paciente em tela Então

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

vamos lá Os betabloqueadores são importantes tanto na fase aguda quanto na fase crônica do IAMST, e podem ser feitos tanto pela via oral quanto pela via intravenosa (com preferência pela primeira). Contudo, temos que respeitar suas contraindicações (tabela)... Ora, nossa paciente está em Killip II (dispneia crepitações pulmonares), logo, não poderemos marcar as letras A e B... Diante de um supra de ST novo, devemos entender que a coronária está fechada pelo trombo, logo, a conduta prioritária é justamente abrir a coronária Duas estratégias são válidas (1) angioplastia primária (aquela realizada sem administração prévia de trombolíticos ou bloqueadores da GP IIb-IIIa (2) trombolíticos. A melhor opção - sempre que possível - é a angioplastia primária, desde que realizada em tempo hábil. A literatura em farta em evidências que comprovam a superioridade da angioplastia primária em termos de redução da morbimortalidade, comparado ao trombolítico. No entanto, a angioplastia facilitada (angioplastia após administração prévia de trombolítico ou inibidor da GP IIb-IIIa) caiu em desuso justamente por ter demonstrado aumento na taxa de sangramentos, sem qualquer benefício em termos de redução da mortalidade (D errada). Assim, sobrou a letra C, que de fato está correta o uso de AAS precocemente no IAM é uma medida com poucos efeitos colaterais que comprovadamente promove enorme benefício sobre a morbimortalidade Resposta certa C.

152264.

Comentário: Paciente com história de revascularização miocárdica prévia (isto é, portador de doença coronariana conhecida), apresentando dor torácica persistente, com supra de ST no eletro e marcadores de necrose miocárdica alterados... Qual é o diagnóstico de base É claro que se trata de um infarto agudo do miocárdio Um supra de ST novo, neste contexto, deve ser entendido como uma oclusão coronariana TOTAL. No caso da parede diafragmática (parede inferior), a artéria envolvida é a coronária direita. Sabemos que quando a coronária está fechada , a conduta prioritária é abri-la o quanto antes, para o que dispomos de duas opções (1) angioplastia primária, (2) trombólise química. Das duas, A MELHOR é a angioplastia primária, que se mostrou mais eficaz na literatura (maior taxa de sucesso da revascularização, com menor morbimortalidade). Repare que as duas opções são citadas nas alternativas, o que gerou enorme confusão Na realidade, não

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

há que se ter dúvida sempre que a angioplastia primária estiver disponível em tempo hábil, ela será preferível à trombólise química, mesmo que esta última também possa ser feita imediatamente (na ausência de contraindicações). Como o enunciado não especifica se há ou não contraindicações ou dificuldades para a realização de qualquer uma das abordagens, a melhor resposta é sem dúvida a letra A (lembrando que estudo hemodinâmico é a mesma coisa que cineangiocoronariografia , isto é, uma intervenção coronariana percutânea que pode ser tanto diagnóstica quanto terapêutica)

133834.

Comentário: O paciente da questão apresenta uma síndrome coronariana aguda com síndrome de ST associada a um quadro de Killip 2 (B3 estertoração basal), logo, a administração de betabloqueador só vai piorar o quadro, podendo precipitar um edema agudo de pulmão (Killip 3). Está indicada a reperfusão por trombólise ou angioplastia. A definição do tratamento depende da disponibilidade e do tempo estimado para transferência para centro de hemodinâmica. A trombólise pode ser realizada até 12h após o início da dor. Não há benefício em oferecer suplementação de O2 para o paciente caso sua saturação parcial de O2 esteja acima de 94%. Dessa forma, a única opção errada e com potencial malefício ao paciente é a letra C.

107003.

Comentário: Essa questão trata de um evento relacionado aos nitratos conhecido como taquifilaxia. A base está na depleção dos radicais sulfidrila livre quando utilizamos tais drogas, que ocorre no nível vascular por metabolismo e consumo endoteliais. É a taquifilaxia que justifica o longo intervalo dado entre uma das doses, para que estes radicais sejam recompostos. Resposta letra C.

106937.

Comentário: A tradicional classificação de Killip-Kimball estratifica a gravidade do infarto agudo do miocárdio com supra de ST valendo-se tão somente dos achados do exame físico. Em termos práticos, ela reflete as consequências imediatas do IAMST para o sistema cardiovascular do paciente. Vamos relembrá-la (VER IMAGEM) Resposta certa D.

106944.

Comentário: Questão absurdamente MAL-FEITA Vejam só é claro que dependendo das derivações

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

do ECG onde se observem as alterações isquêmicas, podemos localizar a parede lesada e, por conseguinte, podemos inferir que coronária deve estar doente. O eletro também pode indicar a realização de cateterismo cardíaco, por exemplo, diante do encontro de supradesnível de ST, um marcador de alto risco que indica que a coronária está fechada . Lembre-se que, apesar de podermos utilizar trombolíticos em pacientes com IAMST, o ideal - sempre que possível - é submetê-los a uma angioplastia primária . Ora, diversos parâmetros encontrados ao ECG denotam maior gravidade e risco. Um deles nós já citamos o supra de ST. Mas existem outros, como as inversões de T simétricas e muito profundas (3 mm). Logo, questão devidamente ANULADA após os pedidos de recurso.

106996.

Comentário: A letra D cita condições não cardíacas, logo, não serve como resposta aqui. As letras B e C citam condições que causam dor cardíaca ISQUÊMICA Ora, na letra A temos doenças cardiovasculares que fazem diagnóstico diferencial com a dor isquêmica, porém, possuem em sua gênese outros mecanismos que não um desequilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio pelo miocárdio. Resposta certa A.

81211.

Comentário: Os principais diagnósticos diferenciais do IAM são as demais patologias que também se manifestam com uma síndrome de dor torácica aguda. Dentre as entidades de elevado potencial de gravidade, merecem destaque a dissecção aórtica aguda (também chamada de aneurisma dissecante de aorta), o pneumotórax e a pericardite. Condições de menor gravidade, como espasmo esofagiano e doenças da coluna vertebral, evidentemente, também compõem este diagnóstico diferencial. Como o IAM ainda pode se apresentar de maneira atípica , justificando queixas álgicas ou de desconforto inespecífico até mais ou menos a altura da cicatriz umbilical, entram no seu diagnóstico diferencial entidades como a pancreatite e a gastrite, entre outras. Melhor resposta, portanto, letra D.

81216.

Comentário: AVC hemorrágico, a qualquer tempo, é a principal contraindicação ABSOLUTA aos

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

trombolíticos. Sabe-se que tais indivíduos possuem chance elevadíssima de recidiva da hemorragia no SNC caso utilizem a referida medicação. Hemorragias ativas potencialmente graves, como a HDA, evidentemente, também contraindicam trombolíticos, mas não de forma definitiva - cessada a hemorragia digestiva e resolvida a doença de base (ex. doença ulcerosa péptica) é possível utilizar trombolíticos. Na vigência de dissecção aguda de aorta, o uso de trombolíticos pode provocar ruptura aórtica espontânea (lembre-se de que na dissecção de aorta o jato de sangue abre caminho entre as túnicas interna e média da aorta, podendo dissecar também a adventícia. Neste caso, o trombolítico impede a formação de um coágulo intramural que tampone de maneira eficaz a hemorragia, a qual, desse modo, pode se expandir e romper). As demais alternativas contêm uma opção que não é nem contraindicação (arritmia, menstruação, dor abdominal e diabetes), logo, resposta certa D.

83515.

Comentário: Na síndrome coronariana aguda sem supra de ST, como se subentende a ausência de uma oclusão total do vaso coronariano, não há papel para os trombolíticos e nem para a angioplastia primária (aquela feita em menos de 90 minutos) O objetivo principal é estabilizar de imediato o trombo coronariano suboclusivo na artéria culpada , evitando que evolua para um trombo coronariano oclusivo e estabilizar as demais placas coronarianas instáveis porventura presentes. Assim, o primeiro passo será estabelecer uma terapia medicamentosa agressiva com este objetivo. Contudo, além desta terapia, de acordo com a definição da classe de risco do paciente, definiremos dois caminhos possíveis estratégia conservadora ou invasiva precoce. Neste caso, temos redução da função sistólica com múltiplas lesões obstrutivas coronarianas, porém com bom leito distal. Dessa forma, trata-se de paciente que certamente se beneficiará de cirurgia de revascularização miocárdica.

83433.

Comentário: A questão apresenta um paciente de 60 anos com dor torácica compatível com isquemia miocárdica, ECG com supra de ST na parede inferior com infra em espelho na parede anterolateral, hipotenso, mas com pulmões limpos. Com esses dados não temos dúvida que

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

estamos diante de um infarto agudo do miocárdio. Mas qual a artéria acometida Em todo IAM de parede inferior devemos olhar a derivação D1. Se houver supradesnivelamento nessa derivação, sugere acometimento da artéria Circunflexa (Cx) e se houver infradesnivelamento (como no caso) provavelmente estamos diante de um infarto de Coronária Direita (CD) que pode vir associado a infarto de VD. Se D1 estiver isoelétrico devemos comparar o supradesnivelamento de D2 com o de D3. Supra maior em D2 sugere acometimento de Cx, enquanto supra maior em D3 sugere de CD. No paciente apresentado, os dois parâmetros apontam para infarto com CD acometida. Devemos realizar o ECG completo com as derivações V3R e V4R para avaliar o acometimento do VD e V7-V8 para avaliar a parede posterior que deve estar comprometida no caso da CD ser dominante. Além do ECG, aponta para o provável acometimento de VD a clínica do paciente com hipotensão, mas sem congestão pulmonar. Devemos suspeitar sempre de infarto de VD, pois o choque cardiogênico quando ocorre pelo infarto de VE tipicamente cursa com congestão pulmonar importante. O tratamento, além da terapia comum a todos os infartos com supra de ST como antitrombótica e da reperfusão, inclui reposição volêmica com SF 0,9% (1-2L). Ao contrário do VE, o VD disfuncionante tolera alta carga volêmica, aumentando o seu débito, já que esta câmara trabalha com baixas pressões de enchimento. Se não responder devemos iniciar dobutamina. Os nitratos, a morfina e diuréticos (ou qualquer droga redutora de pré-carga) são contraindicados (B INCORRETA). Assim, o gabarito correto é a letra A trata-se de infarto do miocárdio extenso acometendo também o ventrículo direito, devendo medicamentos como nitratos e morfina ser evitados nesta fase do infarto.

60288.

Comentário: É óbvio que não se deve ministrar trombolítico a um paciente que apresenta franca hemorragia intracraniana, suspeita de dissecção aórtica ou neoplasia localizada no sistema nervoso central. Os trombolíticos podem acarretar sangramento espontâneo, e em todas essas situações o risco de sangramento grave já é, de antemão, extremamente alto Na realidade, diante de qualquer sangramento patológico não se deve ministrar trombolíticos. Sendo assim, guarde o conceito de que um sangramento fisiológico como a menstruação NÃO representa contraindicação absoluta

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

aos trombolíticos Pois bem, porque essa questão foi anulada então Porque algumas fontes de referência (como o Cecil Tratado de Medicina Interna) afirmam que o intervalo de tempo após um AVC isquêmico em que se deve evitar os trombolíticos é de 3 meses apenas, e não de 6 meses, como quer a letra C. Vale lembrar que história prévia de AVC hemorrágico - a qualquer tempo - constitui contraindicação absoluta à trombólise farmacológica. QUESTÃO ANULADA pela banca após pedidos de recurso.

64952.

Comentário: Idoso com múltiplos fatores de risco cardiovascular se apresenta com dor torácica típica, com 20 min de duração, e ECG revelando a presença de supra de ST em parede inferior (DII, DIII e aVF). Qual deve ser a conduta imediata logo após esse diagnóstico (IAMST) A princípio, antes de adotar qualquer estratégia específica para a reperfusão do vaso envolvido com o infarto devemos seguir o clássico mnemônico MONAB (Morfina, Oxigênio, Nitrato, AAS e Betabloqueador). Então responda num paciente com FC 48 bpm, dá pra fazer BB É claro que não. E no IAM de parede inferior (oclusão da coronária direita), existe risco de IAM de VD associado Sim. Diante da possibilidade de IAM de VD (que poderá ser confirmado neste caso pela realização de ECG nas derivações precordiais direitas - V3R e V4R), alguma das drogas citadas estaria contraindicada Na realidade, mais de uma delas. No IAM de VD, a manutenção do débito de VD (e, consequentemente, a manutenção do próprio débito cardíaco) depende muito de uma adequada pré-carga do VD. Por este motivo, qualquer medida que reduza o retorno venoso (reduzindo o enchimento diastólico do VD, ou sua pré-carga) deve ser evitada. Sabemos que morfina e nitrato são drogas que promovem venodilatação, aumentando o diâmetro da veia cava inferior e, desse modo, ambas reduzem o retorno venoso ao coração. Logo, morfina e nitrato devem ser evitados se houver possibilidade de IAM de VD. Enfim, como deu pra perceber, do clássico MONAB sobrou apenas oxigênio e AAS. É claro que este paciente deverá ser colocado em repouso, sob monitorização não invasiva contínua (cardioscópio, PNI e saturímetro periférico) e deverá ter um acesso venoso periférico imediatamente puncionado. Prescreveríamos dobutamina somente se houvesse franca hipotensão arterial. Melhor resposta A.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

64956.

Comentário: Se o supra de ST está localizado em DII, DIII e aVF, estamos observando um IAMST na parede inferior do coração. Relembre então a classificação de Killip para o IAMST (classificação clínica do status hemodinâmico associado ao IAM) (VER IMAGEM). Como o paciente está dispneico (tiragem intercostal) e crepitando nas bases pulmonares, resposta certa letra E.

34546.

Comentário: Questão fácil. Devido à meia-vida prolongada (10 dias para a TnI e 14 dias para a TnT), as troponinas cardioespecíficas são os marcadores de necrose miocárdica de escolha para o diagnóstico tardio de IAM (isto é, diagnóstico passada a fase de isquemia aguda por exemplo cerca de 1-2 semanas após o IAM). As troponinas cardioespecíficas são os MNM mais sensíveis e específicos, sendo preconizadas, de um modo geral, como parâmetro laboratorial de primeira linha para o diagnóstico de IAM. Sua principal desvantagem seria a incapacidade de estabelecer o diagnóstico de reinfarto precoce (novo evento nas primeiras 48-72h após um IAM) pelo mesmo motivo já exposto (meia-vida prolongada), as troponinas do primeiro infarto continuam elevadas no momento do segundo, não sendo possível confirmar a ocorrência deste com segurança. Para tanto, o MNM de escolha exclusivamente nesta situação é a CKMB (de preferência, CKMB massa), que além de ter excelente acurácia para IAM, possui meia-vida de 48-72h (isto é, um novo aumento após normalização, ou aumento 20% em relação ao valor prévio, no contexto apropriado, identifica a recorrência do IAM). A CPK total (creatinofosfoquinase todas as frações), de forma isolada, é absolutamente inespecífica para o diagnóstico de IAM, já que aumenta em diversas formas de lesão muscular lisa e esquelética (além, é claro, de aumentar na lesão muscular cardíaca). A mioglobina idem, porém, esta última pode ser útil na avaliação do paciente com suspeita de infarto por possuir meia-vida extremamente curta (12-24h, início da elevação sérica em 1-2h), confere elevado valor preditivo negativo (isto é, um resultado normal descarta IAM) propiciando a triagem do paciente que se apresenta com dor torácica aguda. Resposta certa E.

25774.

Comentário: Sabemos que a administração de O 2 suplementar não é custo-efetiva nas primeiras

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

24 h em TODOS os pacientes com IAM Tal medida só está absolutamente justificada quando a saturação de O 2 se encontra reduzida neste período e, por isso, o gabarito oficial da banca foi a letra B... Contudo, também não está correto afirmar que o AAS deve ser feito em TODOS os doentes com dor torácica sugestiva de isquemia aguda O próprio guideline da AHA ACC corrobora este conceito ao destacar que pacientes com história de alergia ao AAS ou uso prévio de warfarin não devem receber AAS no tratamento inicial. Deste modo, a questão possui duas respostas possíveis, as letras A e B, merecendo, portanto, a anulação Infelizmente, a banca manteve como gabarito a letra B e não considerou os recursos impetrados...

8749.

Comentário: Achou estranho que o gabarito oficial tenha sido a letra A Preste atenção no que ela está dizendo (e esqueça o que diz o enunciado) somente por causa de uma dor torácica você já deve sair dando aspirina para todo mundo É fundamental lembrar, nessas horas, diante de um paciente de verdade, de um dos mais sérios e importantes diagnósticos diferenciais da dor torácica aguda o aneurisma dissecante de aorta O uso de agentes antiplaquetários ou antitrombóticos neste caso pode afetar de maneira extremamente desfavorável o curso clínico do paciente (por exemplo os pacientes com dissecções aórticas proximais devem ser operados imediatamente, e o uso de AAS aumenta o risco de complicações hemorrágicas) É claro que se o diagnóstico de IAM foi estabelecido, o uso imediato de AAS é uma das medidas com maior benefício comprovado (redução de 20-25% na mortalidade hospitalar). Entretanto, a letra A não está falando de IAM especificamente (ainda que o enunciado esteja) O fato é que na abordagem de um paciente com dor torácica aguda sugestiva de isquemia, a primeira droga a ser administrada (que inclusive visa promover o alívio imediato DO SINTOMA) são os NITRATOS, como o dinitrato de isossorbida sublingual Lembre-se, contudo, de dois detalhes (1) a melhora da dor com nitrato é compatível com a hipótese de dor isquêmica, mas não é patognomônica dessa condição (pode ocorrer também nos espasmos esofágicos ou por efeito placebo, no paciente com transtorno de ansiedade e ataque de pânico), (2) antes de dar o nitrato para o doente devemos perguntar se ele fez uso de medicamentos para disfunção erétil nas últimas 24h (inibidores da fosfodiesterase), pois se fez, o

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

uso de nitrato é totalmente PROIBIDO Resposta certa letra A as demais alternativas estão corretas e são autoexplicativas

359377.

Comentário: Questão bem difícil A banca descreve idoso que, no contexto de infarto com supra de ST (IAMCSST), foi trombolisado com sucesso é citada resposta clínica e eletrocardiográfica, com eletro pós-trombólise sem alterações. Até aí, tudo ótimo... O problema é que, enquanto estava sendo monitorizado após o procedimento, desenvolveu alterações eletrocardiográficas que nos chamaram bastante atenção para a possibilidade de bloqueio de ramo esquerdo (BRE). Como interpretar esse achado Vamos com calma Apesar de o traçado demonstrar, de fato, padrão de BRE, entenda o que o paciente tem é RIVA ritmo idioventricular acelerado arritmia de reperfusão, isto é, que demonstra tão somente o sucesso da trombólise. Para facilitar a identificação desse ritmo, observe (1) que não há onda P positiva em D2 (afastando ritmo sinusal), (2) que o QRS está alargado (com padrão de BRE) e frequência entre 60 120 bpm e (3) que as ondas P estão dissociadas do QRS, achado mais visível em V1. Difícil, né Enfim, agora que já esclarecemos o eletro, vejamos cada uma das alternativas. Administração de amiodarona pela via IV incorreta. Amiodarona seria usada para controle de arritmias e ou em parada cardiorrespiratória, não para tratamento de BRE. Cardioversão elétrica sincronizada. incorreta. Cardioversão elétrica O paciente não taquiarritmia com critérios de instabilidade. Conduta expectante e suporte clínico. correta. O doente desenvolveu RIVA, clássico ritmo de reperfusão coronariana. A conduta é expectante (comemorar faz parte). Transferência para cateterismo de urgência (em até 1 hora). incorreta. Todo paciente trombolisado deve ser submetido a cateterismo oportunamente. Mas com achados compatíveis à abertura da coronária e ausência de sinais de instabilidade, não há por que fazê-lo com urgência, pelo menos não no cenário construído pela banca. Observação importante de acordo com as diretrizes atuais, todo paciente com IAMCSST submetido à trombólise deve ser transferido para centro com hemodinâmica logo após a infusão do trombolítico. Neste caso, porém, por alguma razão, a banca optou por manter o paciente no mesmo serviço em que ele fora trombolisado. Então, o cenário foi este e não daria para mudar, ok Resposta letra C.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

149917.

Comentário: O infarto inferior (alterações isquêmicas em D2, D3 e aVF) com grande frequência se associa ao infarto de ventrículo direito, pois a mesma artéria que irriga a parede inferior também irriga a parede lateral do VD (a coronária direita). Para confirmar IAM de VD é preciso rodar o ECG nas derivações precordiais direitas V3R, V4R, V5R etc. A suspeita de IAM de VD sempre deve ser aventada em pacientes com IAM inferior que evoluem com hipotensão arterial e sinais de falência sistólica de VD, por exemplo turgência jugular patológica, estando os campos pulmonares limpos (ausência de congestão e crepitações). Vale lembrar drogas que reduzem a pré-carga do VD, como os nitratos, são contraindicadas neste contexto. Resposta certa C.

127492.

Comentário: Menos de uma semana após um IAM com Q, isto é, um IAM transmural, o paciente evolui com recidiva da dor torácica acompanhada de irradiação para o trapézio e atrito pericárdico na ausculta, um quadro clássico de pericardite aguda. A manutenção da estabilidade hemodinâmica e ausência de congestão pulmonar falam contra novo insulto isquêmico ao miocárdio. Lembre-se que até 20% dos pacientes que sofrem um IAM transmural desenvolvem algum grau de pericardite fibrinosa, por extensão do processo inflamatório para a superfície epicárdica. Quando isso acontece entre o 2º e o 7º dias do evento chamamos de pericardite epistenocárdica. Tal quadro é diferente da pleuropericardite autoimune desencadeada por exposição a antígenos miocárdicos que aparecem em consequência ao infarto, surgindo 2 a 8 semanas após o evento, a chamada síndrome de Dressler (cuja fisiopatologia está descrita na letra D). Logo, tendo em vista que as demais assertivas são corretas, a única alternativa passível de marcação aqui é a letra D.

78425.

Comentário: Paciente idoso, 8 horas após um IAM de parede anterior, que complica de forma gravíssima No que pensar Poderia ser um choque cardiogênico Claro, mas reparem nas opções com exceção da letra A (IAM de VD), todas são direcionadas para uma complicação mecânica. E por se tratar de parede anterior, vamos dizer então que o IAM de VD (ligado à parede inferior e

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

direita) estaria descartado, ok Como escolher entre B, C e D é a pergunta seguinte. Podemos dizer que a rotura da parede livre do ventrículo é típica do IAM de parede anterior, ocorrendo geralmente no limite entre a necrose transmural e o miocárdio viável. O paciente costuma evoluir com morte súbita não arrítmica, devido ao hemopericárdio agudo e tamponamento cardíaco levando à atividade elétrica sem pulso. A sobrevivência é a exceção, sendo possível apenas nos casos de cirurgia cardíaca imediata ou nos raros casos subagudos ou quando o sangue é tamponado por um hematoma trombosado, contido apenas pelo pericárdio, ao que denominamos pseudoaneurisma ventricular. Apesar de o paciente estar fora do período típico dessa complicação (entre o terceiro e o quinto dia de IAM), dentre as opções, a mais provável de cursar com um quadro fulminante de morte súbita, conforme apresentado, é a letra C. Para as demais, além de um quadro menos grave , ainda teríamos a dica do aparecimento de um sopro.

60337.

Comentário: O que vemos nesse traçado eletrocardiográfico Há uma elevação generalizada do segmento ST, com concavidade virada para cima, envolvendo 3 derivações básicas dos membros além de V2-V6, com depressões recíprocas em AVR e V1, assim como depressão do segmento PR. Esta é a descrição clássica do primeiro estágio eletrocardiográfico da pericardite aguda E como é a dor de um paciente com pericardite É intensa, retroesternal e precordial esquerda, sendo referida para o pescoço e ombro esquerdo, de caráter pleurítico (em consequência da irritação pleural associada), sendo aliviada pela posição sentada e inclinada para frente, e agravada pelo decúbito dorsal. Resposta correta letra A.

53362.

Comentário: Temos um paciente com hipertensão, diabético e com angina estável. Neste caso, estaria indicada a suspensão da nifedipina (fármaco comumente associado à taquicardia reflexa, podendo piorar a isquemia cardíaca) e o início de IECA como medida nefroprotetora (e também como anti-hipertensivo). Para esclarecer o diagnóstico de doença coronariana, os melhores exames são aqueles que provocam isquemia, sendo o mais utilizado o teste ergométrico ou teste de esforço . A presença de B4 à ausculta e de sobrecarga atrial esquerda deve nos levar à investigação de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

uma hipertrofia ventricular esquerda sobrejacente, que deve ser realizada preferencialmente com ecocardiograma, mas que pode ser iniciada com um RX simples de tórax. Além disso, todo portador de coronariopatia deve receber Ácido Acetilsalicílico (AAS) 100 mg dia, salvo contraindicações. Além disso, fora as medidas dietéticas, este paciente tem indicação de pronto início de estatina, já que seu colesterol LDL está muito acima do nível desejado para pacientes de alto risco (diabéticos, com aterosclerose difusa, síndromes isquêmicas instáveis) 70 mg dl, para os demais coronariopatas 100 mg dl.

52418.

Comentário: A súbita piora da função cardíaca 48h após a ocorrência de um infarto agudo do miocárdio tem que nos fazer pensar na possibilidade de uma das complicações mecânicas do infarto. No caso do IAM inferior, é possível, por exemplo, o surgimento de uma comunicação interventricular através de perfuração da porção inferior do septo interventricular. E este é justamente o diagnóstico mais provável para o caso quem fala muito a favor de tal hipótese é o súbito surgimento de um sopro sistólico rude, na borda esternal esquerda média baixa. Esta doente, sem dúvida nenhuma, necessita de um ecocardiograma com Doppler a fim de confirmar este diagnóstico. Resposta certa C.

22880.

Comentário: Guarde a seguinte regra todo paciente com queixa típica de angina pectoris (desconforto precordial em aperto, que piora com atividade física ou excitação emocional e melhora com repouso ou nitrato), e que pertença a um grupo de risco para doença coronariana, deve ser encarado como portador de coronariopatia obstrutiva até que se prove o contrário Logo, a história e o exame físico são as principais ferramentas para o diagnóstico de DAC, que deverá apenas ser confirmado e estratificado (estimativa do risco de eventos coronarianos agudos) através do uso de alguns exames complementares (A correta). Dos exames que podem ser empregados com este intuito, o ECG de esforço (teste ergométrico) é um dos mais úteis, ainda que sua sensibilidade e especificidade não sejam muito altas (75% e 85%, respectivamente). Estes valores relativamente baixos são compensados quando a população estudada possui uma alta probabilidade pré-teste

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

para doença coronariana (isto é, uma população com alta prevalência da doença) neste caso, os valores preditivos aumentam. O ECG de repouso possui baixíssima sensibilidade (não detecta com segurança a maioria dos portadores de doença coronariana), logo, seu valor preditivo negativo não é confiável (isto é, um resultado negativo não descarta o diagnóstico). Agora apesar de não ser necessária em TODOS os casos, a cineangiocoronariografia (cateterismo cardíaco) permanece como método padrão-ouro para o diagnóstico de DAC Todavia, sabemos que este exame não tem a capacidade de dizer se uma placa é instável ou não Ele apenas demonstra as placas obstrutivas, sem conseguir prever qual delas possui maior risco de ruptura (mais instável mais inflamada). Resposta certa letra D.

359305.

Comentário: Vamos analisar a questão sobre o uso de corticosteroides no tratamento da pericardite aguda, lembrando que a escolha do tratamento depende de vários fatores, incluindo a causa da pericardite e a resposta a tratamentos iniciais. Agora, vejamos as alternativas Letra A correta. O uso de corticosteroides é considerado em pacientes que não respondem adequadamente aos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) e à colchicina. Estes são os tratamentos de primeira linha para a pericardite aguda. Os corticosteroides são geralmente reservados para casos refratários ou em situações específicas devido ao risco de efeitos colaterais e potenciais complicações. Letra B incorreta. Não é recomendado usar corticosteroides em todos os pacientes com pericardite aguda. O tratamento inicial geralmente envolve AINEs e colchicina. Os corticosteroides são usados seletivamente e com cautela. Letra C incorreta. A etiologia viral da pericardite não é, por si só, uma indicação para o uso de corticosteroides. Embora a pericardite viral possa ser grave, o tratamento inicial ainda envolve AINEs e colchicina. Corticosteroides são considerados em casos complicados ou refratários. Letra D incorreta. Pacientes com alergia ao ácido acetilsalicílico podem ser tratados com outros AINEs ou com colchicina. A alergia ao ácido acetilsalicílico por si só não é uma indicação direta para o uso de corticosteroides. Resposta letra A.

340700.

Comentário: Questão extraída, integralmente, da Atualização da Diretriz de Avaliação

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Cardiovascular Perioperatória da Sociedade Brasileira de Cardiologia Foco em Manejo dos Pacientes com Intervenção Coronária Percutânea 2022. Segundo este documento, a recomendação da DAPT (dupla antiagregação plaquetária), com associação de ácido acetilsalicílico e um inibidor de P2Y12 (clopidogrel, ticagrelor ou prasugrel) após ICP (intervenção coronária percutânea), varia conforme o contexto clínico (doença arterial aguda ou crônica) e tipo de stent utilizado. Em pacientes submetidos à ICP na vigência de síndrome coronariana aguda (SCA), recomenda-se a manutenção por 12 meses, podendo a terapia ser reduzida para 6 meses ou estendida, levando-se em consideração o risco individual de sangramento, bem como o risco isquêmico . Já no contexto de doença arterial coronariana (DAC) crônica, a recomendação atual é a realização de DAPT durante tempo mínimo de 4 a 6 semanas para stents não farmacológicos, e geralmente de 3 a 12 meses para os stents farmacológicos, com abreviação excepcionalmente em 30 dias, a depender do risco de sangramento e geração do stent implantado. Resposta letra C.

340706.

Comentário: A questão aborda um tema bem comum nos pacientes com doença arterial coronariana (DAC), que é a dupla antiagregação plaquetária (do inglês DAPT), marcada pela associação de AAS inibidor de P2Y12 (clopidogrel, ticagrelor ou prasugrel), sendo que o conceito aqui foi retirado na íntegra da diretriz mais recente sobre manejo perioperatório nesses pacientes. O que precisamos, primeiro de tudo, lembrar é o seguinte conceito em pacientes submetidos à intervenção coronariana percutânea (ICP), na vigência de síndrome coronariana aguda, recomenda-se a manutenção por um ano, podendo-se reduzir para seis meses ou estendida, levando-se em consideração o risco de sangramento e de isquemia. Assim, temos que a recomendação, segundo o documento é de mantermos a DAPT durante tempo mínimo de 4 a 6 semanas para stents não farmacológicos, e geralmente de 3 a 12 meses para os stents farmacológicos, com abreviação excepcionalmente em 30 dias, a depender do risco de sangramento e geração do stent implantado. Resposta letra A.

346210.

Comentário: Questão bastante direta As etiologias viral e idiopática correspondem às principais

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

causas de pericardite aguda, sendo a letra D a resposta adequada. Os vírus Coxsackie B e Echovirus, comumente relacionados à resfriados comuns, são os agentes mais usualmente implicados na inflamação pericárdica. Menos frequentes, outras infecções pericárdicas são reconhecidas, tais quais as bacterianas, especialmente por Staphylococcus aureus e Micobacterium tuberculosis , e fúngicas, principalmente relacionadas ao Histoplasma capsulatum . Diversamente da doença viral, estas entidades podem implicar em efusão purulenta. A doença neoplásica decorre, em geral, por envolvimento metastático, sendo os sítios primários mais descritos pulmão, mama e linfoma de Hodgkin. Entre as colagenoses que afetam o pericárdio são importantes o lúpus eritematoso sistêmico, a febre reumática e a artrite reumatoide, as quais são gêneses menos cotidianas de pericardite, dado sua ocorrência mais esporádica na população geral. Resposta letra D.

340764.

Comentário: Questão extraída, integralmente, da Atualização da Diretriz de Prevenção Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Segundo este documento, algumas evidências sugerem que pacientes hipertensos devem ser aconselhados a praticar pelo menos 30 minutos de exercício aeróbico dinâmico de intensidade moderada (caminhada, corrida, ciclismo ou natação) em 5 a 7 dias por semana. O desempenho de exercícios resistidos em 2 a 3 dias por semana também pode ser recomendado. Para benefício adicional em adultos saudáveis, recomenda-se um aumento gradual da atividade física aeróbica para 300 minutos por semana de intensidade moderada ou 150 minutos por semana de atividade física aeróbica de intensidade vigorosa, ou uma combinação equivalente dos mesmos, idealmente com exercício diário supervisionado . O impacto de exercícios isométricos sobre a PA e o risco CV está menos bem estabelecido. Resposta letra D.

278836.

Comentário: Questão retirada, integralmente, na Atualização da Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia 2019. Vamos, então, revisar o trecho que respondia a questão Avaliação de dor

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

torácica A dor torácica é o principal sintoma sugestivo de Síndrome Coronária Aguda (SCA) com características da dor torácica sugestivas de isquemia miocárdica. Pacientes com dor anginosa em repouso com mais de 20 minutos de duração, angina limitante de início recente e angina em crescendo (maior frequência, maior intensidade e menor limiar para aparecimento dos sintomas que o habitual) devem ser encaminhados aos serviços de emergência, já que essas características da dor são sugestivas de SCA. Resposta letra D.

260533.

Comentário: O achado eletrocardiográfico mais clássico (e o que mais aparece em provas) da hipercalcemia é o encurtamento do intervalo QT, mas esse distúrbio também pode provocar supradesnivelamento do segmento ST, simulando uma síndrome coronariana aguda. O mesmo vale para a hipercalemia além do clássico apiculamento das ondas T, também pode haver supra. Este achado também pode ser observado na síndrome de Brugada, distúrbio hereditário marcado por um defeito nos canais de sódio do miocárdio ventricular, propiciando uma heterogeneidade dos períodos refratários do ciclo cardíaco, um fator predisponente a taquiarritmias ventriculares maligna o critério eletrocardiográfico para o diagnóstico da síndrome de Brugada é o padrão típico no ECG em ritmo sinusal, demonstrando um pseudo-BRD com supra de ST nas derivações precordiais direitas (V1 e V2 V3) - veja a imagem. A sobrecarga de VD, por outro lado, caracteristicamente cursa com padrão strain em V1 e V2, ou seja, inversão assimétrica da onda T e INFRA de ST. Resposta (C).

260534.

Comentário: Para entender o que significa o pulso paradoxal, é preciso relembrar alguns conceitos básicos de Fisiologia... Durante a inspiração, a redução da pressão intratorácica transmite-se para o pericárdio e para as câmaras cardíacas, promovendo um aumento do retorno venoso para o coração direito. Enquanto isso, o retorno venoso para o coração esquerdo diminui, pois há um ligeiro desvio do septo interventricular para dentro do VE e uma redução das pressões no sistema venoso pulmonar. Dessa forma, o débito sistólico e a PA caem um pouco durante a inspiração. Quando a pressão intrapericárdica está alta, como no tamponamento cardíaco, o fenômeno fica

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ainda mais exacerbado, gerando o pulso paradoxal redução da PA sistólica em mais de 10 mmHg e ou a redução detectável da amplitude do pulso arterial, durante a inspiração. O mecanismo do pulso paradoxal é a restrição pericárdica ao VD, impedindo que sua parede anterior se desloque para frente para acomodar o maior retorno venoso imposto pela inspiração. Para isso, o abaulamento do septo interventricular para o interior do VE é exacerbado, reduzindo importantemente o seu enchimento diastólico. Olhando as alternativas, percebemos que a única condição que se encaixa nesse contexto é o tamponamento. Apesar de haver restrição de relaxamento ventricular na IC diastólica, isso não impede o desvio do septo interventricular para o VE, já que não há restrição pericárdica. Resposta (A).

260257.

Comentário: Em relação à síndrome coronariana aguda sem supradesnivelamento do segmento ST os betabloqueadores diminuem o consumo de O pelo miocárdio, controlando a dor e a isquemia. Devem ser iniciados nas primeiras 24h pós-infarto, se não houver contraindicações. Ademais, o uso destas drogas diminui o risco de reinfarto e fibrilação ventricular. A nitroglicerina também reduz o consumo de oxigênio pelo miocárdio (diminuindo a pré-carga) e aumentando o aporte de O (vasodilatação coronariana). A diminuição da pré-carga auxilia nos quadros de congestão e hipertensão arterial refratária. É uma medicação que traz muito alívio sintomático ao paciente, mas não altera a mortalidade em longo prazo. Em curto prazo, a mortalidade nos pacientes com SCA sem supra de ST é menor que naqueles com elevação do segmento ST. Entretanto, em longo prazo, esta relação é perdida, não havendo diferenças significativas entre os dois tipos de infarto. O modelo GRACE estima o risco de mortalidade por SCA intra-hospitalar, em seis meses e um ano. O valor preditivo em um ano do modelo GRACE é maior que o do escore TIMI. Pacientes com escore de GRACE 140 são ditos de alto risco e necessitam de estratificação de risco na admissão e na alta. Resposta letra C.

266590.

Comentário: Em um primeiro momento, é quase intuitivo pensar em uma síndrome coronariana diante de um paciente de meia-idade com forte dor retroesternal. Porém, se observarmos

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

atentamente à descrição do exame físico, vemos que se trata de uma dor pleurítica que piora com o decúbito dorsal e é aliviada na posição sentada com o tronco inclinado para frente (posição genupeitoral). Tais características devem nos fazer suspeitar do diagnóstico de pericardite aguda Nestes casos, a dispneia pode ocorrer por hipoventilação, devido à dor pleurítica apresentada. Outros dados que, quando presentes, reforçam essa hipótese são a presença de taquicardia e o clássico atrito pleural à ausculta talvez para tentar dificultar um pouco, o autor da questão nem menciona sobre a ausculta do paciente. Mas não tem problema, porque o eletrocardiograma tira qualquer dúvida que ainda possa existir sobre o diagnóstico do caso vemos a presença de um supradesnível de ST de aspecto côncavo, presente em várias derivações, mas poupando V1 e aVR. Além disso, há um infradesnível do PR nas derivações precordiais, o que corresponde ao achado eletrocardiográfico mais específico de pericardite Quando não há uma etiologia bem estabelecida (forma idiopática), o tratamento da pericardite é feito com AINE ou AAS em dose alta, devendo ser suspenso após melhora da dor ou redução dos marcadores inflamatórios (VHS e PCR). A colchicina também já demonstrou ser efetiva no alívio da dor e na prevenção de recorrência, sendo comumente associada. Dito isso, ao perceber que não se trata de uma síndrome coronariana, automaticamente podemos excluir as outras alternativas. Logo, resposta analgesia com anti-inflamatório não esteroidal e colchicina.

253900.

Comentário: Embora não haja consenso para o significado do termo cardiopatia isquêmica , ele é predominantemente utilizado para descrever a disfunção ventricular esquerda secundária à doença arterial coronariana. Para tratamento da cardiopatia dilatada de etiologia isquêmica com fração de ejeção reduzida, os betabloqueadores indicados são o carvedilol (estudos US Carvedilol HF Study e COPERNICUS), bisoprolol (estudo CIBIS-II) e metoprolol (estudo MERIT-HF). O propranolol é um betabloqueador com menor seletividade cardíaca, e nao foi aprovado para uso em cardiopatia isquemica com fração de ejeção reduzida. Sendo assim, embora o gabarito oficial divulgado tenha sido a letra C, pela análise da equipe MEDGRUPO a resposta para a questão deveria ser a letra A

253902.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Questão direta, porém que requer conhecimento das medicações mais recentes da cardiologia. A terapia antianginosa para pacientes portadores de doença arterial coronariana estável consiste no uso de medicações que reduzem a demanda miocárdica e ou aumentam a oferta de suprimento sanguíneo coronariano. As medicações de primeira linha no tratamento incluem os betabloqueadores e na impossibilidade de seu uso bloqueadores dos canais de cálcio (verapamil, diltiazen). Em seguida, as opções disponíveis incluem os nitratos de ação prolongada (ex monocordil) e as mais novas medicações antianginosas inibidoras da oxidação dos ácidos graxos, como a ranolazina e a trimetazidina. Nestas últimas, e desvio do metabolismo cardíaco ao inibir a oxidação de ácidos graxos e favorecer a oxidação da glicose aumenta a eficiência metabólica, reduzindo os sintomas de angina. Resposta letra D

244513.

Comentário: Questão muito difícil retirada, na íntegra, da Diretriz brasileira baseada em evidências sobre prevenção de doenças cardiovasculares em pacientes com diabetes posicionamento da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM). Vamos, então, relembrar um trecho do documento que respondia a questão Os resultados das análises de metaregressão sugerem que a terapia com aspirina pode estar associada a uma diminuição do AVC entre as mulheres diabéticas e uma diminuição do IAM entre os homens diabéticos, (letra A - CORRETA) e que as reduções de risco obtidas com baixas doses (75 mg dia) foram tão grandes quanto às obtidas com doses mais elevadas (650 mg dia). (letra B - CORRETA) O estudo concluiu que a baixa dose de aspirina era benéfica para a prevenção primária da DCV e que a decisão sobre um tratamento com de aspirina deveria ser feita individualmente . (letra C - INCORRETA) Os efeitos da terapia com aspirina variaram por sexo e diabetes. ( ) Em pacientes com muito alto risco, incluindo aqueles com DACL e eventos cardiovasculares prévios (prevenção secundária), a terapia antiplaquetária é indicada . (letra D - CORRETA) Resposta letra C.

238640.

Comentário: A angioplastia de resgate está indicada nos casos em que há falha de reperfusão

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

coronariana com uso de trombolítico. São critérios que indicam reperfusão redução do segmento ST em pelo menos 50%, melhora da dor, pico precoce de marcadores de necrose miocárdica e arritmia de reperfusão (ritmo idioventricular). Assim, a alternativa C traz critérios que indicam falha terapêutica, com indicação de angioplastia de urgência. Gabarito alternativa C.

219404.

Comentário: Sem dúvida, o diagnóstico de base mais provável dessa paciente é o lúpus eritematoso sistêmico (os achados clássicos ao exame físico e o uso de hidroxicloroquina corroboram nossa hipótese). E o que será que está acontecendo com ela agora Bom, repare que ela apresenta sinais de insuficiência cardíaca (dispneia e edema de MMII) associados à dor torácica e ao aumento da silhueta cardíaca. Ao que tudo indica, ela está evoluindo com derrame pericárdico, um tipo de serosite (cabe ressaltar que nem todo paciente com serosite irá evoluir com IC - isso irá depender muito do volume de líquido acumulado no saco pericárdico). O pulso típico de uma IC é o de baixa amplitude O anacrótico, o bífido e o colapsante (em martelo d água) são característicos da estenose aórtica, da miocardiopatia hipertrófica e da insuficiência aórtica. Resposta (D).

201647.

Comentário: É pra ligar o sinal de alarme para infarto ao encontrar um homem de meia-idade com um monte de fator de risco (como dislipidemia e diabetes) e dor torácica. Acontece que quando você analisa um pouco melhor, a dor não é tão típica assim. Aí o eletrocardiograma mostra um supradesnivelamento de ST, mas que é difuso e tem sua concavidade virada para cima. Nem todo supra de ST é síndrome coronariana aguda (LETRA A INCORRETA) e um diagnóstico diferencial importante de dor torácica é a pericardite. Nesse caso, a dor costuma mesmo ser aguda e intensa, tem localização retroesternal e precordial esquerda, sendo referida para pescoço, braços ou ombro esquerdo e pode ser do tipo pleurítica se houver inflamação pleural associada. Em geral, a dor é aliviada pela posição sentada ou inclinada para frente (posição genupeitoral), abraçando-se um travesseiro (posição de Blechman) e agravada pelo decúbito dorsal. O supradesnivelamento de ST, diferente do infarto, é difuso, poupa aVR e V1 e tem concavidade voltada para cima (aspecto

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

presente somente na fase hiper-aguda dos infartos). Podemos observar ainda infradesnivelamento de PR, um achado mais específico que o supra. Laboratorialmente, é possível acharmos leucocitose, aumento do VHS, do PCR e ainda elevação dos marcadores de lesão miocárdica (como troponina) quando há injúria miocárdica por contiguidade, mas nesse caso, não há lesão coronariana alguma Outros dados não mencionados na questão que ajudariam pode ser identificável um quadro viral inespecífico recente e ruído de atrito pericárdico, audível em cerca de 85% dos pacientes, no exame físico. Quanto ao ecocardiograma, deve ser realizado em todos os casos suspeitos, pode evidenciar derrame pericárdico e diagnosticar tamponamento cardíaco em casos graves (LETRA C INCORRETA). O tratamento é feito com AINEs (sendo o Ibuprofeno o de escolha) e AAS em dose alta. A colchicina é bastante efetiva e também pode ser utilizada. Prednisona é reservada para casos refratários (LETRA D CORRETA). A letra B traz a conduta para o tromboembolismo pulmonar (LETRA B INCORRETA). Melhor resposta, letra D

203929.

Comentário: Paciente com quadro de síndrome coronariana aguda SEM supradesnivelamento do segmento ST, com onda T invertida e simétrica em parede anterior (derivações precordiais). Dessa forma, a droga que não pode ser utilizada, estando indicada apenas para os casos de supra de ST é o trombolítico (alteplase). Gabarito alternativa A.

210452.

Comentário: Temos um paciente com dor torácica e ECG evidenciando supra de ST em parede inferior (DII, DIII e AVF). Nesses casos, devemos sempre nos preocupar com a possibilidade de infarto de VD, estando indicada a realização de ECG com V3r e V4r, além de V7 e V8 para avaliação da parede posterior. Em um paciente com choque cardiogênico, como o apresentado pela questão, sem absolutamente nenhum grau de congestão pulmonar (pelos dados da história), é extremamente improvável que tal instabilidade se dê por acometimento de VE. Portanto, nesse cenário, a principal hipótese é IAM de VD. A conduta inicial adequada deve ser a reposição volêmica, associada a dupla antiagregação, anticoagulação e trombólise angioplastia primária. O uso de nitratos encontra-se contraindicado pela ação venodilatadora dessas drogas, que ao

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

promoverem redução da pré-carga, diminuem o débito (já reduzido) de VD, levando à deterioração clínica e hemodinâmica desse perfil de paciente. Gabarito alternativa A.

181241.

Comentário: O eco-stress pode sim ser empregado para a detecção de viabilidade miocárdica em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva de etiologia isquêmica... O sinal que denuncia a presença de áreas de miocárdio viável é o seguinte quando se começa a infundir dobutamina, as áreas viáveis inicialmente acinéticas recuperam de forma transitória sua contratilidade, tornando-se novamente acinéticas na medida em que a dose de dobutamina continua aumentando (A errada). As demais são conceituais e estão corretas. Resposta certa A.

181253.

Comentário: A estratificação de risco numa síndrome coronariana (SCA) é multifatorial, envolvendo diversos parâmetros além da dosagem de troponinas (A correta). Boa parte dos pacientes que desenvolvem complicações no contexto de uma SCA (ex. morte súbita) apresenta troponinas normais. Apesar de as troponinas atuais serem cardioespecíficas, existem resultados falso positivos e falso negativos, ou seja, nenhum marcador de dano miocárdico é perfeito (B correta). Os ensaios atuais permitem detecção de aumento das troponinas a partir de 3h do início do dano miocárdico. Logo, é mandatório dosar marcadores de necrose miocárdica de maneira seriada, a fim de identificar a existência de uma curva de aumento e decréscimo, que confirma a ocorrência de infarto (C errada). Tanto é assim que parte dos paciente que recebe diagnóstico de IAM se apresenta com troponinas inicialmente normais (dosagem precoce), confirmando-se o IAM com a dosagem seriada (D correta). Resposta certa C.

181027.

Comentário: A radiografia mostra a existência de uma carapaça calcificada em volta do coração, isto é, considerando as queixas de congestão eminentemente venosa sistêmica, não resta dúvida de que se trata de um caso de pericardite constrictiva , uma das complicações da radioterapia torácica... Na pericardite constrictiva, tal qual no derrame pericárdico com tamponamento, o principal problema é a restrição ao enchimento diastólico do coração, levando a um aumento nas

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

pressões de enchimento. No entanto, diferentemente do tamponamento, onde a restrição ao enchimento diastólico é constante ao longo de toda a diástole, na pericardite constrictiva ela não é observada durante a fase de enchimento diastólico rápido, somente no enchimento diastólico lento... Isso explica alguns dados semiológicos que nos ajudam a diferenciar uma entidade da outra, por exemplo no tamponamento o descenso Y da curva de pressão venosa jugular é atenuado ou mesmo desaparece, porém, na pericardite constrictiva o descenso Y é exacerbado (A errada)... No tamponamento as bulhas estão abafadas e não se nota nenhum som acessório, porém, na pericardite constrictiva é característico do chamado knock pericárdico, isto é, a capa fibrótica produz um verdadeiro estalo ao término da fase de enchimento diastólico rápido, criando um breque para o enchimento diastólico lento (D correta)... A TC de tórax, por ser o melhor exame para avaliar calcificações, é mais sensível do que o ecocardiograma para demonstrar a existência de pericardite constrictiva (B errada)... A principal causa de pericardite constrictiva nos países pobres ainda é a tuberculose pericárdica (C errada)... Resposta certa D.

181248.

Comentário: Os stents farmacológicos (SF) de 1a geração eram os que continham sirolimus ou paclitaxel, ambas drogas com efeito antiproliferativo. As taxas de trombose de stent, que culminam em IAM ou óbito, gira em torno de 1% no 1o ano (trombose tardia) sendo 50% dos casos nos primeiros 30 dias. Nos casos de trombose bastante tardia (após 1 ano), as taxas são menores de 1%. Quando comparada às taxas observadas com stents metálicos não farmacológicos, observou-se um aumento nas taxas de trombose bastante tardia (A correta). A primeira geração de stents não é utilizada na prática clínica e foi substituída por stents contendo derivados do sirolimus o zotarolimus e o everolimus, que são os SFs de 2a geração. Estes são mais biocompatíveis, gerando menos resposta inflamatória, menos hiperplasia intimal e endotelização mais precoce. Esta opção peca em colocar o sirolimus como stent de 2a geração. (B incorreta). Os novos stents tem uma plataforma feita de um composto de cobalto-or cromo e platina, são mais finos e de mais fácil posicionamento vascular. Estão em constante análise pela ANVISA que acompanha as recomendações da literatura médica vigente. (C correta). Apesar do aumento das taxas de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

trombose muito tardia com uso dos SFs de 1a geração, não observou-se aumento da ocorrência de óbito e IAM. (D incorreta). Questão que a princípio possui duas respostas, já que a opção B coloca o sirolimus como pertencente aos SFs de 2a geração e a opção D cita um aumento na ocorrência de óbitos e IAM. Gabarito liberado pelo concurso D

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina